

CARDIOLOGÍA

2013

1) Paciente de 53 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento con enalapril, consulta por disnea de medianos esfuerzos asociado a palpitaciones intermitentes desde hace un mes. Al examen físico destaca ritmo irregular asociado a aumento de R1. El diagnóstico más probable es: a) Flutter auricular

b) Taquicardia ventricular

c) Taquicardia paroxística supraentricular

d) Fibrilación auricular

e) Enfermedad del nodo sinusal

R: Tiene una Estenosis Mitral con FA

3) Paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, actualmente hospitalizado por cuadro de edema generalizado en estudio, presenta dolor torácico de inicio súbito, asociado a diaforesis. Al examen físico destaca saturación de 89% con FiO2 ambiental, murmullo pulmonar con crepitaciones difusas bilaterales. En sus exámenes de laboratorio destaca proteinuria de 24 horas de 5gramos, albúmina de 2g/dL y perfil lipídico con triglicéridos de 450 mg/dL. La causa más probable de su dolor torácico es:

a) Neumonía aguda

b) Tromboembolismo pulmonar

c) Infarto agudo al miocardio

d) Pericarditis aguda

e) Disección aórtica

R: Tiene un síndrome nefrótico, secundario a una nefropatía membranosa y complicado con un TEP

16) Paciente de 50 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento irregular con hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico de 30 minutos de duración, transfixiante, irradiado a epigastrio, asociado a mareos y diaforesis. Al examen se aprecia pálido, sudoroso, PA 150/90, FC: 110x', saturación de oxígeno de 93% con FiO2 ambiental, ritmo regular, asociado a soplo diastólico II/ VI y disminución del segundo ruido, abdomen blando, depresible e indoloro, ruidos hidroaéreos presentes. Al ingreso se solicita ECG que muestra alteraciones inespecíficas en pared anterolateral, además troponinas que están con resultado pendiente. El diagnóstico más probable es:

a) Disección aórtica

b) Infarto agudo al miocardio sin supradesnivel de ST

c) Tromboembolismo pulmonar

d) Infarto mesentérico

e) Pancreatitis aguda

R: Disección aórtica por el soplo diastólico. La disminución del R2 y el soplo son por la insuficiencia Aórtica

45) Paciente de 35 años de edad, consulta por cuadro de 2 días de palpitaciones de dos días de evolución asociado a disnea en algunas ocasiones. Al ingreso se conecta a monitor donde se observa presencia de taquiarritmia irregular de complejo angosto. Al examen físico se encuentra consciente y orientada temporoespacialmente, bien perfundida e hidratada, examen pulmonar normal. La conducta más adecuada en este caso es:

a) Realizar cardioversión eléctrica

b) Indicar enoxaparina y amiodarona

c) Indicar acenocumarol y betabloqueo

d) Indicar heparina de bajo peso molecular y verapamilo

e) Indicar heparina no fraccionada y flecainida

R: Tiene una FA rápida, mayor a 48 horas. Se debe anticoagular y controlar la FC mientras tanto. Siempre se inicia la anticoagulación con heparina (es mejor la de bajo peso). Para controlar la FC tenemos propranolol, digital y verapamilo. Aún así, esta pregunta es muy discutible, ya que por no tener ningún criterio de CHADS2, incluso se podría no anticoagular. Sin embargo no hay que rebuscarse y hay que simplificar la pregunta a ¿cómo se maneja una FA de más de 48 horas?. También se puede criticar la pregunta porque dice 2 días y eso puede ser más o menos de 48 horas: pero en las alternativas no aparece el manejo de una FA de menos de 48 horas (cardioversión farmacológica), por lo que la pregunta debe interpretarse así. Habría que revisar cómo estaba originalmente redactada esta pregunta.

53) Paciente de 67 años, con antecedentes de infarto agudo al miocardio hace 6 meses tratado con stent, hipertensión arterial tratada con enalapril e hidroclorotiazida, y diabetes mellitus tratada con insulina horaria, consulta por cuadro de dos meses de disnea de medianos esfuerzos, asociado a ortopnea y edema de extremidades inferiores que aumenta en las tardes. Al examen cardiopulmonar destaca ritmo regular en dos tiempos sin soplos y murmullo pulmonar presente con crepitaciones bibasales. ¿Cuál de los siguientes es el examen de elección para iniciar el estudio diagnóstico?

a) Electrocardiograma

b) Coronariografía

c) Test de esfuerzo

d) Radiografía de torax

e) Ecocardiograma

R: Tiene una insuficiencia cardiaca, secundaria a cardiopatía coronaria. Hay que pedir la Ecocardiografía, para ver la función ventricular.

62) Un recién nacido de término, presenta cianosis desde su nacimiento, con saturación arterial de 65% con aporte de oxígeno al 100%. Al examen físico destaca murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, soplo sistólico y pulsos presentes. Como parte de su estudio se solicita radiografía de tórax que muestra cardiomegalia y mediastino delgado. El diagnóstico más probable es:

a) Trasposición de grandes vasos

b) Comunicación interauricular

c) Coartación aórtica

d) Canal auriculoventricular

e) Comunicación interventricular

R: Si bien suele no tener soplos, la TGV es la única opción que muestra una cardiopatía cianótica. Además sí tiene el mediastino delgado.

69) Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de inicio agudo de dos horas de evolución caracterizados por palpitaciones y dolor torácico. Al ingreso se conecta a monitor que muestra frecuencia cardiaca de 200 latidos por minutos, regular y QRS angosto. La primera medida para el manejo en este caso es:

a) Realizar presión orcular

b) Realizar cardioversión eléctrica

c) Administrar adenosina endovenosa

d) Realizar masaje carotídeo

e) Administrar verapamilo endovenoso

R: Tiene una TPSV y lo primero son las maniobras vagales, luego la adenosina.

76) Un paciente de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control, refiere estar asintomático. Al examen físico se encuentra presión arterial de 138/83, sin otros hallazgos. Sus exámenes de control muestran hemoglobina glicosilada en 6.9%, índice proteinuria creatininuria de 0.3, creatinina 0.8 mg/mL. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Aumentar dosis de metformina
- b) Iniciar hidroclorotiazida
- c) Iniciar enalapril**
- d) Suspender metformina e indicar insulina
- e) Mantener tratamiento actual y reforzar medidas como dieta y ejercicio

R: Tanto por la PA (mayor a 130/80 dice la guía antigua, sin embargo la nueva lo deja en 140/90), como por la proteinuria positiva (IP/ C mayor a 0,2 es proteinuria). La proteinuria hace que sea 100% segura la opción de darle los IECAS.

85) Paciente de 57 años, hipertenso en tratamiento con losartan y tabáquico, consulta por historia de 3 semanas de evolución de episodios caracterizados por dolor torácico que aparece al caminar por más de 10 minutos, el cual tiene una duración máxima de 5 minutos y luego cede al reposo, no asociado a otros síntomas. Actualmente se encuentra asintomático y su examen físico es normal. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para iniciar su estudio?

- a) Radiografía de tórax
- b) Ecocardiograma
- c) Coronariografía
- d) Electrocardiograma

e) Test de esfuerzo

R: Es una angina de esfuerzo. Si bien hay que pedir un ECG, el TE es el examen para la angina en sí. Además el test de esfuerzo es un ECG y si está malo al inicio, no se prosigue con el examen. En la vida real, sí se pedirá probablemente el ECG, pero se debe simplificar la pregunta, a ¿cómo se estudia una angina estable?... con Test d esfuerzo. Si viniera con soplo, se sospecharía una estenosis aórtica y la respuesta sería Ecografía.

10) Una paciente de 65 años, con antecedente de accidente vascular encefálico con compromiso faciobraquiocrural derecho hace dos años en tratamiento con aspirina, consulta por dolor abdominal difuso e intenso de inicio agudo. Al examen físico se encuentra en regulares condiciones, ritmo irregular, abdomen levemente doloroso a la palpación profunda, blumberg (-) El diagnóstico más probable es:

- a) Isquemia mesentérica**
- b) Disección aórtica
- c) Úlcera perforada
- d) Diverticulitis aguda
- e) Trombosis mesentérica

R: Tiene una embolia mesentérica, secundaria a la FA (ritmo irregular).

12) Paciente de 70 años, con antecedentes de diabetes e hipertensión en tratamiento, con historia de dolor torácico que aparece al esfuerzo y cede espontáneamente, la cual se desencadena cada vez con menor esfuerzo, no asociado a otros síntomas. Actualmente se encuentra asintomático y su examen físico muestra ritmo regular en dos tiempos sin soplos, murmullo pulmonar presente sin ruidos asociados. Se realiza ECG que muestra ritmo regular y QRS ancho compatible con bloqueo completo de rama izquierda. El examen más adecuado para continuar el estudio de este paciente es:

- a) Test de esfuerzo
- b) Ecocardiografía de estrés**
- c) Enzimas cardíacas

- d) AngioTAC
- e) Coronariografía

R: El BCRI inutiliza el Test de esfuerzo y se debe pedir la Eco-dobutamina.

20) Un paciente de 40 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión, asintomático, acude a control con perfil lipídico que muestra colesterol total 208, LDL 127, HDL 35, triglicéridos 230. El fármaco de elección para el tratamiento en este caso es:

- a) Ácido nicotínico
- b) Gemfibrozilo
- c) Ácidos grasos omega 3
- d) Colestiramina

e) Atorvastatina

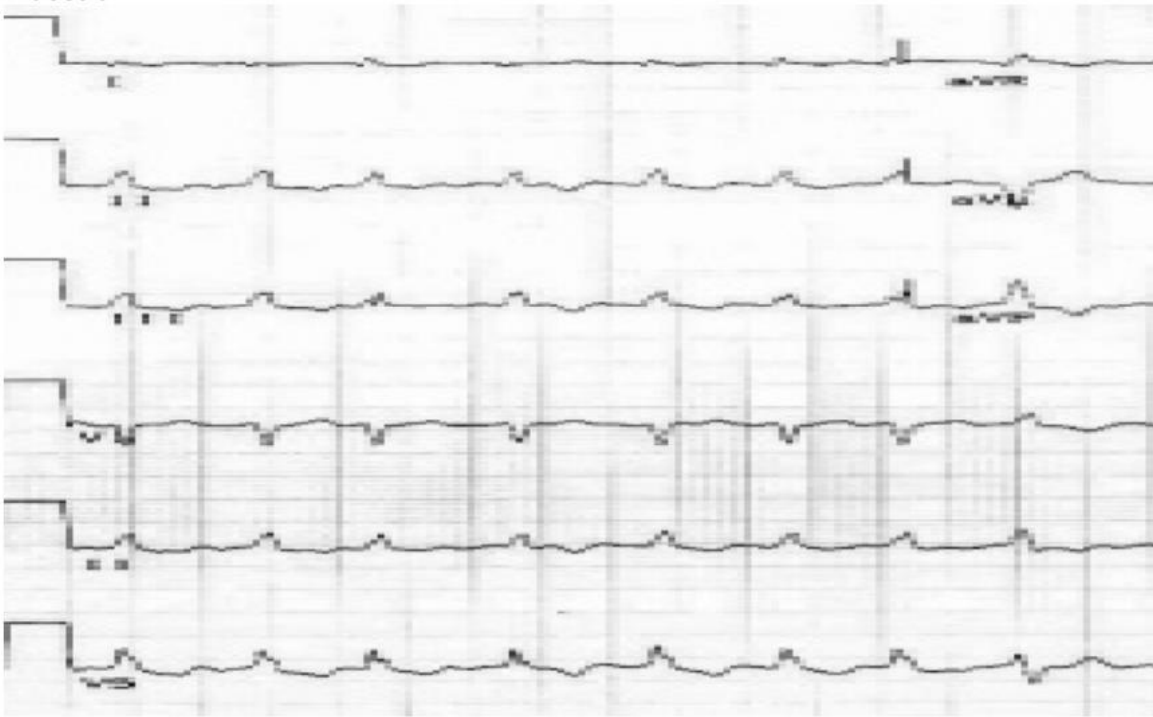
R: Por ser diabético, debe exigirse un LDL menor a 70. El LDL es la prioridad, si los TG están menores a 500. Si los TG hubiesen sido mayores a 500, ahí hubiese sido gemfibrozilo.

35) Un paciente de 55 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 2000mg al día, glibenclamida 15mg al día y enalapril 20mg al día, acude a control con exámenes, donde destaca glicemia de ayuno de 180mg/dL y hemoglobina glicosilada de 8,8%. Se ha mantenido sin síntomas y su examen físico es normal. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Aumentar dosis de glibenclamida
- b) Aumentar dosis de metformina
- c) Iniciar insulina**
- d) Reemplazar metformina con rosiglitazona
- e) Reemplazar glibenclamida con sitagliptina

R: Pregunta muy capciosa: Aún se puede elevar algo la GBC (a 20) y la MTF (a 3.000), pero probablemente tendrá poco efecto, para lo mal controlado que está. Su HbA1c es 8,8%, por lo que es poco probable que baje a 7%, con esas medidas. No estoy 100% seguro de esta respuesta, pero yo marcaría insulina sin dudarlo mucho.

37) Paciente de 60 años con antecedente de hipertensión sin tratamiento, consulta por cuadro de un mes de palpitaciones asociado a disnea ocasional. Al ingreso se realiza electrocardiograma que muestra:



- a) Flutter auricular
- b) Taquicardia sinusal
- c) Fibrilación auricular**
- d) Taquicardia auricular multifocal
- e) Taquicardia ventricular

R: Tanto por la HTA, como porque el ECG se ve la taquicardia irregular, a QRS angosto y ausencia de onda P

60) Paciente de 70 años, con antecedente de EPOC tabáquico, presenta cuadro de 3 meses de aumento de su disnea basal asociado a palpitaciones. Al examen físico destaca frecuencia cardiaca de 100 por minuto, ritmo cardiaco irregular con ausencia de soplos y murmullo pulmonar presente con roncus y sibilancias difusas. Se realiza electrocardiograma que muestra ausencia de onda "p", de forma irregular y presencia de QRS angosto. ¿Cuál de los siguientes fármacos estará contraindicado para el manejo de este paciente?

- a) Verapamilo
- b) Lanantósido C
- c) Losartán
- d) Amiodarona
- e) Carvedilol**

R: Los betabloqueantes empeoran el EPOC (que se trata con beta-agonistas).

82) Paciente de 43 años de edad, con antecedente de migraña en tratamiento con propanolol, consulta por historia de dolor torácico opresivo de 20 minutos, irradiado a miembro superior izquierdo, el cual cede espontáneamente, refiere que ha presentado dicho cuadro en dos ocasiones en su hogar luego de regresar del trabajo. Actualmente está asintomático y su examen físico es normal. Se solicita electrocardiograma que no muestra alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto agudo al miocárdio
- b) Pericarditis aguda
- c) Angina vasomotora**

- d) Espasmo esofágico
- e) Tromboembolismo pulmonar

R: Es una angina vasoespástica de Prinz Metal. Recordar que se diagnostica con pruebas de estimulación con acetilcolina u otros fármacos y se trata con nitroglicerina oral SOS y eventualmente un stent. Recordar además que la causa suele ser ateromatosa igual, ya que ateroma altera la respuesta vasomotora de la arteria coronaria.

83) Lactante de 4 meses de edad, sin antecedentes conocidos, alimentado con lactancia materna de forma exclusiva, es traído por presentar bajo incremento ponderal, asociado a cansancio al alimentarse y decaimiento. Se aprecia decaído, saturación arterial de 90%, examen cardiaco con ritmo regular en dos tiempos, con presencia de soplo sistólico, y pulmonar que muestra murmullo pulmonar disminuido en bases, asociado a crepitaciones finas bilaterales. El manejo inicial más adecuado en este caso es:

- a) Administrar furosemida endovenosa**
- b) Administrar vasodilatadores endovenosos
- c) Administrar epinefrina endovenosa
- d) Realizar intubación endotraqueal y ventilación mecánica
- e) Administrar betabloqueadores endovenosos

R: Hay que hacer una eco por la Cardiopatía congénita. Probable EPA: En lactantes están contraindicados los vasodilatadores, porque empeoran cortocircuito de Izquierda a derecha, al disminuir la resistencia vascular pulmonar. Se prefiere la furosemida

89) Paciente de 17 años, sin antecedentes, es traído a la urgencia por presentar síncope mientras realizaba ejercicio, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia soplo sistólico que aumenta con maniobras de Valsalva, sin otros hallazgos. Se estudia con electrocardiograma que muestra onda Q presente en DII, DIII y AVF, además R profunda de V1 a V3. El diagnóstico más probable es:

- a) Miocardiopatía dilatada
- b) Lipotimia
- c) Soplo fisiológico
- d) Miocardiopatía hipertrófica**
- e) Estenosis mitral

R: Debe decir S profunda. Clínica sí es de MCPHT. Viene con signos de HTVI: S profunda en V1 y V2, R alta en V5, V6. Además tiene ondas T gigantes e invertidas en las precordiales.

JULIO 2015

29) Un paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión y dislipidemia, consulta por dolor en las pantorrillas de dos años de evolución, que aparece al caminar y que le obliga a detenerse, luego de caminar una cuadra. Al examen físico presenta pulso irregular y ausencia de los pulsos pedios de ambas extremidades inferiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Disección aórtica
- b) Aneurisma aórtico abdominal
- c) Insuficiencia venosa
- d) Embolia bilateral de EEII
- e) Enfermedad arterial oclusiva**

R: Que tenga ritmo irregular hace pensar en fibrilación auricular y embolias (isquemia aguda), pero la clínica crónica es más sugerente de enfermedad arterial periférica.

37) Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso, presenta dolor torácico intenso, irradiado al dorso, EVA 9/10. Al examen físico está taquicárdico, con presión arterial es de 160/110, examen cardiaco con RR2T y se ausculta un soplo diastólico en el reborde esternal derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Pericarditis aguda
- c) Infarto agudo al miocárdico con rotura de la pared libre
- d) Infarto agudo al miocárdico con rotura del tabique interventricular

e) Disección aórtica

R: El soplo diastólico (rotura de la válvula aórtica) y la HTA orientan a disección.

38) Un paciente de 70 años, hipertenso, presenta dolor torácico de dos días de evolución, intenso, asociado a malestar general. En las últimas horas se agrega disnea y síncope ortostáticos. Al examen físico aparece un soplo holosistólico en el ápex. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Taponamiento cardiaco por rotura de la pared libre
- b) Disección aórtica

c) Insuficiencia mitral por rotura del músculo papilar

- d) Endocarditis bacteriana
- e) Cardiopatía hipertensiva, descompensada

R: Cuadro clásico (tiene soplo ed insuficiencia mitral y la historia de dolor de 2 días: tuvo un IAM hace dos días y ahora se rompió el músculo papilar).

53) Un paciente hipertenso y diabético se realiza un perfil lipídico, que muestra triglicéridos de 350 mg/dl, colesterol LDL de 230 mg/dl y colesterol HDL de 37. ¿Qué tratamiento debe indicarse?

a) Atorvastatina

- b) Gemfibrozilo
- c) Insulina
- d) Lovastatina más gemfibrozilo
- e) Ezetimibe

R: El LDL es la prioridad (a menos que los triglicéridos estén mayores a 500). Las estatinas están indicadas de inmediato cuando el LDL es mayor a 190 en pacientes de bajo riesgo CV o cuando es mayor a 100 en los diabéticos. Además cuando continúa alto el LDL, a pesar de 3 meses con dieta. Los médicos generales no deben indicar estatinas y gemfibrozilo juntos.

54) Un paciente de 31 años presenta un cuadro de disnea de esfuerzos, ortopnea y astenia. Su presión arterial es 120/70 mmHg y su pulso es de 80x', además presenta edema en las EEII. Presenta desplazamiento del choque de la punta, a dos centímetros de la línea medio-clavicular y se ausculta galope cardiaco, con un soplo sistólico en el ápex, que no varía con la inspiración. Al examen pulmonar tiene crepitos basales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Miocardiopatía hipertrófica
- b) Miocardiopatía dilatada**
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Estenosis aórtica
- e) Estenosis mitral

R: Miocardiopatía dilatada clásica. El soplo que tiene es por insuficiencia mitral, por dilatación del anillo valvular. No aparece insuficiencia mitral en las alternativas (e igual es más probable que sea un MCP dilatada)

55) Un paciente de 82 años ha presentado disnea de esfuerzos y ha presentado síncope, relacionado con actividad física, con recuperación total. Al examen físico presenta presión arterial 120/70 mmHg, FC: 70 x', y a la auscultación cardíaca tiene un soplo paraesternal, de tonalidad ruda, luego del primer ruido, asociada a una disminución marcada del segundo ruido. Además, el choque de la punta se palpa desplazado. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica**
- b) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- c) Estenosis mitral
- d) Insuficiencia mitral
- e) Cardiopatía coronaria

R: Es estenosis aórtica por el síncope y el soplo. Eso sí, la cardiomegalia (desplazamiento del choque de la punta) aparece en estadios muy avanzados.

56) Un paciente de 79 años presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar y que cede con el reposo. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico IV de VI, irradiado a la zona baja del cuello. El examen más adecuado para proseguir con su estudio es:

- a) Prueba de esfuerzo
- b) Electrocardiograma
- c) Coronariografía
- d) AngioTAC de torax
- e) Ecocardiografía doppler**

R: Pregunta difícil. Parece una angina estable, pero en realidad es una estenosis aórtica (por el soplo) y por tanto se debe pedir ecocardio primero

57) Un paciente de 30 años presenta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos. Presenta un soplo sistólico eyectivo, con desdoblamiento del segundo ruido y algunos crépitos pulmonares. Su electrocardiograma muestra un bloqueo completo de rama derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Comunicación interventricular
- b) Comunicación interauricular**
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Tetralogía de Fallot
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

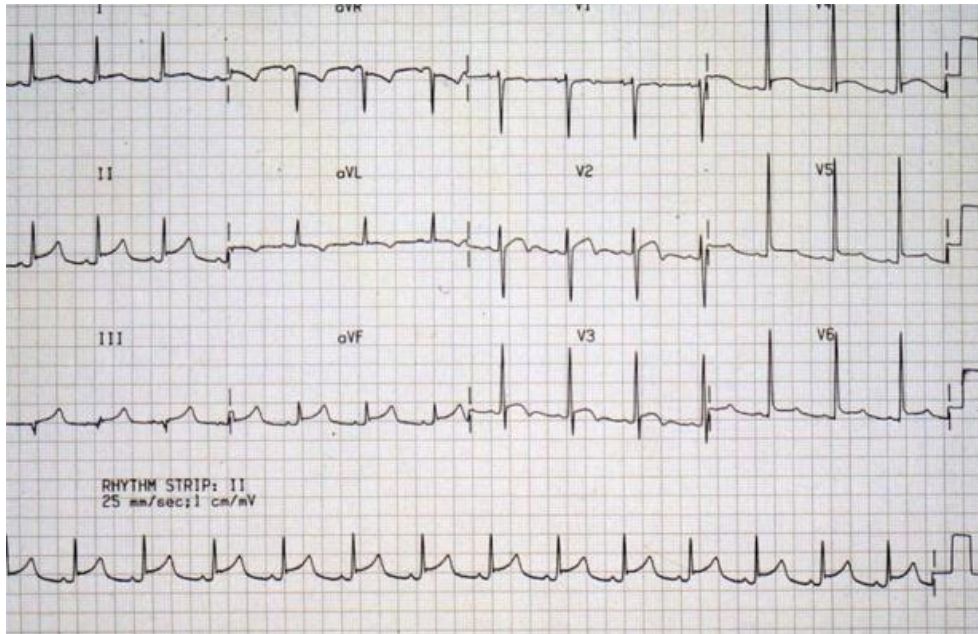
R: Cuadro clásico

58) Un paciente de 62 años, fumador de 30 paquetes años, presenta edema de extremidades inferiores, asociado a astenia, disnea y adinamia. Al examen físico presenta yugulares visibles a 45 grados y aumento de la intensidad del segundo ruido cardíaco. Su electrocardiograma muestra una onda R prominente en V1 más un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Estenosis tricuspídea
- b) Pericarditis constrictiva
- c) Cardiopatía coronaria
- d) Cor pulmonale**
- e) Cardiopatía hipertensiva

R: Cuadro clásico (insuficiencia cardíaca derecha, por HTP, por enfermedad pulmonar (EPOC). Aumento del segundo ruido puede ser por HTP o HTA.

59) Un paciente de 30 años, deportista, pregunta por dolor precordial opresivo, de dos días de evolución, irradiado al cuello y al hombro izquierdo, intenso. Además presenta disnea que aumenta al recostarse. Al examen físico está adolorido, con RR2T sin soplos. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación:

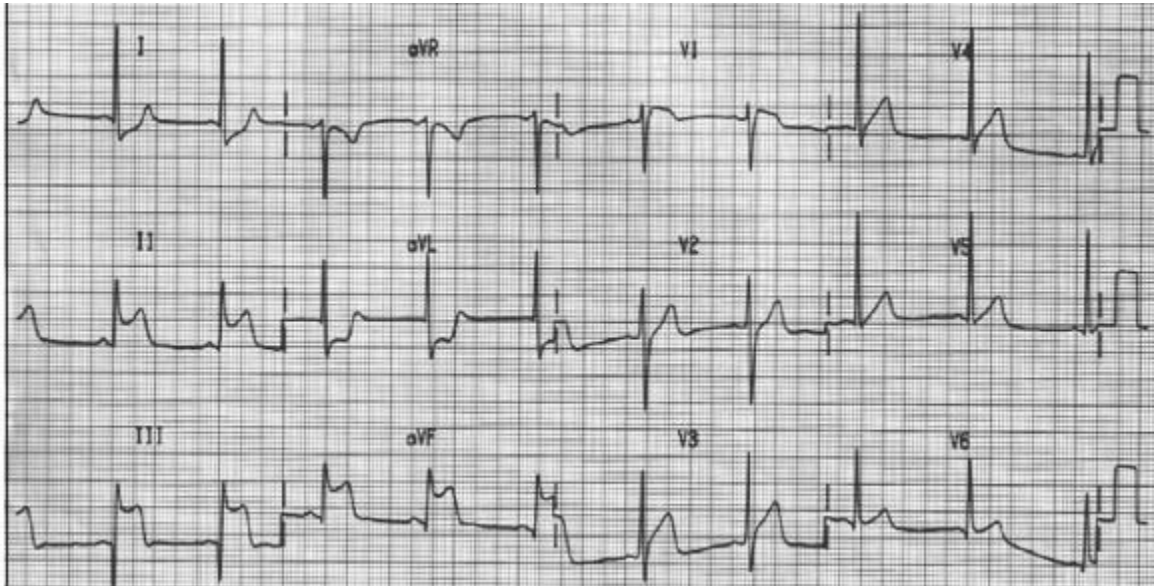


El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Neumotórax
- c) Pericarditis aguda**
- d) Miocardiopatía hipertrófica
- e) Costocondritis del deportista

R: Cuadro difícil. Tiene depresión del PR. En este ECG se ven los SDST, pero en el ECG real solo se veía SDST en V2 y V4. Sí estaba la depresión del PR

60) Un paciente de 60 años presenta dolor precordial, irradiado al cuello, de 4 horas de evolución, EVA 9/10. Al examen físico está sudoroso, disneico, con RR2T, sin soplos. Se solicita un ECG que se muestra a continuación:



¿Cuál es el tratamiento más importante en este paciente?

- a) Anticoagulantes
- b) Revascularización inmediata**
- c) Administración de fluidos intravenosos
- d) Disminuir la presión arterial
- e) Oxigenoterapia y antiarrítmicos

R: Es un IAM con SDST de la pared inferior. Lo más importante es revascularizar.

61) ¿Cuál es el mejor examen para determinar si una insuficiencia cardíaca es de origen isquémico?

- a) Electrocardiograma
- b) Holter de electrocardiograma
- c) Cintigrafía de perfusión miocárdica**
- d) Ecografía bidimensional**
- e) Test de esfuerzo

R: C? D? La verdad es que tanto la Ecocardiografía, como la Cintigrafía de perfusión son útiles para determinar la etiología isquémica de una ICC. La Ecocardiografía verá zonas hipoquinéticas y necrosadas o fibrosadas. La cintigrafía verá las zonas que se isquemizaban con la actividad física.

62) Un paciente diabético de larga data, en tratamiento con insulina, presenta presión arterial de 148/102. Además su índice proteinuria/creatininuria resulta 0,3. ¿Qué fármaco es más adecuado para el manejo de este paciente?

- a) Amlodipino
- b) Enalapril**
- c) Carvedilol
- d) Hidroclorotiazida
- e) Diltiazem

R: Tanto por la HTA, como por la proteinuria se debe iniciar enalapril en el diabético

154) Un niño de 13 años acude a control médico, por una infección respiratoria alta. En su examen físico se ausculta un soplo paraesternal izquierdo, sistólico, de intensidad II/VI, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Soplo inocente**
 - b) Ductus arterioso persistente
 - c) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
 - d) Estenosis aórtica
 - e) Coartación aórtica
- R:** Cuadro clásico

DICIEMBRE 2015

45) Un paciente de 55 años sufrió un accidente vascular encefálico hace un año, consulta por astenia y disnea progresiva, que aparece ante los esfuerzos. Al examen físico presenta FC: 100x', irregular, PA: 120/80 mmHg, crepitaciones pulmonares bilaterales, presencia de un soplo cardíaco diastólico y ambos ruidos cardíacos reforzados. Cuenta con un electrocardiograma, que no muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis mitral**
- b) Estenosis aórtica
- c) Insuficiencia mitral
- d) Insuficiencia tricuspídea
- e) Insuficiencia aórtica

R: Es una estenosis mitral clásica. Además está en fibrilación auricular y por eso tuvo el AVE. El refuerzo del R1 es característico. El refuerzo del R2 se puede deber a HTA. El soplo diastólico es característico. Habitualmente solo se dilata la aurícula izquierda.

46) Un paciente de 18 años ha presentado 2 síncope relacionados con el esfuerzo. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

- a) Cintigrafía de perfusión miocárdica
- b) Ecocardiografía bidimensional**
- c) Monitoreo de presión arterial
- d) Prueba de esfuerzo
- e) TAC de cerebro

R: Lo primero que se debe descartar es una miocardiopatía hipertrófica. De todos modos sí se debe hacer un electrocardiograma y si la ecografía sale normal, se harán otros estudios, como el estudio electrofisiológico.

47) Un paciente de 39 años, diabético y asmático, en tratamiento con metformina y salbutamol inhalado es diagnosticado de hipertensión arterial grado 2, confirmada con monitoreo de presión arterial. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?

- a) Amlodipino
- b) Furosemida
- c) Atenolol
- d) Enalapril**
- e) Hidroclorotiazida

R: Por ser asmático está contraindicado el atenolol (también está relativamente contraindicado en la diabetes). Por ser diabético y también por ser menor de 55 años, el fármaco de elección para iniciar el tratamiento es un IECA.

48) Un paciente de 38 años es diagnosticado de hipertensión arterial, en etapa 1, confirmado con monitoreo de presión arterial de 24 horas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar hidroclorotiazida
- b) Iniciar enalapril
- c) Indicar cambios en el estilo de vida y controlar en 2 meses**
- d) Iniciar atenolol
- e) Pedir un ecodoppler de arterias renales

R: HTA en etapa 1 se trata inicialmente con dieta hiposódica, ejercicios aeróbicos, baja de peso (si obesidad) y el manejo general de sus factores de riesgo vascular. Si en 3 meses no responde, se inician los fármacos en monoterapia.

59) Un paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, consulta por malestar general, asociado a dolor en el flanco izquierdo de dos días de evolución, que inició de forma aguda. Además presenta importante compromiso del estado general. Presenta FC: 101x', PA: 110/70 mmHg, temperatura de 36,0 grados Celsius. Su abdomen es blando, depresible, con dolor a la palpación profunda del flanco izquierdo, sin Blumberg. Además presenta puñopercusión positiva a izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Pielonefritis aguda
- b) Diverticulitis aguda
- c) Infarto esplénico
- d) Isquemia mesentérica
- e) Aneurismo aórtico complicado

R: E (C/A). Tiene la clínica de PNA, pero sin fiebre. Esto se puede deber a que los adultos mayores frecuentemente no hacen fiebre. Sin embargo el cuadro clínico sí es compatible con un infarto esplénico, aunque no tiene los factores de riesgo y es una patología muy infrecuente. En el adulto mayor, todo cuadro similar a un cólico renal obliga a descartar un Aneurisma aórtica abdominal roto.

101) Un niño de 8 años consulta por palpitaciones rápidas e intensa, asociadas a malestar general, disnea y dolor torácico. Al examen físico tiene FC: 200x', presión arterial: 90/60 mmHg. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra en la IMAGEN. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Taquicardia sinusal
- b) Fibrilación auricular
- c) Taquicardia ventricular
- d) Flutter auricular
- e) Taquicardia paroxística supraventricular**

FOTO: Taquiarritmia con QRS angosto, sin onda P, regular, a 200 lpm.

R:TPSV con electrocardiograma clásico. Es frecuente en la edad pediátrica.

102) Un paciente de 40 años consulta por dolor torácico, opresivo intenso, que aumenta al decúbito y con la inspiración. Sus signos vitales muestran FC: 75x', PA: 130/80 mmHg, con RR2T sin soplos y murmullo pulmonar conservado, sin otros ruidos agregados. Se realiza un electrocardiograma, que muestra supradesnivel cóncavo del segmento ST en las derivaciones DI, DII, DIII, AVL, AVF, V4, V5 y V6. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Pericarditis aguda

b) Infarto con supradesnivel del ST

c) Derrame pericárdico

d) Disección aórtica

e) Tromboembolismo pulmonar

R: Es una pericarditis aguda de libro. El ECG es clásico: SDST en "J" en muchas derivaciones.

103) Un paciente de 60 años, con antecedente de insuficiencia renal crónica, consulta por un cuadro de malestar general, asociada a astenia e intolerancia al ejercicio. Al examen físico resenta yugulares ingurgitadas, edema de extremidades inferiores y ruidos cardiacos apagados. Se realiza un electrocardiograma, que muestra disminución difusa de la amplitud de los complejos QRS. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Pericarditis aguda

b) Hipervolemia secundaria a insuficiencia renal

c) Taponamiento cardiaco

d) Infarto agudo al miocardio

e) Síndrome hepatorenal

R: Es un taponamiento, probablemente secundaria a una pericarditis urémica (no es pericarditis aguda). Tiene la hipotensión, la ingurgitación yugular y los ruidos apagados característicos.

104) Un paciente de 55 años, sin antecedente de importancia, consulta por dolor torácico opresivo, intenso, irradiado al cuello. Al examen físico presenta FC: 84x'. PA: 130/85, se ausculta un ritmo cardiaco regular, en dos tiempos, sin presencia de soplos y un examen pulmonar normal. Se realiza un electrocardiograma que muestra infradesnivel del ST en las derivaciones DI, AVL, V5 y V6. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

a) Realizar trombolisis con tenecteplase

b) Realizar angioplastia urgente

c) Realizar cirugía de revascularización coronaria urgente

d) Realizar tratamiento médico del síndrome coronario agudo

e) Indicar aspirina oral y enviar a domicilio

R: Es un síndrome coronario agudo, sin supradesnivel del ST, con un score de TIMI de 1 punto (infradesnivel), por lo que se debe manejar médicamente (Oxígeno, aspirina, clopidogrel, NTG si HTA, heparina, control con troponinas y ECG seriados, etc).

105) Un niño de 6 meses de edad ha presentado múltiples infecciones respiratorias bajas y ha incrementado peso a una tasa más baja de la esperada. Al examen físico se auscultan crepitaciones pulmonares bibasales y un soplo cardiaco holosistólico, en todo el precordio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Comunicación interauricular tipo ostium secundum

b) Comunicación interventricular

- c) Tetralogía de Fallot
- d) Coartación aórtica
- e) Ductus arterioso persistente

R: Las infecciones respiratorias y el mal incremento ponderal orientan a una cardiopatía congénita. El soplo holosistólico es muy sugerente de CIV. La CIA tiene soplo sistólico eyectivo con desdoblamiento fijo del R2. El DAP tiene un soplo continuo o sistodiastólico o en maquinaria. La coartación tiene soplo sistólico eyectivo, con debilidad de los pulsos pedios. La T. Fallot es cianótica.

106) Un paciente de 45 años consulta por disnea de esfuerzos, asociado a ortopnea. En su examen físico presenta FC: 80 lpm, PA: 160/60 mmHg, se palpa un pulso amplio, regular y se ausculta un soplo cardiaco diastólico. Además se palpa desplazamiento del choque de la punta. El diagnóstico más probables es:

- a) Insuficiencia mitral
- b) Estenosis mitral
- c) Insuficiencia aórtica**
- d) Estenosis aórtica
- e) Estenosis tricuspídea

R: Tiene el pulso Celler, el soplo diastólico y la cardiomegalia clásicas de la insuficiencia aórtica.

111) Un paciente hipertenso y diabético, en tratamiento con metformina y enalapril hace 1 mes, consulta por tos seca, intensa de algunas semanas de evolución. Al examen físico presenta signos vitales normales, sin hallazgos patológicos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar test de metacolina
- b) Solicitar espirometría basal y postbroncodilatador
- c) Indicar broncodilatadores inhalados
- d) Suspender el enalapril**
- e) Suspender la metformina

R: Los IECA producen tos, como efecto adverso frecuente. Se deben suspender y reemplazar por un ARA-II (como losartán).

119) En paciente de 60 años, presentó hace un año un infarto con supradesnivel del ST, que es manejado con trombolisis. Evoluciona posteriormente con disnea de esfuerzo, astenia y ortopnea importantes, que limitan su capacidad funcional. Se realiza un electrocardiograma que muestra ondas Q patológicas en la pared anterolateral y su ecocardiograma muestra dilatación del ventrículo izquierdo y fracción de eyección de 35%. De los siguientes fármacos, ¿cuál aumenta la sobrevida?

- a) Digoxina
- b) Enalapril**
- c) Hidroclorotiazida
- d) Amlodipino
- e) Furosemida

R: IECA, betabloqueantes y espironolactona aumentan la sobrevida. En este caso la aspirina también, pero solo por ser coronario. Los digitales y diuréticos solo mejoran los síntomas. El amlodipino está contraindicado por la caída de la fracción de eyección.

146) Un paciente de 62 años presenta pérdida de consciencia, de manera súbita, con caída al suelo, recuperándose por completo a los pocos minutos. Al examen físico se aprecia FC: 46 lpm, sin otras

alteraciones. Se electrocardiograma muestra bradicardia a 45x', con segmento PR fijo y con algunas ondas P no conducentes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado
- b) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado Mobitz 1
- c) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado Mobitz 2**
- d) Bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado
- e) Enfermedad del nodo sinusal

R: ECG clásico. El Mobitz 1 muestra alargamiento progresivo del PR, hasta que no conduce.

JULIO 2016

1) Un paciente hipertenso bien controlado, con antecedente de EPOC, presenta un cuadro de palpitaciones y disnea, siendo diagnosticado de fibrilación auricular. ¿Qué fármaco está contraindicado?

- a) Atenolol
- b) Digoxina
- c) Enalapril
- d) Acenocumarol
- e) Amlodipino

R: El EPOC contraindica los betabloqueadores.

9) Paciente 80 años con antecedente de artrosis en tratamiento con paracetamol 1 gr c/8 horas, con control parcial del dolor. Realiza adecuadamente sus actividades de la vida diaria, usa bastón y sale acompañada. Tiene antecedente de HTA e Insuficiencia cardíaca congestiva en capacidad funcional III. ¿Cuál es el mejor fármaco a agregar para continuar el manejo del dolor?

- a) Ibuprofeno v.o.
- b) Pregabalina v.o.
- c) Ketorolaco v.o.
- d) Lidocaína en parches

e) Tramadol v.o.

R: Si bien los AINES son el tratamiento de segunda línea (paracetamol es de primera), en los pacientes hipertensos (mal controlados) y con insuficiencia cardíaca suelen estar contraindicados, por lo que creo que la respuesta es tramadol (aunque habitualmente son de tercera línea).

14) Una paciente de 53 años, diabética tipo 2, es diagnosticada recientemente de hipertensión. Sus exámenes generales, incluyendo un electrocardiograma, no muestran alteraciones ¿Qué fármaco es más adecuado para su tratamiento?

- a) Atenolol
- b) Hidroclorotiazida
- c) Carvedilol
- d) Amlodipino

e) Enalapril

R: Tanto por ser menor de 55 años, como especialmente por ser diabética, el antihipertensivo de elección son los IECAs (enalapril).

31) Un paciente de 70 años, diabético tipo 2 e hipertenso, en tratamiento con metformina, losartán e hidroclorotiazida, presenta un cuadro de 4 días de vómitos alimentarios y diarrea, evolucionando con malestar general y disminución del volumen urinario. Al examen físico está bradipsíquico, con presión arterial

de 100/50 mmHg, frecuencia cardíaca de 110x'. En sus exámenes de laboratorio destaca creatinina: 2,0 mg/dl, BUN: 78 mg/dl, FeNa: 0,5%, sodio: 130 mEq/L, potasio: 2,0 mEq/L y cloro: 110 mEq/L . ¿Qué fluido debe administrarse inicialmente?

- a) Solución glucosada al 5%
- b) Solución ringer lactato**
- c) Albúmina al 5%
- d) Solución glucosalina isotónica
- e) Solución de bicarbonato al 2/3 molar

R: Lo primero siempre es reponer la volemia y luego preocuparse de los electrolitos. La volemia se repone preferentemente con cristaloides (suero fisiológico y Ringer lactato) y en este caso, por la severa hipokalemia es más recomendable el Ringer. Además, no salía SF dentro de las alternativas.

41) Un paciente de 40 años consulta por un síncope, mientras jugaba fútbol, con recuperación completa. Además refiere disnea de esfuerzos que inició hace 3 meses y que ha aumentado lentamente. Su hermano murió súbitamente a los 25 años. Al examen físico se constata un soplo sistólico eyectivo, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Síndrome de Brugada
- c) Miocardiopatía hipertrófica**
- d) Síndrome disautonómico
- e) Síndrome de QT largo

R: Es una miocardiopatía hioertrófica clásica.

55) Paciente de 63 años, fumador y diabético, que hace una hora comienza con dolor torácico opresivo, intenso, que se irradia a cuello, con diaforesis y sensación de angustia. Se solicita un electrocardiograma, que muestra ritmo sinusal, a 80 lpm, con bloqueo completo de rama izquierda, que no se había visualizado en electrocardiogramas previos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar enzimas cardíacas
- b) Solicitar angiografía pulmonar
- c) Solicitar ecocardiograma transesofágico
- d) Instalar marcapaso externo transitorio
- e) Iniciar terapia de perfusión miocárdica precoz

R: El BCRI es equivalente al SDST en el manejo del infarto, así que se debe reperfundir de inmediato, idealmente con angioplastia (o bien con trombolisis).

86) Un hombre de 40 años consulta por disnea y palpitaciones ocasionales. Al examen físico presenta un soplo sistólico basal, con desdoblamiento fijo del segundo ruido. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Comunicación interauricular**
- b) Ductus arteriosos persistente
- c) Comunicación interventricular
- d) Estenosis aórtica
- e) Estenosis pulmonar

R: Es una CIA clásica, aunque en un adulto.

92) Hombre de 75 años que hace 4 años tuvo un infarto y actualmente presenta palpitaciones intensas y compromiso de conciencia que se recupera después de reanimación cardiopulmonar ¿Qué arritmia debe descartarse en primer lugar?

- a) Fibrilación Auricular
- b) Taquicardia Ventricular**
- c) Taquicardia paroxística supraventricular
- d) Bloqueo A-V de segundo grado mobitz 1
- e) Flutter auricular

R: También podría haber sido una fibrilación ventricular, pero suelen estar precedidas por taquicardias ventriculares. Los infartos son la primera causa, porque se produce un fenómeno de reentrada alrededor de la zona ventricular infartada.

98) Mujer de 56 años cardiópata y con fibrilación auricular crónica, en tratamiento con espironolactona, isosorbide, hidralazina, amiodarona y anticoagulante oral. Inicia hace 6 meses un cuadro de disnea y tos seca. A la exploración pulmonar tiene crépitos bibasales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: FOTO: se ve una radiografía de tórax muy oscura siendo imposible ver con precisión si había o no alteraciones, aunque por la clínica era posible imaginarse un patrón intersticial pulmonar bilateral. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Suspender amiodarona**
- b) Solicitar TAC de tórax
- c) Aumentar diurético
- d) Solicitar ecocardiograma
- e) Solicitar fibrobroncoscopia

R: Si bien es imposible ver bien la radiografía, la historia sugería mucho una fibrosis pulmonar por amiodarona, por lo que se debe suspender.

115) Paciente masculino de 45 años, presenta súbitamente hemiparesia derecha, refiere historia de 2 meses de evolución de astenia, compromiso del estado general y fiebre de predominio nocturno. Al examen físico presenta hemiparesia derecha, fiebre de 37,8 grados celsius y la auscultación cardiaca muestra un ritmo regular en 2 tiempos, con un soplo sistólico IV/VI en el ápex. Su sedimento de orina muestra hematuria microscópica. El diagnóstico más probable es:

- a) Absceso *cerebral*
- b) Tuberculosis meníngea
- c) Meningitis bacteriana
- d) Endocarditis bacteriana**
- e) Leucemia mieloide aguda

R: Tanto el soplo, como los fenómenos embólicos, orientan a EBSA.

117) En un paciente adulto mayor, que presenta síncope, ¿cuál de las siguientes arritmias requiere un marcapaso definitivo?

- a) Fibrilación auricular crónica
- b) Bloqueo auriculoventricular de primer grado
- c) Flutter auricular 2-3 a 1
- d) Enfermedad del nodo sinusal**
- e) Bloqueo completo de rama izquierda

R: La enfermedad del nodo sinusal, sintomática, requiere de marcapasos definitivo. El bloqueo AV requiere ser de tercer grado o de segundo grado Mobitz II, para ser indicación de marcapasos.

147) Una paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con hidroclorotiazida, presenta un cuadro de diarrea y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor profundo, con PA: 80/50 y frecuencia cardíaca de 120x', regular, con sequedad de mucosas. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran natremia: 156. mEq/L, cloremia: 114 mEq/L, potasemia: 3,1 mEq/L, pH: 7,40, bicarbonato: 14 mmol/L, CO2: 20 mmHg. ¿Cuál de los siguientes fluidos se debe administrar en primer lugar?

- a) Suero glucosado al 5% ev
- b) Suero fisiológico al 0,9% ev
- c) Solución de bicarbonato al 2/3 molar ev
- d) Agua por sonda nasogástrica
- e) Sales de rehidratación oral

R: ¿A?. Es una pregunta muy discutible, pero dado el diagnóstico de deshidratación hipertónica, con marcada hipernatremia e hipeclorremia, está contraindicado el suero fisiológico. Debería iniciarse suero glucosalino isosmolar, pero como no aparece en las opciones, el suero glucosado sería el primer fluido a administrar. De todos modos, es un tema muy muy muy controvertido, ya que también es opción, corregir la volemia (con SF o Ringer) y luego corregir la natremia (con suero glucosado), pero la mayoría de las recomendaciones prefieren ser cautelosos en el uso de cristaloides.

163) ¿Cuál es el diagnóstico que se visualiza en el siguiente electrocardiograma? FOTO: muestra un BAVC, con FC: 30x' y QRS angosto y disociación AV.

- a) Bloqueo AV completo
- b) Fibrilación auricular lenta
- c) Bloqueo AV de 2do grado
- d) Bradicardia sinusal
- e) Paro sinusal

R: Es un BAVC clásico.

168) Un paciente de 80 años, hipertenso en tratamiento hace 10 años, consulta por disnea de esfuerzos, que inició hace 6 meses. Al examen físico destaca PA 150/90, ritmo regular, con ausencia del segundo ruido, asociado a soplo mesosistólico III/VI en margen esternal izquierdo, pulso carotídeo de ascenso lento y choque punta en el quinto espacio intercostal izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis mitral
- b) Estenosis aórtica
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Miocardiopatía dilatada

R: Es una estenosis aórtica de libro.

JULIO 2017

8) Paciente de 62 años, diabético diagnosticado hace 5 años en tratamiento con hipoglicemiantes orales, como parte de un chequeo se realiza exámenes de chequeo donde se aprecia creatinina de 0,9mg/dL, hemoglobina glicosilada menor a 7% y un perfil lipídico que muestra triglicéridos de 250 mg/dL, colesterol total de 258 mg/dL,

HDL 52 mg/dL, LDL 156 mg/dL. No presenta síntomas. El tratamiento más adecuado para disminuir su riesgo cardiovascular es:

- a) Fibratos
- b) Estatinas**
- c) Dieta baja en ácidos grasos saturados
- d) Ácido nicotínico
- e) Ezetimibe

R: Por ser diabético, se exige LDL menor a 100 y se inicia atorvastatina con LDL mayor a 70. Dado que los triglicéridos están menores a 500, el LDL es la prioridad y para disminuir el LDL, de elección se usan las estatinas.

24) Una paciente de 27 años, con antecedente de soplo en la infancia, consulta por astenia y disnea que aparece con medianos esfuerzos. Al examen físico presenta edema de extremidades inferiores, ritmo regular en dos tiempos con soplo sistólico intenso asociado a segundo ruido desdoblado permanente, murmullo pulmonar disminuido en bases con crépitos bilaterales. Su electrocardiograma muestra arritmia completa por fibrilación auricular y bloqueo completo de la rama de His.

- a) Comunicación interventricular
- b) Comunicación interauricular**
- c) Estenosis mitral
- d) Estenosis aórtica
- e) Conducto arterioso persistente

R: Es una CIA clásica, aunque diagnosticada en un adulto.

25) Una paciente de 68 años, hipertensa de larga data, consulta por disnea de pequeños esfuerzos, fatigabilidad y palpitaciones irregulares. Al examen físico, su presión arterial es de 100/60 mmHg con frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, irregular, además, presenta ingurgitación yugular y crépitos pulmonares bilaterales. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

¿Qué fármaco está contraindicado en esta paciente?

- a) Verapamilo**
- b) Amiodarona
- c) Lanantósido C
- d) Heparina
- e) Digoxina

R: Es una pregunta discutible, pero al estar algo hipotenso y en Shock cardiogénico, el verapamilo podría agravar el cuadro, por ser un bloqueador del calcio, que producen vasodilatación periférica e hipotensión (aunque el efecto del verapamilo en la circulación periférica es mínimo).

26) Una paciente de 67 años, con antecedente de várices en las piernas con indicación de cirugía, presenta rotura de una de las várices, luego de un traumatismo en la pierna derecha, que produce sangramiento abundante. Al examen tiene FC: 80 latidos por minuto, PA: 120/80 mmHg y se aprecia sangrado profuso del várice roto, en el tercio medio de la pierna. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

- a) Torniquete inframaleolar
- b) Ligadura del cayado de la safena interna
- c) Sutura del várice sangrante**
- d) Escleroterapia variceal
- e) Safenectomía de urgencia

R: Lo más correcto es comprimir la vrice sangrante, elevar la extremidad. Las alternativas que se presenta, exceden los conocimientos de un mdico general, pero la ms aceptable es hacer hemostasia con una sutura simple. Si falla, se procede a la ligadura (B).

35) Un paciente de 60 aos, con antecedentes de hipertensin arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo de 50 paquetes ao, consulta por dolor precordial opresivo y durante la anamnesis presenta compromiso de conciencia, sin respuesta. Al examen no respira y es imposible palpar el pulso carotdeo.

Adems de solicitar ayuda, la conducta ms adecuada es:

- a) Realizar compresiones torxicas**
- b) Realizar intubacin orotraqueal
- c) Dar golpe torxico
- d) Administrar adrenalina intracardiaca
- e) Realizar angioplastia de urgencia

R: Es un paro, por lo que se debe iniciar RCP. Sin embargo, por ser un paro presenciado, est indicado poner primero el desfibrilador, aunque no estaba en las opciones.

46) Un paciente de 62 aos, con antecedentes de dislipidemia y diabetes en tratamiento con dieta e hipoglicemiantes orales, consulta por dolor torxico opresivo irradiado a ambos hombros intenso EVA 9/10, asociado a disnea y sudoracin. Al examen fsico, su presin arterial es 140/70 mmHg con frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto. Presenta RR3T con presencia de R3, murmullo pulmonar presente con crpitos bibasales. Electrocardiograma: SDST en V1-V4. La conducta ms adecuada es:

- a) Tratamiento anticoagulante
- b) Tratamiento antiplaquetario
- c) Solicitar AngioTAC de trax
- d) Ecocardiograma bidimensional

e) Coronariografa de urgencia

R: Es un SCA con SDST, por lo que requiere angioplastia de urgencia (o trombolisis, que no apareca en las opciones, si es que no hay angioplastia). La angioplastia se hace mediante la coronariografa. S se debe dar aspirina (antiplaquetarios), pero lo que se est preguntando es el manejo del SCA con SDST.

60) Un paciente de 65 aos, diabtico e hipertenso, consulta por dolor precordial opresivo intenso, EVA: 9/10, asociado a malestar general y disnea. Al examen fsico con frecuencia cardiaca de 90 por minuto, presin arterial de 150/90 mmHg, al examen cardiaco se ausculta un ritmo regular y tercer ruido. Se realiza estudio con electrocardiograma que muestra supradesnivel del segmento ST en DII, DIII y AVF. Diagnstico ms probable:

- a) Infarto de pared anterior
- b) Infarto de pared inferior**
- c) Pericarditis
- d) Infarto de pared posterior
- e) Infarto de pared lateral

R:DII, DIII y AVF son las derivaciones inferiores.

65) Un paciente de 77 aos, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensin arterial, consulta por dolor abdominal de tipo inespecfico, de 2 meses de evolucin, sin otros sntomas. En su examen fsico se palpa un tumor abdominal de 4 a 5 cm de dimetro, en la zona umbilical, pulstil, sin signos peritoneales.

Cul es el diagnstico ms probable?

- a) Trombosis mesentrica
- b) Tumor de colon**

c) Tumor de páncreas

d) Disección aórtica

e) Aneurisma aórtico abdominal

R:Un tumor pulsátil en esa zona, hace pensar en un AAA. No tiene dolor por lo que no está roto y no puede ser una disección.

70) Un paciente de 45 años, consulta por fiebre de 3 semanas de evolución sin otros síntomas. Al examen físico tiene temperatura 37,8°C, frecuencia cardíaca de 92 por minuto, con presión arterial 120/80mmHG. Al examen cardíaco se ausulta un soplo sistólico en ápex irradiado a dorso. En sus exámenes destacan leucocitos de 12.000/mm³ y PCR 9,6 (valor normal menor a 1,0). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

a) Ecocardiografía bidimensional

b) Resonancia magnética cardíaca

c) Radiografía de tórax

d) AngioTAC de tórax

e) TAC de tórax abdomen y pelvis

R:Se sospecha un endocarditis bacteriana subaguda (mayor a 7 días), por lo que se debe pedir hemocultivos y ecocardiografía.

75) Un niño de 2 años presenta un cuadro de 7 días de fiebre hasta 39 grados, asociado a inyección conjuntival y boca roja con labios partidos, a lo que se agrega un exantema eritematoso generalizado. Al examen, se aprecia decaído, con fiebre de 38,8 grados, presenta adenopatías cervicales y se observa descamación gruesa de los dedos de las 4 extremidades. Se encuentra hospitalizado, recibiendo un tratamiento adecuado. ¿Cuál es la evolución más probable en este paciente?

a) Daño permanente de las arterias coronarias

b) Recurrencia esporádica de los síntomas

c) Resolución completa, sin secuelas

d) Daño vascular periférico generalizado

e) Daño a las válvulas cardíacas

R:Es una enfermedad de Kawasaki y con adecuado tratamiento (IgG ev más aspirina) suele resolverse, sin secuelas.

80) Una paciente de 58 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, consulta por disnea de esfuerzo que ha empeorado en el último tiempo siendo actualmente de mínimos esfuerzos, presentando además edema de extremidades inferiores. Refiere expectoración rosada en algunas oportunidades. Al examen físico se palpa choque de la punta en el 5° espacio intercostal a la altura de la línea media claviclar. La auscultación cardíaca muestra un soplo diastólico de tonalidad ruda, su frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto, irregular. El diagnóstico más probable es:

a) Estenosis mitral

b) Estenosis aórtica

c) Miocardiopatía hipertrófica

d) Insuficiencia aórtica

e) Cardiopatía hipertensiva

R: Es una estenosis mitral clásica, con FA y todo

96) Un paciente de 66 años, hipertenso, cardiópata, en tratamiento anticoagulante por una fibrilación auricular crónica, consulta por dolor abdominal brusco, muy intenso, de 6 horas de evolución. Al examen físico presenta

ritmo irregular en 2 tiempos y abdomen doloroso a la palpación, con signos peritoneales difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trombosis de la vena mesentérica
- b) Hemoperitoneo
- c) Úlcera péptica perforada

d) Embolia mesentérica

- e) Aneurisma aórtico abdominal roto

R: Es una embolia mesentérica clásica, por la FA. Sin embargo, suele cursar sin signos peritoneales al inicio, pero había pasado ya mucho tiempo, por lo que sí aparecen dichos signos.

110) Adulto mayor de 81 años, consulta por pérdida de conciencia súbita con recuperación ad integrum. Al examen físico, presión arterial de 140/90 mmHg, con frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, soplo sistólico eyectivo irradiado al cuello y choque de la punta se palpa en el quinto espacio intercostal. El diagnóstico más probable es:

a) Estenosis aórtica

- b) Miocardiopatía dilatada
- c) Miocardiopatía hipertrófica
- d) Enfermedad coronaria con afectación del sistema excito-conductor
- e) Tromboembolismo pulmonar

R: Tiene el soplo clásico, más los síncope de la estenosis aórtica. Además la edad orienta mucho.

111) Usted controla a una niña de 7 meses de edad, con antecedente de síndrome de Down, con infecciones respiratorias en múltiples ocasiones que han requerido hospitalización y que aún no ha podido duplicar el peso de nacimiento. Al examen físico se ausculta ritmo regular en dos tonos, con soplo holosistólico intenso, irradiado a dorso, asociado a un desdoblamiento del segundo ruido. El diagnóstico más probable es:

- a) Comunicación interauricular tipo ostium secundum

b) Canal auriculoventricular

- c) Atresia tricuspídea
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Comunicación interventricular

R: Es un CAV clásico. Es la cardiopatía clásica del síndrome de Down. Además es una mezcla de CIA (desdoblamiento del segundo ruido), con CIV (soplo holosistólico)

113) Una paciente de 41 años, cursando un embarazo de 13 semanas, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra regurgitación tricuspídea, con presencia de hueso nasal, ductus venoso normal y translucencia nuchal de 1,9 mm (VN: menor a 3 mm). ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

- a) Análisis genético de vellosidad corial
- b) Amniocentesis biopsica

c) Ecocardiograma fetal

- d) Estudio genético de DNA fetal libre en sangre materna
- e) Niveles plasmáticos de HCG y alfafetoproteína

R: Excede lo que debe saber un médico general. Tiene un marcador aislado de aneuploidía (solo tenía la regurgitación mitral, pero estaba normal la translucencia nuchal, había hueso nasal presente y el ductus venoso estaba normal), por tanto, su probabilidad de aneuploidía es baja. Se debería controlar con una nueva Ecografía obstétrica en algunas semanas más. De las opciones que aparecen, el ecocardiograma fetal (que se realizaría después por un subespecialista) podría descartar problemas cardíacos primarios. De las demás opciones, todas

eran análisis genético: en Chile se recomienda la vellosidad corial cuando el riesgo de aneuploidía es alto y el ADN libre fetal cuando es un riesgo intermedio.

151) Paciente de 58 años, con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión y fumador de 40 paquetes año, consulta por un cuadro de tres semanas de evolución de dolor epigástrico opresivo, asociado a disnea y palpitaciones regulares, que lo obligan a detenerse cada 100 metros de caminata y ceden con el reposo. En el examen físico, su presión arterial es 140/90 mmHg, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto regular. El diagnóstico más probable es:

- a) Angina crónica de reciente comienzo**
- b) Fibrilación auricular paroxística
- c) Isquemia cardíaca con arritmia supraventricular
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Cardiopatía hipertensiva

R: La única opción aceptable era la angina de reciente comienzo

174) Una paciente de 25 años, diagnosticada de depresión en tratamiento, hace algunas horas consume múltiples comprimidos de amitriptilina y evoluciona con desorientación, midriasis y taquicardia. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar su enfrentamiento?

- a) Electrocardiograma**
- b) Radiografía de tórax
- c) Creatina fosfoquinasa
- d) Electroencefalograma
- e) Pruebas hepáticas

R: La intoxicación con tricíclicos produce taquicardias ventriculares, que es lo más grave. Por ello, el EKG y la monitorización electrocardiográfica es lo más importante.

DICIEMBRE 2017

1) Una adolescente de 17 años se somete a una evaluación para realizar actividades de alto rendimiento deportivo. Se encuentra asintomática y en su examen físico se pesquisa la presencia de un soplo sistólico de intensidad III/VI en la zona paraesternal izquierda. Su electrocardiograma es normal.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Comunicación interauricular**
- b) Hipertensión pulmonar primaria
- c) Comunicación interventricular
- d) Estenosis mitral
- e) Ductus arterioso persistente

R: Clínicamente parece un soplo funcional, pero aparecía en las alternativas. De las opciones, por la ubicación del soplo, la CIA es la respuesta más aceptable

2) Una paciente de 68 años, con antecedente de diabetes, hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, metformina y aspirina, consulta por un cuadro de palpitaciones, asociado a malestar general y disnea de reposo.

Tiene frecuencia cardíaca irregular de 160 lpm, PA: 85/40 mmHg, extremidades pálidas y frías en la zona distal. Su electrocardiograma muestra una fibrilación auricular rápida.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Administrar amiodarona
- b) Administrar verapamilo
- c) Administrar heparina y clopidogrel

d) Realizar cardioversión eléctrica

- e) Administrar nitritos y morfina

R: Es una FA con hemodinamia inestable y como toda taquiarritmia hemodinámicamente inestable, se debe cardiovertir, de inmediato.

3) Un paciente con antecedente de ser fumador de 30 paquetes año, suspendido hace 5 años, consulta por un cuadro de 24 horas de disnea de mínimos esfuerzos, asociada a intolerancia al ejercicio y malestar general. Al examen físico su PA: 90/60 y su FC: 110x'. Además destacan yugulares ingurgitadas a 45 grados y ruidos cardíacos apagados a la auscultación. Su electrocardiograma muestra disminución difusa del voltaje. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Neumotórax
- c) Derrame pleural
- d) Infarto agudo al miocardio

e) Taponamiento cardíaco

R: Es una clínica de taponamiento clásico

4) Un paciente con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes, usuario de aspirina, metformina, hidroclorotiazida y atorvastatina, presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar 2 cuadras y alcanza un EVA de 5/10. Se solicita un test de esfuerzo que demuestra aparición de un infradesnivel del segmento ST, de 2 mm en las derivadas anteriores. El examen más adecuado para proseguir el estudio es:

- a) Ecocardiograma
- b) TAC de tórax
- c) Ecocardiografía de esfuerzo

d) Coronariografía

- e) Cintigrafía de perfusión miocárdica

R: La angina estable con test de esfuerzo alterado, se estudia con coronariografía.

5) Un paciente de 68 años presenta una fractura de cadera, de la que es operado. Al segundo día, presenta un síncope, que se recupera al a los pocos segundos. Su presión arterial es de 100/60 mmHg y su frecuencia cardíaca es 110. Además satura 91% a FiO2 ambiental. Su examen físico muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados y un ritmo regular en 2 tiempos, sin soplos.

¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio?

- a) Ecocardiograma
- b) Radiografía de tórax

c) AngioTAC de tórax

- d) TILT test

- e) Monitorización electrocardiográfica de 24 horas

R: La sospecha es un TEP.

7) Una paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular, en tratamiento con atenolol, verapamilo y acenocumarol, consulta porque presenta repetidos episodios de malestar, sudoración y

ortostatismo, que duran algunos segundos y revierten espontáneamente. Al examen físico destaca frecuencia cardíaca de 60 lpm, irregular y presión arterial 110/70 mmHg. Su examen cardiopulmonar es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?

- a) Test de esfuerzo
- b) Ecocardiograma
- c) Ecografía doppler de extremidades inferiores
- d) Tilt test

e) Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas

R:La sospecha es una enfermedad del nodo sinusal, en contexto de un síndrome taquicardia/bradicardia (FA + ENS).

8) Un paciente de 50 años, con antecedente de miocardiopatía dilatada, en tratamiento con enalapril, carvedilol y furosemida, presenta disnea que aparece al realizar esfuerzos moderados, asociado a ortopnea. Su examen físico demuestra desplazamiento del choque de la punta, con crepitaciones de ambas bases pulmonares. Además se solicita una ecocardiografía que muestra una fracción de eyección de 24%. ¿Qué cambio recomendaría a este paciente?

- a) Reemplazar la furosemida por hidroclorotiazida
- b) Reemplazar el enalapril por losartán
- c) Reemplazar el carvedilol por atenolol
- d) Agregar hidralazina

e) Agregar espironolactona

R:La espironolactona aumenta la sobrevida en la ICC.

9) Un paciente de 63 años, diabético y dislipidémico, en tratamiento con metformina, atorvastatina y aspirina, se realiza varias tomas de presión arterial, que resultan 170/100 mmHg en promedio. Se realiza exámenes que muestran creatinina: 1,1 mg/dl, proteinuria (+), glucosuria (++), potasemia: 4,0 mEq/L, natremia: 142 mEq/L, glicemia: 115 mg/dl.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar amlodipino
- b) Iniciar hidroclorotiazida
- c) Iniciar enalapril**
- d) Iniciar hidralazina
- e) Iniciar atenolol

R:La HTA en un diabético se trata con IECAs como primera línea. También la proteinuria.

10) Un hombre de 66 años, hipertenso e insuficiente cardíaco, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida, consulta por disnea de grandes esfuerzos, asociada a ortopnea de 2 almohadas y escaso edema de extremidades inferiores. Su electrocardiograma tiene signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuál fármaco es más importante agregar?

- a) Isosorbide
- b) Carvedilol**
- c) Losartán
- d) Furosemida
- e) Hidroclorotiazida

R:El betabloqueo aumenta la sobrevida. El losartán también, pero estaba con enalapril.

11) Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso en tratamiento con dieta, consulta por dolor torácico incitante, intenso, asociado a sudoración y malestar general. Al examen físico está sudoroso, inquieto, con FC:

70x', PA: 120/80 mmHg, RR2T sin soplos. Se solicita un electrocardiograma que muestra un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Qué tratamiento se debe indicar en este momento?

- a) Aspirina y clopidogrel**
- b) Lidocaína y heparina
- c) Morfina y nitritos
- d) Atenolol e hidroclorotiazida
- e) Digoxina y enalapril

R: Es un síndrome coronario agudo. El BCRI es equivalente a un SDST.

12) Un paciente de 75 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor torácico intenso, de inicio súbito, que alcanza un EVA 7/10, de 2 horas de evolución. El dolor tenía una localización retroesternal, pero luego migra a la zona dorsolumbar. Al examen físico destaca disminución de los pulsos de las extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Infarto agudo al miocardio
- b) Aneurisma de la aorta abdominal complicado
- c) Tromboembolismo pulmonar masivo

d) Disección aórtica

- e) Neumotórax

R: Es una disección clásica por la asimetría de pulsos.

13) Una paciente de 40 años, con antecedente de asma e insuficiencia cardíaca, consulta por aumento de su disnea basal, por lo que se realizan algunos exámenes. Se solicita una ecocardiografía, que muestra cardiomegalia, con paredes finas y una fracción de eyección ventricular de 28%. Además se solicitan exámenes de laboratorio que muestran creatinina: 1,8 mg/dl, Na: 140 mEq/L, K: 3,8 mEq/L, Cl: 106 mEq/L.

¿Qué fármaco está contraindicado en esta paciente?

- a) Enalapril
- b) Losartán
- c) Furosemida
- d) Espironolactona

e) Digoxina

R: El asma contraindica los betabloqueantes. La IRC y la caída en la fracción de eyección contraindican los digitálicos.

63) Un paciente de 57 años consulta por un cuadro de 7 días de astenia, malestar general, fiebre hasta 39 grados celsius. Al examen físico tiene un soplo pansistólico III/VI en el precordio izquierdo, además de apreciarse petequias en los pulpejos y alguna petequias subconjuntivales. ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico etiológico?

- a) Ecocardiograma

b) Hemocultivos

- c) Hemograma
- d) Coronariografía
- e) ANA y complemento

R: Es una endocarditis subaguda. Como se pregunta el diagnóstico etiológico, la respuesta son los hemocultivos. Sin embargo, la ecocardiografía, también es un examen importante.

65) Un paciente de 85 años, hipertenso, está en tratamiento con losartan 50 mg/12 horas y amlodipino 2,5 mg/día. Acude a control y refiere múltiples tomas de presión arterial, las que promedian 145/75 mmHg ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Aumentar la dosis de losartán a 100 mg/12 horas
- b) Aumentar el amlodipino a 5 mg/día
- c) Agregar atenolol 12,5 mg/día
- d) Agregar hidroclorotiazida 25 mg/día

e) Mantener el tratamiento

R: Por su edad, está bien controlado, ya que la meta es que sea menor a 150/90 mmHg.

138) Un recién nacido presenta un soplo pansistólico, que se escucha entre el tercer y cuarto espacio intercostal. Además presenta algunas crepitaciones escasas en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Comunicación interauricular
- b) Comunicación interventricular**
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Estenosis mitral
- e) Atresia tricuspídea

R: Es una CIV clásica

153) Una mujer de 35 años desea embarazarse. Como antecedentes es hipertensa, diabética, hipotiroidea y depresiva. Está en tratamiento con enalapril, levotiroxina, fluoxetina, metformina y ácido fólico. ¿Cuál es el consejo preconcepcional más adecuada?

- a) Suspender la metformina
- b) Aumentar la dosis de levotiroxina
- c) Cambiar el enalapril por otro antihipertensivo**
- d) Suspender la fluoxetina
- e) Mantener los medicamentos, sin cambios

R: Por ser diabética, debe recibir dosis de 4 mg de ácido fólico al día. Si bien la recomendación chilena, dice que se prefiere la insulina, por sobre los HGO, la evidencia ha demostrado que tanto MTF, como GBC son tan seguros como la insulina. Además, debe suspender el enalapril y cualquier otro antihipertensivo y cambiarlo por alfametildopa.

JULIO 2018

Un paciente de 61 años, fumador de 31 paquetes años, tosedor, con antecedente de hipertensión arterial presenta un cuadro de disnea de esfuerzo, con edema de extremidades inferiores, que ha progresado en el último tiempo. Al examen físico tiene PA: 158/102 mmHg, FC: 88x', ápex cardíaco no palpable, ritmo regular, con ruidos cardíacos apagados y sibilancias escasas en el examen pulmonar. ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado?

- a. Losartán
- b. Amlodipino
- c. Digoxina
- d. Atenolol**
- e. Espironolactona

R: Como tiene EPOC, están contraindicados los betabloqueantes.

Un paciente de 42 años, con cardiopatía alcohólica, presenta disnea de esfuerzos, ortopnea y disnea paroxística nocturna, que trata con diuréticos. Los síntomas han progresado en el último tiempo ¿Cuál es el fármaco de elección para este paciente?

- a. Enalapril
- b. Diltiazem
- c. Espironolactona
- d. Digoxina
- e. Nitroglicerina

R: El medicamento que más incide en la sobrevida de la insuficiencia cardíaca son los IECA, seguidos del betabloqueo y luego la espironolactona.

Un paciente diagnosticado de diabetes e hipertensión desde hace varios años, mal controlado, evoluciona con disnea de esfuerzos y disnea paroxística nocturna desde hace 8 meses. Actualmente está en capacidad funcional III. Al examen físico se objetiva PA: 160/110 mmHg, FC: 73x', T°:36°C, edema de extremidades inferiores, con signo de fóvea, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales, mayores en las bases; examen cardíaco con ritmo regular en dos tonos, sin soplos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a. Hidroclorotiazida - hidralazina
- b. Amiodarona - digoxina
- c. Bisoprolol - amlodipino

d. Enalapril - furosemida

- e. Acenocumarol - nitroglicerina

R: De las opciones, la más adecuada para el tratamiento de esta insuficiencia cardíaca era el IECA más diurético.

Un paciente de 48 años, con antecedente de que su padre había sufrido un infarto agudo al miocardio a los 50 años, presenta desde hace 10 días, dolor que aparece al caminar 2 cuadras y que desaparece con el reposo. Hace 24 horas presentó el mismo dolor durante el reposo. Su examen físico no presenta alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el estudio en este paciente?

- a. Electrocardiograma de esfuerzo
- b. Ecocardiografía con dobutamina
- c. Coronariografía
- d. Ecocardiograma transesofágico
- e. AngioTAC

R: Pregunta rara, ya que tenía una angina estable, que se estudia con el test de esfuerzo (respuesta correcta) y al mismo tiempo tenía una angina inestable (dolor de reposo), que se maneja como un síndrome coronario agudo, por lo que la coronariografía eventualmente era una opción. Sin embargo, nos inclinamos al test de esfuerzo, por ser lo clásico.

Una paciente de 40 años, consulta por un cuadro, de algunos meses de evolución, de disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a ortopnea y edema de extremidades inferiores. Al examen físico se auscultan crepitaciones pulmonares bilaterales, con un soplo en la zona paraesternal izquierda, en el segundo espacio intercostal. Su radiografía muestra signos de hiperflujo pulmonar, con botón pulmonar prominente. Su electrocardiograma muestra un patrón rSr. El diagnóstico más probable es:

- a. Comunicación interauricular
- b. Dustus arterioso persistente
- c. Estenosis aórtica
- d. Comunicación interventricular
- e. Insuficiencia aórtica

R: Era una clásica CIA del adulto, con toda su clínica, excepto el desdoblamiento fijo del R2.

Un niño de 4 meses, sin control presenta episodio de marcado decaimiento, dificultad respiratoria y cianosis desde hace 3 horas, por lo que sus padres lo llevan a urgencia. Al examen físico llama la atención cianosis

generalizada y presencia de frémito cardíaco al palpar el tórax, con examen cardíaco en que se ausculta un soplo de intensidad IV/VI en la zona paraesternal izquierda. El diagnóstico más probable es:

Selecione una:

- a. Atresia tricuspídea
- b. Tetralogía de Fallot**
- c. Ductus arterioso persistente
- d. Comunicación interauricular
- e. Atresia tricuspídea

R: Por tener cianosis, nos inclinamos a la T. Fallot.

Un paciente de 64 años, con antecedente de un infarto al miocardio hace 8 meses, consulta por dolor torácico de 40 minutos de duración, asociado a palpitaciones. Al examen físico presenta PA: 90/60, FC: 200x' y se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación:

El diagnóstico más probable es:

- a. Taquicardia paroxística supraventricular
- b. Flutter auricular con bloqueo 1:1
- c. Fibrilación auricular con aberrancia

d. Taquicardia ventricular

- e. Arritmia asociada a síndrome de Wolff Parkinson White

R: Si bien el EKG original se parecía mucho a una FA con Sd. de WPW, el antecedente de un IAM antiguo y la taquicardia con QRS ancho, hace que la respuesta sea una taquicardia ventricular.

Un niño de 11 años, presenta un cuadro de 2 horas de evolución de disnea y dolor torácico. Su frecuencia cardíaca es 200 a 240 lpm, PA: 120/80. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación:

La conducta inicial es:

- a. Aplicar hielo en el abdomen
- b. Adenosina endovenosa
- c. Amiodarona endovenosa
- d. Compresión del seno carotídeo**
- e. Verapamilo endovenoso

R: La primera medida frente a las TPSV son las maniobras vagales.

Un paciente de 18 años, con antecedente de prótesis cardíaca valvular, consulta por malestar general, asociado a fiebre y artralgias. Al examen físico tiene FC: 100x', PA: 120/82 mmHg, T°:38,8°C y se ausculta un soplo sistólico III/VI más un soplo diastólico II/VI en el precordio. Su hemograma muestra leucocitosis de 12.000 por mm³, con 70% de neutrófilos y VHS:50 mm/h. ¿Qué examen es más adecuado para el estudio de este paciente?

a. Ecocardiografía

- b. Radiografía de tórax
- c. Punción lumbar
- d. Proteína C reactiva
- e. Cateterismo cardíaco

R: La endocarditis aguda se diagnostica principalmente con la clínica más la ecocardiografía y los hemocultivos.

Una paciente de 81 años consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a paroxística nocturna y ortopnea. Al examen físico se objetiva PA: 160/60 mmHg, con pulso regular, amplio, a 72 lpm. Su examen cardíaco muestra desplazamiento del choque cardíaco, con presencia de un soplo intenso, entre el segundo y el primer ruido cardíaco, que se irradia al cuello. El examen pulmonar muestra crepitaciones escasas, en ambas bases. El diagnóstico de sospecha es:

- a. Insuficiencia tricuspídea
 - b. Estenosis aórtica
 - c. Insuficiencia aórtica**
 - d. Estenosis mitral
 - e. Insuficiencia mitral
- R:** Es una insuficiencia aórtica clásica.

Un paciente de 52 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, consulta por dolor torácico y abdominal, intenso, de carácter opresivo, irradiado al cuello. Al examen físico está taquicárdico, con PA: 150/110 mmHg, con RR2T sin soplos. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Isquemia anterior
- b. Miopericarditis aguda
- c. Infarto inferolateral**
- d. Infarto agudo al miocardio de pared anterior
- e. Espasmo esofágico

R: Los SDST de DII, DIII y AVF dan cuenta de un infarto inferior. Los SDST de V5 y V6, lo hacen respecto al infarto lateral.

Una paciente con antecedente de fibrilación auricular paroxística, la que trata con amiodarona, digoxina, enalapril e hidroclorotiazida, desde hace 6 meses. Evoluciona desde hace 1 mes, con disnea, ortopnea y palpitaciones. Además, refiere baja de peso de 4 kilogramos y temblor. Actualmente está en fibrilación auricular, con FC: 112 x', se auscultan crépitos pulmonares bilaterales y su radiografía de tórax muestra congestión pulmonar, con líneas B de Kerley. El diagnóstico más probable es:

- a. Insuficiencia cardíaca secundaria a cardiopatía coronaria
 - b. Cardiopatía isquémica
 - c. Hipertiroidismo por amiodarona**
 - d. Intoxicación por digitálicos
 - e. Tromboembolismo pulmonar crónico
- R:** Es un hipertiroidismo clásico y la amiodarona lo explica perfectamente.

Una paciente de 94 años, hipertensa, es autovalente y tiene vida social activa. Acude a un control médico, siendo diagnosticada de fibrilación auricular, con FC: 80 lpm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Antiagregantes
 - b. Acenocumarol**
 - c. Ecocardiografía transesofágica
 - d. Ecocardiografía transtorácica
 - e. Solicitar un electrocardiograma de 24 horas
- R:** Es una FA crónica y tiene 2 puntos del CHAD2, así que se debe anticoagular.

Una paciente de 72 años, con antecedente de insuficiencia renal crónica e hipertensión, en tratamiento farmacológico, presenta dolor precordial de 2 horas de evolución, asociada a síncope y afectación del estado general. Al examen físico tiene FC: 43 lpm, PA: 90/60 mmHg. Su electrocardiograma muestra ondas T altas y picudas, en todas las derivaciones.

¿Cuál es la indicación más urgente?

- Seleccione una:
- a. Bicarbonato de sodio
 - b. Ringier

c. Gluconato de calcio

d. Cloruro de potasio

e. Suero fisiológico

R: Tiene una hiperkalemia severa, con compromiso electrocardiográfico, por lo que se debe administrar calcio, como primera medida, para evitar las arritmias malignas.

2013

24) Paciente de 20 años, con antecedente de rinitis alérgica y usuaria de anticonceptivos orales, con historia de disnea y tos seca al realizar ejercicios, no asociado a otros síntomas. Actualmente asintomática y su examen físico es normal. El examen de elección para el diagnóstico de esta paciente es:

- a) Test de esfuerzo
- b) Test de metacolina**
- c) Prick test
- d) Espirometría
- e) PEF

R: Por ser un asma sin clínica actual, no servirá ni el PEF ni la espirometría. Esta pregunta también es muy discutible, ya que el diagnóstico de asma es clínico y los demás exámenes solo son de apoyo diagnóstico. Además en la mayoría de los libros, guías y recomendaciones se prefiere hacer espirometría y solo solicitar las demás pruebas ante la duda diagnóstica. Sin embargo, el eunacom ha preguntado esto varias veces y ante un examen totalmente normal y clínica muy leve, la espirometría resulta normal y no sirve. Además el test de metacolina es una espirometría, pero en la cual se nebuliza con dosis crecientes de metacolina, para producir la broncoconstricción y medir la reactividad bronquial.

35) Un lactante de 10 meses de edad, sin antecedentes, mientras come su almuerzo comienza súbitamente con tos asociado a disminución del esfuerzo respiratorio e hipotonía. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Iniciar reanimación cardiopulmonar
- b) Exploración digital de su cavidad oral
- c) Iniciar presión digital en epigastrio
- d) Dar golpes en la espalda**
- e) Iniciar ventilaciones boca a boca

R: Es un cuerpo extraño laríngeo obstructivo en un niño menor de 1 año, por lo que se deben dar 5 golpes en la espalda. Si no funciona, se hacen 5 compresiones en el pecho y luego se repiten los golpes en la espalda y así sucesivamente. Sobre el año se hace Heimlich.

48) Un paciente de 6 años, con historia de 5 días de odinofagia intensa asociada a secreción purulenta y sensación febril que durante el último día se acompañó de rash papular eritematoso que es más intenso en pliegues. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

- a) Hemograma
- b) IgM para virus Epstein barr
- c) Panel viral
- d) Cultivo de secreción faríngea**
- e) Test pack para Streptococo grupo A

R: Es una escarlatina y el diagnóstico es clínico. No hay que pedir ningún examen, por lo que esta pregunta está técnicamente mala. El cultivo faríngeo es el goldstandard, pero demora. La verdad es que no estoy 100% seguro de que esta sea la respuesta correcta, ya que al igual que en el Herpes, el diagnóstico es clínico y el gold standard es el cultivo. Eso sí, el test pack tiene el resultado es inmediato y hay que iniciar antibióticos ahora (de hecho hay que iniciarlos porque ya está hecho el diagnóstico, porque es un diagnóstico clínico). Lo más razonable es simplificar la pregunta a ¿cuál es el examen para la escarlatina? y responder cultivo. Además, en algunas recomendaciones de expertos se dice que el cultivo se debe pedir siempre, sin embargo, la mayoría de las recomendaciones dicen que el diagnóstico es clínico.

49) Paciente de 34 años, consulta por cuadro de un mes de compromiso del estado general, tos persistente con expectoración mucopurulenta y en dos ocasiones hemoptóica. Al examen físico destaca sudoroso, frecuencia cardiaca de 60 por minuto, presión arterial de 120/70, examen cardiaco normal y pulmonar con murmullo presente, crepitaciones y sibilancias difusas mayores en ápice izquierdo. El examen más adecuado para el diagnóstico en este caso es:

- a) Baciloscopías seriadas**
- b) Prueba cutánea de tuberculina
- c) Radiografía de tórax
- d) TAC de tórax multicorte
- e) Hemocultivo

R: Sospechar una TBC. Se estudia con BK. La Rx hay que pedirla igual, pero BK es la respuesta.

52) Un paciente de 23 años sufre una puñalada en región supraclavicular izquierda, dos días después consulta por disnea y tope inspiratorio. Al examen físico está en regulares condiciones y decaído, en su examen pulmonar se encuentra disminución del murmullo pulmonar izquierdo. Se solicita radiografía de tórax que es compatible con derrame pleural ipsilateral. Se realiza toracocentesis que da salida a líquido blanco. El diagnóstico más probable es:

- a) Empiema
- b) Derrame paraneumónico
- c) Hemotórax
- d) Quilotórax**
- e) Neumotórax

R: Quilotórax de libro. Su primera causa es traumático. Además el ducto torácico está en el lado izquierdo

64) Mujer de 58 años, fumadora e hipertensa, consulta por historia de un año de disnea de esfuerzos moderados y tos seca, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca acropaquia y al examen pulmonar murmullo pulmonar disminuido bilateral con presencia de crépitos gruesos difusos. Se solicita radiografía de tórax que muestra imagen en panal de abejas. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- b) Tuberculosis
- c) Enfermedad pulmonar intersticial difusa**
- d) Cáncer pulmonar
- e) Tromboembolismo pulmonar crónico

R: Es una fibrosis pulmonar.

74) Un paciente de 9 años, es traído por presentar cuadro de 2 días de compromiso del estado general, mialgias, artralgias, tos y fiebre, que durante las últimas horas se agregó cefalea. Al examen físico se encuentra decaído, frecuencia cardiaca de 100 por minuto, frecuencia respiratoria de 22 por minuto, examen pulmonar normal. El agente etiológico más probable es:

- a) Adenovirus
- b) Streptococo pneumoniae
- c) Mycoplasma
- d) Virus influenza A**
- e) Virus respiratorio sincicial

R: Tiene el cuadro de cefalea, tos, fiebre y mialgias.

80) Paciente de 18 años, sin antecedentes mórbidos, es traído al servicio de urgencias por cuadro de dolor en hemitórax izquierdo de inicio súbito irradiado a miembro superior ipsilateral, asociado a disnea leve, el cual

inició mientras jugaba un partido de basquetbol. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones y a la auscultación pulmonar destaca disminución del murmullo pulmonar en hemitórax izquierdo, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Angina inestable
 - b) Tromboembolismo pulmonar
 - c) Neumotorax espontáneo**
 - d) Perforación esofágica
 - e) Contractura muscular
- R: Clínica muy sugerente de neumotórax

5) Paciente de 55 años, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaquismo, es derivado desde servicio de urgencia rural por aumento de su disnea basal, asociado a sensación febril y luego confusión, al ingreso en nuestro centro se solicitan gases arteriales que muestran pH 7.3, PaCO₂ 80, PaO₂ 86 con FiO₂ al 100%. En su examen físico destaca sopor superficial, murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, con sibilancias difusas y crepitaciones en base pulmonar izquierda. La medida más adecuada en este momento es:

- a) Administrar hidrocortisona en bolo
- b) Nebulizar con salbutamol
- c) Administrar ceftriaxona
- d) Intubar e iniciar ventilación mecánica**
- e) Disminuir el aporte de oxígeno a 24%

R: Tiene una encefalopatía hipercárbica. Se va a VMI. El CO₂ mayor a 65 también es indicación de ventilación mecánica. El BiPAP (VMNI) es una buena opción, pero si está encefalópata, se prefiere la VMI

17) Paciente de 23 años, sin antecedentes, con cuadro de 2 semanas de rinorrea y coriza, que durante los últimos dos días se asocia a compromiso del estado general, sensación febril, tos con expectoración mucopurulenta y disnea. Al examen físico presenta signos vitales dentro de rangos normales, murmullo pulmonar presente en ambos campos pulmonares asociado a crepitaciones en base derecha. Se solicita una radiografía de tórax que muestra infiltrado intersticial en base derecha. El tratamiento de elección de esta patología es:

- a) Claritromicina**
- b) Amoxicilina-ácido clavulánico
- c) Clindamicina
- d) Ceftriaxona
- e) Moxifloxacino

R: Por llevar dos semanas, sospechar mycoplasma. También por el compromiso intersticial. El moxifloxacino sí lo cubre, pero su espectro es muy amplio: cubre también anaerobios. Levofloxacino sí habría sido una respuesta correcta. Todos los macrólidos lo cubren bien y son de elección en los niños, que no pueden usar quinolonas y también en los adultos, en particular la azitromicina, que se toma por menos tiempo.

19) Una paciente de 55 años, en quimioterapia por leucemia mieloide aguda, inicia desde hace algunas horas fiebre alta, cefalea y dolor al movimiento ocular, refiere haber estado en contacto con su hijo que cursaba con cuadro respiratorio alto. Se realiza exámenes donde destaca hemoglobina 8.5 mg/dL, leucocitos 1.000/mm³ (10% neutrófilos 90% linfocitos) y plaquetas 80.000/mm³. La conducta más adecuada frente a esta paciente es:

- a) Indicar manejo sintomático
- b) Indicar Ceftazidima con amikacina endovenosas**
- c) Indicar anfotericina B endovenoso

d) Indicar oseltamivir endovenoso

e) Indicar aislamiento e iniciar ceftriaxona endovenosa

R: Es una neutropenia febril. Se trata con doble cobertura para pseudomona. En los casos en que se sospeche stafilococo, además se deja cloxa y si lleva más de 10-14 días, se agrega cobertura para aspergillus.

30) Paciente de 65 años de edad, fumador de 40 paquetes/año, consulta por disnea progresiva asociada a tos con expectoración escasa mucosa. Al examen físico se aprecia disminución de murmullo pulmonar en base pulmonar izquierda. Se solicita radiografía de tórax que muestra derrame pleural en lado izquierdo, el cual se punciona mostrando LDH 250 mg/dL, 300 leucocitos (95% mononucleares) y ADA en 25. El diagnóstico más probable es:

a) Insuficiencia Cardíaca

b) Derrame pleural maligno

c) Tuberculosis

d) Tromboembolismo pulmonar

e) Enfermedad del tejido conectivo

R: Exudado mononuclear con ADA baja. Es cáncer

49) Paciente de 60 años, fumadora de 30 paquetes año, consulta por compromiso del estado general y baja de peso. Su examen físico es normal, se solicita radiografía de tórax que muestra lo siguiente:



La conducta más adecuada en este caso es:

a) Solicitar TAC de tórax

b) Realizar punción transpleural

c) Instalar tubo pleural con trampa de agua

d) Realizar toracocentesis diagnóstica

e) Realizar broncoscopía rígida

R: Tiene un nódulo pulmonar solitario parahiliar derecho. Lo primero es el TAC. Luego será la Bx transbronquial, mediante broncoscopía. Si hubiese tenido radiografías previas, lo primero habría sido revisarlas, antes del TAC.

61) Un paciente de 13 meses, es traído por presentar desde hace 4 días cuadro caracterizado por crisis de tos que aparecen de forma repetitiva durante el día, asociado a decaimiento, rechazo alimentario, náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecia hemorragia subconjuntival derecha, examen pulmonar con murmullo pulmonar presente, sin otros hallazgos. El agente etiológico más probable en este caso es:

- a) Virus respiratorio sincicial
- b) Virus parainfluenza
- c) Mycoplasma
- d) Bordetella pertusis**
- e) Virus sarampión

R: Es un coqueluche de libro

62) Una paciente de 18 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, coriza y odinofagia. Al examen físico destacan amígdalas aumentadas de tamaño con exudado blanquecino adherente, adenopatías cervicales, examen pulmonar normal y abdominal con hepatoesplenomegalia. Se solicitan exámenes que muestran lo siguiente: IgM VCA (+), IgG VCA (-), IgM CMV (-), IgG CMV (+), ELISA VIH (-). El diagnóstico más probable es:

- a) Primoinfección por VIH
- b) Mononucleosis por Citomegalovirus
- c) Mononucleosis por Virus Epstein Barr**
- d) Síndrome mononucleósico por estreptococo pyogenes
- e) Síndrome mononucleósico por leucemia aguda

R: Tiene la IgM VCA positiva

66) Paciente de 66 años, hipertenso en tratamiento, consulta por cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, síntomas que se han hecho más intensos en las últimas horas agregándose cefalea y mialgias intensas. Su examen físico muestra temperatura de 38,5°C, examen pulmonar sin alteraciones. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:

- a) Acetaminofeno**
- b) Oseltamivir
- c) Claritromicina
- d) Zanamivir
- e) Ibuprofeno

R: Es una influenza (adulto mayor). Mayor de 60 años es indicación de oseltamivir. Sin embargo el tratamiento de elección para la influenza es el tratamiento sintomático, además que lleva 3 días, por lo que el oseltamivir es menos efectivo. Ambas son respuestas correctas. Es una pregunta muy discutible, pero si la pregunta es cuál es el tratamiento de la influenza, la respuesta es: paracetamol. No les puedo prometer que esta haya sido la respuesta.

Lean las páginas 6 y 7 del siguiente link: http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/GUIA%20CLINICA%20INFLUENZA%202014_imprimir.pdf

67) Un paciente de 7 años, con historia de 8 días de tos y coriza, sin otros síntomas, presenta desde hace 24 horas aumento de su tos asociado a expectoración mucopurulenta, dificultad respiratoria y sensación febril. Al examen físico se encuentra decaído, con temperatura de 38°C, su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente de forma bilateral, asociado a estertores y sibilancias difusas. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Claritromicina**
- b) Amoxicilina
- c) Amoxicilina con ácido clavulánico

- d) Acetaminofeno y salbutamol
 - e) Cefadroxilo
- R:** Es una NAC atípica

76) Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de 2 días de odinofagia, asociado a tos seca y rinorrea, que durante el primer día se asoció a sensación febril. Al examen físico se encuentra con temperatura de 36,8°C, faringe eritematosa, amígdalas aumentadas de tamaño con escaso exudado blanquecino, examen cardiopulmonar normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Amigdalitis pultácea
- b) Influenza
- c) Rinofaringitis aguda**
- d) Coqueluche
- e) Adenovirus

R: Tiene una infección respiratoria alta, con signos virales: tos, rinorrea. Si bien tiene exudado (orienta a adenovirus), no hay mayores indicios que sea por adenovirus (si hubiese conjuntivitis viral sí sería adenovirus). Es seguro que hay una rinofaringitis viral

JULIO 2015

32) Un paciente de 28 años sufre una puñalada en el tórax, en el lado derecho. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor torácico y presenta disminución del murmullo pulmonar, asociado a hipersonoridad a la percusión en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Pedir radiografía de tórax**
- b) Pedir resonancia magnética de tórax
- c) Instalar un tubo pleural
- d) Solicitar TAC de tórax
- e) Realizar videotoracoscopia

R: Tiene una probable herida penetrante de tórax, con un neumotórax traumático. No tiene clínica de neumotórax a tensión, así que no hay que puncionar el segundo espacio intercostal. Lo primero siempre es pedir la radiografía de tórax, tanto para ver el grado del neumotórax, como para descartar otras complicaciones (ej: hemotórax).

40) Un paciente es sometido a una colecistectomía y a las 24 horas presenta fiebre hasta 38,3 grados celsius. Su examen físico muestra un paciente febril, con crepitaciones en la base pulmonar derecha, asociado a roncus. Tiene vías venosas in situ, sin eritema y su herida quirúrgica está cerrada, sin exudado ni eritema. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Neumonía
- c) Atelectasia**
- d) Infección de la herida operatoria
- e) Infección asociada a catéter

R: Atelectasias son la primera causa de fiebre postoperatoria en las primeras 24 horas y la clínica es absolutamente concordante (crepitaciones localizadas, etc).

63) Un paciente de 40 años, hospitalizado hace 3 días por un síndrome nefrótico, presenta disnea, de inicio súbito. Presenta desaturación arterial hasta 90%, con disminución del murmullo pulmonar a derecha y matidez, por lo que se realiza una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural. Se punciona el derrame, dando salida a un líquido hemorrágico, con LDH: 700, predominio de polimorfonucleares, pH: 7,3 y

lactato de 4,0 mmol/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Empiema
- b) Derrame paraneumónico simple
- c) Tromboembolismo pulmonar**
- d) Transudado pleural
- e) Compromiso pleural maligno

R: El exudado hemorrágico orienta a TEP. También el Sd. nefrótico, que se complica con TEP. También el inicio súbito.

129) Un niño de 7 años de edad presenta un cuadro de fiebre y odinofagia, asociado a malestar general. Al examen físico presenta faringe congestiva, con exudado amigdalino bilateral y se palpa adenopatía cervical, por lo que se inicia amoxicilina oral. Dos días después evoluciona con un exantema, que se muestra en la FOTO. El diagnóstico más probable es:



NOTA: la foto original era de un niño, pero el exantema es muy similar a este (fue la foto más parecida que hallé en Google)

- a) Escarlatina
- b) Reacción alérgica a la amoxicilina
- c) Eritema multiforme menor
- d) Artritis reumatoide juvenil
- e) Mononucleosis infecciosa**

R: Tiene la clínica de mononucleosis clásica. El rash post-ampicilina es clásico también.

131) Un paciente de 8 años presenta un cuadro de odinofagia de un día de evolución, intenso, asociado a fiebre. Al examen físico tiene faringe congestiva, con exudado amigdalino bilateral y presencia de una adenopatía cervical. Su hermano menor está en tratamiento por escarlatina confirmada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar amoxicilina oral**
- b) Solicitar test pack para estreptococo
- c) Solicitar cultivo faríngeo
- d) Solicitar IgM para virus Epstein Barr
- e) Indicar tratamiento sintomático

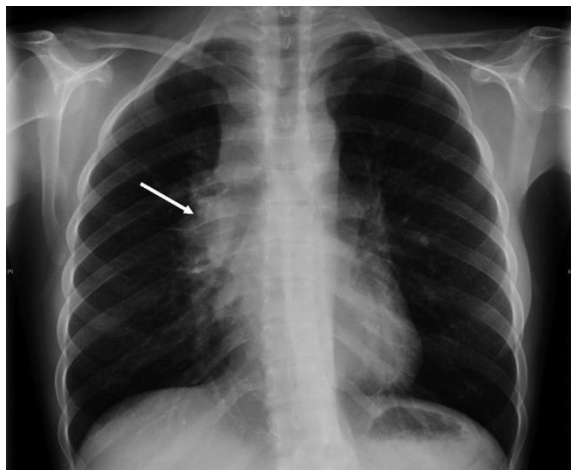
R: Es una amigdalitis pultácea (por *Streptococcus pyogenes*). No tiene nada que oriente a etiología viral. La escarlatina del hermano es por el mismo agente, lo que hace sospecharla aún más. Se debe tratar, por la alta probabilidad de que sea pultácea.

135) Un paciente de 55 años, fumados de 30 paquetes-año, consulta por disnea de esfuerzos, progresiva. Su examen físico no muestra alteraciones. Se solicita una radiografía de tórax, que no muestra alteraciones y se realiza una espirometría, que muestra un VEF1 de 60%, que no mejora con broncodilatador. El diagnóstico más probable es:

- a) Bronquitis crónica
- b) Hipertensión pulmonar
- c) EPOC**
- d) Asma
- e) Fibrosis pulmonar

R: Si bien el Dg. de EPOC se hace con la relación VEF1/CVF (menor a 70%), el VEF1 bajo orienta mucho. Que no mejore con broncodilatador descarta asma y orienta a EPOC. La pregunta en sí está mala, pero probablemente será EPOC la respuesta correcta

136) Un paciente de 60 años, hipertenso, fumador de 25 paquetes-año, consulta por tos de algunos meses de evolución. Su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Se realiza radiografía que se muestra a continuación.

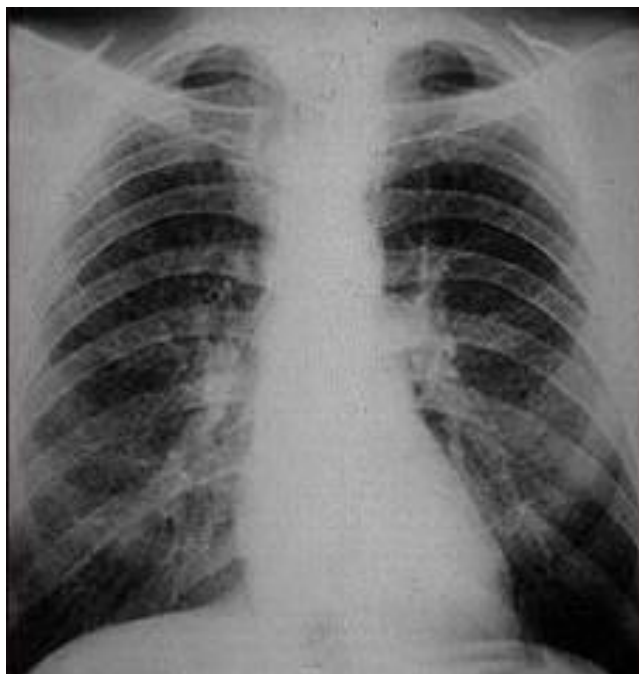


NOTA: la foto original no mostraba nada categórico. Era similar a la que se muestra, pero no tenía flecha.

- a) Cáncer**
- b) Tuberculosis pulmonar
- c) Fibrosis pulmonar
- d) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- e) Cardiopatía hipertensiva

R: La radiografía no mostraba mucho (en la Rx original no había flecha y se veía, usando la imaginación, un engrosamiento bronquial o mediastínico derecho). Casi se veía normal. Pero tos en alguien muy fumador, con examen físico normal, pensar en Cáncer (no tenía secreción como para pensar en bronquitis crónica por cigarrillo).

137) Un paciente de 67 años, fumador de 15 paquetes-año, pero que dejó de fumar hace 10 años, jubilado de la minería, consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, de 6 meses de evolución, asociada a tos. Al examen físico presenta murmullo pulmonar globalmente disminuido, sibilancias y roncus bilaterales, asociados a crepitaciones difusas. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación:



NOTA: la radiografía inicial mostraba infiltrados bilaterales, mayores en las zonas centrales, con imágenes verticales, onduladas de 1-2 cm en ambos campos pulmonares.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Bronquitis crónica

b) Neumoconiosis

c) Cáncer de pulmón

d) Limitación crónica del flujo aéreo

e) Fibrosis pulmonar idiopática

R: Antecedente de minería orienta a neumoconiosis. La Rx era distinta a la que ahí se muestra.

138) Un paciente de 50 años presenta un cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta y fiebre. Al examen físico está se auscultan crepitaciones basales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra más abajo:

NOTA: la radiografía mostraba infiltrados en la base izquierda, que ocupaban el lóbulo inferior izquierdo, pero que permitían ver la cúpula diafragmática, con un pequeño derrame pleural, limitado al ángulo costofrénico. Se punciona el derrame pleural, que muestra un lactato: 2,4 mmol/L, pH: 7,34, con 350 células, 90% de polimorfonucleares. ¿Qué antibiótico debe dejar?

a) Claritromicina

b) Clindamicina

c) Ceftriaxona

d) Azitromicina

e) Amoxicilina

R: Por ser una neumonía, con derrame (paraneumónico simple en este caso), se debe manejar hospitalizada (ATS III), por lo que el ATB de elección es la ceftriaxona.

139) Un paciente de 70 años, diagnosticado de EPOC, presenta un cuadro de mayor dificultad respiratoria, asociada a aumento de su expectoración, la que se vuelve mucopurulenta. Además presenta fiebre y disnea de

reposo. Al examen físico se aprecia respiratoriamente apremiado, con PA: 120/80, FC: 95x'. Se solicita radiografía que se muestra a continuación:



¿Qué antibiótico debe recibir?

- a) Claritromicina
- b) Amoxicilina
- c) Cefotaximo**
- d) Amoxicilina más ácido clavulánico
- e) Clindamicina

R: Era un EPOC descompensado con una neumonía bilateral: se debe manejar hospitalizado, por lo que el ATB de elección es la ceftriaxona (no aparecía en las alternativas, por lo que cefotaximo es la opción más adecuada: tiene el mismo espectro de acción). Sin embargo la Rx original no condensaba claramente y tenía un patrón alveolointersticial (discutible si sospechar mycoplasma, que se trata con macrólidos o levofloxacino, porque la clínica no era arrastrada ni atípica)

140) Un paciente presenta una neumonía, con dificultad respiratoria, taquipnea, fiebre y desaturación arterial. Satura 75% a FiO2 ambiental y tiene gases arteriales, con una presión arterial de O2 de 54 mmHg y presión de CO2 de 32 mmHg. ¿Cómo debe administrarse el oxígeno a este paciente?

- a) Por naricera a 0,5 litros por minuto
- b) Por naricera a 2 litros por minuto
- c) Por mascarilla Venturi, a FiO2 de 24%
- d) Por mascarilla Venturi, a FiO2 de 40%
- e) Por ventilación mecánica invasiva**

R: Hay evidencia de baja calidad y reciente, muy discutida, que dicen que la ventilación mecánica invasiva tendría mejores resultados en mortalidad y en tiempo de hospitalización, que la oxigenoterapia por mascarilla. Pregunta muy discutible, porque en la vida real, se evaluará primero la respuesta al oxígeno y se irá viendo cuánto necesita para saturar adecuadamente.

141) En contexto de un brote de influenza, durante el invierno, un paciente de 22 años presenta un cuadro de rinorrea, congestión nasal, fiebre, mialgias generalizadas y tos seca. Al examen físico presenta 39 grados celsius, con examen pulmonar normal. El tratamiento más adecuado es:

- a) Oseltamivir
- b) Zanamivir
- c) Aciclovir

d) Valaciclovir

e) Paracetamol

R: Pregunta demasiado discutible, ya que los pacientes sin antecedentes de riesgo tienen la opción de usar oseltamivir, si así lo quieren, para disminuir el tiempo de influenza y asegurar que no será grave. La guía minsal solo da oseltamivir a pacientes con factores de riesgo o con influenza grave. Sin embargo el tratamiento sintomático es el de elección en la influenza. Se debe evitar la aspirina y el ibuprofeno, por el riesgo de síndrome de Reye. Además por la rinorrea y congestión, se puede sospechar otro virus, distinto a la influenza

142) Un paciente fuma 5 a 7 cigarrillos al día y consulta porque quiere dejar de fumar. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

a) Terapia cognitivo conductual

b) Terapia de sustitución con nicotina

c) Sertralina

d) Bupropión

e) Cigarrillo electrónico

R: Fuma muy poco, como para que requiera bupropión o nicotina. Además la terapia cognitivo conductual siempre es la más efectiva para dejar de fumar.

148) Un lactante de 5 meses de edad es llevado a urgencias, por presentar un cuadro de obstrucción bronquial. Al examen físico presenta taquipnea importante, satura 90%, tiene retracción intercostal, cianosis perioral y sibilancias bilaterales intensas. ¿Cuál es la primera medida que se debe tomar?

a) Nebulizaciones con salbutamol

b) Nebulizaciones por

c) Dar corticoides orales

d) Dar oxígeno por mascarilla

e) Administrar corticoides endovenosos

R: Ante una hipoxia, en un trastorno V/Q, lo más urgente siempre es el oxígeno. Además hoy está demostrado que el oxígeno es lo único realmente útil en la bronquiolitis y que no sirven ni corticoides ni broncodilatadores

DICIEMBRE 2015

22) Un paciente de 33 años consulta por un cuadro de dos días de evolución de dolor torácico, que aumenta con la inspiración profunda. Al examen tiene FC: 80x', PA: 110/70 mmHg, FR: 15x', eupneico. Su examen pulmonar muestra disminución del murmullo pulmonar y de la transmisión vocal en el campo pulmonar derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra en la IMAGEN. La conducta más adecuada es:

a) Realizar sellamiento pleural

b) Instalar un tubo de drenaje pleural

c) Realizar resección videotoracoscópica de bulas

d) Realizar aspiración con aguja

e) Administrar analgésico y reevaluar en 24 horas

FOTO: neumotórax derecho de 30%-40%

R: Es un neumotórax mayor a 15%, así que se debe drenar con un tubo. Si fuera menor se puede dar analgesia y controlar con nueva radiografía en 4-6 horas. Si fuera recurrente, la indicación es la cirugía (sellamiento más resección de bulas, si existen).

25) Un paciente de 22 años presenta tos y en ocasiones disnea, que frecuentemente aparecen con el ejercicio y en la noche o cuando sacude las cosas de su cuarto. Al examen físico presenta espiración prolongada y en la

auscultación torácica se aprecia un murmullo pulmonar disminuido en intensidad, con algunas sibilancias espiratorias bilaterales. Además, su PEF es de 300 (con PEF teórico de 500) y se solicita radiografía de tórax que no tiene alteraciones. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

a) Test de alérgenos cutáneos

b) TAC de tórax

c) Espirometría basal y postbroncodilatador

d) Test de parches

e) Test de metacolina

R: Es un asma clínico, por lo que no se requiere ningún examen para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, dentro de las opciones, el examen de apoyo de elección es la espirometría, en especial cuando tiene obstrucción clínica. Si no hay obstrucción clínica pierde su sensibilidad y se solicita test de metacolina.

26) Un paciente asmático, en control irregular con fluticasona inhalada consulta por un cuadro de disnea imponente. Al examen físico tiene taquipnea, con FR: 34x', satura: 89% con FiO2 ambiental, presenta uso de musculatura accesoria y se auscultan sibilancias intensas bilaterales, espiratorias, con espiración prolongada y aumento del diámetro torácico. Refiere que ha usado salbutamol cada 4 horas sin lograr respuesta. Además de administrar oxígeno, la conducta inicial más adecuada es:

a) Prednisona vía oral

b) Ipratropio inhalado

c) Salbutamol inhalado

d) Dexametasona intravenosa

e) Adrenalina intramuscular

R: Es una crisis asmática. Se trata con oxígeno para saturar más de 93%, salbutamol inhalado y corticoides sistémicos (vo, im o ev), en ese orden. El ipatropio sí es una buena opción, pero solo si no responde al salbutamol o es un paciente cardíopata, en que el salbutamol puede causar arritmias.

27) Un niño de 2 años y 6 meses, presenta un cuadro de fiebre hasta 38 grados, con tos y disfonía de 2 días de evolución. Despierta a la mañana siguiente con disnea y dificultad respiratoria. Al examen físico presenta taquipnea, cianosis perioral, disminución del murmullo pulmonar y estridor inspiratorio. ¿Cuál es la tratamiento más adecuado en este momento?

a) Salbutamol nebulizado

b) Dexametasona endovenosa

c) Amoxicilina

d) Adrenalina subcutánea

e) Paracetamol oral

R: El tratamiento real es con adrenalina o adrenalina racémica por vía nebulización, más los corticoides sistémicos (vía oral, intramuscular o endovenosa). De las opciones, la única que es parte del tratamiento es la dexametasona, que demora 6 horas en actuar. Sin embargo es una mala pregunta, por no preguntar lo realmente urgente, lo que se presta para confusión.

28) Un paciente de 70 años, exfumador de 40 paquetes años, es diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, severa. Presenta disnea de pequeños esfuerzos y uso frecuente de salbutamol. Su examen físico muestra aumento importante del diámetro anteroposterior del tórax y sibilancias bilaterales, con disminución del murmullo pulmonar, de manera global. Sus gases arteriales muestran pH: 7,38, PaO2: 54 mmHg y PaCO2: 52mmHg y su radiografía de tórax muestra aumento del tamaño de los campos pulmonares y aplanamiento del diafragma. ¿Qué medida será más útil para aumentar su supervivencia?

a) Beta-agonistas de larga acción inhalados

- b) Anticolinérgicos de larga acción inhalados
- c) Corticoides inhalados
- d) Entrenamiento respiratorio

e) Oxígeno domiciliario

R: El suspender el cigarrillo y el oxígeno domiciliario cuando está indicado (PaO₂ menor a 55 o menor a 60 con hipertensión pulmonar, poliglobulia o cor pulmonale) son las únicas medidas que aumentan la supervivencia en el EPOC estable.

29) Un paciente de 64 años, diagnosticado de EPOC severo, que actualmente ya no fuma, consulta por importante aumento de su disnea, de 48 horas de evolución, presentando actualmente disnea de reposo. Al examen físico está orientado, vigil, angustiado por la disnea, con FR: 35x', uso de musculatura accesoria y tiraje, con PA: 100/60 mmHg, FC: 105x'. Se ausculta marcada disminución del murmullo pulmonar y sibilancias espiratorias bilaterales. Sus gases arteriales muestran pH: 7,30, PaO₂: 51 mmHg y CO₂: 55 mmHg y su radiografía de tórax muestra campos pulmonares grandes, con aplanamiento del diafragma y corazón en gota. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Oxígeno por mascarilla
- b) Ventilación mecánica no invasiva**
- c) Broncodilatadores de corta acción inhalados
- d) Antibióticos
- e) Ventilación mecánica invasiva

R: Es un EPOC descompensado con insuficiencia respiratoria global, que requiere ventilación mecánica. Por estar vigil, se recomienda que sea no invasiva, por BiPAP.

30) Un niño de 8 años, presenta un cuadro de dos años de evolución de tos, broncorrea, disnea de esfuerzos y sibilancias, que no han respondido al tratamiento con corticoides y broncodilatadores por vía inhalada. Al examen físico tiene sibilancias y estertores bilaterales, asociados a hiperinflación digital. ¿Cuál es el examen más adecuado para orientar al diagnóstico?

- a) Broncoscopia
- b) Espirometría basal y postbroncodilatador
- c) Test del sudor**
- d) Resonancia magnética de pulmón
- e) Test de metacolina

R: La sospecha diagnóstica es una fibrosis quística. También podría tratarse de bronquiectasias por otra causa (la fibrosis quística sí da bronquiectasias), pero no aparece TAC como opción, así que el test del sudor es la respuesta correcta.

58) Un paciente diabético e hipertenso, consulta por un cuadro de dificultad respiratoria, asociado a tos con expectoración mucopurulenta, que inició hace 3 días. Evoluciona con dificultad respiratoria y malestar general. Al examen físico presenta FR: 23 por minuto, con FC: 97x', PA: 118/82 mmHg, saturación arterial por pulsometría de 89%. Se auscultan respiración sopla y crepitaciones en la base pulmonar derecha, con matidez a la percusión. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra en la IMAGEN. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Amoxicilina más ácido clavulánico oral
- b) Ceftriaxona endovenosa**
- c) Levofloxacino oral
- d) Azitromicina oral
- e) Amoxicilina oral

FOTO: Imagen de condensación del lóbulo inferior derecho.

R: Tiene requerimientos de oxígeno (satura menos de 93%), por lo que se debe hospitalizar y por tanto tratarse con ceftriaxona endovenosa.

77) Un niño de 1 año y 10 meses de edad presenta un cuadro de estornudos, rinorrea y fiebre. Dos días después ya no presenta fiebre, sin embargo se agrega tos y persiste con rinorrea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Resfrío común

b) Influenza

c) Infección por adenovirus

d) Sinusitis bacteriana

e) Bronquiolitis

R: Es un resfrío común clásico.

82) Un paciente de 17 años presenta malestar general, asociada a fiebre hasta 38,8 grados y odinofagia, de 7 días de evolución. Al examen físico presenta adenopatías palpables en la zona cervical anterior, con faringe eritematosa y congestiva, con aumento del tamaño amigdalino. Además se palpa el bazo por 2 cm bajo el reborde costal. Se solicitan exámenes que se muestran a continuación:

IgM virus Eptein Baar: negativo IgG virus Eptein Baar: positivo

IgM Citomegalovirus: positivo IgG Citomegalovirus: negativo

IgM Toxoplasma gondii: negativo IgG Toxoplasma gondii: positivo

Elisa VIH: negativo

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Mononucleosis infecciosa

b) Infección por Citomegalovirus

c) Síndrome retroviral aguda

d) Toxoplasmosis

e) Infección por adenovirus

R: Es un síndrome mononucleósico, con IgM positiva para CMV, por tanto una infección aguda por CMV.

83) Un paciente de 18 años consulta por un cuadro de fiebre, odinofagia y malestar general de 2 semanas de evolución. Al examen físico está febril a 38 grados, se aprecia faringe congestiva con amígdalas aumentadas de tamaño, con exudado blanco bilateral y se palpa esplenomegalia moderada. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con hematocrito: 42%, plaquetas: 200.000 por mm³, leucocitos: 17.000 por mm³, con 80% de linfocitos, 10% de ellos reactivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Infección por adenovirus

b) Linfoma

c) Faringitis estreptocócica

d) Mononucleosis infecciosa

e) Leucemia linfática aguda

R: El cuadro clásico de la mononucleosis.

87) Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, indicándosele tratamiento, con buena evolución clínica. Se controla con baciloscopías de expectoración mensuales, que resultan (+), (-), (-), (+) y (-). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Mantener el tratamiento

b) Suspender el tratamiento

- c) Iniciar tratamiento de segunda línea
- d) Solicitar un PPD
- e) Agregar un fármaco de segunda línea al tratamiento actual

R: Para diagnosticar un fracaso, se requieren 2 BK positivas seguidas o un cultivo positivo. De lo contrario es eliminación esporádica de bacilo muerto. De todos modos si se debió haber pedido el cultivo. Son 6 meses de tratamiento mínimo, así que no se debe suspender.

96) Un niño de 2 años y medio de edad presenta un cuadro de tos, fiebre y rinorrea de 24 horas de evolución. Se agrega disfonía, de manera súbita y finalmente evoluciona con dificultad respiratoria y agitación. Al examen físico presenta estridor inspiratorio, taquipnea, tiraje y disminución del murmullo pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cuerpo extraño laríngeo
- b) Bronquiolitis aguda
- c) Epiglotitis aguda

d) Laringitis aguda viral

- e) Traqueítis bacteriana

R: Es una laringitis aguda por virus parainfluenza.

97) Un paciente de 20 años consulta por estornudos, prurito nasal y rinorrea acuosa, que se exagera en la primavera y al exponerse a algunos pólenes. Tiene antecedente de dermatitis atópica y al examen físico se aprecia mucosa nasal pálida. Se realiza un prick test que resulta positivo para Ballica y Plátano oriental. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para este paciente?

- a) Corticoides orales en pulsos cortos
- b) Antihistamínicos anti-H1, de segunda generación**
- c) Descongestionantes nasales tópicos
- d) Corticoides inhalados por vía nasal
- e) Inhibidores de la degranulación de los mastocitos

R: Es una rinitis alérgica (diagnóstico es clínico, aunque en este caso se haya confirmado con prick test). Los antihistamínicos H1, de segunda generación (loratadina, cetirizina, etc) son de elección para iniciar, a menos que haya mucha obstrucción nasal, en que se prefieren los corticoides nasales tópicos. Si falla uno de esos medicamentos, se agrega el otro.

110) Encuentran inconsciente a una niña de 15 años, en el baño de su casa, con el calefont apagado. Al examen está soporosa, desorientada, con FC: 100x', FR: 30x', saturación de oxígeno por pulsometría de 97%. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Dar oxígeno por mascarilla, al 100%**
- b) Administrar suero fisiológico endovenoso
- c) Dar carbón activado
- d) Administrar suero glucosado al 10% endovenoso
- e) Ventilar con ambú

R: Es una intoxicación por monóxido de carbono. Lo primero que se hace es dar O2 al 100% y se intenta trasladar a una cámara hiperbárica, si fuera posible. Es frecuente que presenten muy altas saturaciones por pulsometría (el CO emula al O2 en ese examen) y las presiones de O2 están normales, ya que el problema no es de presión, sino de ocupación de la hemoglobina, por el CO. Se diagnostica con carboxihemoglobina.

112) Una paciente de 30 años, sin antecedente tabáquico, consulta por tos seca, irritativa, que aparece con frecuencia. Su examen físico, así como su radiografía de tórax son normales. Se realiza un PEF, que también es

normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio de esta paciente?

a) Solicitar test de metacolina

- b) Solicitar espirometría basal y post-salbutamol
- c) Solicitar TAC de cavidades paranasales
- d) Solicitar baciloscopías y PCR para mycobacterias
- e) Solicitar prick test

R: Es un cuadro de tos crónica. Entre las causas a descartar está asma, sinusitis, cáncer, tuberculosis y tabaquismo. En este caso no fuma y no tiene mucha más clínica que oriente a otras causas. Dentro de las opciones para descartar asma está la espirometría, pero esta no sirve cuando el PEF y el examen físico está normal, prefiriéndose el test de metacolina. La sinusitis es una enfermedad a descartar, por lo que podría ser útil el TAC, pero el diagnóstico de sinusitis es principalmente clínico.

JULIO 2016

11) Una paciente de 48 años, se somete a una gastrectomía total. Al segundo día postoperatoria presenta fiebre y taquicardia, con FC: 100x' y PA: 140/90. Al examen físico presenta herida operatoria sin alteraciones, con abdomen sensible a la palpación. El examen pulmonar muestra hipoventilación basal. ¿Cuál es la causa más probable de la fiebre?

- a) Infección urinaria
- b) Filtración de la anastomosis
- c) Reacción adversa a medicamentos
- d) Tromboembolismo pulmonar

e) Atelectasia infectada

R: Pregunta capciosa, con redacción insuficiente. Las atelectasias son la primera causa de fiebre postoperatoria y además la hipoventilación la sugiere. Sin embargo, también podría calzar con un TEP, por el tiempo de evolución, aunque falta información (ej. inicio súbito, desaturación arterial, etc.), como para marcarlo.

73) Paciente con diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, en su cuarto ciclo de quimioterapia, se encuentra hospitalizado por fiebre sin foco, asociado a neutropenia (neutropenia febril), por lo que está en tratamiento con ceftazidima, amikacina y vancomicina, sin mayor respuesta. En sus exámenes de laboratorio presenta neutrófilos 100 por mm³ y en la radiografía de tórax se observa una imagen apical derecha radiopaca, de 3 cm de diámetro, espiculada y con bordes difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tuberculosis
- b) Neumonía intrahospitalaria
- c) Aspergilosis invasiva**
- d) Nocardosis
- e) Neumonía por *Pneumocystis jiroveci*

R: La aspergilosis es una complicación clásica de la neutropenia prolongada.

81) Un Paciente de 52 años con historia de ronquidos frecuentes, de larga data, que desde hace 5 años, se asocia a somnolencia diurna excesiva y deterioro cognitivo. Al examen físico tiene frecuencia cardiaca de 75x' y presión arterial de 140/100 mmHg. Su IMC es de 35. Se realiza polisomnografía que evidencia índice de apenas de 50 eventos de apnea / hipopnea por hora, con predominio de los eventos obstructivos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Oxígeno nocturno
- b) C-PAP nocturno**
- c) Cirugía bariátrica
- d) Uvulopalatoplastia

e) Dispositivo orofaríngeo

R: Tiene un síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño severa, por lo que requiere C-PAP. La cirugía podría servir, pero requiere de obstrucción anatómica y además, dada la severidad, el C-PAP igual es de elección.

118) Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, por lo que se inicia tratamiento con antibióticos asociados. Sus baciloscopías mensuales de control resultan: mes 1 (+), mes 2 (-), mes 3 (-), mes 4 (-), mes 5 (+) y mes 6 (+). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Recaída

b) Eliminación esporádica

c) Fracaso

d) Contaminación

e) Nocardiosis pulmonar

R: Dos BK positivas seguidas, después del cuarto mes, es un fracaso a tratamiento.

119) Un paciente de 26 años de edad presenta un cuadro de tos con expectoración de algunos años de evolución, mayor en las mañanas y que ha presentado hemoptisis. Su examen físico presenta acropaquias y a la auscultación pulmonar hay crepitaciones y estertores bilaterales. El diagnóstico más probable es:

a) Bronquiectasias

b) Cáncer pulmonar

c) Tuberculosis pulmonar

d) Asma

e) EPOC

R: Son bronquiectasias clásicas.

126) Un hombre de 30 años, con rinorrea frecuente, se realiza prueba cutánea (prick test), que muestra reacción de 5mm a pólenes y de 0 mm al control histamina. ¿Cuál es la interpretación más adecuada de esta prueba?

a) Es alérgico

b) Está sensibilizado a pólenes

c) Tiene rinitis vasomotora

d) Tiene sinusitis crónica

e) Anergia cutánea

R: ¿B, E? Es una pregunta mala, ya que el control positivo (con histamina) resulta 0 mm, por lo que probablemente está usando antihistamínicos y el examen no sirve, por la anergia. Sin embargo, resulta positivo para pólenes, por lo que yo marqué la B. Lo más correcto es que hubiese dicho que el control con suero fisiológico estaba en 0 mm y no el de la histamina.

127) Un lactante de 1 año de presenta un ataque súbito de tos, sofocamiento y dificultad respiratoria. Al examen presenta sibilancias y disminución del murmullo pulmonar, con FR: 34x'. El diagnóstico más probable es:

a) Neumotórax

b) Laringitis aguda

c) Bronquitis obstructiva

d) Cuerpo extraño bronquial

e) Angioedema

R: Es el cuadro clásico de aspiración de cuerpo extraño.

135) Niño de 8 meses que sufre desde hace 6 meses diarrea pastosa, abundante. Tiene también antecedente de episodios bronquiales obstructivos y 4 cuadros de infecciones respiratorias, que han requerido de hospitalización. Cuál es el diagnóstico de sospecha?

- a) Enfermedad celiaca
- b) Enteropatía perdedora de proteínas
- c) Enfermedad de cilio inmóvil

d) Fibrosis quística

- e) Alergia a la proteína de la leche de vaca

R: Tanto por las infecciones respiratorias, como por la malabsorción es una FQ.

139) Un paciente de 60 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y tos, asociada a expectoración mucopurulenta. Evoluciona con dificultad respiratoria, por lo que es llevado al servicio de urgencia. Al examen físico tiene FC: 113x', PA: 100/60 mmHg, FR: 33x' y al examen pulmonar presenta crepitaciones inspiratorias, en el hemicampo pulmonar derecho. La radiografía de tórax muestra condensación en los lóbulos medio e inferior derecho y satura 83%, con FiO2 ambiental, que sube a 90%, con oxígeno al 40%, por mascarilla de recirculación. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección para este paciente?

- a) Cefepime más amikacina
- b) Ceftriaxona más clindamicina
- c) Cloxacilina más metronidazol

d) Cefotaximo más moxifloxacino

- e) Piperacilina más tazobactam

R: Es una Neumonía, grave, que requiere tratamiento en UCI y ventilación mecánica. De los tratamientos, lo más adecuado es cefotaximo o ceftriaxona, más un macrólido o una quinolona respiratoria.

140) Puérpera de 15 días, inicia disnea y tos, asociada a expectoración, hemoptoica. Al examen pulmonar tiene murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos y satura 90% a FiO2 ambiental. El diagnóstico más probable es:

a) Tromboembolismo pulmonar

- b) Neumonía adquirida en la comunidad
- c) Neumonía intrahospitalaria
- d) Tuberculosis pulmonar
- e) VIH

R: el antecedente de puerperio orienta muy fuertemente a TEP.

143) Una mujer de 26 años, presenta un cuadro de 5 días de rinorrea, que a los dos días se vuelve mucopurulenta, agregándose odinofagia, y congestión nasal. Al examen físico se aprecia rinorrea, asociada a eritema y congestión faríngea. Se solicita una radiografía de senos paranasales que muestra velamiento de ambos senos maxilares. El tratamiento más adecuado es:

a) Amoxicilina oral

- b) Amoxicilina más ácido clavulánico oral
- c) Corticoide tópico
- d) Descongestionantes tópicos
- e) Antihistamínicos orales

R: Es una sinusitis aguda. Por el tiempo de evolución es probablemente viral y no requiere sino tratamiento sintomático. Sin embargo, no aparecía dentro de las alternativas y lo que se pregunta entonces es el tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda, que de primera línea es con amoxicilina.

151) Un niño de 5 meses de edad presenta un cuadro de rinorrea y tos, que va en aumento, hasta presentar accesos de tos y dificultar la alimentación. Al examen físico está en buenas condiciones generales, afebril y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicita un hemograma, que muestra leucocitosis de 17.000, con 78% de linfocitos y 22% de neutrófilos. La PCR y VHS están levemente elevadas. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un patrón intersticial leve. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía atípica
- b) Infección por virus influenza
- c) Infección por adenovirus

d) Coqueluche

- e) Bronquiolitis aguda

R: Es un coqueluche clásico.

152) Un paciente de 42 años, fumador de 2,6 paquetes-año, presenta un cuadro de 3 meses de compromiso del estado general, astenia y baja de peso de 3 kilogramos, asociado a tos y expectoración mucopurulenta, que en ocasiones es hemoptoica. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra zonas de relleno alveolar en el lóbulo superior derecho. ¿Con qué examen(es) se debe proseguir el estudio?

a) Baciloscopías de expectoración y cultivo para mycobacterias

- b) Elisa VIH
- c) Biopsia pulmonar por videtoracoscopia
- d) Lavado bronquioalveolar por broncoscopia
- e) TAC de tórax

R: Parece una TBC, por lo que debe estudiarse con baciloscopías y cultivo.

155) Un paciente de 66 años, fumador de 40 paquetes-año presenta tos con expectoración mucosa, de 4 años de evolución. Tiene broncorrea, mayor en la mañana y presenta 2 infecciones respiratorias al año, que requieren de antibióticos. Su radiografía de tórax y espirometría son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cáncer de pulmón
- b) Tuberculosis pulmonar
- c) Fibrosis pulmonar
- d) EPOC

e) Bronquitis crónica

R: Es una bronquitis crónica clásica.

164) Paciente de 17 años presenta un cuadro de fiebre, malestar general y odinofagia, de 7 días de evolución. Al examen, presenta lesiones blanquecinas en las amígdalas y congestión de la orofaringe, adenopatías cervicales y se palpa el bazo moderadamente aumentado de tamaño. ¿Cuál es el agente causal más probable?

- a) Adenovirus
- b) Virus influenza
- c) Virus de Epstein Barr
- d) Citomegalovirus
- e) Streptococo A

R: Es una mononucleosis clásica, causada por el VEB.

177) Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, nacido por cesárea, presenta dificultad respiratoria, luego de nacer, con taquipnea, retracción subcostal y crepitantes basales. Se solicita una radiografía de tórax,

que muestra ambos campos pulmonares con hiperinsuflación, reforzamiento hilar, aplanamiento del diafragmas y silueta cardiaca normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumomediastino
- b) Neumonía connatal
- c) Taquipnea transitoria**
- d) Enfermedad de membrana hialina
- e) Cardiopatía congénita

R: Tanto por el antecedente de cesárea, como por la radiografía es taquipnea transitoria.

JULIO 2017

13) Un paciente de 43 años, obeso mórbido, consulta por cansancio y somnolencia diurna. Reclama que ronca en la noche y se queda dormido en las luces rojas del semáforo. En su examen físico destaca PA: 140/90 mmHg, FC: 72x' y faringe normal. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?

- a) Poligrafía nocturna
- b) Polisomnografía**
- c) Saturación arterial de oxígeno durante el sueño
- d) Monitorización de presión arterial de 24 horas
- e) Nasofibroscopí

R: Es un SAHOS (síndrome de apnea e hipopnea del sueño), que se estudia con polisomnografía. La poligrafía es similar, pero no necesariamente está durmiendo y lo que se requiere es que esté durmiendo, es decir, una polisomnografía.

17) Una paciente de 43 años, ex fumadora de 8 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos con expectoración mucosa y respiración sibilante, que aparecen después de realizar ejercicio o presentar infecciones virales. Al examen físico presenta disminución del murmullo pulmonar, sibilancias espiratorias y aumento del diámetro anteroposterior torácico. Se realiza una radiografía que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

El tratamiento inicial más adecuado es:

- a) Salmeterol inhalado
- b) Ipratropio inhalado
- c) Budesonida inhalado
- d) Salbutamol inhalado**
- e) Tiotropio inhalado

R: Es un asma y lo más correcto es iniciar salbutamol SOS, más un corticoide inhalado (budesonida en este caso). Por tanto es una mala pregunta. Si fuerzan a elegir el tratamiento "inicial", la respuesta es salbutamol, ya que tiene un efecto más rápido y a que sus síntomas son muy escasos.

21) Un paciente de 32 años, lleva un año conviviendo con pacientes bacilíferos, se encuentra asintomático y su radiografía de tórax no muestra alteraciones, se solicita un PPD que resulta en 23 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar tratamiento atibiótico con isoniazida, pirazinamida, rifampicina y etambutol por 6 meses
- b) Repetir PPD en un mes
- c) Dar de alta y control en caso de síntomas
- d) Solicitar reacción en cadena de polimerasa para mycobacterium tuberculosis en lavado bronquioloalveolar
- e) Indicar isoniazida por 6 meses**

R: Es un contacto, con PPD mayor a 10, por lo que se debe indicar profilaxis antibiótica (isoniazida 6 meses es la recomendación del Minsal).

22) ¿Cuál de las siguientes sustancias es una causa frecuente de asma pulmonar por exposición laboral?

- a) Asbesto
- b) Sílice
- c) Harina**
- d) Algodón
- e) Carbón

R: Asbesto, sílice y carbón producen neumoconiosis. La inhalación de harina, produce asma y es la causa más frecuente de asma laboral.

27) Un niño de 2 años presenta tos de 3 días de evolución, asociado a odinofagia y fiebre de 38 grados Celsius. Al examen físico presenta congestión y eritema de la faringe y las amígdalas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Ibuprofeno oral**
- b) Amoxicilina oral
- c) Azitromicina oral
- d) Aciclovir oral
- e) Oseltamivir oral

R: Es una simple infección respiratoria alta, que se trata de manera sintomática. Actualmente se recomienda preferir el paracetamol y evitar los AINES en lo posible, en la edad pediátrica.

40) Un paciente de 35 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, agregándose disnea importante. Al examen físico se aprecia enfebrado, con frecuencia respiratoria de 35 por minuto, frecuencia cardíaca de 92 por minuto, presión arterial de 100/70mmHg y saturación de 93% con FiO2 ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad pulmonar intersticial difusa
- b) Bronquitis chlamydia trachomatis
- c) Tuberculosis pulmonar
- d) Neumonía por mycoplasma
- e) Neumonía por pneumocystis jiroveci**

R: Tanto el cuadro clínico, como la RxTx con compromiso bilateral hacen sospechar una infección por VIH más Pneumocystis (La RxTx tiene un ligero error, porque es de una mujer).

45) Un niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 39,5 grados, asociada a tos con expectoración mucopurulenta, de 2 días de evolución. Además refiere cefalea y marcado malestar general. Al examen físico está decaído, febril, con FC:100x', RR2T, sin soplos, examen pulmonar con presencia crepitaciones localizadas en la zona superior del campo pulmonar derecho. Se realiza radiografía de tórax, que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Mycoplasma pneumoniae
- b) Chlamydia pneumoniae

c) Streptococcus pneumoniae

d) Haemophilus influenzae

e) Staphylococcus aureus

R: Es una NAC neumocócica clásica, con la condensación en la radiografía.

52) Un paciente con antecedente de EPOC, fumador de 25 paquetes año, consulta por cuadro de tres días de evolución de exacerbación de su disnea basal y expectoración mucosa, asociado a sensación febril y hace un día se agrega dolor tipo puntada de costado. Al examen se aprecia frecuencia respiratoria de 21 por minuto, frecuencia cardíaca de 92 por minuto, temperatura de 38,1°C. Al examen pulmonar presenta crepitaciones de la cara lateral del hemitórax derecho, asociado a matidez a la percusión. Se solicita una radiografía que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

El diagnóstico más probable:

a) Tuberculosis

b) Derrame pleural

c) Neumonía

d) Tromboembolismo pulmonar

e) Cáncer bronquial

R: Tanto la clínica, como la radiografía apuntaban a NAC.

56) Un lactante de 7 meses, con antecedente de haber sido hospitalizado en varias oportunidades por cuadros respiratorios febriles, presenta diarrea de algunos meses de evolución, asociada a esteatorrea y mal incremento ponderal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Enfermedad celíaca

b) Inmunodeficiencia primaria

c) Fibrosis quística

d) Alergia a la proteína de la leche de vaca

e) Giardiasis intestinal

R: La FQ suele producir neumonías bacterias (S. aureus y P. aureginosa) y un síndrome de malabsorción. Las demás no producen ambos compromisos.

72) Un recién nacido de 2 semanas es hospitalizado por presentar apneas. La madre refiere tos de 3 semanas de evolución, en crisis, que en ocasiones la hacen vomitar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

a) Amoxicilina

b) Azitromicina

c) Ceftriaxona

d) Oseltamivir

e) Aciclovir

R: La sospecha es un coqueluche, que se trata con macrólidos.

76) Paciente de 45 años, fumadora activa de 40 paquetes año, consulta por tos irritativa asociada a disnea y crisis de sibilancias que aparecen en relación a la actividad física e infecciones respiratorias. Se realiza una espirometría que muestra:

Basal:

VEF1/CVF: 62%

VEF1: 2,4L (62% del valor teórico)

CVF: 4,9L (92% del valor teórico)

Post-Salbutamol

VEF1/CVF: 74%

VEF1: 3,6L (89% del valor teórico)

CVF: 5,0L (95% del valor teórico)

El diagnóstico más probable es:

- a) Asma**
- b) EPOC
- c) Fibrosis pulmonar
- d) Bronquiectasias
- e) Bronquitis crónica

R: Es un patrón obstructivo, que mejora con broncodilatador, es decir, un asma.

99) Un paciente de 70 años, consulta por cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por tos con expectoración mucosa que en ocasiones es purulenta y baja de peso, asociado a compromiso del estado general, sensación febril ocasional y fatigabilidad. Se le solicita per☐**í hemático que muestra hematocrito de 32%, leucocitos 12.000/mm3. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación:**

INSERTAR FOTO

La conducta más adecuada para proseguir con el estudio es:

- a) Realizar broncoscopia
- b) Solicitar baciloscopías de expectoración con cultivo de Koch**
- c) Solicitar TAC de tórax
- d) Solicitar angioTAC de tórax
- e) Solicitar cultivo de expectoración

R: La sospecha es una tuberculosis, por el tiempo de evolución y por la clínica.

112) Un paciente de 68 años, con antecedente de EPOC, fumador de 30 paquetes año, consulta por cuadro de 3 días de hemoptisis escasa, asociada a di☐**cultad respiratoria. Tiene antecedente de hernioplastia hace 7 días. Al examen físico su frecuencia cardiaca es de 100 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, presión arterial 120/80mmHg, saturación arterial 95% con FiO2 ambiental. Su examen pulmonar muestra murmullo presente bilateral con escasas sibilancias. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con su estudio?**

- a) TAC de tórax
- b) Cintigrafía V/Q
- c) Angiografía pulmonar
- d) Ecocardiograma
- e) AngioTAC de tórax**

R: La sospecha es un TEP, que se estudia preferentemente con angioTAC de tórax. El antecedente de cirugía reciente orienta mucho. Si hubiese estado hipotenso, habría sido un TEP masivo, que se estudia o con ecocardiograma o con angiografía pulmonar.

123) Un niño de 4 años presenta sensación febril y ojo rojo bilateral, asociado a ardor y lagrimeo, lo que se acompaña de rinorrea y odinofagia. Varios de sus familiares tienen los mismos síntomas. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Chlamydia trachomatis
- b) Staphylococcus aureus
- c) Streptococcus pyogenes
- d) Haemophilus in
- e) Adenovirus**

R: Es una fiebre faringoconjuntival clásica, por ADV.

130) Un niño de 4 años presenta fiebre hasta 39 grados Celsius, mialgias y tos de 3 días de evolución. Además ha presentado rinorrea y cefalea. Al examen físico presenta temperatura de 38,8 grados y su examen pulmonar es normal. Se realiza test pack para virus respiratorios, que resulta positivo para virus influenza B. ¿Cuál es el fármaco de elección para el tratamiento de este paciente?

- a) Oseltamivir
- b) Acetaminofeno**
- c) Aciclovir
- d) Amantadina
- e) Amoxicilina

R: El tratamiento de elección de la influenza es sintomático. La amantadina no sirve en los tipos B y el oseltamivir casi no sirve después de 48 horas y no está indicado en los niños, por no ser de mayor utilidad.

153) Un adulto de 65 años, con antecedente de EPOC, consulta por aumento de su disnea basal asociado a expectoración mucopurulenta y fiebre hasta 38,3°C. Al examen físico presenta frecuencia cardiaca de 95 por minuto, presión arterial 120/80mmHG, satura 91%, frecuencia respiratoria de 27 por minuto. A la auscultación pulmonar presenta crépitos en base izquierda y se solicita radiografía que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO

El tratamiento de elección es:

- a) Cefuroximo oral
- b) Penicilina endovenosa
- c) Azitromicina oral
- d) Amoxicilina oral
- e) Ceftriaxona endovenosa**

R: Falta información sobre el estado general del paciente. Además no se sabe la saturación basal del paciente. Una saturación de 91%, por regla general requiere hospitalización y por tanto ceftriaxona (por ello la dejamos como correcta), pero si basalmente desatura, por ser EPOC, podría bastar el tratamiento oral, con amoxicilina / ácido clavulámico, porque además solo tiene 1 punto del CURB65.

164) Un paciente de 80 años, consulta por cuadro de disnea de un mes de evolución que ha aumentado en el último tiempo, asociado a baja de peso. Al examen físico presenta disminución del murmullo pulmonar en el hemitórax izquierdo con matidez a la percusión. Se solicita radiografía de tórax que muestra presencia de derrame pleural derecho, el que se punciona, dando salida a un líquido pleural con LDH de 300mg/dL, colesterol 60mg/dL, ADA 15 UI, leucocitos 3.000/mm3 con predominio mononuclear. El examen de elección para proseguir con el diagnóstico es:

- a) Broncoscopía
- b) Videotoracoscopia**
- c) Ecografía pleural
- d) Ecocardiografía
- e) TAC de tórax

R: Es un exudado pleural mononuclear y por tanto se debe biopsiar, de primera línea, mediante biopsias percutáneas. Una forma nueva de hacer la biopsia es la videotoracoscopia, que tiene más sensibilidad y que se hace cuando las biopsias percutáneas resultan negativas (en este caso solo salía la VAT, así que esa es la respuesta).

171) Un paciente de 40 años, consulta por disnea desde hace 2 semanas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia matidez a la percusión y disminución del murmullo pulmonar en base izquierda. Se realiza radiografía que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO

El examen más adecuado para seguir con el estudio es:

- a) TAC
- b) AngioTAC
- c) Ecocardiografía
- d) Análisis citoquímico del líquido pleural**
- e) Ecografía pleural

R: Tiene un derrame pleural, que debe ser puncionado, para analizar el líquido.

DICIEMBRE 2017

6) Un paciente de 71 años, con antecedente de tabaquismo de 30 paquetes año, presenta tos de 2 meses de evolución de tos, asociado a baja de peso. Hace 2 días inició con disnea, asociada a dolor con tope inspiratorio. Hoy se agregó fiebre y expectoración hemoptoica. Al examen físico tiene FR: 20x', PA: 110/70 mmHg, FC: 96x', murmullo pulmonar presente, simétrico, con escasos crépitos bilaterales y ritmo regular en 2 tonos, sin ruidos agregados. ¿Cuál es el estudio más adecuado para el enfrentamiento de este paciente?

- a) Radiografía de tórax
- b) Ecocardiografía
- c) Hemograma y hemocultivos

d) AngioTAC de tórax

- e) Cultivos de expectoración

R: La sospecha también es un TEP.

14) Un paciente de 65 años, fumador de 40 paquetes año, consulta por disnea de algunos meses de evolución, progresiva, que actualmente le dificulta caminar más de 3 cuadras. Su examen físico demuestra espiración prolongada y algunas sibilancias en ambos campos pulmonares. Actualmente ya no fuma. Se solicita espirometría que muestra lo siguiente:

Basal Litros % Post SBT Litros %

CVF 2,68 90 CVF 2,96 102

VEF1 1,35 50 VEF1 1,38 51

VEF1/CVF 55 VEF1/CVF 57

FEF25-75 FEF25-75

¿Cuál es el tratamiento inicial?

- a) Salbutamol inhalado
- b) Budesonida inhalada
- c) Ipatropio inhalado
- d) Fluticasona inhalada

e) Tiotropio inhalado

R: Tiene el diagnóstico de EPOC (con espirometría obstructiva, que no mejora con BD). Lo más correcto es que inicie BD de larga acción, más BD de corta acción por horario, pero esto no aparecía en las opciones. Sin embargo, la base del tratamiento del EPOC estable es suspender el cigarrillo y los broncodilatadores de larga acción, como tratamiento sintomático.

15) Un paciente de 21 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y tos con expectoración mucopurulenta, de 2 días de evolución. Al examen físico presenta FC: 70x', PA: 120/80 mmHg, FR: 17x' y en la auscultación pulmonar se escuchan crepitaciones en la mitad inferior del campo pulmonar derecho. Satura 93% a FiO2 ambiental y se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación:

FOTO (Radiografía lateral de tórax con condensación del lóbulo inferior).

¿Cuál es el tratamiento antibiótico más adecuado?

- a) Claritromicina
- b) Cefadroxilo
- c) Clindamicina
- d) Cloxacilina
- e) Ciprofloxacino

R: Lo más correcto era dejar amoxicilina, pero de las opciones, el macrólido era la mejor opción, para una NAC de bajo riesgo.

16) Una paciente de 30 años, asintomática, está cursando un embarazo de 20 semanas. Su marido fue recientemente diagnosticado de tuberculosis pulmonar, mediante baciloscopías de expectoración que resultaron (+++). La mujer se realiza baciloscopías, que son negativas y un PPD que resulta 26 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada para con ella?

- a) Mantener una conducta expectante como protección fetal
- b) Iniciar tratamiento con 4 fármacos (isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol).
- c) Repetir las baciloscopías periódicamente
- d) Administrar la vacuna BCG

e) Indicar profilaxis con isoniazida por 6 meses

R: Es una pregunta demasiado específica y no debería preguntarse. Sin embargo, una embarazada con contacto con un paciente bacilífero y PPD positivo, tiene indicación de profilaxis para TBC.

17) Un paciente 2 meses de malestar general, tos con expectoración, sensación febril, baja de peso y sudoración. Además, en el último tiempo ha aumentado la tos y ha presentado expectoración hemoptoica. Solicita un hemograma que muestra leucocitosis de 15.000 glóbulos blancos por mm3 y se solicita una radiografía que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía de tórax AP, con afectación de ambos lóbulos superiores, mayor al lado izquierdo, con una banda atelectásica en el ápice izquierdo).

¿Cuál es el examen más adecuado ante la sospecha diagnóstica?

- a) Broncoscopia
- b) Baciloscopías de expectoración más cultivo de Koch
- c) TAC de tórax
- d) Cultivo de expectoración
- e) Hemocultivos

R: Tiene clínica de TBC y la RxTx era sugerente.

18) Una paciente de 23 años, que desde la infancia tiene tos frecuente, con expectoración abundante, mayor en la mañana, que en ocasiones es hemoptoica. Además una o dos veces al año, se exacerba los síntomas, con necesidad de uso de antibióticos. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: FOTO (radiografía de tórax AP con afectación en ambas bases, en patrón broncointersticial). ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Recuento de inmunoglobulinas
- b) Test del sudor

c) Resonancia magnética de tórax

d) TAC de tórax

e) Baciloscopías de expectoración

R: La clínica es de bronquiectasias, que se diagnostican preferentemente con un TAC de tórax.

19) Una paciente con antecedente de rinitis alérgica y asma consulta por disnea frecuente, asociada a respiración sibilante y tos, que aparece con frecuencia luego de exponerse a los alérgenos, en la noche, cuando cursa con alguna infección respiratoria alta o después de realizar ejercicio. Al examen físico tiene FR: 13 rpm, satura 96% a FiO₂ ambiental y en su examen pulmonar destacan sibilancias espiratorias bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada con ella?

a) Evitar los alérgenos por 3 meses

b) Iniciar salmeterol 2 puff cada 12 horas

c) Iniciar salbutamol 2 puff cada 6 horas

d) Iniciar fluticasona 2 puff cada 12 horas

e) Iniciar terapia de desensibilización a los alérgenos

R: Lo más correcto es indicar corticoides inhalados cada 12 horas, más salbutamol SOS, pero de las opciones, la D era la más aceptable.

20) Un paciente de 60 años, fumador de 5 cigarrillos al día, consulta por disnea de esfuerzos que ha aumentado en el último tiempo. Ha bajado de peso cerca de 6 kilogramos en los últimos 3 meses. Como antecedente, trabajó durante 30 años en una fábrica de producción de pizarras de asbesto para la construcción. Al examen físico presenta signos vitales normales, edema de extremidades inferiores, yugulares visibles al decúbito y examen pulmonar con MP presente, disminuido a derecha. Se solicita una radiografía de tórax que muestra derrame pleural marcado en el lado derecho, por lo que se realiza punción pleural, que da salida a líquido con 300 células por mm³, con 90% de mononucleares, ADA: 22 UI/L, proteínas: 6 g/dL, estudio citológico negativo, pH: 7,37, lactato: 3 mmol/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Carcinoma pavimentoso

b) Adenocarcinoma

c) Tuberculosis pleural

d) Mesotelioma

e) Silicosis

R: Tiene un derrame canceroso (exudado mononuclear con ADA baja) y el antecedente de exposición a asbesto está muy relacionado a mesotelioma.

21) Un paciente de 55 años, está hospitalizado por una pancreatitis aguda, de diez días de evolución. Presenta un cuadro de fiebre, malestar general y taquipnea de 1 día de evolución. ¿Qué conducta es más adecuada?

a) Solicitar radiografía de tórax

b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

c) Solicitar ecografía abdominal

d) Solicitar angioTAC de tórax

e) Solicitar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

R: La sospecha es un TEP.

60) Un paciente de 36 años presenta desde hace un mes tos irritativa, que se ha vuelto productiva, con expectoración mucosa y últimamente mucopurulenta, asociada a fiebre y malestar general. Al examen está enflaquecido, satura 93% a FiO₂ ambiental, tiene FC: 80x', PA: 110/60 mmHg y FR: 21 rpm. A su examen pulmonar, se auscultan crépitos difusos en ambos campos pulmonares, más algunas sibilancias.

Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía de tórax AP, con patrón alveolointersticial bilateral difuso).

¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Streptococcus pneumoniae
- b) Mycobacterium tuberculosis
- c) Staphylococcus aureus
- d) Mycoplasma pneumoniae

e) Pneumocystis jiroveci

R: La clínica y la radiografía orientaban mucho a un paciente VIH con infección por PJ.

92) Un paciente de 35 años, consulta por un cuadro de 1 semana de malestar general, sensación de edema de la cara en la mañana y tos que ha ido aumentando. Al examen físico se constata una adenopatía cervical, yugulares ingurgitadas y edema facial y de las manos. Además tiene signos de derrame pleural bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tuberculosis
- b) Hipotiroidismo
- c) Taponamiento cardíaco
- d) Mononucleosis infecciosa

e) Síndrome de vena cava superior

R: Es un síndrome de VCI clásico, probablemente secundario a un linfoma, dada la edad y las adenopatías.

94) Un paciente de 26 años, con antecedente de daño cerebral severo, desde hace 2 días presenta sialorrea, tos áfona, estridor inspiratorio y reticencia a alimentarse. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Neumonía aspirativa
- b) Epiglotitis por Haemophilus influenzae tipo B
- c) Crisis epiléptica focal

d) Cuerpo extraño laríngeo

e) Cuerpo extraño esofágico

R: D ¿E? Por la tos áfona y el estridor es un cuerpo extraño laríngeo, pero por la sialorrea y la reticencia a comer era esofágico. Esta pregunta inducía a error. Yo marqué laríngeo, porque le di más importancia a los síntomas laríngeos.

143) Un paciente de 8 años consulta por fiebre alta, asociada a odinofagia intensa. En su examen físico se aprecia faringe eritematosa, asociada a exudado bilateral. Se solicita una prueba rápida de detección de antígenos estreptocócicos, la que resulta positiva. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Amoxicilina

- b) Amoxicilina + ácido clavulánico
- c) Azitromicina
- d) Clindamicina
- e) Metronidazol

R: La amoxicilina es el tratamiento de elección de la amigdalitis estreptocócica.

147) Un niño de 3 años presenta un cuadro de congestión nasal, con rinorrea serosa, asociada a tos y ligera odinofagia. Al examen físico tiene temperatura 37,3 grados celsius, faringe congestiva, rosada y nariz con rinorrea abundante. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

a) Solución salina intranasal

- b) Amoxicilina oral
- c) Corticoides nasales
- d) Diclofenaco oral
- e) Azitromicina oral

R: Es un resfrío común. No aparecía paracetamol SOS, así que la respuesta más adecuada es el SF intranasal.

JULIO 2018

Una paciente de 87 años, institucionalizada, con antecedente de enfermedad de Alzheimer y degeneración macular, presenta lipotimia con recuperación completa, luego de comer. Lcuidadores refieren que la notan rara desde hace algunos días. Su examen físico muestra T°: 38,5°C, FC: 87x', PA: 150/102 mmHg, FR:28 por minuto. El diagnóstico más probable es:

- a. Síncope neurogénico
- b. Neumonía**
- c. Infarto agudo al miocardio
- d. Infección urinaria
- e. Accidente vascular encefálico

R:Es una pregunta muy difícil, ya que la clínica es demasiado inespecífica y puede ser cualquiera de las opciones. Sin embargo, por tener fiebre y además taquipnea, nos inclinamos por la neumonía.

Un paciente de 45 años, indigente que vive en la calle, con antecedente de alcoholismo y drogadicción, presenta un cuadro de 2 meses de evolución de tos con expectoración mucosa y mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica, asociada a malestar general y sensación febril. Al examen físico, está enflaquecido, con T°: 37,2°C, FC: 87x', PA: 110/80 mmHg, FR: 15x'. Su examen pulmonar muestra crépitos bilaterales. Su hemograma muestra hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl VHS: 50 mm/h. PCR: 120 mg/L y elisa VIH negativo. Se realiza una radiografía de tórax, que se muestra a continuación:

El diagnóstico más probable es:

- a. Neumonía adquirida en la comunidad por germen clásico
- b. Cáncer pulmonar
- c. Bronquiectasias
- d. Neumonía por Pneumocystis jiroveci
- e. Tuberculosis pulmonar**

R: Tanto por la clínica, como por la radiografía es una tuberculosis.

Un paciente de 25 años presenta disnea y tos, con expectoración mucosa, que aparece luego de realizar ejercicio y durante las infecciones respiratorias. No presenta síntomas en el reposo. Su examen físico es normal y se solicita un PEF, que resulta 540 L/min, que equivale al 90% del valor esperado. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación:¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?

- a. Prick test
- b. TAC de tórax
- c. Espirometría basal y postbroncodilatador
- d. Niveles plasmáticos de inmunoglobulina E específica
- e. Prueba de provocación bronquial**

R: Es un asma clínico, pero sin obstrucción actual y con examen físico normal, por lo que se debe estudiar con el test de metacolina.

En paciente de 63 años, fumador de 30 paquetes años consulta por cansancio y tos. Refiere que la disnea aparece al caminar 3 cuadras y que la tos es mayor en la mañana. En su examen físico se objetiva aumento del diámetro anteroposterior del tórax y sibilancias escasas bilaterales. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: Además, se realiza una espirometría que resulta: Basal Post-salbutamol

CVF 95% (4.465 cc) 98% (4.606 cc)

VEF1 55% (1.964 cc) 57% (2.036 cc)

VEF1/CVF 44% 48%

El diagnóstico más probable es

- a. Asma
- b. Bronquiolitis
- c. Cáncer pulmonar
- d. Bronquiectasias
- e. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica**

R: Es un EPOC clínico, radiográfico y espirométrico.

Un paciente de 43 años, es agredido en la calle, mientras se encontraba en estado de ebriedad, recibiendo una puñalada en la zona inferior derecha del tórax, por lo que se hace una radiografía que se muestra a continuación:

El diagnóstico más probable es:

- a. Neumotórax
- b. Hemotórax
- c. Enfisema subcutáneo
- d. Neumoperitoneo**
- e. Hemoperitoneo

R: En la radiografía se observa el neumoperitoneo.

Un paciente de 27 años consulta por tos, fiebre alta, disnea y dolor torácico de tipo pleurítico. Al examen físico tiene disminución del murmullo pulmonar izquierdo, con respiración soplante y crépitos. Se solicita una radiografía de tórax que muestra una pleuroneumonía izquierda, por lo que se punciona el derrame pleural, dando salida a un líquido turbio, con LDH: 250 UI/L, proteínas: 5,0 g/dl, con PMN: 60% y MN: 40%, pH: 7,1, lactato: 6 mmol/L, ADA: 8 UI/L. La conducta más adecuada es:

- a. Tomar biopsias pleurales
- b. Instalar un tubo pleural, con trampa de agua**
- c. Administrar fibrinolíticos
- d. Realizar una pleurocentesis y drenaje en 24 horas
- e. Administrar antibióticos pleurales

R: Tenía un empiema o derrame paraneumónico complicado, que se trata con tubo pleural.

Un paciente de 67 años, con antecedente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en tratamiento con broncodilatadores inhalados, evoluciona con aumento importante de su disnea basal, asociado a cianosis y angustia. El paciente está vigil y orientado y en su examen físico tiene FR: 35x', PA: 110/76 mmHg, FC: 110x' y al examen pulmonar se aprecia uso de musculatura accesorio, cianosis, aumento del diámetro anteroposterior y sibilancias y roncus intensos bilaterales. Se ingresa al servicio de urgencia, recibiendo oxígeno y salbutamol, sin respuesta. Se solicitan gases arteriales, que resultan PaO₂: 50 mmHg, PaCO₂: 55 mmHg, pH: 7,29 y HCO₃: 27 mEq/L. La conducta más adecuada es:

- a. Oxígeno por mascarilla al 100%
- b. Bicarbonato endovenoso
- c. Ventilación no invasiva**
- d. Nebulizar con corticoides y salmeterol
- e. Ventilación mecánica invasiva

R: Es un EPOC descompensado, que no responde y que está con una insuficiencia respiratoria global, severa, por lo que requiere apoyo ventilatorio. Por estar vigil y orientado, se prefiere la VM no invasiva, con BiPAP.

Un recién nacido de 30 semanas de edad gestacional, presenta un síndrome de dificultad respiratoria grave, con cianosis, taquipnea y uso de musculatura accesoria. Su examen pulmonar demuestra algunos crépitos y requiere FiO2 de 0,6. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

- a. TAC de tórax
- b. Radiografía de tórax**
- c. Hemocultivos y cultivos de expectoración
- d. Ecocardiografía
- e. Cateterismo cardíaco

R: Se sospecha una enfermedad de membrana hialina, por la edad gestacional, la que se diagnostica con radiografía de tórax.

Una niña de 13 años es encontrada inconsciente en el baño de su casa, con el Calefont apagado. Presenta FC: 70x', PA: 120/80 mmHg, FR: 25x', saturación arterial de 97%, sin cianosis. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Administrar oxígeno al 100%**
- b. Administrar carbón activado
- c. Administrar suero glucosado endovenoso
- d. Administrar suero fisiológico endovenoso
- e. Administrar bicarbonato endovenoso

R: Es una intoxicación por monóxido de carbono, que se trata con O2 al 100%, más cámara hiperbárica.

Un paciente de 23 años consulta por un cuadro de malestar general y fiebre hasta 39,2°C, que empieza a inicios de invierno. Presenta además cefalea intensa, tos seca y rinorrea. Refiere tener mialgias generalizadas y al examen físico está febril, con FC: 101x'. PA: 130/80 mmHg. Su faringe se aprecia eritematosa y congestiva, sin exudado. Su examen pulmonar está normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Amigdalitis estreptocócica
- b. Neumonía bacteriana
- c. Sinusitis bacteriana
- d. Influenza**
- e. Mononucleosis infecciosa

R: Es una gripe o influenza clásica.

Un paciente de 50 años, con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada a los 20 años. Presenta un cuadro de 2 años de evolución de tos con expectoración, que en ocasiones es hemoptoica, asociada a fiebre intermitente y disnea. En su examen físico, se ve enflaquecido y tiene T°: 36,4°C, FC: 70x', PA: 130/88 mmHg. Examen cardíaco normal y examen pulmonar, en que se auscultan crépitos bilaterales. Su hemograma muestra hematocrito: 34%, plaquetas: 188.000 por mm3, blancos: 8.600 por mm3 y VHS: 100 mm/h. Se realiza una radiografía pulmonar, que se muestra a continuación. El diagnóstico más probable es:

- a. Cáncer pulmonar
- b. Aspergiloma**
- c. Tuberculosis pulmonar

- d. Neumonía cavitada
- e. Absceso pulmonar

R: Si bien la clínica también era compatible con una nueva TBC, era muy sugerente de un aspergiloma, formado en las cavernas tuberculosas y además, la radiografía lo mostraba en el lóbulo superior izquierdo. El resto de los hallazgos radiológicos, eran compatibles con las secuelas de la TBC anterior. La imagen original, mostraba una lesión más pequeña que la de esta imagen.

Un niño de 8 años, inmigrante, que no ha recibido la vacuna BCG. Está asintomático y su examen físico es normal. Su padre está siendo tratado para la tuberculosis en su país de origen. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a. Solicitar PPD
- b. Solicitar radiografía de tórax
- c. Solicitar baciloscopías
- d. Iniciar profilaxis con isoniazida**
- e. Administrar la vacuna BCG

R: Es una pésima pregunta, ya que hay que hacer todo lo que ahí aparece, excepto la vacuna BCG. Además, lo más correcto es estudiarlo primero, ya que por ser menor de 15 años, de acuerdo al Minsal, si su radiografía está alterada, o si las baciloscopías están positivas, se debe tratar con 4 fármacos y no solo recibir la profilaxis con isoniazida. Nos inclinamos a dejar como respuesta correcta la profilaxis, ya que por ser menor de 15 años, siempre está indicada (y creemos que eso era lo que se quería preguntar), pero insistimos que la pregunta está derechamente mala.

Un paciente de 60 años, con antecedente de fumar 28 paquetes años, presenta cuadro de tos seca, que en ocasiones es hemoptoica, desde hace 3 meses. Además, ha bajado de peso. En su examen físico presenta FR: 20x', PA: 116/69 mmHg, T°: 37,4°C y en su examen pulmonar, se auscultan sibilancias y crepitaciones en el pulmón derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación:

¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio en este paciente?

- a. TAC de tórax**
- b. Broncoscopía
- c. Cultivo de expectoración
- d. Baciloscopías
- e. PET

R: En nuestra opinión, el diagnóstico más probable era un cáncer, por lo que se tenía que estudiar, tanto con el TAC, que es la forma de objetivar la ubicación, tamaño del tumor, su aspecto y la presencia de metástasis, como la broncoscopía, para poder biopsiarlo y confirmarlo. No quedaba clara la intención de la pregunta, pero nos inclinamos por el TAC, que suele pedirse antes de la confirmación histológica. La foto original venía sin flecha obviamente.

Una paciente de 34 años consulta por congestión nasal, rinorrea y prurito nasal, con estornudos frecuentes. Al examen físico no tiene alteraciones. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación.

¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a. Amoxicilina
- b. Loratadina**
- c. Prednisona
- d. Claritromicina
- e. Salbutamol

R: Era una rinitis alérgica clásica. La radiografía está normal.

Un paciente de 22 años presenta un cuadro de 2 horas de evolución de dolor torácico derecho, con tope inspiratorio. Al examen físico se ausculta disminución del murmullo pulmonar derecho, con hipersonoridad a la percusión. El diagnóstico más probable es:

- a. Pericarditis aguda
- b. Neumotórax espontáneo**
- c. Tromboembolismo pulmonar
- d. Neumonía
- e. Cuerpo extraño bronquial

R: Es un neumotórax clásico.

Un recién nacido de término, sin mayores antecedentes, desde los 7 días de vida comienza con ruido al respirar, de tonalidad alta, que es mayor en la inspiración. Su examen físico no muestra mayores alteraciones y su examen pulmonar es normal. Ha subido adecuadamente de peso y no presenta otros síntomas. EL diagnóstico más probable es:

- a. Fístula traqueoesofágica
- b. Laringomalacia**
- c. Membrana laríngea
- d. Epiglotitis
- e. Laringotraqueobronquitis

R: La causa más frecuente de estridor congénito es la laringomalacia, en especial, si está en buenas condiciones.

Un niño de 18 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea, disfonía y fiebre, hasta 38,5°C. Hace una hora presenta un cuadro de dificultad respiratoria, con respiración ruidosa. Al examen físico se aprecia niño taquipneico, con estridor inspiratorio, uso de musculatura accesoria, sin cianosis. La auscultación pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a. Laringitis aguda viral**
- b. Croup espasmódico
- c. Cuerpo extraño bronquial
- d. Laringomalacia
- e. Coqueluche

Es una laringitis obstructiva clásica, por virus parainfluenza. El croup espasmódico no tiene fiebre, sino que es una reacción de tipo alérgica, o al reflujo o a otra causa, distinta de la laringotraqueítis viral.

Un niño de 6 años consulta por epistaxis bilateral frecuente. Además, tiene antecedente de ser respirador bucal, roncar en la noche y presentar infecciones respiratorias altas a repetición. El diagnóstico más probable es:

- a. Rinofibroangioma bilateral
- b. Rinitis alérgica**
- c. Enfermedad de von Willebrand
- d. Hipertrofia de adenoides
- e. Atresia de coanas

R: Es una pregunta difícil, ya que tanto la rinitis alérgica, como la hipertrofia de adenoides pueden presentar esa clínica. La clínica obstructiva sugiere hipertrofia de adenoides, pero también puede verse en la rinitis alérgica. En cambio, la epistaxis sugiere más una rinitis alérgica, ya que los adenoides no sangran. Yo marqué hipertrofia de adenoides, pero mis amigos otorrinos insisten que es rinitis alérgica, porque es la causa más frecuente no solo de epistaxis, sino de ronquidos, respiración bucal e infecciones a repetición, así que les vamos a creer.

Un niño de 18 meses es traído por su madre, ya que presenta malestar general, fiebre y odinofagia importante. Presenta además rinorrea y congestión nasal. Al examen físico se observa faringe eritematosa, con exudado amigdalino de aspecto blanquecino, bilateral, con adenopatías cervicales bilaterales. Su examen pulmonar es normal. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a. Staphylococcus aureus
- b. Streptococcus pyogenes
- c. Streptococcus pneumoniae
- d. Virus de Epstein Barr

e. Adenovirus

R: Por tener menos de 3 años, no puede ser amigdalitis purulenta, sino que seguramente es viral y el adenovirus parece la opción más aceptable, ya que no siempre cursa con conjuntivitis y es la causa más frecuente de amigdalitis exudativa en lactantes. No tiene clínica de mononucleosis.

GASTROENTEROLOGÍA

1. Paciente de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 3 meses de dolor epigástrico tipo urente que aumenta durante los periodos de ayuno y estrés, asociado ocasionalmente a pirosis. Se realiza endoscopia digestiva alta que objetiva úlcera duodenal activa y se realiza test de ureasa que resulta (-). La conducta más adecuada en este caso es:
 - a. Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina
 - b. Indicar omeprazol y controlar con nueva endoscopia en 6 semanas
 - c. Solicitar nueva endoscopia digestiva alta con test de ureasa
 - d. Iniciar omeprazol, bismuto y metronidazol
 - e. Iniciar medidas anti reflujo y omeprazol a permanencia.
2. Paciente de 80 años, con antecedente de hipertensión, diabetes insulino dependiente con mal control metabólico y epigastralgia en tratamiento crónico con omeprazol, consulta por cuadro de disfagia lógica asociado a odinofagia de un mes de evolución. Al examen físico no se encuentran alteraciones. El diagnóstico más probable es:
 - a. Cáncer esofágico
 - b. Reflujo gastroesofágico
 - c. Acalasia
 - d. Candidiasis esofágica
 - e. Divertículo esofágico
3. Una paciente de 50 años, con antecedente de colecistectomía hace varios años, presenta desde hace dos días cuadro de dolor epigástrico, ictericia fluctuante, orinas oscuras y fiebre. Al examen físico destaca frecuencia cardiaca de 100 por minuto, presión arterial de 80/50 mm de Hg, dolor a la palpación epigástrica, blumberg (+), ruidos hidroaéreos disminuidos. Se solicita ecografía abdominal que muestra vía biliar de 10mm. La conducta más adecuada en esta paciente es:
 - a. Realizar colangiografía
 - b. Realizar tomografía axial computada de abdomen
 - c. Realizar laparotomía abierta
 - d. Indicar antibióticos de amplio espectro y reevaluar en 48 horas
 - e. Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
4. Un paciente de 55 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso asociado a vómitos biliosos. Al examen físico destacan escleras ictericas, sensibilidad a la palpación epigástrica. Se realiza exámenes donde destaca leucocitos 13.000/mm³, PCR 50 mg/dL, GOT 120mg/dL, GPT 140mg/dL, bilirrubina 3mg/dL, fosfatasas alcalinas 400mg/dL, lipasa 100mg/dL. Ecografía abdominal con vía biliar extrahepática dilatada. El diagnóstico más probable es:
 - a. Colangitis aguda
 - b. Pancreatitis aguda
 - c. Colecistitis aguda
 - d. Coledocolitiasis
 - e. Hepatitis aguda
5. Paciente de 28 años, con cuadro de 2 meses de dolor epigástrico urente, que aumenta en ayuno y al beber café, asociado a pirosis y reflujo ocasional. Al examen físico no se aprecian alteraciones. La conducta más adecuada en este caso es:

- a. Iniciar omeprazol
 - b. Iniciar amoxicilina y claritromicina
 - c. Solicitar ecografía
 - d. Solicitar test de ureasa
 - e. Solicitar endoscopia digestiva alta
6. Paciente de 68 años, sin antecedentes conocidos, consulta por cuadro de dolor abdominal desde hace 6 horas, asociado a distensión progresiva, vómitos y sensación febril, además refiere que no ha eliminado gases. Al examen físico destaca ausencia de ruidos hidroaéreos y blumberg (+). Se solicita radiografía de abdomen que se muestra a continuación:
- a. Gastroenteritis aguda
 - b. Vólvulo sigmoide
 - c. Obstrucción intestinal
 - d. Diverticulitis aguda
 - e. Apendicitis aguda



7. Una paciente de 55 años, con antecedente de daño hepático crónico por virus hepatitis C, consulta por cuadro de malestar general, asociado a febrículas, confusión y aumento de perímetro abdominal. Al examen abdominal destaca matidez desplazable. Se realiza paracentesis diagnóstica que muestra transudado y presencia de 300 leucocitos (100% polimorfonucleares). La conducta más adecuada en este caso es:
- a. Administrar albúmina endovenosa
 - b. Realizar paracentesis evacuadora
 - c. Observar
 - d. Administrar antibióticos de forma empírica**
 - e. Iniciar terapia con furosemida y espironolactona
8. Una paciente de 65 años, con antecedente de accidente vascular encefálico con compromiso faciobraquiocrural derecho hace dos años en tratamiento con aspirina, consulta por dolor abdominal difuso e intenso de inicio agudo. Al examen físico se encuentra en regulares condiciones, ritmo irregular, abdomen levemente doloroso a la palpación profunda, blumberg (-). El diagnóstico más probable es:
- a. Isquemia mesentérica**
 - b. Disección aórtica
 - c. Úlcera perforada
 - d. Diverticulitis aguda
 - e. Trombosis mesentérica
9. Un paciente de 45 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso asociado a vómitos biliosos. Al examen físico se encuentra frecuencia cardíaca en 90 por minuto, presión arterial 140/90, escleras levemente ictéricas, abdomen blando, doloroso a palpación epigástrica, blumberg (-). Se solicitan exámenes que muestran GOT 100mg/dL, GPT 110mg/dL, bilirrubina total 2 mg/dL, fosfatasas alcalinas 350mg/dL, lipasa 250mg. Ecografía abdominal que muestra vesícula de paredes delgadas, sin edema, con barro biliar visible y colédoco de 8mm. El diagnóstico más probable es:
- a. Colangitis aguda
 - b. Pancreatitis aguda**
 - c. Coledocolitiasis
 - d. Colecistitis aguda
 - e. Cólico biliar simple
10. Mujer de 29 años, sin antecedentes, con cuadro de tres semanas de dolor abdominal intermitente, de intensidad moderada, asociado a deposiciones con sangre en ocasiones y disentería. Al examen físico se aprecia levemente deshidratada, con dolor a la palpación abdominal profunda, blumberg (-). El diagnóstico más probable es:
- a. Colitis ulcerosa**
 - b. Giardiasis
 - c. Divertículo de Meckel
 - d. Colitis isquémica
 - e. Enfermedad de Crohn
11. Paciente de 65 años, con antecedente de tabaquismo crónico de 30 paquetes/año, consulta por cuadro de 3 meses de compromiso del estado general, pirosis y baja de peso de 10 kg. Al examen físico se

aprecia decaído, deshidratado y muy enflaquecido, con leve edema en extremidades inferiores simétrico. El diagnóstico más probable es:

- a. Cáncer pulmonar
- b. Cáncer gástrico
- c. Cáncer de esófago
- d. Cáncer de páncreas
- e. Cáncer de duodeno

12. Paciente de 43 años, con historia de epigastralgia desde hace 3 semanas sin otros síntomas, como parte del estudio de su patología se realiza endoscopia digestiva alta que muestra gastritis erosiva, sin presencia de úlcera péptica activa y con test de ureasa positivo, por este motivo se indica tratamiento erradicador del helicobacter pylori. Tres horas luego del procedimiento, evoluciona con dolor torácico irradiado a hombro derecho y sensación febril. El examen de elección para confirmar el diagnóstico en este caso es:

- a. Radiografía de tórax
- b. Repetir endoscopia
- c. Tomografía axial computada de tórax
- d. Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
- e. Electrocardiograma

13. Un paciente de 46 años presenta 48 horas de dolor abdominal epigástrico intenso, asociado a vómitos y fiebre hasta 38,2 grados celsius. Al examen físico se aprecia subictérico, adolorido y presenta dolor a la palpación abdominal, mayor en el epigástrico, con ruidos intestinales conservado. En sus exámenes destacan hematocrito: 31%, plaquetas: 350.000 por mm³, leucocitos: 17.000 por mm³, bilirrubina total: 6 mg/dl, bilirrubina directa: 5,4 mg/dl, GOT: 122 UI/L, GPT: 158 UI/L, GGT: 310 UI/L, fosfatasa alcalina: 416 UI/L y amilasa de 280 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a. Colédocolitiasis
- b. Colangitis aguda
- c. Colecistitis aguda
- d. Hepatitis aguda
- e. Pancreatitis aguda

14. Un paciente de 58 años, colecistectomizado hace algunos presenta un cuadro de molestias abdominales, asociadas a ictericia y coluria en algunas oportunidades. Su examen físico muestra FC: 72x', PA: 120/80 mmHg, temperatura: 36,7 grados Celsius. Su piel y mucosas muestran ictericia y su examen abdominal muestra abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación epigástrica, con ruidos hidroaéreos conservados. Se solicitan exámenes de sangre, que muestran GOT: 40 UI/L, GPT: 33 UI/L, GGT: 215 UI/L, FA: 360 UI/L, lipasa: 40 UI/L y protrombinemia: 100%. La ecografía abdominal muestra un cálculo de 7 mm en el colédoco, no obstructivo, lo que se confirma con la colangiografía. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Indicar ácido ursodeoxicólico
- b. Realizar coledocostomía abierta y extracción
- c. Solicitar TAC de abdominal
- d. Realizar colangiopancreatografía terapéutica endoscópica
- e. Indicar dieta y observar evolución

15. Una paciente, diagnosticada de artritis reumatoide, en tratamiento con naproxeno consulta por dolor abdominal alto, de tipo urente, que suele aumentar en los periodos de ayuna. Su examen físico muestra un abdomen blando depresible e indoloro, con ruidos hidroaéreos normales, sin signos de irritación peritoneal. Se realiza una endoscopia digestiva alta, que visualiza una úlcera duodenal activa, sin embargo, no se realizó test de ureasa. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Cambiar el AINE por uno distinto
 - Solicitar una nueva endoscopia digestiva alta
 - Erradicar *Helicobacter pylori*
 - Indicar tratamiento con inhibidores de la bomba de protones por 8 semanas
 - Solicitar anticuerpos contra *Helicobacter pylori*
16. Un paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, consulta por malestar general, asociado a dolor en el flanco izquierdo de dos días de evolución, que inició de forma aguda. Además presenta importante compromiso del estado general. Presenta FC: 101x', PA: 110/70 mmHg, temperatura de 36,0 grados Celsius. Su abdomen es blando, depresible, con dolor a la palpación profunda del flanco izquierdo, sin Blumberg. Además presenta puñopercusión positiva a izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Pielonefritis aguda
 - Diverticulitis aguda
 - Infarto esplénico
 - Isquemia mesentérica
 - Aneurismo aórtico complicado
17. Un paciente de 60 años inicia un cuadro de 2 meses de evolución de pirosis y regurgitación alimenticia diurna y nocturna. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Indicar tratamiento con omeprazol por 6 semanas
 - Realizar radiografías de esófago, estómago y duodeno
 - Indicar tratamiento con domperidona por 6 semanas
 - Realizar endoscopia digestiva alta
 - Realizar medición de pH esofágico por 24 horas (pH-metría esofágica)
18. Un paciente se realiza una cirugía de resección duodenal, con anastomosis primaria, por un cáncer intestinal, hace 6 semanas. Consulta por dolor abdominal epigástrico progresivo, de 24 horas de evolución, al que en las últimas horas se agregan vómitos de contenido intestinal. Al examen físico presenta abdomen blando, depresible e indoloro, sin signos de irritación peritoneal ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Fístula de la anastomosis
 - Recidiva tumoral estenosante
 - Absceso intraabdominal
 - Obstrucción intestinal
 - Perforación de úlcera gástrica
19. Una mujer de 74 años consulta por dolor abdominal tipo cólico, muy intenso de dos días de evolución, al que en el último tiempo se le agregan vómitos e imposibilidad de eliminar gases. Al examen físico presenta temperatura de 37,6 grados Celsius, distensión abdominal, con dolor a la palpación abdominal, sin signos de irritación peritoneal. ¿Qué examen es el más adecuado para evaluar a esta paciente?
- Ecografía abdominal

- b. Entreocclisis por TAC
 - c. Radiografía de abdomen
 - d. Endoscopia digestiva
 - e. TAC de abdomen, sin contraste
20. Un paciente de 70 años ha bajado 4 kilogramos de peso en el último tiempo. Se solicita una ecografía abdominal que visualiza dos lesiones, una en cada lóbulo hepático, de aspecto sólido, hipoecogénicas y borde irregular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Quistes hepático simples
 - b. Metástasis hepáticas
 - c. Adenomas hepáticos
 - d. Hepatocarcinomas
 - e. Hemangiomas hepáticos
21. Un paciente de 54 años con antecedente de daño hepático crónico, por cirrosis alcohólica es hospitalizado para el manejo de un síndrome ascítico. Se inician diuréticos para el tratamiento de la ascitis, sin embargo al tercer día evoluciona con compromiso del estado general y elevación de la creatinina de 0,9 mg/dl a 2,5 mg/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?
- a. Paracentesis evacuadora
 - b. Albúmina endovenosa
 - c. Diálisis peritoneal
 - d. Suspender los diuréticos
 - e. Terlipresina endovenosa
22. Un paciente de 70 años presenta un cuadro de baja de peso de 5 kilogramos en los últimos 3 meses. Además refiere constipación y deposiciones, que en ocasiones presentan sangre. Sus signos vitales son normales y su examen físico muestra un abdomen blando, depresible, indoloro, con ruidos hidroaéros normales, sin visceromegalia. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?
- a. Ecografía abdominal
 - b. TAC de abdomen y pelvis
 - c. Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
 - d. Colonoscopia
 - e. Endoscopia digestiva alta
23. Un paciente de 38 años presenta un cuadro de dolor abdominal, de 4 meses de evolución, de tipo cólico, asociado a baja de peso de 6 kilogramos. En ocasiones presenta deposiciones con sangre y tiene importante pujo rectal. En sus exámenes destaca anemia, con hemoglobina de 9,5 g/dl y hematocrito de 29%. ¿Qué examen es el más adecuado para iniciar el estudio en este paciente?
- a. Anoscopia
 - b. TAC de abdomen y pelvis
 - c. Ecografía abdominal
 - d. Coproparasitológico
 - e. COLONOSCOPIA

24. Una paciente de 26 años consulta por dolor abdominal de 2 meses de evolución, de tipo cólico, que en ocasiones es muy intenso, asociado a diarrea frecuente, que en ocasiones es disintérica. Al examen físico presenta abdomen blando, doloroso, sin signos de irritación abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Enfermedad celiaca
 - Colitis parasitaria
 - Infección por *Clostridium difficile*
 - Colitis ulcerosa
 - Cáncer de colon
25. Un paciente de 55 años, consulta por una hemorragia digestiva alta, con gran compromiso del estado general, por lo que es imposible obtener mayores antecedentes. Al examen físico, no tiene hálito alcohólico, presenta PA: 60/30 mmHg, FC: 115 lpm, con palidez de piel y mucosas, frialdad de extremidades y debilidad de los pulsos. En sus exámenes de sangre destaca hematocrito 25% y protrombinemia de 36%. El diagnóstico más probable es:
- Úlcera gástrica
 - Várices esofágicos
 - Úlcera duodenal
 - Síndrome de Mallory Vice
 - Gastropatía erosiva
26. Un paciente de 60 años, fumador, consulta por ictericia desde hace 10 días, asociada a coluria y prurito de manos. Además refiere baja de peso de 3 kilogramos en el último tiempo. Al examen físico presenta ictericia de piel y mucosas, abdomen blando, depresible, con leve dolor a la palpación del hipocondrio derecho. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GGT: 450 UI/L, GOT: 122 UI/L, GPT: 105 UI/L, bilirrubina total: 17 mg/dl, bilirrubina directa: 15 mg/dl, FA: 712 UI/L. Su ecografía muestra dilatación de la vía biliar intrahepática y colédoco de 12 mm de diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Colédocolitiasis
 - Cáncer de vesícula biliar
 - Colelitiasis
 - Cáncer de cabeza de páncreas
 - Colecistitis aguda
27. Un paciente de 46 años consulta por un cuadro de dolor abdominal tipo cólico, que inició hace 24 horas. En las últimas 6 horas se agregan vómitos de contenido alimentario. Al examen físico presenta abdomen blando, depresible e indoloro, sin signos peritoneales, con aumento de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Pancreatitis aguda
 - Obstrucción intestinal
 - Isquemia mesentérica
 - Úlcera péptica perforada
 - Cáncer de colon perforado
28. Un paciente de 73 años presenta un cuadro de 2 días de dolor abdominal, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, con signos de irritación peritoneal en la zona. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Apendicitis aguda
 - b. Cáncer de colon
 - c. Obstrucción intestinal
 - d. **Diverticulitis aguda**
 - e. Hernia inguinal complicada
29. Un paciente se realiza una colonoscopia, para la resección de unos pólipos intestinales. Algunas horas después presenta dolor abdominal bajo, asociado a hematoquezia escasa y malestar general. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?
- a. Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
 - b. Ecografía abdominal y pélvica
 - c. Colonoscopia
 - d. Radiografía de abdomen y pelvis
 - e. **TAC de abdomen y pelvis**
30. Un paciente presenta dolor epigástrico muy intenso, irradiado a ambos costados, . Tiene antecedente de una transgresión alimentaria y consumo de alcohol, el día anterior. Al examen físico se aprecia adolorido, con temperatura 38 grados, abdomen difusamente doloroso a la palpación, con disminución de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:
- a. Úlcera perforada
 - b. Isquemia mesentérica
 - c. Hepatitis
 - d. Colecistitis aguda
 - e. **Pancreatitis aguda**
31. Un paciente presenta hace una semana dolor en el hipocondrio derecho, intenso, asociado a vómitos, que cede espontáneamente. Actualmente está en buenas condiciones, asintomático, sin alteraciones en el examen físico. ¿Qué examen es el más adecuado para estudiar a este paciente?
- a. **Ecografía abdominal**
 - b. Radiografía de abdomen
 - c. Amilasa / Lipasa
 - d. Colangiorensonancia
 - e. TAC de abdomen
32. Un paciente alcohólico, vagabundo, con antecedente de haber sido tratado por tuberculosis hace dos años, consulta por un cuadro de diarrea y baja de peso, malestar general de algunos meses de evolución. En su examen físico se aprecia IMC de 16, hiperpigmentación de pliegues y melanoplaquias. En sus exámenes tiene K: 5,5 mEq/L, Na: 132 mEq/L. El diagnóstico más probable es:
- a. Síndrome paraneoplásico
 - b. Desnutrición proteica
 - c. **Enfermedad de Addison**
 - d. Cáncer de sitio no precisado
 - e. Pancreatitis crónica

33. Un paciente de 25 años consulta por diarrea, que inició hace 3 meses, que en ocasiones es sanguinolenta. Además presenta pujo y tenesmo frecuente y ha bajado 6 kilogramos de peso. Al examen físico, presenta dolor abdominal a la palpación del flanco izquierdo, ruidos hidroaéreos aumentados y úlceras orales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Solicitar endoscopia digestiva y anticuerpos antitransglutaminasa
 - Iniciar antibióticos orales
 - Solicitar colonoscopia
 - Solicitar ecografía abdominal
 - Pedir un TAC de abdomen y pelvis
34. Un paciente de 55 años, alcohólico, con daño hepático crónico, es traído al servicio de urgencia por deterioro del estado general, dolor abdominal y fiebre de 38,5 grados Celsius. Al examen físico está quejumbroso, en sopor, con dolor a la palpación abdominal y ascitis severa. Se solicita un hemograma que muestra hemoglobina 15 mg/dl, blancos de 15.000 por mm³ y plaquetas de 190.000 por mm³ y sus pruebas hepáticas muestran un daño hepático crónico en etapa C de Child Pugh. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio de este paciente?
- Ecografía abdominal
 - TAC de abdomen y pelvis
 - Colangiografía
 - Estudio de líquido ascítico
 - Endoscopia digestiva alta
35. Una paciente de 27 años presenta constipación de 3 años de evolución, con deposiciones caprinas, duras, que evacua una vez a la semana. Se realiza una radiografía de abdomen que muestra dolicocolon, con contenido en toda su extensión. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?
- Laxantes osmóticos
 - Laxantes de contacto
 - Cambios de hábitos
 - Proquinéticos
 - Cirugía
36. Un paciente inicia tratamiento antituberculoso con 4 fármacos, por una tuberculosis pulmonar. Al séptimo día de tratamiento presenta vómitos y dolor abdominal luego de recibir los fármacos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Agregar omeprazol al tratamiento
 - Retirar uno de los 4 fármacos
 - Suspender el tratamiento y solicitar pruebas hepáticas
 - Derivar para tratamiento secundario
 - Mantener el tratamiento
37. Un paciente de 55 años con pirosis, que es mayor postprandial, que inició hace 2 meses y que ha aumentado en el último tiempo. Además presenta baja de peso de 4 kilogramos en dicho periodo y refiere dolor abdominal, que aumenta al palpar el epigastrio. Además en el último tiempo se han agregado vómitos postprandiales. ¿Cuál es el examen que debe solicitarse para estudiar a este paciente?
- Endoscopia digestiva alta
 - pH-metría de 24 horas

- c. TAC de abdomen
 - d. Ecografía abdominal
 - e. Marcadores tumorales
38. Un paciente con antecedente de daño hepático crónico por alcohol, presenta desorientación, lenguaje incoherente y tendencia a la somnolencia. Al examen físico presenta ictericia, arañas vasculares en la cara y el pecho, asterixis y compromiso cualitativo de conciencia. ¿Qué fármaco es el más adecuado para su tratamiento?
- a. Amonio
 - b. N-acetil-cisteína
 - c. Risperidona
 - d. Donepezilo
 - e. Lactulosa
39. Un paciente es diagnosticado de úlcera gástrica, con test de ureasa positiva, por lo que se inicia tratamiento con amoxicilina 1g cada 12 horas, claritromicina 500mg cada 12 horas y omeprazol 20mg cada 12 horas, por 10 días. Luego queda con omeprazol por 4 semanas más. Se controla posteriormente con antígeno de H. pylori en heces, que resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- a. Repetir el tratamiento, pero por 14 días
 - b. Realizar endoscopia digestiva alta y biopsia
 - c. Indicar tratamiento erradicador de segunda línea
 - d. Realizar test de ureasa
 - e. Observar evolución
40. Un paciente de 35 años, colecistectomizado hace meses, consulta por dolor epigástrico, progresivo, que inició hace 24 horas y que se ha asociado a ictericia y acolia. Al examen físico está afebril, con FC: 80x' y PA: 120/76 mmHg y se aprecia dolor a la palpación del hemiabdomen superior e ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GOT: 42 UI/L, GPT: 63 UI/L, FA: 430 UI/L, GGT: 566 UI/L y bilirrubina de 6,4 mg/dl. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?
- a. TAC de abdomen
 - b. Ecografía abdominal
 - c. Endoscopia digestiva alta y biopsia
 - d. Colangioresonancia
 - e. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
41. Paciente masculino de 42 años, cursa desde hace 1 año con disfagia asociada a regurgitación ocasional de alimentos no digeridos, por lo que necesita tomar agua con las comidas, para poder tragar. Además, refiere baja de peso en los últimos meses. El diagnóstico más probable es:
- a. Cáncer esófago
 - b. Cáncer gástrico de cardias
 - c. Estenosis esofágica, secundaria a esofagitis por reflujo gastroesofágico
 - d. Acalasia esofágica
 - e. Esofagitis por Cándida albicans

42. Un paciente de 70 años, consulta por un cuadro de varios meses de evolución de constipación, alternado con diarrea. Su examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes destaca hematocrito: 36% y hemoglobina de 12 g/dl. ¿Qué examen debe solicitarse a continuación?
- Test de sangre oculta en deposiciones
 - Ecografía abdominal
 - TAC de abdomen y pelvis
 - Colonoscopia**
 - Rectosigmoidoscopia
43. Un paciente de 49 años, fumador, presenta un cuadro de dispepsia postprandial de 4 meses de evolución, asociado a astenia, palidez, ictericia y prurito, que aumenta en las noches. Se solicitan exámenes que muestran hemograma normal y pruebas hepáticas que resultan GOT: 23 UI/L, GPT: 28 UI/L, bilirrubina total: 9,7 mg/dl, bilirrubina directa: 8,5 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 322 UI/L y GGT: 131 UI/L, con protrombinemia 80% y albúmina: 3,2 g/dl. El examen de elección para el estudio de este paciente es:
- Endoscopia digestiva alta
 - Ecotomografía abdominal
 - TAC abdominal
 - Colangiografía por RMN**
 - Colangiografía endoscópica retrógrada
44. Un paciente de 55 años, con antecedente de diabetes mellitus 2, consulta por un cuadro de hematemesis, seguida de malestar general. Al examen físico está pálido, con FC:110x', PA: 100/60 mmHg, constatándose obesidad. En sus exámenes destaca albúmina: 3,0 g/dl; INR: 1,3; hematocrito: 30%, plaquetas: 77.000 por mm³, VCM: 105 fl y VHS: 20 mm/h. El diagnóstico más probable es:
- Síndrome de Mallory Weiss
 - Úlcera gástrica
 - Úlcera duodenal
 - Várices esofágicas**
 - Gastritis crónica atrófica
45. Una paciente de 70 años de edad, con antecedente de cirrosis hepática, sin hábito alcoholístico actual, VHBsAg (-) y Anticuerpos anti-VHC (-), Child Pugh clase A, MELDS: 8 puntos, se realiza una ecografía abdominal, que muestra una lesión sólida, en el lóbulo hepático derecho, de 3,5 cm y aspecto hipoecogénico. En su laboratorio destaca alfafetoproteína de 5,3 ng/ml (VN: 0-7 ng/ml) El diagnóstico más probable es:
- Metastásis hepática
 - Adenoma hepático**
 - Carcinoma hepatocelular
 - Quiste hepático
 - Hemangioma hepático
46. Un paciente de 64 años, con antecedente de cirrosis por NASH, con Child Pugh C, en tratamiento con carvedilol. Hace 1 semana presenta ascitis a tensión, por lo que se indica furosemina y espironolactona. Desde entonces, ha subido 4 kg de peso y al examen físico presenta FC: 90 por minuto, PAM: 72 mmHg, ascitis grado III. En sus exámenes destaca bilirrubina 2,5 mg/dl, INR 1,34, creatinemia: 3,1 mg/dl, Na:

122 mEq/L, K 5.5: mEq/L, Cl: 100 mEq/L y polimorfonucleares: 230 por mm³ en el líquido ascítico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Administrar ceftriaxona i.v.
- b. Administrar solución fisiológica i.v.
- c. Aumentar la dosis de diuréticos
- d. Realizar paracentesis evacuadora y administrar albúmina i.v.
- e. Suspender el carvedilol

47. Un paciente de 43 años acude al servicio de urgencia, luego de 7 días de ingesta alcohólica, porque presentó vómitos alimentarios intensos, seguidos de hematemesis. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor a la palpación epigástrica y en sus exámenes destaca hematocrito: 32%, GOT: 180 UI/L, GPT: 130 UI/L, protrombinemia: 78%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Úlcera gástrica
- b. Úlcera duodenal
- c. Síndrome de Mallory Weiss
- d. Gastritis erosiva
- e. Várices esofágicas

48. Una paciente de 70 años acude por cuadro clínico de doce horas de evolución caracterizada por dolor en hemiabdomen inferior, que ha ido en aumento, siendo mayor en el hemiabdomen izquierdo. Al examen físico, presenta frecuencia cardíaca de 96 lpm, PA: 90/60 mmHg, temperatura 38,5 grados, sudoración y palidez, y examen abdominal con abdomen doloroso a la palpación, con Blumberg (+) y signos de irritación peritoneal en la fosa iliaca izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a. Diverticulitis aguda
- b. Cáncer colorectal complicado
- c. Vólvulo sigmoideo
- d. Obstrucción intestinal
- e. Cáncer de ovario complicado

49. Mujer de 88 años de edad, quien presenta clínica un día de evolución caracterizada por fiebre, diarrea y dolor en hipogastrio. Refiere evacuaciones sin otras alteraciones. Al examen físico presenta temperatura en 38,5 grados, presión arterial de 90/50 mmHg y al examen abdominal presenta dolor y sensibilidad a la palpación en fosa ilíaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

- a. Diverticulitis aguda
- b. Colitis isquémica
- c. Pielonefritis aguda
- d. Enfermedad inflamatoria intestinal
- e. Rectocolitis bacteriana

50. Una paciente de 54 años, se realiza exámenes como parte de chequeo médico, que muestran SGOT: 43 UI/L, SGPT: 70 UI/L, GGT: 433 UI/L, FA: 531 UI/L, bilirrubina total: 3,0 mg/dl, albúmina: 3,7 g/dl y protrombinemia: 88%. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

- a. Colestasia por esteatosis hepática
- b. Cirrosis biliar primaria
- c. Colestasia por compresión externa
- d. Colangitis esclerosante primaria
- e. Colangitis esclerosante secundaria

51. Un paciente de 71 años consulta por dificultad para tragar de 1 mes de evolución. Además presenta halitosis que antes no tenía, asociada a regurgitación de alimentos recién ingeridos
- Estenosis péptica esofágica
 - Divertículo de Zenker**
 - Cáncer de esófago
 - Cáncer de laringe
 - Acalasia esofágica
52. Un paciente de 18 años tiene tendencia a tener una coloración icterica de la piel. Al examen físico presenta escleras de tinte subictérico, sin otras alteraciones. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran bilirrubina total: 2,3 mg/dl, bilirrubina directa: 0,3 mg/dl, mg/dl, FA: 70 UI/L, GGT: 50 UI/L, SGOT: 35 UI/L, SGPT: 40 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Hepatitis
 - Anemia hemolítica
 - Síndrome de Dubin Johnson
 - Síndrome de Gilbert**
 - Síndrome de Crigler Najjar
53. Un paciente con antecedente de daño hepático crónico, por consumo de alcohol, se realiza un TAC abdominal de control, que muestra un tumor sólido en el lóbulo hepático derecho, de 3 cm de diámetro, que es hipervascular en la fase arterial. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Nódulo de regeneración
 - Hepatocarcinoma**
 - Hemangioma hepático
 - Hiperplasia nodular
 - Adenoma hepático
54. Una paciente de 24 años, presenta un cuadro de amenorrea y baja de peso, asociada a náuseas y dolor abdominal de varios meses de evolución. Tiene antecedente de una hermana gemela con hipotiroidismo. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hematocrito: 28%, blancos: 9.600 por mm³, plaquetas: 340.000 por mm³, bilirrubina: 1,1 mg/dl, GOT: 155 UI/L, GPT: 120 UI/L. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?
- Solicitar IgM para VHA
 - Realizar biopsia hepática
 - Solicitar colonoscopia
 - Solicitar ecografía abdominal
 - Solicitar anticuerpos antitransglutaminasa**
55. Un hombre de 25 años consulta por un cuadro de 1 mes de evolución de diarrea, dolor abdominal y malestar general. Además ha tenido disentería en algunas ocasiones y ha bajado 4 kilogramos de peso. Se solicita una colonoscopia, que muestra signos de inflamación en el colon, con zonas de mucosa indemne y sin afectación del recto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Colitis ulcerosa
 - Enfermedad de Crohn**
 - Colitis isquémica
 - Parasitosis intestinal
 - Colitis por Clostridium difficile

56. Un paciente de 23 años presenta dolor abdominal de 2 meses de evolución, asociado a deposiciones acuosas, que han ido en aumento, hasta presentar diarrea varias veces al día. Además ha tenido sensación de fiebre, y ha perdido 3 kilos de peso. Refiere también que en la última semana presentó un cuadro de hematoquezia abundante, con coágulos. ¿Qué examen es el más adecuado para iniciar el estudio de este paciente?
- TAC de abdomen y pelvis
 - Colonoscopia**
 - Coprocultivo y leucocitos fecales
 - Examen parasitológico seriado de deposiciones
 - Toxinas de *Clostridium difficile* en deposiciones
57. Un paciente de 64 años presenta dolor abdominal desde hace un mes, asociado a cambio en el hábito intestinal. Su examen físico no aporta mayor información. Se había realizado un hemograma que muestra una anemia microcítica. ¿Qué examen se debe solicitar?
- Colonoscopia**
 - Radiografía simple de abdomen y pelvis
 - Ecografía abdominal
 - Tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis
 - Test de sangre oculta en deposiciones
58. Un paciente asintomático se realiza pruebas hepáticas como parte de un chequeo médico, que muestran una SGOT: 432 UI/L y SGPT: 310 UI/L. No refiere hábitos tóxicos. Como antecedente, tuvo un hemoperitoneo el año 1992, que requirió de transfusiones. ¿Qué examen se debe solicitar ante la sospecha diagnóstica?
- Antígeno de superficie de VHB
 - IgM para VHA
 - Test de HOMA
 - Anticuerpos antinucleares y anticitoplasma de neutrófilo
 - Anticuerpos totales contra VHC**
59. Un paciente de 34 años lleva 48 horas con dolor abdominal tipo cólico, que ha ido en aumento, asociado a deposiciones líquidas abundantes y sensación febril. Al examen físico tiene temperatura axilar: 37,1 grados Celsius, FC: 80x', PA: 120/80 mmHg, presenta dolor a la palpación del abdomen, mayor en la fosa iliaca derecha. No tiene signo de Blumberg. Se solicita una ecografía abdominal que muestra inflamación del íleon distal y del colon derecho y se ve el apéndice con leve edema de la pared y un coprolito en su base. ¿Cuál es el diagnóstico más probables?
- Apendicitis aguda
 - Enteritis infecciosa**
 - Diverticulitis aguda
 - Enfermedad de Cröhn
 - Colitis isquémica
60. Una paciente diabética, presenta hematemesis en 3 oportunidades. Su frecuencia cardíaca es 117x', su presión arterial es 90/60 mmHg. Al examen físico presenta arañas vasculares en la cara, ictericia en las escleras, abdomen blando depresivo e indoloro, con signos de ascitis. Se solicitan exámenes que

muestran bilirrubina total: 4,3 mg/dl, hematocrito: 39%, INR: 1,8. La causa más probable de su hemorragia digestiva es:

- a. **Várices esofágicas**
 - b. Úlcera gastroduodenal
 - c. Gastritis erosiva
 - d. Síndrome de Mallory Weiss
 - e. Esofagitis erosiva
61. Una paciente de 60 años presenta dolor abdominal de 2 días de evolución, mayor en el abdomen bajo. Al examen físico tiene dolor a la palpación abdominal, especialmente en la fosa iliaca izquierda, con signo de Blumberg positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Enfermedad inflamatoria pélvica
 - b. **Diverticulitis aguda**
 - c. Colitis isquémica
 - d. Apendicitis aguda
 - e. Enfermedad de Cröhn
62. Una paciente de 60 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica electiva, por una colelitiasis. La biopsia es informada como presencia adenocarcinoma invasor en el fondo de la vesícula, subseroso. Se solicita un TAC de abdomen y pelvis con contraste, que no visualiza metástasis. ¿Cuál es la conducta?
- a. Quimioterapia
 - b. Radioterapia
 - c. Cuidados paliativo
 - d. Control con TAC cada 3 meses
 - e. **Colecistectomía radical**
63. Una paciente de 50 años consulta por dolor abdominal de 12 horas de evolución, intenso y asociado a vómitos. Además ha presentado fiebre hasta 38,8 grados y aumento del dolor abdominal, en especial en el hemiabdomen superior. Al examen físico tiene ictericia de piel y mucosas, PA: 90/60 mmHg y FC: 116x'. Se realiza una ecografía abdominal que muestra colédoco de 11 mm de dilatación y litiasis en la vesícula biliar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- a. Realizar colecistectomía laparoscópica
 - b. **Realizar drenaje endoscópico de la vía biliar**
 - c. Solicitar colangiografía resonancia magnética nuclear
 - d. Solicitar TAC de abdomen y pelvis
 - e. Realizar colecistectomía más coledocostomía
64. Una paciente de 92 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer por lo que está institucionalizada, presenta un cuadro de astenia, debilidad, baja de peso de 6 kilos en los últimos dos meses, asociado a hematoquesia intermitente en algunas oportunidades, que los familiares atribuyen a hemorroides externos. Al examen físico presenta un abdomen blando, depresible, con ruidos hidroaéreos presentes. Su piel se aprecia algo pálida y sus signos vitales son normales. ¿Con que examen debe iniciarse el estudio en esta paciente?
- a. Ecografía abdominal
 - b. TAC de abdomen y pelvis
 - c. Resonancia magnética de abdomen y pelvis
 - d. Colonoscopia corta
 - e. **Colonoscopia completa**

65. Un paciente presenta disfonía y disartria, como secuela, luego de haber sufrido un traumatismo encefalo craneano. Evoluciona posteriormente con múltiples neumonías aspirativas. ¿Cuál es la causa más probable de estas neumonías?
- Reflujo gastroesofágico
 - Estenosis subglótica
 - Divertículo esofágico
 - Trastorno de la deglución
 - Parálisis frénica
66. Un paciente de 27 años, con historia de pirosis y regurgitación de algunos meses de evolución, siendo diagnosticado de reflujo gastroesofágico. Se indican cambios en los hábitos alimentarios y omeprazol a razón de 20 mg al día y se controla un mes después con endoscopia digestiva alta que demuestra esofagitis distal severa y test de ureasa (+). ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Agregar prokinéticos
 - Agregar antiácidos
 - Duplicar la dosis de omeprazol
 - Erradicar Helicobacter Pylori
 - Tratamiento quirúrgico
67. Un paciente de 60 años, que hace tres años se habría realizado una colecistectomía con coledocostomía, consulta por cuadro de dolor abdominal tipo cólico intenso, asociado a vómitos alimentarios. No ha podido eliminar gases. Al examen físico presenta dolor difuso a la palpación abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad y tonalidad, con blumberg presente. El diagnóstico más probable es:
- Obstrucción intestinal
 - Trombosis venosa mesentérica
 - Embolia mesentérica
 - Pancreatitis
 - Diverticulitis
68. Un paciente de 77 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, consulta por dolor abdominal de tipo inespecífico, de 2 meses de evolución, sin otros síntomas. En su examen físico se palpa un tumor abdominal de 4 a 5 cm de diámetro, en la zona umbilical, pulsátil, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Trombosis mesentérica
 - Tumor de colon
 - Tumor de páncreas
 - Diseccción aórtica
 - Aneurisma aórtico abdominal
69. Un paciente de 40 años, con antecedente de colecistectomía laparoscópica hace un año por colelitiasis, consulta por cuadro de 24 horas de dolor abdominal asociado a vómitos e ictericia. Su perfil hepático muestra GOT: 42UI/L, FA: 450mg/dL, bilirrubina total es de 10,3mg/dL, con bilirrubina directa de 9,5 mg/dL. Se realiza una ecografía abdominal que muestra dilatación de la vía biliar principal, sin visualización de cálculos. El examen de elección para continuar el estudio es:
- Colangiografía endoscópica
 - Colangiografía endoscópica

- c. TAC de abdomen y pelvis
 - d. Exploración quirúrgica
 - e. Marcadores tumorales
70. Un paciente de 62 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo dos y de daño hepático crónico secundario a una esteatohepatitis no alcohólica, ha presentado hospitalizaciones por cuadros de hemorragia digestiva alta en el último año, actualmente controlado. Se realizan exámenes de control en que se demuestra fosfatasas alcalinas de 565 UI/L, GOT: 186 UI/L GPT: 172 UI/L, bilirrubina total 4,2mg/dL, alfafetoproteína: 119 ng/mL. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?
- a. Endoscopia digestiva alta
 - b. Ecografía abdominal
 - c. TAC abdominal
 - d. Gammaglutamil transferasa
 - e. Colangioresonancia
71. Un paciente de 66 años, hipertenso, cardíopata, en tratamiento anticoagulante por una fibrilación auricular crónica, consulta por dolor abdominal brusco, muy intenso, de 6 horas de evolución. Al examen físico presenta ritmo irregular en 2 tiempos y abdomen doloroso a la palpación, con signos peritoneales difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Trombosis de la vena mesentérica
 - b. Hemoperitoneo
 - c. Úlcera péptica perforada
 - d. Embolia mesentérica
 - e. Aneurisma aórtico abdominal roto
72. Una paciente de 70 años consulta por un cuadro de dolor abdominal y sensación febril, de 6 horas de evolución, a lo que se ha agregado ictericia. Al examen físico presenta FC: 87x', PA. 90/60 mmHg, temperatura: 38,5 grados Celsius. Al examen abdominal tiene intenso dolor a la palpación epigástrica, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Coledocolitiasis
 - b. Colangitis aguda
 - c. Pancreatitis aguda
 - d. Colecistitis aguda
 - e. Hepatitis aguda
73. Una paciente de 31 años, con antecedente de parto hace 3 meses, consulta por un cuadro de diarrea de dos meses de evolución de tipo acuoso que ha empeorado en los últimos días, no ha presentado fiebre ni sangre en sus deposiciones. En su examen físico presenta dolor difuso a la palpación abdominal y meteorismo. El diagnóstico más probable es:
- a. Enfermedad celiaca
 - b. Colitis ulcerosa
 - c. Diarrea nosocomial
 - d. Enteroparasitosis
 - e. Diarrea crónica funcional

74. Una paciente de 23 años, consulta por un cuadro de diarrea de tres meses de evolución asociada a sensación febril y fiebre cuantificada hasta 38,0°C. Además, ha presentado disentería en algunas oportunidades y refiere entre otros síntomas, dolor articular migratorio en las cuatro extremidades. Al examen físico se aprecian aftas orales y nódulos eritematosos dolorosos en la cara anterior de las piernas. Su examen abdominal muestra un abdomen blando, doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. El diagnóstico más probable es:
- Enfermedad celiaca
 - Infección por salmonella
 - Déficit de IgA
 - Colitis ulcerosa**
 - Lupus eritematoso sistémico
75. Un paciente de 40 años, con antecedente de infección crónica por VIH, diagnosticado hace varios años, sin tratamiento, consulta por diarrea de 3 meses, de tipo acuoso, sin fiebre, asociado a dolor abdominal. Al examen físico está afebril y presenta abdomen blando, depresible, levemente doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el agente etiológico más probable
- Salmonella sp.
 - Shigella sp.
 - Criptococcus
 - Microsporidium**
 - Toxoplasma gondii
76. Una mujer de 50 años, es diagnosticada recientemente de diabetes, por lo que está en tratamiento con hipoglucemiantes orales, presenta un cuadro de 2 semanas de prurito generalizado, asociado a astenia e ictericia. En su examen físico, destaca ictericia de piel y escleras. Se solicitan exámenes, entre los que destaca bilirrubina: 5,7 mg/dl, fracción directa: 4,7 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 540 UI/L, GGT: 344 UI/L, GOT: 70 UI/L. Se realiza una ecografía abdominal que muestra una vía biliar dilatada, de 12 mm a la altura del conducto hepático común, con vesícula biliar muy distendida, de paredes finas. El diagnóstico más probable es:
- Colangitis esclerosante primaria
 - Ampuloma
 - Coledocolitiasis
 - Cáncer de páncreas**
 - Colangiocarcinoma
77. Una paciente de 59 años inicia un cuadro de 3 semanas de evolución de pirosis y dolor epigástrico, con episodios diurnos y nocturnos. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Realizar endoscopia digestiva alta**
 - Solicitar ecografía abdominal
 - Solicitar TAC de abdomen
 - Iniciar omeprazol oral
 - Medir pH esofágico de 24 horas
78. Un paciente de 64 años, diabético e hipertenso, mal controlado, consulta por dolor abdominal de 5 días de evolución, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen físico está adolorido, con T°: 37,4 grados, FC: 88x', PA: 120/82 mmHg. Tiene abdomen blando, depresible, doloroso, más intenso en el hemiabdomen

izquierdo, sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el estudio?

- a. Colonoscopia
- b. Ecografía abdominal
- c. Radiografía de abdomen simple
- d. Tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis
- e. Resonancia magnética de abdomen y pelvis

79. Un paciente de 80 años, consulta por dolor abdominal de 2 días de evolución, tipo cólico, intenso, al que se han agregado vómitos alimentarios importantes. El dolor es más intenso en el hemiabdomen superior. Al examen físico se aprecia paciente adolorido, con PA: 110/68 mmHg, FC: 110x', T°: 37,4. Abdomen doloroso a la palpación, con distensión abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados y sin signos de irritación peritoneal. Se solicitan exámenes entre los que destaca PCR: 10 mg/dl, hematocrito: 37%, blancos: 11.000 por mm³, plaquetas: 340.000, GOT: 66 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a. Colitis isquémica
- b. Trombosis de la vena mesentérica
- c. Perforación gástrica
- d. Pancreatitis aguda
- e. Obstrucción intestinal

80. Un paciente de 70 años presenta tres episodios de hematoquecia abundante, en las últimas 24 horas. Al examen físico, está taquicárdico, sudoroso, con PA: 90/60 mmHg. Su abdomen se palpa blando, depresible y doloroso. ¿Cuál es la causa más probable de su hemorragia digestiva?

- a. Colitis isquémica
- b. Hemorroides internos
- c. Cáncer de colon
- d. Enfermedad diverticular
- e. Colitis ulcerosa

81. Una paciente de 45 años consulta por astenia de 8 meses de evolución, asociada a prurito. Hace 2 meses se agrega ictericia y acumulación de grasa en los pliegues cubitales, poplíteos y alrededor de los ojos. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran bilirrubina: 4,9 mg/dl, fosfatasa alcalina: 655 UI/L, GOT: 88 UI/L, GPT: 76 UI/L, GGT: 230 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a. Hepatitis autoinmune
- b. Cirrosis idiopática
- c. Colédocolitiasis
- d. Cirrosis biliar primaria
- e. Cirrosis biliar secundaria

82. Una mujer de 41 años presenta diarrea de 3 semanas de evolución con deposiciones acuosas y hemorragia ocasional, asociada a fiebre, artralgias y aparición de úlceras orales. Al examen está hidratada, con temperatura: 37,3°C. Su examen abdominal muestra abdomen distendido, doloroso a la palpación, con ruidos hidroaéreos presentes y ausencia de signos peritoneales. El diagnóstico más probable es:

- a. Enfermedad de Crohn

- b. Colitis ulcerosa
 - c. Colitis isquémica
 - d. Cáncer de colon
 - e. Colitis por *Clostridium difficile*
83. Una paciente de 32 años tiene un cuadro de náuseas y dolor abdominal, que es mayor luego de comer y en las tardes. Su examen físico no tiene alteraciones. Se solicita una ecografía abdominal, que visualiza un pólipo en la vesícula biliar, de 4 mm de diámetro y aspecto homogéneo, sin presencia de cálculos. La conducta más adecuada es:
- a. Realizar colecistectomía laparoscópica
 - b. Solicitar endoscopia digestiva alta
 - c. Realizar seguimiento con ecografía en 6 meses
 - d. Realizar colangiografía resonancia
 - e. Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
84. Una paciente de 51 años consulta por disfagia ilógica intermitente, de 6 meses de evolución, asociada a odinofagia, pirosis y en ocasiones dolor retroesternal, más baja de peso de 4 kilogramos en los últimos meses. Es usuaria de omeprazol y el examen físico no presenta alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Acalasia esofágica
 - b. Candidiasis esofágica
 - c. Cáncer de esófago
 - d. Esofagitis por reflujo
 - e. Esofagitis eosinofílica
85. Una mujer de 30 años consulta por disfagia ilógica intermitente, asociada a pirosis, regurgitación de alimentos y en ocasiones, dolor retroesternal. Es usuaria de omeprazol, de manera intermitente. Su examen físico muestra signos vitales normales y el examen abdominal también es normal. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en esta paciente?
- a. Manometría esofágica
 - b. Radiografías contrastadas de esófago, estómago y duodeno
 - c. Monitorización de pH esofágico de 24 hora
 - d. TAC de abdomen y pelvis
 - e. Ecografía abdominal
86. Una paciente de 46 años, consulta por dolor abdominal de 1 mes de evolución, mayor en la fosa ilíaca derecha, asociada a artralgias y sensación febril, a lo que se ha asociado diarrea acuosa, que en ocasiones es disintérica. Ha bajado 4 kilogramos de peso y ha notado palidez. Al examen físico presenta abdomen sensible de manera difusa, con dolor especialmente intenso en la fosa ilíaca derecha. Se solicita un hemograma, que muestra Hematocrito: 30%, blancos: 12.000 por mm³ y plaquetas: 220.000 por mm³. El diagnóstico más probable es:
- a. Colitis isquémica
 - b. Colitis ulcerosa
 - c. Colitis isquémica
 - d. Enfermedad de Crohn
 - e. Cáncer de colon

87. Una paciente de 56 años, con cambio del hábito intestinal, presenta un cuadro de astenia y palidez, por lo que se realiza un hemograma, que demuestra hematocrito: 30%, hemoglobina: 10,1 g/dl, VCM:76, blancos: 7.500 por mm³ y plaquetas: 230.000 por mm³. Se realiza endoscopia digestiva alta, que resulta normal. El estudio más adecuado para proseguir el estudio de esta paciente es:
- TAC de abdomen
 - Ferritina
 - Test de sangre oculta en deposiciones
 - Colonoscopia**
 - Ecografía abdominal
88. Una paciente de 17 años, consultó por epigastralgia recurrente, que en algunas ocasiones se había asociado a melena. Se realiza endoscopia digestiva alta, que muestra una úlcera y erosiones en la primera porción del duodeno. Como antecedente refiere cefalea ocasional, que trata con paracetamol. Su padre fue tratado de úlcera duodenal. ¿Cuál es la causa más probable de sus alteraciones?
- Enfermedad celíaca
 - Enfermedad de Cröhn
 - Síndrome de Zollinger Ellison
 - Consumo de medicamentos
 - Helicobacter pylori**
89. Un paciente de 52 años consulta por dolor abdominal intenso, asociado a vómitos alimentarios, a los que luego se ha agregado coluria y fiebre. Al examen físico tiene T°:39°C, FC: 100x'. PA: 90/60 mmHg. Al examen abdominal se palpa abdomen doloroso, mayor en el abdomen superior, con ruidos hidroaéreos presentes. Se solicita hemograma que muestra 18.000 glóbulos blancos por mm³; hematocrito: 45%, plaquetas normales. Además, tiene bilirrubina: 5,8 mg/dl, bilirrubina directa: 3,6 mg/dl, GOT: 88 UI/L, GPT: 74 UI/L, GGT: 370 UI/L, FA: 468 UI/L, amilasa: 280 UI/L. El diagnóstico más probable es:
- Colecistitis aguda
 - Colédocolitiasis
 - Colangitis aguda**
 - Pancreatitis aguda
 - Colelitiasis
90. Un hombre de 53 años consulta por hematemesis y melena en varias oportunidades. Al examen físico tiene parotidomegalia, asterixis, eritema palmar y edema de EEII. ¿Cuál es la causa más probable de su hemorragia digestiva?
- Várices esofágicas**
 - Úlcera gástrica
 - Úlcera duodenal
 - Gastritis erosiva
 - Síndrome de Mallory Weiss

ENDOCRINOLOGÍA

1. Un paciente de 50 años, sin antecedentes, acude a realizarse un chequeo, asintomático. Su examen físico es normal. Trae exámenes que se habría tomado la semana pasada donde destaca hemoglobina 14 mg/dL, leucocitos 7.000/mm³, plaquetas 230.000/mm³, creatinina 0.8 mg/dL, calcio 11, albúmina 4, electrocardiograma normal. La conducta más adecuada en este caso es:
 - a. Mantener control ambulatorio anual
 - b. Solicitar cintigrafía ósea
 - c. Solicitar radiografía de huesos largos y huesos parietales
 - d. Solicitar niveles de paratohormona
 - e. Solicitar electroforesis de proteínas
2. Una paciente de 13 años, sin antecedentes, consulta por cefalea e hirsutismo. Al examen físico se encuentra presión arterial en percentil 99 para su edad, índice de masa corporal mayor al percentil 95 para su edad, acné inflamatorio en su rostro y estrías abdominales. El diagnóstico más probable es:
 - a. Diabetes mellitus tipo 2
 - b. Síndrome de ovario poliquístico
 - c. Síndrome de Cushing
 - d. Hipotiroidismo
 - e. Hiperprolactinemia
3. Una paciente de 16 años, obesa, consulta por astenia y debilidad de semanas de evolución, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se corrobora obesidad en percentil 97 para la edad, se aprecia hirsutismo, acné inflamatorio y estrías abdominales. El diagnóstico más probable es:
 - a. Resistencia insulínica
 - b. Síndrome de ovario poliquístico
 - c. Síndrome de Cushing
 - d. Diabetes Mellitus tipo 1
 - e. Hiperprolactinoma
4. Una paciente de 16 años de edad, con cuadro caracterizado por polidipsia y poliuria desde hace aproximadamente 3 semanas, no asociado a otros síntomas. Se realizan exámenes donde destaca osmolaridad plasmática disminuida, por lo que se solicita test de la sed que muestra normalización de diuresis y osmolaridad plasmática. El diagnóstico más probable es:
 - a. Polidipsia psicógena
 - b. Diabetes insípida nefrogénica
 - c. Diabetes insípida central
 - d. Hipercalcemia
 - e. Diabetes mellitus tipo 1
5. Una paciente de 30 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por cuadro de 8 días de sudoración, palpitaciones e insomnio, que durante los últimos días se ha asociado a dolor en región cervical anterior. Al examen físico se aprecia con frecuencia cardíaca de 100 por minuto, presión arterial 140/90, dolor a la palpación cervical. Se solicitan exámenes donde destaca T4 y T4L aumentadas y TSH suprimida, electrocardiograma normal. El tratamiento de elección en este caso es:

- a. Propiltiouracilo
 - b. Paracetamol
 - c. Metimazol
 - d. Ketoprofeno
 - e. Enalapril
6. Un paciente se realiza hace poco una tiroidectomía total, por un cáncer de tiroides, evolucionando en el postoperatorio con marcado compromiso del estado general y debilidad muscular generalizada, asociado a parestesias. Refiere parestesias intensas en las extremidades y en la región peribucal y al examen físico se aprecia contracción del músculo masétero al golpear la zona de la rama mandibular. Además se produce espasmo de la mano y la muñeca en flexión, al inflar el manguito de presión arterial, recuperándose a los pocos minutos de desinflarlo ¿Qué examen es el más adecuado para establecer el diagnóstico en este caso?
- a. Calcio plasmático
 - b. Cloro plasmático
 - c. Sodio plasmático
 - d. Magnesio plasmático
 - e. PTH plasmática
7. Una mujer de 47 años consulta por bochornos, que aparecen con frecuencia. Está en amenorrea desde hace 9 meses y se realiza exámenes, que muestran FSH de 45 UI/L, colesterol total de 240 mg/dl y triglicéridos de 286 mg/dl. El tratamiento más adecuado es:
- a. Raloxifeno
 - b. Estrógenos orales
 - c. Estrógenos más progesterona por vía transdérmica.
 - d. Sertralina
 - e. Venlafaxina
8. Una paciente de 40 años está en amenorrea desde hace 4 meses y ha presentado subida de peso de 8 kilogramos en dicho periodo. Al examen físico presenta FC: 67x', PA: 150/96, asociado a obesidad de predominio abdominal, con estrías vinosas en el abdomen. El examen de elección para iniciar el diagnóstico es:
- a. Cortisol matinal y vespertino
 - b. Cortisol y ACTH a las 9 am
 - c. TAC de gándula suprarrenales
 - d. RMN de la región selar
 - e. Cortisol libre urinario de 24 horas
9. Un paciente de 33 años consulta por disminución de la libido y de la potencia sexual, asociado a astenia. Se realiza exámenes que muestran testosterona de 180 ng/dl (valor normal: 270 a 1070), LH: 1,8 (valor normal: 1,5 a 9,8) y prolactinemia en rango normal. Para continuar el estudio de este paciente se debe solicitar:
- a. Ecografía testicular
 - b. FSH
 - c. TSH
 - d. Resonancia magnética de la región selar
 - e. Prueba de LHRH

10. Un paciente de 27 años es diagnosticado de hipertensión arterial, mediante prueba de monitoreo de presión arterial de 24 horas. Presenta presiones arteriales cercanas a 180/110 mmHg y en sus exámenes destaca potasio plasmático de 3,0 mEq/L, sodio plasmático de 140 mEq/L y cloro plasmático de 97 mEq/L. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?
- Ecodoppler renal**
 - Metanefrinas en orina de 24 horas
 - Biopsia renal
 - Índice de aldosterona / actividad de renina plasmática
 - PTH y calcio
11. Un paciente de 30 años consulta por un cuadro de nerviosismo, sudoración, diarrea e intolerancia al calor, asociado a palpitations, debilidad y dificultades para ver. Al examen físico presenta piel sudorosa y fina, con exoftalmos bilaterales, mayor a derecha y un bocio difuso, con soplo. Su TSH resulta 0,01 UI/L y su T4 libre de 2,8 ng/dl (VN: 0,75 – 1,95). ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?
- Cintigrafía tiroidea**
 - T3 plasmática
 - Anticuerpos antitiroideos
 - Ecografía cervical
 - Biopsia por punción
12. Una paciente de 28 años, se realiza una histerectomía postparto, por una inercia uterina. Usted la atiende 6 meses después, sin lactancia y permaneciendo en amenorrea. Presenta un cuadro de astenia, adinamia y malestar general, asociada a debilidad. Tiene piel seca, con cabello quebradizo, palidez y su presión arterial es de 90/60 mmHg. El diagnóstico más probable es:
- Tiroiditis postparto
 - Panhipopituitarismo**
 - Depresión postparto
 - Insuficiencia ovárica
 - Hipotiroidismo
13. Una paciente de 35 años presenta un cuadro de astenia importante. Al examen físico tiene FC: 59x', PA: 110/70 mmHg, se aprecia palidez, ictericia, vitiligo, edema de EEII, piel seca, con pelo quebradizo. En sus exámenes tiene hematocrito: 27%, con VCM: 110. El diagnóstico más probable es:
- Depresión
 - Daño hepático crónico
 - Déficit de vitamina B12
 - Enfermedad de Addison
 - Hipotiroidismo**
14. Una paciente de 38 años, usuaria de anticonceptivos combinados orales, desde hace 4 meses, consulta por galactorrea de algunas semanas de evolución, sin otros síntomas. Las mamas se palpan sin nódulos y se objetiva la galactorrea al comprimir las mamas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Solicitar niveles de progesterona
 - Solicitar niveles de prolactina**
 - Cambiar los anticonceptivos a progestágenos solos
 - Solicitar TAC de cerebro

- e. Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH
15. Un paciente alcohólico, vagabundo, con antecedente de haber sido tratado por tuberculosis hace dos años, consulta por un cuadro de diarrea y baja de peso, malestar general de algunos meses de evolución. En su examen físico se aprecia IMC de 16, hiperpigmentación de pliegues y melanoplaquias. En sus exámenes tiene K: 5,5 mEq/L, Na: 132 mEq/L. El diagnóstico más probable es:
- Síndrome paraneoplásico
 - Desnutrición proteica
 - Enfermedad de Addison
 - Cáncer de sitio no precisado
 - Pancreatitis crónica
16. Un paciente presenta astenia y aumento de tamaño de la mandíbula, con separación entre los dientes. Además refiere hipertrofia malar, de la nariz y las manos. También ha aumentado el número de sus zapatos. ¿Qué examen es más adecuado para continuar el estudio de este paciente?
- Niveles de hormona de crecimiento
 - Radiografías de pies y de la arcada dentaria
 - Radiografía de manos
 - Niveles de IGF-1
 - Resonancia magnética de hipófisis
17. Una paciente de 65 años, en tratamiento con calcio 2 gramos al día y vitamina D, 600 UI al día, se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -2,7 en la cadera derecha y de 2,8 en la columna lumbar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Indicar ejercicio aeróbico
 - Indicar reposo relativo
 - Aumentar dosis de vitamina D y calcio
 - Agregar bifosfonatos al tratamiento
 - Mantener el tratamiento
18. Una paciente de 17 años, con IMC de 34, presenta oligomenorrea, desde su primera menstruación. Además tiene acné y se observa hirsutismo en la cara, los pezones e intermamario. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?
- Testosterona plasmática
 - Andrógenos totales
 - Prueba de progesterona
 - Índice de andrógenos libres
 - 17 hidroxiprogesterona
19. Una paciente de 27 años de edad, con antecedente de parto hace 9 meses, dando lactancia materna parcial, consulta porque no ha iniciado sus menstruaciones aún. Está usando medroxiprogesterona inyectable intramuscular 150 mg cada 3 meses, como anticonceptivo. Su test de embarazo ha resultado negativo en más de una oportunidad. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Solicitar prueba de progesterona
 - Solicitar TSH y prolactina
 - Solicitar niveles HCG en sangre venosa
 - Mantener el tratamiento

- e. Solicitar ecografía transvaginal
20. Una paciente de 14 años aún no ha tenido su menarquia. Presenta desarrollo puberal Tanner 2, mamario y pubiano, con vello axilar. No tiene otras alteraciones en el examen físico. La conducta más adecuada es:
- Solicitar ecografía ginecológica
 - Solicitar cariotipo
 - Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH
 - Realizar prueba de progesterona
 - Controlar en un año
21. Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico destaca PA: 170/95 mmHg, FC: 80 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K: 2.6 mEq/L, Cl: 90 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. La causa más probable de la hipertensión es:
- Hipertensión renovascular
 - Feocromocitoma
 - Hipotiroidismo
 - Hiperaldosteronismo
 - Hipertensión esencial
22. Un paciente de 64 años consulta por astenia y mialgias de 3 meses de evolución. Se solicita TSH, que resulta 5,6 UI/L y T4 libre, que resulta 1,2 ug/ml (Valor Normal: 0,95 a 1,75 ug/ml). La conducta más adecuada es:
- Solicitar ecografía cervical
 - Iniciar levotiroxina
 - Solicitar TSH y T4 libre en 3 meses
 - Indicar punción tiroidea
 - Solicitar cintigrafía tiroidea
23. Una mujer de 34 años, con amenorrea de 6 meses, presenta un cuadro de astenia y malestar general. Además, refiere equimosis ante mínimos traumatismos. Actualmente tiene PA: 150/90 mmHg, acné facial, cuello ancho, obesidad centrípeta y estrías violáceas. Tiene prueba de embarazo negativa. ¿Cuál es la prueba a realizar en primer lugar?
- Cortisol plasmático basal
 - FSH y estradiol plasmático
 - Cortisol libre urinario
 - Prueba de estimulación con ACTH
 - Resonancia magnética de silla turca
24. Un paciente de 32 años consulta por un cuadro de disfunción sexual asociado a disminución del vello facial. Al examen físico presenta disminución del vello corporal y disminución del tamaño testicular bilateral. ¿Cuál es el estudio más adecuado para proseguir el enfrentamiento de este paciente?
- Prolactina
 - Testosterona y LH
 - Espermograma y FSH
 - Ecografía testicular
 - HCG y estradiol

25. En el estudio de una osteoporosis de una paciente, se pesquisa tiene calcemia de 11 mg/dl, niveles de paratohormona de 155 UI/L (VN: 15 a 55), niveles de vitamina D: (VN:) y albúmina de 3,8 g/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Hipercalcemia idiopática
 - Hiperparatiroidismo primario
 - Hiperparatiroidismo secundario
 - Hiperparatiroidismo terciario
 - Hipercalcemia familiar
26. Una paciente presenta su sexta litiasis urológica, por lo que se realizan exámenes, entre los que destacan creatinina: 1,2 mg/dl, BUN: 30 mg/dl, calcio: 11 mg/dl, fósforo: 2,3 mg/dl, natremia normal, potasemia normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio diagnóstico?
- Paratohormona
 - LH y FSH
 - 25 OH vitamina D
 - Biopsia de médula ósea
 - Índice proteinuria / creatininuria
27. Un paciente de 36 años consulta por aumento de volumen en la zona anterior del cuello. Al examen físico tiene un nódulo duro, de 2 cm de diámetro, asociado a una adenopatía cervical anterior de consistencia dura. Se solicita una TSH que resulta 6,1 UI/L. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?
- Punción con aguja fina
 - Ecografía tiroidea
 - Cintigrafía con yodo radiactivo
 - TAC de cuello
 - Resonancia magnética nuclear de cuello
28. Una paciente presenta un cuadro de 2 meses de evolución de sensación de calor mayor al habitual y sudoración. Se palpa su tiroides de tamaño normal y no presenta exoftalmo. Se solicitan pruebas tiroideas que demuestran TSH: 0,01 UI/L y T4 libre: 3,9 ng/ml. ¿Cuál es el examen de elección para determinar el diagnóstico etiológico?
- Captación de yodo 131
 - Ecografía de tiroides
 - Punción aspirativa con aguja fina de tiroides
 - Cintigrafía tiroidea
 - Anticuerpos antitiroglobulina
29. Un paciente se realiza una tiroidectomía total hace varios años, por un carcinoma tiroideo. Suspende el tratamiento con levotiroxina hace 6 meses. ¿Qué alteración tendrá con mayor probabilidad en su examen físico?
- Mixedema pretibial
 - Exoftalmo
 - Melanoplaquias
 - Piel seca
 - Acantosis nigricans

30. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para una paciente que se realiza una densitometría ósea con T score de -2,7 en las vértebras lumbares y -2,9 en la cadera izquierda?
- Bifosfonatos
 - Calcitriol
 - Vitamina D
 - Calcio
 - Raloxifeno
31. Un paciente se realiza una ecografía de cuello, como parte del estudio de un nódulo cervical, que visualiza un tumor sólido y redondeado, localizado en el istmo, de 4 mm de diámetro, sin presencia de adenopatías. Sus pruebas tiroideas muestran TSH y T4 libre dentro de rangos normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?.
- Iniciar tratamiento levotiroxina
 - Iniciar levotiroxina en dosis de supresión
 - Realizar punción con aguja fina
 - Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
 - Realizar seguimiento ecográfico
32. Una paciente de 32 años presenta reglas irregulares, cada 2 a 3 meses, asociada a hirsutismo y acné. Consulta porque ha tenido problemas para embarazarse ¿Cuál es el mejor fármaco para de tratar la infertilidad en esta paciente?
- Espironolactona
 - Análogos de la GnRH
 - Citrato de clomifeno
 - Metformina
 - Progesterona
33. Una paciente de 33 años, consulta por dolor cervical intenso de una semana de evolución asociado a sensación febril. Al examen físico destaca glándula tiroides del doble del tamaño normal, muy dolorosa a la palpación, frecuencia cardiaca de 90 latidos por minuto y presión arterial de 120/80 mm Hg. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,2 UI/L, T4L: 1,9 ng/mL (Valor normal: 0,6-1,7 ng/mL), captación de yodo radioactivo de 2% (Valor normal: mayor a 3%). ¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente?
- Propiltiouracilo
 - Ibuprofeno
 - Prednisona
 - Levotiroxina
 - Yodo radioactivo
34. Una pareja consulta por infertilidad de 2 años de evolución. Ella no tiene antecedentes de importancia y tanto su examen físico, como exploración ginecológica son normales. Él realiza ciclismo de montaña y en su examen físico se constatan testículos de tamaño pequeño, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el primer examen para evaluarlo?
- Espermiograma
 - Ecografía testicular
 - Niveles plasmáticos de LH, FSH y testosterona

- d. Niveles plasmáticos de TSH, prolactia
 - e. Biopsia testicular
35. Paciente de 63 años, con antecedente de hipernefroma operado hace un año, con buena evolución, consulta por cuadro de astenia y debilidad de 7 días, controlándose exámenes de sangre entre los que destaca calcemia de 11,8 mg/dL (valor normal 8,5-10,5 mg/dL), albúmina normal. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente?
- a. Cintigrafía ósea
 - b. Niveles plasmáticos de calcio y paratohormona
 - c. TAC de abdomen y pelvis
 - d. Niveles plasmáticos de vitamina D
 - e. Resonancia magnética de abdomen y pelvis
36. Un paciente de 35 años, padre de tres hijos consulta por disfunción eréctil progresiva que inició hace 3 meses. Su examen físico no muestra alteraciones, y su examen genital y testicular resulta normal. Se solicitan exámenes que muestran testosterona de 190 ng/dL (valor normal: 280-1100ng/dL) y LH de 1,8 UI/L (valor normal: 1,5-20 UI/L). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente?
- a. Espermiograma
 - b. Ecografía testicular
 - c. Niveles plasmáticos de FSH
 - d. Resonancia magnética de hipófisis
 - e. Niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona
37. Una paciente de 66 años, que mide 1,68 metros y pesa 49 kilos, se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -3,5 DS en cadera izquierda y -2,8 en la columna lumbar a la altura de la vértebra L4. Trae además una glicemia, un perfil bioquímico y perfil lipídico, todos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada para esta paciente?
- a. Indicar calcio y vitamina D vía oral
 - b. Indicar una carga de vitamina D vía oral
 - c. Administrar calcitonina endovenosa
 - d. Indicar bifosfonatos vía oral o endovenosa
 - e. Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos más progestágenos por vía oral
38. Una paciente de 48 años, usuaria de DIU hace 8 años, consulta por reglas irregulares. Su FUR fue hace 50 días y no refiere otros síntomas. En la especuloscopia, no es posible visualizar las guías del DIU. La conducta más adecuada es:
- a. Solicitar radiografía pélvica
 - b. Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, prolactina, FSH y LH
 - c. Realizar ecotomografía pelviana
 - d. Solicitar niveles plasmáticos de subunidad beta-HCG
 - e. Intentar exploración uterina con pinza, para extraer el DIU
39. Una adolescente de 16 años, presenta un cuadro de astenia y malestar general, asociada a debilidad muscular, amenorrea, aparición de acné y obesidad. Al examen físico tiene hipertensión arterial, hirsutismo moderado, acné en la cara y espalda, obesidad abdominal, con estrías vinosas. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstica?

- a. Cortisol matinal y vespertino
 - b. Cortisol basal y post-ACTH
 - c. TAC de la región selar
 - d. Cortisol y ACTH matinales
 - e. **Cortisol libre urinario de 24 horas**
40. Una niña de 14 años aún no ha tenido su menarquia. Al examen físico no presenta desarrollo puberal y tiene talla baja. Como antecedente, fue operada de una coartación aórtica hace varios años. ¿Cuál es el examen más adecuado para seguir con el estudio en esta paciente?
- a. Niveles de FSH
 - b. Hormona antimülleriana
 - c. Edad ósea
 - d. Niveles de estradiol
 - e. **Cariograma**
41. Un hombre de 31 años consulta por aumento de volumen en el cuello, que se palpa como un nódulo tiroideo de consistencia firme. Es estudiado con ecografía, que muestra un nódulo hipoeocogénico, sólido, heterogéneo, de 1,3 cm. La TSH: resulta 3,0 UI/L. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?
- a. TAC de cuello
 - b. Biopsia excisional del nódulo
 - c. **Biopsia citológica**
 - d. Cintigrafía con yodo radiactivo
 - e. Seguimiento ecográfico
42. Una paciente de 26 años, atleta, está en amenorrea hace 8 meses. Se realiza test de embarazo, que resulta negativo. Sus niveles de prolactina y TSH son normales. Se solicita FSH: 80 UI/L (VN: menor a 18), estradiol: 5 (VN: 20-150 pg/ml). Su examen físico no tiene alteraciones. El diagnóstico más probable es:
- a. Hipogonadismo de causa central
 - b. **Falla ovárica primaria**
 - c. Amenorrea por ejercicio
 - d. Amenorrea hipotalámica funcional
 - e. Anovulación
43. Una paciente con antecedente de dolores óseos se realiza exámenes que muestran calcio corregido: 14,4 mg/dl (VN: 8,5 a 10,5 mg/dl), fósforo: 4,5 mg/dl y fosfatasas alcalinas: 340 UI/L. Se realiza cintigrafía ósea, que es compatible con metástasis óseas múltiples. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar con el estudio?
- a. Calcio iónico
 - b. **Paratohormona**
 - c. Calcitonina
 - d. Calciuria de 24 horas
 - e. 25-OH-vitamina D

DIABETES Y NUTRICIÓN

1. Un paciente de 55 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 2000mg al día, glibenclamida 15mg al día y enalapril 20mg al día, acude a control con exámenes, donde destaca glicemia de ayuno de 180mg/dL y hemoglobina glicosilada de 8,8%. Se ha mantenido sin síntomas y su examen físico es normal. La conducta más adecuada en este caso es:
 - a. Aumentar dosis de glibenclamida
 - b. Aumentar dosis de metformina
 - c. Iniciar insulina
 - d. Reemplazar metformina con rosiglitazona
 - e. Reemplazar glibenclamida con sitagliptina

2. Un paciente de 17 años, obeso, se realiza chequeo con glicemia de ayuno que resulta en 130, por lo que se repite este examen obteniendo 137, no ha presentado síntomas. En el examen físico destaca presencia de acantosis nígricans en pliegue cervical y acrocordones. El diagnóstico más probable es:
 - a. Diabetes mellitus tipo 1
 - b. Diabetes mellitus tipo 2
 - c. Diabetes mellitus autoinmune
 - d. Intolerancia a la glucosa
 - e. Glicemia de ayuno alterada

3. Una paciente de 40 años, con antecedente de hipotiroidismo desde la adolescencia, vitiligo y diabetes diagnosticada hace un año, en tratamiento con régimen oral, acude a control con glicemia de ayuno en 250 mg/dL y hemoglobina glicosilada en 9,0%. El diagnóstico más probable es:
 - a. Diabetes mellitus tipo 1
 - b. Diabetes mellitus tipo 2
 - c. Diabetes mellitus autoinmune
 - d. Hipopituitarismo autoinmune
 - e. Neoplasia endocrina múltiple tipo 1

4. Un paciente de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control, refiere estar asintomático. Al examen físico se encuentra presión arterial de 138/83, sin otros hallazgos. Sus exámenes de control muestran hemoglobina glicosilada en 6.9%, índice proteinuria creatininuria de 0.3, creatinina 0.8 mg/mL. La conducta más adecuada en este caso es:
 - a. Aumentar dosis de metformina
 - b. Iniciar hidroclorotiazida
 - c. Iniciar enalapril
 - d. Suspender metformina e indicar insulina
 - e. Mantener tratamiento actual y reforzar medidas como dieta y ejercicio

5. Un paciente de 45 años, diagnosticado de diabetes hace un mes, se le indicó tratamiento con metformina, la cual suspendió por que le producía diarrea, desde entonces ha estado asintomático. Acude a control con exámenes donde destaca hemoglobina glicosilada de 8,5%, glicemia de ayuno 180mg/dL, creatinina de 1,5 mg/dL. La conducta más adecuada en este caso es:
 - a. Indicar Insulina

- b. Indicar glibenclamida
 - c. Indicar rosiglitazona
 - d. Indicar acarbosa
 - e. Indicar metformina de acción prolongada
6. Un paciente de 40 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión, asintomático, acude a control con perfil lipídico que muestra colesterol total 208, LDL 127, HDL 35, triglicéridos 230. El fármaco de elección para el tratamiento en este caso es:
- a. Ácido nicotínico
 - b. Gemfibrozilo
 - c. Ácidos grasos omega 3
 - d. Colestiramina
 - e. Atorvastatina
7. Un paciente hipertenso y dislipidémico, en tratamiento con enalapril y atorvastatina sufre dolor torácico opresivo, intenso, siendo diagnosticado de síndrome coronario agudo e infarto al miocardio, que es manejado adecuadamente, con buena evolución clínica. Durante su hospitalización, sus glicemias están constantemente sobre 200 mg/dl. Sus exámenes actuales muestran glicemia: 203 mg/dl, creatinina: 0,6 mg/dl, hematocrito: 40%. Para el adecuado manejo de sus glicemias, el tratamiento de elección es:
- a. Metformina v.o.
 - b. Glibenclamida v.o.
 - c. Insulina glargina s.c.
 - d. Insulina cristalina cada 6 horas e.v.
 - e. Dieta
8. Un paciente diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas, enalapril 10 mg cada 12 horas y atorvastatina 20 mg/día, con hemoglobina glicosilada de 6,4%, es hospitalizado por una pielonefritis aguda, que es adecuadamente tratada con soporte y antibióticos. ¿Con qué fármaco debe continuar su tratamiento para la diabetes, luego del alta?
- a. Metformina
 - b. Glibenclamida
 - c. Sitagliptina
 - d. Insulina cristalina
 - e. Insulina glargina
9. Una paciente se realiza una pancreatectomía parcial, debido a un cáncer de páncreas. Evoluciona con glicemias elevadas, siendo diagnosticada de diabetes mellitus. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?
- a. Insulina
 - b. Metformina
 - c. Dieta
 - d. Glibenclamida
 - e. Sitagliptina
10. Un niño de 16 años, con IMC en percentil 97 para la edad, presenta un cuadro de polidipsia y poliuria, por lo que se solicita una glicemia de ayuno, que resulta 203 mg/dl. ¿Cuál es la indicación más adecuada?
- a. Insulina

- b. Metformina
 - c. **Insulina**
 - d. Solo dieta
 - e. Glibenclamida
11. Un paciente diabético e hipertenso, está en tratamiento con glibenclamida 5 mg cada 12 horas, acude a control con exámenes de sangre, entre los que destaca hemoglobina A1c de 9,4%, creatinina plasmática: 1,7, proteinuria de 500mg/24 horas, colesterol total: 200 mg/dl, triglicéridos 150 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- a. Aumentar la dosis de glibenclamida
 - b. **Iniciar insulina NPH**
 - c. Reemplazar la glibenclamida por acarbosa
 - d. Iniciar insulina glargina
 - e. Agregar metformina al tratamiento
12. Una paciente de 25 años, vegetariana estricta, con antecedente de un hijo con mielomeningocele, presenta anemia. ¿Cuál es la indicación más adecuada?
- a. Vitamina B12
 - b. **Folatos**
 - c. Tiamina
 - d. Ácidos grasos omega 3
 - e. Aminoácidos esenciales
13. Una paciente de 50 años, con diagnóstico de artritis reumatoide, en tratamiento con prednisona 15 mg/día, presenta glicemia de ayuno de 115, y glicemias prealmuerzo y posprandial de 230 y 295 mg/dl respectivamente. ¿Cuál es el mejor tratamiento para esta paciente?
- a. Dieta y ejercicio
 - b. Metformina
 - c. Glibenclamida
 - d. Pioglitazona
 - e. **Insulina**
14. Un paciente de 12 años, diabético tipo 1, en tratamiento con una dosis de NPH matinal, despierta con glicemias de ayuno muy elevadas, asociadas a hipoglicemias frecuentes antes del almuerzo. Su hemoglobina glicosilada es de 11,7%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- a. Reemplazar el tratamiento por insulina glargina en la mañana
 - b. **Dejar dos dosis de insulina NPH más tres refuerzos de insulina cristalina precomidas**
 - c. Agregar insulina NPH nocturna
 - d. Reemplazar la insulina NPH matinal por insulina NPH nocturna
 - e. Agregar metformina al tratamiento
15. Un paciente de 60 años, diabético tipo 2, en tratamiento con 500 mg de metformina al día, acude a control, con hemoglobina glicosilada de 8,8%, proteinuria (+) y clearance de creatinina de 50 ml/min. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- a. Subir la dosis de metformina
 - b. Agregar glibenclamida
 - c. Agregar insulina NPH nocturna
 - d. **Tratar con mezcla de insulinas**

- e. Agregar glipizida al tratamiento
16. Un paciente de 12 años consulta por un cuadro de malestar general, asociado a bajo de peso, que en las últimas horas se le agrega poliuria importante. Consulta porque en las últimas horas se agrega gran compromiso del estado general, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está taquicárdico, soporoso, con polipnea y signos de deshidratación. En sus exámenes presenta glicemia de 470 mg/dl, sodio de 143 mEq/L, potasio de 4,8 mEq/L, cloro de 97 mEq/L, bicarbonato de 12 mEq/L y pH de 7,05. ¿Qué fluido debe administrarse a este paciente?
- Suero glucosado
 - Suerlo glucosalino
 - Solución salina al 0,45%
 - Solución salina al 0,9%
 - Solución ringer lactato
17. Un adolescente de 16 años, con IMC de 33, se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 96 mg/dl, más una insulina basal que resulta 23 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Iniciar insulina
 - Iniciar dieta y ejercicio
 - Iniciar metformina
 - Solicitar test de tolerancia a la glucosa
 - Iniciar metformina más glibenclamida
18. Un paciente hipertenso y diabético se realiza un perfil lipídico, que muestra triglicéridos de 350 mg/dl, colesterol LDL de 230 mg/dl y colesterol HDL de 37. ¿Qué tratamiento debe indicarse?
- Atorvastatina
 - Gemfibrozilo
 - Insulina
 - Lovastatina más gemfibrozilo
 - Ezetimibe
19. Un paciente diabético de larga data, en tratamiento con insulina, presenta presión arterial de 148/102. Además su índice proteinuria/creatininuria resulta 0,3. ¿Qué fármaco es más adecuado para el manejo de este paciente?
- Amlodipino
 - Enalapril
 - Carvedilol
 - Hidroclorotiazida
 - Diltiazem
20. Un paciente de 20 años presenta un cuadro de poliuria y polidipsia, de 2 días de evolución, a lo que se ha agregado dolor abdominal y vómitos hace pocas horas. Se solicita una glicemia, que resulta 360 mg/dl. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?
- Cetonemia
 - Creatininemia
 - Perfil lipídico
 - Hemoglobina glicosilada
 - Hemograma

21. Mujer asintomática de 46 años, con IMC de 24. Tiene antecedente de diabetes gestacional con su último embarazo. Se practica una glicemia en ayunas que resulta en 112 mg/dl. La conducta más adecuada es:
- Repetir la glicemia en ayunas
 - Practicar niveles de hemoglobina glicosilada
 - Indicar metformina
 - Realizar control de glicemia en 6 meses
 - Solicitar curva de tolerancia a la glucosa
22. Una mujer de 86 años, con múltiples patologías crónicas, en tratamiento farmacológico, acude a control, constatándose IMC: 23, frecuencia cardíaca: 76 lpm, presión arterial: 110/70 mmHg. Además trae exámenes, que muestran TSH: 2,65 UI/L, LDH: 152 UI/L, hemoglobina glicosilada: 5,2%, colesterol HDL: 35 mg/dl, colesterol total: 205 mg/dl. ¿Qué fármaco debería suspenderse?
- Losartán
 - Atorvastatina
 - Levotiroxina
 - Carvedilol
 - Glibenclamida
23. Un paciente presentó varios episodios de mareos y sudoraciones, objetivándose una hipoglicemia severa de 35 mg/dl en la más grave. Se realiza un test de ayuno y a las 9 horas presenta una hipoglicemia de 45 mg/dl. Se solicitan exámenes que muestran insulina de 65 UI/L y péptido C indetectable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Hepatoma
 - Hipoglicemia facticia por insulina
 - Hipoglicemia facticia por sulfonilúreas
 - Insulinoma
 - Hipoglicemia reactiva idiopática
24. Un paciente de 67 años, diabético, tipo 2, en tratamiento con metformina 1700 mg/día y glibenclamida 20 mg/día, ambos separados en dos dosis diarias consulta por episodios repetidos de mareos, malestar y sudoración, asociado a temblor, que ocurren al final de la mañana o antes de almuerzo. Han coincidido con glicemias capilares de 65 mg/dl. Su IMC es 32 Kg/m². Su hemoglobina A1c resulta 8,1. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Suspender la glibenclamida
 - Agregar una colación con 25 gramos de hidrato de carbono antes del almuerzo
 - Suspender la glibenclamida
 - Reemplazar la glibenclamida por sitagliptina
 - Reemplazar la metformina por pioglitazona
25. Un paciente dislipidémico, está en tratamiento con atorvastatina 10 mg/día y se realiza un perfil lipídico de control con colesterol total: 183 mg/dl, colesterol HDL: 32 triglicéridos: 860 mg/dl. ¿Cuál es la dosis más adecuada?
- Subir la dosis de la atorvastatina a 40 mg/día
 - Cambiar la atorvastatina por rosuvastatina
 - Agregar gemfibrozilo 900 mg/día
 - Agregar ezetimibe al tratamiento

- e. Reemplazar la atorvastatina por gemfibrozilo 900 mg/día
26. Un paciente de 30 años, con IMC: 30 Kg/m² consulta por hiperpigmentación de la piel de las axilas y el cuello, asociado a aparición de acrocórdenes en pliegues inguinales, cervicales y en las axilas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Enfermedad de Cushing
 - Hipotiroidismo
 - Síndrome paraneoplásico
 - Insuficiencia suprarrenal
 - Resistencia a la insulina
27. Una paciente de 25 años, con antecedente de anorexia nervosa desde hace 5 años. Actualmente pesa 29 kilos y mide 1,68 metros, con IMC de 10,3. ¿Con cuántas kilocalorías diarias se debe iniciar su alimentación?
- 300
 - 600
 - 1200
 - 1500
 - 2400
28. Paciente de 62 años, diabético diagnosticado hace 5 años en tratamiento con hipoglicemiantes orales, como parte de un chequeo se realiza exámenes de chequeo donde se aprecia creatinina de 0,9mg/dL, hemoglobina glicosilada menor a 7% y un perfil lipídico que muestra triglicéridos de 250 mg/dL, colesterol total de 258 mg/dL, HDL 52 mg/dL, LDL 156 mg/dL. No presenta síntomas. El tratamiento más adecuado para disminuir su riesgo cardiovascular es:
- Fibratos
 - Estatinas
 - Dieta baja en ácidos grasos saturados
 - Ácido nicotínico
 - Ezetimibe
29. Un paciente 67 años, diabético en tratamiento con metformina 1,5 gramos al día, consulta por edema de extremidades inferiores asociado a orinas espumosas. Al examen físico se constata edema blando de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes entre los que destaca una glicemia de ayuno de 215mg/dL, hemoglobina glicosilada de 12,5%, creatinemia 1,2mg/dL, proteinuria +++ y albuminemia 3,0g/dL. La conducta más adecuada es:
- Aumentar dosis de metformina
 - Iniciar insulina NPH
 - Reemplazar la metformina por glimepiride
 - Agregar glibenclamida al tratamiento
 - Reemplazar la metformina por insulina cristalina
30. Un paciente de 59 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina 850mg dos veces al día y glibenclamida 5mg cada 12 horas, se realiza exámenes de control entre los que destaca una creatinina de 1,0 mg/dL y una hemoglobina glicosilada de 6,9%. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Suspender la glibenclamida

- b. Aumentar dosis de glibenclamida
 - c. Suspender metformina
 - d. Aumentar dosis de metformina
 - e. **Mantener el tratamiento sin cambios**
31. Un paciente de 60 años, con antecedente de diabetes mellitus 2 insulino dependiente, en tratamiento con insulina NPH 30U en la mañana y 20 U en la noche. Presenta un cuadro de malestar, sudoración y palpitations intensas a las 3 de la madrugada, constatándose un hemoglucotest de 50mg/dL. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- a. Disminuir la insulina NPH matinal
 - b. Suspender la insulina NPH matinal
 - c. **Disminuir la insulina NPH nocturna**
 - d. Suspender la insulina NPH nocturna
 - e. Disminuir ambas dosis de insulina NPH
32. Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con metformina 1,7 gramos al día y enalapril 20 mg cada 12 horas, asintomático, acude a control. Se solicitan exámenes, entre los que destacan HbA1c: 6,7%, colesterol total: 265 mg/dl, colesterol HDL: 34 mg/dl y triglicéridos: 344 mg/dl. ¿Qué fármaco se debe agregar al tratamiento?
- a. Fenofibrato
 - b. Gemfibrozilo
 - c. **Atorvastatina**
 - d. Glibenclamida
 - e. Ezetimibe
33. Un paciente de 53 años, con antecedente de hipertensión arterial y fumador, consulta por dolor torácico, siendo diagnosticado de un infarto agudo al miocardio, por lo que se hospitaliza para manejo. Al ingreso, presenta glicemia de 256 mg/dl, hemoglobina glicosilada: 5,8%. Evoluciona con varias glicemias sobre 200 mg/dl, durante la hospitalización. ¿Cuál es la forma más adecuada de manejar sus glicemias?
- a. Metformina más glibenclamida con las comidas
 - b. Sitagliptina
 - c. Dieta
 - d. **Insulina rápida cada 6 horas, endovenosa**
 - e. Insulina NPH más insulina cristalina endovenosa con las comidas
34. Un paciente de 32 años, normopeso, diagnosticado de diabetes desde los 20 años, en tratamiento. Su padre, su hermano y su abuelo son diabéticos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. DM tipo 1
 - b. DM tipo 2
 - c. DM LADA
 - d. **DM Mody**
 - e. DM mitocondrial
35. Un paciente de 30 años, obeso, cuya madre es diabética tipo 2, por lo que él quiere saber si también es diabético, para lo cual se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 104 mg/dl. La conducta más adecuada es:
- a. Repetir la glicemia de ayuno
 - b. Pedir una prueba de HOMA

- c. Solicitar una glicemia 2 horas post-desayuno
- d. Solicitar prueba de tolerancia a la glucosa oral
- e. Solicitar insulinemia basal y 2 horas post-desayuno

36. Una paciente de 16 años, con antecedente de muchos parientes con diagnóstico de diabetes tipo 2, presenta un cuadro de algunas semanas de evolución de polidipsia y poliuria. Tiene acantosis nigricans en el cuello y obesidad, con IMC en p97, para su edad. Se solicita una glicemia de ayuno, que resulta 204 mg/dl. Además del control dietético y el ejercicio, la conducta inicial más adecuada es:

- a. Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- b. Repetir la glicemia de ayuno
- c. Iniciar insulina
- d. Iniciar glibenclamida
- e. Iniciar metformina

NEUROLOGÍA

1. Un paciente de 51 años, con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión en tratamiento, es traído por presentar cuadro de hemiparesia faciobraquiocrural izquierda de inicio súbito desde hace 2 horas, asociado a dificultad para articular palabras. Al examen físico se corrobora dicha paresia asociada a disminución de reflejos en lado izquierdo. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:
 - a. Punción lumbar
 - b. Resonancia magnética
 - c. TAC de cerebro con contraste
 - d. TAC de cerebro sin contraste
 - e. Angiografía de arteria cerebral media

2. Mujer de 23 años, con cuadro de 24 horas de evolución de compromiso del estado general, fiebre y somnolencia progresiva. Al examen físico destaca con temperatura de 38,5°C, petequias y equimosis en extremidades, rigidez de nuca sin focalización neurológica. El diagnóstico más probable es:
 - a. Meningitis tuberculosa
 - b. Meningitis meningocócica
 - c. Meningitis neumocócica
 - d. Meningitis por listeria
 - e. Meningitis herpética

3. Una paciente de 35 años, sin antecedentes, sufre fractura de diáfisis humeral izquierda, evolucionando posteriormente con hipostesia del dorso de dicha mano, asociado a imposibilidad de realizar extensión de muñeca y falanges. ¿La estructura más probablemente dañada en este caso es?:
 - a. Nervio mediano
 - b. Nervio ulnar
 - c. Nervio radial
 - d. Nervio axilar
 - e. Nervio musculocutáneo

4. Un paciente de 80 años, autovalente, inicia cuadro de compromiso del estado general, tos y expectoración mucopurulenta, se realiza radiografía de tórax en donde se comprueba diagnóstico de neumonía basal derecha por lo que se hospitaliza para el tratamiento. Durante la hospitalización en la noche el paciente se agita, se saca sonda foley y vías venosas, durante la mañana está tranquilo. El diagnóstico más probable es:
 - a. Síndrome confusional agudo

- b. Delirium
 - c. Alzheimer
 - d. Meningitis bacteriana
 - e. Demencia frontotemporal
5. Un paciente de 35 años, sin antecedentes, con cuadro de una semana de compromiso del estado general y sensación febril, que durante los últimos días se agrega cefalea y diplopía. Al examen físico destaca reflejo fotomotor conservado, parálisis del sexto par derecho y rigidez de nuca esbozada. Se solicita punción lumbar que muestra células aumentadas de predominio mononuclear, glucosa disminuida y proteínas altas, gram no visualiza gérmenes. El agente etiológico más probable en este caso es:
- a. **Mycobacterium tuberculosis**
 - b. Neumococo
 - c. Enterovirus
 - d. Herpes virus
 - e. Criptococosis
6. Un paciente de 45 años, sin antecedentes, presenta cuadro de 3 semanas de evolución de cefalea y sensación febril que durante los últimos días se ha hecho más intensa, asociado a dolor cervical. Al examen físico destaca leve rigidez de nuca y parálisis del IV par craneano derecho. El diagnóstico más probable es:
- a. **Meningitis tuberculosa**
 - b. Meningoencefalitis por enterovirus
 - c. Meningoencefalitis herpética
 - d. Meningitis bacteriana
 - e. Meningitis por hongos
7. Paciente embarazada de 26 semanas, bien controlada, consulta por cuadro de una semana de sensación de hormigueo en ambas manos de predominio nocturno, mayor en lado derecho, sin otros síntomas. Al examen físico destaca parestesia en ambas manos al mantener muñecas flexionadas por 20 segundos. El diagnóstico más probable:
- a. Mielopatía cervical
 - b. Polimiositis
 - c. Miastenia gravis
 - d. Atrapamiento del nervio cubital
 - e. **Atrapamiento del nervio mediano**
8. Un paciente de 50 años, sin antecedentes, presenta cefalea de inicio súbito mientras hacía deporte, asociado a dolor en la zona cervical posterior y dorsal. Al examen físico presenta reflejo fotomotor conservado, signos meníngeos presentes, fuerza y sensibilidad disminuidas en hemicuerpo izquierdo. El diagnóstico más probable es:
- a. **Hemorragia subaracnoidea**
 - b. Hematoma epidural
 - c. Hematoma subdural
 - d. Hemorragia cerebral intraparenquimatosa
 - e. Accidente vascular isquémico

9. Un paciente de 24 años, sin antecedentes, es traído porque desde que despertó en la mañana no puede movilizar sus cuatro extremidades, sin otros síntomas. Al examen físico se corrobora fuerza totalmente disminuida en todo su cuerpo, sensibilidad normal, reflejos osteotendíneos presentes y simétricos. El diagnóstico más probable es:
- Síndrome de Guillain Barré
 - Miastenia Gravis
 - Botulismo
 - Lesión medular cervical
 - Parálisis periódica hipokalémica**
10. Un paciente de 12 años, consulta por cuadro caracterizado por de visión de destellos hace una hora, tras lo cual evolucionó con cefalea frontotemporal intensa, de tipo pulsátil, asociado a fotofobia y fonofobia. Refiere que desde los cinco años ha presentado cuadros similares, y que durante el último año ha presentado cinco episodios. El diagnóstico más probable es:
- Migraña clásica**
 - Cefalea en racimos
 - Cefalea tensional
 - Migraña complicada
 - Tumor cerebral
11. Un paciente de 78 años, diabético, tratado con metformina, con antecedente de depresión, en tratamiento con fluoxetina, desde hace un año. Consulta por temblor de la extremidad superior derecha, que aumenta al caminar y al realizar actividades con la otra mano. Al examen presenta bradicinesia importante, asociada a rigidez. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Temblor senil
 - Temblor ortostático
 - Enfermedad de Parkinson**
 - Enfermedad de Alzheimer
 - Parkinsonismo secundario a fármacos
12. Un niño de 8 años, sin antecedentes de importancia presenta un cuadro de desviación de la mirada, con movimientos rítmicos de las extremidades, seguidas de caída al suelo y posición tónica de las extremidades superiores en flexión. El diagnóstico más probable es:
- Crisis parcial motora
 - Epilepsia
 - Crisis atónica
 - Crisis conversiva
 - Primoconvulsión**
13. Un paciente de 45 años presenta dolor lumbar muy intenso, de inicio súbito, que se irradia por la extremidad inferior izquierda. Al examen físico presenta debilidad a la flexión plantar del primer orjejo izquierdo, disminución de la sensibilidad de la zona lateral del pie izquierdo y abolición del reflejo aquiliano ipsilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Síndrome facetario, lateralizado a izquierda
 - Lesión del nervio ciático izquierdo
 - Afectación de la raíz S1**

- d. Lesión del plexo lumbar
 - e. Afectación de la raíz L5
14. Un paciente de 52 años presenta dolor en la región mastoidea derecha, asociado a desviación de la comisura labial a izquierda e imposibilidad de cerrar el ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Neuralgia del trigémino
 - b. Parálisis facial periférica
 - c. Infarto de cerebelo
 - d. Infarto de troncoencéfalo
 - e. Lesión del tercer nervio craneal
15. Un paciente de vértigo intenso, de algunas horas de evolución, que le dificulta la marcha. Al examen físico presenta ataxia de la marcha y disdiadococineia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- a. Realizar maniobras de reposición
 - b. Realizar un TAC de encéfalo
 - c. Solicitar un examen de VIII par
 - d. Indicar difenidol oral y controlar ambulatoriamente
 - e. Iniciar corticoides orales
16. Un adulto mayor de 74 años, diabético, hipertenso y dislipidémico, en tratamiento con metformina, aspirina, atorvastatina y enalapril, desde hace un año es diagnosticado de depresión, por lo que inicia tratamiento con fluoxetina. Hace 6 meses inicia cuadro de alteración de la memoria reciente, cambio conductual, asociado a inestabilidad de la marcha y desorientación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Enfermedad de Parkinson
 - b. Enfermedad de Alzheimer
 - c. Hidrocefalia normotensiva
 - d. Efectos adversos de sus fármacos
 - e. Descompensación de su depresión
17. Una mujer de 45 años consulta por debilidad para tomar objetos, desde hace 3 meses. Además presenta parestesias, especialmente en la noche, que mejoran al sacudir las manos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Atrapamiento del nervio cubital
 - b. Polineuropatía
 - c. Síndrome de túnel carpiano
 - d. Lesión del nervio radial
 - e. Síndrome del opérculo torácico
18. Una mujer de 50 años consulta por parestesias en ambas manos, mayor a derecha, que la despiertan en la noche, por lo que debe sacudir las manos, para aliviarse. Además presenta dificultad para tomar objetos con las manos. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?
- a. Ecografía de mano
 - b. Electromiografía
 - c. Prueba de estimulación con edrofonio
 - d. Resonancia magnética de cuello

- e. Radiografía de mano
19. Un paciente de 35 años consulta por debilidad del cuarto y quinto dedos derechos, es especial a la flexión, asociado a parestias en dichos dedos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Lesión de los tendones profundos
 - b. Síndrome del opérculo torácico
 - c. Atrapamiento del nervio radial
 - d. Síndrome de atrapamiento cubital
 - e. Síndrome de túnel carpiano
20. Un paciente, luego de un “sueño profundo”, en relación a una intoxicación alcohólica, presenta debilidad y dificultad para tomar objetos con la mano derecha, como sostener una taza, la que se le cae. Al examen físico no tiene alteraciones en la sensibilidad, ni en los reflejos osteotendíneos, los que permanecen conservados. Sin embargo, al solicitarle que ponga los brazos en posición horizontal, se observa que la mano derecha está “caída”. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?
- a. Lesión del nervio radial
 - b. Lesión del plexo braquial
 - c. Lesión de los nervios cubital y mediano
 - d. Isquemia de los músculos del antebrazo
 - e. Accidente vascular encefálico
21. Un niño de 7 años presenta episodios en los que se queda quieto, mirando fijo, los que luego no recuerda. Han aumentado en frecuencia, hasta suceder 5 veces al día. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Síncopes vasovagales
 - b. Epilepsia mioclónica
 - c. Crisis de ausencia
 - d. Epilepsia focal
 - e. Déficit atencional
22. Un niño de 4 años, con antecedente de una convulsión febril hace 2 años, presenta un cuadro de fiebre y cefalea, seguido luego de deterioro del estado general y compromiso de conciencia. Luego, convulsiona en una oportunidad. Se realiza una punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo, con glucosa de 68 mg/dl, 62 mg/dl de proteínas, 300 glóbulos blancos, con 80% mononuclear y 60 glóbulos rojos, crenados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Encefalitis herpética
 - b. Hemorragia subaracnoidea
 - c. Meningitis bacteriana
 - d. Meningitis tuberculosa
 - e. Convulsión febril benigna
23. Un paciente de 69 años presenta debilidad de las manos, asociados a disminución de la sensibilidad de manos y pies. Refiere además dolor tipo ardor en las extremidades inferiores. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad “en calcetín”, signo de Lasegue negativo y presenta abolición de ambos reflejos aquileanos. El diagnóstico más probable es:
- a. Síndrome de Guillain Barré
 - b. Radiculopatía S1

- c. Síndrome de cola de caballo
 - d. Polineuropatía**
 - e. Esclerosis lateral amiotrófica
24. Un paciente de 18 años presenta debilidad progresiva de las extremidades, con dificultad para caminar. Al examen físico no puede ponerse de pie y sus reflejos osteotendíneos están disminuidos, sin afectación de la sensibilidad. El diagnóstico más probable es:
- a. Polirradiculoneuritis desmielinizante**
 - b. Miastenia gravis
 - c. Polineuropatía
 - d. Parálisis hipokalémica
 - e. Mielitis transversa
25. Un paciente de 37 años consulta por dolor en la mandíbula inferior de segundos de duración, muy intenso, EVA 9/10, que se gatilla al comer y al lavarse los dientes. El dolor se ubica en la mitad izquierda de la mandíbula y en la arcada dental inferior izquierda. El examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Neuralgia del trigémino**
 - b. Cefalea cluster
 - c. Jaqueca clásica
 - d. Jaqueca complicada
 - e. Disfunción de la articulación temporomandibular
26. Un paciente de 70 años presenta un cuadro de dificultad para girarse y para meterse a la tina, asociado a múltiples caídas. Además presenta cambios en la escritura y temblor de reposo. No presenta deterioro cognitivo evidente. El diagnóstico más probable es:
- a. Atrofia generalizada
 - b. Hidrocefalia normotensiva
 - c. Temblor senil
 - d. Demencia por cuerpos de Lewy
 - e. Enfermedad de Parkinson**
27. y dolorosa del cuello y del brazo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Distonía aguda**
 - b. Acatisia
 - c. Síndrome neuroléptico maligno
 - d. Balismo
 - e. Disquinesia tardía
28. Un paciente de 55 años ha presentado varios cambios cognitivos conductuales, como tendencia a la apatía, lenguaje coprolálico o andar desnudo. No ha tenido alteraciones en la conciencia ni en la memoria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Demencia por cuerpos de Lewy
 - b. Hidrocefalia normotensiva
 - c. Enfermedad de Alzheimer
 - d. Demencia frontotemporal**
 - e. Delirium

29. Una paciente de 25 años presenta un cuadro de cefalea holocránea y fiebre alta. Al examen físico presenta rigidez de nuca y signo de Brudzinsky, con petequias en extremidades inferiores, asociadas a algunas equimosis. El agente causal más probable es:
- a. **Neisseria meningitidis**
 - b. Streptococcus pneumoniae
 - c. Haemophilus influenzae
 - d. Listeria monocytogenes
 - e. Virus herpes simplex
30. Un paciente de 65 años, alcohólico inveterado, se queda dormido sobre el costado derecho, mientras estaba borracho. Al despertar, al día siguiente, no puede mover la mano derecha. Al examen neurológico, no puede extender los dedos ni la muñeca, aunque puede flectarlos sin problemas. Además no tiene alteraciones visuales ni afasia. El diagnóstico más probable es:
- a. Hematoma subdural izquierdo
 - b. Trombosis de la vena subclavia
 - c. **Neuropatía compresiva del nervio radial**
 - d. Trombosis de la arteria subclavia
 - e. Hematoma capsular izquierdo
31. Un joven 17 años, comienza tratamiento con risperidona 3mg al día, hace 1 semana, por esquizofrenia primer brote. Presenta contracción cervical, mantenida y recurrente, que se acompaña de dolor. El diagnóstico más probable es:
- a. **Distonía aguda**
 - b. Disquinesia tardía
 - c. Acatisia
 - d. Trastorno conversivo
 - e. Parkinsonismo por drogas
32. Paciente mujer de 74 años, hipertensa controlada. Presenta dolor de tipo “eléctrico” laseinante en la mejilla y ala nasal izquierda, que compromete la arcada dentaria superior y la encía, así como la zona maxilar superior del lado izquierdo. Además presenta dolor retro ocular izquierdo. El dolor es de escasos segundos, pero intenso EVA 10/10, que se desentadena al tacto y al realizar actividades, como cepillarse los dientes e incluso una suave brisa puede desencadenarlo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para este cuadro?
- a. Pregabalina
 - b. Tramadol
 - c. Prednisona
 - d. **Carbamazepina**
 - e. Paracetamol y AINEs
33. Paciente masculino, de 71 años de edad, con un cuadro de 2 años de evolución de temblor de ambas extremidades superiores, lo cual le sucede al escribir, tomar un objeto, o al usar cubiertos. Toma alprazolam 0,5 mg/dl, dos veces por día por cuadro ansioso. Al examen físico no tiene temblor de reposo y se observan reflejos osteotendíneos conservados, con tono muscular y sensibilidad normal. El temblor se acentúa al tratar de tomar un objeto. El diagnóstico más probable es:
- a. Hipertiroidismo
 - b. Enfermedad de Parkinson

- c. Temblor esencial
 - d. Temblor por ansiedad
 - e. Temblor por medicamentos
34. Paciente de 45 años presenta paresia facial bilateral de instalación progresiva, en 2 semanas, a lo que luego se agrega parálisis del sexto par craneal. Al examen físico, el tono muscular está disminuido de forma simétrica en las cuatro extremidades, con reflejos osteotendinosos abolidos. El diagnóstico más probable es:
- a. Accidente vascular tronco encefálico
 - b. Miastenia gravis
 - c. Sd. de Guillain Barre
 - d. Botulismo
 - e. Hemorragia intracraneana
35. Una paciente de 40 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por cefalea holocránea, muy intensa, de 5 días de evolución, que se ha asociado a vómitos alimentarios, mayores en la mañana, y que no ha respondido al uso de analgésicos orales. En su examen físico no hay signos neurológicos focales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Trombosis venosa profunda de seno encefálico
 - b. Hemorragia subaracnoidea
 - c. Infarto lacunar
 - d. Hematoma intraparenquimatoso
 - e. Crisis de migraña
36. Un paciente diabético tipo 2, de 58 años, mal controlado, consulta por dolor en las extremidades inferiores, de tipo urente y que es más intenso en la noche. Al examen físico se aprecia ausencia de la sensibilidad de las extremidades con el uso de monofilamento. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?
- a. Ecodoppler de extremidades inferiores
 - b. Electromiografía
 - c. Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra
 - d. Angiografía aortofemoral
 - e. Pletismografía de volumen del pulso de extremidades inferiores
37. Un hombre de 58 años presenta un cuadro de 3 años de evolución de debilidad progresiva de las extremidades, que trae problemas para caminar, hasta no poder hacerlo, a lo que luego se agrega dificultad para tragar. Evoluciona finalmente con dificultad respiratoria y necesidad de traqueostomía. No tiene alteración sensitiva. Se solicita espirometría que se muestra a continuación ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Polineuropatía diabética
 - b. Distrofia muscular
 - c. Esclerosis múltiple
 - d. Esclerosis lateral amiotrófica
38. Un paciente de 63 años, diabético mal controlado, presenta parestesias, asociada a dolor en ambas manos, que es mayor en la noche y que se irradia a ambos codos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Polineuropatía diabética
 - b. Hernia del núcleo pulposo

- c. Síndrome de túnel carpiano
 - d. Síndrome de atrapamiento cubital
 - e. Neuropatía radial
39. Un paciente de 40 años consulta por cefalea holocránea, mayor en la zona occipital, que se irradia al cuello. Suele iniciarse a medio día y alcanza su máxima intensidad al llegar a su casa, después del trabajo. Su examen neurológico no tiene signos focales ni meníngeos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Cefalea tensional
 - b. Migraña
 - c. Cefalea en racimo o cluster
 - d. Cefalea por hipertensión endocraneana
 - e. Neuralgia de Arnold
40. Un paciente consulta por 5 días de cefalea holocránea intensa, asociada a fiebre hasta 38 grados. En su examen físico se aprecia rigidez de nuca y signo de Brudzinsky esbozados, por lo que se realiza punción lumbar, que da salida a un líquido con 60 células por mm³, 86% mononucleares, glucorraquia: 0,67 y proteínas de 66 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Meningitis bacterial
 - b. Encefalitis herpética
 - c. Meningitis viral
 - d. Tuberculosis meníngea
 - e. Infección por Listeria monocytogenes
41. Un adolescente de 17 años sufre un accidente de tránsito, en bicicleta, con golpe en la cabeza. Inicialmente está sin signos neurológicos focales, con escala de Glasgow de 15. Se solicita una radiografía de cráneo que muestra una fractura de la escama del temporal. A las 2 horas evoluciona con cefalea intensa y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Se aprecia midriasis derecha, arreactiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Hematoma subdural derecho
 - b. Hematoma epidural derecho
 - c. Hemorragia subaracnoidea
 - d. Contusión encefálica frontal
 - e. Contusión encefálica temporal
42. Una paciente de 14 años sufre una convulsión tónico clónica, luego de una noche con privación de sueño y exposición a pantallas. Previo a esto, presentaba movimientos bruscos, como sacudidos, de manera involuntaria. Sus amigas relatan que en ocasiones “se queda pegada” por algunos segundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Epilepsia mioclónica juvenil
 - b. Epilepsia de ausencia juvenil
 - c. Epilepsia tónicoclónica
 - d. Epilepsia focal
 - e. Crisis convulsiva por privación de sueño
43. Un paciente presenta vértigo, de segundos de duración, que se le produce al girar la cabeza a derecha, mientras está acostado. No tiene síntomas auditivos y como antecedente refiere haber sufrido un traumatismo encefálico hace 10 días, en un accidente de trabajo. No presenta adiadococinesia ni dismetría. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Iniciar unarizina
 - b. Iniciar tietilperazina
 - c. Solicitar un TAC de oídos
 - d. Derivar para maniobras de reposición vestibular
 - e. Iniciar difenidol
44. Un paciente de 43 años, obeso mórbido, consulta por cansancio y somnolencia diurna. Refiere que ronca en la noche y se queda dormido en las luces rojas del semáforo. En su examen físico destaca PA: 140/90 mmHg, FC: 72x' y faringe normal. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?
- a. Poligrafía nocturna
 - b. Polisomnografía
 - c. Saturación arterial de oxígeno durante el sueño
 - d. Monitorización de presión arterial de 24 horas
 - e. Nasofibroscopía
45. Un lactante de 18 meses de edad, presenta un convulsión tónico-clónica de 3 minutos de duración. Al examen físico está afebril, sin alteraciones en el examen segmentario. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis?
- a. Diazepam
 - b. Ácido valproico
 - c. Fenitoína
 - d. Carbamazepina
 - e. Topiramato
46. Un paciente de 65 años, es traído por su señora, dado que presenta dificultades en sus actividades de la vida diaria. Ella refiere que ha estado repetitivo con errores en el manejo del dinero, así como dificultad para realizar actividades que normalmente realizaba sin problemas. El niega estos síntomas. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca 68 latidos por minutos, con presión arterial de 130/85 mmHg, sin alteraciones en el examen segmentario, ni signos de focalidad neurológica. El diagnóstico más probable es:
- a. Delirium
 - b. Demencia vascular
 - c. Depresión del adulto mayor
 - d. Demencia tipo Alzheimer
 - e. Demencia por cuerpos de Lewi
47. Un niño de 7 años comienza hace 3 meses con pestañeo frecuente asociado a expresiones faciales como levantar las cejas, a lo que en el último tiempo se agregan movimientos involuntarios de las extremidades superiores, asociados a sacudidas bruscas de la cabeza y en los últimos días además se ha agregado carraspera. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Síndrome de Gilles de la Tourette
 - b. Trastorno obsesivo
 - c. Corea
 - d. Enfermedad por tics
 - e. Crisis epiléptica parcial

48. Paciente de 30 años comienza hace una semana con cuadro de dolor en la espalda y extremidades, a lo que luego se agrega debilidad progresiva que actualmente dificulta la marcha asociado a dificultad para orinar. Al examen físico se constata debilidad de las cuatro extremidades con abolición de los reflejos osteotendíneos y disminución del tono muscular. Se constata nivel sensitivo a la altura de T4. Su sondaje vesical da salida a 1300 cc de orina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Miastenia gravis
 - Síndrome de Guillain Barre
 - Mielitis transversa**
 - Compresión medular torácica
 - Parálisis hipokalémica episódica
49. Un niño de 10 años convulsiona a la mañana siguiente, de haber trasnochado jugando videojuegos. Además refiere mioclonías matinales frecuentes, desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. ¿Cuál es la medida más adecuada?
- Prohibir por completo los videojuegos
 - Iniciar ácido valproico**
 - Iniciar carbamazepina
 - Iniciar fenobarbital
 - Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
50. Un paciente de 65 años, consulta por fiebre y cefalea de 3 días de evolución, a lo que luego se agrega desorientación. Al examen físico se aprecia confuso, con temperatura 38,5 grados Celsius, FC: 95x' y PA: 110/70 mmHg. En su examen neurológico se aprecia rigidez de nuca, por lo que realiza punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo con 610 células por mm³, con 90% de polimorfonucleares, glucosa: 26 mg/dl y proteínas 123 mg/dl. Además, la tinción de Gram muestra visualización de diplococos gramnegativos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?
- Ceftriaxona endovenosa**
 - Cloxacilina endovenosa
 - Vancomicina endovenosa
 - Imipenem endovenoso
 - Cipro oxacino oral
51. Un paciente de 62 años presenta tendencia a la somnolencia, asociado a dificultad para realizar movimientos con la mitad derecha del cuerpo, que inició hace 2 horas. Al examen físico se aprecia un paciente confuso con una hemiparesia braquiocrural derecha, parálisis del tercer par izquierdo y signo de Babinski bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Infarto de arteria cerebral media derecha
 - Infarto de arteria cerebral media izquierda
 - Infarto de tronco-encéfalo**
 - Síndrome de enclavamiento
 - Infarto vertebro-basilar
52. Una paciente de 58 años, con antecedente de cáncer de mama, tratado con cirugía y radioterapia hace un año, consulta astenia y debilidad de las 4 extremidades. Al examen físico presenta edema y eritema palpebral, asociado a aumento de volumen en el brazo derecho. Al examen neurológico se constata la tetraparesia, con reflejos osteotendíneos normales, sin alteraciones en el tono muscular, ni signos focales. El diagnóstico más probable es:

- a. Síndrome de Guillain Barré
 - b. Miastenia gravis
 - c. Polimialgia reumática
 - d. Dermatomiositis**
 - e. Vasculitis
53. Una paciente de 24 refiere que luego de realizar ejercicios de elongación, presenta dolor súbito en el cuello y en la cabeza, con cefalea en trueno (thunderclap). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Cefalea cluster o en racimo
 - b. Accidente isquémico transitorio
 - c. Disección de la arteria cerebral o carótida**
 - d. Migraña sin aura desencadenada por el ejercicio.
 - e. Hernia traumática del núcleo pulposo
54. Un lactante de 7 meses, en tratamiento con domperidona por reflujo gastroesofágico, presenta desviación del cuello a la izquierda, asociado a llanto y movimientos irregulares de los ojos. Al examen físico presenta contractura de los músculos del cuello. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Crisis epiléptica focal
 - b. Distonía aguda por fármacos
 - c. Disquinesia aguda por fármacos**
 - d. Síndrome de West
 - e. Infección por Clostridium tetani
55. Un lactante de 15 meses de edad presenta una convulsión tónico-clónica de 1 minuto de duración, autolimitada, mientras cursaba con fiebre de 39 grados Celsius. Al examen está bien perfundido, algo pálido, consciente, con pulso y presión arterial normales, sin signos focales, ni signos meníngeos. El resto de su exploración, no presenta hallazgos de importancia. Además de bajar la temperatura del niño ¿cuál es la conducta más adecuada?
- a. Realizar punción lumbar: menores de un año
 - b. Iniciar diazepam
 - c. Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
 - d. Iniciar ácido valproico
 - e. Mantener en observación por 4 horas**
56. Un niño de 4 meses, desde hace 2 horas presenta letargia, decaimiento y compromiso de conciencia. Su fondo de ojo muestra petequias retinales. ¿Cuál es el examen más adecuada para proseguir con el estudio?
- a. Punción lumbar
 - b. TAC de cerebro**
 - c. Sedimento de orina y urocultivo
 - d. Hemocultivos
 - e. Radiografías de cráneo
57. Un paciente de 70 años, con antecedente de depresión de larga data, en tratamiento con fluoxetina e hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, consulta por temblor y torpeza de la mano derecha. Al examen se aprecia el mencionado temblor, de frecuencia baja en la mano derecha, que aumenta al caminar. Además, presenta rigidez de la mano y pie derechos. El diagnóstico más probable es:

- a. Enfermedad de Parkinson
 - b. Accidente vascular encefálico izquierdo
 - c. Parkinsonismo por fármacos
 - d. Temblor senil
 - e. Síndrome piramidal, por compresión medular
58. Un niño de 4 meses de edad presenta un cuadro de fiebre y letargia de 2 días de evolución. Su hemograma demuestra leucocitos: 12.500, con desviación izquierda y su TAC de cerebro es normal. Se realiza punción lumbar, que da salida a líquido turbio, con glucosa: 35 mg/dl, proteínas: 1.080 mg/L, células: 890 por mm³, con 90% de polimorfonucleares. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?
- a. Virus herpes simplex
 - b. Streptococcus pneumoniae
 - c. Staphylococcus aureus
 - d. Coxsackie virus
 - e. Listeria monocytogenes
59. Un paciente de 54 años, hipertenso, en tratamiento con diurético, despierta con dificultad para mover la mano derecha, asociada a hipoestesia. Al examen físico tiene paresia de la extremidad superior derecha, con hipoestesia. No tiene alteraciones de conciencia ni del habla. La movilidad y sensibilidad de las extremidades inferiores está conservada. El diagnóstico más probable es:
- a. Accidente vascular encefálico lacunar izquierdo
 - b. Accidente vascular encefálico de arteria cerebral media izquierda
 - c. Parálisis hipokalémica
 - d. Lesión del nervio radial
 - e. Lesión del nervio mediano
60. Un paciente de 70 años consulta por diplopía intermitente de 7 días de evolución. Además, refiere que, al tomar líquidos, estos se devuelven por la nariz. Al examen físico hay dificultades en la convergencia ocular y el párpado izquierdo cubre la pupila en un 50% y al levantarlo con el dedo del examinador, aparece ptosis del ojo derecho. Refiere debilidad variable y que debe permanecer más tiempo sentado, ya que está más cansado. No puede silbar. El diagnóstico más probable es:
- a. Parálisis facial recurrente
 - b. Variante del síndrome de Guillain Barré
 - c. Miastenia gravis
 - d. Accidente vascular de troncoencéfalo
 - e. Neuropatía craneal múltiple
61. Una paciente de 28 años, diagnosticada de trastorno esquizoafectivo hace poco, está recibiendo hace 7 días risperidona 5 mg al día. Evoluciona con marcada inquietud e incomodidad al permanecer en una posición, por lo que debe cambiar de posición con frecuencia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Parkinsonismo por fármacos
 - b. Distonía aguda
 - c. Discinesia tardía
 - d. Acatisia
 - e. Síndrome neuroléptico maligno

NEFROLOGÍA

1. Paciente de 25 años, deportista, corre una triatlón, luego de esta competencia, para evaluación de dopaje se realiza examen de orina, el cual muestra proteinuria ++, sin presencia de drogas. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su proteinuria?
 - a. Proteinuria funcional
 - b. Rabdomiolisis**
 - c. Deshidratación
 - d. Acidosis metabólica
 - e. Glomerulopatía membranosa

2. Un paciente de 65 años, con cuadro de compromiso del estado general de tres meses de evolución asociado a nicturia y en las últimas semanas dolor lumbar. Al examen físico destaca paciente enflaquecido, piel seca y mucosas pálidas. Se solicitan exámenes de orina que muestra proteinuria ++, urocultivo negativo, 2-3 glóbulos rojos por campo, creatinina 1,8mg/dL y antígeno prostático de 5,5 (VN <4). Además, se realiza ecografía renal que muestra dos quistes renales en lado derecho, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:
 - a. Mieloma múltiple**
 - b. Cáncer prostático metastásico
 - c. Cáncer renal metastásico
 - d. Espondilodiscitis crónica
 - e. Espondilolistesis

3. Paciente de 20 años de edad, sin antecedentes, con coriza, tos y odinofagia desde hace dos días manejadas con ibuprofeno, paracetamol y clorfenamina, consulta por aparición de hematuria el día de hoy, asociado a los síntomas antes descritos. Al examen físico presenta presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca normal, resto sin hallazgos patológicos. Se solicita examen de orina que muestra: glóbulos rojos 40-50 por campo con 20% de dismorfismo y cilindros hemáticos. El diagnóstico más probable es:
 - a. Glomerulonefritis post estreptocócica
 - b. Glomerulonefritis lúpica
 - c. Glomerulonefritis mesangial
 - d. Glomerulonefritis por IgA**
 - e. Glomerulonefritis por drogas

4. ¿Cuál de los siguientes fármacos puede producir una retención urinaria aguda?
 - a. Diazepam
 - b. Propanolol
 - c. Fluoxetina
 - d. Quetiapina
 - e. Amitriptilina**

5. Un paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, consulta por malestar general, asociado a dolor en el flanco izquierdo de dos días de evolución, que inició de forma aguda. Además presenta importante compromiso del estado general. Presenta FC: 101x', PA: 110/70 mmHg, temperatura de 36,0 grados Celsius. Su abdomen es blando, depresible, con dolor a la palpación profunda del flanco izquierdo, sin Blumberg. Además presenta puñopercusión positiva a izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
 - a. Pielonefritis aguda

- b. Diverticulitis aguda
 - c. Infarto esplénico
 - d. Isquemia mesentérica
 - e. **Aneurisma aórtico complicado**
6. Un paciente de 38 años sufre un traumatismo encefálico y de tórax en un accidente de tránsito, por lo que es hospitalizado. Se solicitan exámenes que muestran sodio plasmático: 127 mEq/l, potasio plasmático: 4,0 y Cloro plasmático: 90 mEq/L. Su densidad urinaria es de 1030 g/L y la osmolaridad urinaria, de 460 mOsm/L. El diagnóstico más probable es:
- a. Diabetes insípida
 - b. Necrosis tubular aguda
 - c. Hipovolemia
 - d. Hiponatremia secundaria a fármacos
 - e. **Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética**
7. Un paciente operado hace 7 días por una hiperplasia prostática benigna, mediante resección transuretral (RTU). Evoluciona con orinas turbias y disuria dolorosa, por lo que se realiza un sedimento de orina que muestra leucocituria y bacteriuria y un urocultivo positivo para *Pseudomona aureginosa*, con antibiograma pendiente. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente?
- a. Amoxicilina más ácido clavulánico
 - b. Nitrofurantoína
 - c. **Imipenem**
 - d. Ceftriaxona
 - e. Cotrimoxazol
8. Un paciente de 61 años, fumador, presenta hematuria durante 24 horas. Se realiza un sedimento de orina que muestra abundantes glóbulos rojos y urocultivo, que está negativo. Se realiza un UroTAC, que resulta normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?
- a. Ecografía renal y vesical
 - b. Resonancia magnética nuclear
 - c. **Cistoscopia**
 - d. Baciloscopías en orina
 - e. Cistomanometría
9. Un paciente de 27 años es diagnosticado de hipertensión arterial, mediante prueba de monitoreo de presión arterial de 24 horas. Presenta presiones arteriales cercanas a 180/110 mmHg y en sus exámenes destaca potasio plasmático de 3,0 mEq/L, sodio plasmático de 140 mEq/L y cloro plasmático de 97 mEq/L. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?
- a. **Ecodoppler renal**
 - b. Metanefrinas en orina de 24 horas
 - c. Biopsia renal
 - d. Índice de aldosterona / actividad de renina plasmática
 - e. PTH y calcio
10. Un niño de 7 años presenta edema de párpados y de EEII, asociado a orinas oscuras. Al examen tiene edema de párpados y de ambas piernas, con presión arterial de 127/85. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. **Síndrome nefrítico**
 - b. Síndrome nefrótico

- c. Enfermedad de Berger
 - d. Necrosis tubular aguda
 - e. Síndrome hemolítico urémico
11. Un paciente de 32 años presenta un cuadro de dos días de odinofagia, fiebre y mialgias, a lo que se agrega hematuria. En sus exámenes destaca sedimento de orina con incontables glóbulos rojos, con 9% de dismorfia, creatinina plasmática de 0,7 mg/dl, BUN: 13 mg/dl, C3 y C4 en niveles normales y proteinuria de 500 mg/día. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Nefropatía mesangiocapilar
 - b. Lupus
 - c. Glomerulonefritis postestreptocócica
 - d. Nefropatía por IgA
 - e. Vasculitis de vaso pequeño
12. Un paciente de 62 años presenta un cuadro de varios días de evolución, de orinas espumosas, asociado a edema marcado de extremidades inferiores. Su sedimento de orina muestra 2-4 hematíes por campo, 5-10 leucocitos por campo, creatininemia de 1,2 mg/dl y proteinuria de 24 horas de 7 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Nefropatía por IgA
 - b. Enfermedad renal lúpica
 - c. Glomerulonefritis postestreptocócica
 - d. Glomerulonefritis mesangiocapilar
 - e. Nefropatía membranosa
13. Un paciente de 64 años, con antecedente de haber sido tratado por un mieloma, con buena respuesta, consulta ahora por cuadro de astenia, con constipación y aumento del volumen urinario, a lo que luego se le agrega desorientación. Al examen físico se aprecia soporoso, pálido. En sus exámenes presenta hematocrito 27%, con Hb: 9 g/dl, VHS: 93 mm/h, proteínas plasmáticas: 7,8 g/dl, albúmina: 3,7 g/dl, sodio: 140 mEq/L, potasio: 4,8 mEq/L, calcio: 14,3 mg/dl. En este momento debe recibir:
- a. Calcitonina
 - b. Solución salina al 0,9%
 - c. Vitamina D
 - d. Bifosfonatos
 - e. Corticoides
14. Un niño de 4 años, presenta un cuadro de 10 días de evolución de edema bipalpebral, a lo que se ha agregado, en los últimos dos días, oliguria y orinas espumosas. Al examen físico presenta presión arterial 102/62 mmHg, FC: 80x', edema facial y de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca examen de orina con proteínas ++, creatininemia 0,9 mg/dl y BUN: 20 mg/dl. El diagnóstico más probable es:
- a. Síndrome nefrótico
 - b. Glomerulonefritis aguda
 - c. Insuficiencia renal crónica
 - d. Síndrome hemolítico urémico
 - e. Nefritis intersticial

15. Un paciente de 70 años, diabético tipo 2 e hipertenso, en tratamiento con metformina, losartán e hidroclorotiazida, presenta un cuadro de 4 días de vómitos alimentarios y diarrea, evolucionando con malestar general y disminución del volumen urinario. Al examen físico está bradipsíquico, con presión arterial de 100/50 mmHg, frecuencia cardíaca de 110x'. En sus exámenes de laboratorio destaca creatinina: 2,0 mg/dl, BUN: 78 mg/dl, FeNa: 0,5%, sodio: 130 mEq/L, potasio: 2,0 mEq/L y cloro: 110 mEq/L . ¿Qué fluido debe administrarse inicialmente?
- Solución glucosada al 5%
 - Solución ringer lactato**
 - Albúmina al 5%
 - Solución glucosalina isotónica
 - Solución de bicarbonato al 2/3 molar
16. Un paciente de 32 años presenta un cuadro de cólico renal, asociado a microhematuria en el sedimento de orina. ¿Cuál es el examen de elección para el estudio de este paciente?
- UroTAC
 - PieloTAC**
 - Pielografía de eliminación intravenosa
 - Ecografía
 - Radiografía simple
17. Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico destaca PA: 170/95 mmHg, FC: 80 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K:2.6 mEq/L, Cl:90 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. La causa más probable de la hipertensión es:
- Hipertensión renovascular
 - Feocromocitoma
 - Hipotiroidismo
 - Hiperaldosteronismo**
 - Hipertensión esencial
18. Un hombre de 32 años presenta dolor muscular y oliguria, 24 horas después de realizar ejercicio intenso, a lo que se agrega malestar general. En sus exámenes destaca creatininemia de 5 mg/dl, uremia de 9 mg/dl y potasemia de 5,4 mEq/L, con natremia: 140 UI/L. ¿Qué examen debe pedirse a continuación?
- Creatininkinasa**
 - Proteinuria de 24 horas
 - Hemograma
 - Sedimento de orina
 - Clearence de creatinina
19. Paciente 36 años, sin antecedentes de importancia, cursa con un cuadro de un mes de evolución de edema de EEII que posteriormente se agrega edema bpalpebral que aparece en las mañanas. Al examen físico, presenta FC: 96'x, TA: 130/70 mmHg, se constata edema de miembros inferiores, en ambos tobillos, que asciende hasta la pierna. Se solicitan exámenes de laboratorio, que muestran creatininemia 1,7 mg/dl, BUN 20 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, examen de orina con densidad: 1020 g/L, glucosuria (-), nitritos (-), proteínas (++) , eritrocitos: 2-3 x campo, leucocitos 3-5 x campo. El diagnóstico más probable es:
- Síndrome nefrítico
 - Síndrome nefrótico**
 - Síndrome cardiorrenal

- d. Injuria renal aguda
- e. Hiperaldosteronismo primario

20. Una paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con hidroclorotiazida, presenta un cuadro de diarrea y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor profundo, con PA: 80/50 y frecuencia cardíaca de 120x', regular, con sequedad de mucosas. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran natremia: 156. mEq/L, cloremia: 114 mEq/L, potasemia: 3,1 mEq/L, pH: 7,40, bicarbonato: 14 mmol/L, CO₂: 20 mmHg. ¿Cuál de los siguientes fluido se debe administrar en primer lugar?
- a. Suero glucosado al 5% ev
 - b. Suero fisiológico al 0,9% ev
 - c. Solución de bicarbonato al 2/3 molar ev
 - d. Agua por sonda nasogástrica
 - e. Sales de rehidratación oral
21. Paciente femenina, fumadora de 30 paquetes/año, presenta hematuria, con abundante coágulos de sangre. No presenta dolor, fiebre, ni otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina, que muestra abundantes eritrocitos, sin bacterias. El diagnóstico más probable es:
- a. Cistitis hemorrágica
 - b. Cáncer de vejiga
 - c. Cáncer renal.
 - d. Tuberculosis renal
 - e. Infección urinaria
22. Paciente de 36 años con fiebre y la presencia de una lesión en miembro inferior, en forma de una placa de eritematosa, con bordes definidos de aproximadamente 15 x 8 cm, que responde bien al tratamiento con cloxacilina. Al quinto día comienza con náuseas, vómitos, diuresis adecuada, con leucocitosis de 15.000 por mm³, con 10% de eosinófilos, 40% de neutrófilos y 48% de linfocitos, uremia en 50 mg/dl, creatinina en 3 mg/dl, hematuria microscópica, leucocituria, y proteinuria de 0,8 g/día. Identificar el posible diagnóstico:
- a. Glomerulonefritis post estreptocócica
 - b. Vasculitis de vasos pequeños
 - c. Injuria renal pre renal
 - d. Endocarditis infecciosa
 - e. Nefritis intersticial
23. Un paciente de 66 años consulta por dolor lumbar derecho de 8 horas de evolución, irradiado al flanco ipsilateral y asociado a fiebre, vómitos, hematuria y agitación psicomotora. Al examen físico presenta FC: 100x', con ritmo cardíaco irregular, en dos tiempos, PA: 120/70 mmHg y puñopercusión positiva a derecha. En sus exámenes, se aprecian incontables glóbulos rojos en el sedimento de orina y 20 glóbulos blancos por campo. Destaca además creatinina plasmática de 2,3 mg/dl. El diagnóstico más probable es:
- a. Aneurisma aórtico abdominal roto
 - b. Urolitiasis
 - c. Pielonefritis aguda
 - d. Torsión testicular
 - e. Embolia renal

24. Un paciente de 30 años, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de rinorrea, tos y disfonía, a lo que se agregó hematuria. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, con presión arterial 150/100 mmHg, edema blando de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes entre los que destaca sedimento de orina con 15 leucocitos por campo más incontables eritrocitos con 9% de dismorfía, proteinuria de 24 horas de 2 gramos y creatinina de 1,7mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Glomerulonefritis post estreptocócica
 - Nefropatía por depósitos de IgA**
 - Litiasis renal
 - Pielonefritis aguda
 - Lupus eritematoso sistémico
25. Paciente de 63 años, con antecedente de hipernefroma operado hace un año, con buena evolución, consulta por cuadro de astenia y debilidad de 7 días, controlándose exámenes de sangre entre los que destaca calcemia de 11,8 mg/dL (valor normal 8,5-10,5 mg/dL), albúmina normal. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente?
- Cintigrafía ósea
 - Niveles plasmáticos de calcio y paratohormona**
 - TAC de abdomen y pelvis
 - Niveles plasmáticos de vitamina D
 - Resonancia magnética de abdomen y pelvis
26. Un paciente de 87 años, institucionalizado por una demencia tipo Alzheimer y que es portador de sonda Foley a permanencia, que se cambia cada un mes, presenta orinas turbias, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli sensible a nitrofurantoína, gentamicina e imipenem. El paciente está asintomático, sin mayor confusión de la habitual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Iniciar nitrofurantoína v.o.
 - Iniciar gentamicina i.m.
 - Iniciar imipenem e.v.
 - Observar evolución, sin necesidad de retirar la sonda**
 - Solicitar hemograma, VHS y PCR y decidir conducta según hallazgos
27. Un paciente de 33 años, hospitalizado por una endocarditis subaguda por estreptococcus viridans, en tratamiento con penicilina y gentamicina por vía endovenosa, presenta un cuadro de hematuria de algunos días de evolución. Se solicita sedimento de orina que muestra 50 glóbulos rojos por campo con 95% de dismorfia y presencia de cilindros hemáticos, creatinina de 2,4mg/dL, ANA (-), fracción C3 del complemento de 53mg/dL (valor normal: 75-135 mg/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Embolias renales a repetición
 - Nefritis intersticial secundaria al uso de penicilina
 - Daño tubular agudo secundario al uso de gentamicina
 - Glomerulonefritis por depósito de complejos inmunes**
 - Síndrome hemolítico urémico
28. Una paciente presenta su sexta litiasis urológica, por lo que se realizan exámenes, entre los que destacan creatinina: 1,2 mg/dl, BUN: 30 mg/dl, calcio: 11 mg/dl, fósforo: 2,3 mg/dl, natremia normal, potasemia normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio diagnóstico?
- Paratohormona**
 - LH y FSH

- c. 25 OH vitamina D
 - d. Biopsia de médula ósea
 - e. Índice proteinuria / creatininuria
29. Una paciente de 67 años, presenta un cuadro de malestar general, asociado a febrículas y edema de las extremidades inferiores. Al examen físico, su presión arterial es 180/110 mmHg y se constata el edema blando, con signo de la fóvea. En sus exámenes de sangre destaca creatininemia de 4,1 mg/dl, BUN de 60 mg/dl y sedimento de orina con 60 eritrocitos por campo, con 80% de dismorfia y leucocitos de 10 a 15 por campo y cilindros hemáticos. Su hemograma muestra hemoglobina: 11,8 mg/dl, hematocrito: 36%, blancos: 10.000 por mm³, plaquetas: 160.000 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Glomerulonefritis postestreptocócica
 - b. Nefropatía diabética
 - c. Lesión glomerular mínima
 - d. Vasculitis ANCA positiva
 - e. Púrpura trombocitopénico trombótico
30. Un paciente de 45 años ha presentado 3 episodios de gota en el último año, por lo que se inició tratamiento colchicina y luego se agregó alopurinol 100 mg/día. Actualmente está asintomático, sin signos de artritis y se controla uricemia de 7 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- a. Suspender el tratamiento
 - b. Aumentar la dosis de alopurinol a 300 mg/día
 - c. Agregar probenecid al tratamiento
 - d. Suspender la colchicina
 - e. Agregar prednisona en baja dosis
31. Un paciente de 28 años, con antecedente de tuberculosis renal a los 16 años, tratada a esa edad, presenta edema blando de extremidades inferiores mayor en las tardes, asociada a hipertensión arterial de 150/90 mmHg. En sus exámenes destaca creatinina plasmática: 2,8 mg/dl, BUN: 40 mg/dl, Na⁺: 132 mEq/L, K⁺: 5,0 mEq/L, orina completa con proteinuria ++ y sedimento de orina normal. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio diagnóstico?
- a. Pielografía de eliminación
 - b. Ecografía abdominal
 - c. Índice proteinuria / creatininuria
 - d. Cintigrafía DMSA
 - e. TAC renal
32. Una paciente de 60 años, con antecedente de hipotiroidismo, hipertensión y depresión, en tratamiento con levotiroxina, enalapril y citalopram se realiza exámenes de control, entre los que destacan sodio plasmático de 127 mEq/L, potasio plasmático de 4,1 mEq/L, creatinina plasmática de 0,9 mg/dl y sodio urinario de 60 mEq/L. ¿Cuál es la causa más probable de su hiponatremia?
- a. Uso del enalapril
 - b. Reacción secundaria al citalopram
 - c. Síndrome paraneoplásico
 - d. Insuficiencia suprarrenal
 - e. Hipotiroidismo descompensado

33. Un paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con enalapril, amlodipino, furosemida y carvedilol. Realiza un cambio de diurético por clortadilona, con buena respuesta clínica, reduciendo de la disnea. Sin embargo evolucionando con debilidad de las extremidades inferiores, por lo que se solicitan exámenes que muestran creatinina plasmática: 1,0 mg/dl y electrolitos plasmáticos, que resultan Na⁺:132 mEq/L y K⁺: 3,5 mEq/L. ¿Cuál es la indicación más adecuada?
- Aumentar el consumo de agua
 - Restringir el consumo de cloruro de sodio
 - Suspender la clortadinona
 - Bajar la dosis de enalapril
 - Iniciar hidroclorotiazida
34. Un paciente de 80 años consulta por equimosis periorbitaria, sin antecedente traumático, asociado a astenia y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destacan creatinina: 2,6 mg/dl, proteinuria de 24 horas: 8,4 gramos/día, albuminemia: 1,4 g/dl. Su hemograma es normal y su VHS: 96 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Nefrosis lipoidea
 - Nefropatía diabética
 - Amiloidosis primaria
 - Enfermedad de Berger
 - Arteritis de la temporal
35. Un paciente de 24 años es hospitalizado por un accidente automovilístico, con traumatismo torácico complejo y traumatismo encefalocraneano. Es manejado con soporte y reposición de fluidos y se controlan exámenes, entre los que destaca hiponatremia, con sodio plasmático: 125 mEq/L, cloremia: 92 mEq/L, potasemia: 4,0 mEq/L, creatininemia: 0,8 mg/dl, osmolaridad urinaria: 650 mOsm/L, densidad urinaria: 1030 g/L. ¿Cuál es la causa más probable de la hiponatremia?
- Administración de fluidos hipotónicos
 - Diabetes insípida
 - Administración de diuréticos
 - Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
 - Disminución de la ingesta de sal
36. Un hombre de 36 años, que desde hace 3 días presenta un cuadro de congestión nasal y rinorrea, con escasos tos. Evoluciona con edema maleolares, malestar general, hematuria en varias oportunidades y disnea. Al examen físico está FC: 68x', PA: 160/100 mmHg, tiene edema de ambas extremidades, con signo de la fóvea (+) y al examen pulmonar se auscultan crépitos bibasales. Se solicitan exámenes, con complemento normal, creatininemia: 0,9 mg/dl, BUN: 21 mg/dl, sedimento de orina con abundantes glóbulos rojos, con 30% de dismorfia. El diagnóstico más probable es:
- Glomerulonefritis postinfecciosa
 - Nefropatía por IgA
 - Necrosis tubular aguda
 - Síndrome hemolítico urémico
 - Glomerulonefritis rápidamente progresiva, asociada a ANCA
37. Un paciente de 65 años presenta hace 2 meses incontinencia urinaria, de urgencia. Además, tiene disminución del calibre del chorro miccional, con disuria de esfuerzos. Hace 2 semanas evoluciona con náuseas, vómitos y malestar general, asociado a edemas maleolares e hipertensión arterial. Se realiza exámenes, que muestran

creatininemia: 4,2 mg/dl, uremia: 90 mg/dl, Na: 130 mEq/L, K: 5,8 mg/dl. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio?

- a. **Ecografía renal**
- b. Cintigrafía renal
- c. Cistoscopia
- d. PielotAC
- e. Uretrocistografía

38. Un paciente de 53 años, con antecedente de úlcera gastroduodenal recurrente, desde hace una semana empieza con sensación de plenitud precoz, asociada a vómitos alimentarios frecuentes, mayores postprandiales. Evoluciona con malestar general, mareos y marcado decaimiento. Su examen físico muestra FC:120x', PA: 90/60 mmHg y se aprecia decaído. Se solicitan exámenes que muestran creatinina plasmática: 2,1; uremia: 80 mg/dl, Na+ plasmático: 125 mEq/L, K+ plasmático:4,5 mEq/L, Cl- plasmático:120, bicarbonato plasmático: 40 mEq/L, K+ urinario: 25 mEq/L, Na+ urinario: 8 mEq/L. La medida inicial más adecuada es:

- a. Administrar acetazolamida
- b. Administrar suero glucosado al 5% endovenosa
- c. **Administrar solución salina al 0,9% endovenosa**
- d. Administrar solución salina al 3%
- e. Administrar bicarbonato endovenoso

NEFROLOGÍA

39. Paciente de 25 años, deportista, corre una triatlón, luego de esta competencia, para evaluación de dopaje se realiza examen de orina, el cual muestra proteinuria ++, sin presencia de drogas. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su proteinuria?
- a. Proteinuria funcional
 - b. Rabdomiolisis**
 - c. Deshidratación
 - d. Acidosis metabólica
 - e. Glomerulopatía membranosa
40. Un paciente de 65 años, con cuadro de compromiso del estado general de tres meses de evolución asociado a nicturia y en las últimas semanas dolor lumbar. Al examen físico destaca paciente enflaquecido, piel seca y mucosas pálidas. Se solicitan exámenes de orina que muestra proteinuria ++, urocultivo negativo, 2-3 glóbulos rojos por campo, creatinina 1,8mg/dL y antígeno prostático de 5,5 (VN <4). Además, se realiza ecografía renal que muestra dos quistes renales en lado derecho, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:
- a. Mieloma múltiple**
 - b. Cáncer prostático metastásico
 - c. Cáncer renal metastásico
 - d. Espondilodiscitis crónica
 - e. Espondilolistesis
41. Paciente de 20 años de edad, sin antecedentes, con coriza, tos y odinofagia desde hace dos días manejadas con ibuprofeno, paracetamol y clorfenamina, consulta por aparición de hematuria el día de hoy, asociado a los síntomas antes descritos. Al examen físico presenta presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca normal, resto sin hallazgos patológicos. Se solicita examen de orina que muestra: glóbulos rojos 40-50 por campo con 20% de dismorfismo y cilindros hemáticos. El diagnóstico más probable es:
- a. Glomerulonefritis post estreptocócica
 - b. Glomerulonefritis lúpica
 - c. Glomerulonefritis mesangial
 - d. Glomerulonefritis por IgA**
 - e. Glomerulonefritis por drogas
42. ¿Cuál de los siguientes fármacos puede producir una retención urinaria aguda?
- a. Diazepam
 - b. Propanolol
 - c. Fluoxetina
 - d. Quetiapina
 - e. Amitriptilina**
43. Un paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, consulta por malestar general, asociado a dolor en el flanco izquierdo de dos días de evolución, que inició de forma aguda. Además presenta importante compromiso del estado general. Presenta FC: 101x', PA: 110/70 mmHg, temperatura de 36,0 grados Celsius. Su abdomen es blando, depresible, con dolor a la palpación profunda del flanco izquierdo, sin Blumberg. Además presenta puñopercusión positiva a izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Pielonefritis aguda

- b. Diverticulitis aguda
 - c. Infarto esplénico
 - d. Isquemia mesentérica
 - e. **Aneurisma aórtico complicado**
44. Un paciente de 38 años sufre un traumatismo encefálico y de tórax en un accidente de tránsito, por lo que es hospitalizado. Se solicitan exámenes que muestran sodio plasmático: 127 mEq/l, potasio plasmático: 4,0 y Cloro plasmático: 90 mEq/L. Su densidad urinaria es de 1030 g/L y la osmolaridad urinaria, de 460 mOsm/L. El diagnóstico más probable es:
- a. Diabetes insípida
 - b. Necrosis tubular aguda
 - c. Hipovolemia
 - d. Hiponatremia secundaria a fármacos
 - e. **Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética**
45. Un paciente operado hace 7 días por una hiperplasia prostática benigna, mediante resección transuretral (RTU). Evoluciona con orinas turbias y disuria dolorosa, por lo que se realiza un sedimento de orina que muestra leucocituria y bacteriuria y un urocultivo positivo para *Pseudomona aureginosa*, con antibiograma pendiente. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente?
- a. Amoxicilina más ácido clavulánico
 - b. Nitrofurantoína
 - c. **Imipenem**
 - d. Ceftriaxona
 - e. Cotrimoxazol
46. Un paciente de 61 años, fumador, presenta hematuria durante 24 horas. Se realiza un sedimento de orina que muestra abundantes glóbulos rojos y urocultivo, que está negativo. Se realiza un UroTAC, que resulta normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?
- a. Ecografía renal y vesical
 - b. Resonancia magnética nuclear
 - c. **Cistoscopia**
 - d. Baciloscopías en orina
 - e. Cistomanometría
47. Un paciente de 27 años es diagnosticado de hipertensión arterial, mediante prueba de monitoreo de presión arterial de 24 horas. Presenta presiones arteriales cercanas a 180/110 mmHg y en sus exámenes destaca potasio plasmático de 3,0 mEq/L, sodio plasmático de 140 mEq/L y cloro plasmático de 97 mEq/L. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?
- a. **Ecodoppler renal**
 - b. Metanefrinas en orina de 24 horas
 - c. Biopsia renal
 - d. Índice de aldosterona / actividad de renina plasmática
 - e. PTH y calcio
48. Un niño de 7 años presenta edema de párpados y de EEII, asociado a orinas oscuras. Al examen tiene edema de párpados y de ambas piernas, con presión arterial de 127/85. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. **Síndrome nefrítico**
 - b. Síndrome nefrótico

- c. Enfermedad de Berger
- d. Necrosis tubular aguda
- e. Síndrome hemolítico urémico

49. Un paciente de 32 años presenta un cuadro de dos días de odinofagia, fiebre y mialgias, a lo que se agrega hematuria. En sus exámenes destaca sedimento de orina con incontables glóbulos rojos, con 9% de dismorfia, creatinina plasmática de 0,7 mg/dl, BUN: 13 mg/dl, C3 y C4 en niveles normales y proteinuria de 500 mg/día. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Nefropatía mesangiocapilar
 - b. Lupus
 - c. Glomerulonefritis postestreptocócica
 - d. **Nefropatía por IgA**
 - e. Vasculitis de vaso pequeño
50. Un paciente de 62 años presenta un cuadro de varios días de evolución, de orinas espumosas, asociado a edema marcado de extremidades inferiores. Su sedimento de orina muestra 2-4 hematíes por campo, 5-10 leucocitos por campo, creatininemia de 1,2 mg/dl y proteinuria de 24 horas de 7 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Nefropatía por IgA
 - b. Enfermedad renal lúpica
 - c. Glomerulonefritis postestreptocócica
 - d. Glomerulonefritis mesangiocapilar
 - e. **Nefropatía membranosa**
51. Un paciente de 64 años, con antecedente de haber sido tratado por un mieloma, con buena respuesta, consulta ahora por cuadro de astenia, con constipación y aumento del volumen urinario, a lo que luego se le agrega desorientación. Al examen físico se aprecia soporoso, pálido. En sus exámenes presenta hematocrito 27%, con Hb: 9 g/dl, VHS: 93 mm/h, proteínas plasmáticas: 7,8 g/dl, albúmina: 3,7 g/dl, sodio: 140 mEq/L, potasio: 4,8 mEq/L, calcio: 14,3 mg/dl. En este momento debe recibir:
- a. Calcitonina
 - b. **Solución salina al 0,9%**
 - c. Vitamina D
 - d. Bifosfonatos
 - e. Corticoides
52. Un niño de 4 años, presenta un cuadro de 10 días de evolución de edema bipalpebral, a lo que se ha agregado, en los últimos dos días, oliguria y orinas espumosas. Al examen físico presenta presión arterial 102/62 mmHg, FC: 80x', edema facial y de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca examen de orina con proteínas ++, creatininemia 0,9 mg/dl y BUN: 20 mg/dl. El diagnóstico más probable es:
- a. **Síndrome nefrótico**
 - b. Glomerulonefritis aguda
 - c. Insuficiencia renal crónica
 - d. Síndrome hemolítico urémico
 - e. Nefritis intersticial

53. Un paciente de 70 años, diabético tipo 2 e hipertenso, en tratamiento con metformina, losartán e hidroclorotiazida, presenta un cuadro de 4 días de vómitos alimentarios y diarrea, evolucionando con malestar general y disminución del volumen urinario. Al examen físico está bradipsíquico, con presión arterial de 100/50 mmHg, frecuencia cardíaca de 110x'. En sus exámenes de laboratorio destaca creatinina: 2,0 mg/dl, BUN: 78 mg/dl, FeNa: 0,5%, sodio: 130 mEq/L, potasio: 2,0 mEq/L y cloro: 110 mEq/L . ¿Qué fluido debe administrarse inicialmente?
- Solución glucosada al 5%
 - Solución ringer lactato**
 - Albúmina al 5%
 - Solución glucosalina isotónica
 - Solución de bicarbonato al 2/3 molar
54. Un paciente de 32 años presenta un cuadro de cólico renal, asociado a microhematuria en el sedimento de orina. ¿Cuál es el examen de elección para el estudio de este paciente?
- UroTAC
 - PieloTAC**
 - Pielografía de eliminación intravenosa
 - Ecografía
 - Radiografía simple
55. Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico destaca PA: 170/95 mmHg, FC: 80 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K:2.6 mEq/L, Cl:90 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. La causa más probable de la hipertensión es:
- Hipertensión renovascular
 - Feocromocitoma
 - Hipotiroidismo
 - Hiperaldosteronismo**
 - Hipertensión esencial
56. Un hombre de 32 años presenta dolor muscular y oliguria, 24 horas después de realizar ejercicio intenso, a lo que se agrega malestar general. En sus exámenes destaca creatininemia de 5 mg/dl, uremia de 9 mg/dl y potasemia de 5,4 mEq/L, con natremia: 140 UI/L. ¿Qué examen debe pedirse a continuación?
- Creatininkinasa**
 - Proteinuria de 24 horas
 - Hemograma
 - Sedimento de orina
 - Clearence de creatinina
57. Paciente 36 años, sin antecedentes de importancia, cursa con un cuadro de un mes de evolución de edema de EEII que posteriormente se agrega edema bipalpebral que aparece en las mañanas. Al examen físico, presenta FC: 96'x, TA: 130/70 mmHg, se constata edema de miembros inferiores, en ambos tobillos, que asciende hasta la pierna. Se solicitan exámenes de laboratorio, que muestran creatininemia 1,7 mg/dl, BUN 20 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, examen de orina con densidad: 1020 g/L, glucosuria (-), nitritos (-), proteínas (++) , eritrocitos: 2-3 x campo, leucocitos 3-5 x campo. El diagnóstico más probable es:
- Síndrome nefrítico
 - Síndrome nefrótico**
 - Síndrome cardiorenal

- d. Injuria renal aguda
- e. Hiperaldosteronismo primario

58. Una paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con hidroclorotiazida, presenta un cuadro de diarrea y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor profundo, con PA: 80/50 y frecuencia cardíaca de 120x', regular, con sequedad de mucosas. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran natremia: 156. mEq/L, cloremia: 114 mEq/L, potasemia: 3,1 mEq/L, pH: 7,40, bicarbonato: 14 mmol/L, CO₂: 20 mmHg. ¿Cuál de los siguientes fluido se debe administrar en primer lugar?

- a. Suero glucosado al 5% ev
- b. Suero fisiológico al 0,9% ev
- c. Solución de bicarbonato al 2/3 molar ev
- d. Agua por sonda nasogástrica
- e. Sales de rehidratación oral

59. Paciente femenina, fumadora de 30 paquetes/año, presenta hematuria, con abundante coágulos de sangre. No presenta dolor, fiebre, ni otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina, que muestra abundantes eritrocitos, sin bacterias. El diagnóstico más probable es:

- a. Cistitis hemorrágica
- b. Cáncer de vejiga
- c. Cáncer renal.
- d. Tuberculosis renal
- e. Infección urinaria

60. Paciente de 36 años con fiebre y la presencia de una lesión en miembro inferior, en forma de una placa de eritematosa, con bordes definidos de aproximadamente 15 x 8 cm, que responde bien al tratamiento con cloxacilina. Al quinto día comienza con náuseas, vómitos, diuresis adecuada, con leucocitosis de 15.000 por mm³, con 10% de eosinófilos, 40% de neutrófilos y 48% de linfocitos, uremia en 50 mg/dl, creatinina en 3 mg/dl, hematuria microscópica, leucocituria, y proteinuria de 0,8 g/día. Identificar el posible diagnóstico:

- a. Glomerulonefritis post estreptocócica
- b. Vasculitis de vasos pequeños
- c. Injuria renal pre renal
- d. Endocarditis infecciosa
- e. Nefritis intersticial

61. Un paciente de 66 años consulta por dolor lumbar derecho de 8 horas de evolución, irradiado al flanco ipsilateral y asociado a fiebre, vómitos, hematuria y agitación psicomotora. Al examen físico presenta FC: 100x', con ritmo cardíaco irregular, en dos tiempos, PA: 120/70 mmHg y puñopercusión positiva a derecha. En sus exámenes, se aprecian incontables glóbulos rojos en el sedimento de orina y 20 glóbulos blancos por campo. Destaca además creatinina plasmática de 2,3 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a. Aneurisma aórtico abdominal roto
- b. Urolitiasis
- c. Pielonefritis aguda
- d. Torsión testicular
- e. Embolia renal

62. Un paciente de 30 años, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de rinorrea, tos y disfonía, a lo que se agregó hematuria. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, con presión arterial 150/100 mmHg, edema blando de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes entre los que destaca sedimento de orina con 15 leucocitos por campo más incontables eritrocitos con 9% de dismorfía, proteinuria de 24 horas de 2 gramos y creatinina de 1,7mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Glomerulonefritis post estreptocócica
 - Nefropatía por depósitos de IgA**
 - Litiasis renal
 - Pielonefritis aguda
 - Lupus eritematoso sistémico
63. Paciente de 63 años, con antecedente de hipernefroma operado hace un año, con buena evolución, consulta por cuadro de astenia y debilidad de 7 días, controlándose exámenes de sangre entre los que destaca calcemia de 11,8 mg/dL (valor normal 8,5-10,5 mg/dL), albúmina normal. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente?
- Cintigrafía ósea
 - Niveles plasmáticos de calcio y paratohormona**
 - TAC de abdomen y pelvis
 - Niveles plasmáticos de vitamina D
 - Resonancia magnética de abdomen y pelvis
64. Un paciente de 87 años, institucionalizado por una demencia tipo Alzheimer y que es portador de sonda Foley a permanencia, que se cambia cada un mes, presenta orinas turbias, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli sensible a nitrofurantoína, gentamicina e imipenem. El paciente está asintomático, sin mayor confusión de la habitual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Iniciar nitrofurantoína v.o.
 - Iniciar gentamicina i.m.
 - Iniciar imipenem e.v.
 - Observar evolución, sin necesidad de retirar la sonda**
 - Solicitar hemograma, VHS y PCR y decidir conducta según hallazgos
65. Un paciente de 33 años, hospitalizado por una endocarditis subaguda por estreptococcus viridans, en tratamiento con penicilina y gentamicina por vía endovenosa, presenta un cuadro de hematuria de algunos días de evolución. Se solicita sedimento de orina que muestra 50 glóbulos rojos por campo con 95% de dismorfia y presencia de cilindros hemáticos, creatinina de 2,4mg/dL, ANA (-), fracción C3 del complemento de 53mg/dL (valor normal: 75-135 mg/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Embolias renales a repetición
 - Nefritis intersticial secundaria al uso de penicilina
 - Daño tubular agudo secundario al uso de gentamicina
 - Glomerulonefritis por depósito de complejos inmunes**
 - Síndrome hemolítico urémico
66. Una paciente presenta su sexta litiasis urológica, por lo que se realizan exámenes, entre los que destacan creatinina: 1,2 mg/dl, BUN: 30 mg/dl, calcio: 11 mg/dl, fósforo: 2,3 mg/dl, natremia normal, potasemia normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio diagnóstico?
- Paratohormona**
 - LH y FSH

- c. 25 OH vitamina D
- d. Biopsia de médula ósea
- e. Índice proteinuria / creatininuria

67. Una paciente de 67 años, presenta un cuadro de malestar general, asociado a febrículas y edema de las extremidades inferiores. Al examen físico, su presión arterial es 180/110 mmHg y se constata el edema blando, con signo de la fóvea. En sus exámenes de sangre destaca creatininemia de 4,1 mg/dl, BUN de 60 mg/dl y sedimento de orina con 60 eritrocitos por campo, con 80% de dismorfia y leucocitos de 10 a 15 por campo y cilindros hemáticos. Su hemograma muestra hemoglobina: 11,8 mg/dl, hematocrito: 36%, blancos: 10.000 por mm³, plaquetas: 160.000 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Glomerulonefritis postestreptocócica
 - b. Nefropatía diabética
 - c. Lesión glomerular mínima
 - d. Vasculitis ANCA positiva
 - e. Púrpura trombocitopénico trombótico
68. Un paciente de 45 años ha presentado 3 episodios de gota en el último año, por lo que se inició tratamiento colchicina y luego se agregó alopurinol 100 mg/día. Actualmente está asintomático, sin signos de artritis y se controla uricemia de 7 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- a. Suspender el tratamiento
 - b. Aumentar la dosis de alopurinol a 300 mg/día
 - c. Agregar probenecid al tratamiento
 - d. Suspender la colchicina
 - e. Agregar prednisona en baja dosis
69. Un paciente de 28 años, con antecedente de tuberculosis renal a los 16 años, tratada a esa edad, presenta edema blando de extremidades inferiores mayor en las tardes, asociada a hipertensión arterial de 150/90 mmHg. En sus exámenes destaca creatinina plasmática: 2,8 mg/dl, BUN: 40 mg/dl, Na⁺: 132 mEq/L, K⁺: 5,0 mEq/L, orina completa con proteinuria ++ y sedimento de orina normal. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio diagnóstico?
- a. Pielografía de eliminación
 - b. Ecografía abdominal
 - c. Índice proteinuria / creatininuria
 - d. Cintigrafía DMSA
 - e. TAC renal
70. Una paciente de 60 años, con antecedente de hipotiroidismo, hipertensión y depresión, en tratamiento con levotiroxina, enalapril y citalopram se realiza exámenes de control, entre los que destacan sodio plasmático de 127 mEq/L, potasio plasmático de 4,1 mEq/L, creatinina plasmática de 0,9 mg/dl y sodio urinario de 60 mEq/L. ¿Cuál es la causa más probable de su hiponatremia?
- a. Uso del enalapril
 - b. Reacción secundaria al citalopram
 - c. Síndrome paraneoplásico
 - d. Insuficiencia suprarrenal
 - e. Hipotiroidismo descompensado

71. Un paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con enalapril, amlodipino, furosemida y carvedilol. Realiza un cambio de diurético por clortadilona, con buena respuesta clínica, reduciendo de la disnea. Sin embargo evolucionando con debilidad de las extremidades inferiores, por lo que se solicitan exámenes que muestran creatinina plasmática: 1,0 mg/dl y electrolitos plasmáticos, que resultan Na⁺:132 mEq/L y K⁺: 3,5 mEq/L. ¿Cuál es la indicación más adecuada?
- Aumentar el consumo de agua
 - Restringir el consumo de cloruro de sodio
 - Suspender la clortadinona
 - Bajar la dosis de enalapril
 - Iniciar hidroclorotiazida
72. Un paciente de 80 años consulta por equimosis periorbitaria, sin antecedente traumático, asociado a astenia y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destacan creatinina: 2,6 mg/dl, proteinuria de 24 horas: 8,4 gramos/día, albuminemia: 1,4 g/dl. Su hemograma es normal y su VHS: 96 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Nefrosis lipoidea
 - Nefropatía diabética
 - Amiloidosis primaria
 - Enfermedad de Berger
 - Arteritis de la temporal
73. Un paciente de 24 años es hospitalizado por un accidente automovilístico, con traumatismo torácico complejo y traumatismo encefalocraneano. Es manejado con soporte y reposición de fluidos y se controlan exámenes, entre los que destaca hiponatremia, con sodio plasmático: 125 mEq/L, cloremia: 92 mEq/L, potasemia: 4,0 mEq/L, creatininemia: 0,8 mg/dl, osmolaridad urinaria: 650 mOsm/L, densidad urinaria: 1030 g/L. ¿Cuál es la causa más probable de la hiponatremia?
- Administración de fluidos hipotónicos
 - Diabetes insípida
 - Administración de diuréticos
 - Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
 - Disminución de la ingesta de sal
74. Un hombre de 36 años, que desde hace 3 días presenta un cuadro de congestión nasal y rinorrea, con escasa tos. Evoluciona con edema maleolares, malestar general, hematuria en varias oportunidades y disnea. Al examen físico está FC: 68x', PA: 160/100 mmHg, tiene edema de ambas extremidades, con signo de la fóvea  y al examen pulmonar se auscultan crépitos bibasales. Se solicitan exámenes, con complemento normal, creatininemia: 0,9 mg/dl, BUN: 21 mg/dl, sedimento de orina con abundantes glóbulos rojos, con 30% de dismorfia. El diagnóstico más probable es:
- Glomerulonefritis postinfecciosa
 - Nefropatía por IgA
 - Necrosis tubular aguda
 - Síndrome hemolítico urémico
 - Glomerulonefritis rápidamente progresiva, asociada a ANCA
75. Un paciente de 65 años presenta hace 2 meses incontinencia urinaria, de urgencia. Además, tiene disminución del calibre del chorro miccional, con disuria de esfuerzos. Hace 2 semanas evoluciona con náuseas, vómitos y malestar general, asociado a edemas maleolares e hipertensión arterial. Se realiza exámenes, que muestran

creatininemia: 4,2 mg/dl, uremia: 90 mg/dl, Na: 130 mEq/L, K: 5,8 mg/dl. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio?

- a. **Ecografía renal**
- b. Cintigrafía renal
- c. Cistoscopia
- d. PieloTAC
- e. Uretrocistografía

76. Un paciente de 53 años, con antecedente de úlcera gastroduodenal recurrente, desde hace una semana empieza con sensación de plenitud precoz, asociada a vómitos alimentarios frecuentes, mayores postprandiales. Evoluciona con malestar general, mareos y marcado decaimiento. Su examen físico muestra FC:120x', PA: 90/60 mmHg y se aprecia decaído. Se solicitan exámenes que muestran creatinina plasmática: 2,1; uremia: 80 mg/dl, Na+ plasmático: 125 mEq/L, K+ plasmático:4,5 mEq/L, Cl- plasmático:120, bicarbonato plasmático: 40 mEq/L, K+ urinario: 25 mEq/L, Na+ urinario: 8 mEq/L. La medida inicial más adecuada es:

- a. Administrar acetazolamida
- b. Administrar suero glucosado al 5% endovenosa
- c. **Administrar solución salina al 0,9% endovenosa**
- d. Administrar solución salina al 3%
- e. Administrar bicarbonato endovenoso

HEMATO-ONCOLOGÍA

1. Un paciente de 17 años, sin antecedentes, presenta desde hace 1 mes dolor en muslo izquierdo asociado a impotencia funcional. Al examen físico se palpa aumento de volumen en cara interna de muslo, de consistencia aumentada, sin otros hallazgos. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:
 - a. Tomografía axial computada sin contraste
 - b. Ecotomografía**
 - c. Tomografía axial computada con contraste
 - d. Radiografía
 - e. Resonancia magnética

2. Una paciente de 29 años, sin antecedentes, consulta por disnea progresiva asociada a fatigabilidad. Al examen físico destaca mucosas pálidas, cardiopulmonar normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 8.3mg/dL, hematocrito 26%, VCM 110, reticulocitos 0.3%, leucocitos 8.500/mm³ y plaquetas 200.000/mm³. El diagnóstico más probable en este caso es:
 - a. Anemia falciforme
 - b. Anemia perniciosa**
 - c. Anemia ferropénica
 - d. Anemia por enfermedades crónicas
 - e. Anemia por déficit de vitamina B6

3. Una paciente de 12 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de hemorragia gingival al lavarse los dientes, asociado a equimosis frente a pequeños traumatismos desde hace 2 semanas. Al examen físico destacan dichas equimosis y petequias generalizadas, sin otros hallazgos. Se solicita hemograma donde destaca hemoglobina de 12mg/dL, leucocitos de 7.000/mm³ y plaquetas de 4000/ mm³. El tratamiento de elección en este caso es:
 - a. Transfusión de plaquetas
 - b. Esplenectomía
 - c. Corticoides
 - d. Inmunoglobulina no específica
 - e. Administrar crioprecipitado

4. Un paciente de 46 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de disnea y palidez desde hace 2 semanas, asociado a coluria e ictericia. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas y se palpa esplenomegalia, sin otros hallazgos. El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:
 - a. Haptoglobina
 - b. LDH
 - c. Coombs
 - d. Hemograma con reticulocitos**
 - e. Bilirrubina total e indirecta

5. Un paciente de 19 años, sin antecedentes, hace un mes sufre golpe contuso en rodilla izquierda mientras jugaba fútbol, tras lo cual ha permanecido con dolor el cual ha aumentado en las últimas semanas, asociado a aumento de volumen duro. Se solicita radiografía de rodilla que muestra lesión de gran tamaño en metáfisis y diáfisis de fémur, asociado a compromiso cortical. El diagnóstico más probable es:

- a. Sarcoma de Ewing
 - b. Osteosarcoma
 - c. Osteoma osteoide
 - d. Sarcoma de partes blandas
 - e. Tumor de células gigantes
6. Una paciente de 55 años, en quimioterapia por leucemia mieloide aguda, inicia desde hace algunas horas fiebre alta, cefalea y dolor al movimiento ocular, refiere haber estado en contacto con su hijo que cursaba con cuadro respiratorio alto. Se realiza exámenes donde destaca hemoglobina 8.5 mg/dL, leucocitos 1.000/mm³ (10% neutrófilos 90% linfocitos) y plaquetas 80.000/mm³. La conducta más adecuada frente a esta paciente es:
- a. Indicar manejo sintomático
 - b. Indicar Ceftazidima con amikacina endovenosas
 - c. Indicar anfotericina B endovenoso
 - d. Indicar oseltamivir endovenoso
 - e. Indicar aislamiento e iniciar ceftriaxona endovenosa
7. Un paciente de 76 años consulta por dolor en el tórax de algunas semanas de evolución que ha ido en aumento y que aumenta al recostarse. El paciente refiere el dolor de intensidad subcrítica y ha presentado astenia y baja de peso. Al examen tiene dolor al palpar la parrilla costal. En sus exámenes destaca calcemia: 10,6 mg/dl, creatinina plasmática: 2,0 mg/dl, proteínas plasmáticas: 10,3 g/dl, albúmina plasmática: 3,4 g/dl, hematocrito: 28%, VHS: 92 mm/h. ¿Qué examen es el más adecuado para determinar el diagnóstico?
- a. Beta-2-microglobulina
 - b. TAC de tórax
 - c. Mielograma
 - d. Recuento de inmunoglobulinas en sangre
 - e. Niveles plasmáticos de PTH
8. Una paciente de 34 años, con antecedente de un by-pass gástrico en “y” de Roux, cursando un embarazo de 12 semanas, presenta un cuadro de astenia y adinamia. Al examen está pálida, sin disnea ni otros síntomas. Su FC: 80x' y su PA: 120/80 mmHg. Se realiza un hemograma que muestra anemia con Hb: 8,2 g/dl, hematocrito: 26%, VCM: 108 fl, HCM: 34 pg, plaquetas: 160.000 por mm³, glóbulos blancos: 5.000 por mm³, con 60% de neutrófilos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- a. Indicar fierro v.o
 - b. Administrar vitamina B12 i.m.
 - c. Indicar fierro e.v.
 - d. Indicar vitaminas del complejo B v.o.
 - e. Transfundir glóbulos rojos
9. Una paciente de 45 años, con antecedente de una gastrectomía, por cáncer gástrico, hace 2 años, consulta por disestesias y dolor en las extremidades inferiores, asociados a cefalea frecuente, astenia, palidez. Al examen físico presenta palidez de piel, con hipoestesia de las extremidades inferiores, piel seca, con queilitis. Se realizan exámenes entre los que destaca hemoglobina: 8,5 g/dl, hematocrito: 26%, VCM: 110fl, plaquetas: 90.000 por mm³, blancos: 3.000 por mm³, hiperssegmentación de los neutrófilos al frotis y LDH: 930 UI/L. ¿Cuál es la indicación más adecuada?
- a. Prueba de Coombs

- b. **Vitamina B12 i.m.**
 - c. Metilprednisolona e.v.
 - d. Fierro v.o.
 - e. Transfusión de glóbulos rojos
10. Una paciente de 37 años presenta una hemorragia puerperal, profusa, por inercia uterina, que respondió a la administración de uterotónicos. Se le realiza un hemograma un hemograma al día siguiente, que muestra una hemoglobina de 8,6 g/dl. La indicación más adecuada es:
- a. **Fierro v.o.**
 - b. Fierro e.v.
 - c. Transfusión de glóbulos rojos
 - d. Observar evolución
 - e. Indicación de eritropoyetina
11. Una mujer de 28 años de edad consulta por un cuadro de algunas semanas de evolución de importante astenia, asociada a somnolencia e intolerancia al ejercicio. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas. No tiene antecedentes de importancia y sus reglas son normales. Se realiza exámenes que muestran una anemia con hemoglobina de 7,8 g/dl, hematocrito: 23%, VCM: 66 fl, ferritina de 6%. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio?
- a. Prueba de Coombs y haptoglobina
 - b. Biopsia de médula ósea
 - c. Ecografía transvaginal
 - d. **Endoscopia digestiva alta**
 - e. Niveles plasmáticos de vitamina B12
12. Una paciente de 20 años consulta por un cuadro de malestar general, astenia, asociado a dolores óseos y fiebre, de pocas semanas de evolución. Al examen físico presenta temperatura 37,8, palidez de piel y mucosas, sin esplenomegalia. Se realiza hemograma, que muestra hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,8 g/dl leucocitos: 3.100 por mm³, plaquetas: 30.000 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Aplasia medular
 - b. Linfoma
 - c. Mieloma
 - d. **Leucemia linfática aguda**
 - e. Mielodisplasia
13. Un paciente de 24 años comienza un cuadro de fiebre, con expectoración productiva, la que se evoluciona mucopurulenta, agregando malestar general importante. Al examen físico está taquipneico, con FC: 97x', temperatura: 38,5 grado Celsius, PA: 120/80 mmHg y en su examen pulmonar presenta respiración sopiante y matidez en la base izquierda y se auscultan crepitaciones en dicha zona. Se solicita un hemograma muestra Hb: 13,5 g/dl, glóbulos blancos: 60.000 por mm³, 77% de segmentados, 10% de baciliformes y 3% de mielocitos, con plaquetas: 380.000. Su radiografía de tórax muestra una imagen de condensación en el lóbulo inferior izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Leucemia mieloide aguda
 - b. Leucemia mieloide crónica
 - c. Mielodisplasia en transformación
 - d. **Reacción leucemoide**
 - e. Mieloma

14. Una paciente de 22 años presenta un cuadro de fiebre nocturna, asociada a baja de peso de 3 meses de evolución y astenia. Además refiere aumento de volumen cervical. Al examen físico se aprecia palidez de piel y mucosas y una masa de 6 cm de diámetro en la cara lateral derecha del cuello. En la radiografía de tórax, se constata ensanchamiento del mediastino. El diagnóstico más probable es:
- Leucemia linfática crónica
 - Infección por VIH
 - Tuberculosis ganglionar
 - Linfoma de Hodgkin**
 - Linfoma no Hodgkin
15. Paciente masculino de 88 años de edad quien consulta por astenia de 3 meses de evolución. Al examen físico se observa palidez de piel y mucosas y leve tinte icterico en escleras. Hemograma: Hemoglobina 6,6 grs/dl; hematocrito: 17% ; VCM :117 fl; plaquetas: 110.000 por mm³; glóbulos blancos: 3.400 x mm³; fórmula diferencial: neutrófilos: 74 %, linfocitos: 20 %, eosinófilos: 5 % y baciliformes: 1 %. El examen para confirmar el diagnóstico es:
- Mielograma
 - Citometría de flujo
 - Prueba de Coombs
 - Niveles de Eritropoyetina.
 - Niveles de vitamina B12 y Ácido fólico.**
16. Una paciente de 15 años, consulta por hipermenorrea y menometrorragia, de Se solicita una ecografía transvaginal, que no muestra lesiones, ni alteraciones uterinas ni ováricas. El endometrio tiene 5 mm de grosor. Su hemograma muestra anemia leve, con glóbulos blancos: 7.000 por mm³ y plaquetas: 250.000 por mm³. La conducta más adecuada es:
- Realizar biopsia de endometrio
 - Solicitar estudio de alteraciones de la hemostasia**
 - Solicitar estudio de trombofilias
 - Solicitar resonancia magnética nuclear abdominopélvica
 - Solicitar endosonografía uterina (histerosonografía)
17. Una paciente de 64 años, con antecedente de by-pass gástrico, por obesidad mórbida, presenta un cuadro de dificultad a la marcha, asociado a astenia y malestar general. En sus exámenes destaca anemia macrocítica, plaquetas: 100.000 por mm³, blancos: 6.000 por mm³, ferritina 56 ug/dl y saturación de transferrina de 18%. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en este caso?
- Fierro
 - Ácido fólico
 - Cianocobalamina**
 - Zinc
 - Tiamina
18. Un paciente de 75 años presenta un cuadro de dolor lumbar de 3 meses de evolución, asociado a pérdida de peso y astenia. En sus exámenes tiene hemograma con hemoglobina: 9,2 g/dl, Plaquetas: 92.000 por mm³, blancos: 5000 por mm³, VHS:103 mm/h, creatinina: 1,7 mg/dl, albúmina: 3,2 g/dl, proteínas plasmáticas: 9,8 g/dl. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica?
- Radiografía de huesos largos

- b. Radiografía de cráneo
 - c. Recuento de inmunoglobulinas
 - d. **Mielograma**
 - e. Calcemia
19. Un niño de edad escolar presenta aparición de petequias y equimosis en el dorso y en las extremidades, con epistaxis y gingivorragia, que comenzaron hace 4 días. Se solicita un hemograma, que demuestra hematocrito de 35%, con hemoglobina de 11,8 g/dl, blancos: 9.000 por mm³, con fórmula diferencial normal y plaquetas: 18.000 por mm³. Además presenta INR: 1,1 y protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:
- a. Púrpura de Schönlein Henoch
 - b. **Púrpura trombocitopénico inmune**
 - c. Leucemia aguda
 - d. Meningococemia
 - e. Hemofilia
20. Un adolescente de 16 años presenta dolor en la rodilla derecha, luego de haberse golpeado. Al examen físico se palpa aumento de volumen de consistencia ósea, por lo que se solicita una radiografía, que muestra una lesión ósea herterogénea, ubicada en el extremo distal del fémur, con disrupción de la cortical y zonas líticas, con otras de aumento de la densidad. El diagnóstico más probable es:
- a. Osteocondroma
 - b. Tumor de células gigantes
 - c. **Osteosarcoma**
 - d. Displasia ósea fibrosa
 - e. Quiste óseo
21. Un paciente de 60 años, gastrectomizado, presenta un cuadro de astenia, adinamia, asociada a disminución de la sensibilidad distal de las extremidades y debilidad. Además ha presentado algún grado de disminución de la capacidad cognitiva. Al examen físico se aprecia disminución de los reflejos osteotendíneos, palidez y disminución de la sensibilidad de las Extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con Hemoglobina de 6,3 g/dl, VCM: 110 fl, plaquetas: 200.000 por mm³, blancos: 3.200 por mm³. La indicación más adecuada es:
- a. Ácido fólico
 - b. **Vitamina B12**
 - c. Fierro
 - d. Biopsia de médula ósea
 - e. Endoscopia digestiva alta
22. Un paciente de 81 años, en espera de una cirugía de cataratas, se realiza un hemograma, como parte de los exámenes preoperatorios, que muestra 140.000 blancos, con predominio de linfocitos, de aspecto redondo, con citoplasma escaso, cromatina heterogénea y sombras de Gumprecht, además tiene hemoglobina de 13,1 g/dl y 180.000 plaquetas por mm³. Al examen físico se palpa una adenopatía cervical de 3 cm, indolora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Leucemia aguda
 - b. Mielodisplasia
 - c. Leucemia mieloide crónica
 - d. Linfoma

- e. **Leucemia linfática crónica**
23. Un joven de 18 años presenta sangrado prolongado, luego de la extracción de un molar. Además refiere equimosis ante pequeños traumatismos y epistaxis frecuente. Hace unos años estuvo hospitalizado por un hematoma profundo del muslo derecho. Su hemograma es normal y su TTPA está levemente alargado, con protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:
- a. **Enfermedad de Von Willebrand**
 - b. Púrpura trombopénico inmune
 - c. Enfermedad de Glanzmann
 - d. Hemofilia
 - e. Factor V de Leiden
24. Un niño de 11 años presenta un cuadro de astenia y fiebre de algunas semanas de evolución. Al examen físico se aprecia palidez, asociado a esplenomegalia. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para continuar el estudio en este paciente?
- a. IgM para virus Epstein Barr
 - b. **Hemograma VHS**
 - c. Biopsia ganglionar
 - d. IgM para Bartonella henselae
 - e. Tiempos de coagulación
25. Un paciente de 54 años, presenta un cuadro de varias semanas de evolución de astenia, adinamia y disnea que aparecen a los grandes esfuerzos. Al examen físico se aprecia palidez de piel y mucosas, se palpa el hígado 6 cm bajo el reborde costal derecho y el bazo se palpa 10 cm bajo el reborde costal izquierdo. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito de 29% con hemoglobina de 9,6g/dL, blancos 4.200/mm³, plaquetas 111.000/mm³ y al frotis se aprecia macrocitosis y abundantes dacriocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Mieloptosis
 - b. Mieloma múltiple
 - c. Leucemia mieloide crónica
 - d. Mielodisplasia
 - e. **Mielofibrosis primaria**
26. Una paciente de 20 años, que desde los siete años presenta epistaxis frecuente y equimosis ante pequeños traumatismos, desde los 14 años tiene su menarquía con sangrado menstrual abundantes. Se solicita hemograma que muestra hematocrito 45%, VCM: 90, leucocitos 6.000/mm³, plaquetas 2.5000/mm³, TTPK normal, protrombinemia 85%, tiempo de sangría mayor a 8 minutos. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el estudio en este caso?
- a. Mielograma
 - b. Citometría de flujo para receptor de la proteína IIb/IIIa
 - c. **Estudio de enfermedad de Von Willebrand**
 - d. Niveles plasmáticos de factor VIII y factor IX de la coagulación
 - e. Electroforesis de proteína en sangre
27. Una paciente de 52 años, con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento permanente con AINES y prednisona por vía oral y tratamiento intermitente con metotrexato por vía oral, presenta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos que ha empeorado en el último tiempo. Se solicitan exámenes en

los que destacan una creatinina de 1,6mg/dL, hemograma con hematocrito 29%, hemoglobina 9,7g/dL, plaquetas 147.000/mm³, blancos 4.200/mm³ y al frotis se aprecia microcitosis. Además se solicita perŷl de ŷerro que muestra ferremia de 40ug/dL (60-160 ug/dL) y transferrina de 190mg/dL (240-360mg/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. **Anemia por enfermedades crónicas**
- b. Mielodisplasia
- c. Anemia por insuficiencia renal crónica
- d. Hipoplasia medular
- e. Mieloma múltiple

28. Una mujer de 40 años consulta por astenia, asociada a adinamia y disnea de medianos esfuerzos progresivas, desde hace una semana. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 mg/dl, VCM elevado; glóbulos blancos: 9.800 por mm³, plaquetas: 160.000 por mm³. El frotis sanguíneo demuestra macrocitosis y policromasia. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

- a. **Prueba de Coombs**
- b. Niveles plasmáticos de B12
- c. LDH y bilirrubina directa
- d. Recuento de reticulocitos
- e. Biopsia de médula ósea

29. Un paciente consulta por fiebre, malestar general y astenia. Al examen físico tiene esplenomegalia de 15 cm bajo el reborde costal. Se solicita un hemograma que muestra plaquetas: 450.000 por mm³, hematocrito: 39%, glóbulos blancos: 60.000 por mm³, con 20% de juveniles, 15% de mielocitos, 20% de baciliformes y 5% de blastos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Leucemia mieloide aguda
- b. **Leucemia mieloide crónica**
- c. Mielofibrosis
- d. Leucemia linfática aguda
- e. Leucemia linfática crónica

30. Una mujer púerpera, presenta hemorragia postparto importante. En sus exámenes destacan hemograma con hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,3 g/dl, glóbulos blancos: 8.000 por mm³, plaquetas: 80.000 y además tiene TTPA y TP alargados y fibrinógeno 90 mg/dl (VN: 200 a 400) ¿Cuál es la mejor indicación transfusional?

- a. Crioprecipitado
- b. Glóbulos rojos
- c. Plaquetas
- d. Sangre fresca
- e. **Plasma fresco congelado**

31. Un preescolar de 2 años, presenta un cuadro de fiebre alta, desde hace 5 días, asociado marcado decaimiento. Al examen físico presenta un exantema eritematoso en el tronco, asociado a eritema de las manos y ojo rojo. La boca muestra amígdalas congestivas y lengua enrojecida. El diagnóstico más probable es:

- a. Síndrome pie mano boca
- b. Eritema infeccioso

- c. Escarlatina
- d. Sarampión
- e. **Enfermedad de Kawasaki**

32. Una paciente de 19 años presenta desde hace 2 semanas de fiebre, malestar general, asociada a astenia y disnea. Al examen físico tiene T°: 37,7°C, FC: 97x', PA: 120/66 mmHg y se aprecia palidez de piel y mucosas y algunas petequias en las extremidades. Se solicita un hemograma, que demuestra hematocrito: 26%, blancos: 8.500 por mm³, con blastos de 35%, con presencia de bastones de Auer y plaquetas: 70.000 por mm³. Su dímero D resulta 897 ng/ml (normal: menor a 500). El diagnóstico más probable es:
- a. Leucemia linfática aguda
 - b. **Leucemia promielocítica**
 - c. Mielodisplasia en transformación
 - d. Púrpura trombocitopénico trombótico
 - e. Púrpura trombocitopénico inmune
33. Una mujer de 24 años, sin antecedentes de importancia, consulta por disnea de esfuerzos, astenia y palidez de piel y mucosas, asociada a aparición de petequias en las extremidades. Se solicita un hemograma, que muestra glóbulos blancos: 700 por mm³, con fórmula diferencial normal, plaquetas: 30.000 y hematocrito 22%. El diagnóstico más probable es:
- a. Leucemia linfática aguda
 - b. Mielodisplasia en transformación
 - c. Mieloma múltiple
 - d. Aplasia medular
 - e. Déficit de vitamina B12
34. Un paciente de 64 años consulta por dolores óseos. Se realiza un hemograma que muestra hematocrito: 24%, con hemoglobina: 8g/dl, VC: 85 fl, plaquetas: 180.000 por mm³ y blancos: 5.800 por mm³, con VHS: 90 mm/h. En los otros exámenes, destaca hipogamaglobulinemia y en el análisis de proteínas séricas se objetiva elevación monoclonal de proteínas, en la zona Kappa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Macroglobulinemia de Waldeström
 - b. Gamapatía monoclonal incierta
 - c. **Mieloma múltiple**
 - d. Amiloidosis
 - e. Enfermedad por cadenas pesadas
35. Una paciente de 67 años, con antecedente de gastrectomía hace 2 años, presenta astenia y adinamia marcada, asociada a disnea de esfuerzo, que ha ido aumentando en los últimos meses. Al examen físico destaca palidez de la piel y las mucosas. Se realiza exámenes, entre los que destaca un hemograma que muestra Hematocrito: 32%, Hb:10,6 g/dl, con VCM: 72 fl y HCM: 28 pg. Los blancos están en 7.800 por mm³ y las plaquetas, en 756.000 por mm³. El diagnóstico, que con mayor probabilidad es causa de su anemia, es:
- a. **Anemia ferropénica**
 - b. Anemia por déficit de B12
 - c. Anemia por enfermedades crónicas

- d. Trombocitosis esencial
- e. Talasemia

36. Un paciente de 35 años presenta un cuadro de 5 días de tos con expectoración mucopurulenta, asociada a malestar general, fiebre y dolor torácico con tope inspiratorio. Al examen físico presenta T°: 38,9°C, FR: 23 rpm, PA: 120/82 mmHg y al examen pulmonar se ausculta respiración soplate y crépitaciones en el lóbulo inferior derecho, con broncofonía. Se realiza una radiografía de tórax, que muestra una condensación en el lóbulo inferior derecho y un hemograma, que presenta hemoglobina: 13 g/dl, plaquetas: 350.000 por mm³, blancos: 60.000 por mm³, 80% de neutrófilos, 10% de baciliformes y 3% de mielocitos. El diagnóstico más probable es:

- a. Leucemia mielode crónica
- b. Leucemia mieloide aguda
- c. Mielodisplasia en transformación
- d. Reacción leucemoide
- e. Mieloma múltiple

PREGUNTAS INFECTOLOGÍA

1. Una paciente de 33 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de dolor lumbar y fiebre desde hace un día, asociado a disuria y orinas de mal olor. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, con temperatura de 38°C y en el resto del examen solo destaca puño percusión positiva a derecha. Se solicita sedimento de orina y urocultivo, con lo que se confirma pielonefritis aguda por lo que inicia tratamiento ambulatorio con ciprofloxacino. Dos días después acude a control persistiendo sintomática. Su resultado del urocultivo muestra presencia de *E. coli* sensible a nitrofurantoina, carbapenémicos, ampicilina/sulbactam y amikacina, y resistente a cefalosporinas, gentamicina y ciprofloxacino. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el de elección para el manejo en este caso?
 - a. Amikacina
 - b. Nitrofurantoina
 - c. Ertapenem
 - d. Ampicilina
 - e. Moxifloxacino
2. Paciente de 34 años, consulta por cuadro de un mes de compromiso del estado general, tos persistente con expectoración mucopurulenta y en dos ocasiones hemoptóica. Al examen físico destaca sudoroso, frecuencia cardíaca de 60 por minuto, presión arterial de 120/70, examen cardíaco normal y pulmonar con murmullo presente, crepitaciones y sibilancias difusas mayores en ápice izquierdo. El examen más adecuado para el diagnóstico en este caso es:
 - a. Baciloscopías seriadas
 - b. Prueba cutánea de tuberculina
 - c. Radiografía de tórax
 - d. TAC de tórax multicorte
 - e. Hemocultivo
3. Un paciente de 21 años, con antecedente de dermatitis atópica y onicomycosis en manos y pies, es diagnosticado por varicela necrohemorrágica la cual es manejada con aciclovir. ¿Cuál de las siguientes patologías de base es más probable que tenga este paciente?
 - a. Inmunodeficiencia por déficit de inmunoglobulina A
 - b. Inmunodeficiencia por alteración en la fagocitosis
 - c. Inmunodeficiencia por déficit de inmunoglobulina G
 - d. Inmunodeficiencia por déficit de complemento
 - e. Inmunodeficiencia combinada adquirida
4. Paciente de 70 años, diabético en tratamiento farmacológico y hospitalizado por neumonía desde hace 5 días, comienza desde ayer con cuadro de deposiciones diarreicas acuosas asociado a desorientación temporoespacial. Al examen físico destaca abdomen doloroso a palpación profunda, con ruidos hidroaéreos aumentados y ausencia de irritación peritoneal. Se solicita coprocultivo que se informa negativo y leucocitos fecales positivos. El tratamiento de elección en este caso es:
 - a. Hidratación por vía oral abundante
 - b. Metronidazol oral
 - c. Ciprofloxacino oral
 - d. Clindamicina ev
 - e. Probióticos orales

5. Un paciente de 35 años, sin antecedentes, con cuadro de una semana de compromiso del estado general y sensación febril, que durante los últimos días se agrega cefalea y diplopía. Al examen físico destaca reflejo fotomotor conservado, parálisis del sexto par derecho y rigidez de nuca esbozada. Se solicita punción lumbar que muestra células aumentadas de predominio mononuclear, glucosa disminuida y proteínas altas, gram no visualiza gérmenes. El agente etiológico más probable en este caso es:
- Mycobacterium tuberculosis**
 - Neumococo
 - Enterovirus
 - Herpes virus
 - Criptococosis
6. Una mujer de 18 años consulta por dolor genital, que aumenta al orinar. Además ha presentado fiebre y malestar general. Es sexualmente activa y al examen se aprecia adenopatías inguinales y se visualizan múltiples úlceras, en relación con los labios menores. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?
- Tinidazol oral
 - Ceftriaxona intramuscular
 - Axitromicina oral
 - Valaciclovir oral**
 - Fluconazol oral
7. Un paciente de 48 años, carpintero, sufre un corte en su mano derecha durante sus actividades laborales, que evoluciona a las 6 horas con eritema y dolor del cuarto y quinto dedos de esa mano. A las 24 horas, evoluciona con compromiso del estado general, fiebre, eritema de toda la mano, que se extiende por el antebrazo, con lesiones negruzcas en los dedos mencionados. Al examen presenta FC: 110x', PA: 90/60 mmHg, temperatura: 39 grados Celsius y las lesiones descritas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Erisipela
 - Fasciitis necrotizante**
 - Miositis
 - Tétanos
 - Gangrena gaseosa
8. Un paciente de 17 años presenta malestar general, asociada a fiebre hasta 38,8 grados y odinofagia, de 7 días de evolución. Al examen físico presenta adenopatías palpables en la zona cervical anterior, con faringe eritematosa y congestiva, con aumento del tamaño amigdalino. Además se palpa el bazo por 2 cm bajo el reborde costal. Se solicitan exámenes que se muestran a continuación: IgM virus Epstein Baar: negativo IgG virus Epstein Baar: positivo IgM Citomegalovirus: positivo IgG Citomegalovirus: negativo IgM Toxoplasma gondii: negativo IgG Toxoplasma gondii: positivo Elisa VIH: negativo ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Mononucleosis infecciosa
 - Infección por Citomegalovirus**
 - Síndrome retroviral aguda
 - Toxoplasmosis
 - Infección por adenovirus
9. Un paciente de 18 años consulta por un cuadro de fiebre, odinofagia y malestar general de 2 semanas de evolución. Al examen físico está febril a 38 grados, se aprecia faringe congestiva con amígdalas

aumentadas de tamaño, con exudado blanco bilateral y se palpa esplenomegalia moderada. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con hematocrito: 42%, plaquetas: 200.000 por mm³, leucocitos: 17.000 por mm³, con 80% de linfocitos, 10% de ellos reactivos. ¿Cuál es el diagnóstico mas probable?

- a. Infección por adenovirus
- b. Linfoma
- c. Faringitis estreptocócica
- d. Mononucleosis infecciosa
- e. Leucemia linfática aguda

10. Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, indicándosele tratamiento, con buena evolución clínica. Se controla con baciloscopías de expectoración mensuales, que resultan (+), (-), (-), (+) y (-). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Mantener el tratamiento
- b. Suspender el tratamiento
- c. Iniciar tratamiento de segunda línea
- d. Solicitar un PPD
- e. Agregar un fármaco de segunda línea al tratamiento actual

11. Una paciente de 24 años presenta un cuadro de 6 horas de evolución de diarrea, vómitos alimentarios y dolor abdominal tipo cólico, asociado a fiebre hasta 38,4 grados Celsius. Refiere que el día anterior hicieron una comida en su empresa y que hay otros compañeros de trabajo con síntomas similares. ¿Cuál es el agente más probable?

- a. Rotavirus
- b. Shigella flexneri
- c. Norovirus
- d. Escherillia coli enteropatógena
- e. Salmonella enteritidis

12. Una paciente de 48 años consulta por dolor en el dorso, muy molesto, que le dificulta el sueño, de 3 días de evolución. Al examen físico se observa una zona eritematosa en la piel de la espalda, con microvesículas, dolorosa al roce. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a. Aciclovir tópico
- b. Corticoides orales
- c. Imipramina oral
- d. Corticoides tópicos
- e. Valaciclovir oral

13. Un paciente operado hace 7 días por una hiperplasia prostática benigna, mediante resección transuretral (RTU). Evoluciona con orinas turbias y disuria dolorosa, por lo que se realiza un sedimento de orina que muestra leucocituria y bacteriuria y un urocultivo positivo para Pseudomona aureginosa, con antibiograma pendiente. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente?

- a. Amoxicilina más ácido clavulánico
- b. Nitrofurantoína
- c. Imipenem
- d. Ceftriaxona
- e. Cotrimoxazol

14. Una paciente de 90 años, con grave deterioro funcional y cognitivo, presenta una escara sacra, que compromete hasta la superficie ósea. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de su lesión?
- Aseo frecuente y curaciones con agua oxigenada
 - Cirugía plástica con reconstrucción en colgajo
 - Debridación química o quirúrgica
 - Curaciones con povidona yodada y aseo frecuente
 - Escarectomía con injerto de piel
15. Una niña de 6 años presenta gran picazón en la cabeza, desde hace 7 días. Al examen físico se observan múltiples liendres en el cabello, sin poder observar ningún piojo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Tratar con permetrina al 5% tópica
 - Tratar con permetrina al 1% tópica
 - Tratar con ivermectina oral
 - Tratar con lindano al 1% tópico
 - No tratar mientras no se visualicen piojos
16. Un joven de 17 años presenta un cuadro de fiebre y baja de peso, con malestar general, de algunas semanas de evolución. Consulta ahora por un cuadro de rápida instalación de cefalea, tos, edema de extremidades superiores y de la cara, seguido de desorientación y sopor. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar el diagnóstico en este paciente?
- Radiografía de tórax
 - Ecocardiograma
 - TAC de tórax con contraste
 - Endoscopia digestiva alta
 - Resonancia magnética nuclear
17. Un paciente alcohólico, de 50 años, en situación de calle, consulta por dolor en el antebrazo derecho, muy intenso. Al examen físico se aprecia una lesión grande en el antebrazo derecho, con áreas violáceas, que crepita a la palpación. Su frecuencia cardíaca es de 108x', con PA: 90/60 mmHg y su hemograma muestra leucocitosis de 17.000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Loxocelismo cutáneo
 - Celulitis
 - Úlcera por presión
 - Fascitis necrosante
 - Miositis necrosante
18. Un hombre de 60 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona sacra baja. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de 4 cm de diámetro, dolorosa a la palpación, fluctuante, con signos inflamatorios. El tratamiento más adecuado es:
- Curación plana
 - Drenaje quirúrgico
 - Antibióticos orales
 - Punción y drenaje
 - Analgésicos

19. ¿Cuál es la conducta más adecuada ante un hombre joven, que presenta múltiples condilomas acuminados perianales?
- Descartar otras enfermedades de transmisión sexual
 - Determinar el genotipo del virus papiloma
 - Realizar rectosigmoidoscopia
 - Realizar tratamiento con podofilino
 - Indicar aciclovir oral
20. Una paciente se realiza exámenes, ya que su pareja fue diagnosticada de hepatitis B. Tiene antígeno de superficie para VHB negativo y anticuerpos anti-VHBsuperficie positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Vacunada contra la hepatitis B
 - Hepatitis B aguda
 - Hepatitis B crónica
 - Hepatitis B en periodo de ventana
 - Infección asintomática por virus hepatitis B
21. Un paciente de 32 años regresa de un viaje a un país vecino. A los pocos días presenta un cuadro de 5 días de fiebre, asociado a malestar general, que es seguido luego de dolor abdominal, ictericia y orinas oscuras. Al examen físico está icterico, con dolor a la palpación del hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Hepatitis A
 - Hepatitis B
 - Hepatitis alcohólica
 - Colédocolitiasis
 - Fiebre tifoidea
22. Una paciente está en tratamiento con ciprofloxacino por una infección urinaria. Al séptimo día inicia diarrea acuosa, abundante, asociada a dolor abdominal. Al examen físico se constata dolor a la palpación abdominal, sin irritación peritoneal, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Los leucocitos fecales resultan positivos. ¿Cuál es el agente etiológico?
- Escherichia coli
 - Clostridium difficile
 - Shigella flexneri
 - Rotavirus
 - Campylobacter jejuni
23. Una paciente de 25 años presenta un cuadro de cefalea holocránea y fiebre alta. Al examen físico presenta rigidez de nuca y signo de Brudzinsky, con petequias en extremidades inferiores, asociadas a algunas equimosis. El agente causal más probable es:
- Neisseria meningitidis
 - Streptococcus pneumoniae
 - Haemophilus influenzae
 - Listeria monocytogenes
 - Virus herpes simplex

24. Un hombre de 29 años, presenta un cuadro de tos seca, de 5 semanas de evolución, a lo que se ha agregado disnea y malestar general. Al examen físico destaca FC: 100x', PA: 110/70 mmHg, temperatura: 37,5 grados Celsius y FR: 30x'. El examen cardiopulmonar, así como la radiografía de tórax son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Infección por adenovirus
 - Infección por virus influenza
 - Infección por Bordetella pertussis
 - Infección por *Pneumocystis jiroveci*
 - Infección por *Mycobacterium tuberculosis*
25. Un paciente adulto mayor, diabético, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, como se ve en la siguiente imagen:
FOTO: se ve una placa eritematosa, que sigue un dermatomo, con vesículas en su superficie. El tratamiento más adecuado es:
- Aciclovir 400 mg cada 8 horas, por 5 días
 - Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 5 días
 - Aciclovir tópico
 - Loratadina 10 mg al día por 5 días
 - Flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 10 días
26. Una mujer de 28 años, puérpera de 2 meses, con 3 semanas de diarreas con presencia de sangre y dolor abdominal difuso leve. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con abdomen blando, sensible a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal, con meteorismo. El diagnóstico más probable es:
- Diarrea debida a *Clostridium difficile*
 - Colitis ulcerativa
 - Enfermedad de Crohn
 - Colitis inespecífica
 - Shigellosis
27. Un hombre de 40 años presenta un cuadro de dolor abdominal, de 3 meses de evolución, leve, intermitente. Al examen físico presenta leve dolor a la palpación del hipocóndrio derecho, por lo que se solicita una ecografía de abdomen, que visualiza una lesión hepática quística, con paredes visibles y gruesas, de 8 cm. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito y plaquetas normales, con 8.000 blancos, 50% de neutrófilos, 40% de linfocitos, 3% de eosinófilos y 7% de monocitos. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?
- IgG para *Toxoplasma gondii*
 - Serología para hidatidosis
 - Serología para *Trichinella spiralis*
 - IgG para *Fasciola hepática* (Distoma)
 - Examen parasitológico seriado de deposiciones
28. Paciente con diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, en su cuarto ciclo de quimioterapia, se encuentra hospitalizado por fiebre sin foco, asociado a neutropenia (neutropenia febril), por lo que está en tratamiento con ceftazidima, amikacina y vancomicina, sin mayor respuesta. En sus exámenes de laboratorio presenta neutrófilos 100 por mm³ y en la radiografía de tórax se observa una imagen apical

derecha radiopaca, de 3 cm de diámetro, espiculada y con bordes difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Tuberculosis
- b. Neumonía intrahospitalaria
- c. **Aspergilosis invasiva**
- d. Nocardosis
- e. Neumonía por *Pneumocystis jiroveci*

29. Adolescente de 15 años con cuadro de 5 días de evolución con fiebre, astenia, náuseas, ictericia, a lo que últimamente se ha agregado prurito. Ha tomado Paracetamol (500 mg), un total de 6 tabletas. Al examen físico, hipocondrio derecho levemente sensible a la palpación. Tiene antecedente de haber estado en un campamento hace 1 mes. En sus exámenes tiene fosfatasa alcalina y GGT: 8 veces por encima del valor normal; y transaminasas: 20 veces por encima del valor normal; bilirrubinemia aumentada. ¿Cuál es el diagnóstico probable?

- a. Colecolitiasis
- b. **Hepatitis A**
- c. Hepatitis C
- d. Hepatitis por fármacos
- e. Hepatitis autoinmune

30. Un paciente de 45 años, diagnosticado de VIH, presenta sangrado rectal ocasional. Al examen físico, se observa lesión solevantada en los márgenes anales, de 4 cm, que se introduce en el recto, sobrepasando la línea pectínea, con una ulceración central, con escaso sangrado. El diagnóstico más probable es:

- a. Hemorroide externa trombosado
- b. Condiloma acuminado
- c. Sífilis
- d. **Cáncer epidermoide**
- e. Enfermedad de Crohn

31. Un paciente de 24 años mantiene relaciones sexuales, por vía vaginal, sin protección, evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a. *Trichomona vaginalis*
- b. *Treponema pallidum*
- c. ***Ureaplasma urealyticum***
- d. *Mycoplasma genitalis*
- e. *Chlamydia trachomatis*

32. Paciente masculino de 45 años, presenta súbitamente hemiparesia derecha, refiere historia de 2 meses de evolución de astenia, compromiso del estado general y fiebre de predominio nocturno. Al examen físico presenta hemiparesia derecha, fiebre de 37,8 grados celsius y la auscultación cardíaca muestra un ritmo regular en 2 tiempos, con un soplo sistólico IV/VI en el ápex. Su sedimento de orina muestra hematuria microscópica. El diagnóstico más probable es:

- a. Absceso cerebral
- b. Tuberculosis meníngea
- c. Meningitis bacteriana

- d. **Endocarditis bacteriana**
 - e. Leucemia mieloide aguda
33. Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, por lo que se inicia tratamiento con antibióticos asociados. Sus baciloscopías mensuales de control resultan: mes 1 (+), mes 2 (-), mes 3 (-), mes 4 (-), mes 5 (+) y mes 6 (+). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Recaída
 - b. Eliminación esporádica
 - c. **Fracaso**
 - d. Contaminación
 - e. Nocardiosis pulmonar
34. Una paciente de sexo femenino de 17 años de edad, con antecedente de relaciones sexuales sin protección, consulta prurito vulvar, asociado a ardor progresivo. Refiere sensación de aumento del volumen de la vulva, que luego fue seguido por los síntomas actuales. Al examen físico se observa lo expuesto en la siguiente imagen.FOTO: Se ve la vulva con múltiples ulceraciones.Se trata de una infección por:
- a. Treponema pallidum
 - b. **Virus herpes simplex**
 - c. Chlamydia trachomatis
 - d. Virus papiloma humano
 - e. Ureaplasma urealyticum
35. Un paciente de 42 años, fumador de 2,6 paquetes-año, presenta un cuadro de 3 meses de compromiso del estado general, astenia y baja de peso de 3 kilogramos, asociado a tos y expectoración mucopurulenta, que en ocasiones es hemoptoica. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra zonas de relleno alveolar en el lóbulo superior derecho. ¿Con qué examen se debe proseguir el estudio?
- a. **Baciloscopías de expectoración y cultivo para mycobacterias**
 - b. Elisa VIH
 - c. Biopsia pulmonar por videtoracoscopia
 - d. Lavado bronquioalveolar por broncoscopia
 - e. TAC de tórax
36. Paciente de 17 años presenta un cuadro de fiebre, malestar general y odinofagia, de 7 días de evolución. Al examen, presenta lesiones blanquecinas en las amígdalas y congestión de la orofaringe, adenopatías cervicales y se palpa el bazo moderadamente aumentado de tamaño. ¿Cuál es el agente causal más probable?
- a. Adenovirus
 - b. Virus influenza
 - c. **Virus de Epstein – Barr**
 - d. Citomegalovirus
 - e. Estreptococo A
37. Una paciente de 30 años, asintomática, está cursando un embarazo de 20 semanas. Su marido fue recientemente diagnosticado de tuberculosis pulmonar, mediante baciloscopías de expectoración que

resultaron (+++). La mujer se realiza baciloscopías, que son negativas y un PPD que resulta 26 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada para con ella?

- a. Mantener una conducta expectante como protección fetal
- b. Iniciar tratamiento con 4 fármacos (isoniazida, rifampicina, rifampicina, pirazinamida y etambutol).
- c. Repetir las baciloscopías periódicamente
- d. Administrar la vacuna BCG
- e. **Indicar profilaxis con isoniazida por 6 meses**

38. Un paciente 2 meses de malestar general, tos con expectoración, sensación febril, baja de peso y sudoración. Además, en el último tiempo ha aumentado la tos y ha presnetado expectoración hemoptoica. Solicita un hemograma que muestra leucocitosis de 15.000 glóbulos blancos por mm³ y se solicita una radiografía que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía de tórax AP, con afectación de ambos lóbulos superiores, mayor al lado izquierdo, con una banda atelectásica en el ápice izquierdo). ¿Cuál es el examen más adecuado ante la sospecha diagnóstica?

- a. Broncoscopía
- b. **Baciloscopías de expectoración más cultivo de Koch**
- c. TAC de tórax
- d. Cultivo de expectoración
- e. Hemocultivo

39. Un paciente asintomático se realiza pruebas hepáticas como parte de un chequeo médico, que muestran una SGOT: 432 UI/L y SGPT: 310 UI/L. No refiere hábitos tóxicos. Como antecedente, tuvo un hemoperitoneo el año 1992, que requirió de transfusiones. ¿Qué examen se debe solicitar ante la sospecha diagnóstica?

- a. Antígeno de superficie de VHB
- b. IgM para VHA
- c. Test de HOMA
- d. Anticuerpos antinucleares y anticitoplasma de neutrófilo
- e. **Anticuerpos totales contra VHC**

40. Un paciente de 36 años presenta desde hace un mes tos irritativa, que se ha vuelto productiva, con expectoración mucosa y últimamente mucopurulenta, asociada a fiebre y malestar general. Al examen está enflaquecido, satura 93% a FiO₂ ambiental, tiene FC: 80x', PA: 110/60 mmHg y FR: 21 rpm. A su examen pulmonar, se auscultan crépitos difusos en ambos campos pulmonares, más algunas sibilancias. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía de tórax AP, con patrón alveolointersticial bilateral difuso). ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a. Streptococcus pneumoniae
- b. Mycobacterium tuberculosis
- c. Staphylococcus aureus
- d. Mycoplasma pneumoniae
- e. **Pneumocystis jiroveci**

41. Un paciente consulta por 5 días de cefalea holocránea intensa, asociada a fiebre hasta 38 grados. En su examen físico se aprecia rigidez de nuca y signo de Brudzinsky esbozados, por lo que se realiza punción lumbar, que da salida a un líquido con 60 células por mm³, 86% mononucleares, glucorraquia: 0,67 y proteínas de 66 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Meningitis bacterial
 - b. Encefalitis herpética
 - c. **Meningitis viral**
 - d. Tuberculosis meníngea
 - e. Infección por *Listeria monocytogenes*
42. Un paciente es diagnosticado de infección por VIH, hace 3 meses. Está en etapa A3 e inició tratamiento con triterapia antirretroviral al momento del diagnóstico. Consulta ahora por aparición de placas pruriginosas en el tronco, más algunas lesiones similares en las palmas y plantas. Además tiene una lesión parecida en la cara interna de la mejilla derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Pitiriasis rosada
 - b. Pitiriasis versicolor
 - c. Síndrome pie mano boca
 - d. **Sífilis secundaria**
 - e. Reacción adversa a la triterapia antirretroviral
43. Un paciente de 57 años consulta por un cuadro de 7 días de astenia, malestar general, fiebre hasta 39 grados celsius. Al examen físico tiene un soplo pansistólico III/VI en el precordio izquierdo, además de apreciarse petequias en los pulpejos y alguna petequias subconjuntivales. ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico etiológico?
- a. Ecocardiograma
 - b. **Hemocultivos**
 - c. Hemograma
 - d. Coronariografía
 - e. ANA y complemento
44. Una paciente de 50 años, diabética, con antecedente de insuficiencia renal e hígado graso, consulta por lesiones pruriginosas y eritematosas debajo de las mamas, en la región inguinal y debajo del abdomen. El tratamiento más adecuado es:
- a. Mupirocina tópica
 - b. Cefadroxilo oral
 - c. Griseofulvina oral
 - d. Fluconazol oral
 - e. **Ketoconazol tópico**
45. Un adolescente consulta por aparición de lesiones en zona nasogeniana, eritematosas, pruriginosas, desde hace una semana. Al examen físico se aprecian costras mielécricas en la zona descrita. ¿Cuál es el tratamiento de elección?
- a. **Amoxicilina más ácido clavulánico**
 - b. Macrólidos
 - c. Betametasona
 - d. Cefoperazona
 - e. Ciprofloxacino

46. Una paciente consulta por aparición de una lesión en el antebrazo, que inicialmente era dolorosa y eritematosa, pero que luego de 6 horas se volvió más oscura y más grande. Al examen físico, se aprecia lo siguiente: FOTO (típica placa livedoide en el antebrazo).
- Loxocelismo cutáneo
 - Necrosis grasa
 - Ectima
 - Pioderma gangrenoso
 - Fasceítis necrotizante
47. Un paciente de 28 años tiene un quiste epidérmico en el cuello y consulta porque ahora aumentó de volumen y se ha vuelto doloroso y eritematoso. Al examen físico se lo aprecia según la imagen: FOTO (absceso en el cuello, con algo de eritema alrededor y se ve de aspecto amarillo). La conducta más adecuada es:
- Observar evolución
 - Indicar corticoides tópicos
 - Indicar antibióticos más drenaje quirúrgico
 - Realizar resección quirúrgica del quiste
 - Puncionar la lesión
48. Una paciente de 25 años, sexualmente activa, que no utiliza métodos de barrera, consulta por fiebre, asociada a dolor abdominal, disuria, polaquiuria y leucorrea. Al examen físico presenta temperatura 38 grados, dolor a la palpación abdominal, mayor en la fosa ilíaca derecha. Además, en el examen ginecológico se observa leucorrea y tiene dolor a la palpación bimanual. El agente etiológico más probable es:
- Escherichia coli
 - Gardnerella vaginalis
 - Trichomona vaginalis
 - Streptococo grupo A
 - Gonococo
49. Un paciente de 47 años, obeso, consulta por dolor y aumento de volumen en la zona interglútea. Al examen físico se aprecia aumento de volumen en la zona sacra, de consistencia blanda, eritematoso y doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:
- Realizar drenaje quirúrgico con anestesia local
 - Antibióticos orales
 - Solicitar una ecografía de partes blandas
 - Solicitar resonancia nuclear magnética de pelvis
 - Solicitar TAC de abdomen y pelvis
50. Un paciente de 32 años, lleva un año conviviendo con pacientes bacilíferos, se encuentra asintomático y su radiografía de tórax no muestra alteraciones, se solicita un PPD que resulta en 23 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Realizar tratamiento antibiótico con isoniazida, pirazinamida, rifampicina y etambutol por 6 meses
 - Repetir PPD en un mes
 - Dar de alta y control en caso de síntomas
 - Solicitar reacción en cadena de polimerasa para Mycobacterium tuberculosis en lavado bronquioloalveolar

- e. Indicar isoniazida por 6 meses
51. Una paciente de 24 años, que hace 1 semana inicia cuadro de Ñebre, dolores osteoarticulares, ictericia. Como antecedente, hace tres semanas regresó de un viaje al caribe. Se solicitan exámenes que muestran GOT: 1.210 UI/L, GPT: 1.120 UI/L, bilirrubina de 12 mg/dL. El examen inicial para el diagnóstico etiológico es:
- IgG anti VHA
 - Anticuerpos anti VHC
 - Ag VHBs
 - IgM VHA
 - Anticuerpos antinucleares
52. Un paciente de 40 años consulta por hiperqueratosis y cambio de coloración de las uñas de los ortejos, de algunos meses de evolución. Se realiza estudio micológico, que muestra presencia de *Trichophyton rubrum*. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?
- Itraconazol
 - Griseofulvina
 - Fluconazol
 - Terbinafina
 - Clotrimazol
53. Un paciente de 65 años, consulta por Ñebre y cefalea de 3 días de evolución, a lo que luego se agrega desorientación. Al examen físico se aprecia confuso, con temperatura 38,5 grados Celsius, FC: 95x' y PA: 110/70 mmHg. En su examen neurológico se aprecia rigidez de nuca, por lo que realiza punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo con 610 células por mm³, con 90% de polimorfonucleares, glucosa: 26 mg/dl y proteínas 123 mg/dl. Además, la tinción de Gram muestra visualización de diplococos gramnegativos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?
- Ceftriaxona endovenosa
 - Cloxacilina endovenosa
 - Vancomicina endovenosa
 - Imipenem endovenoso
 - Ciprofloxacino oral
54. Una paciente de 30 años presenta una caída, con erosión de la rodilla derecha. Usted la evalúa 3 días después, observándose una zona eritematosa que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes parcialmente deñidos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?
- Curación con suero fisiológico y cobertura con apósito
 - Curaciones con povidona yodada
 - Mupirocina tópica
 - Amoxicilina oral por 7 días
 - Cefadroxilo oral por 7 días
55. Un hombre de 77 años, alérgico a la penicilina, consulta por dolor de la rodilla izquierda, asociado a aumento de volumen y Ñebre. Al examen físico tiene temperatura de 38,5 grados y presenta aumento de volumen y eritema de la rodilla izquierda, asociado a signos de derrame articular. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este paciente?
- Cefazolina endovenosa

- b. Cloxacilina endovenosa
 - c. Azitromicina oral
 - d. Clindamicina endovenosa
 - e. Gentamicina endovenosa
56. Un paciente se realiza una cirugía transuretral hace 7 días. Evoluciona con disuria dolorosa, asociada a malestar general y fiebre hasta 38,7 grados Celsius. Se realiza un sedimento de orina con leucocituria de 50 por campo y abundantes bacterias, y un urocultivo, que resulta positivo para *Pseudomona aureginosa* y el antibiograma está pendiente. El tratamiento de elección es:
- a. Amoxicilina-clavulánico
 - b. Nitrofurantoína
 - c. Cotrimoxazol
 - d. Imipenemen
 - e. Ceftriaxona
57. Un paciente de 23 años consulta por un cuadro de malestar general y fiebre hasta 39,2°C, que empieza a inicios de invierno. Presenta además cefalea intensa, tos seca y rinorrea. Refiere tener mialgias generalizadas y al examen físico está febril, con FC: 101x'. PA: 130/80 mmHg. Su faringe se aprecia eritematosa y congestiva, sin exudado. Su examen pulmonar está normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Amigdalitis estreptocócica
 - b. Neumonía bacteriana
 - c. Sinusitis bacteriana
 - d. Influenza
 - e. Mononucleosis infecciosa
58. Un niño de 8 años, inmigrante, que no ha recibido la vacuna BCG. Está asintomático y su examen físico es normal. Su padre está siendo tratado para la tuberculosis en su país de origen. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?
- a. Solicitar PPD
 - b. Solicitar radiografía de tórax
 - c. Solicitar baciloscopías
 - d. Iniciar profilaxis con isoniazida
 - e. Administrar la vacuna BCG
59. Una paciente de 7 años presenta un cuadro de una semana de evolución de malestar general, fiebre de 38,3°C, asociada a dolor abdominal y vómitos alimentarios en varias oportunidades. Hace 3 días se agrega ictericia y acolia. Tiene todas sus vacunas del Plan Nacional de Inmunizaciones al día. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Hepatitis A
 - b. Hepatitis B
 - c. Fiebre tifoidea
 - d. Mononucleosis infecciosa
 - e. Síndrome hemolítico urémico

60. Una paciente de 43 años está en tratamiento antibiótico, hace 2 semanas por una neumonía nosocomial. Evoluciona con diarrea acuosa, asociada a dolor abdominal intenso, tipo cólico y fiebre hasta 38,3°C. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio de esta paciente?
- Leucocitos fecales
 - Colonoscopia
 - Parasitológico de deposiciones
 - Toxinas A y B de Clostridium difficile en deposiciones**
 - Coprocultivo
61. Un paciente de 34 años tuvo relaciones sexuales sin protección hace 14 días. Consulta por aparición de una úlcera indolora en el pene. Al examen físico se aprecia una úlcera en la zona derecha del surco balanoprepucial, que se extiende al glande, de borde solevantado. Además, tiene una adenopatía inguinal sensible, al lado derecho. El agente etiológico más probable es:
- Virus herpes simplex
 - Haemophilus ducreyi
 - Klebsiella oxytoca
 - Virus papiloma humano
 - Treponema pallidum**
62. Una mujer de 35 años, diagnosticada recientemente de VIH, consulta por odinofagia y disfagia, que iniciaron hace una semana. Al examen físico tiene faringe eritematosa, con placas blanquecinas en la faringe y en la mucosa yugal, que se desprenden fácilmente al removerlas con un hisopo. Se palpan múltiples adenopatías cervicales, sensibles. ¿Cuál es el tratamiento de elección?
- Colutorios de nistatina
 - Anfotericina ev
 - Aciclovir vo
 - Fluconazol vo**
 - Cotrimoxazol vo
63. Un paciente de 31 años, que vive en una zona rural, consulta por un cuadro de malestar general, asociado a fiebre hasta 39°C y mialgias intensas, invalidantes. Al examen físico presenta dolor importante a la palpación de las masas musculares. Su hemograma muestra hematocrito: 44%, plaquetas: 400.000 por mm³, leucocitosis de 16.000 blancos por mm³, con 35% de eosinófilos. ¿Cuál es el agente más probable?
- Ascaris lumbricoides
 - Trichinella spiralis**
 - Giardia lamblia
 - Fasciola hepática
 - Entamoeba histolytica

REUMATOLOGÍA

1. Un paciente de 70 años, con cuadro de 2 horas de dolor y ardor en pie derecho. Al examen físico destaca eritema en primera articulación metacarpofalángica de pie derecho, sin otras alteraciones. Refiere que ha presentado este mismo cuadro en dos ocasiones en los últimos 6 meses. El tratamiento de elección en este paciente es:
 - a. Probenecid
 - b. Alopurinol
 - c. Corticoides
 - d. Paracetamol
 - e. Colchicina

2. Una paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento, con cuadro de tres meses de dolor en ambas manos y muñecas, asociados a rigidez matinal de 2 horas de evolución. Al examen físico se aprecia compromiso en ambas manos de articulaciones metacarpofalángica e interfalángicas proximales. Se solicita radiografía de manos que muestra erosión de la base de la quinta articulación metacarpofalángica. Además se solicita factor reumatoideo que resulta negativo y péptido citrulinado que también resulta negativo. El diagnóstico más probable es:
 - a. Artritis reumatoídea
 - b. Artritis psoriática
 - c. Osteoartritis
 - d. Espondilitis anquilosante
 - e. Lupus con compromiso articular

3. Un paciente de 20 años, con antecedente de gastroenteritis aguda hace dos semanas, consulta por dolor en tobillo derecho desde hace 1 día. Refiere haber presentado molestias similares hace una semana en rodilla y pie izquierdo. Al examen físico destaca tobillo derecho con eritema leve, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:
 - a. Artritis por cristales
 - b. Artritis por stafilococo aureus
 - c. Artritis por neisseria gonorrhoeae
 - d. Artritis reactiva
 - e. Artritis reumatoídea juvenil

4. Una mujer de 50 años, sin antecedentes, presenta cuadro de dos meses de dolor en ambas manos asociados a rigidez matinal de 40 minutos de duración que disminuye con los movimientos. Al examen físico destaca eritema en articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos, sin otros síntomas. Se solicita factor reumatoideo que resulta positivo y péptido citrulinado que resulta negativo. El tratamiento de elección para esta enfermedad es:
 - a. Metotrexato
 - b. Inmunoglobulina G no específica
 - c. Antiinflamatorios no esteroideos
 - d. Corticoides
 - e. Hidroxicloroquina

5. Un paciente de 50 años, consulta por molestias oculares, con sensación de arenilla ocular, asociado a sequedad de la boca y artralgias de manos. En ocasiones presenta dolor y aumento de volumen, en relación a las parótidas. El diagnóstico más probable es:
- Infección por VIH
 - Sialolitiasis
 - Lupus eritematoso sistémico
 - Cáncer de glándula salival
 - Síndrome de Sjögren**
6. Una paciente de 48 años consulta por artralgias y artritis de las articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos y de ambas muñecas, asociadas a derrame articular y aumento de volumen. Además, presenta artralgias de las articulaciones interfalángicas proximales. Su examen físico muestra artritis de muñecas y metacarpofalángicas. Su factor reumatoide es de 280 UI/L y su radiografía de manos muestra erosiones articulares en relación a la segunda articulación metacarpofalángica derecha. ¿Cuál es el tratamiento de elección para esta paciente?
- Azulfidine
 - Prednisona
 - Hidroxicloroquina
 - AINES
 - Metotrexato**
7. Un paciente de 67 años presenta desde hace 2 semanas dolor en la rodilla derecha, que le dificulta la marcha. Al examen físico presenta crepitación articular en dicha rodilla y aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas. Su factor reumatoide está positivo en titulación 1/80. El diagnóstico más probable es:
- Artrosis**
 - Gota
 - Pseudogota
 - Artritis reumatoide
 - Osteoporosis
8. Un paciente de 80 años es diagnosticado de artrosis, de caderas, que le produce dolor, limitando la marcha. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para iniciar el tratamiento de este paciente?
- Celecoxib
 - Condroitin sulfato
 - Paracetamol**
 - Tramadol
 - Ibuprofeno
9. Una paciente de 50 años presenta dolores musculoesqueléticos generalizados, asociados a astenia y cansancio. Despierta con mialgias y con hinchazón de las manos, que no puede describir bien. Tiene antecedente de una tía con lupus eritematoso sistémico. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la mayoría de las masas musculares, sin debilidad propiamente tal, ni atrofia muscular. Presenta positividad de los anticuerpos antinucleares a títulos 1/40. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Iniciar prednisona
 - Iniciar pregabalina y ejercicios aeróbicos**
 - Solicitar biopsia muscular

- d. Iniciar AINEs
 - e. Solicitar anticuerpos anti-antígenos nucleares extractables (perfil ENA) y anticuerpos anti-DNA
10. Una paciente consulta por dolor en el hombro derecho, que ha ido en aumento en el último tiempo y que le dificulta las labores habituales, como realizar el aseo de la casa. Refiere que en el último tiempo el dolor aumenta en la noche y en ocasiones lo despierta. Al examen físico presenta dolor del hombro tanto ante los movimientos activos, como pasivos de la extremidad, con todo el rango articular conservado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Osteosarcoma de la cabeza femoral
 - b. Capsulitis adhesiva
 - c. Artrosis de la articulación glenohumeral
 - d. Artrosis de la articulación acromioclavicular
 - e. **Tendinitis del manguito rotador**
11. Un paciente de 33 años, consulta por dolor en la rodilla izquierda de 24 horas de evolución, que ha aumentado rápidamente de volumen y que le impide caminar. Se agrega fiebre y marcado malestar general. Al examen físico hay aumento de volumen de la articulación, con eritema y signos de derrame articular. Se realiza punción articular, que da salida a un líquido turbio, con abundantes células polimorfonucleares y presencia de bacterias cocáceas Gram positivas, dispuestas en racimos. ¿Cuál es el antibiótico más adecuado para iniciar el tratamiento?
- a. Ceftriaxona
 - b. **Cloxacilina**
 - c. Gentamicina
 - d. Imipenem
 - e. Vancomicina
12. Un paciente de 42 años, diabético tipo 2, consulta por dolor en la rodilla derecha, que apareció luego de realizar actividad física. Al examen presenta aumento de volumen articular y eritema, por lo que se realiza punción articular, que da salida a un líquido articular con 27.000 glóbulos blancos por mm³, con 95% de polimorfonucleares, sin visualización de bacterias. El diagnóstico más probable es:
- a. Artritis séptica
 - b. **Artritis por cristales**
 - c. Artritis reactiva
 - d. Artritis reumatoide
 - e. Sinovitis postraumática
13. Un paciente de 54 años consulta por dolor en la rodilla derecha, que le dificulta la marcha. Evoluciona rápidamente, impidiéndole caminar y asociándose a derrame articular. Se realiza punción articular que da salida a un líquido con 7.200 glóbulos blancos por mm³, con presencia de múltiples microcristales con birrefringencia de elongación levemente positiva. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?
- a. Colchicina
 - b. Antibióticos
 - c. Drenaje quirúrgico
 - d. **AINEs**
 - e. Corticoides

14. Un paciente presenta dolor en la cara lateral de la cadera derecha, que aumenta con la marcha y al recostarse apoyado en esa cadera. Los movimientos están conservados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Síndrome de la banda ileotibial
 - Bursitis ileopectínea
 - Bursitis trocantérica**
 - Pinzamiento femoroacetabular
 - Artrosis de cadera
15. Una paciente de 45 años presenta dolor en el hombro derecho, que es mayor en la noche y que presenta impotencia funcional, que dificulta sus actividades. Al examen físico presenta dolor a la flexión y a la abducción tanto activa, como pasiva, del hombro derecho. La conducta más adecuada es:
- AINES y reposo
 - AINES y kinesioterapia**
 - Cabestrillo
 - Infiltración con corticoides
 - Cirugía
16. Una paciente de 67 años consulta por un cuadro de dolor e impotencia funcional del codo derecho, asociado a fiebre, que inició hace 2 días. Al examen físico tiene temperatura de 39 grados Celsius, FC: 100x' y PA: 110/70 mmHg, asociado a aumento de volumen del codo derecho, con eritema y aumento de la temperatura local. Además, tanto la movilidad pasiva, como la activa, son muy dolorosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Artritis reactiva
 - Artritis séptica**
 - Artritis gotosa
 - Condrocálcinosis
 - Artritis reumatoide
17. Una paciente de 61 años consulta por dolor articular de ambas manos. Al examen se aprecia aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Se solicita radiografía de manos, que muestra disminución simétrica del espacio interarticular de las articulaciones interfalángicas, con compromiso de la primera articulación carpometacarpiana bilateral, con presencia de quistes subcondrales. Los ANA y FR resultan positivos. El diagnóstico más probable es:
- Artritis psoriática
 - Artritis reumatoide
 - Artritis reactiva
 - Condrocálcinosis
 - Artrosis**
18. Una paciente de 61 años, hipertensa y diabética, en tratamiento regular con hipoglicemiantes orales y antihipertensivos, desde hace 3 días presenta dolor y aumento de volumen en hombro derecho. Al examen físico presenta temperatura 38,2 °C, eritema, rubor y aumento de volumen del hombro derecho y limitación funcional, que impide el movimiento. El diagnóstico más probable es:
- Gota
 - Condrocálcinosis
 - Artritis reumatoidea

- d. Artritis séptica
 - e. Artritis reactiva
19. Una paciente de 54 años ha presentado dolores simétricos en pequeñas y grandes articulaciones, con compromiso de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, que iniciaron hace un año, y que se asocian a rigidez matinal de más de una hora y a sensación de arenilla y sequedad ocular. Se solicitan exámenes que muestran PCR: 10, factor reumatoideo: negativo, anticuerpos antinucleares: negativo y anticuerpos anti-CCP negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Artritis reumatoidea
 - b. Artritis reactiva
 - c. Artrosis
 - d. Artritis psoriática.
 - e. Síndrome de Sjögren primario
20. Paciente femenina con artritis reumatoide, en tratamiento con metotrexate y prednisona desde hace 4 años, es diagnosticada de diabetes mellitus, por lo que se inicia metformina como tratamiento. ¿Que examen es perentorio realizarle, como seguimiento a esta paciente?
- a. Hemograma, con recuento de plaquetas
 - b. Radiografía atlantoaxoidea
 - c. Insulinemia
 - d. LDH
 - e. Densitometría ósea
21. Un paciente de 75 años consulta por cefalea de 2 semanas de evolución, holocránea, intensa, que ha ido en aumento. En el último tiempo refiere además dolor al tocarse el cuero cabelludo y dolor en la rodilla derecha. Al examen físico se constatan signos de derrame articular de la rodilla derecha. Se realiza exámenes, entre los que figura un hemograma, con hemoglobina: 12,0 g/dl, blancos: 9.600 por mm³ y VHS: 76 mm/h. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Artritis seronegativa
 - b. Arteritis de células gigantes
 - c. Artritis reactiva
 - d. Lupus
 - e. Endocarditis aguda
 - f.
22. Una paciente de 67 años presenta un cuadro de malestar general, asociado a febrículas y edema de las extremidades inferiores. Al examen físico, su presión arterial es 180/110 mmHg y se constata el edema blando, con signo de la fovea. En sus exámenes de sangre destaca creatininemia de 4,1 mg/dl, BUN de 60 mg/dl y sedimento de orina con 60 eritrocitos por campo, con 80% de dismorfia y leucocitos de 10 a 15 por campo y cilindros hemáticos. Su hemograma muestra hemoglobina: 11,8 mg/dl, hematocrito: 36%, blancos: 10.000 por mm³, plaquetas: 160.000 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. Glomerulonefritis postestreptocócica
 - b. Nefropatía diabética
 - c. Lesión glomerular mínima
 - d. Vasculitis ANCA positiva
 - e. Púrpura trombocitopénico trombótico
23. Una paciente de 50 años, con antecedente de fenómeno de Raynaud frecuente, desde hace 5 años consulta por edema de los dedos y artritis de algunas articulaciones interfalángicas. Se solicitan

exámenes inmunológicos que resultan ANA: positivos 1/320, en patrón anticentrómero; antiDNA: negativos; Anti Sm: negativos; Anti Ro negativo; Anti La: negativo; Factor reumatoide: negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Artritis psoriática
- b. Esclerosis sistémica
- c. Lupus
- d. Enfermedad mixta del tejido conectivo
- e. Artritis reumatoide

24. Una paciente de 39 años consulta por deseos de embarazo. Tiene antecedente de artritis reumatoide, en tratamiento con paracetamol. Refiere artralgiás de manos con frecuencia. Al examen físico no tiene signos inflamatorios, salvo en una de las articulaciones metacarpofalángicas derechas. Trae factor reumatoideo y anticuerpos antiCCP positivos a títulos elevados y una radiografía de manos, con lesiones erosivas en algunas articulaciones interfalángicas proximales. ¿Cuál es el tratamiento más indicado en esta paciente?

- a. Metotrexato
- b. Leflunomide
- c. Azulfidine
- d. Anticuerpos contra el receptor de TNF alfa
- e. Plaquinol

25. Un paciente de 45 años ha presentado 3 episodios de gota en el último año, por lo que se inició tratamiento colchicina y luego se agregó alopurinol 100 mg/día. Actualmente está asintomático, sin signos de artritis y se controla uricemia de 7 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Suspender el tratamiento
- b. Aumentar la dosis de alopurinol a 300 mg/día
- c. Agregar probenecid al tratamiento
- d. Suspender la colchicina
- e. Agregar prednisona en baja dosis

26. Un paciente de 32 años presenta una trombosis venosa profunda femoropoplítea. Como antecedente, su abuelo falleció a los 80 años, por un accidente vascular encefálico y su padre falleció a los 60 años por un infarto agudo al miocardio. En sus exámenes destacan TTPA: 39 segundos (valor normal: 25 a 35) y VDRL (+). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Déficit de antitrombina III
- b. Déficit de factor VIII
- c. Síndrome antifosfolípidos
- d. Sífilis secundaria
- e. Enfermedad de Von Willebrand

27. Una paciente de 31 años, secretaria, consulta por dolor en el hombro derecho, que ha aumentado en el último tiempo. Ella refiere que es más intenso en la noche y que aparece especialmente al levantar el codo por sobre el hombro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Tendinitis del manguito rotador
- b. Hernia del núcleo pulposo cervical
- c. Artrosis glenohumeral
- d. Tendinitis de la cabeza larga del bíceps

- e. Capsulitis adhesiva de hombro
28. Un paciente de 75 años es hospitalizado hace 2 días por un accidente vascular encefálico. Presenta dolor, eritema y aumento de volumen de la rodilla izquierda, con impotencia funcional. Al examen se aprecia eritema y signos de derrame articular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Artritis séptica
 - Artritis por cristales
 - Artritis reactiva
 - Artritis reumatoide
 - Osteoartritis
29. Una paciente de 28 años, consulta por artralgiyas generalizadas, asociadas a sensación febril y úlceras orales. En sus exámenes destaca creatinina: 1,5 mg/dl, sedimento de orina con hematuria y cilindros hemáticos y hemograma con 4.000 blancos por mm³. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?
- Solicitar factor reumatoide
 - Solicitar radiografía de tórax
 - Solicitar PCR, VHS y creatinfosfoquinasa
 - Solicitar anticuerpos antinucleares
 - Solicitar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos
30. Un niño de 2 años presenta un cuadro de 7 días de fiebre hasta 39 grados, asociado a inyección conjuntival y boca roja con labios partidos, a lo que se agrega un exantema eritematoso generalizado. Al examen, se aprecia decaído, con fiebre de 38,8 grados, presenta adenopatías cervicales y se observa descamación gruesa de los dedos de las 4 extremidades. Se encuentra hospitalizado, recibiendo un tratamiento adecuado. ¿Cuál es la evolución más probable en este paciente?
- Daño permanente de las arterias coronarias
 - Recurrencia esporádica de los síntomas
 - Resolución completa, sin secuelas
 - Daño vascular periférico generalizado
 - Daño a las válvulas cardíacas
31. Una paciente de 64 años consulta por artralgiyas de las manos, caderas y rodillas. Al examen físico presenta aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas, con nódulos de Heberden. Además, tiene limitación de los movimientos de las rodillas, con dolor y crepitación articular, sin signos inflamatorios y limitación a la abducción ambas caderas. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?
- Prednisona
 - Paracetamol
 - Metotrexato
 - Bifosfonatos
 - Ibuprofeno
32. Un escolar de 8 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades inferiores, consistentes en pápulas eritematosas, palpables. Refiere además artralgiyas migratorias en las manos, rodillas y codos, y también hematoquezia en algunas oportunidades desde hace algunos días ¿Cuál es la complicación más probable en el mediano plazo?
- Aneurismas coronarios

- b. Infartos cerebrales
 - c. Hepatitis
 - d. Daño vascular periférico
 - e. **Nefritis**
33. Una paciente de 65 años consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de astenia y debilidad de las cuatro extremidades, asociada mialgias. Al examen físico presenta dolor a la palpación de los músculos trapecios y supraespinosos y de la región trocantérica. En sus exámenes destaca CK: 125 UI/L, y hemograma con VHS: 65 mmHg. El diagnóstico más probable es:
- a. Fibromialgia
 - b. Artritis reumatoide
 - c. Polimiositis
 - d. **Polimialgia reumática**
 - e. Vasculitis
34. Un paciente de 78 años consulta por dolor en ambas ingles, irradiado a los muslos, que inició hace 5 años y que es más intenso al caminar, lo que ha limitado su movilidad en el último tiempo. Se solicita una radiografía AP de pelvis, que se muestra a continuación:
- a. Displasia de caderas
 - b. Metástasis óseas
 - c. Necrosis avascular de la cabeza femoral bilateral
 - d. Sacroileítis
 - e. **Coxoartrosis bilateral**
35. Una paciente de 33 años presenta úlceras orales recurrentes, desde hace varios meses. Además, tiene úlceras genitales. Hace una semana comienza con aparición de eritema nodoso en la cara anterior de ambas piernas y uveítis. El diagnóstico más probable es:
- a. Infección por virus herpes
 - b. SIDA
 - c. Sífilis
 - d. **Enfermedad de Behcet**
 - e. Granulomatosis microangiática
36. Un hombre de 32 años consulta por dolor lumbar y glúteo, de predominio nocturno y matinal, que ha ido en aumento. En el último tiempo se agrega dolor en los pies y en varias articulaciones, en especial en las metacarpofalángicas, en el codo derecho y la rodilla izquierda. Tiene antecedente de aparición de lesiones papulares eritematosas, mayores en las rodillas y cara anterior de las piernas. En su examen físico presenta dactilitis de 3 dedos, edema de la zona distal de ambos pies, aumento de volumen y eritema en varias de las articulaciones descritas y depresiones ungueales en las manos y ortijos. El diagnóstico más probable es:
- a. **Artritis psoriática**
 - b. Artritis reactiva
 - c. Artritis reumatoide
 - d. Esclerosis sistémica
 - e. Vasculitis primaria

37. Una paciente de 30 años presenta artralgias de las articulaciones metacarpofalángicas de 2 meses de evolución, a lo que se ha agregado edemas bimaleolares. Refiere además fenómeno de Raynaud y fotosensibilidad. Se solicitan exámenes, en que destaca hemograma con VHS: 43 mm/h, blancos: 5.100 por mm³, hemoglobina: 10,7 g/dl, hematocrito: 32%, plaquetas: 70.000 por mm³. Su sedimento de orina se aprecia con 30 GR por campo y 2-5 GB por campo. Se solicitan anticuerpos, que muestran ANA +++ en dilución 1:1024, anticuerpos anti-DNA +++ , Anti-ENA + , FR: 26 UI/ml. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a. **Lupus eritematoso sistémico**
 - b. Esclerosis sistémica
 - c. Artritis reumatoides
 - d. CREST
 - e. Enfermedad mixta del tejido conectivo
38. Una paciente de 48 años consulta por 2 meses de artralgias de las articulaciones de las manos, asociada a artralgias de tobillos, codos y pies. Además, tiene rigidez matinal de 2 horas. Al examen físico tiene eritema y aumento de volumen en las muñecas, articulaciones metacarpofalángicas, articulaciones interfalángicas proximales de manos y pies y del codo izquierdo. Su hemograma muestra Hcto: 38%, blancos: 5.900 por mm³, plaquetas: 230.000 por mm³, VHS: 46 mm/h y su PCR: 8 mg/dl (VN: menor a 1). Se solicita factor reumatoide que resulta: 240 UI/ml (VN: menor a 40 UI/ml) y anticuerpos anti-CCP que resultan: 112 UI (VN: menor a 20 UI). ¿Cuál es el fármaco de elección para modificar la progresión de la enfermedad?
- a. Prednisona
 - b. Naproxeno
 - c. Hidroxicloroquina
 - d. Azulfidine
 - e. **Metotrexato**
39. Un paciente de 60 años, diabético, consulta por dolor lumbar intenso, de 5 días de evolución, asociado a malestar general y fiebre hasta 38,9°C. Al examinarlo, presenta marcado dolor al presionar la zona vertebral lumbar, con una contractura de la musculatura paravertebral. El diagnóstico más probable es:
- a. Espondilitis anquilosante
 - b. Aplastamiento vertebral
 - c. Lumbago mecánico
 - d. Lumbociática
 - e. **Discitis lumbar**

Diciembre 2017

2) Una paciente de 65 años, diabética tipo 2 en tratamiento con metformina, consulta por cuadro de dolor en fosa iliaca izquierda, asociado a fiebre y hematoquezia en una oportunidad. Al examen físico destaca Blumberg (+) en fosa iliaca izquierda y disminución de ruidos hidroaéreos. El examen de elección para establecer el diagnóstico en este caso es:

a) Tomografía axial computada de abdomen

b) Colonoscopia

c) Ecotomografía abdominal

d) Radiografía de abdomen

e) Resonancia magnética de abdomen

12) Paciente de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 3 meses de dolor epigástrico tipo urente que aumenta durante los periodos de ayuno y estrés, asociado ocasionalmente a pirosis. Se realiza endoscopia digestiva alta que objetiva úlcera duodenal activa y se realiza test de ureasa que resulta (-). La conducta más adecuada en este caso es:

a) Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina **

b) Indicar omeprazol y controlar con nueva endoscopia en 6 semanas

c) Solicitar nueva endoscopia digestiva alta con test de ureasa

d) Iniciar omeprazol, bismuto y metronidazol

e) Iniciar medidas anti reflujo y omeprazol a permanencia.

16) Paciente de 50 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento irregular con hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico de 30 minutos de duración, transfixiante, irradiado a epigastrio, asociado a mareos y diaforesis. Al examen se aprecia pálido, sudoroso, PA 150/90, FC: 110x', saturación de oxígeno de 93% con FiO2 ambiental, ritmo regular, asociado a soplo diastólico II/VI y disminución del segundo ruido, abdomen blando, depresible e indoloro, ruidos hidroaéreos presentes. Al ingreso se solicita ECG que muestra alteraciones inespecíficas en pared anterolateral, además troponinas que están con resultado pendiente. El diagnóstico más probable es:

a) Disección aórtica

b) Infarto agudo al miocardio sin supradesnivel de ST

c) Tromboembolismo pulmonar

d) Infarto mesentérico

e) Pancreatitis aguda

22) Paciente de 80 años, con antecedente de hipertensión, diabetes insulínica dependiente con mal control metabólico y epigastralgia en tratamiento crónico con omeprazol, consulta por cuadro de disfagia lógica asociado a odinofagia de un mes de evolución. Al examen físico no se encuentran alteraciones. El diagnóstico más probable es:

a) Cáncer esofágico **

b) Reflujo gastroesofágico

c) Acalasia

d) Candidiasis esofágica

e) Divertículo esofágico

23) Una paciente de 50 años, con antecedente de colecistectomía hace varios años, presenta desde hace dos días cuadro de dolor epigástrico, ictericia fluctuante, orinas oscuras y fiebre. Al examen físico destaca frecuencia

cardíaca de 100 por minuto, presión arterial de 80/50 mm de Hg, dolor a la palpación epigástrica, blumberg (+), ruidos hidroaéreos disminuidos. Se solicita ecografía abdominal que muestra vía biliar de 10mm. La conducta más adecuada en esta paciente es:

- a) Realizar colangiografía
- b) Realizar tomografía axial computada de abdomen
- c) Realizar laparotomía abierta
- d) Indicar antibióticos de amplio espectro y reevaluar en 48 horas
- e) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

52) Un paciente de 23 años sufre una puñalada en región supraclavicular izquierda, dos días después consulta por disnea y tope inspiratorio. Al examen físico está en regulares condiciones y decaído, en su examen pulmonar se encuentra disminución del murmullo pulmonar izquierdo. Se solicita radiografía de tórax que es compatible con derrame pleural ipsilateral. Se realiza toracocentesis que da salida a líquido blanco. El diagnóstico más probable es:

- a) Empiema
- b) Derrame paraneumónico
- c) Hemotórax
- d) Quilotórax
- e) Neumotórax

66) Un paciente de 55 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso asociado a vómitos biliosos. Al examen físico destacan escleras ictéricas, sensibilidad a la palpación epigástrica. Se realiza exámenes donde destaca leucocitos 13.000/mm³, PCR 50 mg/dL, GOT 120mg/dL, GPT 140mg/dL, bilirrubina 3mg/dL, fosfatasas alcalinas 400mg/dL, lipasa 100mg/dL. Ecografía abdominal con vía biliar extrahepática dilatada. El diagnóstico más probable es:

- a) Colangitis aguda
- b) Pancreatitis aguda
- c) Colecistitis aguda
- d) Coledocolitiasis **
- e) Hepatitis aguda

70) Paciente de 28 años, con cuadro de 2 meses de dolor epigástrico urente, que aumenta en ayuno y al beber café, asociado a pirosis y reflujo ocasional. Al examen físico no se aprecian alteraciones. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Iniciar omeprazol
- b) Iniciar amoxicilina y claritromicina
- c) Solicitar ecografía
- d) Solicitar test de ureasa
- e) Solicitar endoscopia digestiva alta

73) Paciente de 68 años, sin antecedentes conocidos, consulta por cuadro de dolor abdominal desde hace 6 horas, asociado a distensión progresiva, vómitos y sensación febril, además refiere que no ha eliminado gases. Al examen físico destaca ausencia de ruidos hidroaéreos y blumberg (+). Se solicita radiografía de abdomen que se muestra a continuación:



- a) Gastroenteritis aguda
- b) Vólvulo sigmoides
- c) Obstrucción intestinal**
- d) Diverticulitis aguda
- e) Apendicitis aguda

80) Paciente de 18 años, sin antecedentes mórbidos, es traído al servicio de urgencias por cuadro de dolor en hemitórax izquierdo de inicio súbito irradiado a miembro superior ipsilateral, asociado a disnea leve, el cual inició mientras jugaba un partido de basquetbol. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones y a la auscultación pulmonar destaca disminución del murmullo pulmonar en hemitórax izquierdo, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Angina inestable
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Neumotorax espontáneo**
- d) Perforación esofágica
- e) Contractura muscular

10) Una paciente de 65 años, con antecedente de accidente vascular encefálico con compromiso faciobraquiocrural derecho hace dos años en tratamiento con aspirina, consulta por dolor abdominal difuso e intenso de inicio agudo. Al examen físico se encuentra en regulares condiciones, ritmo irregular, abdomen levemente doloroso a la palpación profunda, blumberg (-). El diagnóstico más probable es:

- a) Isquemia mesentérica**
- b) Disección aórtica
- c) Úlcera perforada
- d) Diverticulitis aguda
- e) Trombosis mesentérica

31) Un paciente de 45 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso asociado a vómitos biliosos. Al examen físico se encuentra frecuencia cardiaca en 90 por minuto, presión arterial 140/90, escleras levemente ictéricas, abdomen blando, doloroso a palpación epigástrica, blumberg (-). Se solicitan exámenes que muestran GOT 100mg/dL, GPT 110mg/dL, bilirrubina total 2 mg/dL, fosfatasas alcalinas

350mg/dL, lipasa 250mg. Ecografía abdominal que muestra vesícula de paredes delgadas, sin edema, con barro biliar visible y colédoco de 8mm. El diagnóstico más probable es:

- a) Colangitis aguda
- b) Pancreatitis aguda**
- c) Coledocolitiasis
- d) Colecistitis aguda
- e) Cólico biliar simple

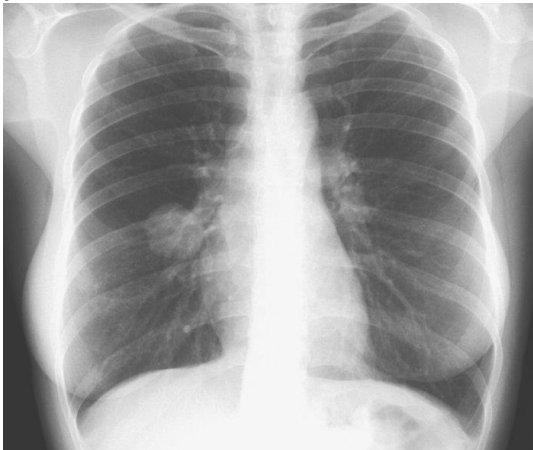
33) Mujer de 29 años, sin antecedentes, con cuadro de tres semanas de dolor abdominal intermitente, de intensidad moderada, asociado a deposiciones con sangre en ocasiones y disentería. Al examen físico se aprecia levemente deshidratada, con dolor a la palpación abdominal profunda, blumberg (-). El diagnóstico más probable es:

- a) Colitis ulcerosa**
- b) Giardiasis
- c) Divertículo de Meckel
- d) Colitis isquémica
- e) Enfermedad de Crohn

43) Paciente de 65 años, con antecedente de tabaquismo crónico de 30 paquetes/año, consulta por cuadro de 3 meses de compromiso del estado general, pirosis y baja de peso de 10 kg. Al examen físico se aprecia decaído, deshidratado y muy enflaquecido, con leve edema en extremidades inferiores simétrico. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer pulmonar
- b) Cáncer gástrico**
- c) Cáncer de esófago
- d) Cáncer de páncreas
- e) Cáncer de duodeno

49) Paciente de 60 años, fumadora de 30 paquetes año, consulta por compromiso del estado general y baja de peso. Su examen físico es normal, se solicita radiografía de tórax que muestra lo siguiente:



La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Solicitar TAC de tórax**
- b) Realizar punción transpleural
- c) Instalar tubo pleural con trampa de agua
- d) Realizar toracocentesis diagnóstica

e) Realizar broncoscopía rígida

53) Un paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, presenta desde hace unas semanas úlcera en zona plantar derecha, asociado a secreción purulenta. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones y afebril, se aprecia úlcera bajo la articulación metatarsofalángica del primerortejo derecho, con compromiso de piel, tejido subcutáneo y tendones, sin signos de compromiso óseo ni articular. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Antibióticos vía oral y curaciones ambulatorias
- b) Angiografía
- c) Amputación abierta
- d) Amputación cerrada
- e) Antibióticos endovenosos y debridación quirúrgica**

64) Paciente de 43 años, con historia de epigastralgia desde hace 3 semanas sin otros síntomas, como parte del estudio de su patología se realiza endoscopia digestiva alta que muestra gastritis erosiva, sin presencia de úlcera péptica activa y con test de ureasa positivo, por este motivo se indica tratamiento erradicador del helicobacter pylori. Tres horas luego del procedimiento, evoluciona con dolor torácico irradiado a hombro derecho y sensación febril. El examen de elección para confirmar el diagnóstico en este caso es:

- a) Radiografía de tórax
- b) Repetir endoscopia
- c) Tomografía axial computada de tórax**
- d) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
- e) Electrocardiograma

79) Una paciente de 43 años, sin antecedentes, consulta por aparición de nódulo mamario, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se palpa nódulo pequeño, no adherido, de consistencia gomosa, sin presencia de adenopatías axilares. Se realiza mamografía inicialmente que es informada como BIRADS 0, por lo que se solicita ecografía mamaria que muestra un nódulo sólido de bordes regulares, con paredes lisas de dos milímetros. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Control con mamografía anual**
- b) Realizar biopsia estereotáxica
- c) Realizar tumorectomía con biopsia rápida
- d) Indicar estrógenos orales y controlar al año con nueva ecografía
- e) Control con ecografía en seis meses ****

Julio 2015

27) Una paciente de 60 años presenta aumento de volumen en la axila derecha, de 4 cm de diámetro, indolora, de consistencia dura y adherida a planos profundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hidrosadenitis
- b) Cáncer de mama**
- c) Cáncer de pulmón
- d) Lipoma
- e) Tuberculosis ganglionar

29) Un paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión y dislipidemia, consulta por dolor en las pantorrillas de dos años de evolución, que aparece al caminar y que le obliga a detenerse, luego de caminar una cuadra. Al examen físico presenta pulso irregular y ausencia de los pulsos pedios de ambas extremidades inferiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Disección aórtica
- b) Aneurisma aórtico abdominal
- c) Insuficiencia venosa
- d) Embolia bilateral de EEII
- e) Enfermedad arterial oclusiva**

30) Un paciente de 28 años sufre un accidente con un vidrio, resultando con una herida cortante en el muslo izquierdo, de 10 cm de largo, que sangra profusamente. ¿Cuál es la mejor forma de manejar la hemorragia?

- a) Aplicación de torniquete
- b) Compresión directa de la herida**
- c) Identificar y ligar el vaso sanguíneo sangrante
- d) Compresión de la arteria femoral
- e) Cubrir la herida con apósitos

31) Un paciente sufre una herida por arma blanca en el abdomen, hace 8 horas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y examen abdominal sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. Se realiza exploración digital de la herida, con anestesia local, objetivándose laceración del peritoneo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar lavado peritoneal diagnóstico
- b) Realizar ecografía fast
- c) Suturar la herida
- d) Solicitar TAC abdominal
- e) Realizar laparoscopia exploradora**

32) Un paciente de 28 años sufre una puñalada en el tórax, en el lado derecho. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor torácico y presenta disminución del murmullo pulmonar, asociado a hipersonoridad a la percusión en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Pedir radiografía de tórax**
- b) Pedir resonancia magnética de tórax
- c) Instalar un tubo pleural
- d) Solicitar TAC de tórax
- e) Realizar videotoracoscopia

33) Un paciente de 73 años presenta un cuadro de 2 días de dolor abdominal, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, con signos de irritación peritoneal en la zona. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Apendicitis aguda
- b) Cáncer de colon

- c) Obstrucción intestinal
- d) Diverticulitis aguda**
- e) Hernia inguinal complicada

34) Un paciente se realiza una colonoscopia, para la resección de unos pólipos intestinales. Algunas horas después presenta dolor abdominal bajo, asociado a hematoquezia escasa y malestar general. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?

- a) Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
- b) Ecografía abdominal y pélvica
- c) Colonoscopia
- d) Radiografía de abdomen y pelvis
- e) TAC de abdomen y pelvis**

35) Un paciente presenta dolor epigástrico muy intenso, irradiado a ambos costados, . Tiene antecedente de una transgresión alimentaria y consumo de alcohol, el día anterior. Al examen físico se aprecia adolorido, con temperatura 38 grados, abdomen difusamente doloroso a la palpación, con disminución de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Úlcera perforada
- b) Isquemia mesentérica
- c) Hepatitis
- d) Colecistitis aguda
- e) Pancreatitis aguda**

36) Un paciente presenta hace una semana dolor en el hipocondrio derecho, intenso, asociado a vómitos, que cede espontáneamente. Actualmente está en buenas condiciones, asintomático, sin alteraciones en el examen físico. ¿Qué examen es el más adecuado para estudiar a este paciente?

- a) Ecografía abdominal**
- b) Radiografía de abdomen
- c) Amilasa / Lipasa
- d) Colangioresonancia
- e) TAC de abdomen

37) Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso, presenta dolor torácico intenso, irradiado al dorso, EVA 9/10. Al examen físico está taquicárdico, con presión arterial es de 160/110, examen cardiaco con RR2T y se ausculta un soplo diastólico en el reborde esternal derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Pericarditis aguda
- c) Infarto agudo al miocárdico con rotura de la pared libre
- d) Infarto agudo al miocárdico con rotura del tabique interventricular
- e) Disección aórtica**

39) Se muestra la siguiente radiografía:



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cáncer pulmonar
- b) Neumoperitoneo**
- c) Signo de Chilaiditi
- d) Absceso pulmonar
- e) Quiste hidatídico

40) Un paciente es sometido a una colecistectomía y a las 24 horas presenta fiebre hasta 38,3 grados celsius. Su examen físico muestra un paciente febril, con crepitaciones en la base pulmonar derecha, asociado a roncus. Tiene vías venosas in situ, sin eritema y su herida quirúrgica está cerrada, sin exudado ni eritema.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Neumonía
- c) Atelectasia**
- d) Infección de la herida operatoria
- e) Infección asociada a catéter

41) Un hombre de 60 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona sacra baja. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de 4 cm de diámetro, dolorosa a la palpación, fluctuante, con signos inflamatorios. El tratamiento más adecuado es:

- a) Curación plana
- b) Drenaje quirúrgico**
- c) Antibióticos orales
- d) Punción y drenaje
- e) Analgésicos

42) Un paciente consulta por dolor anal, que aparece luego de defecar y persiste, asociándose a sangrado rectal, tras la defecación. Al examen físico presenta hipertonia del esfínter anal interno. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Indicar analgésicos y baños de asiento**
- b) Resolver quirúrgicamente
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear de pelvis y periné
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Indicar laxantes

121) Un paciente de 55 años con pirosis, que es mayor postprandial, que inició hace 2 meses y que ha aumentado en el último tiempo. Además, presenta baja de peso de 4 kilogramos en dicho periodo y refiere dolor abdominal, que aumenta al palpa el epigastrio. Además, en el último tiempo se han agregado vómitos postprandiales. ¿Cuál es el examen que debe solicitarse para estudiar a este paciente?

- a) Endoscopia digestiva alta**
- b) pH-metría de 24 horas
- c) TAC de abdomen
- d) Ecografía abdominal
- e) Marcadores tumorales

124) Un paciente es diagnosticado de úlcera gástrica, con test de ureasa positiva, por lo que se inicia tratamiento con amoxicilina 1g cada 12 horas, claritromicina 500mg cada 12 horas y omeprazol 20mg cada 12 horas, por 10 días. Luego queda con omeprazol por 4 semanas más. Se controla posteriormente con antígeno de H. pylori en heces, que resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir el tratamiento, pero por 14 días
- b) Realizar endoscopia digestiva alta y biopsia
- c) Indicar tratamiento erradicador de segunda línea**
- d) Realizar test de ureasa
- e) Observar evolución

Diciembre 2015

22) Un paciente de 33 años consulta por un cuadro de dos días de evolución de dolor torácico, que aumenta con la inspiración profunda. Al examen tiene FC: 80x', PA: 110/70 mmHg, FR: 15x', eupneico. Su examen pulmonar muestra disminución del murmullo pulmonar y de la transmisión vocal en el campo pulmonar derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra en la IMAGEN. La conducta más adecuada es: FOTO: neumotórax derecho de 30%-40%

- a) Realizar sellamiento pleural
- b) Instalar un tubo de drenaje pleural**
- c) Realizar resección videotoracoscópica de bulas
- d) Realizar aspiración con aguja
- e) Administrar analgésico y reevaluar en 24 horas

31) Un paciente de 46 años presenta 48 horas de dolor abdominal epigástrico intenso, asociado a vómitos y fiebre hasta 38,2 grados celsius. Al examen físico se aprecia subictérico, adolorido y presenta dolor a la palpación abdominal, mayor en el epigástrico, con ruidos intestinales conservado. En sus exámenes destacan hematocrito: 31%, plaquetas: 350.000 por mm³, leucocitos: 17.000 por mm³, bilirrubina total: 6 mg/dl, bilirrubina directa: 5,4 mg/dl, GOT: 122 UI/L, GPT: 158 UI/L, GGT: 310 UI/L, fosfatasa alcalinas: 416 UI/L y amilasa de 280 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Colédocolitiasis
- b) Colangitis aguda
- c) Colecistitis aguda
- d) Hepatitis aguda
- e) Pancreatitis aguda**

33) Un paciente de 58 años, colecistectomizado hace algunos presenta un cuadro de molestias abdominales, asociadas a ictericia y coluria en algunas oportunidades. Su examen físico muestra FC: 72x', PA: 120/80 mmHg, temperatura: 36,7 grados Celsius. Su piel y mucosas muestran ictericia y su examen abdominal muestra abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación epigástrica, con ruidos hidroaéreos conservados. Se solicitan exámenes de sangre, que muestran GOT: 40 UI/L, GPT: 33 UI/L, GGT: 215 UI/L, FA: 360 UI/L, lipasa: 40 UI/L y protrombinemia: 100%. La ecografía abdominal muestra un cálculo de 7 mm en el colédoco, no obstructivo, lo que se confirma con la colangioresonancia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Indicar ácido ursodeoxicólico
- b) Realizar coledocostomía abierta y extracción
- c) Solicitar TAC de abdominal
- d) Realizar colangiopancreatografía terapéutica endoscópica**
- e) Indicar dieta y observar evolución

35) Un paciente presenta dolor anal intenso, que inició al defecar, permaneciendo por algunas horas y que fue seguido de escasa rectorragia. Ha presentado nuevos episodios de dolor y rectorragia, y en ocasiones, prurito anal. El diagnóstico más probable es:

- a) Fístula anal
- b) Hemorroide externo trombosado
- c) Fisura anal**
- d) Hemorroides internos
- e) Absceso perianal

41) Una paciente, diagnosticada de artritis reumatoide, en tratamiento con naproxeno consulta por dolor abdominal alto, de tipo urente, que suele aumentar en los periodos de ayuna. Su examen físico muestra un abdomen blando depresible e indoloro, con ruidos hidroaéreos normales, sin signos de irritación peritoneal. Se realiza una endoscopia digestiva alta, que visualiza una úlcera duodenal activa, sin embargo, no se realizó test de ureasa. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Cambiar el AINE por uno distinto
- b) Solicitar una nueva endoscopia digestiva alta
- c) Erradicar Helicobacter pylori**

- d) Indicar tratamiento con inhibidores de la bomba de protones por 8 semanas
- e) Solicitar anticuerpos contra *Helicobacter pylori*

59) Un paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, consulta por malestar general, asociado a dolor en el flanco izquierdo de dos días de evolución, que inició de forma aguda. Además presenta importante compromiso del estado general. Presenta FC: 101x', PA: 110/70 mmHg, temperatura de 36,0 grados Celsius. Su abdomen es blando, depresible, con dolor a la palpación profunda del flanco izquierdo, sin Blumberg. Además presenta puñopercusión positiva a izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Pielonefritis aguda
- b) Diverticulitis aguda
- c) Infarto esplénico
- d) Isquemia mesentérica
- e) Aneurisma aórtico complicado**

60) Un paciente de 60 años inicia un cuadro de 2 meses de evolución de pirosis y regurgitación alimenticia diurna y nocturna. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Indicar tratamiento con omeprazol por 6 semanas
- b) Realizar radiografías de esófago, estómago y duodeno
- c) Indicar tratamiento con domperidona por 6 semanas
- d) Realizar endoscopia digestiva alta**
- e) Realizar medición de pH esofágico por 24 horas (pH-metría esofágica)

66) Una paciente de 24 años se palpa un nódulo mamario, durante su autoexamen, de 2 cm de diámetro, indoloro, móvil y de consistencia gomosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Tumor phylloides
- b) Fibroadenoma**
- c) Mastopatía fibroquística
- d) Cáncer de mama
- e) Quiste mamario simple

67) Una paciente de 40 años acaba de ser diagnosticada de embarazo, en relación a un atraso menstrual de 7 semanas. Al examen físico se palpa un nódulo mamario derecho, ubicado en el cuadrante superior externo, de consistencia dura y adherida a planos profundos. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio en esta paciente?

- a) Mamografías (Esta sale en la pauta, pero no están seguros)**
- b) Ecografía mamaria**
- c) Resonancia magnética nuclear de mama
- d) TAC de mama y tórax
- e) Biopsia por punción del nódulo

70) Un paciente se realiza una cirugía de resección duodenal, con anastomosis primaria, por un cáncer intestinal, hace 6 semanas. Consulta por dolor abdominal epigástrico progresivo, de 24 horas de evolución, al

que en las últimas horas se agregan vómitos de contenido intestinal. Al examen físico presenta abdomen blando, depresible e indoloro, sin signos de irritación peritoneal ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fístula de la anastomosis
- b) Recidiva tumoral estenosante
- c) Absceso intraabdominal
- d) Obstrucción intestinal**
- e) Perforación de úlcera gástrica

71) Una mujer de 74 años consulta por dolor abdominal tipo cólico, muy intenso de dos días de evolución, al que en el último tiempo se le agregan vómitos e imposibilidad de eliminar gases. Al examen físico presenta temperatura de 37,6 grados Celsius, distensión abdominal, con dolor a la palpación abdominal, sin signos de irritación peritoneal. ¿Qué examen es el más adecuado para evaluar a esta paciente?

- a) Ecografía abdominal
- b) Entreoclis por TAC
- c) Radiografía de abdomen
- d) Endoscopia digestiva
- e) TAC de abdomen, sin contraste**

72) Un paciente de 70 años ha bajado 4 kilogramos de peso en el último tiempo. Se solicita una ecografía abdominal que visualiza dos lesiones, una en cada lóbulo hepático, de aspecto sólido, hipoecogénicas y borde irregular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Quistes hepático simples
- b) Metástasis hepáticas**
- c) Adenomas hepáticos
- d) Hepatocarcinomas
- e) Hemangiomas hepáticos

80) Una paciente presenta por un nódulo cervical, ubicado en la línea media, de la zona inferior del cuello. Al examen físico se palpa un nódulo de 1,5 cm de diámetro, de consistencia aumentada, asciende con la deglución. Además presenta una adenopatía cervical anterior. ¿Con qué examen se debe iniciar el estudio de esta paciente?

- a) Cintigrafía tiroidea
- b) Ecografía cervical**
- c) Hormonas tiroideas
- d) Resonancia magnética nuclear de cuello
- e) TAC de cuello

85) Un paciente de 70 años presenta un cuadro de baja de peso de 5 kilogramos en los últimos 3 meses. Además, refiere constipación y deposiciones, que en ocasiones presentan sangre. Sus signos vitales son normales y su examen físico muestra un abdomen blando, depresible, indoloro, con ruidos hidroaéreos normales, sin visceromegalia. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

- a) Ecografía abdominal
- b) TAC de abdomen y pelvis
- c) Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
- d) Colonoscopia**
- e) Endoscopia digestiva alta

86) Un paciente de 38 años presenta un cuadro de dolor abdominal, de 4 meses de evolución, de tipo cólico, asociado a baja de peso de 6 kilogramos. En ocasiones presenta deposiciones con sangre y tiene importante pujo rectal. En sus exámenes destaca anemia, con hemoglobina de 9,5 g/dl y hematocrito de 29%. ¿Qué examen es el más adecuado para iniciar su estudio en este paciente?

- a) Anoscopia
- b) TAC de abdomen y pelvis
- c) Ecografía abdominal
- d) Coproparasitológico
- e) Colonoscopia**

100) Una paciente de 90 años, con grave deterioro funcional y cognitivo, presenta una escara sacra, que compromete hasta la superficie ósea. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de su lesión?

- a) Aseo frecuente y curaciones con agua oxigenada
- b) Cirugía plástica con reconstrucción en colgajo
- c) Debridación química o quirúrgica**
- d) Curaciones con povidona yodada y aseo frecuente
- e) Escarectomía con injerto de piel

126) Un paciente de 75 años presenta hemorragia rectal, en relación a las deposiciones, sin dolor. En el último tiempo solo presenta evacuación de sangre por el ano, sin deposiciones. No ha bajado de peso, ni presenta cambios en el hábito intestinal. Su examen físico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hemorroides internos**
- b) Fisura anal
- c) Cáncer de recto
- d) Enfermedad diverticular
- e) Hemorroides externos

127) Un paciente de 55 años de edad, consulta por una hemorragia digestiva alta, con gran compromiso del estado general, por lo que es imposible obtener mayores antecedentes. Al examen físico, no tiene hálito alcohólico, presenta PA: 60/30 mmHg, FC: 115 lpm, con palidez de piel y mucosas, frialdad de extremidades y debilidad de los pulsos. En sus exámenes de sangre destaca hematocrito 25% y protrombinemia de 36%. El diagnóstico más probable es:

- a) Úlcera gástrica
- b) Várices esofágicas**
- c) Úlcera duodenal

- d) Síndrome de Mallory Vice
- e) Gastropatía erosiva

136) Un adolescente de 17 años consulta por dolor intermitente, de leve intensidad, en la zona anterior del cuello. Al examen físico presenta un nódulo cervical, a la altura de la prominencia laríngea, ubicado en la línea media, algo desviada a la izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Quiste branquial
- b) Adenopatía
- c) Quiste del conducto tirogloso**
- d) Cáncer de tiroides
- e) Higroma quístico

137) Un niño de 6 años presenta un cuadro de dolor cervical, asociado a fiebre y malestar general. Al examen físico presenta un nódulo cervical muy doloroso, eritematoso y fluctuante, en relación a la línea media anterior del cuello, a la altura del hueso hioides. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Adenitis supurada
- b) Quiste del conducto tirogloso infectado**
- c) Quiste branquial infectado
- d) Higroma quístico infectado
- e) Tiroiditis subaguda

163) Un paciente de 60 años, fumador, consulta por ictericia desde hace 10 días, asociada a coluria y prurito de manos. Además refiere baja de peso de 3 kilogramos en el último tiempo. Al examen físico presenta ictericia de piel y mucosas, abdomen blando, depresible, con leve dolor a la palpación del hipocondrio derecho. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GGT: 450 UI/L, GOT: 122 UI/L, GPT: 105 UI/L, bilirrubina total: 17 mg/dl, bilirrubina directa: 15 mg/dl, FA: 712 UI/L. Su ecografía muestra dilatación de la vía biliar intrahepática y colédoco de 12 mm de diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Colédocolitiasis
- b) Cáncer de vesícula biliar
- c) Colelitiasis
- d) Cáncer de cabeza de páncreas**
- e) Colecistitis aguda

175) Un paciente de 46 años consulta por un cuadro de dolor abdominal tipo cólico, que inició hace 24 horas. En las últimas 6 horas se agregan vómitos de contenido alimentario. Al examen físico presenta abdomen blando, depresible e indoloro, sin signos peritoneales, con aumento de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Pancreatitis aguda
- b) Obstrucción intestinal**
- c) Isquemia mesentérico
- d) Úlcera péptica perforada
- e) Cáncer de colon perforado

Julio 2016

6) Un paciente de 35 años, colecistectomizado hace meses, consulta por dolor epigástrico, progresivo, que inició hace 24 horas y que se ha asociado a ictericia y acolia. Al examen físico está afebril, con FC: 80x' y PA: 120/76 mmHg y se aprecia dolor a la palpación del hemiabdomen superior e ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GOT: 42 UI/L, GPT: 63 UI/L, FA: 430 UI/L, GGT: 566 UI/L y bilirrubina de 6,4 mg/dl. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- a) TAC de abdomen
- b) Ecografía abdominal
- c) Endoscopia digestiva alta y biopsia
- d) Colangiioresonancia**
- e) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

7) Una paciente de 30 años, con antecedente de un quiste mamario izquierdo, consulta por dolor en la mama izquierda, asociada a fiebre y eritema. Al examen físico se constata eritema, aumento de volumen y dolor en la mama izquierda, con un nódulo doloroso a la palpación. Se solicita una ecografía que muestra una imagen quística de 5 cm de diámetro, con signos inflamatorios en las partes blandas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar seguimiento ecográfico
- b) Iniciar tratamiento con AINES
- c) Realizar punción y drenaje
- d) Drenar mediante cirugía**
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas

11) Una paciente de 48 años, se somete a una gastrectomía total. Al segundo día postoperatoria presenta fiebre y taquicardia, con FC: 100x' y PA: 140/90. Al examen físico presenta herida operatoria sin alteraciones, con abdomen sensible a la palpación. El examen pulmonar muestra hipoventilación basal. ¿Cuál es la causa más probable de la fiebre?

- a) Infección urinaria
- b) Filtración de la anastomosis
- c) Reacción adversa a medicamentos
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Atelectasia infectada**

21) Paciente femenina de 35 años, quien evidencia masa en cuadrante superoexterno de mama izquierda, no doloroso, de consistencia lisa y no adherido a planos profundos. Tiene una tía fallecida de cáncer de mama a los 71 años y usa anticonceptivos orales. La conducta mas apropiada es:

- a) Realizar ecotomografía de mamas**
- b) Relizar mamografía
- c) Punción con aguja fina

- d) Realizar tumorectomía y biopsia
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas

25) Una paciente de 25 años presenta un nódulo tiroideo de 2 cm de diámetro, a la palpación. Se solicita TSH y T4 libre, que resultan normales. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de esta paciente?

a) Ecografía cervical

- b) Punción aspiración con aguja fina
- c) Anticuerpos antiroideos
- d) Cintigrafía con yodo radiactivo
- e) TAC cervical

49) Paciente masculino de 42 años, cursa desde hace 1 año con disfagia asociada a regurgitación ocasional de alimentos no digeridos, por lo que necesita tomar agua con las comidas, para poder tragar. Además refiere baja de peso en los últimos meses. El diagnóstico más probable es:

a) Cáncer esófago

- b) Cáncer gástrico de cardias
- c) Estenosis esofágica, secundaria a esofagitis por reflujo gastroesofágico
- d) Acalasia esofágica
- e) Esofagitis por *Cándida albicans*

50) Un paciente de 70 años, consulta por un cuadro de varios meses de evolución de constipación, alternado con diarrea. Su examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes destaca hematocrito: 36% y hemoglobina de 12 g/dl. ¿Qué examen debe solicitarse a continuación?

- a) Test de sangre oculta en deposiciones
- b) Ecografía abdominal
- c) TAC de abdomen y pelvis
- d) Colonoscopia**
- e) Rectosigmoidoscopia

52) Un paciente de 49 años, fumador, presenta un cuadro de dispepsia postprandial de 4 meses de evolución, asociado a astenia, palidez, ictericia y prurito, que aumenta en las noches. Se solicitan exámenes que muestran hemograma normal y pruebas hepáticas que resultan GOT: 23 UI/L, GPT: 28 UI/L, bilirrubina total: 9,7 mg/dl, bilirrubina directa: 8,5 mg/dl, fosfatasa alcalina: 322 UI/L y GGT: 131 UI/L, con protrombinemia 80% y albúmina: 3,2 g/dl. El examen de elección para el estudio de este paciente es:

- a) Endoscopia digestiva alta
- b) Ecotomografía abdominal
- c) TAC abdominal
- d) Colangiografía por RMN**
- e) Colangiografía endoscópica retrógrada

68) Niña de 7 años de edad, quien consulta por cuadro de 12 horas de evolución, caracterizada por fiebre y dolor hipogástrico. Al examen físico tiene temperatura: 38,7 grados, FC: 100x', PA: 100/60, dolor a la palpación

de hipogastrio, con signo de Blumberg positivo y resistencia en la pared abdominal. Exámenes de laboratorio; 18.000 glóbulos blancos. Sedimento urinario muestra 20 leucocitos por campo. Proteína C reactiva: 15. El diagnóstico más probable es:

- a) Pielonefritis aguda
- b) Apendicitis aguda**
- c) ITU baja
- d) Torsión ovárica
- e) Plastrón apendicular

77) Una lactante de 8 meses de edad, con antecedente de prematurez, presenta un cuadro de 12 horas de evolución, de irritabilidad, llanto y dolor abdominal, asociado a dos de posiciones sanguinolentas. Al examen físico presenta abdomen blando y doloroso a la palpación. En su analítica destaca hematocrito de 34%, con Hemoglobina de 11,2 g/dl, leucocitos: 14.500 por mm³ y plaquetas: 230.000 por mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Enterocolitis necrotizante
- b) Divertículo de Meckel complicado
- c) Atresia esofágica
- d) Invaginación intestinal**
- e) Shigellosis

84) Un paciente de 55 años, con antecedente de diabetes mellitus 2, consulta por un cuadro de hematemesis, seguida de malestar general. Al examen físico está pálido, con FC:110x', PA: 100/60 mmHg, constatándose obesidad. En sus exámenes destaca albúmina: 3,0 g/dl; INR: 1,3; hematocrito: 30%, plaquetas: 77.000 por mm³, VCM: 105 fl y VHS: 20 mm/h. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Mallory Weiss
- b) Úlcera gástrica
- c) Úlcera duodenal
- d) Várices esofágicas**
- e) Gastritis crónica atrófica

89) Un paciente de 45 años, diagnosticado de VIH, presenta sangrado rectal ocasional. Al examen físico, se observa lesión solevantada en los márgenes anales, de 4 cm, que se introduce en el recto, sobrepasando la línea pectínea, con una ulceración central, con escaso sangrado. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemorroide externa trombosado
- b) Condiloma acuminado
- c) Sífilis
- d) Cáncer epidermoide**
- e) Enfermedad de Cröhn

93) Una paciente de 70 años de edad, con antecedente de cirrosis hepática, sin hábito alcohólico actual, VHBsAg (-) y Anticuerpos anti-VHC (-), Child Pugh clase A, MELDS: 8 puntos, se realiza una ecografía abdominal, que muestra una lesión sólida, en el lóbulo

hepático derecho, de 3,5 cm y aspecto hipoecogénico. En su laboratorio destaca alfafetoproteína de 5,3 ng/ml (VN: 0-7 ng/ml) El diagnóstico más probable es:

- a) Metástasis hepática
- b) Adenoma hepático**
- c) Carcinoma hepatocelular
- d) Quiste hepático
- e) Hemangioma hepático

116) Un paciente de 25 años de edad, sin patologías previas, presenta desde hace 4 años aumento de volumen cervical lateral, que ha ido creciendo. Al examen se constata una masa palpable, de 3 cm, en la zona lateral del cuello, de ubicación submandibular. Se solicita una ecografía cervical, que muestra un nódulo hipoecogénico, de bordes bien delimitados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Nódulo tiroideo
- b) Quiste branquial**
- c) Quiste tirogloso
- d) Linfadenopatía tuberculosa
- e) Tumor de glándula salival secundaria

130) Una paciente de 70 años acude por cuadro clínico de doce horas de evolución caracterizada por dolor en hemiabdomen inferior, que ha ido en aumento, siendo mayor en el hemiabdomen izquierdo. Al examen físico, presenta frecuencia cardíaca de 96 lpm, PA: 90/60 mmHg, temperatura 38,5 grados, sudoración y palidez, y examen abdominal con abdomen doloroso a la palpación, con Blumberg (+) y signos de irritación peritoneal en la fosa iliaca izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Diverticulitis aguda**
- b) Cáncer colorectal complicado
- c) Vólvulo sigmoideo
- d) Obstrucción intestinal
- e) Cáncer de ovario complicado

134) Una mujer de 55 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 4, con microcalcificaciones agrupadas. ¿Cuál es la conducta mas adecuada?

- a) Ecotmografía mamaria
- b) Biopsia estereotáctica.**
- c) Resonancia magnética
- d) Control mamográfico en 6 meses
- e) mastectomía parcial

157) Mujer de 88 años de edad, quien presenta clínica un día de evolución caracterizada por fiebre, diarrea y dolor en hipogastrio. Refiere evacuaciones sin otras alteraciones. Al examen físico presenta temperatura en 38,5 grados, presión arterial de 90/50 mmHg y al examen abdominal presenta dolor y sensibilidad a la palpación en fosa ilíaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

- a) Diverticulitis aguda**

- b) Colitis isquémica
- c) Pielonefritis aguda
- d) Enfermedad inflamatoria intestinal
- e) Rectocolitis bacteriana

174) Una paciente de 54 años, se realiza exámenes como parte de chequeo médico, que muestran SGOT: 43 UI/L, SGPT: 70 UI/L, GGT: 433 UI/L, FA: 531 UI/L, bilirrubina total: 3,0 mg/dl, albúmina: 3,7 g/dl y protrombinemia: 88%. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

- a) Colestasia por esteatosis hepática
- b) Cirrosis biliar primaria**
- c) Colestasia por compresión externa
- d) Colangitis esclerosante primaria
- e) Colangitis esclerosante secundaria

Julio 2017

Un paciente de 47 años, obeso, consulta por dolor y aumento de volumen en la zona interglútea. Al examen físico se aprecia aumento de volumen en la zona sacra, de consistencia blanda, eritematoso y doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar drenaje quirúrgico con anestesia local**
- b) Antibióticos orales
- c) Solicitar una ecografía de partes blandas
- d) Solicitar resonancia nuclear magnética de pelvis
- e) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

Es un quiste pilonidal infectado. Se debe drenar. Si no se infecta, solo se observa

Una paciente de 67 años, con antecedente de várices en las piernas con indicación de cirugía, presenta rotura de una de las várices, luego de un traumatismo en la pierna derecha, que produce sangramiento abundante. Al examen tiene FC: 80 latidos por minuto, PA: 120/80 mmHg y se aprecia sangrado profuso del várice roto, en el tercio medio de la pierna. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

- a) Torniquete inframaleolar
- b) Ligadura del cayado de la safena interna
- c) Sutura del várice sangrante**
- d) Escleroterapia variceal
- e) Safenectomía de urgencia

Lo más correcto es comprimir la várice sangrante, elevar la extremidad. Las alternativas que se presenta, exceden los conocimientos de un médico general, pero la más aceptable es hacer hemostasia con una sutura simple. Si falla, se procede a la ligadura (B)

Un paciente de 54 años consulta por dolor anal, que se presenta al defecar, persistiendo por algunos minutos luego de la defecación. En algunas ocasiones además ha presentado sangre en las deposiciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hemorroide externo trombosado
- b) Cáncer de recto
- c) Fisura anal**
- d) Fístula anal
- e) Absceso perianal

Fisura anal clásica (dolor postdefecación más rectorragia escasa).

Un paciente de 60 años, que hace tres años se habría realizado una colecistectomía con coledocostomía, consulta por cuadro de dolor abdominal tipo cólico intenso, asociado a vómitos alimentarios. No ha podido eliminar gases. Al examen físico presenta dolor difuso a la palpación abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad y tonalidad, con blumberg presente. El diagnóstico más probable es:

- a) Obstrucción intestinal**
- b) Trombosis venosa mesentérica
- c) Embolia mesenterica
- d) Pancreatitis
- e) Diverticulitis

Es una obstrucción intestinal clásica, probablemente por bridas (antecedente de cirugía).

Un paciente de 77 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, consulta por dolor abdominal de tipo inespecífico, de 2 meses de evolución, sin otros síntomas. En su examen físico se palpa un tumor abdominal de 4 a 5 cm de diámetro, en la zona umbilical, pulsátil, sin signos peritoneales.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trombosis mesentérica
- b) Tumor de colon
- c) Tumor de páncreas
- d) Disección aórtica
- e) Aneurisma aórtico abdominal**

Un tumor pulsátil en esa zona, hace pensar en un AAA. No tiene dolor por lo que no está roto y no puede ser una disección

Un paciente se realiza una cirugía abdominal. Usted lo evalúa a las 24 horas y observa que la herida operatoria presenta abundante secreción serohemática, con depresión de la zona central. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hernia umbilical
- b) Eventración
- c) Seroma**
- d) Evisceración
- e) Infección de la herida operatoria

La descripción era muy pobre, pero seroma era lo más aceptable (aunque llevaba poco tiempo).

Un paciente de 40 años, con antecedente de colecistectomía laparoscópica hace un año por colelitiasis, consulta por cuadro de 24 horas de dolor abdominal asociado a vómitos e ictericia. Su perfil hepático muestra GOT: 42UI/L, FA: 450mg/dL, bilirrubina total es de 10,3mg/dL, con bilirrubina directa de 9,5 mg/dL. Se realiza una

ecografía abdominal que muestra dilatación de la vía biliar principal, sin visualización de cálculos. El examen de elección para continuar el estudio es:

- a) Colangioresonancia**
- b) Colangiografía endoscópica
- c) TAC de abdomen y pelvis
- d) Exploración quirúrgica
- e) Marcadores tumorales

La sospecha es una coledocolitiasis residual y la verdad es que no existe una única forma de enfrentarla. La evidencia no es clara y las recomendaciones son muy variables. Por un lado, la conlangioresonancia da mucha información y en el algún momento, la sociedad chilena de cirugía la recomendó antes que la CPRE, por tener menos efectos adversos y poder diferenciar aquellos pacientes que se benefician de la CPRE de aquellos que requieren otro tratamiento. Sin embargo para muchos, la CPRE sigue siendo el examen de elección, por ser diagnóstico y terapéutico. Mi recomendación es que solo marquen CPRE si es que 1. Hay clínica de colangitis, 2. La ColangioRMN ve los cálculos y 3. La Ecografía inicial no solo ve la dilatación del colédoco, sino además los cálculos.

Un paciente obeso, con antecedente de hígado graso. Luego de una trasgresión alimentaria con abundante consumo de alcohol, presenta cuadro de dolor epigástrico irradiado a ambos costados, asociado a vómitos alimentarios, sensación febril e ictericia. Al examen físico, su presión arterial es de 110/70mmHg, con frecuencia cardíaca 100 por minuto, y al examen abdominal presenta dolor a la palpación de forma difusa, con abolición de ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Isquemia mesentérica
- b) Colangitis
- c) Pancreatitis**
- d) Colecistitis
- e) Coledocolitiasis

Es una pancreatitis clásica: dolor irradiado en faja, signos peritoneales (disminución de los RHA y dolor). Además, el antecedente de ingesta de alcohol es la segunda causa más frecuente, después de la litiasis biliar.

Un paciente de 62 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo dos y de daño hepático crónico secundario a una esteatohepatitis no alcohólica, ha presentado hospitalizaciones por cuadros de hemorragia digestiva alta en el último año, actualmente controlado. Se realizan exámenes de control en que se demuestra fosfatasas alcalinas de 565 UI/L, GOT: 186 UI/L GPT: 172 UI/L, bilirrubina total 4,2mg/dL, alfafetoproteína: 119 ng/mL. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?

- a) Endoscopia digestiva alta
- b) Ecografía abdominal**
- c) TAC abdominal
- d) Gammaglutamil transferasa
- e) Colangioresonancia

La sospecha es un cáncer hepático, dada la alfafetoproteína de 119. Se inicia el estudio con una Ecografía.

Una paciente de 45 años, hipertensa, se detecta un nódulo mamario, por lo que se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 4. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar mamografía en un año

- b) Solicitar ecografía mamaria
- c) Solicitar resonancia nuclear magnética de mamas
- d) Realizar biopsia por punción**
- e) Realizar mastectomía parcial

Birradi 0: Eco; 1 y 2: mamografía en un año; 3: mamografía en 6 meses; 4: biopsia histológica y 5: biopsia quirúrgica.

Un paciente de 19 años consulta por dolor en el testículo izquierdo, de inicio brusco y que se ha asociado a vómitos y malestar general. Al examen físico se aprecia testículo izquierdo edematoso, muy doloroso y ascendido. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar exploración quirúrgica escrotal**
- b) Realizar ecografía doppler testicular
- c) Realizar pielotac
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Indicar reposo y analgésicos

Todo testículo agudo se explora. Más aún a esa edad, en que se sospecha una torsión testicular

Una paciente de 70 años consulta por un cuadro de dolor abdominal y sensación febril, de 6 horas de evolución, a lo que se ha agregado ictericia. Al examen físico presenta FC: 87x', PA. 90/60 mmHg, temperatura: 38,5 grados Celsius. Al examen abdominal tiene intenso dolor a la palpación epigástrica, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Coledocolitiasis
- b) Colangitis aguda**
- c) Pancreatitis aguda
- d) Colecistitis aguda
- e) Hepatitis aguda

Tiene la triada de Charcot: fiebre, ictericia y dolor, más la hipertensión arterial. Es una colangitis clínica (se diagnostica con la clínica).

Un paciente de 50 años, con antecedente de infección de VIH, consulta por una lesión perianal, de larga data, sin tendencia a la cicatrización. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, de consistencia aumentada, de 4 cm de diámetro, bordes cartográficos y que se introduce por el ano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Sífilis
- b) Enfermedad de Crohn
- c) Carcinoma epidermoide**
- d) Melanoma
- e) Tuberculosis

Es un cáncer de recto clásico. Bordes cartográficos significa que simulan a un mapa (en otras palabras, borde irregular).

Una paciente de 42 años, consulta por adenopatía supraclavicular derecha persistente. Al examen físico se palpa además un nódulo cervical paratraqueal derecho de consistencia aumentada, que asciende con la deglución, de alrededor de 2 cm de diámetro. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio de esta paciente?

- a) Niveles plasmáticos de calcitonina
- b) Ecografía cervical**
- c) TAC de cuello
- d) Resonancia magnética de cuello
- e) Biopsia quirúrgica

Todo nódulo cervical se estudia inicialmente con Ecografía de cuello

Un paciente de 50 años, en tratamiento con antimicóticos orales desde hace 3 semanas, consulta por un cuadro de 2 días de evolución de prurito, ictericia y acolia, sin dolor. En su examen físico se aprecia icterico, afebril, con FC: 70x', PA: 110/70 mmHg, con abdomen blando, depresible. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran un patrón colestásico y la ecografía abdominal demuestra vesícula biliar con barro biliar y colédoco de 10 mm diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Coledocolitiasis**
- b) Colestasia farmacológica
- c) Síndrome de Mirizzi
- d) Esteatosis hepática
- e) Colelitiasis

Dado que hay dilatación del colédoco (mayor a 7 mm), lo más probable es que sea una colédocolitiasis, la que generalmente cursa con dolor, pero puede hacerlo solo con ictericia (igual que el cáncer). Las colestasias farmacológicas suelen producirse a nivel hepático y no a nivel del colédoco. El Síndrome de Mirizzi es la obstrucción del colédoco por un cálculo ubicado en la vesícula, el que se habría visto en la ecografía.

Diciembre 2017

12) Un paciente de 75 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor torácico intenso, de inicio súbito, que alcanza un EVA 7/10, de 2 horas de evolución. El dolor tenía una localización retroesternal, pero luego migra a la zona dorsolumbar. Al examen físico destaca disminución de los pulsos de las extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Infarto agudo al miocardio
- b) Aneurisma de la aorta abdominal complicada
- c) Tromboembolismo pulmonar masivo
- d) Disección aórtica**
- e) Neumotórax

22) Un paciente de 71 años consulta por dificultad para tragar de 1 mes de evolución. Además presenta halitosis que antes no tenía, asociada a regurgitación de alimentos recién ingeridos

- a) Estenosis péptica esofágica
- b) Divertículo de Zenker**
- c) Cáncer de esófago
- d) Cáncer de laringe
- e) Acalasia esofágica

31) Una paciente diabética, presenta hematemesis en 3 oportunidades. Su frecuencia cardíaca es 117x', su presión arterial es 90/60 mmHg. Al examen físico presenta arañas vasculares en la cara, ictericia en las escleras, abdomen blando depresivo e indoloro, con signos de ascitis. Se solicitan exámenes que muestran bilirrubina total: 4,3 mg/dl, hematocrito: 39%, INR: 1,8. La causa más probable de su hemorragia digestiva es:

a) Várices esofágicas

b) Úlcera gastroduodenal

c) Gastritis erosiva

d) Síndrome de Mallory Weiss

e) Esofagitis erosiva

34) Un paciente de 36 años consulta por aumento de volumen en la zona anterior del cuello. Al examen físico tiene un nódulo duro, de 2 cm de diámetro, asociado a una adenopatía cervical anterior de consistencia dura. Se solicita una TSH que resulta 6,1 UI/L. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

a) Punción con aguja fina

b) Ecografía tiroidea

c) Cintigrafía con yodo radiactivo

d) TAC de cuello

e) Resonancia magnética nuclear de cuello

38) Un paciente se realiza una ecografía de cuello, como parte del estudio de un nódulo cervical, que visualiza un tumor sólido y redondeado, localizado en el istmo, de 4 mm de diámetro, sin presencia de adenopatías. Sus pruebas tiroideas muestran TSH y T4 libre dentro de rangos normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Iniciar tratamiento levotiroxina

b) Iniciar levotiroxina en dosis de supresión

c) Realizar punción con aguja fina

d) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo

e) Realizar seguimiento ecográfico

90) Un paciente de 28 años tiene un quiste epidérmico en el cuello y consulta porque ahora aumentó de volumen y se ha vuelto doloroso y eritematoso. Al examen físico se lo aprecia según la imagen:

FOTO (absceso en el cuello, con algo de eritema alrededor y se ve de aspecto amarillo). La conducta más adecuada es:

a) Observar evolución

b) Indicar corticoides tópicos

c) Indicar antibióticos más drenaje quirúrgico

d) Realizar resección quirúrgica del quiste

e) Puncionar la lesión

91) Una paciente de 60 años presenta dolor abdominal de 2 días de evolución, mayor en el abdomen bajo. Al examen físico tiene dolor a la palpación abdominal, especialmente en la fosa iliaca izquierda, con signo de Blumberg positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Enfermedad inflamatoria pélvica

b) Diverticulitis aguda

c) Colitis isquémica

d) Apendicitis aguda

e) Enfermedad de Crohn

92) Un paciente de 35 años, consulta por un cuadro de 1 semana de malestar general, sensación de edema de la cara en la mañana y tos que ha ido aumentando. Al examen físico se constata una adenopatía cervical, yugulares ingurgitadas y edema facial y de las manos. Además tiene signos de derrame pleural bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Tuberculosis

- b) Hipotiroidismo
- c) Taponamiento cardíaco
- d) Mononucleosis infecciosa
- e) Síndrome de vena cava superior

93) Un niño de 7 años es mordido por un perro callejero en el brazo derecho. Además del manejo de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto a la profilaxis de la rabia?

- a) Observar al niño por 10 días
- b) Vacunar al niño solo si el perro presenta síntomas
- c) Administrar la vacuna antirrábica al niño
- d) Vacunar al niño solo si el perro muere
- e) Administrar inmunoglobulina antirrábica al niño

95) Una paciente de 60 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica electiva, por una coledocitis. La biopsia es informada como presencia adenocarcinoma invasor en el fondo de la vesícula, subseroso. Se solicita un TAC de abdomen y pelvis con contraste, que no visualiza metástasis. ¿Cuál es la conducta?

- a) Quimioterapia
- b) Radioterapia
- c) Cuidados paliativo
- d) Control con TAC cada 3 meses
- e) Colecistectomía radical

96) Una paciente de 50 años consulta por dolor abdominal de 12 horas de evolución, intenso y asociado a vómitos. Además ha presentado fiebre hasta 38,8 grados y aumento del dolor abdominal, en especial en el hemiabdomen superior. Al examen físico tiene ictericia de piel y mucosas, PA: 90/60 mmHg y FC: 116x'. Se realiza una ecografía abdominal que muestra colédoco de 11 mm de dilatación y litiasis en la vesícula biliar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar colecistectomía laparoscópica
- b) Realizar drenaje endoscópico de la vía biliar
- c) Solicitar colangioresonancia magnética nuclear
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Realizar colecistectomía más coledocostomía

124) Un niño de 6 años sufre un accidente en el campo, golpeándose con un palo en la cabeza y resultando con una herida supraciliar derecha de 5 cm de longitud. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Afrontamiento con cianoacrilato
- b) Afrontamiento con tela adhesiva
- c) Sutura con punto separado
- d) Sutura intradérmica
- e) Dejar que cure por segunda intención

176) Una mujer de 22 años consulta por un nódulo mamario, que se autopalpó. Al examen físico se constata un nódulo en la mama derecha, de 2 cm de diámetro, móvil. No se palpan adenopatías axilares. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?

- a) Mamografías
- b) Ecografía mamaria
- c) Resonancia magnética nuclear de mamas
- d) TAC de tórax

e) Biopsia

Julio 2018

Una mujer de 50 años, es diagnosticada recientemente de diabetes, por lo que está en tratamiento con hipoglicemiantes orales, presenta un cuadro de 2 semanas de prurito tratamiento con hipoglicemiantes orales, presenta un cuadro de 2 semanas de prurito generalizado, asociado a astenia e ictericia. En su examen físico, destaca ictericia de piel y escleras. Se solicitan exámenes, entre los que destaca bilirrubina: 5,7 mg/dl, fracción directa: 4,7 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 540 UI/L, GGT: 344 UI/L, GOT: 70 UI/L. Se realiza una ecografía abdominal que muestra una vía biliar dilatada, de 12 mm a la altura del conducto hepático común, con vesícula biliar muy distendida, de paredes finas. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Colangitis esclerosante primaria
- b. Ampuloma
- c. Coledocolitiasis
- d. Cáncer de páncreas**
- e. Colangiocarcinoma

Un paciente de 64 años, diabético e hipertenso, mal controlado, consulta por dolor abdominal de 5 días de evolución, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen físico está adolorido, con T°: 37,4 grados, FC: 88x', PA: 120/82 mmHg. Tiene abdomen blando, depresible, doloroso, más intenso en el hemiabdomen izquierdo, sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el estudio?

Seleccione una:

- a. Colonoscopia
- b. Ecografía abdominal
- c. Radiografía de abdomen simple
- d. Tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis**
- e. Resonancia magnética de abdomen y pelvis

Un paciente de 80 años, consulta por dolor abdominal de 2 días de evolución, tipo cólico, intenso, al que se han agregado vómitos alimentarios importantes. El dolor es más intenso en el hemiabdomen superior. Al examen físico se aprecia paciente adolorido, con PA: 110/68 mmHg, FC: 110x', T°: 37,4. Abdomen doloroso a la palpación, con distensión abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados y sin signos de irritación peritoneal. Se solicitan exámenes entre los que destaca PCR: 10 mg/dl, hematocrito: 37%, blancos: 11.000 por mm³, plaquetas: 340.000, GOT: 66 UI/L. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Colitis isquémica
- b. Trombosis de la vena mesentérica
- c. Perforación gástrica
- d. Pancreatitis aguda
- e. Obstrucción intestinal**

Un paciente de 70 años presenta tres episodios de hematoquecia abundante, en las últimas 24 horas. Al examen físico, está taquicárdico, sudoroso, con PA: 90/60 mmHg. Su abdomen se palpa blando, depresible y doloroso. ¿Cuál es la causa más probable de su hemorragia digestiva?

Seleccione una:

- a. Colitis isquémica

- b. Hemorroides internos
- c. Cáncer de colon
- d. Enfermedad diverticular**
- e. Colitis ulcerosa

Un paciente de 43 años, es agredido en la calle, mientras se encontraba en estado de ebriedad, recibiendo una puñalada en la zona inferior derecha del tórax, por lo que se hace una radiografía que se muestra a continuación:

El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Neumotórax
- b. Hemotórax
- c. Enfisema subcutáneo
- d. Neumoperitoneo**
- e. Hemoperitoneo

Un hombre de 34 años presenta erección dolorosa, desde hace 8 horas. Al examen tiene cuerpos cavernosos duros, pero con glándula y cuerpos esponjosos blandos. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada? Seleccione una o más de una:

- a. Aplicar paños fríos en la zona genital
- b. Fenilefrina endovenosa
- c. Vaciamiento quirúrgico de los cuerpos cavernosos.
- d. Drenaje con suero fisiológico frío intracavernoso
- e. Fenilefrina intracavernosa**

Un niño de 7 años presenta aumento de volumen en el cuello, que se desplaza con la deglución. El examen físico, se aprecia en la siguiente imagen. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?

Seleccione una:

- a. TAC de cuello
- b. Ecografía de cuello** quiste tirogloso
- c. Radiografía de cuello
- d. Cintigrafía con yodo radiactivo
- e. Captación de yodo radiactivo

Un hombre de 31 años consulta por aumento de volumen en el cuello, que se palpa como un nódulo tiroideo de consistencia firme. Es estudiado con ecografía, que muestra un nódulo hipoecogénico, sólido, heterogéneo, de 1,3 cm. La TSH: resulta 3,0 UI/L. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

Seleccione una:

- a. TAC de cuello
- b. Biopsia excisional del nódulo
- c. Biopsia citológica**
- d. Cintigrafía con yodo radiactivo
- e. Seguimiento ecográfico

Una paciente de 22 años presenta un nódulo mamario, en el lado derecho. Al examen físico se palpa un nódulo de 2 cm de diámetro, de consistencia gomosa, que no está adherido a la piel, ni a planos profundos. No tiene otras alteraciones. El examen más adecuado para iniciar el estudio es: Seleccione una:

- a. Ecografía mamaria** – fibroadenoma

- b. Mamografías bilaterales
- c. Punción con aguja fina
- d. Resonancia magnética nuclear
- e. Extirpación y biopsia de la pieza quirúrgica

Una paciente de 32 años tiene un cuadro de náuseas y dolor abdominal, que es mayor luego de comer y en las tardes. Su examen físico no tiene alteraciones. Se solicita una ecografía abdominal, que visualiza un pólipo en la vesícula biliar, de 4 mm de diámetro y aspecto homogéneo, sin presencia de cálculos. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- a. Realizar colecistectomía laparoscópica
- b. Solicitar endoscopia digestiva alta
- c. Realizar seguimiento con ecografía en 6 meses** – pólipo < 1 cm
- d. Realizar colangiografía
- e. Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Una paciente de 51 años consulta por disfagia ilógica intermitente, de 6 meses de evolución, asociada a odinofagia, pirosis y en ocasiones dolor retroesternal, más pérdida de peso de 4 kilogramos en los últimos meses. Es usuaria de omeprazol y el examen físico no presenta alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

- a. Acalasia esofágica**
- b. Candidiasis esofágica
- c. Cáncer de esófago
- d. Esofagitis por reflujo
- e. Esofagitis eosinofílica

Una mujer de 50 años, histerectomizada, en terapia de reemplazo hormonal, hace un año, con estrógeno solo. Se palpa un nódulo mamario derecho, el que es estudiado con mamografías, informándose como BIRADS 4. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- a. Cambiar la terapia de reemplazo hormonal a estrógenos más progestágenos
- b. Solicitar ecografía mamaria
- c. Control con mamografía en 6 meses
- d. Biopsia por punción estereotáxica**
- e. Resección del tumor con biopsia quirúrgica

Un paciente de 22 años presenta un cuadro de 2 horas de evolución de dolor torácico derecho, con tope inspiratorio. Al examen físico se ausculta disminución del murmullo pulmonar derecho, con hiperresonancia a la percusión. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Pericarditis aguda
- b. Neumotórax espontáneo**
- c. Tromboembolismo pulmonar
- d. Neumonía
- e. Cuerpo extraño bronquial

Un paciente es recibido 30 minutos luego de un accidente de tránsito de alto impacto. Al ingreso tiene PA:100/60 mmHg, sin embargo, durante el examen físico, se hipotensa hasta 80/40 mmHg y presenta marcada

taquicardia. No tiene signos de irritación peritoneal ni deformaciones en las extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

- a. Perforación de víscera hueca
- b. Shock neurogénico
- c. Rotura de víscera sólida :OOOOOOOOO**
- d. Traumatismo raquímedular
- e. Fractura de pelvis

Una mujer de 30 años consulta por disfagia ilógica intermitente, asociada a pirosis, regurgitación de alimentos y en ocasiones, dolor retroesternal. Es usuaria de omeprazol, de manera intermitente. Su examen físico muestra signos vitales normales y el examen abdominal también es normal. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en esta paciente?

Seleccione una o más de una:

- a. Manometría esofágica - acalasia esofágica**
- b. Radiografías contrastadas de esófago, estómago y duodeno
- c. Monitorización de pH esofágico de 24 horas
- d. TAC de abdomen y pelvis
- e. Ecografía abdominal

Un paciente de 65 años, con antecedente de hemorroides, consulta por dolor anal de tres días de evolución, que aparece en relación a la defecación. Además, presenta rectorragia escasa, que sigue a la defecación. Refiere que sus deposiciones han sido duras. El diagnóstico más probable es: Seleccione una:

- a. Cáncer rectal
- b. Fístula anal**
- c. Hemorroides internos
- d. Fisura anal
- e. Absceso perianal

Un paciente de 40 años, diabético e hipertenso, presenta aumento de volumen eritematoso y doloroso, en la zona interglútea, además se observa pus, que sale de un orificio de 1 mm de diámetro, ubicado en la línea media, por 5 cm sobre el ano. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Quiste pilonidal
- b. Absceso pilonidal
- c. Fisura anal
- d. Quiste sebáceo
- e. Fístula perianal**

Una paciente de 56 años, con cambio del hábito intestinal, presenta un cuadro de astenia y palidez, por lo que se realiza un hemograma, que demuestra hematocrito: 30%, hemoglobina: 10,1 g/dl, VCM:76, blancos: 7.500 por mm³ y plaquetas: 230.000 por mm³. Se realiza endoscopia digestiva alta, que resulta normal. El estudio más adecuado para proseguir el estudio de esta paciente es: Seleccione una:

- a. TAC de abdomen
- b. Ferritina
- c. Test de sangre oculta en deposiciones
- d. Colonoscopia – Ca colon**
- e. Ecografía abdominal

Un paciente de 52 años consulta por dolor abdominal intenso, asociado a vómitos alimentarios, a los que luego se ha agregado coluria y fiebre. Al examen físico tiene T°:39°C, FC: 100x'. PA: 90/60 mmHg. Al examen abdominal se palpa abdomen doloroso, mayor en el abdomen superior, con ruidos hidroaéreos presentes. Se solicita hemograma que muestra 18.000 glóbulos blancos por mm³; hematocrito: 45%, plaquetas normales. Además, tiene bilirrubina: 5,8 mg/dl, bilirrubina directa: 3,6 mg/dl, GOT: 88 UI/L, GPT: 74 UI/L, GGT: 370 UI/L, FA: 468 UI/L, amilasa: 280 UI/L. El diagnóstico más probable es: Seleccione una:

- a. Colecistitis aguda
- b. Colédocolitiasis
- c. Colangitis aguda**
- d. Pancreatitis aguda
- e. Colelitiasis

Un paciente de 78 años, postrado, presenta una lesión en la zona sacra, de 11 cm de diámetro, que afecta la piel y dermis y que en una zona deja entrever el músculo. Tiene necrosis en el borde y mal olor. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Seleccione una:

- a. Antibióticos tópicos
- b. Debridamiento químico**
- c. Curaciones con suero fisiológico
- d. Colgajo
- e. Cámara hiperbárica

Diciembre 2014

- 71. Paciente con antecedente de colecistectomía por laparotomía con clínica de obstrucción intestinal: conducta: RX
- 72. Paciente que vomita algo similar a la caca. Diagnóstico: vólvulo de sigmoides? Ca sigmoides
- 73. Paciente con clínica de cólico biliar a repetición con pólipo de 4 mm conducta: ¿observar? colecistectomía?
- 74. Típico caso de colangitis aguda
- 75. Paciente con coledocolitiasis y colelitiasis. conducta: CPRE, colecistectomía
- 76. Neumotórax espontáneo "moderado" conducta: tubo, drenaje con aguja fina, puncionar 2do espacio intercostal?

Diciembre 2016

- 59. Arma blanca, hipotenso, yugulares: revisión herida, cx ?
- 60. Gastrectomizado parcial con anemia: endoscopia
- 61. Paciente dolor abdominal: isquemia mesentérica
- 62. Con trastorno de líquidos: acalasia ? Ca esófago?
- 63. Se retira gastro: poner sonda nuevamente

64. Con antec. bariátrica pre op: erradicar pylori

65. Hidatidosis: arco 5

66. Tiroidectomía: parálisis cuerda vocal

67. Pólipo 5 mm, cambio intestinal: colonoscopia

68. Paciente con dolor epigastrio > amilasa: pancreatitis

69. Ictericia, Triada colangitis: colangitis

70. Fiebre post quirúrgica?

TRAUMATOLOGÍA

Diciembre 2013

10) Una paciente de 26 años, sin antecedentes, mientras iba como copiloto sufre accidente de tránsito, resultando con dolor en extremidad inferior derecha. Al ingreso con vía aérea permeable, respiración espontánea, sin sangramientos evidentes, presión arterial de 150/90, Glasgow 15, extremidad inferior derecha en posición púdica. El diagnóstico más probable es:

- a) Luxación anterior de cadera
- b) Fractura intertrocantérica
- c) Fractura de cuello femoral
- d) Luxación posterior de cadera**
- e) Fractura de pelvis

41) Una paciente de 35 años, sin antecedentes, sufre fractura de diáfisis humeral izquierda, evolucionando posteriormente con hipostesia del dorso de dicha mano, asociado a imposibilidad de realizar extensión de muñeca y falanges. ¿La estructura más probablemente dañada en este caso es?:

- a) Nervio mediano
- b) Nervio ulnar
- c) Nervio radial**
- d) Nervio axilar
- e) Nervio musculocutáneo

4) Un paciente de 19 años, sin antecedentes, hace un mes sufre golpe contuso en rodilla izquierda mientras jugaba fútbol, tras lo cual ha permanecido con dolor el cual ha aumentado en las últimas semanas, asociado a aumento de volumen duro. Se solicita radiografía de rodilla que muestra lesión de gran tamaño en metáfisis y diáfisis de fémur, asociado a compromiso cortical. El diagnóstico más probable es:

- a) Sarcoma de Ewing**
- b) Osteosarcoma ****
- c) Osteoma osteoide
- d) Sarcoma de partes blandas
- e) Tumor de células gigantes

51) Una paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus ambas en tratamiento farmacológico, consulta por dolor en hombro derecho de varios meses de evolución, el cual aumenta de intensidad en la noche, asociado a impotencia funcional. Al examen físico sin dolor a la movilización pasiva y con dolor a la abducción y rotación externa de hombro derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Tendinopatía bicipital
- b) Osteoartritis de hombro
- c) Tendinopatía deltoidea
- d) Tendinopatía del manguito rotador**
- e) Disyunción acromioclavicular leve

Julio 2015

1) Una mujer de 45 años consulta por debilidad para tomar objetos, desde hace 3 meses. Además, presenta parestias, especialmente en la noche, que mejoran al sacudir las manos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Atrapamiento del nervio cubital
- b) Polineuropatía
- c) Síndrome de túnel carpiano**
- d) Lesión del nervio radial
- e) Síndrome del opérculo torácico

2) Una mujer de 50 años consulta por parestesias en ambas manos, mayor a derecha, que la despiertan en la noche, por lo que debe sacudir las manos, para aliviarse. Además presenta dificultad para tomar objetos con las manos. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?

- a) Ecografía de mano
- b) Electromiografía**
- c) Prueba de estimulación con edrofonio
- d) Resonancia magnética de cuello
- e) Radiografía de mano

3) Un paciente de 35 años consulta por debilidad del cuarto y quinto dedos derechos, es especial a la flexión, asociado a parestesias en dichos dedos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Lesión de los tendones profundos
- b) Síndrome del opérculo torácico
- c) Atrapamiento del nervio radial
- d) Síndrome de atrapamiento cubital**
- e) Síndrome de túnel carpiano

4) Un paciente presenta dolor en la cara lateral de la cadera derecha, que aumenta con la marcha y al recostarse apoyado en esa cadera. Los movimientos están conservados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de la banda ileotibial
- b) Bursitis ileopectínea
- c) Bursitis trocantérica**
- d) Pinzamiento femoroacetabular
- e) Artrosis de cadera

5) Un paciente de 77 años presenta dolor inguinal derecho de 2 años de evolución, que aumenta con la marcha, limitándola. Al examen físico se aprecia pérdida de la rotación interna y la flexión de la cadera derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Necrosis avascular de la cabeza femoral
- b) Coxartrosis**
- c) Hernia foraminal S1
- d) Pinzamiento femoroacetabular
- e) Estenosis raquimedular

6) Un paciente, luego de un “sueño profundo”, en relación a una intoxicación alcohólica, presenta debilidad y dificultad para tomar objetos con la mano derecha, como sostener una taza, la que se le cae. Al examen físico

no tiene alteraciones en la sensibilidad, ni en los reflejos osteotendíneos, los que permanecen conservados. Sin embargo, al solicitarle que ponga los brazos en posición horizontal, se observa que la mano derecha está “caída”. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- a) Lesión del nervio radial
- b) Lesión del plexo braquial
- c) Lesión de los nervios cubital y mediano
- d) Isquemia de los músculos del antebrazo
- e) Accidente vascular encefálico

7) Un niño de 3 meses de edad se realiza una radiografía de pelvis, que muestra displasia de cadera izquierda, con índice acetabular de 36 grados. La indicación más adecuada es:

- a) Ejercicios de rotación y compresión
- b) Bota larga bilateral de yeso, con yugo
- c) Yeso pelvipedio
- d) Uso de doble pañal
- e) Arnés de Pavlik

8) Un adulto mayor presenta gonalgia bilateral, de dos años de evolución, que aumenta con la marcha. Hace algunas horas el dolor de la rodilla izquierda se vuelve mucho más intenso, apareciendo eritema, aumento de volumen y sensación febril. ¿Cuál es el examen más adecuado para este paciente?

- a) Resonancia magnética de rodilla
- b) Radiografía de rodilla
- c) Hemograma VHS
- d) Estudio de líquido articular
- e) TAC de rodilla

9) Un adolescente de 16 años presenta dolor en la rodilla derecha, luego de haberse golpeado. Al examen físico se palpa aumento de volumen de consistencia ósea, por lo que se solicita una radiografía, que muestra una lesión ósea heterogénea, ubicada en el extremo distal del fémur, con disrupción de la cortical y zonas líticas, con otras de aumento de la densidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Osteocondroma
- b) Tumor de células gigantes
- c) Osteosarcoma
- d) Displasia ósea fibrosa
- e) Quiste óseo

52) Un paciente de 27 años sufre una fractura cerrada de antebrazo, que es manejada con un valva de yeso braquiopalmar. A las 5 horas presenta aumento del dolor y edema de la extremidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Trombosis venosa profunda
- b) Síndrome compartimental
- c) Distrofia simpático refleja

- d) Alergia al yeso
- e) Síndrome de túne carpiano agudo

125) Un paciente de 23 años presenta dolor lumbar, irradiado a ambas piernas, de 2 años de evolución, y que suele ser mayor en la noche. Además presenta dolor torácico, que aumenta con los movimientos respiratorios. El dolor cede parcialmente con AINEs. Refiere un cuadro de artritis de rodilla derecha, autolimitado, hace un año. Al examen físico presenta restricción a los movimientos torácicos y a limitación de la flexión lumbar. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- a) Factor reumatoide
- b) Resonancia magnética de articulaciones sacroiliacas**
- c) TAC de columna lumbosacra
- d) Radiografía de tórax
- e) Hemograma y VHS

126) Una paciente de 45 años presenta dolor en el hombro derecho, que es mayor en la noche y que presenta impotencia funcional, que dificulta sus actividades. Al examen físico presenta dolor a la flexión y a la abducción tanto activa, como pasiva, del hombro derecho. La conducta más adecuada es:

- a) AINES y reposo
- b) AINES y kinesioterapia**
- c) Cabestrillo
- d) Infiltración con corticoides
- e) Cirugía

Diciembre 2015

42) Un paciente de 67 años presenta desde hace 2 semanas dolor en la rodilla derecha, que le dificulta la marcha. Al examen físico presenta crepitación articular en dicha rodilla y aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas. Su factor reumatoide está positivo en titulación 1/80. El diagnóstico más probable es:

- a) Artrosis**
- b) Gota
- c) Pseudogota
- d) Artritis reumatoide
- e) Osteoporosis

43) Un paciente de 80 años es diagnosticado de artrosis, de caderas, que le produce dolor, limitando la marcha ¿Cuál es el fármaco más adecuado para iniciar el tratamiento de este paciente?

- a) Celecoxib
- b) Condroitin sulfato
- c) Paracetamol**
- d) Tramadol
- e) Ibuprofeno

44) Una paciente de 50 años presenta dolores musculoesqueléticos generalizados, asociados a astenia y cansancio. Despierta con mialgias y con hinchazón de las manos, que no puede describir bien. Tiene antecedente de una tía con lupus eritematoso sistémico. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la mayoría de las masas musculares, sin debilidad propiamente tal, ni atrofia muscular. Presenta positividad de los anticuerpos antinucleares a títulos 1/40. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar prednisona
- b) Iniciar pregabalina y ejercicios aeróbicos**
- c) Solicitar biopsia muscular
- d) Iniciar AINEs
- e) Solicitar anticuerpos anti-antígenos nucleares extractables (perfil ENA) y anticuerpos anti-DNA

54) Usted examina a un niño de 4 años de edad, que presenta pie plano valgo flexible bilateral. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Controlar en un año**
- b) Realizar radiografía de ambos pies
- c) Indicar plantillas correctoras
- d) Realizar resonancia magnética nuclear de ambos pies
- e) Indicar calzado corrector

57) Un niño crece en el percentil 2 para la talla. Además presenta genu valgo bilateral, que le dificulta la marcha. Se realiza una radiografía de mano, que se muestra en la IMAGEN. El diagnóstico más probable es:

- a) Osteomalacia
- b) Osteoporosis
- c) Displasia fibrosa ósea
- d) Raquitismo**
- e) Osteogénesis imperfecta

90) Una niña de 4 años presenta claudicación de la marcha, asociada a compromiso del estado general y decaimiento. Evoluciona con aumento del dolor, que le impide caminar y fiebre hasta 39 grados. Al examen físico está febril, decaída y presenta intenso dolor tanto a la movilización pasiva, como a la movilización activa de la cadera derecha. Se solicitan exámenes que muestran PCR: 10 y glóbulos blancos: 17.000 por mm³. FOTO: Mano con solo 3 núcleos de osificación en el carpo, con todas las epífisis de las falanges claramente separadas de las diáfisis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Osteomielitis de la cabeza femoral
- b) Leucemia aguda
- c) Sinovitis transitoria
- d) Artritis viral
- e) Artritis piógena**

107) Un adolescente de 14 años presenta dolor en la rodilla derecha. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y dolor, en relación al fémur derecho. Tiene antecedente de traumatismo en la zona. Se solicitan

exámenes radiológicos (radiografía y resonancia magnética), que se muestran en la IMAGEN. FOTO: Radiografía con lesión osteolítica en el tercio medio de la diáfisis del fémur, con un tumor alrededor, apenas visible. RMN muestra un gran tumor, en relación a la diáfisis femoral, de gran tamaño, heterogéneo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Osteocondroma
- b) Condrosarcoma
- c) Tumor de células gigantes
- d) Sarcoma de Ewing
- e) Sarcoma de partes blandas

113) Un paciente de 45 años presenta dolor lumbar muy intenso, de inicio súbito, que se irradia por la extremidad inferior izquierda. Al examen físico presenta debilidad a la flexión plantar del primer dedo izquierdo, disminución de la sensibilidad de la zona lateral del pie izquierdo y abolición del reflejo aquiliano ipsilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome facetario, lateralizado a izquierda
- b) Lesión del nervio ciático izquierdo
- c) Afectación de la raíz S1
- d) Lesión del plexo lumbar
- e) Afectación de la raíz L5

114) Un paciente de 60 años, diabético, consulta por dolor lumbar de 3 semanas de evolución, que ha ido aumentando en intensidad y se ha asociado a fiebre y malestar general. Al examen físico presenta fiebre de 38,3 grados Celsius, dolor a la palpación de la zona prevertebral lumbar y una contractura muscular paravertebral izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Lumbago mecánico
- b) Lumbociática
- c) Discitis lumbar
- d) Osteomielitis
- e) Metástasis lumbar

161) Una paciente consulta por dolor en el hombro derecho, que ha ido en aumento en el último tiempo y que le dificulta las labores habituales, como realizar el aseo de la casa. Refiere que en el último tiempo el dolor aumenta en la noche y en ocasiones lo despierta. Al examen físico presenta dolor del hombro tanto ante los movimientos activos, como pasivos de la extremidad, con todo el rango articular conservado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Osteosarcoma de la cabeza femoral
- b) Capsulitis adhesiva
- c) Artrosis de la articulación glenohumeral
- d) Artrosis de la articulación acromioclavicular
- e) Tendinitis del manguito rotador

162) Un paciente de 33 años, consulta por dolor en la rodilla izquierda de 24 horas de evolución, que ha aumentado rápidamente de volumen y que le impide caminar. Se agrega fiebre y marcado malestar general. Al examen físico hay aumento de volumen de la articulación, con eritema y signos de derrame articular. Se realiza punción articular, que da salida a un líquido turbio, con abundantes células polimorfonucleares y presencia de bacterias cocáceas Gram positivas, dispuestas en racimos. ¿Cuál es el antibiótico más adecuado para iniciar el tratamiento?

- a) Ceftriaxona
- b) Cloxacilina**
- c) Gentamicina
- d) Imipenem
- e) Vancomicina

164) Un paciente de 42 años, diabético tipo 2, consulta por dolor en la rodilla derecha, que apareció luego de realizar actividad física. Al examen presenta aumento de volumen articular y eritema, por lo que se realiza punción articular, que da salida a un líquido articular con 27.000 glóbulos blancos por mm³, con 95% de polimorfonucleares, sin visualización de bacterias. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis séptica
- b) Artritis por cristales**
- c) Artritis reactiva
- d) Artritis reumatoide
- e) Sinovitis postraumática

165) Un paciente de 54 años consulta por dolor en la rodilla derecha, que le dificulta la marcha. Evoluciona rápidamente, impidiéndole caminar y asociándose a derrame articular. Se realiza punción articular que da salida a un líquido con 7.200 glóbulos blancos por mm³, con presencia de múltiples microcristales con birrefringencia de elongación levemente positiva. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Colchicina
- b) Antibióticos
- c) Drenaje quirúrgico
- d) AINES**
- e) Corticoides

Julio 2016

10) Un paciente de 24 años, sufre una caída a nivel, mientras jugaba básquetbol, cayendo con el hombro izquierdo, contra el suelo. Presenta impotencia funcional y al examen físico destaca dolor a la movilización del hombro izquierdo. Se solicita una radiografía AP de hombro y axial de escápula, que se muestran a continuación: FOTO: Se ve ligera separación entre la clavícula distal derecha y el acromion, con desplazamiento hacia superior del extremo distal de la clavícula. El diagnóstico más probable es:

- a) Luxación anterior de hombro

- b) Fractura de escápula
- c) Luxación acromioclavicular**
- d) Fractura de clavícula
- e) Lesión del tendón del manguito rotador

26) Un paciente de 30 años sufre una caída de altura, desde 15 metros, golpeándose contra el suelo. Al examen físico está orientado, con FC: 80x' y PA: 120/80 mmHg, con mucho dolor a la compresión de la pelvis, mayor a izquierda. Se solicita una radiografía de pelvis AP, que se muestra a continuación: FOTO: se ve una fractura de pelvis, con compromiso del acetábulo izquierdo y algún grado de separación en la sínfisis del pubis. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Pasar una sonda Foley
- b) Indicar reposo en hamaca
- c) Administrar antibióticos
- d) Realizar cirugía**
- e) Solicitar ecografía de abdomen y pelvis

65) Una paciente de 65 años sufre caída a nivel, apoyando la mano derecha contra el suelo, en extensión de la extremidad. Evoluciona con dolor intenso en la muñeca, que le impide realizar movimientos. Al examen físico se aprecia deformidad de la muñeca y dolor epicrítico a la presión del radio distal. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura de escafoides
- b) Fractura de epifisis distal del radio**
- c) Disyunción-fractura de radio distal
- d) Luxofractura de Monteggia
- e) Luxación de cúpula radial

101) Un paciente de 18 años, consulta porque desde hace un año presenta aumento de volumen progresivo en la cara anterior del muslo derecho, que recientemente se ha vuelto dolorosa. Al examen físico se palpa una masa de 10 cm de diámetro, de consistencia dura, no pétrea, sin afectación de la piel. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar resección y biopsia
- b) Observar evolución
- c) Solicitar ecografía de partes blandas**
- d) Solicitar radiografía de fémur
- e) Realizar punción y drenaje

102) Una paciente de 61 años consulta por dolor articular de ambas manos. Al examen se aprecia aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Se solicita radiografía de manos, que muestra disminución simétrica del espacio interarticular de las articulaciones interfalángicas, con compromiso de la primera articulación carpometacarpiana bilateral, con presencia de quistes subcondrales. Los ANA y FR resultan positivos. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis psoriática

- b) Artritis reumatoide
- c) Artritis reactiva
- d) Condrocalcinosis
- e) Artrosis

103) Una paciente de 61 años, hipertensa y diabética, en tratamiento regular con hipoglicemiantes orales y antihipertensivos, desde hace 3 días presenta dolor y aumento de volumen en hombro derecho. Al examen físico presenta temperatura 38,2 °C, eritema, rubor y aumento de volumen del hombro derecho y limitación funcional, que impide el movimiento. El diagnóstico más probable es:

- a) Gota
- b) Condrocalcinosis
- c) Artritis reumatoidea
- d) Artritis séptica
- e) Artritis reactiva

105) Una niña de 5 años presenta dolor en muslo izquierdo, que luego se ubica en la cadera izquierda y que limita su movimiento. Al examen físico está en buenas condiciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Sinovitis transitoria
- b) Artritis séptica
- c) Artritis reumatoidea
- d) Osteomielitis
- e) Tumor de Ewing

178) Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en cadera izquierda y claudicación progresiva, que actualmente impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. Se realiza radiografía AP pelvis y caderas, que se muestra a continuación: FOTO: se muestra una epifisiolisis de cadera izquierda clásica. El diagnóstico es:

- a) Displasia del desarrollo de la cadera
- b) Epifisiolisis
- c) Fractura del cuello del fémur
- d) Luxación de la Cadera izquierda
- e) Necrosis avascular de la cabeza del fémur

Diciembre 2017

58) Un paciente de 63 años, diabético mal controlado, presenta parestesias, asociada a dolor en ambas manos, que es mayor en la noche y que se irradia a ambos codos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Polineuropatía diabética
- b) Hernia del núcleo pulposo
- c) Síndrome de túnel carpiano
- d) Síndrome de atrapamiento cubital
- e) Neuropatía radial

98) Un hombre protagoniza un accidente de tránsito, chocando de manera frontal, contra otro automóvil. Presenta intenso dolor en la cadera derecha, que le impide caminar. En su examen tiene una rotación fija hacia interno, con aducción del muslo. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura de cuello femoral
- b) Fractura de cotilo
- c) Esguince grado 3 de cadera
- d) Luxación anterior de cadera
- e) Luxación posterior de cadera**

99) Un paciente de 28 años sufre una caída a nivel, cayendo sobre la mano izquierda, con extremidad superior izquierda en extensión. Al examen físico presenta dolor a la compresión axial del pulgar y al presionar la tabaquera anatómica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fractura de la base de la primera falange proximal
- b) Fractura de escafoides**
- c) Fractura perilunar
- d) Fractura del extremo distal del radio
- e) Esguince de la primera articulación metacarpofalángica

100) Un paciente sufre una caída a nivel, con golpe en el hombro derecho, evolucionando con dolor e impotencia funcional. Se realizan radiografías de hombro, una de las que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía AP de hombro, con fractura del tercio medio de la clavícula derecha, con ligero desplazamiento, sin conminución) ¿Qué tipo de inmovilización es la más adecuada?

- a) Vendaje axial de hombro
- b) Vendaje en ocho
- c) Yeso Velpeau
- d) Yeso toracobraquial
- e) Cabestrillo**

101) Una paciente de 31 años, secretaria, consulta por dolor en el hombro derecho, que ha aumentado en el último tiempo. Ella refiere que es más intenso en la noche y que aparece especialmente al levantar el codo por sobre el hombro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tendinitis del manguito rotador**
- b) Hernia del núcleo pulposo cervical
- c) Artrosis glenohumeral
- d) Tendinitis de la cabeza larga del bíceps
- e) Capsulitis adhesiva de hombro

Diciembre 2014

151. Caso clínico con RADIOGRAFÍA (Fractura antebrazo): Nervio lesionado? R: radial

152. Hombre choca en su auto, con dolor en cadera, acortamiento extremidad y rotación interna: luxación posterior de cadera

153. Hombre, caída a nivel, brazo en extensión. ¿Con deformación? dolor, rotación externa. Dg? luxación anterior de hombro.

154. El paciente con luxación de hombro días atrás y trastorno de la sensibilidad en la región del hombro el nervio lesionado era el circunflejo o axilar.

155. Paciente con dolor lumbar de tiempo de evolución irradiado a ambos muslos y la región poplíteas comienza con dolor reciente e inflamación del tendón de Aquiles. La respuesta era espondilitis anquilosante

Diciembre 2016

119. Luxación de hombro: sensibilidad deltoides

120. Paciente dializado se cae: ruptura tendón cuádriceps

121. Tratamiento artrosis: paracetamol

122. Mujer adulta mayor con dolor rodilla, Punción articular: artrosis

123. Fractura con dolor: síndrome compartimental

124. Golpe de pies y torsión rodilla: LCM

125. Artritis séptica: pabellón

126. Adulto mayor con dolor lumbar: discitis lumbar

Diciembre 2013

8) Un paciente de 50 años, diabético en tratamiento con metformina, consulta por poliaquiuria, nicturia, latencia y debilidad del chorro miccional desde hace meses, no asociado a otros síntomas. Su tacto rectal muestra próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Con respecto a este caso, ¿Cuál de las siguientes es una indicación absoluta para resolución quirúrgica en esta patología?

- a) Hematuria en una ocasión
- b) Retención aguda de orina**
- c) Residuo postmiccional de 150 ml
- d) Próstata mayor a 40 cc
- e) Antígeno prostático de 5 ng/ml

50) Paciente de 30 años, sufre caída de altura resultando con traumatismo contuso en flanco derecho, asociado a hematuria macroscópica. Al examen físico presenta equimosis en flanco derecho, sin otros hallazgos. ¿Cuál de los siguientes exámenes es el más indicado para el estudio de este paciente?

- a) Ecografía abdominal
- b) Tomografía axial computada sin contraste de abdomen
- c) Radiografía abdominal
- d) Tomografía axial computada con contraste de abdomen**
- e) Pielografía de eliminación

56) Un paciente de 27 años, sin antecedentes, consulta por dolor en flanco izquierdo de 2 horas de evolución tipo cólico, irradiado a genitales, náuseas y vómitos, sudoración y hematuria. Al examen físico se encuentra inquieto, con puño percusión positiva a izquierda. El fármaco de elección para el manejo de este paciente es:

- a) Ketorolaco**
- b) Acetaminofeno
- c) Pargeverina
- d) Tramadol
- e) Clonixinato de lisina

82) Un paciente de 21 años, sin antecedentes, mientras jugaba futbol sufre golpe en zona testicular tras lo cual se palpa una masa. Al examen físico se palpa masa en polo superior blanda. Se solicita ecografía escrotal que muestra lesión quística en epidídimo de 3 cm de diámetro, sin otros hallazgos. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Orquiectomía por vía inguinal
- b) Punción y aspiración del quiste
- c) Orquiectomía por vía escrotal
- d) Observación**
- e) Indicar inhibidores de la 5 alfa reductasa

14) Un paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril y diabetes mellitus en tratamiento con metformina y glibenclamida, presenta desde hace 3 meses y en forma progresiva, poliaquiuria y nicturia, asociado a latencia, chorro miccional doble y débil. Al examen físico se palpa próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Se solicita antígeno prostático que resulta en 3,5ng/ml. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Realizar prostatectomía vía resección transuretral ****

- b) Realizar prostatectomía por vía retropúbica
- c) Indicar alfa agonista
- d) Indicar inhibidor de la 5 alfa reductasa**
- e) Indicar análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas

39) Un paciente de 18 años, sin antecedentes, consulta por dolor en flanco izquierdo de 1 hora de evolución tipo cólico e irradiado a genitales, sin otros síntomas. Su examen físico es normal. Se solicita sedimento de orina muestra 50 eritrocitos por campo, sin dismorfia. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

- a) Tomografía axial computada con contraste
- b) Pielografía de eliminación
- c) Radiografía de abdomen
- d) Ecografía abdominal
- e) Tomografía axial computada sin contraste**

68) Un paciente de 16 años, sin antecedentes, consulta por dolor testicular que inició hace una hora, asociado a náuseas, vómitos y sudoración. Al examen físico se aprecia testículo derecho ascendido respecto al contralateral y escaso eritema circundante. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Realizar ecografía testicular
- b) Indicar doxiciclina y cirpofloxacino
- c) Indicar ketorolaco endovenoso y suspensión testicular
- d) Realizar exploración quirúrgica inmediata**
- e) Solicitar exámenes generales, parámetros inflamatorios y sedimento de orina, luego decidir conducta según resultados

Julio 2015

43) Un paciente de 46 años presenta un accidente, resultando con una fractura de pelvis. Presenta dolor y salida de sangre fresca por la uretra. Además se palpa la próstata ascendida en el tacto rectal y no ha podido orinar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Pedir un TAC de abdomen y pelvis
- b) Solicitar resonancia magnética
- c) Realizar cistoscopia
- d) Instalar sonda Foley
- e) Instalar cistostomía**

44) Un paciente de 16 años presenta dolor testicular derecho intenso, de inicio súbito, asociado a náuseas. Al examen se palpa el testículo derecho muy doloroso y aumentado de tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Torsión testicular**
- b) Torsión de la hidátide
- c) Infarto testicular
- d) Orquiepididimitis
- e) Trombosis de varicocele

45) Un paciente de 68 años, fumador de 20 paquetes-año, presenta hematuria abundante, con coágulos. Se realiza un sedimento que muestra incontables glóbulos rojos y un urocultivo que resulta negativo. Se le realiza un TAC de abdomen y pelvis que no muestra alteraciones. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?

- a) Ecografía pélvica
- b) Resonancia magnética nuclear
- c) Pielografía de eliminación
- d) Cistoscopia**
- e) Uretrocistografía

46) Un paciente de presenta dolor abdominal en el flanco izquierdo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que muestra un tumor renal sólido, de 2,5 cm de diámetro, en el polo superior del riñón derecho. Se solicita un TAC, que confirma el tumor renal de aspecto sólido y que capta contraste. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Nefrectomía radical
- b) Nefrectomía parcial**
- c) Nefroureterectomía
- d) Iniciar inhibidores de la tirosinasa
- e) Realizar seguimiento ecográfico

47) Una paciente de 57 años, multípara de 5, presenta incontinencia de esfuerzos moderados. Su examen físico muestra genitales normales, sin prolapso. Tiene sedimento de orina normal y urocultivo negativo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?

- a) Oxibutinina
- b) Suspensión uretral
- c) Terapia de remplazo hormonal
- d) Kinesioterapia pélvica**
- e) Doxazosina

48) Una paciente de 69 años diabética, mal controlada, presenta escapes de orina. Además ha presentado algunas infecciones urinarias. Su urocultivo actual está negativo, pero consulta por la incontinencia urinaria. Se realiza una ecografía que muestra una vejiga de paredes lisas, con volumen urinario de 930cc y residuo postmiccional de 750cc. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Resolver quirúrgicamente
- b) Instalar una sonda Foley
- c) Realizar cateterismo intermitente**
- d) Indicar anticolinérgicos
- e) Indicar colinérgicos

49) Un paciente ha presentado 5 episodios de litiasis uretral en los últimos años. ¿Cuál es la alteración metabólica más probable en este paciente?

- a) Hiper calciuria**

- b) Hiperoxaluria
- c) Hiperuricosuria
- d) Hipocitraturia
- e) Hipercistinuria

50) Un paciente presenta dolor lumbar intenso, irradiado a testículo, que se ha asociado a vómitos y a inquietud psicomotora. Su sedimento de orina muestra microhematuria. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar el diagnóstico en este paciente?

- a) TAC de abdomen con contraste
- b) Ecografía abdominal
- c) PieloTAC**
- d) Pielografía de eliminación
- e) Radiografía simple de abdomen y pelvis

51) Un paciente de 81 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, usuario de Sonda Foley a permanencia, se realiza un urocultivo, porque sus orinas se han vuelto turbias. Dicho urocultivo resulta positivo para Escherichia coli, con más de 100.00 UFC, sensible a nitrofurantoína, gentamicina e imipenem. ¿Cuál de las siguientes actitudes es la más adecuada?

- a) Observar evolución**
- b) Indicar tratamiento con imipenem
- c) Indicar tratamiento con gentamicina
- d) Indicar tratamiento con nitrofurantoína
- e) Retirar la sonda

Diciembre 2015

1) Un paciente de 30 años consulta por dolor testicular izquierdo, intermitente, de algunas semanas de evolución. Al examen físico ginecomastia bilateral y se palpa aumento de volumen del testículo izquierdo, de consistencia aumentada, no doloroso. El diagnóstico más probable es:

- a) Hidrocele
- b) Cáncer de epidídimo
- c) Epididimitis
- d) Cáncer de testículo**
- e) Quiste de epidídimo

2) Un paciente de 68 años es operado de una hernia inguinal, sin embargo, a las 6 horas del postoperatorio evoluciona con dolor abdominal hipogástrico, intenso y malestar. Su presión arterial es 96/64 mmHg, su FC: 98x', temperatura: 37 grados Celsius. Al examen físico presenta una masa hipogástrica, dolorosa a la palpación. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar tamsulosina
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Realizar sondeo con sonda Foley**

- d) Administrar neostigmina
- e) Indicar analgésicos y observar evolución

3) Un paciente consulta porque presenta intenso dolor en el pene. Al examen físico, se observa edema y color violáceo en el glande, por lo que se intenta reducción manual, sin éxito. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Instalar una sonda Foley
- b) Realizar circuncisión
- c) Administrar analgésicos endovenosos
- d) Aplicar hielo local y reintentar la reducción manual
- e) Realizar una incisión en la zona dorsal del prepucio

98) Una paciente de 38 años presenta escapes de orina, asociados a intensos deseos de ir al baño, imposibles de controlar. Se realiza un sedimento de orina y urocultivos, que resultan normales y se solicita examen de urodinamia, cuya cistomanometría muestra contracciones no inhibidas del detrusor, que aparecen ante el llenado vesical de 80 a 100 cc. ¿Cuál es el tratamiento inicial para el manejo de esta paciente?

- a) Anticolinérgicos
- b) Reeducación vesical
- c) Antiadrenérgicos
- d) Ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico
- e) Cirugía de suspensión vesical

115) Un paciente de 61 años, fumador, presenta hematuria durante 24 horas. Se realiza un sedimento de orina que muestra abundantes glóbulos rojos y urocultivo, que está negativo. Se realiza un UroTAC, que resulta normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?

- a) Ecografía renal y vesical
- b) Resonancia magnética nuclear
- c) Cistoscopia
- d) Baciloscopías en orina
- e) Cistomanometría

Julio 2016

33) Un paciente de 32 años presenta un cuadro de cólico renal, asociado a microhematuria en el sedimento de orina. ¿Cuál es el examen de elección para el estudio de este paciente?

- a) UroTAC
- b) PielotAC
- c) Pielografía de eliminación intravenosa
- d) Ecografía
- e) Radiografía simple

91) Adolescente de 13 años quien consulta por dolor inguinal y testicular izquierdo, intenso, de 45 minutos de evolución, irradiado a hipogastrio y acompañado de náuseas y vómitos. Al examen físico está afebril, con escroto enrojecido, testículo retraído y doloroso a la palpación. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- a) Administrar AINES
- b) Administrar antibióticos
- c) Cirugía**
- d) Realizar suspensión testicular
- e) Solicitar ecografía testicular

131) Mujer de 85 años tiene el diagnóstico de incontinencia urinaria de urgencia. Su examen ginecológico es normal, y trae un examen de orina, que resulta normal. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más indicado para el manejo de esta paciente?

- a) Amitriptilina
- b) Imipramina
- c) Oxibutinina**
- d) Tolterodina
- e) Trazodona

159) Paciente femenina, fumadora de 30 paquetes/año, presenta hematuria, con abundante coágulos de sangre. No presenta dolor, fiebre, ni otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina, que muestra abundantes eritrocitos, sin bacterias. El diagnóstico más probable es:

- a) Cistitis hemorrágica
- b) Cáncer de vejiga**
- c) Cáncer renal.
- d) Tuberculosis renal
- e) Infección urinaria

Diciembre 2017

76) ¿Cuál de las siguientes exposiciones laborales se asocian al desarrollo de cáncer de vejiga?

- a) Solventes
- b) Mercurio
- c) Anilinas**
- d) Pesticidas
- e) Plomo

77) Un paciente de 67 años, fumador de 20 cigarrillos diarios, consulta por hematuria de 4 días de evolución, abundante, con coágulos. No ha presentado disuria, ni poliaquiuria, ni mal olor en la orina, ni dolor. Su examen de orina muestra abundantes eritrocitos por campo, sin dismorfia. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer renal
- b) Cáncer de vejiga**
- c) Cáncer de uréter
- d) Cáncer de próstata
- e) Cistitis intersticial

78) Un paciente de 60 años, que durante una infección urinaria, se detectó APE de 14,2 ng/ml y un tacto rectal, con presencia de un nódulo prostático duro. Una vez tratada con éxito su infección, el APE es bajó a 12 ng/ml. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Prostatectomía radical
- b) Seguimiento con APE y tacto en 1 año
- c) Ecografía de próstata
- d) Resección transuretral
- e) Biopsia prostática**

79) Una mujer de 73 años, presenta escapes de orina, precedidos por grandes e incontrolables deseos de orinar. Además, ha tenido escapes de orina en la noche. Al examen físico, no hay mayores alteraciones. Se solicita una ecografía vesical, que visualiza una vejiga urinaria de paredes delgadas, sin litiasis y sin residuo postmiccional significativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar cistoscopia
- b) Realizar suspensión uretral con cinta transvaginal
- c) Iniciar oxibutinina**
- d) Indicar ejercicios de piso pélvico
- e) Realizar cirugía abierta de piso pélvico

80) Un paciente de 70 años, con antecedente de hiperplasia prostática benigna, consulta por escapes de grandes cantidades de orina, asociada a deseos intensos de ir al baño. Se solicita una ecografía vesicoprostática que visualiza adenoma prostático de 50 cc de volumen, vejiga urinaria con paredes engrosadas y residuo postmiccional significativo. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

- a) Imipramina oral
- b) Tamsulosina oral**
- c) Amitriptilina oral
- d) Tolterodina oral
- e) Cloruro de trospio

148) Un adolescente de 15 años presenta dolor frecuente del testículo izquierdo. Al examen físico se palpa aumento de volumen perotesticular, compatible con un varicocele y además se palpa el testículo izquierdo de menor tamaño que el testículo derecho. Se solicita una ecografía testicular que muestra una dilatación patológica del plexo pampiniforme.

- a) Observa evolución hasta que complete su desarrollo puberal
- b) Realizar varicosectomía**
- c) Solicitar espermograma
- d) Realizar biopsia testicular
- e) Solicitar cariograma y niveles de testosterona, LH y FSH

DICIEMBRE 2014

30. Niña 8 años, disuria, micción cada 1 hora, prurito y eritema leve vagina. Urocultivo E Coli 58,000. ¿Dg?
Infección urinaria, vaginosis, vejiga neurogénica

31. Mujer con disuria??? Era un fármaco que había que agregar alfa agonista, beta agonistas

32. Hombre con hematuria y globo vesical. ¿Conducta? Foley + irrigación? Nelaton + lavado?

33. Cólico renal se le administra ketorolaco y tramadol, además administrar: tamsulosina

DICIEMBRE 2016

127. Pene eritematoso: clotrimazol

128. Paciente sintomático con HPB: tamsulosina

129. Trauma uretra: cistostomía

130. RTU con pseudomona → carbapenémico

131. Testículo atrófico criptorquidea → orquedectomía

PSIQUIATRÍA

Diciembre 2013

9) Un paciente de 24 años, estudiante de derecho, debe rendir su examen oral final para obtener su título profesional, ha estudiado por varios meses y tiene buen dominio de los temas, pero a pesar de que se ha preparado, no ha querido presentar aún el examen, ya que según él “no puedo hacerlo”. Refiere que le ha pasado lo mismo en situaciones similares donde le ha tocado exponer presentando gran nerviosismo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Trastorno de la personalidad evitativo
- c) Ansiedad social**
- d) Trastorno de ansiedad generalizada
- e) Agorafobia

17) Una mujer de 35 años, sin antecedentes, consulta porque está segura de que todos sus compañeros de trabajo la seducen y la acosan, esto le ocurre desde hace aproximadamente 10 años y le ha traído problemas en su trabajo, por lo que ha sido despedida en otros trabajos. No refiere presentar problemas en otros ámbitos de su vida, tiene buena relación con familiares y amigos. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad paranoide
- b) Trastorno de personalidad histriónico
- c) Trastorno delirante crónico**
- d) Trastorno bipolar
- e) Trastorno de la personalidad esquizotípico

26) Una paciente de 40 años, con antecedente de cuatro episodios depresivos tratados y usuaria de fluoxetina de forma permanente, cursa un nuevo episodio luego de separación con su marido. En su último control se encontraba de mejor ánimo ya que asistiría al casamiento de su hija. Actualmente consulta muy preocupada porque hace aproximadamente una semana atrás, su mano derecha intentó atacarla, pero se defendió con la su mano izquierda y ayuda de familiares. El diagnóstico más probable en este caso es:

- a) Trastorno conversivo
- b) Trastorno delirante
- c) Psicosis
- d) Trastorno disociativo**
- e) Trastorno por somatización

39) Un paciente de 16 años, sin antecedentes mórbidos, es traído por presentar mal rendimiento escolar y mala relación con sus padres. Sus padres refieren que esto comenzó hace tres meses, que ha estado irritable, se alimenta mal y duerme poco. Al entrevistar solo al paciente, refiere que hace aproximadamente tres meses terminó una relación amorosa que fue muy importante. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno ansioso
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno delirante
- d) Distimia
- e) Depresión**

51) Paciente joven de 24 años, es traído por sus padres ya que desde hace aproximadamente un año se vuelve muy solitario, no sale de su hogar, descuida su higiene y habla frecuentemente sobre el apocalipsis y el fin de

la humanidad. Al entrevistarle se aprecia con marcado aplanamiento afectivo y frente a distintas preguntas habla sobre el apocalipsis. Su madre está actualmente cursando con depresión y su padre tiene trastorno bipolar en tratamiento con litio. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno por abuso de sustancias
- c) Trastorno de la personalidad esquizotípico
- d) Esquizofrenia
- e) Trastorno delirante crónico

67) Una paciente de 24 años, sin antecedentes, consulta en urgencias por cuadro de inicio brusco caracterizado por sensación de falta de aire, dolor en hemitórax izquierdo, mareos, sudoración y adormecimiento de manos, de 30 minutos de duración. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca 120 por minuto, presión arterial 140/90, cardiopulmonar normal. Se solicita electrocardiograma que muestra ritmo sinusal, QRS angosto, sin signos de isquemia. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:

- a) Haloperidol
- b) Diazepam
- c) Lorazepam
- d) Fenitoina
- e) Clonazepam

86) Un paciente de 24 años, sin antecedentes, consulta porque hace ocho meses mientras esperaba transporte colectivo, presenció un accidente automovilístico con resultados fatales, desde entonces intenta no acercarse mucho a la calle y cada vez que está en un paradero se encuentra muy inquieto, además refiere que le cuesta conciliar el sueño ya que presenta pesadillas frecuentemente. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por estrés post traumático
- b) Trastorno de ansiedad
- c) Trastorno evitativo
- d) Trastorno por estrés agudo
- e) Trastorno adaptativo

23) Una paciente de 36 años, sin antecedentes, consulta porque desde hace tres meses ha presentado varios episodios caracterizados por taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, náuseas y sensación de muerte que tienen una duración de 30 minutos máximo y que ceden espontáneamente, por lo cual está muy preocupada, ya que dos de ellos le ocurrieron cuando se encontraba en una cafetería. Refiere que hace tres meses su pareja le pidió el divorcio en un restaurant, tras lo cual, intenta no salir de su hogar por miedo a que algo le ocurra y nadie la ayude. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por ansiedad social
- b) Trastorno adaptativo
- c) Trastorno por estrés post traumático
- d) Agorafobia
- e) Trastorno de ansiedad **

32) Una paciente de 28 años tiene relaciones amorosas muy intensas, se viste muy provocativa y es muy coqueta, lo que le ha traído problemas con sus pares a las que ella las llama “envidiosas”. Durante la entrevista es muy exagerada al contar sus problemas. El trastorno de la personalidad más probable en este caso es:

- a) Narcisista
- b) Límitrofe

c) Histriónico

d) Dependiente

e) Antisocial

38) Una paciente de 23 años, sin antecedentes, consulta muy preocupada porque desde hace un mes ha presentado en cuatro oportunidades cuadros de inicio agudo caracterizados por dolor torácico intenso, asociados a cefalea, mareos, parestesias y disnea, los cuales tienen una duración aproximada de una hora y ceden espontáneamente. Al preguntarle de forma dirigida, desconoce que puede desencadenar estas crisis. Trae electrocardiograma que le habrían tomado en el servicio de urgencias cuando consultó por una crisis el cual se aprecia normal. Los fármacos de elección para el tratamiento de esta paciente son:

a) Fluoxetina y carbamazepina

b) Amitriptilina y clonazepam

c) Citalopram y risperidona

d) Sertralina y diazepam

e) Paroxetina y lamotrigina

40) Una mujer de 75 años, sufre caída a nivel presentando fractura de cuello femoral, por lo que se realiza prótesis total de cadera. Luego de la cirugía comienza a hablar incoherencias, se agita, se vuelve agresiva y además presenta desorientación temporoespacial. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo de esta paciente?

a) Risperidona v.o

b) Haloperidol e.v

c) Diazepam i.m

d) Lorazepam e.v

e) Midazolam e.v

47) Un paciente de 26 años, estudiante universitario con regular rendimiento, es traído por sus padres porque desde hace tres meses no ha asistido a clases, ya que prefiere quedarse en su habitación. Ellos refieren que siempre fue solitario y que no buscaba tener amistades. Al entrevistarle de forma dirigida se ríe sin motivo y refiere que no quiere salir de su habitación porque la voz del diablo lo amenaza. El diagnóstico más probable es:

a) Trastorno delirante crónico

b) Trastorno de la personalidad esquizoide

c) Delirium

d) Esquizofrenia hebefrénica

e) Trastorno Bipolar

65) Una paciente de 55 años, se lava las manos recurrentemente porque siente que se encuentran sucias, el hecho de no hacerlo rápidamente le provoca gran angustia. Esto le ha provocado dermatitis en sus manos, por lo cual está preocupada. Sabe que esta conducta no tiene sentido, pero no puede evitarlo. El diagnóstico más probable es:

a) Trastorno de ansiedad

b) Ansiedad específica

c) Trastorno dismórfico corporal

d) Trastorno disociativo

e) Trastorno obsesivo compulsivo

78) Paciente de 76 años, con antecedentes de HTA en tratamiento, es hospitalizado por neumonía

requiriendo antibióticos endovenosos. Estando hospitalizado comienza con desorientación temporoespacial, inatención y pensamiento desorganizado, de curso fluctuante durante el día. El

diagnóstico más probable es:

- a) Demencia senil
- b) Demencia frontotemporal
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Delirium**

84) Un paciente de 40 años, sin antecedentes, con cuadro de disforia y anhedonia desde hace tres semanas, momento en el cual fue despedido de su trabajo, además presenta apetito disminuido, baja de peso e insomnio. Al entrevistarle de forma dirigida refiere que siente que no vale nada y no ha presentado intentos ni ideas suicidas. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Venlafaxina
- b) Amitriptilina
- c) Clonazepam
- d) Escitalopram**
- e) Bupropion

Julio 2015

68) Un paciente consulta muy angustiado, porque cree ser pedófilo. Le aterra acercarse a los niños y no sabe qué hacer, a pesar de que sabe que su idea es rara. Refiere que reza para no serlo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno delirante cónico
- b) Trastorno esquizoafectivo
- c) Trastorno psicótico agudo
- d) Trastorno obsesivo compulsivo**
- e) Parafilia

69) Una mujer de 40 años pierde súbitamente la movilidad de ambos brazos. Esto sucede en relación con la reactivación de un conflicto familiar. Al examen físico se aprecia una disociación con los síntomas, por lo que se descarta patología orgánica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno somatomorfo
- b) Trastorno facticio
- c) Trastorno conversivo**
- d) Trastorno disociativo
- e) Trastorno adaptativo

70) Un paciente sufre una fractura de muñeca, en relación a un accidente laboral. Presenta con mucho dolor, a pesar de haber evolucionado bien y de llevar mucho tiempo desde el accidente. Tiene antecedente de cuadros previos similares, con dolores crónicos y difíciles de tratar. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno somatomorfo**
- b) Trastorno conversivo
- c) Trastorno de estrés postraumático

- d) Depresión reactiva
- e) Trastorno facticio

71) Una paciente de 82 años, con antecedente de 2 intentos de suicidio previos, presenta un cuadro de ánimo bajo, irritabilidad, problemas de memoria. Su minimental es 27/30, su GDS (escala de depresión geriátrica) es de 12/15 y presenta ideas delirantes de daño. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Terapia electroconvulsiva**
- b) Iniciar sertralina
- c) Hospitalizar con mirtazapina
- d) Indicar clorpromazina
- e) Hospitalizar con amitriptilina

72) Un paciente de 24 años presenta un cuadro de ánimo exaltado e irritabilidad. Presenta verborrea y muchas ideas de éxito y negocios. Los familiares se muestran muy preocupados. Actualmente duerme dos horas al día, porque no se siente cansado. Al examen físico presenta verborrea, luego se vuelve agresivo y finalmente se agita. ¿Qué fármaco debe recibir en este momento?

- a) Olanzapina
- b) Escitalopram
- c) Ácido valproico
- d) Litio
- e) Haloperidol**

73) Un paciente bipolar recibe haloperidol y tras su tercera dosis presenta contracción persistente y dolorosa del cuello y del brazo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Distonía aguda**
- b) Acatisia
- c) Síndrome neuroléptico maligno
- d) Balismo
- e) Disquinesia tardía

74) Un paciente de 18 años presenta un cuadro de ánimo bajo, en tratamiento con antidepresivos por 3 meses, sin respuesta. Sus padres están muy preocupados, porque permanece encerrado en su cuarto, sin hacer nada, ni siquiera ver televisión. Al examinarlo, no se aprecia anhedonia, ni tristeza. No ha tenido alucinaciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Distimia
- b) Trastorno de personalidad esquizoide
- c) Esquizofrenia**
- d) Trastorno esquizoafectivo
- e) Depresión mayor

75) Un paciente de 24 años tiene la idea de que es el enviado de Dios y que está encargado de la salvación de las almas. Se muestra convencido de ello y al confrontarlo con la realidad, reacciona algo agresivo. Es un

paciente tranquilo, con pocos amigos y afectivamente plano. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno esquizoafectivo
- b) Trastorno bipolar
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno de personalidad narcisista
- e) Esquizofrenia**

76) Un paciente de 56 años dice, desde hace algunos meses, que sus vecinos lo espían y que están conspirando contra él. No tiene otros problemas y tiene una vida laboral y familiar normales. La esposa se muestra muy preocupada y refiere además que el paciente es aceptado y querido por todos y que los vecinos nunca lo han espiado ni nada similar. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Depresión
- c) Trastorno delirante crónico**
- d) Trastorno de personalidad paranoide
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

77) Un niño de 4 años no tiene interés en juntarse con otros niños, no habla y solo se comunica con señas. Aplaudiva con frecuencia, ante situaciones estresantes, no le gusta que lo toquen y juega siempre con el mismo juguete. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno global del desarrollo
- b) Trastorno del espectro autista**
- c) Hipoacusia
- d) Parálisis cerebral
- e) Trastorno de conducta

78) Un niño de 5 años presenta movimientos repetitivos con las manos, estereotipados (manierismos), no habla y solo se comunica con señas, no se relaciona con otros niños y llora cuando le quitan el sombrero. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno generalizado del desarrollo**
- b) Trastorno por déficit atencional
- c) Trastorno de conducta
- d) Hipotiroidismo congénito
- e) Epilepsia generalizada

79) Una paciente tiene relaciones interpersonales intensas e inestables y problemas frecuentes con las demás personas. Presenta antecedentes de dos intoxicaciones medicamentosas y autoagresiones. Además estuvo en tratamiento por bulimia hace un año. Tiene un sentimiento crónico de inutilidad y vacío. Además es impulsiva en el consumo de alcohol y compras. ¿A qué trastorno de la personalidad corresponde el cuadro?

- a) Histriónico
- b) Límitrofe**
- c) Narcisista

- d) Antisocial
- e) Dependiente

80) Una paciente de 17 años ha bajado 15 kilogramos en el último tiempo. Su IMC actual es de 16. Tiene mucho miedo a engordar y de hecho quiere bajar un poco más de peso, por lo que luego de comer se induce vómitos, con mucha frecuencia. Está en amenorrea desde hace 4 meses. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno alimentario no especificado
- b) Bulimia nervosa
- c) Anorexia nervosa**
- d) Depresión mayor
- e) Distimia

81) Un paciente de 54 años, alcohólico hace 20 años, que en contexto de una festividad consume abundante alcohol, con cerca de 3 botellas de vino al día. Se reintegra a su trabajo y al tercer día después de suspender el consumo, evoluciona con un cuadro de malestar general, ansiedad, temblor, seguido luego de agitación psicomotora y alucinaciones. ¿Qué fármaco debe administrarse?

- a) Diazepam**
- b) Fenobarbital
- c) Fenitoína
- d) Haloperidol
- e) Tiamina

82) Una paciente de 20 años presenta mucha ansiedad ante las situaciones en que debe hacer exposiciones o presentaciones ante los demás. Presenta sudoración y palpitaciones antes de las presentaciones, con opresión cordial y disnea y está dispuesta incluso a aumentar su carga de trabajo, con tal de evitar ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno de ansiedad generalizada
- b) Trastorno de personalidad evitativo
- c) Trastorno de personalidad dependiente
- d) Trastorno de angustia
- e) Trastorno de ansiedad social**

83) Una paciente de 24 años presenta un cuadro de opresión precordial, disnea, parestesias en extremidades superiores, palpitaciones y mucha ansiedad y miedo. Los síntomas se instalan en pocos minutos. ¿Cuál es el mejor medicamento para el manejo de esta crisis?

- a) Diazepam
- b) Fluoxetina
- c) Lorazepam**
- d) Haloperidol
- e) Clorpromazina

84) Una paciente que desde niña es muy tímida, tiene dificultades para relacionarse con otras personas, por temor al rechazo. No ha tenido pareja y evita las situaciones en que hay muchas personas. Le gustaría mejorar su situación y desarrollar su autoestima. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Trastorno de personalidad evitativo

b) Trastorno de personalidad dependiente

c) Fobia social

d) Agorafobia

e) Trastorno de ansiedad generalizada

85) Un paciente de 55 años ha presentado varios cambios cognitivos conductuales, como tendencia a la apatía, lenguaje coprolático o andar desnudo. No ha tenido alteraciones en la conciencia ni en la memoria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Demencia por cuerpos de Lewy

b) Hidrocefalia normotensiva

c) Enfermedad de Alzheimer

d) Demencia frontotemporal

e) Delirium

86) Un paciente de 25 años presenta mal rendimiento en la universidad, habiendo reprobado una de las asignaturas. Refiere que no se concentra en sus estudios y que no alcanza a leer toda la materia. En la entrevista se ve verborreico, inquieto y teatral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Trastorno histriónico de la personalidad

b) Déficit atencional

c) Trastorno bipolar

d) Insuficiencia intelectual leve

e) Síndrome de Asperger

87) Un niño de 7 años perdió el año escolar. Presenta dificultades en la lectoescritura, invierte fonemas con frecuencia, es muy lento para leer y le cuesta deletrear. Su padre no terminó el colegio, porque tenía problemas similares. El diagnóstico más probable es:

a) Coeficiente intelectual límite

b) Trastorno oposicionista desafiante

c) Trastorno por déficit atencional

d) Dislexia

e) Trastorno del desarrollo

108) Un paciente de 81 años presenta insomnio de conciliación y de mantención, que afecta sus actividades y lo tiene angustiado. Refiere que no duerme siesta. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo de su insomnio?

a) Clonazepam

b) Diazepam

c) Midazolam

d) Alprazolam

e) Zolpidem

Diciembre 2015

36) Una paciente evoluciona con imposibilidad de utilizar sus dos extremidades superiores, luego de ser despedida de su trabajo. Llama la atención lo tranquila que está y la disociación con el examen físico, ya que no presenta las alteraciones orgánicas. El diagnóstico más probable es:

a) Trastorno somatomorfo

b) Trastorno hipocondríaco

c) Trastorno conversivo

d) Trastorno disociativo

e) Trastorno facticio

37) Una paciente de 56 años consulta por cefalea holocránea, asociada a malestar lumbar, parestesias en las manos, artralgias y dolores musculares generalizados. Además presenta prurito generalizado y en ocasiones disfagia. Los síntomas suelen aumentar cuando tiene discusiones con su marido y ha sido hospitalizada en dos oportunidades para estudio, sin hallar una causa orgánica. El diagnóstico más probable es:

a) Trastorno disociativo

b) Trastorno por somatización

c) Trastorno conversivo

d) Depresión

e) Trastorno adaptativo

38) Un paciente de 55 años, profesor de física, fue despedido de su trabajo hace 3 años, a pesar de haber resuelto un problema de física, que llevaba décadas sin poder resolverse. No ha podido encontrar un nuevo trabajo, a pesar de sus capacidades superiores. Esto le causó problemas con su esposa, separándose hace 3 años. Cuando habla de este tema lo hace de manera vehemente, pero al referirse a otros temas habla de manera tranquila y muy amable. El diagnóstico más probable es:

a) Trastorno delirante crónico

b) Trastorno bipolar en episodio maniaco con delirio megalomaniaco

c) Depresión psicótica

d) Esquizofrenia con delirio megalomaniaco

e) Psicosis reactiva

39) Un paciente de 24 años tiene el impulso de romper vidrios, por lo que lo ha hecho en varias oportunidades. El refiere que no quiere hacerlo, pero no puede evitarlo, por lo que le pide a las personas que lo contengan para no hacerlo, lo que lo calma. El diagnóstico más probable es:

a) Trastorno facticio

b) Trastorno obsesivo compulsivo

c) Esquizofrenia

- d) Trastorno disociativo
- e) Trastorno por descontrol de impulsos

128) Un paciente de 18 años abandona sus estudios porque no presenta interés en seguir estudiando. Pasa encerrado en su pieza y sus padres se encuentran muy preocupados porque anda con ideas raras. Al examen presenta actitud alucinatoria y delirio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Depresión psicótica
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Psicosis reactiva
- d) Esquizofrenia primer brote**
- e) Manía psicótica

129) Un paciente de 18 años no tiene interés en las relaciones interpersonales, de hecho no tiene novia ni amigos y nunca ha “pololeado”. Es indiferente a las críticas y opiniones de las demás personas y no ha continuado sus estudios ya que no presenta interés en ellos. Prefiere siempre estar solo y pasas mucho tiempo encerrado en su pieza. Él refiere que esto no le preocupa. El diagnóstico más probable es:

- a) Distimia
- b) Depresión
- c) Trastorno de personalidad esquizoide**
- d) Esquizofrenia
- e) Trastorno de personalidad paranoide

130) Una paciente de 15 años, diabética tipo 1, ha sido hospitalizada 8 veces en el último año, por hipoglucemias severas. Es sorprendida por sus padres inyectándose una dosis de insulina que no estaba indicada. A pesar de ello, niega rotundamente el hecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno conversivo
- b) Trastorno disociativo
- c) Trastorno de personalidad histriónico
- d) Trastorno hipocondriaco
- e) Trastorno facticio**

131) Una mujer de 73 años es hospitalizada por una pielonefritis aguda para tratamiento. Evoluciona con inquietud y angustia, asociada a la idea de que alguien la quería matar. Al examen físico está desorientada y agitada. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Trastorno disociativo
- c) Enfermedad de Alzheimer
- d) Trastorno adaptativo
- e) Delirium**

132) Un paciente alcohólico es hospitalizado para una cirugía. Evoluciona con malestar general, sudoración, inquietud y temblor de extremidades superiores y al tercer día de hospitalización, presenta desorientación,

con marcada angustia y agitación, asociado a alucinaciones de insectos que subían a su camilla y lo atacaban.

El tratamiento más adecuado es:

- a) Carbamazepina
- b) Vitamina B1
- c) Risperidona
- d) Diazepam**
- e) Haloperidol

133) Un paciente intenta suicidarse ingiriendo múltiples comprimidos de clonazepam. Al examen físico está comprometido de conciencia, con frecuencia respiratoria de 5 respiraciones por minuto. ¿Cuál de los siguientes es el fármaco de elección para el tratamiento de este paciente?

- a) Suero fisiológico
- b) Flumazenil**
- c) Naloxona
- d) N-acetyl cisteína
- e) Bicarbonato

135) Un paciente inicia tratamiento hace una semana con sertralina 100 mg, debido a un trastorno obsesivo compulsivo. Presenta un cuadro de diarrea, asociado a cefalea, dolor abdominal y vómitos, a lo que luego se agrega malestar general temblor y desorientación, seguido de sopor. Al examen físico presenta taquicardia, fiebre hasta 39,0 grados Celsius y llama la atención la marcada rigidez de sus extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome anticolinérgico
- b) Síndrome serotoninérgico**
- c) Síndrome colinérgico
- d) Síndrome anticolinérgico
- e) Síndrome neuroléptico maligno

Julio 2016

8) Mujer de 81 años, hospitalizada por neumonía, presenta agitación psicomotora en las noches, agrediendo al personal hospitalario y no reconoce a sus familiares. En el día, por el contrario, está en buenas condiciones, tranquila y no recuerda lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Esquizofrenia
- b) Accidente vascular encefálico
- c) Delirium**
- d) Demencia
- e) Trastorno delirante

35) Una paciente de 20 años, universitaria, tiene escasa interacción con sus compañeros, porque la inhibe el juicio que ellos puedan tener sobre su desempeño. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad esquizoide
- b) Trastorno de ansiedad
- c) Fobia social**
- d) Trastorno del espectro autista
- e) Esquizofrenia

44) Paciente masculino de 27 años de edad , quien presenta desde hace 1 año temor a volar, por lo que prefiere desplazarse por tierra siempre. Incluso ha dejado de asistir a congresos y visitar a familiares en el extranjero. Siente mucha angustia y palpitaciones, cada vez que sabe que debe tomar un avión, desde los días antes y en dos oportunidades, previo a los vuelos, ha tomado benzodicepinas con respuesta parcial. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de ansiedad generalizada
- b) Fobia específica**
- c) Agorafobia
- d) Trastorno de pánico
- e) Trastorno por ansiedad de separación

45) Paciente de 23 años, que desde hace 6 meses experimenta desánimo, que ella dice que es causado por estar muy disconforme con su figura. Refiere que experimenta momentos en que come muchas galletas, sin parar, hasta ser imposible seguir comiendo, en especial cuando está ansiosa. Además tiene miedo de reprobador en la universidad. Refiere que 3 veces por semana, puede trotar 5 horas y comer menos de 200 Calorías al día. Niega provocarse vómitos, ya que refiere que no puede inducirlos, aunque ha intentado. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

- a) Anorexia nervosa
- b) Trastorno por atracones
- c) Depresión mayor
- d) Bulimia nervosa**
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

57) Una paciente femenina de 33 años, que hace 5 años comienza con síntomas recurrentes y variables de molestias genitourinarias, y gastrointestinales, asociados a mareos y prurito, ha consultado en reiteradas ocasiones a especialistas los cuales han descartado enfermedad orgánica, llegando incluso a realizarse una laparoscopia exploradora, que no tenía alteraciones. Sus síntomas le impiden trabajar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hipocondria
- b) Trastorno facticio
- c) Trastorno de personalidad
- d) Trastorno de somatización**
- e) Simulación

58) Una mujer de 23 años quien, desde la niñez es extremadamente introvertida y con baja autoestima por lo que se le es difícil conseguir amigos, por miedo a que pensarán de ella, esto la hace infeliz. En cambio, con su familia es muy cariñosa. EL diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno evitativo de la personalidad
- b) Síndrome de Asperger
- c) Depresión mayor
- d) Distimia
- e) Fobia social**

83) Un hombre de 46 años refiere que las mujeres de su trabajo se le insinúan y quieren tener una relación con él. Sin embargo, no hay testigos de esos hechos y al interrogar a sus compañeras de trabajo, lo niegan. Al confrontar al paciente, se enoja, ya que le molesta que no crean en lo que él dice. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipomanía
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno delirante crónico**
- d) Dismorfofobia
- e) Trastorno de personalidad narcisista

125) Una paciente de 45 años, fumadora de 25 paquetes-año, fuma al despertarse, y fuma más durante la mañana, con grandes bocanadas. Evita lugares donde no se puede fumar y fuma a pesar de enfermarse. La ansiedad es el principal desencadenante para fumar. Ella refiere que no desea dejar de fumar. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Vareniclina
- b) Bupropión oral
- c) Parches de nicotina
- d) Tratar la ansiedad**
- e) Entrevista motivacional

128) Un paciente de 28 años presenta ánimo bajo e irritable, desde hace 2 meses, fecha en que murió su hermano. Se siente ansioso e intranquilo, sin cambios en el peso. Los síntomas interfieren moderadamente con sus actividades laborales. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de estrés agudo
- b) Trastorno de adaptación**
- c) Episodio depresivo mayor
- d) Trastorno de ansiedad generalizada
- e) Distimia

129) Una mujer de 34 años se siente muy ansiosa al realizar actividades como hacer presentaciones o hablar en reuniones de trabajo. Por ello evita ese tipo de situaciones y asigna dichas tareas a sus subalternos, sobrecargándolos. Incluso dejó de asistir a un congreso de ejecutivos, en el que tendría que exponer. El diagnóstico más probable es:

a) Fobia social

- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Trastorno de personalidad antisocial
- d) Trastorno de personalidad evitativo
- e) Trastorno de pánico

138) Una paciente de 78 años, diabética e hipertensa, es hospitalizada por una pielonefritis aguda. Estaba en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y metformina. Durante el día está tranquila, pero en la noche se agita y dice que la tienen secuestrada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Indicar benzodiacepinas en la noche

b) Indicar haloperidol oral

- c) Agregar glibenclamida al tratamiento
- d) Disminuir la dosis de metformina
- e) Administrar suero fisiológico

172) Un paciente masculino, de 22 años, desde hace más de 6 meses ha dejado de compartir con su familia y casi no sale de su pieza. Además, ha descuidando su aspecto personal. Sus familiares refieren que en ocasiones lo escuchan musitar, hablar y reírse solo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Esquizofrenia

- b) Depresión psicótica
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno de personalidad esquizoide
- e) Trastorno bipolar

Julio 2017

Una paciente de 25 años, con antecedente de anorexia nervosa desde hace 5 años. Actualmente pesa 29 kilos y mide 1,68 metros, con IMC de 10,3. ¿Con cuantas kilocalorías diarias se debe iniciar su alimentación?

a) 300

- b) 600
- c) 1200
- d) 1500
- e) 2400

En todo paciente muy desnutrido, para prevenir el síndrome de realimentación se debe iniciar con 10-15 Kcal/Kg/día

Una paciente de 59 años, luego de una pelea con su marido, se va de su casa y es encontrada varias horas después sin recordar lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Trastorno facticio

b) Trastorno disociativo

- c) Trastorno somatomorfo
- d) Trastorno conversivo
- e) Trastorno adaptativo

Es una fuga disociativa clásica. Además tiene algún grado de amnesia disociativa (no recuerda).

Una paciente presenta disminución de la sensibilidad e imposibilidad de mover la extremidad superior derecha, luego de haber sido despedida de su trabajo. Su examen neurológico no tiene alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno somatomorfo
- b) Trastorno facticio
- c) Trastorno disociativo
- d) Trastorno conversivo**
- e) Trastorno por simulación

Es un trastorno conversivo clásico. Sin embargo, son un tipo de trastorno somatomorfo. No debería haber un distractor correcto, pero nuevamente hay que marcar la opción más específica.

Una paciente de 30 años, diabética tipo 1, con historia de 5 hospitalizaciones en el último año por cuadros de hipoglucemia severa. Actualmente ingresa en shock hipoglucémico, el que es manejado adecuadamente. Durante su hospitalización, es sorprendida en el baño inyectándose una dosis de insulina que no le correspondía, lo cual ella posteriormente niega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno disociativo
- b) Trastorno somatomorfo
- c) Trastorno hipocondriaco
- d) Trastorno por simulación
- e) Trastorno facticio**

Es un trastorno facticio clásico. No es por simulación, porque no hay un fin económico (conseguir licencia, ganar demanda, etc.), sino afectivo.

Un paciente con antecedente de daño hepático crónico por consumo de alcohol, bebedor activo, que toma 1 botella de vino al día, sin emborracharse, es ingresado al hospital. Evoluciona con malestar general, ansiedad y luego desorientación, asociada a alucinaciones zoomorfas de pequeños animales que lo atacan.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Haloperidol
- b) Lorazepam**
- c) Tiamina
- d) Carbamacepina
- e) Setralina

Es un delirium tremens, por privación de alcohol, que se trata con diazepam, aunque en el daño hepático, se prefiere el lorazepam.

Un paciente de 50 años, presentó una pelea con su vecino hace 4 meses y desde hace un mes comienza con recuerdos del incidente, asociado a pesadillas recurrentes. En las últimas semanas evita pasar por fuera de la casa de su vecino por miedo, y su familia refiere que se encuentra con ánimo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno adaptativo
- b) Trastorno de estrés postraumático**
- c) Depresión reactiva
- d) Depresión psicótica

e) Trastorno de ansiedad generalizada

Es un TEPT clásico (evento traumatizante, seguido de reexperimentación [pesadillas o recuerdos], evitación, estado de hiperalerta y embotamiento afectivo. Se complica con depresión, que es lo que parece haber ahora.

Un paciente de 70 años consulta por anhedonia, marcada angustia y desconcentración de 2 meses de evolución, asociada a insomnio de conciliación y de despertar precoz y baja de peso de 5 kilogramos. No presenta alteraciones del pensamiento, ni del examen neurológico ¿Cuál es el tratamiento de elección para iniciar el tratamiento en este paciente?

- a) Trazodona
- b) Mirtazapina
- c) Venlafaxina
- d) Fluoxetina**
- e) Amitriptilina

Es una depresión en el adulto mayor. Se trata con inhibidores de la recaptura de serotonina. Están contraindicados los tricíclicos (amitriptilina) en el adulto mayor y se prefiere evitar la trazodona porque produce mucha sedación. Si fallan los IRS, se pueden indicar los duales (venlafaxina, mirtazapina)

Un paciente de 84 años consulta por un cuadro de 4 semanas de evolución de desconianza, asociada a enojo porque quienes viven con él le roban y le cambian sus cosas de lugar, para molestarlo. Hace 1 semana despidió a alguien que había trabajado por 30 años con él, por la misma razón. Al examen se muestra molesto respecto al tema, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Demencia
- b) Paranoia
- c) Delirium
- d) Trastorno delirante**
- e) Depresión psicótica

Cumple criterios de trastorno delirante (delirio sistematizado mayor a 4 semanas), con delirio de persecución. No se indicaba desorientación ni inatención, como para pensar en delirium; tampoco había síntomas anímicos, como para pensar en depresión. La memoria no estaba afectada, como para pensar en demencia. No es un trastorno delirante crónico (mayor a 3 meses).

Un niño de 2 años y 8 meses realiza rabietas con frecuencia, se tira al suelo y grita cuando no se hace lo que él quiere, lo que ha pasado frente a sus padres y las profesoras del jardín infantil. Dice 300 palabras y su desarrollo motor es acorde a su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno oposicionista desafiante
- b) Trastorno de conducta
- c) Trastorno por déficit atencional
- d) Trastorno generalizado del desarrollo
- e) Oposicionismo normal para su desarrollo**

Por la edad y la intensidad de las rabietas, parece un niño normal ("los terribles 2"). El TOD es un niño muy insolente, que hace rabietas muy intensas y hace lo contrario de lo que se le dice, en una actitud muy irrespetuosa y desafiante

Una paciente de 81 años, hace un año tiene la idea de padecer de VIH, por lo que se ha realizado múltiples exámenes, los que siempre han resultado negativo. A pesar de ello, ella continúa con la idea. Fuera de esto, su vida no ha sido mayormente afectada. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia
- b) Trastorno obsesivo compulsivo
- c) Trastorno delirante crónica**
- d) Trastorno por hipocondría
- e) Depresión psicótica

Es un TDC clásico, con delirio de enfermedad.

Un paciente alcohólico es ingresado, indicándosele tratamiento con diazepam 0,5 mg/noche y haloperidol 0,5 mg/noche. Evoluciona con sudoración, inquietud, palpitaciones e insomnio con angustia que es mayor en la noche.

- a) Acatisia
- b) Síndrome de privación de alcohol**
- c) Síndrome neuroléptico maligno
- d) Disonía aguda
- e) Diquinesia aguda

Es un síndrome de abstinencia moderado. No tiene delirium tremens, ni convulsiones (sería severo). Probablemente necesitará una dosis algo más alta de diazepam para controlar los síntomas. Las demás opciones no son clínicamente compatibles.

Un hombre de 18 años tiene la idea de que algunas personas quieren dañarlo. Previamente a esto presentaba retraimiento social. En el último tiempo el cuadro empeora, agregándose alucinaciones de voces, que lo insultan y ha descuidado significativamente su higiene personal. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia**
- b) Personalidad esquizotípica
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno esquizoafectivo
- e) Depresión psicótica

Una paciente de 22 años presenta ansiedad persistente, relacionada a abandonar la casa sola, por miedo a que le pase algo, sin recibir ayuda de sus familiares, lo que se ha agravado en el último tiempo. Por esto abandonó sus estudios hace un mes y en general ha visto seriamente afectada su vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fobia social
- b) Trastorno de angustia generalizada
- c) Trastorno de personalidad dependiente
- d) Trastorno de angustia
- e) Agorafobia**

Es una agorafobia clásica: miedo a no recibir ayuda.

Una paciente de 50 años se siente atrapada en lugares como estacionamientos, autopistas, los lugares al aire libre y los lugares cerrados, como ascensores. Por esto, ha dejado de salir de su casa. Además tiene cuadros de angustia episódica, con marcado miedo a perder el control. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Agorafobia
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Trastorno de angustia**
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Fobia específica

Tiene un trastorno de angustia (angustia episódica = crisis de angustia y miedo a perder el control) con agorafobia (miedo a los lugares descritos y evitación). Es una mala pregunta, ya que ambas respuestas son correctas, pero prima el diagnóstico basal, que es el T. de angustia.

Un paciente de 60 años, con antecedente de depresión, en tratamiento con paroxetina 40 mg en la noche y clonazepam 0,5 mg en la noche, hace 7 días disminuyó la dosis de los fármacos a la mitad. Hace 4 días inicia un cuadro de malestar general, asociado a inquietud, insomnio, sensación de pinchazos eléctricos en los brazos y miedo a morir. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Acatisia
- b) Síndrome de discontinuación de antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina**
- c) Síndrome de privación de benzodiacepinas
- d) Manía aguda
- e) Delirium

Una paciente de 23 años, en tratamiento antidepresivo, desde hace 15 días, consulta por un cuadro paranoide, asociado a expansividad. Además presenta disminución de los requerimientos de sueño, irritabilidad, agresividad y aumento de la actividad psicomotora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Acatisia
- b) Esquizofrenia
- c) Depresión psicótica
- d) Trastorno bipolar**
- e) Trastorno de personalidad limítrofe

Es una manía aguda, en contexto del uso de antidepresivos. Por tanto es un trastorno bipolar.

Diciembre 2017

102) Un paciente presenta dolor abdominal y vómitos desde hace 5 días, y tiene una actitud muy demandante y agresiva, solicitando la realización de exámenes y administración de medicamentos. En una ocasión fue sorprendido tomando laxantes y adulterando la temperatura del termómetro. Además, hace un año estuvo hospitalizado por un cuadro similar, hecho que él no refirió en la consulta. Al indagar un poco más, se concluye que no tiene una causa orgánica que explique sus síntomas, pero que tampoco hay una ganancia evidente para él. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno por hipocondría
- b) Trastorno de somatización
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Episodio psicótico breve
- e) Trastorno facticio**

103) Una paciente presenta sensación de opresión precordial intensa, asociada a disnea, vértigo y dificultad para ver, que sucede de manera episódica, con varias recurrencias en el último tiempo. Está muy preocupada y además tiene mucho miedo a morir de un infarto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno de ansiedad social
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Agorafobia
- d) Trastorno de pánico**
- e) Trastorno conversivo

104) Una mujer de 30 años se preocupa mucho por las finanzas y la salud de su familia. Además, le angustia que alguno de sus familiares pudiera quedarse sin trabajo o que la economía decayera. Refiere estar pasando por un periodo de estrés laboral y estar estresada porque muchas cosas dependen de ella, tanto en su trabajo, como en su familia. Refiere que en el último tiempo, lo único que la mantiene más tranquila es tomar un poco de clonazepam, el que consume 2 a 3 veces por semana. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno obsesivo compulsivo
- b) Trastorno de pánico
- c) Trastorno de personalidad dependiente
- d) Reacción adversa a las benzodiazepinas
- e) Trastorno de ansiedad generalizada**

105) Un paciente esquizofrénico, recién diagnosticado, inicia tratamiento con risperidona. Al tercer día, inicia un cuadro de disestesias en las extremidades inferiores, asociadas a temblor, inquietud y cambio continuo de posición. Se muestra muy incómodo y angustiado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Parkinsonismo por fármacos
- b) Distonía aguda
- c) Disquinesia aguda
- d) Acatisia**
- e) Manía aguda

106) Un paciente de 21 años no sale de su casa por miedo a encontrarse con alguien que conozca y que le haga preguntas sobre su vida. Incluso desconecta el teléfono, para evitar que sus familiares lo llamen y le hagan preguntas. Se siente muy incómodo por lo que pudieran pensar de él las demás personas. Desde el colegio era muy tímido, pero esto empeoró al entrar a estudiar sus estudios superiores y actualmente afecta significativamente su vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Depresión psicótica
- b) Trastorno de ansiedad social**
- c) Trastorno obsesivo compulsivo
- d) Esquizofrenia
- e) Trastorno delirante crónico

107) Un paciente es despedido de su trabajo, luego de ser sorprendido robando. Evoluciona con paresia de ambas manos. Al examen neurológico no tiene alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno conversivo**
- b) Trastorno facticio
- c) Trastorno de somatización
- d) Trastorno adaptativo
- e) Trastorno disociativo

108) Un paciente de 54 años está seguro de que su esposa lo engaña, lo que confirma con un cambio de actitud que ella ha tenido en el último tiempo. Además cree saber con quién lo engaña, ya que se ha encontrado con

el sujeto en la calle y siempre mira para abajo. La esposa y los familiares niegan los hechos, pero están preocupados por lo que pasa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno de personalidad esquizoide
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno obsesivo compulsivo
- d) Trastorno delirante crónico**
- e) Trastorno bipolar

109) Una paciente de 58 años ha tenido gran conflicto con la comunidad del edificio en que vive y también con la administración. Además, se la ha visto vociferando en los pasillos. Ella refiere que existe una asociación ilícita para explotar personas, en la que estarían involucrados el conserje, el administrador y varios de los copropietarios del edificio. Fuera de eso, no hay mayor afectación y se desenvuelve normalmente en su trabajo. Los familiares niegan las acusaciones. Al ser consultada dirigidamente, ella refiere el antecedente de consumir marihuana alrededor de una vez al mes. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión psicótica
- b) Trastorno delirante crónico**
- c) Esquizofrenia
- d) Psicosis inducida por drogas
- e) Trastorno bipolar

110) Una paciente de 42 años, que 2 meses después de una separación conyugal, evoluciona con un cuadro de delirio paranoide y alucinaciones auditivas. Además presenta marcada tristeza, anhedonia, irritabilidad y culpa patológica. Como antecedentes psiquiátricos, ella sufrió una depresión postparto y uno de sus tíos está en tratamiento con litio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Depresión psicótica
- b) Trastorno bipolar
- c) Trastorno esquizoafectivo
- d) Esquizofrenia**
- e) Trastorno esquizoide de la personalidad

111) Un hombre de 40 años acaba de terminar su tercer matrimonio, por lo que está pasando por un mal momento. Tiene además algunos problemas en su trabajo y su historial académico, laboral y también familiar siempre ha tenido dificultades. Como antecedente, refiere que cuando niño sufrió un accidente en que él resultó herido y su padre falleció. Él refiere que no le gustan los desafíos a largo plazo, y prefiere enfocarse en tareas a corto plazo, ya que las cosas a largo plazo no le resultan bien. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad evitativo
- b) Trastorno de conducta
- c) Trastorno por déficit atencional**
- d) Trastorno de estrés postraumático
- e) Ciclotimia

112) Una paciente de 28 años tiene problemas frecuentes con sus familiares, con quienes suele pelearse y distanciarse, pero luego de algunos meses retoma la relación, como si nada hubiese pasado. Además tiene antecedente de haber ingerido medicamentos con intención suicida y haberse autoagredido. Además ha cambiado varias veces de trabajo, ya que le cuesta atenerse a las normas, lo que le ha generado problemas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno adaptativo
- b) Trastorno de personalidad límite**

- c) Trastorno bipolar
- d) Distimia
- e) Depresión mayor

113) ¿Cuál es el riesgo principal del consumo de marihuana entre los 12 y los 18 años de edad?

- a) Riesgo de dependencia a la marihuana
- b) Riesgo de intoxicación aguda
- c) Desarrollo de esquizofrenia
- d) Disminución de la motivación escolar**
- e) Desarrollo de alcoholismo

114) Una mujer de 18 años subió a un taxi, en el que el taxista se desvió del camino que debía tomar, siendo luego agredida por él. Es encontrada por terceras personas en un sitio eriazo, con evidentes signos de haber sido abusada sexualmente. Fue trasladada al Servicio Médico Legal, donde se constató la violación. Sin embargo, ella no recuerda nada de lo sucedido, recordando solo cuando estaba en el taxi y luego cuando estaba en el Servicio Médico Legal. Ella se muestra muy preocupada, pero no logra recordar nada de lo que aconteció entremedio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno conversivo
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Trastorno facticio
- d) Trastorno adaptativo
- e) Trastorno disociativo**

115) Una paciente de 50 años consulta por dolor abdominal, asociado a náuseas y malestar general. Además ha tenido disestesias en la piernas y sensación de frío, más otras molestias inespecíficas. Refiere estar angustiada por lo que le sucede y relata que está pasando por un periodo de estrés. Se solicitan exámenes que descartan patología orgánica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno somatomorfo
- b) Trastorno conversivo
- c) Trastorno hipocondríaco
- d) Trastorno facticio
- e) Depresión**

116) Un paciente de 21 años, abandonó a los 18 años su hogar, viviendo solo en la calle. Tiene la idea de ser un enviado de Dios, con la misión de salvar al mundo y dice que los ángeles le susurran al oído diciéndole cómo hacerlo. Los familiares refieren que empezó hace 3 años con esto y que no ha cambiado mucho desde entonces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Esquizofrenia**
- c) Trastorno bipolar
- d) Trastorno de personalidad esquizoide
- e) Trastorno de conducta

Julio 2018

Un paciente está en tratamiento con sertralina, desde hace 1 mes, por un episodio depresivo mayor. Desde hace 2 semanas anda más irritable y agresivo, con peleas frecuentes con sus familiares. Además, fue despedido de su trabajo porque insultó a su jefe y se ha involucrado

con 4 parejas sexuales.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

- a. Esquizofrenia
- b. Trastorno bipolar**
- c. Trastorno esquizoafectivo
- d. Depresión severa con síntomas psicóticos
- e. Trastorno de personalidad

¿Cuál es el fármaco de mantención, de elección para un paciente masculino de 76 años, hipertenso, con diagnóstico de depresión recurrente?

Seleccione una:

- a. Trazodona
- b. Mirtazapina
- c. Citalopram**
- d. Venlafaxina
- e. Amitriptilina

Un paciente de 71 años, viudo, presenta cuadro de ánimo bajo y disminución de sus actividades. Él refiere que se siente bien, sin embargo, la hija refiere que puede estar deprimido. Se realiza un test de Minimental, que resulta normal y una prueba GDS que resulta 12/15 puntos. ¿Cuál es el fármaco de elección?

Seleccione una:

- a. Fluoxetina
- b. Sertralina**
- c. Mirtazapina
- d. Diazepam
- e. Amitriptilina

Un paciente de 23 años, luego de una ruptura sentimental con su pareja, evoluciona con amnesia parcial de lo ocurrido y una actitud extraña. A la entrevista está perplejo y resignado a lo que estaba sucediendo. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Trastorno conversivo
- b. Trastorno disociativo**
- c. Trastorno somatomorfo
- d. Episodio psicótico reactivo
- e. Trastorno depresivo

Una paciente de 28 años, diagnosticada de trastorno esquizoafectivo hace poco, está recibiendo hace 7 días risperidona 5 mg al día. Evoluciona con marcada inquietud e incomodidad al permanecer en una posición, por lo que debe cambiar de posición con frecuencia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

- a. Parkinsonismo por fármacos
- b. Distonía aguda
- c. Discinesia tardía
- d. Acatisia**
- e. Síndrome neuroléptico maligno

Una paciente de 18 años, que hace 6 meses se siente angustiada, con ánimo bajo. Ha bajado de peso e ingiere muy pocas calorías al día. Es muy preocupada por el peso y refiere que se pone triste y se angustia al mirarse en el espejo, ya que se encuentra gorda. Al examen físico se ve enflaquecida, es de talla pequeña, pero usa ropa 2 números más grandes y está en amenorrea hace 3 meses. Le encanta cocinar y recibir críticas positivas sobre su comida por las demás personas. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Anorexia nervosa
- b. Bulimia nervosa
- c. Trastorno por atracones
- d. Dismorfofobia
- e. Depresión mayor

Una paciente de 42 años tiene licencia médica desde hace 3 meses, por un cuadro de opresión precordial, disestesias en las piernas y dolor abdominal, asociado a náuseas, que afectan significativamente su vida. Tiene ánimo bajo y se ha sentido angustiada por esto. Ha sido estudiada, en múltiples ocasiones, en busca de una causa orgánica, sin embargo, los exámenes han resultado normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

- a. Episodio depresivo mayor
- b. Trastorno conversivo
- c. Trastorno hipocondríaco
- d. Trastorno somatomorfo
- e. Trastorno disociativo

Un paciente de 32 años es diagnosticado de depresión mayor, hace una semana, por lo que se inició sertralina 100 mg al día. Evoluciona con malestar general, desorientación, a lo que se ha agregado dolor abdominal, asociado a diarrea y vómitos. Al examen físico está desorientado y soporoso, con rigidez muscular en las extremidades. Su temperatura es: 38,5°C y su PA: 160/100 mmHg. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Síndrome colinérgico
- b. Síndrome anticolinérgico
- c. Síndrome adrenérgico
- d. Síndrome neuroléptico maligno
- e. Síndrome serotoninérgico

Un paciente de 36 años, soltero, que aún vive con sus padres. Casi no sale de la casa, porque se siente observado en la calle. Además, tiene dificultades para dormir, porque siente que sus vecinos se pueden apoderar de sus pensamientos. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Trastorno evitativo de la personalidad
- b. Trastorno esquizotípico de la personalidad
- c. Trastorno esquizoafectivo
- d. Esquizofrenia
- e. Trastorno delirante crónico

Una adolescente se intenta suicidar, ingiriendo 60 comprimidos de amitriptilina. ¿Cuál es el examen más adecuado para determinar su pronóstico?

Seleccione una:

- a. Electrocardiograma

- b. Gama-glutamyl-transferasa
- c. Bilirrubinemia
- d. Gases arteriales
- e. Creatinfosfoquinasa

Una paciente de 19 años, ha sido hospitalizada 8 veces por hipoglicemias, sin una causa clara, que han requerido hospitalización y que se resuelven fácilmente. En la última hospitalización, fue sorprendida inyectándose una dosis de insulina en el baño. Sin embargo, ella niega abiertamente este hecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una o más de una:

- a. Trastorno disociativo
- b. Trastorno conversivo
- c. Trastorno somatomorfo
- d. Trastorno facticio**
- e. Episodio psicótico

Una paciente de 30 años, embarazada con 32 semanas de gestación presenta un episodio depresivo mayor, sin síntomas psicóticos ni ideación suicida. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

Seleccione una:

- a. Terapia electroconvulsiva
- b. Sertralina**
- c. Mirtazapina
- d. Venlafaxina
- e. Amitriptilina

Diciembre 2014

- 137. Paciente que usa carbonato de litio. ¿Qué fármaco potencia la intoxicación por litio? Atorvastatina, Quetiapina
- 138. Joven 20 años que tras quiebre sentimental está más triste. ¿Trastorno adaptativo?
- 139. Mujer que le duele todo, nada orgánico. ¿Trastorno de somatización?
- 140. Hombre que consumió cocaína hace 2 semanas, actualmente con pensamiento rápido, verborreico, conduce a grandes velocidades. De repente llora. ¿Dg? Privación de cocaína, trastorno bipolar
- 141. Mujer que no quiere salir a la calle por temor a que la ataquen: agorafobia
- 142. Joven que se pone nervioso en la universidad y entrevistas: fobia social
- 143. Manejo de TOC: ¿paroxetina?
- 144. Mujer joven en tto con risperidona. Le suben la dosis por alucinaciones visuales y auditivas. No se puede quedar quieta. ¿Dg? Acatisia.
- 145. Mujer que vive en la calle, come basura, no se baña, habla incoherencias. Esquizofrenia
- 146. Paciente que se lava las manos seguido, algunas veces se devuelve a la casa a lavarse las manos, sabe que está mal que lo haga y le angustia esto, pero no puede evitarlo. TOC

Diciembre 2016

- 146. Cuidado de esposa: ¿facticio?
- 147. Paciente que no duerme: ¿clorfenamina?
- 148. Paciente con dolores y que se desmaya: somatización
- 149. Piensa que está enamorado de él: delirante crónico
- 150. Paciente que se corta, con varios hijos: personalidad limítrofe
- 151. Distonía aguda: lorazepam
- 152. Consumo de sertralina: serotoninérgico
- 153. Síntomas depresivos en embarazo: citalopram
- 154. Examen de grado, nerviosa frente a público: fobia social
- 155. Paciente con síntomas depresivos: pedir TSH
- 156. Trastorno de pánico: sertralina
- 157. Paciente que se aleja de su hijo: TOC
- 158. Niña con opo desafiante

Salud pública

1. Se realiza un estudio de casos y controles que busca establecer la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y cáncer. Luego de analizar los datos se obtiene que el Odds Ratio 1,3 con intervalo de confianza al 95% con valores entre 0,86 y 2,1. Con estos resultados se puede afirmar que
 - a. Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer
 - b. Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer, pero que no es estadísticamente significativa
 - c. Existe una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer, pero este resultado no es extrapolable a otras poblaciones
 - d. Las personas que tienen cáncer consumen un 30% más de anticonceptivos orales
 - e. Las personas que usan anticonceptivos orales, tienen 1,3 veces más riesgo de desarrollar cáncer.
2. Se realiza un estudio en el que se busca la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de hipertensión arterial, el cual concluye que existe mayor desarrollo de hipertensión arterial en pacientes que utilizaban anticonceptivos orales. Sin embargo, las pacientes que recibieron anticonceptivos orales fueron controladas 3 veces más que las pacientes que no recibieron esta intervención. ¿Qué sesgo se encuentra presente en el estudio descrito?
 - a. Sesgo de selección
 - b. Sesgo de notificación
 - c. Sesgo de exclusión
 - d. Sesgo de vigilancia
 - e. Sesgo del evaluador
3. ¿Cuál es el mejor diseño de estudio epidemiológico que entrega evidencia de mayor calidad, para buscar la asociación entre una exposición y una enfermedad en una población?
 - a. Estudio de serie de casos
 - b. Estudio de series temporales
 - c. Estudio de casos y controles
 - d. Estudio de cohorte
 - e. Estudio clínico no randomizado
4. Paciente de 45 años, trabajador de una fábrica textil, sufre un accidente, resultado con atrición del brazo, en una de las máquinas, mientras se encontraba trabajando. ¿Quién cubre los gastos médicos de este paciente?
 - a. El empleador
 - b. 50% por parte de FONASA y 50% por parte del trabajador
 - c. La institución de Salud Previsional
 - d. La Mutual de Seguridad
 - e. El Estado
5. ¿Cuál es el mejor indicador para determinar si un test de tamizaje, para la detección de cáncer, es efectivo?

- a. Disminución de la tasa de incidencia
 - b. Disminución de la tasa de prevalencia
 - c. Disminución de la tasa de letalidad
 - d. Disminución de la tasa de mortalidad
 - e. Aumento de la supervivencia de la enfermedad
6. ¿A que tipo de medida corresponde la vacunación contra una enfermedad, en la historia natural de una enfermedad?
- a. Promoción de salud
 - b. Protección específica
 - c. Erradicación de la enfermedad
 - d. Diagnóstico oportuno
 - e. Tratamiento precoz
7. La Subsecretaría de Redes Asistenciales delega sus funciones a nivel territorial en:
- a. La Superintendencia de Salud
 - b. La Secretaría Regional Ministerial de Salud
 - c. La Dirección del Servicio de Salud
 - d. El hospital autogestionado
 - e. La Dirección de Salud Comunal
8. ¿Cuál de los siguientes parámetros es más adecuado para determinar la gravedad de una enfermedad?
- a. Años de vida saludable perdidos
 - b. Tasa de mortalidad
 - c. Tasa de letalidad
 - d. Tasa de incidencia
 - e. Tasa de ataque
9. Según los criterios de causalidad de Hills Bradford, ¿cuál es requisito para establecer una asociación causal?
- a. Fuerza de asociación
 - b. Plausibilidad biológica
 - c. Respuesta dosis dependiente
 - d. Secuencia temporal
 - e. Asociación estadística
10. ¿Cuál es el mejor indicador para determinar el éxito de una campaña de vacunación?
- a. Tasa de incidencia
 - b. Tasa de prevalencia
 - c. Tasa de hospitalizaciones
 - d. Tasa de mortalidad
 - e. Tasa de cobertura de vacunación

11. ¿Qué tipo de sesgo se trata de evitar, al validar previamente los cuestionarios en un estudio?
- a. Sesgo de memoria
 - b. Sesgo de información
 - c. Sesgo de confusión
 - d. Sesgo de selección
 - e. Sesgo del entrevistador
12. Se busca la asociación entre distintos parámetros con el cáncer de tiroides, en un estudio de caso – control, con el Odds Ratio (OR), más un intervalo de confianza (IC) al 95%. ¿Qué factor es más importante en esta asociación?
- a. Antecedentes familiares: OR: 1,88 ; IC [0,56 – 4,01]
 - b. Edad: OR: 2,6 ; IC [0,95 – 3,17]
 - c. Sexo masculino: OR: 0,56 ; IC [0,33 – 0,87]
 - d. Exposición a radiación: OR: 1,52 ; IC [0,91 – 2,01]
 - e. Tiroiditis de Hashimoto: OR: 4,6 ; IC [0,7 – 6,2]
13. ¿A qué tipo de medida corresponde el screening de fenilcetonuria que se hace a todos los recién nacidos en Chile?
- a. Promoción de la salud
 - b. Protección de la salud
 - c. Prevención primaria
 - d. Prevención secundaria
 - e. Prevención terciaria
14. La erradicación del *Helicobacter pylori* reduce significativamente la recidiva de la úlcera gastroduodenal, en comparación a aquellos casos en que no se erradica. Este es uno de los principales argumentos para afirmar la relación causal entre esta bacteria y dicha patología. ¿A qué criterio de causalidad de Bradford Hills corresponde?
- a. Asociación
 - b. Relación dosis efecto
 - c. Plausibilidad biológica
 - d. Cesación de la exposición
 - e. Congruencia con el conocimiento científico existente
15. En un estudio de cohortes sobre el tabaco y cáncer de pulmón, luego de 20 años, se determinó que 65 de 2.000 pacientes fumadores enfermaron de cáncer. ¿Qué medida es posible calcular con esta información?
- a. Incidencia acumulada en los pacientes fumadores
 - b. Prevalencia en los pacientes fumadores
 - c. Riesgo relativo
 - d. Odds ratio
 - e. Tasa de ataque en los pacientes fumadores

16. ¿Cuál es la mejor estrategia de vigilancia para una enfermedad infectocontagiosa, que se transmite a través de la contaminación de acuíferos?
- a. Vigilancia activa
 - b. Vigilancia pasiva
 - c. Vigilancia estacional
 - d. Encuestas
 - e. Centros centinelas
17. Si se quiere determinar la utilidad de una prueba diagnóstica, ¿Qué técnica es la más adecuada?
- a. Elaboración de curvas de ROC
 - b. Determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba
 - c. Determinar la sensibilidad de la prueba y la prevalencia de la enfermedad
 - d. Determinar la especificidad y el valor predictivo negativo de la prueba
 - e. Determinar el número necesario para tratar (NNT)
18. En Chile, el financiamiento de la seguridad social relacionada a los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales viene dado principalmente por:
- a. El aporte de Fonasa y las Isapres
 - b. Financiamiento tripartito (Estado, trabajadores y empleadores)
 - c. El 7% de aporte de los trabajadores
 - d. El aporte estatal directo
 - e. Aporte patronal de 0,95% del sueldo del trabajador
19. Si se mejorara el tratamiento de una enfermedad crónica, y se mantiene la incidencia, ¿que pasaría con la prevalencia?
- a. Aumenta
 - b. No se modifica
 - c. Disminuye
 - d. No se puede saber
 - e. Depende de la enfermedad
20. ¿A qué indicador corresponde la siguiente afirmación “De 100 pacientes tuberculosos, 13 fallecen”?
- a. Valor absoluto
 - b. Razón
 - c. Frecuencia relativa
 - d. Índice
 - e. Tasa
21. ¿Qué tipo estudio es el más adecuado para determinar el desarrollo de obesidad en un grupo de escolares a lo largo de un determinado tiempo?
- a. Estudio de prevalencia
 - b. Estudio de incidencia
 - c. Estudio de caso control
 - d. Estudio de cohortes

- e. Ensayo clínico controlado
22. En la vigilancia de las enfermedades transmisibles, ¿cuál es el parámetro que se utiliza para definir si la notificación de los casos de dicha enfermedad es de tipo diaria o inmediata?
- a. Periodo de incubación
 - b. Oportunidad de control y prevención
 - c. Letalidad y prevalencia
 - d. Número de casos
 - e. Disponibilidad de vacuna
23. Se realiza un estudio que muestra que en la comuna A, el consumo de drogas es de un 40%, mientras que en la comuna B, es de 10%. El diseño de estudio más adecuado, para determinar las causas de estas diferencias, es:
- a. Ecológico
 - b. Descriptivo
 - c. Analítico
 - d. De prevalencia
 - e. De incidencia
24. Se quiere realizar un estudio para determinar las patologías más frecuentes, que afectan a los niños de una determinada comuna, además de su edad, peso y talla. ¿Qué tipo de estudio es el más adecuado para ello?
- a. Estudio analítico
 - b. Estudio descriptivo
 - c. Estudio prospectivo
 - d. Estudio retrospectivo
 - e. Comunitario cuasiexperimental
25. Un paciente de 42 años, que trabaja en un aserradero, comienza con un cuadro de dificultad respiratoria, con tos y expectoración, asociada a respiración sibilante. Luego de estudiarlo, es diagnosticado de asma no laboral. Sin embargo, él discrepa de este diagnóstico, ya que lo considera de origen laboral. ¿A qué institución puede apelar contra esta determinación?
- a. Superintendencia de Seguridad Social
 - b. Servicio de Salud de su comuna
 - c. Instituto de Salud Pública
 - d. Fonasa
 - e. Ministerio de Salud
26. ¿Cuál de las siguientes opciones justifica la realización de pruebas tamizaje para una enfermedad?
- a. Baja frecuencia
 - b. Existencia de un tratamiento eficaz disponible
 - c. Alta virulencia
 - d. Corta duración y luego mejoría

- e. Escasas complicaciones y repercusiones en la salud
27. ¿Qué tipo de estudio es el que entrega una mejor información para determinar la relación de causalidad entre un factor de riesgo y una patología, en una determinada población?
- a. Estudio de caso control
 - b. Estudio ecológico
 - c. Estudio de cohortes
 - d. Estudio descriptivo
 - e. Estudio de intervención comunitaria o cuasiexperimental
28. ¿Mediante qué estrategia de vigilancia se lleva a cabo la investigación en una intoxicación alimentaria?
- a. Vigilancia activa
 - b. Vigilancia de centros centinela
 - c. Vigilancia pasiva
 - d. Tamizaje
 - e. Vigilancia comunitaria
29. Se desea evaluar la efectividad de un nuevo antihipertensivo de la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, para esto, ¿Qué tipo de estudio escogería? Pregunta 5 2013 primera parte
- a. Caso control
 - b. Meta-análisis
 - c. Cohorte
 - d. Corte transversal
30. Acude a control una paciente de 26 años, trae el resultado de su papanicolau que es informado como "muestra satisfactoria, sin atipías". ¿A qué tipo de prevención corresponde este examen? Pregunta 21 diciembre 2013 primera parte
- a. Prevención específica
 - b. Promoción de salud
 - c. Prevención secundaria
 - d. Prevención terciaria
 - e. Prevención primaria
31. La medida que mejor estima la diferencia de riesgo entre un grupo expuesto y otro no expuesto a un factor de riesgo en una misma población es: (2013 diciembre pregunta 13)
- a. Riesgo atribuible
 - b. Odds Ratio
 - c. Riesgo Relativo
 - d. Incidencia acumulada
 - e. Razón de incidencias

32. Durante el año 2012 en Chile se presentaron 60 casos de meningitis causadas por la Neisseria Meningitidis serotipo W135, de los cuales 20 fallecieron por causa atribuible a esta enfermedad. Por lo tanto la letalidad de la N.Meningitidis serotipo W135 durante el 2013 fue: (2013 diciembre pregunta 29)
- a. 25%
 - b. 66%
 - c. 50%
 - d. 33%**
 - e. 75%
33. Durante el año 2012 hubo una natalidad en Chile de 13.9 por cada 1000 habitantes y en Estados Unidos de 12.5 por cada 1000 habitantes. Se desean comparar ambos índices, ¿Cuál de los siguientes parámetros es más útil para este propósito? (42 2013 diciembre segunda parte)
- a. Razón
 - b. Proporción
 - c. Número absoluto
 - d. Índice
 - e. Tasa**
34. Desde el año 2005 existe la ley que obliga a los automovilistas a utilizar el cinturón de seguridad con el objetivo de disminuir traumatismos asociados a accidentes. Con respecto a esta ley, en términos de prevención, corresponde a ☺2013 diciembre segunda parte pregunta 80
- a. Prevención primaria**
 - b. Promoción de salud
 - c. Prevención secundaria
 - d. Prevención terciaria
 - e. Control sanitario
35. Múltiples estudios han determinado que existe un riesgo relativo entre 3 y 4 para el desarrollo de enfermedad de Parkinson, ante la exposición a pesticidas. ¿A cuál de los criterios de causalidad de Hills corresponde este proceso?
- a. Replicabilidad
 - b. Asociación**
 - c. Efecto dosis dependiente
 - d. Plausibilidad biológica
 - e. Congruencia
36. Dentro del sistema institucional de salud chileno, ¿Cuál es la institución encargada del registro de medicamentos y la farmacovigilancia?
- a. Central Nacional de Abastecimiento
 - b. Instituto de Salud Pública**
 - c. Seremi de Salud
 - d. Superintendencia de salud
 - e. Servicio de Salud

37. ¿A qué tipo de medida corresponde la instalación de las salas IRA (infecciones respiratorias agudas) y las salas ERA (enfermedades respiratorias del adulto), en la atención primaria, durante la campaña de invierno?
- a. Prevención primaria
 - b. Prevención secundaria
 - c. Prevención terciaria
 - d. Protección específica
 - e. Protección de la salud
38. Una paciente de 80 años, autovalente, que vive con su hija, es incorporada a un estudio, sin su consentimiento. Sin embargo el consentimiento fue prestado por su hija. ¿Qué principio de la bioética ha sido vulnerado?
- a. Autonomía
 - b. Justicia
 - c. Doble efecto
 - d. No maleficencia
 - e. Beneficencia
39. ¿A cuál de las garantías del GES (Garantías Explícitas de Salud) corresponde el registro de los profesionales y prestadores en la superintendencia de salud?
- a. Protección financiera
 - b. Accesibilidad a la atención
 - c. Oportunidad
 - d. Calidad en la atención
 - e. Universalidad
40. ¿En qué lugar de Chile se producen casos autóctonos de dengue?
- a. En la Isla de Juan Fernández
 - b. En la zona norte
 - c. En la zona austral
 - d. En la Isla de Pascua
 - e. En las zonas limítrofes con otros países
41. ¿Cuál es el mejor tipo de estudio para enfermedades poco prevalentes?
- a. Serie de casos
 - b. Estudio de cohortes
 - c. Ensayo clínico
 - d. Estudio ecológico
 - e. Estudios de caso-control
42. ¿Para qué se utiliza la aleatorización?
- a. Para que el evaluador pueda escoger los grupos
 - b. Para que el evaluador y el sujeto de estudio den información confiable, sin sesgos
 - c. Para evitar sesgos de selección
 - d. Para asegurar que la muestra sea representativa de la población general
 - e. Para disminuir los errores causados por el azar

43. ¿Cómo se financia el seguro público de salud?
- a. El aporte estatal, desde los impuestos generales
 - b. El aporte tripartito del estado, los empleadores y trabajadores
 - c. El aporte de las mutuales
 - d. El 7% de los trabajadores
 - e. El aporte de los empleadores
44. Las instituciones de salud previsional y el seguro público de salud tienen en salud que:
- a. Administrar el seguro de cotización individual
 - b. Administran el seguro público de salud
 - c. Administrar los fondos para las garantías de salud, comprendidas en el plan AUGE
 - d. Administran el seguro general de salud
 - e. Dan prestaciones de salud
45. ¿Qué institución es la encargada de acreditar y autorizar a los prestadores individuales de salud y a los centros de salud?
- a. La superintendencia de seguridad social
 - b. La autoridad regional sanitaria
 - c. La superintendencia de salud
 - d. Fonasa
 - e. La municipalidad
46. ¿Qué instituciones están encargadas de administrar el seguro de la salud laboral, accidentes del trabajo y del trayecto?
- a. Instituciones de Salud Previsional
 - b. Instituto de Salud Laboral
 - c. Superintendencia de Seguridad Social
 - d. Instituto Nacional de Previsión
 - e. Mutualidades de empleadores
47. ¿Qué significa que una enfermedad se endémica?
- a. Que mantiene una frecuencia relativamente estable en la zona, con sus variaciones estacionales
 - b. Aquella que presenta muchos más casos, a los habituales para la zona geográfica
 - c. Que se extiende a todos los lugares del planeta: Pandemia
 - d. Aquella que presenta varios casos, relacionados entre sí, en un corto periodo de tiempo: Epidemia
 - e. Aquella que presenta casos escasos, sin poder identificar un patrón
48. ¿Qué rama de la Salud Pública se preocupa de obtener información, a través del contraste de hipótesis?
- a. Epidemiología descriptiva
 - b. Bioestadística
 - c. Prevención de salud
 - d. Epidemiología analítica
 - e. Vigilancia epidemiológica
49. ¿Cuál es el indicador que más se utiliza para reflejar el nivel de desarrollo de los países?
- a. Tasa de morbilidad general
 - b. Tasa de mortalidad general

- c. Tasa de fecundidad
- d. Tasa de natalidad
- e. Tasa de mortalidad infantil

DERMATOLOGÍA

Diciembre 2013

13) Un paciente de 8 años, sin antecedentes, es traído por presentar múltiples pápulas de 3-4 milímetros de diámetro en manos, tórax y extremidades, algunas de ellas agrupadas en forma lineal, asociado a prurito ocasional. El diagnóstico más probable

- a) Molusco contagioso
- b) Fibromatosis
- c) Liquen plano
- d) Verrugas planas**
- e) Dermatitis atópica

46) Paciente de 29 años, cursando embarazo de 38 semanas, consulta por aparición de vesículas dolorosas a nivel vulvar, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecian vesículas con base eritematosa a nivel vulvar. El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:

- a) Cultivo viral
- b) PCR para virus herpes**
- c) Biopsia
- d) Inmunoglobulina G para virus herpes
- e) Tinción para virus herpes

48) Un paciente de 6 años, con historia de 5 días de odinofagia intensa asociada a secreción purulenta y sensación febril que durante el último día se acompañó de rash papular eritematoso que, es más intenso en pliegues. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

- a) Hemograma
- b) IgM para virus Epstein Barr
- c) Panel viral
- d) Cultivo de secreción faríngea****
- e) Test pack para Streptococo grupo A**

90) Un paciente de 8 años presenta aparición de lesiones en la cara, desde hace 3 días, las que han aumentado. Al examen físico se aprecia lo siguiente:

El diagnóstico más probable es:

- a) Acné
- b) Rosácea
- c) Erisipela
- d) Impétigo**
- e) Ántrax



18) Embarazada de 30 semanas, sin antecedentes, consulta por lesiones eritematosas en antebrazos, genitales, manos y tronco, asociadas a prurito. Al examen físico se aprecian lesiones eritematosas pápulares y maculares en patrón sinuoso, con signos de grataje, por lo que se decide realizar un ácaro test, que resulta positivo. El tratamiento de elección, en este caso es:

- a) Permetrina oral
- b) Puvaterapia
- c) Corticoides locales
- d) Permetrina tópica al 5%
- e) Vaselina azufrada**

28) Hombre de 18 años, sin antecedentes, con cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, que durante el último día se ha asociado a prurito generalizado. Al examen físico destaca presencia de lesiones papulares y vesículas muy pruriginosas en tronco y extremidades, no asociado a otros hallazgos. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Clorfenamina oral
- b) Aspirina oral
- c) Aciclovir oral**
- d) Vacuna contra virus herpes 3
- e) Inmunoglobulina G no específica

86) Una paciente de 70 años, diabética en tratamiento farmacológico y con obesidad, consulta por lesiones en el tórax, asociadas a prurito. Al examen físico de pliegues mamarios se encuentran lesiones eritematosas asociadas a rezumación con pequeñas pústulas blancas. El diagnóstico más probable es:

- a) Acrocordones
- b) Intértrigo candidiásico**
- c) Impétigo bulloso
- d) Tiña corporis
- e) Psoriasis

Julio 2015

28) Un paciente alcohólico, de 50 años, en situación de calle, consulta por dolor en el antebrazo derecho, muy intenso. Al examen físico se aprecia una lesión grande en el antebrazo derecho, con áreas violáceas, que crepita a la palpación. Su frecuencia cardíaca es de 108x', con PA: 90/60 mmHg y su hemograma muestra leucocitosis de 17.000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Loxocelismo cutáneo
- b) Celulitis
- c) Úlcera por presión
- d) Fascitis necrosante**
- e) Miositis necrosante

88) Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, consulta por aparición de placas eritematodescamativas en las rodillas y los codos. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis de contacto
- b) Psoriasis vulgar**
- c) Tiña corporis

- d) Pitiriasis rosada de Gilbert
- e) Dermatitis atópica

89) Adolescente de 20 años, consulta por la siguiente lesión, en el pliegue interglúteo, que presenta prurito y ardor:

El diagnóstico más probable es:

- a) Picadura de insecto
- b) Condilomas acuminados
- c) Herpes simple**
- d) Impétigo ampollar
- e) Erisipela



90) Un niño de 7 meses nació con una mácula eritematosa, de tres cm, en la mano izquierda, la que ha ido creciendo en tamaño y espesor. Actualmente se ve de la siguiente forma:

FOTO: No encontré fotos en internet, pero la imagen era una placa, que afectaba el dorso de la mano, de color rojo, de 1 mm de alto y de 4 a 5 cm de largo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Observar evolución**
- b) Corticoides orales
- c) Corticoides locales
- d) Propanolol
- e) Cirugía

91) ¿Cuál es la conducta más adecuada ante un hombre joven, que presenta múltiples condilomas acuminados perianales?

- a) Descartar otras enfermedades de transmisión sexual**
- b) Determinar el genotipo del virus papiloma
- c) Realizar rectosigmoidoscopia
- d) Realizar tratamiento con podofilino
- e) Indicar Aciclovir oral

Diciembre 2015

21) Un lactante de 1 mes y medio de vida presenta lesiones en el tronco y en las extremidades, como se muestran en la IMAGEN. Su madre presenta lesiones similares, pruriginosas en las manos, piernas y pies.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado para el lactante?

- a) Permetrina al 5%
- b) Permetrina al 1%
- c) Vaselina líquida

d) Ivermectina i.m.

e) Vaselina azufrada al 10%

23) Un adolescente de 18 años consulta por aparición de lesiones en la zona posterior del muslo derecho, que han ido apareciendo desde hace 4 meses y que en ocasiones son algo pruriginosas. Al examen físico, se observan como en la siguiente IMAGEN. FOTO: cerca de 10 pápulas, mínimamente eritematosas. Solo en una es posible ver una umbilicación central. Las demás se ven algo borrosas. El diagnóstico más probable es:

a) Dermatitis atópica

b) Verrugas vulgares

c) Papular fibronodulares

d) Molusco contagioso

e) Acrocordones



24) Un niño de 3 años presenta habones generalizados, como se observa en la IMAGEN, muy pruriginosas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, inquieto, con las lesiones descritas. La madre refiere que había comido pescado. FOTO: habones en tronco y extremidades. El diagnóstico más probable es:

a) Urticaria aguda

b) Dermatitis de contacto alérgica

d) Dermatitis atópica

multiforme mayor



c) Anafilaxia

e) Eritema

55) Un paciente de 48 años, carpintero, sufre un corte en su mano derecha durante sus actividades laborales, que evoluciona a las 6 horas con eritema y dolor del cuarto y quinto dedos de esa mano. A las 24 horas, evoluciona con compromiso del estado general, fiebre, eritema de toda la mano, que se extiende por el antebrazo, con lesiones negruzcas en los dedos mencionados. Al examen presenta FC: 110x', PA: 90/60 mmHg, temperatura: 39 grados Celsius y las lesiones descritas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Erisipela

b) Fasceítis necrotizante

c) Miositis

d) Tétanos

e) Gangrena gaseosa

69) Una adolescente de 16 años presenta múltiples comedones en la cara, asociada a algunas pápulas y pústulas. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

- a) Prohibir el consumo de chocolates
- b) Peróxido de benzoílo tópico**
- c) Limpieza facial con jabón alcalino
- d) Terapia estrogénica
- e) Isotretinoína oral

93) Un paciente de 18 años consulta por lesiones cutáneas ubicadas en el pecho y en la espalda, que han aumentado de tamaño en el último tiempo y que en ocasiones son muy molestas. Al examen físico se observan las lesiones de la IMAGEN. El diagnóstico más probable es:

- a) Foliculitis estafilocócica
- b) Moluscos contagiosos
- c) Reacción adversa a medicamentos
- d) Eritema multiforme mayor
- e) Acné conglobata**



94) Una paciente de 48 años consulta por dolor en el dorso, muy molesto, que le dificulta el sueño, de 3 días de evolución. Al examen físico se observa una zona eritematosa en la piel de la espalda, con microvesículas, dolorosa al roce. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Aciclovir tópico
- b) Corticoides orales
- c) Imipramina oral
- d) Corticoides tópicos
- e) Valaciclovir oral**

173) Una niña de 6 años presenta gran picazón en la cabeza, desde hace 7 días. Al examen físico se observan múltiples liendres en el cabello, sin poder observar ningún piojo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Tratar con permetrina al 5% tópica
- b) Tratar con permetrina al 1% tópica**
- c) Tratar con ivermectina oral

- d) Tratar con lindano al 1% tópico
- e) No tratar mientras no se visualicen piojos

Julio 2016

12) Un niño de 20 días de edad, presenta lesiones eritematosas, con descamación en la cabeza y la zona intercililar, con descamación amarilla, de aspecto oleoso. Se ve de buen aspecto y ha subido de peso. La indicación más adecuada es:

- a) Administrar fórmula, con proteína hidrolizada, como alimentación
- b) Crema de betametasona tópica
- c) Crema de clotrimazol tópico (Esta es según la pauta)**
- d) Vaselina tópica**
- e) Antibióticos tópicos

23) Una niña de 5 años, en tratamiento con amoxicilina por una amigdalitis, evoluciona al séptimo día con fiebre y lesiones cutáneas generalizadas. Al examen físico se aprecian lesiones en tiro al blanco, asociadas a úlceras en las mucosas oral, rectal y vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Urticaria aguda
- b) Gingivoestomatitis herpética
- c) Síndrome de Steven Johnson**
- d) Escarlatina
- e) Mononucleosis infecciosa

27) Un lactante de 10 meses de edad, presenta un cuadro de fiebre hasta 37,8 grados Celsius, asociado a aparición de un exantema generalizado, de tipo macular eritematoso, de aspecto tenue. Al examen físico destacan adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores, sensibles a la palpación. El diagnóstico más probable es:

- a) Exantema súbito
- b) Eritema infeccioso
- c) Rubeola**
- d) Sarampión
- e) Exantema por citomegalovirus

43) Un paciente adulto mayor, diabético, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, como se ve en la siguiente imagen: FOTO: se ve una placa eritematosa, que sigue un dermatomo, con vesículas en su superficie. El tratamiento más adecuado es:

- a) Aciclovir 400 mg cada 8 horas, por 5 días
- b) Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 5 días**
- c) Aciclovir tópico
- d) Loratadina 10 mg al día por 5 días
- e) Flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 10 días



48) Una paciente de 26 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica hace 2 semanas. Inicialmente evoluciona bien, pero hace 12 horas presenta un cuadro de fiebre y dolor cutáneo generalizado, con eritema generalizado de la piel y compromiso de las mucosas. Hace algunas horas comienza con aparición de ampollas generalizadas. Al examen físico se observa lo mostrado en la siguiente imagen: FOTO: Se muestran las extremidades inferiores de una paciente, con eritema generalizado y la epidermis desprendida. El diagnóstico más probable es:

- a) Psoriasis eritrodérmica
- b) Escarlatina quirúrgica
- c) Pustulosis exantemática
- d) Necrosis epidermolítica tóxica**
- e) Pénfigo



70) Un lactante de 10 meses de edad, con antecedente de dermatitis del pañal presenta aparición de lesiones eritematosas y pruriginosas en el muslo izquierdo, que se muestran en la imagen: FOTO: tenía dos lesiones eritematosas, ulceradas, algo descamativas de cerca de 1 cm cada una. Tenían aspecto de una ectima. El tratamiento más adecuado es:

- a) Antimicóticos tópicos en crema
- b) Corticoides tópicos en crema
- c) Antibióticos tópicos en crema**
- d) Aciclovir tópico
- e) Vaselina tópica

71) Un paciente de 38 años con cuadro de 6 meses con aumento de volumen en región preauricular derecha. Al examen físico se constata nódulo en región preauricular de 4 cm de diámetro, de consistencia blanda, indoloro a la palpación y fija, sin afectación de la piel que lo recubre. El diagnóstico más probable:

- a) Adenopatía tuberculosa
- b) Adenoma pleomorfo

c) Lipoma

d) Quiste sebáceo

e) Sarcoma

82) Una niña de 5 años, con antecedentes de atopia, consulta por presentar lesiones hipo pigmentadas en el rostro, no pruriginosas, ni dolorosas con descamación amarilla como se muestra en la siguiente imagen:

FOTO: se muestra imagen de cara de niña, con pitiriasis alba. La indicación más adecuada es:

a) Crema de hidrocortisona tópica

b) Crema de betametasona tópica

c) Crema de clotrimazol tópico

d) Griseofulvina oral

e) Bloqueador solar



144) Una adolescente de 15 años presenta lesiones en ambas orejas, que se extienden hasta el cuello. Tiene antecedente de hacerse piercings, hace una semana. Al examen físico se observa la siguiente imagen: FOTO: se visualiza la cara de una niña con eritema en todo el pabellón auricular, costras amarillentas en el lóbulo y algunas lesiones en la zona preauricular y submandibular. El diagnóstico más probable es:

a) Celulitis

b) Erisipela

c) Dermatitis de contacto alérgica

d) Dermatitis de contacto irritativa

e) Piodermitis superficial



145) Una paciente de sexo femenino de 17 años de edad, con antecedente de relaciones sexuales sin protección, consulta prurito vulvar, asociado a ardor progresivo. Refiere sensación de aumento del volumen de la vulva, que luego fue seguido por los síntomas actuales. Al examen físico se observa lo expuesto en la siguiente imagen. FOTO: Se ve la vulva con múltiples ulceraciones. Se trata de una infección por:

a) Treponema pallidum

b) Virus herpes simplex

- c) Chlamydia trachomatis
- d) Virus papiloma humano
- e) Ureaplasma urealyticum

Julio 2017

Un lactante de 12 meses de edad es traído por su madre, ya que presenta coloración amarillenta anaranjada en las palmas de las manos, las plantas y en las mejillas. No tiene otros antecedentes, pesa 9,5 Kg y mide 73,5 cm y su examen físico no muestra otras alteraciones. ¿Cuál es la causa de esta alteración?

- a) Hipercolesterolemia
- b) Hipertrigliceridemia
- c) Hiperbilirrubinemia de predominio directo
- d) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- e) Un componente de la dieta**

Es una carotenosis clásica (cara, manos y pies se ponen amarillos anaranjados), por ingesta de betacaroteno, presente en zanahorias, zapallos, repollo morado, melón y otras frutas y verduras

Un escolar de 7 años consulta por una zona alopécica de 2 semanas de evolución, que ha ido en creciendo. Al examen físico se aprecia la placa alopécica de 4 cm, con descamación y pelos entrecortados, tal como se muestra en la siguiente imagen:

INSERTAR FOTO

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tiña capitis**
- b) Tricotilomanía
- c) Alopecia areata
- d) Lupus discoide
- e) Dermatitis solar



Un paciente de 40 años consulta por hiperqueratosis y cambio de coloración de las uñas de los orfejos, de algunos meses de evolución. Se realiza estudio micológico, que muestra presencia de Trichophitum rubrum. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Itraconazol
- b) Griseofulvina
- c) Fluconazol
- d) Terbinafina**

e) Clotrimazol

La terbinafina oral es el tratamiento de elección de la onicomicosis

Un niño de 8 años presenta una lesión en la cara lateral del primero orjejo derecho. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, hiperqueratósica, con puntos negros en su superficie, la que se muestra en la siguiente imagen:

INSERTAR FOTO

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Queratosis seborreica
- b) Melanoma
- c) Panadizo
- d) Verruga vulgar**
- e) Cuerpo extraño periungueal

Es una verruga paraungueal clásica. La descripción era clara. La imagen era algo más confunde



muy

Una paciente de 30 años presenta una caída, con erosión de la rodilla derecha. Usted la evalúa 3 días después, observándose una zona eritematosa que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes parcialmente definidos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Curación con suero fisiológico y cobertura con apósito
- b) Curaciones con povidona yodada
- c) Mupirocina tópica
- d) Amoxicilina oral por 7 días
- e) Cefadroxilo oral por 7 días**

Parece una infección de una herida abrasiva. Como los bordes son parcialmente definidos, no queda claro si es una celulitis o una erisipela. Afortunadamente el cefadroxilo cubre bien tanto al *S. Aureus*, como al *S. Pyogenes*. La amoxicilina no cubre al *S. Aureus*.

Un paciente de 25 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades inferiores. Refiere que ayer estuvo jugando fútbol y que las lesiones empezaron a aparecer después. Además, dice que hace un año, le había pasado algo similar, luego de andar en moto por los cerros. Al examen físico se observan lesiones como las que se muestran en la siguiente imagen: INSERTAR FOTO (la imagen original mostraba ambos muslos y piernas con múltiples lesiones eritemato violáceas, muchas de ellas con disposición lineal)

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fitodermatitis**
- b) Enfermedad ampollar
- c) Urticaria solar
- d) Lupus discoide
- e) Vasculitis leucocitoclástica

Era una fitofotodermatosis por litre (árbol de la zona central chilena).

Un niño de 6 años presenta múltiples en el tronco, que se muestran en la imagen. Su padre tiene lesiones similares.

INSERTAR FOTO

El diagnóstico más probable es:

- a) Neurofibromatosis tipo 1
- b) Enfermedad de Addison
- c) Enfermedad celiaca
- d) Síndrome de Peutz-Jeghers
- e) Hiperplasia suprarrenal congénita



Diciembre 2017

62) Un paciente es diagnosticado de infección por VIH, hace 3 meses. Está en etapa A3 e inició tratamiento con triterapia antirretroviral al momento del diagnóstico. Consulta ahora por aparición de placas pruriginosas en el tronco, más algunas lesiones similares en las palmas y plantas. Además, tiene una lesión parecida en la cara interna de la mejilla derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Pitiriasis rosada
- b) Pitiriasis versicolor
- c) Síndrome pie mano boca
- d) Sífilis secundaria
- e) Reacción adversa a la triterapia antirretroviral

85) Una paciente de 50 años, diabética, con antecedente de insuficiencia renal e hígado graso, consulta por lesiones pruriginosas y eritematosas debajo de las mamas, en la región inguinal y debajo del abdomen. El tratamiento más adecuado es:

- a) Mupirocina tópica
- b) Cefadroxilo oral
- c) Griseofulvina oral
- d) Fluconazol oral
- e) Ketoconazol tópico

86) Un adolescente consulta por aparición de lesiones en zona nasogeniana, eritematosas, pruriginosas, desde hace una semana. Al examen físico se aprecian costras mielicéricas en la zona descrita. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Amoxicilina más ácido clavulánico
- b) Macrólidos
- c) Betametasona
- d) Cefoperazona
- e) Ciprofloxacino

87) Un recién nacido de 5 días de vida tiene un hemangioma en el párpado izquierdo, de 1 cm de diámetro, que cubre parcialmente el iris. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Observar evolución
- b) Indicar propranolol oral
- c) Indicar corticoides orales

- d) Biopsiar
- e) Derivar a cirujano plástico infantil

88) Una paciente de 84 años consulta por aparición de una lesión en la zona supraciliar izquierda, hace 12 meses, pruriginosa, que en ocasiones se ulcera y sangra. Al examen físico se observa lo siguiente: FOTO (Mujer adulta mayor con lesión ulcerada en la zona supraciliar, borde eritematoso, de 1 cm de diámetro aprox.) El diagnóstico más probable es:

- a) Carcinoma basocelular**
- b) Queratosis actínica
- c) Queratosis seborreica
- d) Granuloma piógeno
- e) Melanomaacrómico



89) Una paciente consulta por aparición de una lesión en el antebrazo, que inicialmente era dolorosa y eritematosa, pero que luego de 6 horas se volvió más oscura y más grande. Al examen físico, se aprecia lo siguiente: FOTO (típica placa livedoide en el antebrazo).

- a) Loxocelismo cutáneo**
- b) Necrosis grasa
- c) Ectima
- d) Pioderma gangrenoso
- e) Fasceítis necrotizante



131) Una preescolar de 4 años presenta prurito en la cabeza. Al examen físico se ven abundantes liendres, a menos de 3 cm del cuero cabelludo, sin visualizar piojos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Ivermectina oral
- b) Permetrina tópica al 1%**
- c) Permetrina tópica al 5%
- d) Lindano tópico

e) No tratar, mientras no se visualicen piojos

Julio 2018

Un niño de 4 años presenta aparición de ronchas evanescentes, desde hace 4 días. Además, desde hace algunos días presentaba congestión nasal, con rinorrea y estornudos. Al examen físico se observan habones en el tórax y dermatografismo en las extremidades. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Seleccione una:

- a. Indicar corticoides orales
- b. Solicitar prick test
- c. Indicar antihistamínicos orales
- d. Solicitar IgE sérica total
- e. Solicitar test de parches

Un adolescente de 14 años consulta por una lesión de color rojo, en el tórax, que apareció hace algunas semanas y que ha sangrado varias veces, en relación con el roce de la ropa. Se muestra a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

- a. Pioderma gangrenoso
- b. Hemangioma infantil
- c. Nevo atípico ulcerado
- d. Granuloma telangiectásico
- e. Queratosis seborreica



Una paciente de 33 años presenta úlceras orales recurrentes, desde hace varios meses. Además, tiene úlceras genitales. Hace una semana comienza con aparición de eritema nodoso en la cara anterior de ambas piernas y uveítis. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Infección por virus herpes
- b. SIDA
- c. Sífilis
- d. Enfermedad de Behcet
- e. Granulomatosis microangeítica

Síndrome de Behçet

Un recién
nacido de
3 días de
presenta
lesiones

Criterio mayor:

- Úlceras orales recurrentes (aftosas o herpetiformes)

Criterios menores (2 o más):

- Úlceras genitales o sus cicatrices
- Lesiones oculares (uveítis anterior o posterior)
- Lesiones cutáneas: eritema nodoso
- Patergia
- Los hallazgos de laboratorio son inespecíficos
- Tratamiento sintomático



nacido de
vida,
múltiples

amarillentas, pequeñas, apenas sollevantadas en ambas alas nasales. La conducta más adecuada es:

Selecione una:

- a. Corticoides tópicos
- b. Antimicóticos tópicos
- c. Vaselina líquida tópica
- d. Mantener el aseo habitual** (millium sebáceo)
- e. Antibióticos tópicos

Un paciente de 23 años consulta por aparición de lesiones en sus muslos, las que se muestran a continuación:
¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Selecione una:

- a. Dermatitis atópica
- b. Eritema nodoso
- c. Micosis cutánea** – tiña cruris
- d. Piodermitis
- e. Reacción adversa a fármacos



Un paciente de 34 años tuvo relaciones sexuales sin protección hace 14 días. Consulta por aparición de una úlcera indolora en el pene. Al examen físico se aprecia una úlcera en la zona derecha del surco balanoprepucial, que se extiende al glande, de borde sollevantado. Además, tiene una adenopatía inguinal sensible, al lado derecho. El agente etiológico más probable es:

Selecione una:

- a. Virus herpes simplex

- b. *Haemophilus ducreyi*
- c. *Klebsiella oxytoca*
- d. Virus papiloma humano
- e. *Treponema pallidum*

Diciembre 2014

147. Caso clínico con FOTO: “mancha” (ultra ordinaria) que aumenta su tamaño y cambia de color en 2 meses: Melanoma
148. Mujer con eritema violáceo facial, telangiectasias periungueales, pápulas de gottron: dermatomiositis
149. Paciente niño con alopecia en cuero cabelludo, prueba de tracción positiva, ¿pelos cortados dg? Tiña capitis, alopecia areata, alopecia por tracción
150. Paciente con placa heráldica (eritematosa, aparece una y el resto después). Dg? Pitiriasis rosada

Diciembre 2016

132. Lesión en mano: espinocelular
133. Foto: hemangioma
134. Foto: melanoma
135. Foto: Eritema pernio
136. Eritema nodoso: SGB cultivo

OFTALMOLOGÍA

Diciembre 2013

31) Un lactante de 6 meses, sin antecedentes perinatales, es traído por presentar epifora desde hace 2 meses, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia córnea de 15mm de diámetro en ojo izquierdo, asociado a opacidad corneal. El diagnóstico más probable es:

- a) Retinoblastoma
- b) Catarata congénita
- c) Atresia del conducto lacrimal
- d) Glaucoma congénito**
- e) Persistencia del vítreo primario hiperplásico

44) Un paciente de 35 años, con cuadro de ojo rojo asociado a secreción mucopurulenta desde hace un día, por lo cual se le indicó colirio de cloranfenicol cada 8 horas, sin embargo, evoluciona posteriormente con aumento del enrojecimiento, edema palpebral y quemosis. El diagnóstico más probable es:

- a) Alergia al cloranfenicol (?)**
- b) Celulitis orbitaria****
- c) Obstrucción lacrimal
- d) Chalazion
- e) Absceso tarsal

1) Un paciente de 50 años, sin antecedentes, consulta por ojo rojo izquierdo desde ayer asociado a sensación de dolor, blefarospasmo y fotofobia. Su examen físico es dificultoso por dolor, por lo que se administra anestésico local, tras lo cual se aprecia ojo rojo tipo central y al aplicar fluoresceína se tiñe la mitad superior de la córnea. La conducta más apropiada en este caso es:

- a) Evertir el párpado superior**
- b) Aplicar colirio de gentamicina
- c) Poner parche ocular y controlar
- d) Aplicar colirio con atropina
- e) Realizar aseo local

54) Una paciente de 50 años consulta por dolor ocular izquierdo de inicio agudo, asociado a visión borrosa. Al examen físico destaca ojo rojo periquerático y pupila midriática arreactiva, la agudeza visual es de 0,6 en ojo izquierdo y 1 en ojo derecho. El diagnóstico más probable en este caso es:

- a) Uveítis aguda
- b) Endoftalmitis
- c) Queratitis aguda
- d) Escleritis
- e) Glaucoma agudo**

Julio 2015

105) Un paciente de 80 años, diabético, hipertenso y fumador de 30 paquetes-año, consulta por dificultades para leer, que ha empeorado lentamente. Además, notó hace poco una metamorfopsia en el ojo izquierdo. Tiene agudeza visual de 0,8 en el ojo derecho y de 0,4 en el ojo izquierdo y al examen ocular, se aprecia leve disminución del rojo pupilar bilateral, con reflejos fotomotores normales. ¿Cuál es el diagnóstico más

probable?

a) Degeneración macular relacionada con la edad

- b) Glaucoma de ángulo abierto
- c) Desprendimiento de retina
- d) Glaucoma de ángulo estrecho
- e) Retinopatía diabética

106) Una paciente de 60 años está en espera de cirugía, por obstrucción crónica del conducto nasolagrimal, sin embargo, presenta cuadro de aumento de volumen en la zona medial del ojo derecho, con dolor, eritema y epifora. La conducta más adecuada es:

a) Iniciar antibióticos orales

- b) Indicar masajes y compresiones locales
- c) Indicar corticoides tópicos
- d) Indicar antibióticos en colirios
- e) Resolver quirúrgicamente

107) Una paciente miope, usuaria de lentes de contacto blando, consulta por dolor ocular izquierdo, asociada a epifora. Al examen muestra ojo rojo periquerático en el ojo izquierdo, con lagrimeo y una zona de opacidad corneal de 2,1 mm de diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Conjuntivitis bacteriana

b) Úlcera corneal

- c) Uveítis aguda
- d) Glaucoma agudo
- e) Blefaritis

179) Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, mal controlado, consulta por pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierda. Con el ojo izquierdo solo puede contar dedos. Al examen físico no se ven alteraciones externas, pero el rojo pupilar del ojo izquierdo está muy disminuido. El diagnóstico más probable es:

- a) Trombosis de la vena central de la retina
- b) Desprendimiento de retina
- c) Neuritis óptica
- d) Embolia de arteria central de la retina
- e) Hemorragia vítrea**

Diciembre 2015

7) Un paciente de 80 años, diabético, hipertenso y dislipidémicos presenta disminución progresiva de la agudeza visual izquierda, asociado a disminución de la percepción del contraste. Al examen físico, presenta agudeza visual de 0,3 con el ojo izquierdo y de 0,8 con el ojo derecho, con reflejos fotomotores conservados y oculomotilidad normal. Además, presenta disminución del rojo pupilar izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Glaucoma crónico
- b) Retinopatía diabética
- c) Degeneración macular relacionada con la edad
- d) Vicio de refracción
- e) Catarata**

8) Un paciente de 34 años consulta por importante disminución de la agudeza visual del ojo derecho, que se ha instalado en dos días. Al examen físico presenta agudeza visual de 0,2 con el ojo derecho y de 1 con el ojo izquierdo. Además, presenta defecto pupilar aferente relativo, asociado a alteración de la percepción de colores. El fondo de ojo muestra edema de papila en 360 grados, con hemorragias. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuritis óptica**
- b) Hipertensión endocraneana
- c) Oclusión de la arteria central de la retina
- d) Neuropatía isquémica óptica
- e) Glaucoma aguda

9) Una niña de 4 años, presenta un cuadro catarral, con rinorrea bilateral y malestar general. Al cuarto día presenta dificultad para ver con el ojo derecho, con ojo rojo. Al examen físico presenta fiebre, FC: 100x', asociado a proptosis derecha y edema del párpado ipsilateral. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis alérgica
- b) Celulitis orbitaria**
- c) Queratoconjuntivitis viral
- d) Orbitopatía distiroidea
- e) Celulitis preorbitaria

91) Un paciente de 50 años, diabético tipo 2, consulta por disminución de la agudeza visual del ojo derecho, progresiva, asociada a dificultad para reconocer objetos. Al examen presenta agudeza visual de 0,2 en el ojo derecho y de 0,9 en el ojo izquierdo. En el fondo de ojo se visualizan múltiples exudados céreos en el polo posterior. El diagnóstico más probable es:

- a) Oclusión de la arteria central de la retina
- b) Desprendimiento de retina
- c) Trombosis de la vena central de la retina
- d) Retinopatía diabética proliferativa
- e) Edema macular**

92) Una paciente presenta epifora derecha desde hace 3 meses. En el último mes se agrega ojo rojo derecho, asociado a aumento de volumen. Al examen físico se aprecia ojo rojo superficial y al comprimir el saco lagrimal se observa salida de 2 gotas de secreción mucopurulenta. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Realizar masajes en el saco lagrimal 3 veces al día
- b) Indicar amoxicilina / ácido clavulánico**
- c) Aplicar compresas húmedas 3 veces al día

- d) Indicar colirios de corticoides 3 veces al día
- e) Realizar cateterismo de la vía lagrimal

122) Una mujer de 36 años, con mesenquimopatía en estudio, consulta por sensación de arenilla ocular, asociada a ojo rojo y dolor. Evoluciona con epifora y blefarospasmo. En el examen se aprecia ojo rojo profundo y la tinción con fluoresceína muestra queratitis en el tercio inferior de la córnea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cuerpo extraño ocular
- b) Uveítis aguda
- c) Glaucoma
- d) Síndrome de ojo seco**
- e) Lupus eritematoso sistémico

Julio 2016

5) Una paciente de 26 años, con antecedente de esclerosis múltiple consulta por disminución de la agudeza visual derecha, de 2 días de evolución, asociado a leve dolor retroocular derecho, que aumenta con los movimientos. Al examen físico se aprecia rojo pupilar y movimientos normales, escape pupilar, con defecto pupilar aferente en el ojo derecho y presencia de un escotoma derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Desprendimiento de retina
- b) Trombosis de la vena central de la retina
- c) Trombosis de arteria central de la retina
- d) Neuritis óptica**
- e) Absceso orbitario

34) Un niño de 2 años presenta estrabismo divergente, con desviación del ojo derecho hacia temporal, que apareció hace pocos meses y que ha ido progresando. Al examen físico, además se constata ausencia del rojo pupilar de ese ojo. El diagnóstico más probable es:

- a) Glaucoma congénito
- b) Retinoblastoma**
- c) Catarata congénita
- d) Leucoma
- e) Estrabismo esencial

75) Una paciente de 32 años, con antecedentes de asma y rosácea, usuaria de corticoides inhalados, presenta un cuadro de algunos meses de evolución de ojo rojo bilateral, asociado a ardor, epifora y secreción mucosa, que a veces se vuelve purulenta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Glaucoma agudo
- b) Blefaritis**
- c) Uveítis
- d) Dacriocistitis

e) Conjuntivitis bacteriana crónica

153) Un paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo, presenta pérdida de la visión del ojo izquierdo, con instalación súbita. Al examen, es capaz de distinguir la luz de la sombra y contar dedos y destaca defecto pupilar aferente relativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Glaucoma agudo
- b) Glaucoma crónico terminal
- c) Neuritis óptica
- d) Neuropatía óptica isquémica**
- e) Desprendimiento de retina

Julio 2017

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, consulta por disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. En su evaluación, tiene agudeza visual 20/20 en el ojo izquierdo y 10/20 en el ojo derecho. Su rojo pupilar demuestra una opacidad con forma de estrella, en la zona central. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Desprendimiento de retina
- b) Edema macular
- c) Catarata**
- d) Glaucoma
- e) Retinopatía diabética proliferativa

Es una catarata inicial. La opacidad en forma de estrella es la catarata misma, que se está formando.

Un lactante de 5 meses presenta opacidad corneal bilateral, asociado a epifora y aumento del diámetro corneal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Retinoblastoma
- b) Macrocórnea
- c) Glaucoma congénito**
- d) Atresia lagrimal
- e) Catarata congénita

Es un glaucoma congénito clásico

Un paciente de 18 años presenta agudeza visual de 1 en el ojo izquierdo y de 0,6 en el ojo derecho, que mejora a 0,8, al mirar por un agujero estenoico. No presenta dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Glaucoma
- b) Estrabismo
- c) Vicio de refracción**
- d) Catarata
- e) Coriorretinitis

La mejora de la AV al mirar por un agujero estenoico es característico de los vicios de refracción.

Una niña de 12 años consulta por molestias, secreción y una lesión en el ojo izquierdo, que se muestra en la siguiente foto:

INSERTAR FOTO

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Amoxicilina
- b) Azitromicina
- c) Aciclovir
- d) Mupirocina
- e) Dexametasona

Era un herpes periocular.

Un paciente de 68 años, diabético e hipertenso presenta disminución brusca de la visión del ojo izquierdo, que solo le permite diferenciar los movimientos de una mano, sin poder identificar letras. La agudeza visual del ojo derecho es normal. La exploración externa es normal y el rojo pupilar es negativo en ese ojo. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 9,2%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Neuritis óptica isquémica
- b) Desprendimiento de retina
- c) Hemorragia vítrea
- d) Trombosis de la arteria central
- e) Edema macular

Es una hemorragia vítrea clásica, con su característica pérdida del rojo pupilar.

Diciembre 2017

81) Un paciente de 30 años, con antecedente de espondilitis anquilosante consulta por ojo rojo izquierdo con dolor, desde hace 24 horas, asociado a disminución de la agudeza visual. Hace 2 años presentó un episodio similar autolimitado, por el que no había consultado. Al examen físico, se muestra lo siguiente:

FOTO (Ojo examinado con la luz de hendidura que muestra discoria). El diagnóstico más probable es:

- a) Uveítis anterior
- b) Catarata
- c) Disgenesia pupilar
- d) Endoftalmitis
- e) Hemorragia vítrea

82) Una paciente, con antecedente de esclerosis múltiple, consulta por dolor ocular derecho, de 2 días de evolución, a lo que se le ha agregado visión borrosa. Tiene agudeza visual de 0,9 en el lado derecho y 1 en el lado izquierdo, que no cambia al mirar por un agujero estenopeico. Además, se constata que en el ojo derecho está muy afectada la visión de colores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Discromatopsia
- b) Retinitis pigmentosa
- c) Coriorretinitis
- d) Desprendimiento de retina
- e) Neuritis óptica

83) Un niño de 8 meses presenta leucocoria del ojo derecho. Como antecedente, su madre usa una prótesis ocular, por una pérdida ocular en su infancia, por una causa no precisada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Retinopatía del prematuro
- b) Catarata congénita
- c) Retinoblastoma**
- d) Glaucoma congénito
- e) Infección por Chlamydia trachomatis

84) Una paciente de 50 años se realiza una tonometría ocular, que muestra una presión intraocular de 28 mmHg en el ojo derecho. La inspección ocular no tiene alteración. La agudeza visual es 1,0 en ambos ojos y se constata una excavación papilar es de 0,7 a derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Degeneración macular relacionada con la edad
- b) Neuropatía óptica
- c) Glaucoma crónico**
- d) Catarata
- e) Desprendimiento de retina

122) Una niña de 4 años presenta un cuadro catarral, con abundante rinorrea. Evoluciona con eritema y, dolor periocular derecho, asociado a proptosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Celulitis preorbitaria
- b) Celulitis orbitaria**
- c) Orbitopatía distiroidea
- d) Pseudotumor orbitario
- e) Etmoiditis aguda

Julio 2018

Un niño de 8 años consulta por ojo rojo y sensación de arenilla ocular, bilateral. Al examen físico se aprecia eritema en el borde de los párpados y entre las pestañas, con pérdida de algunas de ellas y escasa secreción ocular. Además, tiene descamación gruesa de la piel del párpado superior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

- a. Chalazión
- b. Conjuntivitis alérgica
- c. Blefaritis**
- d. Conjuntivitis bacteriana
- e. Glaucoma congénito

Una paciente de 78 años presenta disminución de la visión del ojo derecho, de 4 meses de evolución. Al examen tiene caída de la agudeza visual de dicho ojo, con disminución de la visión del contraste y afectación del rojo pupilar. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Glaucoma crónico
- b. Catarata**
- c. Degeneración macular relacionada con la edad
- d. Vicio de refracción
- e. Atrofia del nervio óptico

Una paciente presenta un cuadro de 2 semanas de evolución, de fotopsias en la zona inferolateral del campo visual izquierdo, al que hace dos días se agrega disminución de la visión de dicho ojo, que ella describe como un muro que se va levantando. Tiene antecedente de artritis reumatoide, en tratamiento de prednisona. Además, es hipertensa y tiene antecedente oftalmológico de una faquectomía izquierda, con lente intraocular. Su examen físico muestra agudeza visual de 1,0 en el ojo derecho y de 0,1 en el ojo izquierdo.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

- a. Catarata
- b. Desprendimiento de retina**
- c. Neuropatía óptica isquémica
- d. Hemorragia vítrea
- e. Glaucoma

Una paciente de 40 años, en estudio por mesenquimopatía, consulta por ardor ocular bilateral, asociado a secreción y visión borrosa. Al examen oftalmológico se objetiva ojo bilateral, asociado a secreción y visión borrosa. Al examen oftalmológico se objetiva ojo rojo, con una úlcera corneal en la mitad inferior. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Cuerpo extraño tarsal
- b. Conjuntivitis alérgica
- c. Escleritis
- d. Síndrome de ojo seco**
- e. Conjuntivitis bacteriana

Una niña de 4 años presenta, desde hace 5 días, tos, odinofagia, rinorrea y congestión nasal, a lo que ahora se agrega aumento de volumen del ojo izquierdo, con proptosis y edema del globo ocular. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Celulitis orbitaria**
- b. Meningitis aguda
- c. Mononucleosis infecciosa
- d. Celulitis preorbitaria
- e. Infección por adenovirus

Diciembre 2014

125. Fármaco contraindicado de uso en glaucoma crónico y asma bronquial: Lanaprost, Pilocarpina, Acetazolamida, Timolol

126. paciente que ve fotopsias y después le disminuye la agudeza visual: desprendimiento de retina

Diciembre 2016

137. Dolor lagrimal en viejo: obstrucción vía lagrimal

138. Corrige al estenopeico: ametropía

139. Diabético, pérdida AV aguda: hemorragia vítrea

140. Otra hemorragia vítrea

141. Ojo rojo asociado a EII: uveítis

142. Niño leucocoria: retinoblastoma

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Diciembre 2013

84) Un paciente de 45 años, con historia de años de evolución de hipoacusia y supuración por oído derecho, consulta por compromiso del estado general, fiebre hasta 39°C, vértigo y secreción ótica purulenta. Al examen se aprecia nistagmus horizontal con fase rápida a izquierda, a la otoscopia solo se aprecia secreción purulenta en conducto auditivo externo, no se observa tímpano. El tratamiento más adecuado en este caso es:

- a) Antibióticos endovenosos ****
- b) Lavado ótico
- c) Cirugía de urgencia**
- d) Corticoides endovenosos
- e) antiinflamatorios endovenosos

56) Un paciente de 8 años de edad, con historia de un año de evolución de rinorrea mucopurulenta bilateral intermitente asociado a prurito y en algunas ocasiones a epistaxis, actualmente sin síntomas. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Antihistamínicos orales**
- b) Antibióticos orales
- c) Corticoides tópicos
- d) Derivar a cirugía de adenoides
- e) Oximetazolina tópica

76) Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de 2 días de odinofagia, asociado a tos seca y rinorrea, que durante el primer día se asoció a sensación febril. Al examen físico se encuentra con temperatura de 36,8°C, faringe eritematosa, amígdalas aumentadas de tamaño con escaso exudado blanquecino, examen cardiopulmonar normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Amigdalitis pultácea
- b) Influenza
- c) Rinofaringitis aguda**
- d) Coqueluche
- e) Adenovirus

81) Un paciente de 34 años, sin antecedentes, sufre caída mientras subía una escalera, resultando con golpe en su rostro, al ingreso se en buenas condiciones generales, pero con epistaxis. Se realiza especuloscopia nasal donde se aprecia engrosamiento septal bilateral y epistaxis anterior. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Drenaje por punción
- b) Observar y controlar en 2 semanas
- c) Drenaje quirúrgico urgente**
- d) Antibióticos endovenosos
- e) Taponamiento nasal bilateral

85) Un paciente de 3 años, sin antecedentes, con cuadro de rinofaringitis viral de dos días de evolución en tratamiento sintomático, es traído por presentar desde hace unas horas mayor

compromiso del estado general, asociado a otalgia intensa izquierda y sensación febril. Al examen físico destaca examen cardiopulmonar normal y a la otoscopia se aprecia tímpano izquierdo eritematoso y abombado con escasa secreción purulenta. El fármaco de elección en este caso es:

- a) Ibuprofeno oral
- b) Amoxicilina oral**
- c) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
- d) Gentamicina tópica
- e) Claritromicina oral

Julio 2015

101) Un paciente de 18 años sufre un pelotazo en la cara hace 7 días, evolucionando con dolor, obstrucción nasal, rinorrea purulenta y fiebre. Está subfebril y se aprecia aumento de volumen bilateral, en relación al septo nasal. En sus exámenes destaca leucocitosis de 15.000 blancos por mm³. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar drenaje con punción
- b) Indicar antibióticos orales
- c) Poner tapón, con gasas empapadas en antibióticos tópicos
- d) Indicar corticoides y descongestionantes
- e) Realizar drenaje inmediato con bisturí**

102) Un niño de 7 años presenta otalgia derecha, asociada a otorrea. Al examinarlo presenta otorrea, sin olor y a la otoscopia presenta canal auditivo estrecho, por lo que no es posible ver el tímpano. Además presenta dolor al traccionar el pabellón auricular. EL diagnóstico más probable es:

- a) Otitis media aguda
- b) Otitis media crónica
- c) Otitis externa**
- d) Tapón de cerumen
- e) Otomastoiditis aguda

103) Un paciente de 30 años presenta disfonía persistente, de un mes de evolución, que inició al asistir a un concierto de Rock. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Nódulos vocales
- b) Disfonía musculotensional
- c) Cáncer de laringe
- d) Pólipos vocales**
- e) Reflujo faringo-laríngeo

104) Un paciente de 59 años presenta hipoacusia bilateral, asociado a otorrea, de larga data. Consulta por un cuadro de reciente inicio, de mayor hipoacusia derecha, asociada a vértigo persistente, que ha ido en aumento. Al examen se aprecia nistagmo horizontal, con fase rápida a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Otomastoiditis aguda

b) Laberintitis aguda

- c) Vértigo postural paroxístico
- d) Absceso cerebral
- e) Neuronitis vestibular

Diciembre 2015

4) Un niño de 2 años y 5 meses presenta rinorrea purulenta de una semana de evolución, por la fosa nasal izquierda. No presenta compromiso del estado general y sus signos vitales son normales. Al examen físico se aprecia salida de rinorrea purulenta por la narina izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Cuerpo extraño nasal

- b) Atresia unilateral de coanas
- c) Rinitis alérgica
- d) Hipertrofia adenoidea
- e) Sinusitis bacteriana

5) Un paciente de 60 años, fumador de 30 paquetes-año, consulta por disfonía de 1 mes de evolución, asociado a odinofagia y baja de peso de 4 kilogramos en el último tiempo. Al examen físico presenta una adenopatía cervical anterior, de consistencia dura y adherida a planos profundos. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

a) Ecografía de cuello

b) Nasofibrolaringoscopia

- c) TAC de cuello
- d) RMN de cuello
- e) Biopsia ganglionar por punción

6) Un hombre de 25 años consulta por otalgia derecha de 5 días de evolución, intensa, asociada a otorrea ipsilateral. Al examen físico se constata dolor al traccionar el conducto auditivo externo y en la otoscopia se aprecia edema y eritema del conducto auditivo externo derecho, con secreción. El tratamiento de elección es:

- a) Amoxicilina oral
- b) Amoxicilina / ácido clavulánico oral
- c) Ciprofloxacino tópico en gotas**
- d) Levofloxacino oral
- e) Neomicina tópica en gotas

95) Una paciente de 45 años, luego de un accidente con un huesito de pollo, evoluciona con intenso dolor en la faringe y en el cuello, asociado a fiebre, odinofagia y marcado malestar general. El dolor es especialmente intenso con la movilización cervical en el sentido anteroposterior. Al examen se observa aumento de volumen de la zona posterior y lateral derecha de la faringe. El diagnóstico más probable es:

- a) Absceso periamigdalino
- b) Angina de Vincent
- c) Absceso retrofaríngeo**

- d) Angina de Ludwig
- e) Absceso parafaríngeo

97) Un paciente de 20 años consulta por estornudos, prurito nasal y rinorrea acuosa, que se exagera en la primavera y al exponerse a algunos pólenes. Tiene antecedente de dermatitis atópica y al examen físico se aprecia mucosa nasal pálida. Se realiza un prick test que resulta positivo para Ballica y Plátano oriental. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para este paciente?

- a) Corticoides orales en pulsos cortos
- b) Antihistamínicos anti-H1, de segunda generación**
- c) Descongestionantes nasales tópicos
- d) Corticoides inhalados por vía nasal
- e) Inhibidores de la degranulación de los mastocitos

Julio 2016

126) Un hombre de 30 años, con rinorrea frecuente, se realiza prueba cutánea (prick test), que muestra reacción de 5mm a pólenes y de 0 mm al control histamina. ¿Cuál es la interpretación más adecuada de esta prueba?

- a) Es alérgico
- b) Está sensibilizado a pólenes**
- c) Tiene rinitis vasomotora
- d) Tiene sinusitis crónica
- e) Anergia cutánea

143) Una mujer de 26 años, presenta un cuadro de 5 días de rinorrea, que a los dos días se vuelve mucopurulenta, agregándose odinofagia, y congestión nasal. Al examen físico se aprecia rinorrea, asociada a eritema y congestión faríngea. Se solicita una radiografía de senos paranasales que muestra velamiento de ambos senos maxilares. El tratamiento más adecuado es:

- a) Amoxicilina oral**
- b) Amoxicilina más ácido clavulánico oral
- c) Corticoide tópico
- d) Descongestionantes tópicos
- e) Antihistamínicos orales

164) Paciente de 17 años presenta un cuadro de fiebre, malestar general y odinofagia, de 7 días de evolución. Al examen, presenta lesiones blanquecinas en las amígdalas y congestión de la orofaringe, adenopatías cervicales y se palpa el bazo moderadamente aumentado de tamaño. ¿Cuál es el agente causal más probable?

- a) Adenovirus
- b) Virus influenza
- c) Virus de Ebstein Barr**
- d) Citomegalovirus

e) Estreptococo A

Julio 2017

Un paciente presenta vértigo, de segundos de duración, que se le produce al girar la cabeza a derecha, mientras está acostado. No tiene síntomas auditivos y como antecedente refiere haber sufrido un traumatismo encefálico hace 10 días, en un accidente de trabajo. No presenta adiadococinesia ni dismetría. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar flunarizina
- b) Iniciar tietilperazina
- c) Solicitar un TAC de oídos
- d) Derivar para maniobras de reposición vestibular**

e) Iniciar Difenidol

Es un vértigo postural paroxístico benigno clásico. Se trata con las maniobras de reposición (los antivertiginosos algo sirven, pero no son de elección en el VPPB, a diferencia de la neuronitis vestibular y la enfermedad de Ménière). La ausencia de síntomas auditivos descarta Ménière y la ausencia de signos cerebelosos, hace improbable un vértigo central.

Un niño de 7 años, respirador bucal es traído por su madre. No presenta apnea del sueño, ni infecciones a repetición. Al examen físico, no tiene obstrucción nasal y se observa faringe con amígdalas grado II. Se solicita radiografía de cavum, que constata hipertrofia adenoidea, con 80% de obstrucción. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Desloratadina oral
- b) Fluticasona intranasal
- c) Adenoidectomía
- d) Observar evolución y controlar ambulatoriamente**
- e) Solicitar TAC de cavidades paranasales

Esta pregunta excede lo que debe saber un médico general y causa conflicto en los mismo ORL que la analizaron. Tiene adenoides grado III, por lo que hay una indicación relativa de cirugía, pero no tiene complicaciones y a su edad ya no seguirán creciendo, por lo que probablemente se pueda intentar el tratamiento con corticoides tópicos (han demostrado reducir el tamaño de los adenoides) o incluso observar evolución, ya que la respiración bucal, no es de tipo obstructivo (no hay obstrucción nasal en el examen físico), sino por otra causa (hiperlaxitud, malos hábitos).

Un paciente de 23 años consulta por odinofagia intensa, asociada a fiebre, que han empeorado y que y en el último tiempo se agrega dificultades para comer, por trismus. Al examen físico presenta eritema faríngeo, exudado amigdalino bilateral y abombamiento del pilar diafragmático derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Absceso retrofaríngeo
- b) Angina de Ludwig
- c) Amigdalitis ulcero-necrótica
- d) Absceso periamigdalino**
- e) Mononucleosis infecciosa

Es un absceso periamigdalino clásico: odinofagia, trismus y abombamiento del pilar faríngeo.

Diciembre 2017

117) Una paciente con un cuadro de 5 años de evolución de marcada obstrucción nasal y rinorrea acuosa. Se realiza una radiografía de cavidades paranasales, que muestra velamiento de los senos maxilares. Se solicita un TAC de cavidades paranasales que muestra engrosamiento de la mucosa de los senos etmoidales y maxilares. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar fluticasona tópica**
- b) Realizar cirugía endoscópica nasal
- c) Solicitar rinomanometría
- d) Indicar tratamiento antibiótico
- e) Iniciar antihistamínicos orales

118) Un paciente, con antecedente de rinitis alérgica, presenta marcada obstrucción nasal marcada, asociada varios episodios de sinusitis en el último tiempo. En la rinoscopia anterior, se visualizan numerosos pólipos en la mucosa, de aspecto pálido y brillante. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar fluticasona tópica
- b) Iniciar prednisona oral**
- c) Solicitar TAC de cavidades paranasales
- d) Realizar cirugía endoscópica nasal
- e) Solicitar niveles plasmáticos de inmunoglobulinas

119) Un paciente está en el tercer día de tratamiento con azitromicina, por una amigdalitis con exudado. Consulta por aumento de la odinofagia, asociada a imposibilidad de comer por trismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Absceso periamigdalino**
- b) Angina de Ludwig
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Absceso parafaríngeo
- e) Absceso retrofaríngeo

Julio 2018

Un paciente de 54 años, fumador de 32 paquetes año presenta un cuadro de disfonía de 6 semanas de evolución, que ha empeorado y se asocia a odinofagia. Hace 2 semanas se agrega aumento de volumen en el cuello, palpándose una adenopatía cervical de 2 cm, no desplazable en el grupo II-A del triángulo cervical anterior derecho. El examen más adecuado para continuar el estudio en este paciente es:

Seleccione una:

- a. Radiografía de tórax
- b. Ecografía de cuello
- c. Radiografía lateral de cuello
- d. Laringoscopia directa**
- e. TAC de cuello

Una paciente de 43 años presenta vértigo de 5 días de evolución, intenso, asociado a vómitos, lo que limita sus actividades. No tiene síntomas auditivos. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Paresia cocleovestibular
- b. Vértigo postural
- c. Hídrops endolinfático
- d. Neuritis vestibular**
- e. Neurinoma del acústico

Una paciente de 34 años consulta por congestión nasal, rinorrea y prurito nasal, con estornudos frecuentes. Al examen físico no tiene alteraciones. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación.

¿Cuál es el tratamiento de elección?

Seleccione una:

- a. Amoxicilina
- b. Loratadina** – rinitis alérgica
- c. Prednisona
- d. Claritromicina
- e. Salbutamol

Un niño de 6 años consulta por epistaxis bilateral frecuente. Además, tiene antecedente de ser respirador bucal, roncar en la noche y presentar infecciones respiratorias altas a repetición. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Rinofibroangioma bilateral
- b. Rinitis alérgica** (esa dice la pauta)
- c. Enfermedad de von Willebrand
- d. Hipertrofia de adenoides**
- e. Atresia de coanas

Una paciente de 39 años presenta otorrea izquierda de varios meses de evolución y que persiste por varios días después de bañarse en el mar. Tiene hipoacusia leve en ese oído. La otoscopia muestra abundante secreción amarillenta en el oído. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Otitis media aguda recurrente
- b. Otitis media con efusión
- c. Otitis media crónica**
- d. Otitis externa
- e. Fístula de líquido cefalorraquídeo

Diciembre 2014

127. Niño con hiperplasia amigdalina grado II. ¿Para continuar el estudio? Radiografía de cavum

128. Mujer joven con hipoacusia súbita asociada a tinitus. Sin vértigo. Otoscopia normal: Manejo: Amoxicilina por 7 días, Desloratadina, prednisona

Diciembre 2016

143. Otitis perforada: amoxi / amoxi clav

144. Se extuba: estenosis

145. Oído que pica y usa cotonitos: hongo / cuerpo extraño ¿?

2013

4) Una paciente de 60 años, es diagnosticada de cistoadenocarcinoma seroso de ovario el cual presenta diseminación difusa en peritoneo, por lo cual no es operable. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Cuidados paliativos
- b) Radioterapia
- c) Hormonoterapia
- d) Quimioterapia**
- e) Inmunoterapia

7) Una paciente de 30 años, con embarazo de 35 semanas controlado, consulta al servicio de urgencias por metrorragia escasa asociada a dolor abdominal. Al examen físico destaca aumento marcado del tono uterino de forma permanente y frecuencia cardíaca fetal de 110 por minuto. El diagnóstico más probable es:

- a) Placenta previa
- b) Rotura uterina
- c) Rotura de vasa previa
- d) Síntomas de parto prematuro
- e) Desprendimiento de placenta**

19) Una paciente de 22 años, nulípara, con antecedentes de migraña a repetición y un episodio de amaurosis fugax desea iniciar un método anticonceptivo. Su examen físico se encuentra normal. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos indicaría a esta paciente?

- a) Anticonceptivos combinados por vía oral
- b) Anticonceptivos combinados por vía transdérmica
- c) Salpingoligadura
- d) Dispositivo intrauterino con progestinas**
- e) Anticonceptivos combinados inyectables

Nota: Pregunta muy difícil, ya que por ser nulípara tiene contraindicación relativa del DIU, sin embargo por tener jaqueca con amaurosis fugax, están contraindicados absolutamente los estrógenos, ya que los ACO están contraindicados en algunas jaquecas con mayor riesgo de AVE: la amaurosis fugax es uno de los criterios de contraindicación absoluta. Además la salpingoligadura es irreversible. Esta pregunta es muy muy difícil y debería anularse, ya que todas las opciones están contraindicadas; la del DIU medicado es la más aceptable.

25) Una mujer de 28 años, con embarazo de 30 semanas, consulta angustiada por no percibir movimientos fetales, sin otros síntomas. Su examen físico es normal. Se solicita registro basal no estresante de veinte minutos que se muestra a continuación:

La conducta más adecuada en este caso es:



- a) Tranquilizar a la paciente e indicar que mantenga controles habituales
- b) Solicitar perfil biofísico
- c) Solicitar ecografía obstétrica
- d) Repetir registro basal no estresante por veinte minutos más**
- e) Realizar test de tolerancia a las contracciones uterinas

29) Embarazada de 35 semanas, con altura uterina menor a lo esperado, es derivada a alto riesgo obstétrico donde se realiza ecografía que muestra feto de 1.800 gramos y el doppler umbilical muestra flujo reverso en diástole. La paciente está en buenas condiciones, sin dinámica uterina y su tacto vaginal no presenta cambios cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Inducir con misoprostol y conducir trabajo de parto
- b) Interrumpir por cesárea**
- c) Hospitalizar para estudio de la unidad fetoplacental
- d) Solicitar estudio de líquido amniótico
- e) Indicar reposo y control en 48 horas

32) Una paciente de 36 años, multípara de 3, con historia de amenorrea desde hace 4 meses, no asociado a otros síntomas. Refiere haber sido usuaria de anticonceptivos orales hasta hace 6 meses y que se realizó test de embarazo en dos oportunidades con resultado negativo. Se solicitan niveles de hormona tiroestimulante y prolactina que resultan normales, además prueba de progesterona que es negativa, por este motivo se solicita prueba de estrógeno más progesterona que resulta positiva y niveles de hormona folículo estimulante que resulta en 5 mUI/mL. El diagnóstico más probable es:

- a) Falla ovárica primaria
- b) Falla del eje hipotálamo hipofisiario**
- c) Síndrome de ovario poliquístico
- d) Malformación uterina
- e) Síndrome de Cushing

36) Un paciente de 54 años, post menopáusica, sin uso de terapia de reemplazo hormonal, consulta por presentar metrorragia en dos oportunidades, sin otros síntomas. Se realiza especuloscopia que no muestra signos de sangramiento activo ni lesiones, el resto del examen físico resulta normal. El examen de elección en este caso es:

- a) Realizar histeroscopia
- b) Lgrado biopsico endometrial
- c) Ecografia abdominal
- d) Colposcopia y biopsia
- e) Ecografia transvaginal

46) Paciente de 29 años, cursando embarazo de 38 semanas, consulta por aparición de vesículas dolorosas a nivel vulvar, sin otros síntomas. Al examen físico se apreian vesículas con base eritematosa a nivel vulvar. El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:

- a) Cultivo viral
- b) PCR para virus herpes
- c) Biopsia
- d) Inmunoglobulina G para virus herpes
- e) Tinción para virus herpes

54) Embarazada de 33 semanas, hospitalizada por preeclamsia, comienza con dinámica uterina de 3 en 10 minutos, sus últimos exámenes de control presenta creatinina 1,5mg/dL y proteinuria de 24 horas 2 gramos. Al examen físico presenta presión arterial de 150/90, reflejos osteotendíneos presentes, tacto vaginal sin cambios cervicales. Se realiza monitoreo fetal que muestra variabilidad de 3 latidos por minutos y desaceleraciones tardías. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar tocolíticos e interrumpir a las 34 semanas
- b) Administrar labetalol endovenoso y mantener conducta expectante
- c) Realizar perfil biofísico
- d) Solicitar ecografia doppler umbilical
- e) Interrupción del embarazo

60) Una mujer de 35 años, con embarazo de 15 semanas, sin síntomas, en exámenes de control destaca VDRL negativo, hemoglobina de 11,5 mg/dL y glicemia de ayuno 108mg/dL. Su examen físico es normal, con altura uterina sobre el pubis. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Solicitar test de tolerancia oral a la glucosa
- b) Indicar dieta y mantener control habitual
- c) Solicitar hemoglobina glicosilada
- d) Indicar insulina subcutánea
- e) Solicitar nueva glicemia de ayunas

63) Una paciente de 30 años, nulípara, consulta por presentar reglas abundantes, asociado a astenia e hipersomnía. Al examen físico destacan mucosas pálidas, sin otros hallazgos. Se realiza hemograma donde destaca hemoglobina que resulta en 8mg/dL, y además se realiza ecografia transvaginal que muestra presencia de dos miomas intramurales. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Anticonceptivos orales
- b) Agonistas de las gonadotrofinas
- c) Histerectomía
- d) Miomectomía
- e) Observación

65) Paciente de 34 años, sin antecedentes, consulta por atraso menstrual asociado a metrorragia abundante, náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas, útero a nivel suprapúbico y se palpan masas anexiales bilaterales no sensibles. El diagnóstico más probable es:

- a) Embarazo normal
- b) Aborto en evolución
- c) Adenomiosis
- d) Embarazo gemelar
- e) Embarazo molar

72) Una mujer de 34 años, multípara de dos, cursando embarazo de veinte semanas, con antecedente de dos partos prematuros a las 20 y 24 semanas, asintomática, acude a control. Su examen físico es normal, útero a nivel umbilical. Se realiza cervicometría de control, la cual muestra cuello de 20mm. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Solicitar perfil biofísico
- b) Indicar corticoides y antibióticos, manteniendo una conducta expectante
- c) Realizar cerclaje
- d) Administrar tocolisis y corticoides, manteniendo una conducta expectante
- e) Aplicar estrógenos tópicos

75) Embarazada de 35 semanas, multípara de 2, refiere pérdida de líquido claro abundante por genitales, no asociado a otros síntomas. A la especuloscopia no se observa líquido saliendo del orificio cervical externo. Se realiza registro basal no estresante que se encuentra reactivo. El examen de elección para evaluar a esta paciente es:

- a) Ecografía
- b) Test de nitrazina
- c) Test de cristalización
- d) Detección de alfa 1 microglobulina placentaria
- e) Medición del pH vaginal

79) Una paciente de 26 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por historia de tres meses de amenorrea asociada a galactorrea, sin otros síntomas, con prueba de detección de bHCG en orina negativa en dos oportunidades. Su examen físico resulta normal, su índice de masa corporal es de 20. El examen de elección para iniciar el estudio en este caso es:

- a) Hormona estimulante tiroidea
- b) Prueba de progesterona
- c) Ecografía transvaginal
- d) Prolactina
- e) Prueba de estrógeno más progesterona

88) Una mujer de 35 años, multípara de uno, cursando embarazo de 28 semanas, consulta por dolor abdominal, sin otros síntomas. Al examen se aprecia presencia de contracciones uterinas de tres en diez minutos, al tacto vaginal se palpa cuello con un centímetro de dilatación, 50% borrado. Se realiza ecografía transvaginal que muestra cérvix de 18 mm. El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:

- a) Atosiban
- b) Nifedipino
- c) Fenoterol
- d) Progesterona

e) Sulfato de magnesio

3) Un adolescente de 13 años, con antecedentes familiares de cáncer de mama, es traído por presentar aumento de volumen en mama derecha, asociado a hipersensibilidad local, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia mama derecha aumentada de volumen y a la palpación, destaca tumoración de consistencia gomosa y fácil de movilizar, desarrollo puberal normal para su edad, sin otros hallazgos. Se solicita ecografía mamaria que muestra nódulo de bordes lisos de 5 milímetros de diámetro. La conducta más adecuada es:

a) Solicitar estudio genético

b) Tranquilizar a los padres y al paciente, y controlar en un año

c) Indicar tratamiento hormonal y controlar

d) Realizar mastectomía parcial

e) Realizar biopsia estereotáxica

6) Una mujer de 34 años, cursando su primer embarazo de 36 semanas, refiere salida de abundante líquido por los genitales, no asociado a otros síntomas. A la especuloscopia vaginal no se observa salida de líquido por el orificio cervical externo, al tacto vaginal se palpa cuello sin dilatación, de localización posterior y duro, sin borramiento. Se realiza ecografía abdominal que muestra oligoamnios. La conducta más adecuada en este caso es:

a) Indicar antibióticos profilácticos y mantener conducta expectante

b) Inducir parto con misoprostol

c) Realizar cesárea

d) Inducir parto con oxitocina

e) Solicitar perfil biofísico para tomar conducta definitiva

16) Mujer de 29 años, cursando embarazo de 33 semanas, consulta por presentar metrorragia escasa en una oportunidad no asociado a otros síntomas. Al examen físico no se aprecia sangre proveniente del orificio cervical externo, resto normal. Se realiza registro basal no estresante que resulta reactivo. El diagnóstico más probable en este caso es:

a) Rotura de vasa previa

b) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera

c) Placenta previa

d) Rotura uterina

e) Sinusorragia

18) Embarazada de 30 semanas, sin antecedentes, consulta por lesiones eritematosas en antebrazos, genitales, manos y tronco, asociadas a prurito. Al examen físico se aprecian lesiones eritematosas pápulares y maculares en patrón sinuoso, con signos de grataje, por lo que se decide realizar un ácaro test, que resulta positivo. El tratamiento de elección, en este caso es:

a) Permetrina oral

b) Puvaterapia

c) Corticoides locales

d) Permetrina tópica al 5%

e) Vaselina azufrada

25) Una mujer de 27 años, nulípara, usuaria de anticonceptivos orales por seis años, consulta por amenorrea de cinco meses de evolución, no asociado a otros síntomas. Su examen físico es normal. La conducta más adecuada en este caso es:

a) Solicitar niveles de prolactina, tirotropina, hormona folículoestimulante y estrógenos

- b) Solicitar prueba de estrógeno y progesterona
- c) Indicar anticonceptivos orales combinados
- d) Observar evolución por un año
- e) Indicar uso de agonistas de las gonadotrofinas y controlar en un mes

34) Una paciente de 23 años, nulipara, consulta por presentar metrorragia desde ayer, no asociado a otros síntomas. Se realizó prueba de embarazo en orina que resultó positiva. Al examen físico se aprecia sangre proveniente del orificio cervical externo. Se realiza ecografía transvaginal que muestra útero sin alteraciones y una masa anexial derecha solidoquística de tres centímetros de diámetro. Además se solicitan niveles de gonadotrofina coriónica que se encuentran en 700 mUI/mL. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Indicar tratamiento con metotrexato
- b) Controlar con niveles de gonadotrofina coriónica y ecografía transvaginal en 48 horas**
- c) Controlar con nueva ecografía transvaginal en siete días
- d) Hospitalizar y realizar salpingectomía derecha
- e) Indicar reposo y controlar con niveles de gonadotrofina coriónica y ecografía transvaginal en siete días

44) Embarazada de 37 semanas, primigesta, presenta contracciones uterinas desde hace dos horas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se constata dinámica uterina de dos contracciones en 10 minutos y auscultación de latidos cardiorfetales normal. Se realiza tacto vaginal donde se aprecia borramiento del 100% y tres centímetros de dilatación. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Realizar cesárea
- b) Administrar tocolíticos
- c) Indicar antibióticos y corticoides
- d) Conducir trabajo de parto**
- e) Solicitar perfil biofísico

50) Una paciente de 38 años, cursando embarazo de 36 semanas, consulta por cuadro de una hora de evolución caracterizado por epigastralgia asociada a cefalea, sin otros síntomas. En el examen físico presenta dolor a la palpación de hipocondrio derecho, asociado a exaltación de los reflejos osteotendíneos. Al tacto vaginal se palpa cuello duro y posterior. Se auscultan latidos cardiorfetales con variabilidad francamente disminuida. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Realizar cesárea de urgencia**
- b) Inducir con oxitocina
- c) Inducir con misoprostol
- d) Lateralizar a izquierda
- e) Hospitalizar y esperar a las 37 semanas para realizar interrupción

59) Una pareja joven consulta por infertilidad, refieren que llevan 15 meses intentando tener hijos pero no han tenido resultado, ambos no tienen hijos anteriormente. El hombre trae consigo espermiograma que se realizó hace dos semanas que está normal. Ella nunca ha utilizado anticonceptivos orales y refiere ciclos menstruales normales, su examen físico resulta normal. El examen de elección para continuar el estudio de infertilidad en este caso es:

- a) Repetir espermiograma
- b) Test post coital**
- c) Laparoscopia
- d) Histeroscopia
- e) Histerosalpingografía

Comentario : De elección es el seguimiento folicular, que no está dentro de las alternativas. El test postcoital requiere de un seguimiento folicular y se le pide que tengan relaciones el día previo a la ovulación (se sabe ese día por el Seguimiento folicular ecográfico), de modo de evaluar el factro cervical además. Los demás exámenes son de segunda o tercera línea

63) Una paciente de 16 años, sin antecedentes, es traída por no presentar aún menarquia, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia talla de 1.53 metros y desarrollo puberal tanner 1, sin otros hallazgos. Se realiza test de progesterona que resulta negativo. El diagnóstico más probable en este caso es:

- a) Anovulación
- b) Malformación uterina
- c) Hipopituitarismo
- d) Hipotiroidismo
- e) Síndrome de turner**

69) Una paciente de 48 años, consulta por episodios de calor y enrojecimiento de la cara y la zona superior del tórax, que duran algunos minutos y ceden espontáneamente, no ha presentado menstruación en los últimos doce meses. Su examen físico es normal. Refiere antecedente de hermana con cáncer de mama. ¿Cuál de los siguientes fármacos indicaría como terapia de reemplazo hormonal en esta paciente?

- a) Tibolona**
- b) Estrógenos y progestágenos orales
- c) Estrógenos transdérmicos
- d) Tamoxifeno
- e) Venlafaxina

74) Una paciente de 25 años, cursando embarazo de 35 semanas, acude a control ginecológico asintomática. Su examen físico es normal. Se realiza ecografía donde se estima peso fetal en percentil 8 para su edad gestacional. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Realizar perfil biofísico
- b) Medición del flujo cerebral y umbilical**
- c) Medición del flujo de arterias uterinas
- d) Realizar ecografías seriadas
- e) Interrupción del embarazo

79) Una paciente de 43 años, sin antecedentes, consulta por aparición de nódulo mamario, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se palpa nódulo pequeño, no adherido, de consistencia gomosa, sin presencia de adenopatías axilares. Se realiza mamografía inicialmente que es informada como BIRADS 0, por lo que se solicita ecografía mamaria que muestra un nódulo sólido de bordes regulares, con paredes lisas de dos milímetros. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Control con mamografía anual
- b) Realizar biopsia estereotáxica
- c) Realizar tumorectomía con biopsia rápida
- d) Indicar estrógenos orales y controlar al año con nueva ecografía
- e) Control con ecografía en seis meses**

88) Una paciente de 26 años, sin antecedentes, consulta por secreción vaginal asociada a prurito. Al examen físico se aprecia liquenificación y signos de grataje a nivel vulvar, a la especuloscopia se aprecia leucorrea blanquecina. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:

- a) Metronidazol

b) Fluconazol

- c) Miconazol
- d) Doxiciclina
- e) Ceftriaxona

115) Una paciente de 17 años, con IMC de 34, presenta oligomenorrea, desde su primera menstruación. Además tiene acné y se observa hirsutismo en la cara, los pezones e intermamario. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

- a) Testosterona plasmática
- b) Andrógenos totales
- c) Prueba de progesterona

d) Índice de andrógenos libres

- e) 17 hidroxiprogesterona

155) Una paciente se realiza un legrado por un aborto espontáneo. La biopsia es informada como “mola completa”. Su HCG postlegrado es de 750 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Seguir la con niveles seriados de HCG

- b) Realizar biopsia endometrial
- c) Indicar anticonceptivos con progestágeno solo
- d) Repetir el legrado
- e) Indicar metotrexato

156) Una mujer de 65 años, cuya menopausia fue a los 57 años, consulta por metrorragia de 20 días de evolución. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra dos miomas, uno submucoso de 16 mm y el otro subseroso de 44 mm, con endometrio de 16 mm de grosor. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar miomectomía
- b) Observar evolución
- c) Realizar histerectomía
- d) Iniciar terapia de remplazo hormonal

e) Realizar biopsia endometrial

157) Una paciente se realiza un PAP, que es informado como probable NIE-3, por lo que se realiza colposcopia, que no visualiza ninguna lesión exocervical. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Controlar con nuevo PAP en un año
- b) Realizar conización con asa LEEP
- c) Realizar curetaje endocervical

d) Cono frío

- e) Histerectomía

158) Una paciente de 60 años consulta por dolor abdominal de 6 meses de evolución. Al examen físico se palpa una masa anexial derecha, de 8 cm de diámetro, con ascitis significativa. La ecografía transvaginal muestra una masa anexial, multiloculada, con incrementos y excrecencias. Su Ca-125 resulta 700 UI/L. Se realiza un TAC que muestra engrosamiento peritoneal, probablemente de origen tumoral y se observa un tumor adosado a la pared gástrica y hepática. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Derivar a cuidados paliativos
- b) Terapia de remplazo hormonal
- c) Cirugía más quimioterapia

d) Quimioterapia paliativa

e) Tamoxifeno

159) Una mujer tiene un PAP alterado, por lo que se realiza una colposcopia y biopsia, que es informada como lesión de bajo grado/VPH. ¿A qué evolucionará con mayor probabilidad esta lesión?

a) Involución espontánea

b) NIE 2

c) Carcinoma in situ

d) Condiloma acuminado

e) Cáncer de cuello uterino

160) Una paciente primigesta, cursando un embarazo de 37 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas, 3 en 10 minutos. Tiene 8 cm de dilatación, con 100% de borramiento, con feto en posición podálica y registro fetal tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Tocolíticos

b) Reversión interna

c) Reversión externa

d) Fórceps

e) Operación cesárea

161) Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una altura uterina de 28 cm. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra un feto creciendo en percentil 8, con ILA de 8 cm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Inducir el parto con misoprostol

b) Realizar registro basal no estresante

c) Observar evolución

d) Realizar doppler materno fetal

e) Realizar operación cesárea

162) Una paciente de 30 años, con antecedente de absceso tubo-ovárico drenado, consulta por metrorragia y dolor pélvico. Es usuaria de DIU y tiene atraso menstrual de 5 semanas. Al examen físico presenta dolor a la palpación del hipogastrio y del fonde del saco de Douglas. Su PA es de 100/60 mmHg y su FC es de 90x'. Se realiza beta-HCG, que resulta 5.500 UI/L, hemograma con leucocitosis de 14.000 por mm³ y ecografía transvaginal, que muestra DIU in situ, endometrio engrosado y líquido libre en el fondo de saco de Douglas. El diagnóstico más probable es:

a) Enfermedad inflamatoria pélvica

b) Aborto incompleto

c) Embarazo molar

d) Endometritis

e) Embarazo ectópico

163) Una paciente de 34 años presenta hemorragia puerperal luego del parto. Recibe 10 unidades de oxitocina por vía endovenosa, pero persiste con hemorragia. Se palpa el útero por sobre el ombligo, blando. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Administrar 10 UI de oxitocina por vía endovenosa

b) Administrar 0,2 mg de metilergonovina por vía intramuscular

c) Administrar 800 µg de misoprostol por vía rectal

d) Realizar ligadura de las arterias hipogástricas

e) Realizar exploración manual de la cavidad endometrial

164) Una paciente, que cursa un embarazo de 30 semanas de edad gestacional, inicia contracciones uterinas de 3 en 10 minutos. Su tacto vaginal muestra un cuello con 80% de borramiento y 3 cm de dilatación. Se administra nifedipino y la primera dosis de corticoides. Se reevalúa a las 2 horas y persiste con la dinámica uterina de 3 a 4 contracciones en 10 minutos, con 4 cm de dilatación, por lo que se realiza amniocentesis, que da salida a un líquido con escasas bacterias a la tinción de Gram. ¿Cuál es la conducta más adecuada? a) Dejar a evolución espontánea

b) Administrar la segunda dosis de corticoides

c) Determinar madurez fetal en líquido amniótico

d) Realizar operación cesárea

e) Administrar tocolíticos de segunda línea

165) Una paciente de 35 años, multípara de 1, cursando un nuevo embarazo de 35 semanas, presenta rotura prematura de membranas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Realizar operación cesárea

b) Realizar amniocentesis

c) Interrumpir el embarazo

d) Administrar tocolíticos

e) Administrar antibióticos y mantener una conducta expectante

166) Una mujer de 25 años, primigesta, cursando su embarazo de 22 semanas, se realiza una cervicometría, que muestra un cuello de 25 mm de largo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Mantener conducta expectante

b) Indicar progesterona oral

c) Indicar progesterona vaginal

d) Realizar cerclaje

e) Administrar corticoides

167) Una paciente de 35 años, multípara de 2, tiene un embarazo de 30 semanas. Consulta porque inició contracciones uterinas dolorosas, hace pocas horas. Al examen tiene un cuello 80% borrado, con 2cm de dilatación y 3 contracciones uterinas cada 10 minutos. El registro fetal no muestra alteraciones. ¿Cuál es la medida más importante ante esta paciente?

a) Antibióticos

b) Tocólisis

c) Conducir el trabajo de parto

d) Cerclaje

e) Interrumpir el embarazo

168) Una paciente, primigesta, presenta 4 semanas de atraso menstrual, por lo que se realiza test de embarazo, que resulta positivo. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra un saco gestacional intrauterino, con un embrión de 3 mm, sin latidos. La beta-HCG resulta 6.800 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Repetir la beta-HCG en 48 horas

b) Indicar metotrexato

c) Realizar nueva ecografía en 7 días

d) Realizar legrado en 14 días

e) Realizar legrado inmediatamente

169) Una paciente embarazada de 38 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas. Al tacto vaginal tiene 3 cm de dilatación, con borramiento de 50% y presentación en vértice. Se realiza un registro cardiaco fetal, que se muestra a continuación:



¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar anestesia epidural
- b) Realizar cesárea
- c) Solicitar ecodoppler umbilical
- d) Enviar a domicilio y pedirle que reconsulte en unas horas
- e) Conducir el trabajo de parto**

170) Una paciente presenta embarazo de término. Inicia trabajo de parto con 3-4 contracciones uterinas cada 10 minutos y dilatación cervical de 6 cm. El registro fetal muestra variabilidad disminuida de la frecuencia cardiaca fetal. A las 2 horas mantiene dinámica uterina, tiene dilatación de 8 cm y el registro muestra variabilidad disminuida, pero además, presencia de desaceleraciones tardías, en relación a cada contracción uterina. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar fórceps
- b) Realizar operación cesárea**
- c) Administrar misoprostol
- d) Iniciar oxitocina en goteo

e) Mantener una conducta expectante y reevaluar en 30 minutos

171) Una mujer de 36 años, multípara de 3, con su último parto hace 3 años, tiene antecedente personal de cáncer de mama, que fue adecuadamente tratado hace 1 año. ¿Qué método de planificación familiar debe utilizar?

- a) Anticonceptivos orales combinados, con microdosis de estrógeno
- b) Anticonceptivos orales con estrógeno solo
- c) Progestágeno inyectable
- d) Anillo vaginal con progestágeno
- e) Dispositivo intrauterino

172) Una paciente consulta por leucorrea, asociada a prurito vaginal importante. Al examen físico se observa vulvovaginitis, con leucorrea de mal olor, con pH de 5,8 y test de KOH positivo. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

- a) Metronidazol a la paciente y a su pareja
- b) Tinidazol
- c) Clindamicina
- d) Fluconazol a la paciente y a su pareja
- e) Azitromicina

173) Una paciente de 65 años, nulípara, asintomática, se realiza una ecografía tranvaginal, que muestra un tumor anexial izquierdo, de 23 mm, de aspecto quístico, con paredes lisas, sin tabiques ni excrecencias y sin presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar laparoscopia
- b) Iniciar terapia de reemplazo hormonal
- c) Solicitar marcadores tumorales
- d) Realizar punción del quiste
- e) Realizar control ecográfico en 3 meses

174) Una paciente se realiza un legrado por un aborto retenido, a las 11 semanas de amenorrea. Cuarto día después evoluciona con dolor hipogástrico y metrorragia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Embarazo molar
- b) Restos ovulares
- c) Embarazo ectópico
- d) Endometritis
- e) Rotura uterina

175) Una paciente de 17 años, que está en su día 16 del ciclo menstrual, consulta por dolor abdominal bajo, mayor al lado izquierdo. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. Su examen ginecológico demuestra dolor a la palpación anexial izquierda y la ecografía transvaginal muestra un quiste anexial izquierdo, heterogéneo, con escaso líquido libre en el fondo del saco de Douglas. La conducta más adecuada es:

- a) Controlar con ecografía postmenstrual
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar marcadores tumorales
- d) Realizar laparoscopia
- e) Realizar laparotomía

176) Una paciente cursa un embarazo de 24 semanas y es diagnosticada de infección urinaria baja, por Escherichia coli sensible, que se resuelve adecuadamente, luego de tratamiento antibiótico por 7 días. Tiene antecedente de una bacteriuria asintomática, tratada a las 16 semanas de embarazo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar urocultivo semanal
- b) Solicitar pielografía de eliminación
- c) Indicar aumento del consumo de agua
- d) Indicar nitrofurantoína a permanencia**
- e) Indicar profilaxis, con jugo de cranberry

177) Una paciente de 34 años consulta por genitorragia y sinusorragia, por lo que se realiza una especuloscopia, que muestra una lesión cervical ulcerada, friable. La conducta más adecuada es:

- a) Colposcopia y biopsia**
- b) Conización cervical
- c) Seguimiento ecográfico
- d) Citología cervica
- e) Buscar virus papiloma humano

178) Una mujer de 65 años, nulípara, con IMC de 33, sin síntomas, se realiza un PAP que muestra abundantes células endometriales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Controlar con nuevo PAP en un año
- b) Indicar estrógenos tópicos
- c) Solicitar colposcopia y biopsia
- d) Realizar curejate endocervical
- e) Solicitar ecografía transvaginal**

JULIO 2016

2) Una paciente de 27 años de edad, con antecedente de parto hace 9 meses, dandolactancia materna parcial, consulta porque no ha iniciado sus menstruaciones aún. Está usando medroxiprogesterona inyectable intramuscular 150 mg cada 3 meses, como anticonceptivo. Su test de embarazo ha resultado negativo en más de una oportunidad. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar prueba de progesterona
- b) Solicitar TSH y prolactina
- c) Solicitar niveles HCG en sangre venosa
- d) Mantener el tratamiento**
- e) Solicitar ecografía transvaginal

3) Una paciente consulta por atraso menstrual de 7 semanas y trae test de embarazo en orina, que resulta positivo. Se realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza embarazo intrauterino y que constata la presencia de un tumor anexial derecho, complejo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar niveles de HCG en sangre**
- b) Solicitar una nueva ecografía transvaginal en 7 días
- c) Solicitar marcadores tumorales en sangre
- d) Solicitar proteína plasmática asociada al embarazo
- e) Solicitar niveles de progesterona y estradiol

16) Una paciente de 34 años, multípara, embarazada de 36 semanas, presenta pérdida

de líquido amniótico hace una hora, confirmándose rotura de membranas, con la prueba de microglobulina placentaria. La ecografía obstétrica muestra disminución del líquido amniótico, con presentación cefálica, y con bienestar fetal ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Realizar cesárea

b) Administrar corticoides

c) Inducir el parto

d) Esperar 48 horas para inicio espontáneo del trabajo de parto

e) Administrar antibióticos

18) Una paciente de 40 años, cursando un embarazo de 24 semanas, se realiza ecografía obstétrica, que visualiza a los vasos umbilicales en las membranas amnióticas y al cordón umbilical, que se inserta en la zona marginal inferior de la placenta. La conducta más adecuada es:

a) Solicitar una nueva ecografía el tercer trimestre

b) Observar evolución

c) Realizar rotura de membranas tardía

d) Realizar cesárea de inmediato

e) Administrar corticoides e interrumpir el embarazo en 48 horas

32) Una paciente de 14 años aún no ha tenido su menarquía. Presenta desarrollo

puberal Tanner 2, mamario y pubiano, con vello axilar. No tiene otras alteraciones en el examen físico. La conducta más adecuada es:

a) Solicitar ecografía ginecológica

b) Solicitar cariotipo

c) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH

d) Realizar prueba de progesterona

e) Controlar en un año

36) Un mujer de 33 años, cursando con un embarazo de 26 semanas, sufre un accidente de tránsito, por lo que es llevada al servicio de urgencias, constatándose metrorragia moderada. Desde el punto de vista obstétrico, lo primero que se debe evaluar es:

a) La vitalidad fetal

b) La ubicación placentaria

c) La dilatación cervical

d) La dinámica uterina

e) La integridad de las membranas

37) Mujer de 25 años, con embarazo de 15 semanas, presenta unVDRL positivo en dilución 1/16. Refiere ser alérgica a la amoxicilina, con una reacción alérgica, que requirió hospitalización, cuando presentó una infección faríngea en la infancia. La conducta más adecuada es:

a) Tratar con penicilina benzatina, administrando una dosis ahora y otra en una semana.

b) Pedir ANA y anticuerpos anti-DNA

c) Solicitar FTA-abs

d) Tratar con eritromicina

e) Tratar con ceftriaxona

38) Una paciente de 31 años, cursando un embarazo de 28 semanas, sin alteraciones hasta el momento, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que resulta 75 mg/dl basal y 160 mg/dl a las 2 horas de la carga de glucosa. El diagnóstico más probable es:

a) Intolerancia a la glucosa

b) Diabetes gestacional

c) Diabetes pregestacional

d) Diabetes mellitus 2

e) Resistencia a la insulina

40) Una paciente multipara, con un parto anterior por cesárea, cursando con un nuevo embarazo de 35 semanas, consulta por metrorragia moderada. Al examen físico presenta una contracción uterina cada diez minutos y se realiza ecografía que visualiza una placenta posterior que sobrepasa en dos centímetros al orificio cervical. El ecodoppler materno-fetal es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Administrar tocolíticos

b) Inducir el parto con misoprostol

c) Administrar corticoides para maduración pulmonar

d) Repetir la ecografía a las 37 semanas

e) Realizar cesárea

47) Una paciente de 35 años, usuaria de dispositivo intrauterino, hace 9 años, consulta por un cuadro de dolor pélvico, que aumentó en la última menstruación. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra una lesión quística de 6 cm en el ovario derecho, con contenido denso. Se solicitan niveles de Ca-125 que resultan 160 UI/ml (VN: menor a 35). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Quiste folicular

b) Cáncer de ovario inicial

c) Quiste endometriósico

d) Cáncer de ovario avanzado

e) Teratoma ovárico

51) Una paciente de 20 años, consulta por dolor intenso en la fosa iliaca izquierda, de 3

horas de evolución, que se ha asociado a vómitos. Al examen físico está afebril, con signos vitales normales y al examen abdominal presenta intenso dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, con signo de Blumberg y resistencia muscular. No presenta atraso menstrual. Se solicita ecografía ginecológica, que muestra útero y ovario derecho normales y ovario izquierdo, con aumento de tamaño y presencia de un quiste de 6 x 4 cm, sin flujo al doppler y sin visualización de líquido peritoneal libre. El diagnóstico más probable es:

- a) Endometrioma
- b) Cuerpo lúteo hemorrágico
- c) Quiste ovárico torcido**
- d) Teratoma ovárico
- e) Embarazo ectópico

56) Una paciente multipara, de 40 años, cursando un embarazo de 32 semanas, se realiza una ecografía obstétrica, que muestra líquido amniótico sin alteraciones, con un feto creciendo en percentil 10 para la edad gestacional, con un peso fetal estimado de 1.320 gramos. ¿Cuál es la actitud más adecuada?

- a) Observar evolución
- b) Solicitar ecodoppler uterina

c) Solicitar ecodoppler umbilical

- d) Repetir la ecografía obstétrica en 2 semanas
- e) Inducir maduración pulmonar con corticoides

63) Una niña 14 años consulta por talla baja. Tiene IMC/edad: p65, Talla/edad: – 2 DS, cabello de implantación baja, cuello alado, mamas y vello púbico en Tanner 1. Trae radiografía de mano, con edad ósea de 11 años. ¿Con que examen debe continuar el

estudio?

a) Hemograma

b) Cariotipo

c) Anticuerpos antitransglutaminasa

d) LDH

e) Hormona de crecimiento

66) Paciente de 35 años, múltipara, con un nuevo embarazo de 32 semanas, presenta salida de líquido amniótico por genitales. El test de cristalización confirma rotura prematura ovular. Al examen físico se constata taquicardia materna y fetal, asociada a contracciones uterinas dolorosas y útero doloroso a la palpación. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Inducir el parto

b) Realizar cesárea

c) Administrar corticoides

d) Administrar antibióticos

e) Administrar tocolíticos

76) Una mujer de 65 años de edad, múltipara de 4, con todos los partos por vía vaginal, con menopausia a 50 años, sin terapia de reemplazo hormonal, presenta escape de pequeñas cantidades de orinal, al realizar esfuerzos, así como al toser o reírse, lo que la obliga a usar protectores. No tiene urgencia miccional. Su examen físico no aporta mayor información, pero es posible visualizar leve escape de orina, al toser. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para esta paciente?

a) Cirugía (TVT)

b) Anticolinérgicos

c) Alfa adrenérgicos

d) Kinesioterapia del piso pélvico

e) Antibióticos, como profilaxis de ITU

85) Una paciente de 15 años, consulta por hipermenorrea y menometrorragia, de Se solicita una ecografía transvaginal, que no muestra lesiones, ni alteraciones uterinas ni ováricas. El endometrio tiene 5 mm de grosor. Su hemograma muestra anemia leve, con glóbulos blancos: 7.000 por mm³ y plaquetas: 250.000 por mm³. La conducta más adecuada es:

a) Realizar biopsia de endometrio

b) Solicitar estudio de alteraciones de la hemostasia

c) Solicitar estudio de trombofilias

d) Solicitar resonancia magnética nuclear abdominopélvica

e) Solicitar endosonografía uterina (histerosonografía)

88) Paciente de 30 años, multípara de 1 parto vaginal, presenta parto de termino, con 4 cm de dilatación, membranas rotas, se administra anestesia peridural, presentando PA 100/65 mmHg, LCF 90/min y 6 contracciones uterinas cada 10 minutos. La conducta más adecuada es:

a) Administrar volumen y monitorización fetal

b) Realizar cesárea de urgencia

c) Iniciar tocolisis de urgencia

d) Realizar fórceps

e) Iniciar amniotransfusión

97) Mujer 54 años obesa, diabética e hipertensa, presenta hace 3 meses genitorragia intermitente, con antecedentes de menopausia a los 50 años, sin terapia hormonal de

reemplazo y PAP normal de este año. El examen físico y ginecológico es normal. Se realiza una Ecografía tranvaginal, que muestra: útero en anteversoflexión, con tamaño normal, endometrio homogéneo de 3 mm de grosor, con anexos normales, sin líquido libre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hiperplasia endometrial.
- b) Cáncer endometrial
- c) Pólipo endometrial
- d) Atrofia endometrial.**
- e) Sarcoma uterino

100) Una paciente primigesta, cursando un embarazo de 38 semanas, presenta presiones arteriales cercanas a 150/90 mmHg. Está en buenas condiciones generales, sin exaltación neurológica, ni otros síntomas. Se solicita proteinuria de 24 horas, que resulta 400 mg. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar ecodoppler de arterias umbilicales
- b) Realizar operación cesárea
- c) Solicitar monitoreo fetal no estresante
- d) Inducir el parto**
- e) Repetir la proteinuria en 2 semanas

106) Una paciente primigesta de 40 años, con amenorrea de 8 semanas, se realiza un test de embarazo en orina, que resulta positivo. Se realiza ecografía transvaginal, que visualiza saco generacional de 15 mm diámetro, con saco vitelino, pero no se observa embrión. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir la ecografía en 7 días**
- b) Observar evolución por 30 días
- c) Realizar legrado

d) Administrar misoprostol

e) Solicitar betaHCG y niveles de progesterona

107) Una paciente de 56 años de edad presenta metrorragia abundante, que requiere de legrado. Se envía a biopsia, que es informada, como hiperplasia endometrial atípica y compleja. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Anticonceptivos combinados

b) Solicitar niveles de estradiol y FSH

c) Progestágenos orales en altas dosis

d) Histerectomía total

e) Progestágenos endovaginales

110) Un paciente de 24 años mantiene relaciones sexuales, por vía vaginal, sin protección, evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

a) Trichomona vaginalis

b) Treponema pallidum

c) Ureaplasma urealyticum

d) Mycoplasma genitalis

e) Chlamydia trachomatis

124) Una paciente, cursando embarazo de término, inicia contracciones uterinas intensas. Al examen obstétrico, se palpan 3 contracciones cada 10 minutos y dilatación cervical de 5 cm. Al romper las membranas, se produce metrorragia moderada, seguida de bradicardia fetal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Rotura uterina

b) Desprendimiento de placenta normoinserta

c) Placenta previa

d) Rotura de vasa previa

e) Procidencia de cordón umbilical

131) Mujer de 85 años tiene el diagnóstico de incontinencia urinaria de urgencia. Su examen ginecológico es normal, y trae un examen de orina, que resulta normal. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el mas indicado para el manejo de esta paciente?

a) Amitriptilina

b) Imipramina

c) Oxibutinina

d) Tolterodina

e) Trazodona

133) Una mujer de 34 años, cursando un embarazo de 24 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que resulta 205 a las 2 horas.

Además de dieta y ejercicio, el tratamiento de elección es:

a) Acarbosa

b) Sitagliptina

c) Metformina

d) Insulina

e) Glibenclamida

134) Una mujer de 55 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 4, con microcalcificaciones agrupadas. ¿Cuál es la conducta mas adecuada?

a) Ecotmografía mamaria

b) Biopsia estereotáctica.

c) Resonancia magnética

d) Control mamográfico en 6 meses

e) mastectomía parcial

137) Una paciente de 23 años, cursando un embarazo de 7 semanas, presenta un cuadro de disuria y polaquiuria, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli sensible, con más de 100.000 UFC. El tratamiento más adecuado es:

a) Cotrimoxazol

b) Flucloxacilina

c) Nitrofurantoína

d) Levofloxacino

e) Ciprofloxacino

140) Puérpera de 15 días, inicia disnea y tos, asociada a expectoración, hemoptoica. Al examen pulmonar tiene murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos y saturación 90% a FiO2 ambiental. El diagnóstico más probable es:

a) Tromboembolismo pulmonar

b) Neumonía adquirida en la comunidad

c) Neumonía intrahospitalaria

d) Tuberculosis pulmonar

e) VIH

145) Una paciente de sexo femenino de 17 años de edad, con antecedente de relaciones sexuales sin protección, consulta prurito vulvar, asociado a ardor progresivo. Refiere sensación de aumento del volumen de la vulva, que luego fue seguido por los síntomas actuales. Al examen físico se observa lo expuesto en la siguiente imagen.

FOTO: Se ve la vulva con múltiples ulceraciones.

Se trata de una infección por:

a) Treponema pallidum

b) Virus herpes simplex

c) Chlamydia trachomatis

d) Virus papiloma humano

e) Ureaplasma urealyticum

148) Una paciente de 42 años se realiza un histerectomía radical, por un cáncer de cuello uterino. Evoluciona con bochornos, cefalea y dispareunia profunda, por resequeidad vaginal. Al examen físico tiene sobrepeso y presión arterial normal. Además trae exámenes en los que destaca Colesterol total: 204 mg/dl, Colesterol HDL: 54 mg/dl, Triglicéridos: 405 mg/dl. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

a) Estrógenos más progestágenos orales

b) Estrógenos orales

c) Estrógenos en parches

d) Progestágenos endovaginales

e) Sertralina

149) Una paciente de 25 años, con atraso menstrual de 3 semanas, consulta por dolor abdominal de 5 días de evolución, que ha ido en aumento. Al examen físico presenta abdomen doloroso a la palpación abdominal baja, mayor en la fosa iliaca izquierda, sin signos peritoneales. Además se realiza una HCG, que resulta 5.500 UI/L y se solicita una Ecografía Transvaginal, que visualiza útero sin gestación intrauterina, con endometrio de 15 mm, y un tumor anexial izquierdo de 53 mm de diámetro, de aspecto complejo, sin líquido libre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Realizar laparoscopia exploradora

b) Realizar laparotomía exploradora

c) Indicar metotrexato

d) Solicitar ecografía en 7 días

e) Solicitar niveles de HCG y ecografía en 48 horas

150) Una paciente de 46 años, nulípara, sin método anticonceptivo, presenta una metrorragia, que es manejada con legrado uterino. La biopsia demuestra presencia de

hiperplasia endometrial atípica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Repetir el legrado en 3 meses

b) Implantar DIU medicado con progestágenos

c) Realizar histerectomía total

d) Indicar progestágenos cíclicos

e) Indicar progestágenos continuos

165) Una paciente se realiza un PAP, que es informado como probable lesión de bajo

grado y presencia de virus papiloma humano. ¿Cuál es la conducta mas adecuada?

a) Vacunar contra virus papiloma humano

b) Realizar colposcopia y biopsia

c) Repetir el PAP en 6 meses

d) Realizar hibridación para serotipos oncogénicos de virus papiloma

e) Realizar PAP en fase líquida en 1 a 3 meses

166) paciente de 28 años de edad, con 34 semanas de gestación consulta por

metrorragia moderada. Al examen físico tiene presión arterial: 130/70 mmHG y FC:

107x', útero doloroso e hipertónico y metrorragia escasa en la especuloscopia. Se realiza

ecografía obstétrica que resulta normal, con placenta posterior, sin signos de

desprendimiento. El doppler materno-fetal resulta normal normal y el cuello tiene 30

mm de longitud. La conducta mas adecuada con la paciente es:

a) Administrar nifedipino b) Inducción de parto

c) Repetir el doppler fetal en 7 días

d) Realizar rotura de membranas

e) Realizar cesárea

176) Una paciente de 43 años, multípara de 3, con antecedente de oligomenorrea,

presenta metrorragia abundante, por lo que se realiza una ecografía transvaginal, que muestra endometrio engrosado, por lo que se realiza una biopsia endometrial por técnica de Pipelle, que demuestra presencia de hiperplasia endometrial compleja, con células atípicas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar anticonceptivos combinados orales
- b) Indicar progestágenos orales en altas dosis

c) Realizar histerectomía total

- d) Repetir el legrado
- e) Indicar estrógenos orales en altas dosis

180) Mujer de 51 años consulta por metrorragia moderada de 10 días de evolución. Su última menstruación fue hace 6 meses. ¿Cuál es la causa mas probable de su hemorragia?

- a) Atrofia vaginal
- b) Hiperplasia endometrial
- c) Cáncer de endometrio
- d) Cáncer cervicouterino

e) Metrorragia disfuncional

DICIEMBRE 2015

17) Una paciente de 34 años, con antecedente de un by-pass gástrico en “y” de Roux, cursando un embarazo de 12 semanas, presenta un cuadro de astenia y adinamia. Al examen está pálida, sin disnea ni otros síntomas. Su FC: 80x' y su PA: 120/80 mmHg. Se realiza un hemograma que muestra anemia con Hb: 8,2 g/dl, hematocrito: 26%, VCM: 108 fl, HCM: 34 pg, plaquetas: 160.000 por mm³, glóbulos blancos: 5.000 por mm³, con 60% de neutrófilos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?.

- a) Indicar fierro v.o
- b) Administrar vitamina B12 i.m.**
- c) Indicar fierro e.v.
- d) Indicar vitaminas del complejo B v.o.
- e) Transfundir glóbulos rojos

19) Una paciente de 37 años presenta una hemorragia puerperal, profusa, por inercia uterina, que respondió a la administración de uterotónicos. Se le realiza un hemograma un hemograma al día siguiente, que muestra una hemoglobina de 8,6 g/dl. La indicación más adecuada es:

- a) Fierro v.o.**
- b) Fierro e.v.
- c) Transfusión de glóbulos rojos

- d) Observar evolución
- e) Indicación de eritropoyetina

49) Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 24 semanas se realiza una ecografía obstétrica, que muestra la placenta, cuya zona más baja se inserta en relación al borde del orificio cervical interno. ¿Cuál es la conducta más adecuada para programar la interrupción del embarazo en este caso?

- a) Realizar cesárea en este momento
- b) Inducir el parto con misoprostol en este momento
- c) Solicitar una nueva ecografía obstétrica en el tercer trimestre
- d) Realizar cesárea a las 37 semanas
- e) Inducir el parto con misoprostol a las 37 semanas

50) Una paciente de 30 años, a las 32 semanas de embarazo, presenta metrorragia de algunas horas de evolución, asociada a contracciones uterinas dolorosas. Al examen se palpan 2 contracciones cada 10 minutos e hipertonía uterina y la especuloscopia muestra la sangre saliendo del orificio cervical externo. Los latidos fetales se auscultan a 100x'. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Pedir una ecografía doppler umbilical
- b) Realizar cesárea de urgencia
- c) Inducir el parto con misoprostol
- d) Observar evolución
- e) Administrar tocolíticos de urgencia

51) Una paciente presenta 8 semanas de amenorrea, por lo que se realiza una prueba de embarazo, que resulta positivo. Se realiza una ecografía transvaginal que no visualiza saco gestacional. Se solicitan niveles plasmáticos de beta-HCH, que resultan 2.000 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Embarazo ectópico
- b) Aborto retenido
- c) Aborto completo
- d) Embarazo normal de menor edad gestacional
- e) Embarazo molar

52) ¿Cuál es la medida más importante para evitar la transmisión del VIH de la madre al recién nacido?

- a) Realizar operación cesárea
- b) Prohibir la lactancia materna
- c) Dar tratamiento a la madre durante el embarazo y el parto
- d) Dar tratamiento al recién nacido
- e) Dar tratamiento a la madre durante la lactancia

53) Una mujer de 18 años consulta por dolor genital, que aumenta al orinar. Además ha presentado fiebre y malestar general. Es sexualmente activa y al examen se aprecian adenopatías inguinales y se visualizan múltiples úlceras, en relación a los labios menores. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Tinidazol oral
- b) Ceftriaxona intramuscular
- c) Axitromicina oral
- d) Valaciclovir oral
- e) Fluconazol oral

68) Una mujer de 47 años consulta por bochornos, que aparecen con frecuencia. Está en amenorrea desde hace 9 meses y se realiza exámenes, que muestran FSH de 45 UI/L, colesterol total de 240 mg/dl y triglicéridos de 286 mg/dl. El tratamiento más adecuado es:

- a) Raloxifeno
- b) Estrógenos orales
- c) Estrógenos más progesterona por vía transdérmica.
- d) Sertralina
- e) Venlafaxina

76) Una mujer de 30 años, cursando un embarazo de 34 semanas sufre un accidente de tránsito. Al examen físico está en buenas condiciones generales y obstétricas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar ecografía obstétrica
- b) Monitorizar por 24 horas
- c) Realizar perfil biofísico fetal
- d) Realizar eco-doppler umbilical
- e) Interrumpir el embarazo

81) Una paciente, con embarazo de término, presenta trabajo de parto. Durante el expulsivo, se realiza episiotomía y avanza correctamente, produciéndose la salida de la cabeza fetal. Sin embargo, dos minutos después no avanza el trabajo de parto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Poner a la madre en posición genupectoral y realizar la extracción manual del hombro derecho
- b) Rotar el hombro posterior, hacia anterior, en el sentido del reloj
- c) Ampliar la episiotomía
- d) Traccionar la cabeza suavemente, hasta que se produzca el descenso
- e) Flectar las rodillas por sobre la pelvis y realizar compresión suprapúbica

98) Una paciente de 38 años presenta escapes de orina, asociados a intensos deseos de ir al baño, imposibles de controlar. Se realiza un sedimento de orina y urocultivos, que resultan normales y se solicita examen de urodinamia, cuya cistomanometría muestra contracciones no inhibidas del detrusor, que aparecen ante el llenado vesical de 80 a 100 cc. ¿Cuál es el tratamiento inicial para el manejo de esta paciente?

- a) Anticolinérgicos
- b) Reeducación vesical
- c) Antiadrenérgicos
- d) Ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico
- e) Cirugía de suspensión vesical

116) Una paciente de 40 años está en amenorrea desde hace 4 meses y ha presentado subida de peso de 8 kilogramos en dicho periodo. Al examen físico presenta FC: 67x', PA: 150/96, asociado a obesidad de predominio abdominal, con estrías vinosas en el abdomen. El examen de elección para iniciar el diagnóstico es:

- a) Cortisol matinal y vespertino
- b) Cortisol y ACTH a las 9 am
- c) TAC de glándulas suprarrenales
- d) RMN de la región sellar
- e) Cortisol libre urinario de 24 horas

138) Una paciente de 39 años, esterilizada quirúrgicamente hace 8 meses, presenta 4 semanas de atraso menstrual. Consulta por un cuadro de dolor abdominal, que inició el día de ayer y que se ha vuelto muy intenso en las últimas horas, agregándose malestar general y ortostatismo. Al examen físico presenta FC: 119x', PA: 80/40 mmHg, palidez de piel y mucosas y examen abdominal con abdomen blando, depresible, doloroso de manera difusa. ¿Cuál es el primer examen para enfrentar a esta paciente?

- a) Paracentesis
- b) TAC de abdomen y pelvis
- c) Ecoografía abdominal

d) Beta-HCG

e) Hemograma-VHS

139) Una paciente cursando un embarazo de 8 semanas por amenorrea, consulta por metrorragia escasa. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y examen físico sin otras alteraciones. La especuloscopia muestra escasa metrorragia proveniente del orificio cervical externo. Se realiza una ecografía transvaginal, que se muestra en la IMAGEN. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Repetir la ecografía en 48 horas

b) Solicitar niveles de beta-HCG

c) Repetir la ecografía en 7 días

d) Administrar metotrexato

e) Realizar legrado uterino

FOTO: ecografía transvaginal, con huevo anembrionado de 8,5 mm de diámetro.

140) Una mujer de 32 años consulta por dolor hipogástrico intenso, asociado a fiebre y malestar general. El dolor aumenta de intensidad en los últimos días y se agrega malestar general. Al examen físico está febril (temperatura: 37,9 grados celsius), presenta dolor a la palpación hipogástrica. El tacto vaginal muestra dolor a la palpación del cuello y dolor intenso a la palpación anexial derecha. Sus niveles de gonadotropina coriónica resultan 1,0 UI/L. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra líquido libre peritoneal en normal cantidad, sin otras alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Realizar seguimiento ecográfico

b) Realizar laparotomía

c) Realizar seguimiento con gonadotropina coriónica en 48 horas

d) Indicar antibióticos de amplio espectro

e) Administrar analgésicos y observar evolución

141) Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 42 semanas de edad gestacional, acude a control. Al examen físico está en buenas condiciones, no tiene dinámica uterina y el tacto vaginal muestra un índice de Bishop de 7. La ecografía obstétrica muestra a un feto de 3.650 gramos, en presentación cefálica y un bolsillo de líquido amniótico de 3 cm y el perfil biofísico resulta 10/10. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Realizar operación cesárea

b) Inducir el parto

c) Mantener una conducta expectante

d) Realizar amniocentesis

e) Solicitar ecografía doppler umbilical

142) Una mujer de 33 años, cursando un embarazo en la semana 37, tiene antecedente de un RCIU, creciendo en percentil 5. Se realiza una ecografía de control, que muestra al feto creciendo en el percentil 5 para la edad gestacional, con índice de líquido amniótico de 6. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Realizar cesárea

b) Inducir el parto con misoprostol

c) Realizar ecodoppler materno fetal

d) Realizar un perfil biofísico fetal

e) Mantener una conducta expectante

143) Una mujer de 33 años presenta salida de líquido amniótico por genitales a las 36 semanas de edad gestacional. Se palpa feto en cefálica y la paciente no presenta dinámica uterina. La frecuencia cardíaca fetal está en 120 lpm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Mantener una conducta expectante

b) Interrumpir el embarazo

- c) Administrar corticoides
- d) Administrar antibióticos
- e) Administrar tocolítico

144) Una paciente de 37 años, cursando un embarazo de 37 semanas, se realiza una ecografía obstétrica, que muestra feto en cefálica, con una circular de cordón al cuello y presencia de oligoamnios. No presenta dinámica uterina ni otras alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Mantener conducta expectante
- b) Realizar cesárea
- c) Inducir con misoprostol
- d) Solicitar perfil biofísico fetal**
- e) Solicitar un ecodoppler umbilical

145) Una paciente embarazada de término entra en trabajo parto. Al examen físico presenta 3 contracciones cada 10 minutos, feto en presentación cefálica y al tacto vaginal se constatan 5 cm de dilatación cervical, con membranas íntegras y cabeza fetal se palpa con descenso en espinas -1. Se realiza un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, que se muestra en la IMAGEN. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Mantener conducta expectante
- b) Iniciar oxitocina
- c) Realizar rotura artificial de membranas y administrar anestesia raquídea**
- d) Realizar cesárea
- e) Administrar misoprostol intrarrectal

FOTO: MEF1 1, con FCF basal en 130 y múltiples aceleraciones, variabilidad de 20-25 lpm y se ven 4 contracciones uterinas.

147) Una paciente de 41 años, obesa, está en amenorrea hace un año, con antecedente de reglas irregulares previo a eso. Consulta por dolor abdominal tipo cólico de 12 horas de evolución, que ha ido en aumento. Al examen físico se palpa útero grávido, con altura uterina de 26 cm y 3 contracciones uterinas cada 10 minutos. Al tacto vaginal se constatan 3 cm de dilatación cervical y cuello de 1 cm de longitud. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Pedir un perfil biofísico
- b) Pedir una ecografía obstétrica**
- c) Realizar cesárea
- d) Realizar una amniocentesis
- e) Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG

148) Una paciente se realiza una cesárea por parto en podálica. Luego de cerrar la cesárea y de realizar alumbramiento manual, no se produce retracción uterina y mantiene importante metrorragia, a pesar de haber administrado uterotónicos por vía endovenosa. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar ligadura compresiva de Belynych
- b) Realizar ligadura de las arterias hipogástricas
- c) Realizar ligadura de las arterias uterinas
- d) Realizar histerectomía
- e) Realizar revisión manual de la cavidad intrauterina**

149) Una paciente de 30 años, presenta parto vaginal, de un niño de 4.200 gramos de peso, persistiendo con importante metrorragia. Al examen físico tiene útero retraído y presenta una laceración del canal vaginal, la que es suturada, pese a lo cual persiste con sangramiento, observándose hemorragia en napa, que proviene del fondo de saco vaginal posterior (fórnix posterior). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar ácido tranexánico endovenoso
- b) Administrar misoprostol intrarrectal
- c) Realizar electrocoagulación de los puntos sangrantes
- d) Realizar sutura de los puntos sangrantes
- e) Realizar taponamiento vaginal con compresas**

156) Una paciente de 50 años, en terapia de remplazo hormonal desde hace 9 meses, consulta por genitorragia de 40 días de evolución. Al examen físico presenta IMC: 32 y especuloscopia con escasa metrorragia. Se realiza una ecografía transvaginal que muestra endometrio de 17 mm de grosor, con presencia de un mioma intramural de 2 cm de diámetro. El test de embarazo es negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Cambiar la terapia de remplazo por anticonceptivos orales
- b) Realizar miomectomía
- c) Realizar histerectomía
- d) Realizar biopsia de endometrio**
- e) Cambiar la terapia de remplazo por progestágenos solos

157) Una paciente de 20 años se realiza un Papanicolaou, que es informado como presencia de células epiteliales atípicas de significado incierto (ASCUS). Se realiza colposcopia, que es informada como no satisfactoria. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar PAP en 6 meses
- b) Realizar tipificación de virus papiloma humano**
- c) Realizar histerectomía
- d) Realizar cono LEEP
- e) Realizar curetaje endocervical

158) Una paciente de 40 años, obesa, se realiza un PAP que es informado con presencia de células glandulares atípicas de significado incierto (AGUS). Se realiza colposcopia y curetaje endocervical, que no muestran alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar examen de detección de virus papiloma humano
- b) Controlar con PAP en un año
- c) Hacer cono cervical biopsico
- d) Realizar biopsia endometrial**
- e) Controlar con PAP en 6 meses

159) Una paciente de 36 años, con antecedente de embarazo de 7 semanas por amenorrea, diagnosticado mediante examen de orina, consulta por metrorragia escasa. Al examen físico está en buenas condiciones generales, sin otras alteraciones. Se realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza gestación intrauterina. Se solicita HCG que resulta 200 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir la ecografía en 48 horas
- b) Repetir la HCG en 48 horas**
- c) Repetir la ecografía en 7 días
- d) Administrar misoprostol
- e) Administrar metotrexato

DICIEMBRE 2017

54) Una mujer puerpera, presenta hemorragia postparto importante. En sus exámenes destacan hemograma con hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,3 g/dl, glóbulos blancos:

8.000 por mm³, plaquetas: 80.000 y además tiene TTPA y TP alargados y fibrinógeno 90 mg/dl (VN: 200 a 400)
¿Cuál es la mejor indicación transfusional?

- a) Crioprecipitado
- b) Glóbulos rojos
- c) Plaquetas
- d) Sangre fresca
- e) Plasma fresco congelado

149) Una paciente con antecedente de atraso menstrual, consulta por metrorragia. Su última regla fue hace 3 meses. A la especuloscopia se constata metrorragia. Su PA: 132/ 84 mmHg, FC: 80x', temperatura normal. Se solicitan niveles plasmáticos deHCG, que resultan 960 UI/L.

Se solicita una ecografía transvaginal, que muestra útero con endometrio refringente de 17 mm, sin visualización de saco gestacional ni masas anexiales, ni tampoco líquido libre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Observa evolución y controlar en 2 semanas
- b) Solicitar ecografía en 7 días
- c) Solicitar nueva HCG y ecografía en 48 horas
- d) Realizar laparoscopia
- e) Realizar laparotomía exploradora

150) Una paciente de 55 años se realiza una ecografía transvaginal, como parte de un chequeo ginecológico, que visualiza una lesión anexial derecha, quística, de 4,5 cm de diámetro, con una pared fina y sin tabiques ni excrescencias. Su última regla fue hace 5 años. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar laparoscopia
- b) Iniciar análogos de la GnRH
- c) Realizar biopsia de la lesión por punción, guiada por ecografía
- d) Iniciar anticonceptivos orales
- e) Realizar seguimiento ecográfico en 3 meses

151) Una paciente de 43 años, multipara de 4, consulta por que en el último tiempo se ha sentido más cansada de lo normal y además presenta disnea de grandes esfuerzos. Refiere también como antecedente, que sus reglas son abundantes. En su examen ginecológico, destaca útero en ateversoflexión, irregular y anexos sin alteraciones palpables. En sus exámenes de laboratorio destaca un hemograma, con Hb: 8 g/dl, Hcto: 23%, blancos: 6.500 por mm³ y plaquetas: 260.000 por mm³, que en el frotis muestramuestra hipocromía y microcitosis. Se solicita una ecografía transvaginal, que muestra múltiples miomas intramurales de hasta 5 cm de diámetro, más un mioma submucoso de 4 cm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar histeroscopia
- b) Realizar histerectomía total
- c) Administrar análogos de la GnRH

d) Iniciar anticonceptivos orales

e) Antifibrinolíticos

152) Una paciente de 25 años, sexualmente activa, que no utiliza métodos de barrera, consulta por fiebre, asociada a dolor abdominal, disuria, polaquiuria y leucorrea. Al examen físico presenta temperatura 38 grados, dolor a la palpación abdominal, mayor en la fosa ilíaca derecha. Además, en el examen ginecológico se observa leucorrea y tiene dolor a la palpación bimanual. El agente etiológico más probable es:

- a) Escherichia coli
- b) Gardnerella vaginalis
- c) Trichomona vaginalis
- d) Streptococo grupo A
- e) **Gonococo**

153) Una mujer de 35 años desea embarazarse. Como antecedentes es hipertensa, diabética, hipotiroidea y depresiva. Está en tratamiento con enalapril, levotiroxina, fluoxetina, metformina y ácido fólico. ¿Cuál es el consejo preconcepcional más adecuada?

- a) Suspender la metformina
- b) Aumentar la dosis de levotiroxina
- c) **Cambiar el enalapril por otro antihipertensivo**
- d) Suspender la fluoxetina
- e) Mantener los medicamentos, sin cambios

154) Una paciente de 22 semanas de gestación, con embarazo bien controlado, se realiza un doppler de arterias uterinas, que demuestra aumento de la resistencia. Como antecedente, estuvo hospitalizada en un embarazo anterior por una preclamsia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) **Iniciar aspirina**
- b) Iniciar heparina
- c) Iniciar L-arginina
- d) Mantener el control normal del embarazo
- e) Administrar corticoides

155) Usted atiende a una paciente de 33 años, con 13 semanas de embarazo. Como antecedentes, tuvo una cesárea de urgencia en un embarazo anterior, a las 31 semanas, por una preclamsia severa. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) **Indicar aspirina**
- b) Indicar heparina
- c) Indicar L-arginina
- d) Indicar ácidos grasos omega 3
- e) Indicar dexametasona

156) Una paciente de 34 años, cursando un embarazo de 38 semanas, con antecedente de RCIU en percentil 5. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en percentil menor a 5 y oligohidroamnios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar corticoides, manteniendo una conducta expectante
- b) **Realizar cesárea dentro de las próximas 24 horas**
- c) Inducir el parto con misoprostol
- d) Solicitar doppler umbilical y decidir según resultados

e) Realizar test de tolerancia a las contracciones

157) Una paciente de 28 años, multípara de 1, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por metrorragia escasa. A la especuloscopia se ven restos de sangre, sin metrorragia actual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar amniocentesis
- b) Inducir el parto con misoprostol
- c) Realizar cesárea
- d) Solicitar una ecografía obstétrica
- e) Realizar un tacto vaginal

158) Una paciente de 31 años, cursando un embarazo de 11 semanas, se realiza una ecografía obstétrica, que muestra una translucencia nuchal de 6 mm (VN: menor a 3 mm), asociada a ausencia de hueso nasal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar biopsia de vellosidad corial
- b) Realizar amniocentesis a las 20 semanas
- c) Realizar detección de ADN fetal en sangre materna
- d) Realizar seguimiento con relación fémoro / craneana
- e) Realizar el control normal del embarazo

159) Una paciente de 25 años, con antecedente de atraso menstrual de 6 semanas, consulta por metrorragia. Su test de embarazo es positivo. Su especuloscopia confirma metrorragia que proviene del orificio cervical y su tacto vaginal muestra un cuello cerrado, duro y de ubicación posterior. Se solicita una ecografía obstétrica que muestra lo siguiente:

FOTO (Ecografía obstétrica con un saco gestacional de 11mm).

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Dar misoprostol
- b) Realizar legrado
- c) Controlar con nueva ecografía en 7 días
- d) Realizar laparoscopia
- e) Dar metotrexato

160) Una paciente, puerpera desde hace 10 días, presenta dolor en la mama derecha, que aumenta especialmente al dar de mamar. En su examen físico se aprecia lo siguiente: FOTO (punto blanco o perla láctea en el pezón).

¿Cuál es la indicación más adecuada?

- a) Frío local antes de dar de mamar
- b) Calor
- c) Punción de la lesión
- d) Drenaje quirúrgico
- e) Uso de pezonera

NOTA: ¿A, C? Tiene un punto blanco o perla láctea, que se produce porque se obstruye la salida de uno de los conductos galactóforos. Su tratamiento es discutible, ya que responde a distintos tratamientos y además, puede estar infectado. El calor local es lo clásico, pero también se suelen puncionar, ya que así se soluciona el problema. En mi opinión, es una mala pregunta, ya que tiene más de una respuesta correcta.

161) Una paciente, con antecedente de mortinato por infección por estreptococo betahemolítico grupo B, cursa un nuevo embarazo de 35 semanas, que no ha presentado complicaciones y se ha controlado adecuadamente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Administrar penicilina endovenosa al recién nacido

b) Administrar ampicilina endovenosa a la mujer durante el trabajo de partoparto

c) Solicitar cultivo perianal y decidir conducta

d) Dar antibióticos profilácticos en este momento

e) Realizar cesárea electiva al término

162) Una paciente de 32 años presenta reglas irregulares, cada 2 a 3 meses, asociada a hirsutismo y acné.

Consulta porque ha tenido problemas para embarazarse ¿Cuál es el mejor fármaco para de tratar la infertilidad en esta paciente?

a) Espironolactona

b) Análogos de la GnRH

c) Citrato de clomifeno

d) Metformina

e) Progesterona

163) Una paciente de 27 años, cursando 36 semanas de embarazo, consulta por malestar general, asociada a cefalea, tinnitus y epigastralgia. Su presión arterial es 170/100 mmHg y presenta reflejos osteotendíneos exaltados. Su tacto vaginal no muestra cambios cervicales y su registro cardiaco fetal no tiene alteraciones. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

a) Administrar labetalol

b) Iniciar alfametildopa

c) Administrar sulfato de magnesio 5 gramos endovenoso y luego 2 gramos cada hora

d) Solicitar un test de tolerancia a las contracciones

e) Realizar cesárea de urgencia

164) Una paciente de 32 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por dolor abdominal. Se constatan contracciones uterinas 3 a 4 en 10 minutos y se realiza un tacto vaginal que muestra dilatación de 6 cm, con borramiento completo. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más importante para mejorar el pronóstico del recién nacido?

a) Corticoides

b) Sulfato de magnesio

c) Tocolíticos

d) Antibióticos

e) Progesterona

165) Una paciente cursa un embarazo de 32 semanas, presenta dinámica uterina 2 a 3 contracciones cada 10 minutos y dilatación cervical de 1 cm. El registro fetal es tranquilizador. Se administran corticoides a la madre, más nifedipino 10 mg vía oral, sin embargo persiste con la dinámica uterina una hora después. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Administrar tocolíticos de segunda línea

b) Dejar a evolución espontánea

c) Administrar sulfato de magnesio

d) Realizar cesárea

e) Realizar amniocentesis

166) Una paciente de 28 años, cursa un embarazo de 32 semanas por amenorrea, sin controles obstétricos previos. Consulta por pérdida de líquido . Al examen físico presenta temperatura 38,5 grados Celsius, PA: 120/80 mmHg, FC: 100x'. Su tacto vaginal tiene uncuello cerrado, duro y posterior. Se solicita un hemograma muestra

glóbulos blancos: 11.000 por mm³. La ecografía obstétrica, que muestra oligoamnios y peso fetal de 1.100 gramos, equivalente a un embarazo de 29 semanas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Inducir el parto con misoprostol
- b) Administrar corticoides y antibióticos y mantener una conducta expectante
- c) Realizar cesárea
- d) Realizar amniocentesis**
- e) Realizar amnioinfusión, con surfactante intramniótico

167) Una paciente de 32 años, hace 2 meses se implantó un DIU medicado, como método anticonceptivo. Consulta por atraso menstrual. Se realiza test de embarazo, la que resulta positiva y se solicitan niveles plasmáticos de HCG que resultan 980 UI/L. No tiene síntomas. La conducta más adecuada es:

- a) Retirar el DIU
- b) Solicitar una ecografía obstétrica**
- c) Observar evolución
- d) Administrar metotrexato
- e) Realizar histeroscopia

168) Una paciente cursando un embarazo de 35 semanas, es diagnosticada de RCIU en percentil 3. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es una indicación de interrupción inmediata del embarazo?

- a) Oligohidroamnios
- b) Aumento de la resistencia de las arterias umbilicales
- c) Dilatación de la arteria cerebral media
- d) Relación femoro/abdominal mayor a 0,25
- e) Ducto venoso con flujo ausente en diástole, al doppler**

169) Una paciente de 37 años, está en trabajo de parto de término. Está con anestesia raquídea y oxitocina en goteo. Presenta registro electrónico fetal tipo III y se constatan 6 contracciones uterinas cada 10 minutos. La conducta más adecuada es:

- a) Poner a la madre en decúbito lateral izquierdo
- b) Suspender la oxitocina**
- c) Realizar rotura artificial de membrana
- d) Dar oxígeno a la madre
- e) Administrar tocolíticos

170) Una paciente de 33 años, cursando un embarazo de 31 semanas, presenta contracciones uterinas frecuentes y dolorosas. Además, su tacto vaginal demuestra 2 cm de dilatación y 50% de borramiento. ¿Qué se debe realizar antes, para decidir si se administran o no los tocolíticos?

- a) Realizar ecodoppler de arterias umbilicales
- b) Determinar vitalidad y bienestar fetal mediante ecografía
- c) Realizar ecodoppler de arterias uterinas
- d) Realizar monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca fetal**
- e) Descartar infección con amniocentesis

171) Una paciente de 58 años, con 18 meses de amenorrea, consulta por metrorragia de 2 días evolución. Su examen ginecológico demuestra escasa metrorragia, que proviene del OCE, sin otras alteraciones. Sus mamografía y PAP son normales y fueron realizados hace menos de un año. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra endometrio de 3 mm, sin masas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar colposcopia

b) Controlar con una ecografía en 1 mes

- c) Realizar legrado
- d) Iniciar terapia de reemplazo hormonal
- e) Realizar histeroscopia

172) Una paciente de 80 años, se realiza una ecografía transvaginal, como parte de un control ginecológico, que muestra un endometrio de 7 mm, con anexos normales. No presenta síntomas y no recibe terapia de reemplazo hormonal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Histerectomía
- b) Terapia de reemplazo hormonal

c) Biopsia de endometrio si es que presenta metrorragia

- d) Legrado
- e) Colposcopia

173) Una paciente se realiza un PAP que muestra atipias escamosas de bajo grado. Se realiza una colposcopia y biopsia, que muestra presencia de una neoplasia intraepitelial grado 1 y un condiloma. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Crioterapia

- b) Tipificación de virus papiloma humano
- c) Conización cervical
- d) Histerectomía
- e) Curetaje endocervical

174) Una paciente de 37 años, puerpera hace 7 días, con antecedente de hemorragia puerperal, evoluciona con aumento de la metrorragia, asociada a fiebre hasta 38,5 grados Celsius y dolor abdominal bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Inercia uterina
- b) Neoplasia trofoblástica gestacional

c) Endometritis

- d) Restos ovulares
- e) Miometritis

175) Una mujer de 18 años, presenta reglas regulares, muy abundantes, asociada a dismenorrea. Se realiza una ecografía transvaginal, que visualiza múltiples quistes menores a 6 mm en ambos ovarios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar biopsia de endometrio
- b) Realizar histeroscopia

c) Solicitar estudio endocrinológico

- d) Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- e) Solicitar estudio de la hemostasia

176) Una mujer de 22 años consulta por un nódulo mamario, que se autopalpó. Al examen físico se constata un nódulo en la mama derecha, de 2 cm de diámetro, móvil. No se palpan adenopatías axilares. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?

a) Mamografías

b) Ecografía mamaria

- c) Resonancia magnética nuclear de mamas
- d) TAC de tórax
- e) Biopsia

177) Una paciente de 18 años, cursando un embarazo de 11 semanas, presenta vómitos frecuentes, desde inicios del embarazo, pero que han ido en aumento. Hace 24 horas ha empeorado, al punto que no ha podido ingerir líquidos adecuadamente, por lo que acude al servicio de urgencia. El diagnóstico más probable es:

- a) Gastroparesia gestacional
- b) Cólico biliar
- c) Hepatitis
- d) Hiperemesis gravídica**
- e) Síndrome de HELLP

178) Una paciente de 24 años, cursando un embarazo de 10 semanas, presenta vómitos frecuentes, que iniciaron hace un mes y han ido en aumento. Además ha bajado 3 kilogramos de peso, desde que se embarazó, ya que muchos de los alimentos y olores le producen muchas náuseas y vómitos. Refiere que vomita cerca de 6 veces al día y que esto afecta claramente su calidad de vida. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Doxilamina**
- b) Clorpromazina
- c) Omeprazol
- d) Metoclopramida
- e) Ondasentrón sublingual

179) Una paciente se realiza un PAP que es informado como satisfactorio, inflamatorio y con atipías glandulares. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Tratamiento con metronidazol
- b) Tratamiento con estrógenos
- c) Control con un PAP en un año
- d) Repetir el PAP
- e) Colposcopia**

180) Una paciente embarazada de 9 semanas, se realiza una glicemia de ayuno en su control del embarazo, que resulta 130 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Glicemia normal para el embarazo
- b) Intolerancia a la glucosa**
- c) Diabetes mellitus gestacional
- d) Diabetes mellitus pregestacional
- e) Prediabetes

JULIO 2017

5) Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 21 semanas, presenta un cuadro de malestar general marcado, asociado a confusión en el último tiempo. Al examen físico está desorientada, tiene petequias en abdomen y extremidades y equimosis en ambas extremidades inferiores. Se controlan exámenes, que muestran LDH: 2.550 UI/L, hemograma con hematocrito 29%, plaquetas: 33.000 por mm³ y frotis con abundantes esquistocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Púrpura trombocitopénico inmune
- b) Púrpura trombocitopénico trombótico**
- c) Síndrome de HELLP
- d) Trombocitopenia gestacional
- e) Enfermedad gestacional

Nota: “Es un HELLP hasta que se demuestre lo contrario” es una frase que se repite con frecuencia en obstetricia, dado la gravedad del cuadro. Sin embargo, en este caso no hay dolor abdominal, ni se describe la ictericia u otro indicador de hepatitis, sino solo los síntomas clásicos del PTT: compromiso de conciencia, petequias y anemia hemolítica. Por el otro lado, el PTT se asocia al embarazo. Por tener más de 20 semanas, es posible un HELLP, pero muy improbable. Es una mala pregunta, pero se nota que la hizo el hematólogo.

11) Una mujer de 30 años, multipara de 1, cursando un embarazo de 29 semanas, consulta por dinámica uterina persistente. Al examen físico presenta 3 contracciones uterinas en 10 minutos y su tacto vaginal muestra feto en céfálica, con cuello delgado y dilatado de 8 centímetros. Además de administrar antibióticos, la conducta más adecuada es:

- a) Dar fenoterol endovenoso
- b) Dar nifedipino oral
- c) Dar sulfato de magnesio endovenoso
- d) Realizar cesárea de urgencia
- e) Administrar corticoides

30) Un paciente de 24 años, cursando un embarazo de 8 semanas, consulta por leucorrea y molestias genitales. Se realiza una especuloscopia, que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO El tratamiento de elección es:

- a) Metronidazol oral
- b) Clotrimazol tópico
- c) Tinidazol oral
- d) Fluconazol oral
- e) Azitromicina oral

37) Una paciente de 30 años, con antecedente de parto hace 3 meses y que está en lactancia materna exclusiva, consulta por dispareunia intensa. Al examen físico se aprecia la mucosa vaginal pálida y muy seca. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antimicóticos orales
- b) Iniciar metronidazol oral
- c) Iniciar anticonceptivos combinados orales
- d) Iniciar ceftriaxona intramuscular más azitromicina oral
- e) Indicar lubricante genital

48) Un niño de 7 años, respirador bucal es traído por su madre. No presenta apnea del sueño, ni infecciones a repetición. Al examen físico, no tiene obstrucción nasal y se observa faringe con amígdalas grado II. Se solicita radiografía de cavum, que constata hipertrofia adenoidea, con 80% de obstrucción. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Desloratadina oral
- b) Fluticasona intranasal
- c) Adenoidectomía
- d) Observar evolución y controlar ambulatoriamente
- e) Solicitar TAC de cavidades paranasales

57) Una paciente, usuaria de DIU hace 7 años, se realiza Papanicolaou como chequeo médico, que muestra presencia de Actinomyces israeli, sin otras alteraciones. No refiere síntomas y su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar Papanicolaou en 1 año

- b) Derivar a colposcopia
- c) Realizar ecotomografía pelviana
- d) Retirar el DIU
- e) Iniciar antibióticos orales

71) Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 39 semanas inicia trabajo de parto. Al tacto vaginal, tiene feto en cefálica, con cuello borrado, con 8 cm de dilatación y membranas íntegras. Se realiza un registro fetal intraparto, cuyo trazado se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Mantener una conducta expectante
- b) Realizar rotura de membranas
- c) Realizar cesárea de urgencia
- d) Iniciar oxitocina endovenosa
- e) Solicitar perŕil biofŕsico

85) Una paciente de 60 años, menopáusica desde los 50 años, consulta por metrorragia de 7 días de evolución. Al examen ginecológico se observa que la metrorragia proviene de la cavidad uterina. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

- a) Ecografía transvaginal
- b) Histerosalpingografía
- c) TAC de pelvis
- d) Resonancia magnética de pelvis
- e) Marcadores tumorales en sangre

88) Una paciente de 22 años, acude a su primer control de un embarazo de 8 semanas. Entre sus exámenes trae un VDRL que resultó negativo, hematocrito de 39% y glicemia de ayuno de 112 mg/dL. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- b) Iniciar hipoglicemiantes orales
- c) Repetir glicemia de ayuno
- d) Solicitar insulínemia basal
- e) Mantener el control embarazo normal

89) Una paciente de 14 años, con menarquia a los 13 años, presenta ciclos menstruales que varían entre 26 y 35 días. Su examen físico es normal y no reŕere otros sŕntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar anticonceptivos orales
- b) Iniciar estrógenos solos por vía oral
- c) Iniciar progestágenos solos por vía oral
- d) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, progesterona, LH y FSH
- e) Controlar ambulatoriamente con calendario menstrual

91) Una mujer cursando un embarazo de 27 semanas, presenta dinámica uterina persistente y dolorosa, asociada a ŕebre hasta 38 grados. Al examen físico tiene temperatura 37,8 grados Celsius, FC: 80x', PA: 120/80 mmHg y 4 contracciones uterinas cada 10 minutos, que persisten, a pesar de administrar nifedipino oral. Sus exámenes de sangre demuestran PCR: 25 ng/ml (VN: menor a 10 ng/ml) y hemograma con 12.000 glóbulos blancos por mm³. El monitoreo fetal es tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Interrumpir el embarazo
- b) Administrar fenoterol
- c) Administrar atosiban

d) Realizar amniocentesis

e) Iniciar antibióticos

98) Una paciente de 37 años, multipara de 1, cesarizada anterior, presenta un nuevo embarazo de término. Ingresa a la sala de parto, por contracciones uterinas dolorosas. Al examen tiene 3-4 contracciones uterinas cada 10 minutos y tacto vaginal con dilatación completa, feto en cefálica con la cabeza en el segundo plano. Durante los minutos siguientes, se produce metrorragia y aumento del dolor. Al examen el útero es difícil de palpar y el monitoreo fetal resulta tipo III, con latidos fetales que se auscultan a 60 por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Placenta previa

b) Procidencia de cordón

c) Rotura uterina

d) Rotura de vasa previa

e) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

113) Una paciente de 41 años, cursando un embarazo de 13 semanas, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra regurgitación tricuspídea, con presencia de hueso nasal, ductus venoso normal y translucencia nuchal de 1,9 mm (VN: menor a 3 mm). ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

a) Análisis genético de vellosidad corial

b) Amniocentesis biopsica

c) Ecocardiograma fetal

d) Estudio genético de DNA fetal libre en sangre materna

e) Niveles plasmáticos de HCG y alfafetoproteína

127) Una mujer puérpera hace 5 semanas, dando lactancia materna exclusiva, consulta por dolor y enrojecimiento del pezón izquierdo. Al examen físico se muestra lo siguiente:

INSERTAR FOTO ¿Cuál es el tratamiento de elección?

a) Mupirocina tópica

b) Clotrimazol tópico

c) Óxido de zinc tópico

d) Lanolina purificada tópica

e) Betametasona tópica

133) Una paciente de 36 años, cursando su primer embarazo a las 28 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que arroja una glicemia basal de 98 mg/dl y una glicemia postcarga, a las 2 horas, de 147 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Resistencia a la insulina

b) Diabetes mellitus gestacional

c) Diabetes mellitus pregestacional

d) Intolerancia a la glucosa oral

e) Embarazo normal

135) Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 38 semanas, consulta por contracciones uterinas, que se constatan como 3-4 cada 10 minutos. Al tacto vaginal presenta 10 cm de dilatación, membranas rotas y cabeza fetal en espaldas, en variante mentoiliaca derecha posterior. El monitoreo fetal resulta tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Dejar a evolución espontánea y controlar en una hora

b) Hacer fórceps

- c) Realizar vaccum de la cabeza fetal
- d) Realizar amnioinfusión con rotación manual
- e) Hacer cesárea de urgencia

138) Una paciente de 25 años presenta un aborto espontáneo, hace 2 meses, que no requirió de legrado. Actualmente presenta metrorragia de 7 días de evolución, que en la especuloscopia se aprecia que sale del orificio cervical externo. Su HCG resulta 135.000 UI/L. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra útero aumentado de tamaño, con contenido uterino irregular y múltiples vesículas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar metotrexato
- b) Esperar evolución espontáneo
- c) Realizar legrado
- d) Realizar resonancia magnética nuclear de pelvis
- e) Realizar histerectomía

139) ¿Qué antecedente es indicación del uso de estrógenos orales solos, en la terapia de reemplazo hormonal?

- a) Antecedente de cáncer de mama
- b) Antecedente de dislipidemia
- c) Antecedente de histerectomía total
- d) Osteoporosis
- e) Edad mayor a 70 años

144) Una paciente de 25 años, cursando con embarazo de 30 semanas, con antecedente de epilepsia hace 1 año, presenta crisis convulsivas tónico-clónicas, desde hace una hora. Al examen físico se aprecia edema de extremidades inferiores, FC: 87x' y PA: 160/100 mmHg. La ecografía obstétrica muestra feto vivo. ¿Cuál es la primera medida?

- a) Administrar nifedipino
- b) Administrar fenobarbital
- c) Administrar diazepam
- d) Administrar sulfato de magnesio
- e) Administrar misoprostol

147) Una paciente de 49 años, obesa, consulta por metrorragia de 10 días de duración, sin otros síntomas. Al examen físico destaca especuloscopia con sangre que proviene del OCE. Se solicita beta-HCG que resulta negativa y ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 15 mm de grosor. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar resonancia magnética nuclear de pelvis
- b) Solicitar histerosalpingografía
- c) Realizar estudio de alteraciones de la hemostasia
- d) Realizar estudio de trombofilias
- e) Realizar biopsia endometrial

150) Una paciente de 30 años, embarazada sin controles iniciales, con edad gestacional dudosa, consulta por pérdida de líquido por los genitales. Sus signos vitales son normales y al examen obstétrico no presenta dinámica uterina ni modificaciones cervicales en el tacto vaginal. Su altura uterina es de 25 cm y las pruebas de bienestar fetal son normales. Se realiza ecografía obstétrica, que muestra índice de líquido amniótico de 5,2 y biometría para 30 semanas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Inducir el parto con misoprostol

- b) Realizar cesárea
- c) Dar antibióticos y corticoides y mantener una conducta expectante**
- d) Determinar madurez fetal en líquido amniótico
- e) Administrar nifedipino oral

159) Una paciente de 31 años, entra en trabajo de parto a las 37+6 semanas y al examinarla se constatan 3 contracciones uterinas en 10 minutos y su tacto vaginal muestra 5 cm de dilatación cervical, membranas íntegras y presentación cefálica, en espaldas -1. El registro de la frecuencia cardíaca fetal está dentro de rangos normales. Se la evalúa a las 3 horas, manteniéndose sin cambios obstétricos. La conducta de elección es:

- a) Mantener una conducta expectante por 1 hora y reevaluar
- b) Realizar fórceps
- c) Realizar cesárea
- d) Realizar rotura artificial de membranas y administrar anestesia epidural**
- e) Administrar oxitocina endovenosa en goteo

160) Una paciente de 30 años de edad, cursando un embarazo de 40 semanas, inicia trabajo de parto en cefálica. Al tacto vaginal tiene 7 cm de dilatación, con membranas íntegras, por lo que se realiza rotura artificial de membranas, que da salida a líquido claro. A los pocos minutos evoluciona con registro fetal tipo III, por bradicardia fetal. La primera conducta a realizar es:

- a) Realizar tacto vaginal**
- b) Cambiar de posición a la madre
- c) Administrar nifedipino
- d) Dar oxígeno a la madre
- e) Realizar cesárea de urgencia

168) Una paciente de 35 años, está en trabajo de parto de término. Durante el expulsivo, se produce desprendimiento de la cabeza fetal, sin embargo no se produce la rotación ni el descenso de los hombros. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Traccionar la cabeza fetal
- b) Realizar compresiones suprapúbicas
- c) Realizar hiperextensión de las caderas (maniobra de McRoberts)**
- d) Realizar rotación manual de los hombros hacia anterior (maniobra de Rubin)
- e) Realizar extracción del brazo posterior (Maniobra de Jacquemier Barnum)

169) Una paciente de 19 años, con ciclos menstruales regulares, consulta por dolor abdominal intenso, mayor en la fosa ilíaca izquierda. Su FUR fue hace 20 días. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la FII, con signos peritoneales esbozados. Se solicita test de embarazo, que resulta negativo y una ecografía transvaginal, que muestra una lesión anexial mixta de 8 cm de diámetro, con presencia de líquido libre en moderada cantidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cuerpo lúteo hemorrágico**
- b) Cuerpo lúteo roto
- c) Apendicitis aguda
- d) Torsión ovárica
- e) Absceso tubo-ovárico

176) Una paciente de 24 años consulta por atraso menstrual de 7 semanas. Se realiza HCG, que resulta 5.000 UI/L, por lo que se hace ecografía transvaginal, que muestra ausencia de gestación intrauterina y abundante líquido libre peritoneal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar curva de HCG
- b) Controlar con ecografía transvaginal en 7 días
- c) Realizar laparoscopia**
- d) Administrar metotrexato
- e) Mantener el control normal del embarazo

Julio 2018

1. Una paciente de 15 años, sin antecedentes de importancia, presenta dolor pélvico muy intenso, en relación a la menstruación, que la hace faltar al colegio. Su menarquia fue hace un año y presenta reglas III-V / 30-35. El tratamiento de elección es:

- a. Ácido mefenámico**
- b. Anticonceptivos orales
- c. Dienogest
- d. Paracetamol
- e. Ácido tranexámico

2. Una mujer embarazada, de 8 semanas, se realiza un VDRL que resulta positivo en dilución 1/64. Tiene antecedente de alergia a la amoxicilina. El tratamiento antibiótico de elección es:

Seleccione una:

- a. Penicilina
- b. Clindamicina
- c. Ceftriaxona
- d. Eritromicina**
- e. Doxiciclina

Nota: Es una pregunta muy discutible, ya que la recomendación Chilena, según el Minsal, es Eritromicina en el embarazo, aunque también puede ser ceftriaxona o incluso doxiciclina. En cambio, la recomendación gringa es penicilina de todas formas, luego de desensibilizarla

3. Una paciente de 41 años, multipara de 2, con antecedente de HTA, en tratamiento con metildopa, cursando un nuevo embarazo de 12 semanas. En chequeo ecográfico obstétrico, se pesquisa elevación de la resistencia de las arterias uterinas. La conducta más adecuada es:

- a. Realizar nuevo Doppler de arterias pélvicas a las 16 semanas
- b. Cambiar el tratamiento antihipertensivo
- c. Iniciar ácido acetilsalicílico**
- d. Iniciar L-arginina
- e. Iniciar heparina de bajo peso molecular

3. Una mujer de 25 años, cursando un embarazo de 38 semanas, se realiza ecografía obstétrica, con feto creciendo en percentil 5 para la edad gestacional y oligoamnios. La ecografía Doppler muestra dilatación de la arteria cerebral media, sin otras alteraciones de la hemodinamia fetal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Seleccione una:

- a. Inducir el parto
- b. Realizar cesárea**
- c. Realizar monitoreo fetal no estresante
- d. Realizar test de tolerancia a las contracciones
- e. Repetir el Doppler en 1 semana

4. Una paciente de 41 años, multipara de 2, con antecedente de HTA, en tratamiento con metildopa, cursando un nuevo embarazo de 12 semanas. En chequeo ecográfico obstétrico, se pesquisa elevación de la resistencia de las arterias uterinas. La conducta más adecuada es:

- a. Realizar nuevo Doppler de arterias pélvicas a las 16 semanas
- b. Cambiar el tratamiento antihipertensivo
- c. Iniciar ácido acetilsalicílico**
- d. Iniciar L-arginina
- e. Iniciar heparina de bajo peso molecular

5. Una paciente de 25 años, con historia de 3 abortos de primer trimestre, presenta atraso menstrual de 3 días, por lo que se realiza una HCG, que resulta 2.200 UI/L. Su examen físico es normal ¿Cuál es el examen más adecuado para seguir la evolución de este embarazo? Seleccione una:

- a. Los niveles plasmáticos de HCG
- b. La ecografía transvaginal**
- c. El Doppler materno-fetal
- d. Los niveles plasmáticos de estradiol y FSH
- e. Los niveles plasmáticos de progesterona

6. Una paciente de 23 años, con antecedente de 2 abortos previos de primer trimestre. Actualmente cursa un nuevo embarazo de 8 semanas, siendo diagnosticada de aborto retenido, mediante ecografía transvaginal. ¿Cuál es el estudio inicial para esta paciente?

- a. Histerosalpingografía
- b. Cariograma al padre y a la madre
- c. Histeroscopia
- d. Estudio de trombofilia
- e. Estudio citogenético del material ovular**

7. Una paciente de 46 años, hipertensa, nulípara consulta por metrorragia de 3 semanas de evolución, la que se objetiva en la especuloscopia. Se solicita test de embarazo que está negativo, por lo que se solicita una ecografía transvaginal que muestra endometrio engrosado, de 18 mm, con una zona de hiperrefringencia focal, en la pared anterior del útero. La conducta más adecuada es

- a. Histerosonografía
- b. Biopsia endometrial**
- c. Resonancia magnética de pelvis
- d. TAC de pelvis
- e. Seguimiento con ecografía transvaginal en 2 meses

8. Una paciente de 30 años se realiza un PAP, que resulta atípico de alto grado, por lo que se realiza una colposcopia y biopsia, que es informada como NIE-1, de localización exocervical. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Seleccione una:

- a. Seguimiento con PAP
- b. Crioterapia**
- c. Cono cervical
- d. Tipificación de virus papiloma humano
- e. Diatermocoagulación

Nota: Es una pregunta difícil, ya que el manejo de la NIE1 es muy variable. Se puede observar si la colposcopia es satisfactoria y el PAP es de bajo grado. En este caso además, se recomienda tipificar el VPH. Se debe tratar con crioterapia o ablación láser, si el PAP era de alto grado. Sinceramente no recuerdo bien si el PAP era de alto grado o no en la pregunta original

9. Una paciente de 26 años, con atraso menstrual de 3 semanas, consulta por metrorragia escasa, sin dolor. Al examen físico. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra tumor anexial de 3 cm, sin líquido libre. Los niveles de HCG resultan 3.400 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Seleccione una:

- a. Controlar con ecografía en 48 horas
- b. Administrar metotrexato**
- c. Controlar con HCG en 48 horas
- d. Realizar legrado
- e. Realizar salpingectomía

10 ¿Cuál es la estrategia más efectiva para evitar la transmisión vertical del VIH, desde la madre embarazada al hijo?

- a. Tratamiento a la madre durante el embarazo y el parto**
- b. Cesárea electiva
- c. Contraindicación de la lactancia materna
- d. Tratamiento a la madre durante la lactancia
- e. Profilaxis al recién nacido

Una mujer de 30 años se realiza un Papanicolaou, que es informado como satisfactorio, inflamatorio, con atipías glandulares. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Controlar con un PAP en 6 meses
- b. Realizar tipificación de virus papiloma
- c. Solicitar ecografía transvaginal
- d. Realizar colposcopia**
- e. Indicar óvulos de clotrimazol

Una paciente de 60 años comienza con escapes de orina, precedidos por urgencia miccional. No tiene incontinencia urinaria de esfuerzos y su examen físico no aporta mayor información. Se realiza sedimento de orina, que resulta normal y un sedimento de orina, que está negativo. La ecografía vesical muestra paredes finas en la vejiga, con residuo postmiccional de 30 cc. El tratamiento más adecuado es:

- a. Antagonistas alfa-adrenérgicos
- b. Antagonistas beta-adrenérgicos
- c. Agonistas adrenérgicos
- d. Anticolinérgicos antimuscarínicos**
- e. Agonistas colinérgicos

Una mujer de 50 años, histerectomizada, en terapia de reemplazo hormonal, hace un año, con estrógeno solo. Se palpa un nódulo mamario derecho, el que es estudiado con mamografías, informándose como BIRADS 4. La conducta más adecuada es:

- a. Cambiar la terapia de reemplazo hormonal a estrógenos más progestágenos
- b. Solicitar ecografía mamaria
- c. Control con mamografía en 6 meses
- d. Biopsia por punción estereotáxica**

e. Resección del tumor con biopsia quirúrgica

Una paciente de 16 años, con antecedente de menarquia a los 14 años, presenta reglas irregulares. Consulta por acné en la cara y espalda. Al examen tiene piel grasa, con abundantes comedones y pápulas. Tiene sobrepeso e hirsutismo moderado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Realizar tratamiento tópico con queratolíticos
- b. Realizar estudio de hiperandrogenismo
- c. Iniciar anticonceptivos orales
- d. Indicar doxiciclina
- e. Indicar isotretinoína

Una paciente de 24 años, con dismenorrea en estudio, de 6 meses de evolución, progresiva. En su examen ginecológico se palpa un tumor anexial derecho, por lo que se solicita una ecografía transvaginal, que muestra un tumor anexial derecho, con contenido espeso y homogéneo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Quiste folicular
- b. Tumor dermoides
- c. Endometrioma
- d. Adenoma mucinoso
- e. Teratoma

Una paciente de 24 años, multipara de 1, con antecedente de cesárea anterior, cursa un nuevo embarazo de 34 + 3 semanas. Consulta por pérdida de líquido por genitales, desde hace 24 horas, lo que se confirma con la especuloscopia. Al examen, se aprecia feto en cefálica, cuello cerrado, sin dinámica uterina. Signos vitales normales, estimación de peso fetal: 2.200 gramos y frecuencia cardíaca fetal: 132 x'. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Inducir el parto
- b. Realizar amniotomía
- c. Realizar amniocentesis
- d. Mantener una conducta expectante
- e. Realizar cesárea

Una paciente de 28 años, multipara de 2, con un parto nacido por cesárea y el segundo nacido por vía vaginal. Consulta por pérdida de líquido claro por genitales. La especuloscopia no muestra alteraciones, por lo que se realiza un test de nitrazina, con pH: 5,5. La ecografía obstétrica muestra feto en cefálica, con peso acorde para la edad gestacional, con índice de líquido amniótico de 2,2 y 128 latidos cardioritmos por minuto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Inducir el parto
- b. Realizar amniocentesis
- c. Solicitar Doppler fetal
- d. Realizar operación cesárea
- e. Mantener una conducta expectante

Una paciente de 30 años, con antecedente de una cesárea previa, está en trabajo de parto, el que inició a las 38 semanas. Al tacto vaginal tiene 6 cm de dilatación, cuello borrado y 4 contracciones uterinas cada 10 minutos. Algunos minutos después, presenta hemorragia abundante y al examen físico se constata PA: 90/50 mmHg, FC: 125x'. El útero es difícil de palpar y el monitoreo fetal intraparto resulta tipo III. El diagnóstico más probable es:

- a. Rotura uterina

- b. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
- c. Placenta previa
- d. Rotura de vasa previa
- e. Hipertonía uterina

Una paciente de 7 años presenta un cuadro de una semana de evolución de malestar general, fiebre de 38,3°C, asociada a dolor abdominal y vómitos alimentarios en varias oportunidades. Hace 3 días se agrega ictericia y acolia. Tiene todas sus vacunas del Plan Nacional de Inmunizaciones al día. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Hepatitis A**
- b. Hepatitis B
- c. Fiebre tifoidea
- d. Mononucleosis infecciosa
- e. Síndrome hemolítico urémico

Una paciente de 26 años, atleta, está en amenorrea hace 8 meses. Se realiza test de embarazo, que resulta negativo. Sus niveles de prolactina y TSH son normales. Se solicita FSH: 80 UI/L (VN: menor a 18), estradiol: 5 (VN: 20-150 pg/ml). Su examen físico no tiene alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a. Hipogonadismo de causa central
- b. Falla ovárica primaria**
- c. Amenorrea por ejercicio
- d. Amenorrea hipotalámica funcional
- e. Anovulación

Una paciente cursando un embarazo de 7 semanas de evolución, presenta prurito vaginal desde hace 7 días, con leucorrea de aspecto grumoso. Se realiza un cultivo vaginal, que muestra desarrollo de Streptococcus beta hemolítico grupo B y Candida albicans. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a. Clotrimazol tópico**
- b. Ampicilina oral
- c. Azitromicina oral
- d. Fluconazol oral
- e. Clindamicina tópica

Una paciente de 23 años, está en trabajo de parto. Está con dilatación completa, buena dinámica uterina, membranas rotas y cabeza fetal 3 cm por sobre las espinas ciáticas. Desde hace 4 horas ha permanecido sin cambios. El monitoreo fetal es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Dejar evolución espontánea
- b. Administrar tocolisis con nifedipino
- c. Realizar cesárea**
- d. Realizar con extracción con fórceps
- e. Realizar extracción con vacuum de la cabeza fetal

Una paciente de 30 años, multipara de 1, está en trabajo de parto, con dinámica uterina de 3 contracciones en 10 minutos. Al tacto vaginal, con 5 cm de dilatación, membranas íntegras y el feto está en cefálica, con la cabeza fetal en espinas +1. Se muestra el registro fetal a continuación:

Dos horas después no hay cambios. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- a. Realizar cesárea

- b. Administrar misoprostol
- c. Administrar anestesia peridural y realizar rotura de membranas**
- d. Administrar oxitocina
- e. Dejar a evolución espontánea

Una paciente púérpera hace 2 días presenta una convulsión tónico clónica. Al examen físico está sin focalidad neurológica, con PA: 140/90 mmHg. Tiene antecedente de epilepsia en la infancia, que había remitido. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

- a. Sulfato de magnesio**
- b. Labetalol
- c. Diazepam
- d. Fenitoína
- e. Carbamazepina

Una paciente de 30 años, embarazada con 32 semanas de gestación presenta un episodio depresivo mayor, sin síntomas psicóticos ni ideación suicida. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

Seleccione una:

- a. Terapia electroconvulsiva
- b. Sertralina**
- c. Mirtazapina
- d. Venlafaxina
- e. Amitriptilina

Una mujer de 27 años, cursando un embarazo de 35 semanas se realiza ecografía obstétrica, con feto creciendo en percentil 3. ¿Cuál es el examen más adecuado para definir la edad gestacional de interrupción?

Seleccione una:

- a. Test de tolerancia a las contracciones
- b. Ecografía Doppler de arterias umbilicales**
- c. Registro basal no estresante
- d. Ecografía Doppler de arteria cerebral media
- e. Ecografía Doppler de ducto venoso

Una mujer de 20 años, con atraso menstrual de 21 días, se realiza un test de embarazo, que está positivo, por lo que se hace una ecografía transvaginal, que muestra un saco gestacional intrauterino, de 10 mm, sin embrión. La HCG está en 4.200 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Administrar metotrexato
- b. Administrar misoprostol
- c. Realizar legrado
- d. Realizar aspiración manual endouterina
- e. Solicitar una nueva ecografía en 7 días**

Una mujer de 35 años, cursando embarazo de 32 semanas, presenta genitorragia, luego de tener relaciones sexuales. Al examen está en buenas condiciones, PA: 120/80 mmHg, FC: 70x', útero sin dinámica uterina, altura uterina de 28 cm y se ausculta la frecuencia cardíaca fetal: 130x'. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a. Ecografía obstétrica transvaginal
- b. Tacto vaginal
- c. Ecografía Doppler fetal
- d. Especuloscopia**

e. Monitoreo fetal no estresante

PEDIATRÍA

2013

1. Una lactante de 2 meses con cuadro de dolor abdominal y vómitos desde hace semanas que en las últimas horas ha empeorado asociándose fiebre, taquipnea y compromiso de conciencia. Al su ingreso destaca PA: 40/20, FC 130x', examen pulmonar con crépitos difusos. Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca creatinina 0.9, glicemia 40, Na⁺ 132, K⁺ 5.7, hemograma con leucocitosis. Se inicia Ceftriaxona y aporte de suero fisiológico en bolo sin respuesta luego de una hora. El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:
 - a. Vancomicina
 - b. Noradrenalina
 - c. **Hidrocortisona**
 - d. Vasopresina
 - e. Dopamina
2. Un paciente de 6 años, sin antecedentes, es traído por presentar sangrado rectal fresco en gotas al final de las deposiciones, no asociado a dolor, ni otros síntomas. Al examen físico se encuentra con índice de masa corporal adecuado para su edad, abdomen blando, depresible y no doloroso, ruidos hidroaéreos presentes. El diagnóstico más probable en este caso es:
 - a. Úlcera rectal solitaria
 - b. Hemorroides
 - c. Divertículo de Meckel
 - d. **Pólipos juvenil**
 - e. Fisura anal
3. Un paciente de 8 años, sin antecedentes, es traído por presentar múltiples pápulas de 3-4 milímetros de diámetro en manos, tórax y extremidades, algunas de ellas agrupadas en forma lineal, asociado a prurito ocasional. El diagnóstico más probable es:
 - a. Molusco contagioso
 - b. Fibromatosis
 - c. Liquen plano
 - d. **Verrugas planas**
 - e. Dermatitis atópica
4. Un lactante de 2 meses de edad, sin antecedentes perinatales, acude a control donde se le administran sus vacunas según el programa nacional de inmunizaciones, doce horas después presenta convulsión tonicoclónica generalizada que dura tres minutos evolucionando posteriormente en buenas condiciones. A futuro la conducta más adecuada con este paciente es:
 - a. No volver a vacunar.
 - b. Vacunar con DPT al año de vida
 - c. Continuar calendario de vacunación de forma normal
 - d. Indicar paracetamol durante la próxima vacunación
 - e. **Reemplazar DPT con DPT acelular.**
5. Una paciente de 13 años, sin antecedentes, consulta por cefalea e hirsutismo. Al examen físico se encuentra presión arterial en percentil 99 para su edad, índice de masa corporal mayor al percentil 95 para su edad, acné inflamatorio en su rostro y estrías abdominales. El diagnóstico más probable es:
 - a. Diabetes mellitus tipo 2
 - b. Síndrome de ovario poliquístico

- c. **Síndrome de Cushing**
- d. Hipotiroidismo
- e. Hiperprolactinemia

6. Recién nacido de 35 semanas, de 5 días de vida, con antecedente de depresión neonatal recuperada, inicia cuadro caracterizado por vómitos y distensión abdominal asociado a deposiciones con sangre. Al examen físico se palpa abdomen distendido, con tono aumentado. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

- a) Ecografía abdominal
- b) Tomografía axial computada de abdomen con contraste
- c) **Radiografía de abdomen**
- d) Laparotomía exploradora
- e) Colonoscopia

7. Un lactante de 6 meses, sin antecedentes perinatales, es traído por presentar epifora desde hace 2 meses, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia córnea de 15mm de diámetro en ojo izquierdo, asociado a opacidad corneal. El diagnóstico más probable es:

- a) Retinoblastoma
- b) Catarata congénita
- c) Atresia del conducto lacrimal
- d) **Glaucoma congénito**
- e) Persistencia del vítreo primario hiperplásico

35) Un lactante de 10 meses de edad, sin antecedentes, mientras come su almuerzo comienza súbitamente con tos asociado a disminución del esfuerzo respiratorio e hipotonía. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Iniciar reanimación cardiopulmonar
- b) Exploración digital de su cavidad oral
- c) Iniciar presión digital en epigastrio
- d) **Dar golpes en la espalda**
- e) Iniciar ventilaciones boca a boca

42) Un paciente de 2 años de edad, sin antecedentes, con historia de dolor abdominal difuso e intenso de inicio brusco, que luego disminuye y se asocia a deposiciones de color rojo oscuro, sin otros síntomas. Actualmente no presenta dolor y su examen físico es normal. El examen de elección en este caso es:

- a) **Ecografía**
- b) Tomografía axial computada de abdomen
- c) Colonoscopia
- d) Cintigrafía
- e) Radiografía

47) Una paciente de 12 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de hemorragia gingival al lavarse los dientes, asociado a equimosis frente a pequeños traumatismos desde hace 2 semanas. Al examen físico destacan dichas equimosis y petequias generalizadas, sin otros hallazgos. Se solicita hemograma donde destaca hemoglobina de 12mg/dL, leucocitos de 7.000/mm³ y plaquetas de 4000/mm³. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Transfusión de plaquetas
- b) Esplenectomía
- c) **Corticoides**
- d) Inmunoglobulina no específica

e) Administrar crioprecipitado

48) Un paciente de 6 años, con historia de 5 días de odinofagia intensa asociada a secreción purulenta y sensación febril que durante el último día se acompañó de rash papular eritematoso que es más intenso en pliegues. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

- a) Hemograma
- b) IgM para virus Epstein barr
- c) Panel viral
- d) Cultivo de secreción faríngea
- e) Test pack para Streptococo grupo A

58) Un paciente de 11 años, es traído por sus padres por ser el más bajo de su curso. Ha estado creciendo en el percentil 2 para su edad desde hace años según su curva de crecimiento y al examen físico se aprecia desarrollo puberal Tanner 1, con testículos de 2cc. Sus padres tienen estatura promedio para la población. Se solicita radiografía de carpo que muestra edad ósea de 8 años y 6 meses. El diagnóstico más probable es:

- a) Talla baja familiar
- b) Hipogonadismo
- c) Acondroplasia
- d) Enanismo
- e) Retardo constitucional del crecimiento

62) Un recién nacido de término, presenta cianosis desde su nacimiento, con saturación arterial de 65% con aporte de oxígeno al 100%. Al examen físico destaca murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, soplo sistólico y pulsos presentes. Como parte de su estudio se solicita radiografía de tórax que muestra cardiomegalia y mediastino delgado. El diagnóstico más probable es:

- a) Trasposición de grandes vasos
- b) Comunicación interauricular
- c) Coartación aórtica
- d) Canal auriculoventricular
- e) Comunicación interventricular

69) Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de inicio agudo de dos horas de evolución caracterizados por palpitaciones y dolor torácico. Al ingreso se conecta a monitor que muestra frecuencia cardiaca de 200 latidos por minutos, regular y QRS angosto. La primera medida para el manejo en este caso es:

- a) Realizar presión orcular
- b) Realizar cardioversión eléctrica
- c) Administrar adenosina endovenosa
- d) Realizar masaje carotídeo
- e) Administrar verapamilo endovenoso

74) Un paciente de 9 años, es traído por presentar cuadro de 2 días de compromiso del estado general, mialgias, artralgias, tos y fiebre, que durante las últimas horas se agregó cefalea. Al examen físico se encuentra decaído, frecuencia cardiaca de 100 por minuto, frecuencia respiratoria de 22 por minuto, examen pulmonar normal. El agente etiológico más probable es:

- a) Adenovirus
- b) Streptococo pneumoniae
- c) Mycoplasma
- d) Virus influenza A

e) Virus respiratorio sincial

77) Escolar de 8 años, es traído por su madre ya que desde hace años presenta equimosis frente a pequeños traumatismos y en una ocasión presentó un hematoma en muslo al jugar en el colegio. Actualmente presenta sangramiento gingival, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia dicho sangramiento, asociado a equimosis en extremidades. Se solicitan exámenes que muestran hemoglobina 12mg/dL, leucocitos 6.000/mm³, plaquetas 230.000/mm³, tiempo de protrombina normal y tiempo de tromboplastina parcial activada prolongada. El diagnóstico más probable en este caso es:

a) Enfermedad de Von Willebrand

b) Enfermedad de Bernard Soulier

c) Enfermedad de Glanzmann

d) Hemofilia

e) Escorbuto

COMENTARIO : Esta pregunta está muy difícil, ya que la gingivorragia puede estar en la EvW y es más frecuente en ella que en la hemofilia. Además la EvW puede alargar levemente el TTPA. Por ser niño, por tener un hematoma profundo y por tener el TTPA largo, podría ser hemofilia. Sin embargo, que no haya tenido hemartrosis y que solo haya tenido un hematoma muscular, más los otros síntomas, lo más probable es que sea un von Willebrand. Habría que ver bien cómo estaba redactada la pregunta original. Revisar el Eunacom 2015 de julio, que tenía una pregunta similar, pero que era una EvW.

81) Una paciente de 6 años, con cuadro caracterizado por disuria, polaquiuria y orinas de mal olor desde hace 2 días, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca temperatura de 36.5°C, abdomen blando, depresible y no doloroso a la palpación, puño percusión negativa. Se realiza sedimento de orina que muestra 6 eritrocitos y 15 leucocitos por campo, además se solicita urocultivo de segundo chorro en el que hay crecimiento de escherichia coli con 60.000 unidades formadoras de colonia multisensible. La conducta más adecuada en este caso es:

a) Iniciar Cefadroxilo oral

b) Iniciar Nitrofurantoina oral

c) Solicitar Ecografía renal y vesical

d) Solicitar cintigrafía renal estática

e) Repetir sedimento de orina y urocultivo

9) Recién nacido de 10 días de vida, sin antecedentes perinatales, inicia desde hace 5 horas cuadro caracterizado por fiebre cuantificada hasta 39°C asociada a rechazo alimentario e hiporreactividad, sin otros síntomas. Su examen físico resulta normal. Se solicita bioquímica de orina que muestra leucocitos ++. La conducta más adecuada en este caso es:

a) Solicitar sedimento de orina y decidir conducta según resultados

b) Hospitalizar para estudio y manejo

c) Indicar antipiréticos orales y control en dos días

d) Indicar antibióticos vía oral y control en dos días

e) Solicitar ecografía renal y vesical

21) Un paciente de 6 años, con historia de que hace dos semanas presentó cuadro caracterizado por rinorrea, odinofagia y tos, el cual fue manejado adecuadamente. Actualmente consulta por presencia de sangrado de encías, sin otros síntomas. Al examen físico destaca en buenas condiciones generales, con petequias en tronco y extremidades, resto normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 12 mg/dL, leucocitos 8.000/mm³ y plaquetas 10.000/mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Purpura trombocitopénico trombótico
- b) Hemofilia A
- c) Púrpura de Schonlein Henoch
- d) Purpura trombocitopénico inmune**
- e) Enfermedad de Von Willebrand

27) Un lactante de un mes, sin antecedentes perinatales, es traído por presentar ictericia, sin otros síntomas. Al examen físico destaca ictericia que llega hasta los muslos, resto normal. Su desarrollo psicomotor ha sido normal, al igual que su crecimiento y alimentación. Al preguntar dirigidamente, su madre refiere que también ha presentado orinas oscuras. El examen de elección frente a este paciente es:

- a) Ecografía abdominal
- b) Hormona estimuladora de tiroides
- c) Resonancia magnética abdominal
- d) Test de coombs
- e) Bilirrubinemia diferenciada**

41) Paciente de 3 años de edad, previamente sano, hace dos días inicia cuadro caracterizado por fiebre intensa, cuantificada hasta 39°C, no asociado a otros síntomas. Su madre le administra acetaminofeno por vía oral durante el primer día, tras lo cual evoluciona con disminución de la fiebre y hoy amanece con exantema maculopapular no pruriginoso, sin fiebre y en buenas condiciones. El agente etiológico más probable es:

- a) Citomegalovirus
- b) Virus Epstein barr
- c) Virus Herpes 6**
- d) Parvovirus B19
- e) Enfermedad de Still

48) Un niño de 6 años, es traído por presentar cuadro de dos días de evolución de diarrea acuosa frecuente, asociado a vómitos, rechazo alimentario y decaimiento. Al examen físico se encuentra somnoliento, frecuencia cardíaca de 110 por minuto, presión arterial de 80/50 mmHg y ojos hundidos. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Indicar suero glucosalino endovenoso en infusión continua
- b) Indicar sales de rehidratación oral 200ml luego de cada deposición
- c) Indicar sales de rehidratación oral 100 ml por kilogramo a beber en 4 horas y luego reevaluar
- d) Indicar suero fisiológico 20ml por kilogramo a pasar en bolo**
- e) Indicar alimentación normal, con abundantes líquidos y control en 48 horas

52) Lactante de 6 meses, es traída por cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por rechazo alimentario, irritabilidad y decaimiento, asociado a inmovilidad de extremidad inferior izquierda. Al examen se encuentra con temperatura de 38,5°C y se aprecia cadera izquierda en flexión, con mucho dolor a la movilización. El examen inicial más adecuado en este caso es:

- a) Hemograma con VHS**
- b) Radiografía de pelvis
- c) Ecografía de cadera
- d) Cintigrafía ósea
- e) Resonancia magnética de cadera

56) Un paciente de 8 años de edad, con historia de un año de evolución de rinorrea mucopurulenta bilateral intermitente asociado a prurito y en algunas ocasiones a epistaxis, actualmente sin síntomas. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Antihistamínicos orales
- b) Antibióticos orales
- c) Corticoides tópicos
- d) Derivar a cirugía de adenoides
- e) Oximetazolina tópica

61) Un paciente de 13 meses, es traído por presentar desde hace 4 días cuadro caracterizado por crisis de tos que aparecen de forma repetitiva durante el día, asociado a decaimiento, rechazo alimentario, náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecia hemorragia subconjuntival derecha, examen pulmonar con murmullo pulmonar presente, sin otros hallazgos. El agente etiológico más probable en este caso es:

- a) Virus respiratorio sincicial
- b) Virus parainfluenza
- c) Mycoplasma
- d) Bordetella pertusis
- e) Virus sarampión

67) Un paciente de 7 años, con historia de 8 días de tos y coriza, sin otros síntomas, presenta desde hace 24 horas aumento de su tos asociado a expectoración mucopurulenta, dificultad respiratoria y sensación febril. Al examen físico se encuentra decaído, con temperatura de 38°C, su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente de forma bilateral, asociado a estertores y sibilancias difusas. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Claritromicina
- b) Amoxicilina
- c) Amoxicilina con ácido clavulánico
- d) Acetaminofeno y salbutamol
- e) Cefadroxilo

72) Un niño de 8 años, es traído por presentar mal olor axilar desde hace semanas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia vello púbico escaso y testículos con volumen de 4cc. Su índice de masa corporal está en percentil 50 para su edad y sexo. El diagnóstico más probable es:

- a) Pubertad precoz central
- b) Pubertad precoz periférica
- c) Pubertad temprana
- d) Hiperplasia suprarrenal
- e) Adrenarquia temprana

COMENTARIO : Tiene una pubertad precoz (menos de 9 años en varones), con testículos de 4 cc, por lo que están estimulados por las gonadotropinas. Como hay elevación de gonadotropinas, es porque está activado el eje hipotálamo hipófisis, es decir, es central.

76) Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de 2 días de odinofagia, asociado a tos seca y rinorrea, que durante el primer día se asoció a sensación febril. Al examen físico se encuentra con temperatura de 36,8°C, faringe eritematosa, amígdalas aumentadas de tamaño con escaso exudado blanquecino, examen cardiopulmonar normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Amigdalitis pultácea
- b) Influenza

c) Rinofaringitis aguda

d) Coqueluche

e) Adenovirus

83) Lactante de 4 meses de edad, sin antecedentes conocidos, alimentado con lactancia materna de forma exclusiva, es traído por presentar bajo incremento ponderal, asociado a cansancio al alimentarse y decaimiento. Se aprecia decaído, saturación arterial de 90%, examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, con presencia de soplo sistólico, y pulmonar que muestra murmullo pulmonar disminuido en bases, asociado a crepitaciones finas bilaterales. El manejo inicial más adecuado en este caso es:

a) Administrar furosemida endovenosa

b) Administrar vasodilatadores endovenosos

c) Administrar epinefrina endovenosa

d) Realizar intubación endotraqueal y ventilación mecánica

e) Administrar betabloqueadores endovenosos

85) Un paciente de 3 años, sin antecedentes, con cuadro de rinofaringitis viral de dos días de evolución en tratamiento sintomático, es traído por presentar desde hace unas horas mayor compromiso del estado general, asociado a otalgia intensa izquierda y sensación febril. Al examen físico destaca examen cardiopulmonar normal y a la otoscopia se aprecia tímpano izquierdo eritematoso y abombado con escasa secreción purulenta. El fármaco de elección en este caso es:

a) Ibuprofeno oral

b) Amoxicilina oral

c) Amoxicilina con ácido clavulánico oral

d) Gentamicina tópica

e) Claritromicina oral

90) Un paciente de 12 años, consulta por cuadro caracterizado por de visión de destellos hace una hora, tras lo cual evolucionó con cefalea frontotemporal intensa, de tipo pulsátil, asociado a fotofobia y fonofobia. Refiere que desde los cinco años ha presentado cuadros similares, y que durante el último año ha presentado cinco episodios. El diagnóstico más probable es:

a) Migraña clásica

b) Cefalea en racimos

c) Cefalea tensional

d) Migraña complicada

e) Tumor

Julio 2015

7) Un niño de 3 meses de edad se realiza una radiografía de pelvis, que muestra displasia de cadera izquierda, con índice acetabular de 36 grados. La indicación más adecuada es:

a) Ejercicios de rotación y compresión

b) Bota larga bilateral de yeso, con yugo

c) Yeso pelvipedio

d) Uso de doble pañal

e) Arnés de Pavlik

15) Un niño de 11 años presenta un cuadro de astenia y fiebre de algunas semanas de evolución. Al examen físico se aprecia palidez, asociado a esplenomegalia. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para continuar el estudio en este paciente?

- a) IgM para virus Epstein Baar
- b) Hemograma VHS**
- c) Biopsia ganglionar
- d) IgM para Bartonella henselae
- e) Tiempos de coagulación

17) Un paciente de 12 años, diabético tipo 1, en tratamiento con una dosis de NPH matinal, despierta con glicemias de ayuno muy elevadas, asociadas a hipoglicemias frecuentes antes del almuerzo. Su hemoglobina glicosilada es de 11,7%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Reemplazar el tratamiento por insulina glargina en la mañana
- b) Dejar dos dosis de insulina NPH más tres refuerzos de insulina cristalina precomidas**
- c) Agregar insulina NPH nocturna
- d) Reemplazar la insulina NPH matinal por insulina NPH nocturna
- e) Agregar metformina al tratamiento

19) Un paciente de 12 años consulta por un cuadro de malestar general, asociado a bajo de peso, que en las últimas horas se le agrega poliuria importante. Consulta porque en las últimas horas se agrega gran compromiso del estado general, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está taquicárdico, soporoso, con polipnea y signos de deshidratación. En sus exámenes presenta glicemia de 470 mg/dl, sodio de 143 mEq/L, potasio de 4,8 mEq/L, cloro de 97 mEq/L, bicarbonato de 12 mEq/L y pH de 7,05. ¿Qué fluido debe administrarse a este paciente?

- a) Suero glucosado
- b) Suerlo glucosalino
- c) Solución salina al 0,45%
- d) Solución salina al 0,9%**
- e) Solución ringer lactato

21) Un niño de 7 años presenta episodios en los que se queda quieto, mirando fijo, los que luego no recuerda. Han aumentado en frecuencia, hasta suceder 5 veces al día. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síncopes vasovagales
- b) Epilepsia mioclónico
- c) Crisis de ausencia**
- d) Epilepsia focal
- e) Déficit atencional

22) Un niño de 4 años, con antecedente de una convulsión febril hace 2 años, presenta un cuadro de fiebre y cefalea, seguido luego de deterioro del estado general y compromiso de conciencia. Luego, convulsiona en una oportunidad. Se realiza una punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo, con glucosa de 68 mg/dl, 62 mg/dl de proteínas, 300 glóbulos blancos, con 80% mononuclear y 60 glóbulos rojos, crenados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Encefalitis herpética**
- b) Hemorragia subaracnoidea
- c) Meningitis bacteriana
- d) Meningitis tuberculosa

e) Convulsión febril benigna

64) Un niño de 7 años presenta edema de párpados y de EEII, asociado a orinas oscuras. Al examen tiene edema de párpados y de ambas piernas, con presión arterial de 127/85. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Síndrome nefrítico

b) Síndrome nefrótico

c) Enfermedad de Berger

d) Necrosis tubular aguda

e) Síndrome hemolítico urémico

77) Un niño de 4 años no tiene interés en juntarse con otros niños, no habla y solo se comunica con señas. Aplauda con frecuencia, ante situaciones estresantes, no le gusta que lo toquen y juega siempre con el mismo juguete. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Trastorno global del desarrollo

b) Trastorno del espectro autista

c) Hipoacusia

d) Parálisis cerebral

e) Trastorno de conducta

78) Un niño de 5 años presenta movimientos repetitivos con las manos, estereotipados (manierismos), no habla y solo se comunica con señas, no se relaciona con otros niños y llora cuando le quitan el sombrero. El diagnóstico más probable es:

a) Trastorno generalizado del desarrollo

b) Trastorno por déficit atencional

c) Trastorno de conducta

d) Hipotiroidismo congénito

e) Epilepsia generalizada

87) Un niño de 7 años perdió el año escolar. Presenta dificultades en la lectoescritura, invierte fonemas con frecuencia, es muy lento para leer y le cuesta deletrear. Su padre no terminó el colegio, porque tenía problemas similares. El diagnóstico más probable es:

a) Coeficiente intelectual límite

b) Trastorno oposicionista desafiante

c) Trastorno por déficit atencional

d) Dislexia

e) Trastorno del desarrollo

90) Un niño de 7 meses nació con una mácula eritematosa, de tres cm, en la mano izquierda, la que ha ido creciendo en tamaño y espesor. Actualmente se ve de la siguiente forma:

FOTO: No encontré fotos en internet, pero la imagen era una placa, que afectaba el dorso de la mano, de color rojo, de 1mm de alto y de 4 a 5 cm de largo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Observar evolución

b) Corticoides orales

c) Corticoides locales

d) Propanolol

e) Cirugía

102) Un niño de 7 años presenta otalgia derecha, asociada a otorrea. Al examinarlo presenta otorrea, sin olor y a la otoscopia presenta canal auditivo estrecho, por lo que no es posible ver el tímpano. Además presenta dolor al traccionar el pabellón auricular. EL diagnóstico más probable es:

- a) Otitis media aguda
- b) Otitis media crónica
- c) Otitis externa
- d) Tapón de cerumen
- e) Otomastoiditis aguda

129) Un niño de 7 años de edad presenta un cuadro de fiebre y odinofagia, asociado a malestar general. Al examen físico presenta faringe congestiva, con exudado amigdalino bilateral y se palpa adenopatía cervical, por lo que se inicia amoxicilina oral. Dos días después evoluciona con un exantema, que se muestra en la FOTO. El diagnóstico más probable es: NOTA: la foto original era de un niño, pero el exantema es muy similar a este (fue la foto más parecida que hallé en Google)

- a) Escarlatina
- b) Reacción alérgica a la amoxicilina
- c) Eritema multiforme menor
- d) Artritis reumatoide juvenil
- e) Mononucleosis infecciosa

131) Un paciente de 8 años presenta un cuadro de odinofagia de un día de evolución, intenso, asociado a fiebre. Al examen físico tiene faringe congestiva, con exudado amigdalino bilateral y presencia de una adenopatía cervical. Su hermano menor está en tratamiento por escarlatina confirmada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar amoxicilina oral
- b) Solicitar test pack para estreptococo
- c) Solicitar cultivo faríngeo
- d) Solicitar IgM para virus Epstein Baar
- e) Indicar tratamiento sintomático

132) Un niño de 5 años de edad presenta fiebre leve, asociada a eritema malar, que dura 2 días y luego cede. Al cuarto día aparece un exantema que afecta el tronco y las zonas extensoras de las extremidades. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Virus herpes 6
- b) Virus rubeola
- c) Virus sarampión
- d) Parvovirus B19
- e) Streptococcus pyogenes

133) Un niño de 9 años estuvo en contacto con un paciente con varicela hace 48 horas. No ha tenido varicela y no está vacunado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Vacuna antivariela
- b) Aciclovir
- c) Valaciclovir
- d) IgG antivariela
- e) Paracetamol

134) Un niño de 7 meses de edad es hospitalizado por una bronquilitis aguda. Al quinto día de la hospitalización, presenta fiebre y diarrea acuosa abundante, de olor ácido, sin sangre, de cerca de 6 deposiciones líquidas al día. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Escherichia coli
- b) Shigella
- c) Clostridium difficile
- d) Rotavirus
- e) Enterovirus

143) ¿Cuál es la posición recomendada para que duerman los lactantes?

- a) Prono
- b) Decúbito lateral derecho
- c) Supino
- d) Decúbito lateral izquierdo
- e) Alternar decúbito lateral derecho e izquierdo

144) Un niño de 16 meses, nacido a las 34 semanas de gestación, logra la posición sentada a los 10 meses y aún no camina. Además succiona y traga muy lento, y también presenta sialorrea. Su perímetro cefálico es de 45 cm, que corresponde a -2 DS y presenta espasticidad en sus 4 extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Parálisis cerebral
- b) Hipotiroidismo congénito
- c) Alteración enzimático-metabólica
- d) Microcefalia
- e) Trastorno del desarrollo

145) Un recién nacido presenta hepatoesplenomegalia e ictericia. Tiene además calcificaciones cerebrales y microcefalia. Evoluciona con coriorretinitis y aumento progresivo del perímetro craneano. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección por VIH
- b) Infección por Streptococcus agalactiae
- c) Rubeola congénita
- d) Toxoplasmosis congénita
- e) Sífilis congénita

Comentario : 145 D Cuadro clásico. Sin embargo la pregunta es muy difícil y claramente no es de médico general, ya que basta decir que tiene un TORCH. Esa clínica además es muy probable de un citomegalovirus. La rubeola produce microcefalia, cardiopatía y cataratas. La sífilis produce exantema, perforación del tabique nasal, deformaciones múltiples.

146) Un niño de 8 años presenta olor axilar. ¿Qué hallazgo debe buscarse para determinar si tiene una pubertad precoz?

- a) Ginecomastia
- b) Elevación de la 17 hidroxiprogesterona
- c) Vello púbico
- d) Aumento de la velocidad de crecimiento
- e) Aumento de volumen testicular

147) Un lactante está en tratamiento por reflujo gastroesofágico con medicamento en gotas. Presenta un cuadro de trismus, nistagmus, más hiperextensión del cuello. ¿Qué fármaco es más probable que esté recibiendo?

- a) Omeprazol
- b) Cisaprida
- c) Metoclopramida
- d) Domperidona
- e) Difenhidramina

148) Un lactante de 5 meses de edad es llevado a urgencias, por presentar un cuadro de obstrucción bronquial. Al examen físico presenta taquipnea importante, satura 90%, tiene retracción intercostal, cianosis perioral y sibilancias bilaterales intensas. ¿Cuál es la primera medida que se debe tomar?

- a) Nebulizaciones con salbutamol
- b) Nebulizaciones por
- c) Dar corticoides orales
- d) Dar oxígeno por mascarilla
- e) Administrar corticoides endovenosos

149) Un niño de 6 años entra al colegio hace 4 semanas. Hace 3 semanas inicia cefalea progresiva, más intensa en la mañana. Se agregan náuseas y vómitos escasos y diplopía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno adaptativo
- b) Trastorno por ansiedad de separación
- c) Jaqueca clásica
- d) Hipertensión endocraneana
- e) Vicio de refracción

150) Un lactante de 6 meses es traído por la madre, porque presenta epistaxis. La madre, de 17 años, refiere que se cayó de la cama. Al examen está poco reactivo y presenta múltiples equimosis, algunas de color morado y otras de color verde. Además tiene dos fracturas costales posteriores. Su TAC de cerebro muestra un hematoma subdural. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

- a) PTH y calcio
- b) Tiempos de coagulación
- c) Exámenes para descartar osteogénesis imperfecta
- d) Fondo de ojo
- e) Ecografía abdominal

151) Un niño de 8 meses de edad ha presentado 5 cuadros de bronquitis obstructiva y además ha presentado diarrea acuosa de 2 meses de evolución. No ha subido de peso en dicho periodo. ¿Qué examen debe realizarse?

- a) Anticuerpos antitransglutaminasa
- b) Niveles plasmáticos de IgA
- c) Test del sudor
- d) Elisa VIH
- e) Colonoscopia

152) Un lactante de 9 meses de edad presenta un cuadro de llanto y dolor abdominal de 10 horas de evolución, con flexión de las caderas, que luego se sigue de eliminación de sangre franca por el ano, cediendo el dolor. Se realiza una ecografía abdominal, que muestra una imagen en forma de dona. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Resección del segmento afectado por laparotomía
- b) Reducción por laparoscopia
- c) Colonoscopia
- d) Reducción neumática**
- e) Observar evolución

153) Un recién nacido de 40 semanas de edad gestacional, presenta disnea importante al nacer, con taquipnea marcada, cianosis y desaturación arterial. Presenta ruidos cardiacos desplazados al lado izquierdo, con ruidos intestinales en el lado derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra asas intestinales en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar cirugía de urgencia
- b) Solicitar endoscopia digestiva alta
- c) Administrar oxígeno en alta concentración, por mascarilla
- d) Administrar prostaglandina
- e) Realizar intubación orotraqueal y conectar a ventilador mecánico**

154) Un niño de 13 años acude a control médico, por una infección respiratoria alta. En su examen físico se ausculta un soplo paraesternal izquierdo, sistólico, de intensidad II/VI, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Soplo inocente**
- b) Ductus arterioso persistente
- c) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- d) Estenosis aórtica
- e) Coartación aórtica

Julio 2016

12) Un niño de 20 días de edad, presenta lesiones eritematosas, con descamación en la cabeza y la zona interiliar, con descamación amarilla, de aspecto oleoso. Se ve de buen aspecto y ha subido de peso. La indicación más adecuada es:

- a) Administrar fórmula, con proteína hidrolizada, como alimentación
- b) Crema de betametasona tópica
- c) Crema de clotrimazol tópica**
- d) Vaselina topica
- e) Antibióticos tópicos

17) Un lactante de 11 meses acude a control de niño sano, constatándose que no tiene aún ningún diente. El resto de su examen físico, así como su desarrollo psicomotor es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Derivar al odontopediatra
- b) Solicitar radiografía panorámica dentaria
- c) Solicitar TSH plasmática
- d) Solicitar niveles plasmáticos de vitamina D
- e) Observar evolución y controlar en 2 meses**

19) Un niño de 2 años, presenta deposiciones abundantes y pastosas, de 1 año de evolución. Además ha subido poco de peso en ese tiempo, teniendo actualmente un índice peso/talla de -1 DS y peso/edad de -2 DS. No ha tenido cuadros febriles. El diagnóstico más probable es:

a) Enfermedad celíaca

b) Fibrosis quística

c) Diarrea crónica inespecífica

d) Intolerancia a la lactosa

e) Alergia a la proteína de vaca

20) Un recién nacido, con antecedente de pielectasia bilateral, diagnosticada por ecografía obstétrica, presenta retraso en la eliminación de orina, por lo que se realiza una ecografía abdominal al tercer día de vida, que visualiza hidroureteronefrosis bilateral, asociada a una vejiga de paredes engrosadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Valvas uretrales posteriores

b) Síndrome de Prune Belly

c) Reflujo vésico-ureteral

d) Vejiga neurogénica

e) Megauréter congénito

23) Una niña de 5 años, en tratamiento con amoxicilina por una amigdalitis, evoluciona al séptimo día con fiebre y lesiones cutáneas generalizadas. Al examen físico se aprecian lesiones en tiro al blanco, asociadas a úlceras en las mucosas oral, rectal y vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Urticaria aguda

b) Gingivoestomatitis herpética

c) Síndrome de Steven Johnson

d) Escarlatina

e) Mononucleosis infecciosa

27) Un lactante de 10 meses de edad, presenta un cuadro de fiebre hasta 37,8 grados Celsius, asociado a aparición de un exantema generalizado, de tipo macular eritematoso, de aspecto tenue. Al examen físico destacan adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores, sensibles a la palpación. El diagnóstico más probable es:

a) Exantema súbito

b) Eritema infeccioso

c) Rubéola

d) Sarampión

e) Exantema por citomegalovirus

34) Un niño de 2 años presenta estrabismo divergente, con desviación del ojo derecho hacia temporal, que apareció hace pocos meses y que ha ido progresando. Al examen físico, además se constata ausencia del rojo pupilar de ese ojo. El diagnóstico más probable es:

a) Glaucoma congénito

b) Retinoblastoma

c) Catarata congénita

d) Leucoma

e) Estrabismo esencial

46) Recién nacido de término, con peso bajo para edad gestacional, tiene perímetro cefálico menor a percentil 3 para la edad gestacional y evoluciona después de nacer con ictericia progresiva, más hepatomegalia. ¿Cuál es el agente causal más probable?

a) Citomegalovirus

- b) Virus papiloma humano
- c) VIH
- d) Virus Zika
- e) Chlamydia trachomatis

53) Un niño de 8 años de edad presenta un cuadro de aparición de lesiones eritematosas en las extremidades inferiores y en los glúteos, asociado a dolor en ambos tobillos, a lo que luego se agrega dolor abdominal y vómitos. Al examen presenta lesiones eritematosas solevantadas en las zonas descritas, aumento de volumen en ambos tobillos y dolor abdominal difuso a la palpación. ¿Qué examen es más adecuado para definir el pronóstico de esta enfermedad?

- a) Hemograma
- b) Sedimento de orina**
- c) LDH
- d) Perfil bioquímico
- e) VHS

60) Un niño de 4 años presenta un cuadro de 2 días de evolución de aparición de múltiples lesiones eritematosas en las extremidades inferiores, palpables, asociado a dolor abdominal difuso y dolor de ambos tobillos. Al examen físico se palpa abdomen blando, depresible, doloroso leve, de manera difusa, sin signos peritoneales y los tobillos se aprecian aumentados de volumen, con dolor a la movilización. ¿Qué examen es más adecuado para definir el pronóstico de la enfermedad descrita?

- a) Perfil bioquímico
- b) Biopsia de médula ósea
- c) Hemograma
- d) Sedimento de orina**
- e) LDH

68) Niña de 7 años de edad, quien consulta por cuadro de 12 horas de evolución, caracterizada por fiebre y dolor hipogástrico. Al examen físico tiene temperatura: 38,7 grados, FC: 100x', PA: 100/60, dolor a la palpación de hipogastrio, con signo de Blumberg positivo y resistencia en la pared abdominal. Exámenes de laboratorio; 18.000 glóbulos blancos. Sedimento urinario muestra 20 leucocitos por campo. Proteína C reactiva: 15. El diagnóstico más probable es:

- a) Pielonefritis aguda
- b) Apendicitis aguda**
- c) ITU baja
- d) Torsión ovárica
- e) Plastrón apendicular

70) Un lactante de 10 meses de edad, con antecedente de dermatitis del pañal presenta aparición de lesiones eritematosas y pruriginosas en el muslo izquierdo, que se muestran en la imagen:

FOTO: tenía dos lesiones eritematosas, ulceradas, algo descamativas de cerca de 1 cm cada una. Tenían aspecto de un ectima.

El tratamiento más adecuado es:

- a) Antimicóticos tópicos en crema
- b) Corticoides tópicos en crema
- c) Antibióticos tópicos en crema
- d) Aciclovir tópico
- e) Vaselina tópica

77) Una lactante de 8 meses de edad, con antecedente de prematurez, presenta un cuadro de 12 horas de evolución, de irritabilidad, llanto y dolor abdominal, asociado a dos de posiciones sanguinolentas. Al examen físico presenta abdomen blando y doloroso a la palpación. En su analítica destaca hematocrito de 34%, con Hemoglobina de 11,2 g/dl, leucocitos: 14.500 por mm³ y plaquetas: 230.000 por mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Enterocolitis necrotizante
- b) Divertículo de Meckel complicado
- c) Atresia esófagica
- d) Invaginación intestinal
- e) Shigellosis

78) Un niño de 7 años es traído por su madre, porque presenta mal rendimiento escolar. Tiene un hermano con déficit atencional diagnosticado. Durante el examen, presenta un breve episodio de desconexión con el medio. ¿Con que examen se debe continuar el estudio de este paciente?

- a) Psicometría
- b) Evaluación psicopedagógica
- c) Electroencefalograma
- d) TAC cerebral
- e) Audiometría

82) Una niña de 5 años, con antecedentes de atopia, consulta por presentar lesiones hipo pigmentadas en el rostro, no pruriginosas, ni dolorosas con descamación amarilla como se muestra en la siguiente imagen:

FOTO: se muestra imagen de cara de niña, con pitiriasis alba.

La indicación más adecuada es

- a) Crema de hidrocortisona tópica
- b) Crema de betametasona tópica
- c) Crema de clotrimazol tópico
- d) Griseofulvina oral
- e) Bloqueador solar

87) Un lactante de 12 meses de edad, que a los 9 meses presentó un exantema, al introducir huevo a su alimentación por lo que fue suspendido, sin haberlo comido de nuevo. ¿Cuál es la conducta a tomar con respecto a la vacuna trivírica?

- a) Aplicar a los 12 meses
- b) Contraindicar la vacuna
- c) Aplicar a los 18 meses
- d) Diferir hasta los 2 años
- e) Realizar IgE específica del huevo y decidir según resultado

91) Adolescente de 13 años quien consulta por dolor inguinal y testicular izquierdo, intenso, de 45 minutos de evolución, irradiado a hipogastrio y acompañado de náuseas y vómitos. Al examen físico está afebril, con escroto enrojecido, testículo retraído y doloroso a la palpación. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- a) Administrar AINES
- b) Administrar antibióticos
- c) Cirugía
- d) Realizar suspensión testicular
- e) Solicitar ecografía testicular

95) Una niña de 5 años, ingiere accidentalmente soda cáustica, hace 45 minutos. Evoluciona con sialorrea y dolor abdominal y torácico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar carbon activado
- b) Solicitar endoscopia digestiva alta
- c) Administrar agente alcalinizante
- d) Instalar una sonda nasogástrica y aspirar el contenido
- e) Inducir los vómitos

105) Una niña de 5 años presenta dolor en muslo izquierdo, que luego se ubica en la cadera izquierda y que limita su movimiento. Al examen físico está en buenas condiciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Sinovitis transitoria
- b) Atritis séptica
- c) Artritis reumatoidea
- d) Osteomielitis
- e) Tumor de Ewing

108) Un lactante de 4 meses de edad presenta una diarrea grave, abundante, asociada a deterioro del estado general y sopor. Sus exámenes muestran elevación de la creatinina, hiponatremia e hipokalemia. Es imposible encontrar una vía venosa para administrar fluidos, ¿cuál es el medio de hidratación más adecuada?

- a) Catéter femoral
- b) Catéter subclavio
- c) Denudación safena
- d) Vía intraósea
- e) Sonda nasogástrica

109) Un lactante de 3 meses de edad pesa 7 kg. Se alimenta con lactancia materna exclusiva a libre demanda. Tiene peso para la edad en +1 DS y el índice peso/talla en +2 DS. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Dar formula de relleno
- b) Amamantar cada 4 horas
- c) Dar agua entre cada toma
- d) Mantener la lactancia materna a libre demanda
- e) Supender la lactancia nocturna

120) Niño con lesiones eritematosas en miembros inferiores (foto) con artralgias de

tobillos de 2 días de evolución y dolor abdominal. Al examen físico presenta edema de ambos tobillos, con lesiones en las piernas, como las que se muestran en la siguiente imagen:

FOTO: se muestran lesiones eritematosas en las extremidades inferiores (es la misma foto del año pasado, que parecen más un eritema nodoso, aunque el cuadro no es de eritema nodoso).

Considerando las complicaciones frecuentes del cuadro, es importante solicitar:

a) Creatininemia

b) Hematocrito

c) Plaquetas

d) Protrombinemia

e) Proteína C reactiva

122) Una niña de 3 años presenta, hace 4 días, un cuadro de diarrea y fiebre hasta 38°C, a la que se agrega sangre en las deposiciones, 48 horas después. En su examen físico se ve decaída, pálida y en sus exámenes destaca hematocrito de 28%, leucocitos 9.800, plaquetas 75.000, BUN 28, creatinina 2,3 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Leucemia aguda

b) Síndrome hemolítico urémico

c) Shock Séptico

d) Glomerulonefritis aguda

e) Púrpura de Schönlein Henoch

127) Un lactante de 1 año de presenta un ataque súbito de tos, sofocamiento y dificultad respiratoria. Al examen presenta sibilancias y disminución del murmullo pulmonar, con FR: 34x'. El diagnóstico más probable es:

a) Neumotórax

b) Laringitis aguda

c) Bronquitis obstructiva

d) Cuerpo extraño bronquial

e) Angioedema

135) Niño de 8 meses que sufre desde hace 6 meses diarrea pastosa, abundante. Tiene también antecedente de episodios bronquiales obstructivos y 4 cuadros de infecciones respiratorias, que han requerido de hospitalización.

Cuál es el diagnóstico de sospecha?

a) Enfermedad celiaca

b) Enteropatía perdedora de proteínas

c) Enfermedad de cilio inmóvil

d) Fibrosis quística

e) Alergia a la proteína de la leche de vaca

146) Un niño de edad escolar presenta aparición de petequias y equimosis en el dorso y en las extremidades, con epistaxis y gingivorragia, que comenzaron hace 4 días. Se solicita un hemograma, que demuestra hematocrito de 35%, con hemoglobina de 11,8 g/dl, blancos: 9.000 por mm³, con fórmula diferencial normal y plaquetas: 18.000 por mm³. Además presenta INR: 1,1 y protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura de Schönlein Henoch
- b) Púrpura trombocitopénico inmune**
- c) Leucemia aguda
- d) Meningococemia
- e) Hemofilia

151) Un niño de 5 meses de edad presenta un cuadro de rinorrea y tos, que va en aumento, hasta presentar accesos de tos y dificultar la alimentación. Al examen físico está en buenas condiciones generales, afebril y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicita un hemograma, que muestra leucocitosis de 17.000, con 78% de linfocitos y 22% de neutrófilos. La PCR y VHS están levemente elevadas. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un patrón intersticial leve. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía atípica
- b) Infección por virus influenza
- c) Infección por adenovirus
- d) Coqueluche**
- e) Bronquiolitis aguda

162) Un niño de 24 meses ha presentado 3 episodios de llanto de breve duración, seguido de apnea y luego pérdida de conciencia, recuperándose al poco tiempo. Al examen físico no tiene alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Instruir a los padres en reanimación cardiopulmonar
- b) Solicitar TAC de cerebro
- c) Educar a los padres en el manejo de las emociones del niño**
- d) Solicitar electroencefalograma
- e) Indicar monitor cardíaco

177) Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, nacido por cesárea, presenta dificultad respiratoria, luego de nacer, con taquipnea, retracción subcostal y crepitantes basales. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra ambos campos pulmonares con hiperinsuflación, reforzamiento hilar, aplanamiento del diafragma y silueta cardíaca normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumomediastino
- b) Neumonía congénita
- c) Taquipnea transitoria**
- d) Enfermedad de membrana hialina
- e) Cardiopatía congénita

178) Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en cadera izquierda y claudicación progresiva, que actualmente impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. Se realiza radiografía AP pelvis y caderas, que se muestra a continuación:
FOTO: se muestra una epifisiolisis de cadera izquierda clásica.

El diagnóstico es:

- a) Displasia del desarrollo de la cadera
- b) Epifisiolisis**

- c) Fractura del cuello del fémur
- d) Luxación de la Cadera izquierda
- e) Necrosis avascular de la cabeza del fémur

DICIEMBRE 2015

4) Un niño de 2 años y 5 meses presenta rinorrea purulenta de una semana de evolución, por la fosa nasal izquierda. No presenta compromiso del estado general y sus signos vitales son normales. Al examen físico se aprecia salida de rinorrea purulenta por la narina izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cuerpo extraño nasal**
- b) Atresia unilateral de coanas
- c) Rinitis alérgica
- d) Hipertrofia adenoidea
- e) Sinusitis bacteriana

9) Una niña de 4 años, presenta un cuadro catarral, con rinorrea bilateral y malestar general. Al cuarto día presenta dificultad para ver con el ojo derecho, con ojo rojo. Al examen físico presenta fiebre, FC: 100x', asociado a proptosis derecha y edema del párpado ipsilateral. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis alérgica
- b) Celulitis orbitaria**
- c) Queratoconjuntivitis viral
- d) Orbitopatía distiroidea
- e) Celulitis preorbitaria

20) Un niño de 10 años, presenta un cuadro de odinofagia, malestar general y aparición de un exantema, que inició hace 48 horas. Evoluciona con compromiso del estado general y marcado decaimiento. Al examen está soporoso, deshidratado, febril y se aprecian petequias generalizadas y una equimosis en el dorso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Púrpura trombocitopénico inmune
- b) Meningococcemia**
- c) Leucemia aguda
- d) Púrpura de Schönlein Henoch
- e) Infección por parvovirus B19

21) Un lactante de 1 mes y medio de vida presenta lesiones en el tronco y en las extremidades, como se muestran en la IMAGEN. Su madre presenta lesiones similares, pruriginosas en las manos, piernas y pies. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para el lactante?

- a) Permetrina al 5%
- b) Permetrina al 1%
- c) Vaselina líquida
- d) Ivermectina i.m.
- e) Vaselina azufrada al 10%**

FOTO: lesiones papulares eritematosas en tronco del lactante y otra con lesiones similares en las plantas de los pies y piernas.

24) Un niño de 3 años presenta habones generalizados, como se observa en la IMAGEN, muy pruriginosos. Al examen físico está en buenas condiciones generales, inquieto, con las lesiones descritas. La madre refiere que

había comido pescado. El diagnóstico más probable es:

- a) **Urticaria aguda**
- b) Dermatitis de contacto alérgica
- c) Anafilaxia
- d) Dermatitis atópica
- e) Eritema multiforme mayor

FOTO: habones en tronco y extremidades.

27) Un niño de 2 años y 6 meses, presenta un cuadro de fiebre hasta 38 grados, con tos y disfonía de 2 días de evolución. Despierta a la mañana siguiente con disnea y dificultad respiratoria. Al examen físico presenta taquipnea, cianosis perioral, disminución del murmullo pulmonar y estridor inspiratorio. ¿Cuál es la tratamiento más adecuado en este momento?

- a) Salbutamol nebulizado
- b) **Dexametasona endovenosa**
- c) Amoxicilina
- d) Adrenalina subcutánea
- e) Paracetamol oral

30) Un niño de 8 años, presenta un cuadro de dos años de evolución de tos, broncorrea, disnea de esfuerzos y sibilancias, que no han respondido al tratamiento con corticoides y broncodilatadores por vía inhalada. Al examen físico tiene sibilancias y estertores bilaterales, asociados a hipocratismo digital. ¿Cuál es el examen más adecuado para orientar al diagnóstico?

- a) Broncoscopía
- b) Espirometría basal y postbroncodilatador
- c) **Test del sudor**
- d) Resonancia magnética de pulmón
- e) Test de metacolina

32) Un niño de 24 meses de edad presenta un cuadro de 1 año de evolución de deposiciones diarreicas e inapetencia, asociado a irritabilidad. Ha subido 950 gramos durante ese periodo y su antropometría demuestra índice peso/talla: -2 DS e índice peso/edad: -1 DS. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fibrosis quística
- b) **Enfermedad celíaca**
- c) Alergia a la proteína de la leche
- d) Giardiasis masiva
- e) Déficit de IgA

54) Usted examina a un niño de 4 años de edad, que presenta pie plano valgo flexible bilateral. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) **Controlar en un año**
- b) Realizar radiografía de ambos pies
- c) Indicar plantillas correctoras
- d) Realizar resonancia magnética nuclear de ambos pies
- e) Indicar calzado corrector

57) Un niño crece en el percentil 2 para la talla. Además presenta genu valgo bilateral, que le dificulta la marcha. Se realiza una radiografía de mano, que se muestra en la IMAGEN. El diagnóstico más probable es:

- a) Osteomalacia
- b) Osteoporosis
- c) Displasia fibrosa ósea
- d) Raquitismo**
- e) Osteogénesis imperfecta

FOTO: Mano con solo 3 núcleos de osificación en el carpo, con todas las epífisis de las falanges claramente separadas de las diafisis.

75) Un niño de 5 meses de edad presenta ictericia de piel y mucosas. La madre refiere que ha presentado coluria en alguna oportunidad. Se palpa el hígado bajo el reborde costal, de consistencia aumentada. Su bilirrubina plasmática es de 12,5 mg/dl, bilirrubina directa: 11,5 mg/dl, con albúmina plasmática: 3,0 g/l, protrombinemia: 60%, GOT: 110 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cirrosis secundaria a hepatitis neonatal
- b) Atresia de las vías biliares**
- c) Síndrome de Crigler Najjar tipo 1
- d) Hipotiroidismo congénito
- e) Cirrosis biliar primaria

77) Un niño de 1 año y 10 meses de edad presenta un cuadro de estornudos, rinorrea y fiebre. Dos días después ya no presenta fiebre, sin embargo se agrega tos y persiste con rinorrea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Resfriado común**
- b) Influenza
- c) Infección por adenovirus
- d) Sinusitis bacteriana
- e) Bronquiolitis

90) Una niña de 4 años presenta claudicación de la marcha, asociada a compromiso del estado general y decaimiento. Evoluciona con aumento del dolor, que le impide caminar y fiebre hasta 39 grados. Al examen físico está febril, decaída y presenta intenso dolor tanto a la movilización pasiva, como a la movilización activa de la cadera derecha. Se solicitan exámenes que muestran PCR: 10 y glóbulos blancos: 17.000 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Osteomielitis de la cabeza femoral
- b) Leucemia aguda
- c) Sinovitis transitoria
- d) Artritis viral
- e) Artritis piógena**

96) Un niño de 2 años y medio de edad presenta un cuadro de tos, fiebre y rinorrea de 24 horas de evolución. Se agrega disfonía, de manera súbita y finalmente evoluciona con dificultad respiratoria y agitación. Al examen físico presenta estridor inspiratorio, taquipnea, tiraje y disminución del murmullo pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cuerpo extraño laríngeo
- b) Bronquiolitis aguda
- c) Epiglotitis aguda

d) Laringitis aguda viral

e) Traqueítis bacteriana

101) Un niño de 8 años consulta por palpitaciones rápidas e intensa, asociadas a malestar general, disnea y dolor torácico. Al examen físico tiene FC: 200x', presión arterial: 90/60 mmHg. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra en la IMAGEN. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Taquicardia sinusal

b) Fibrilación auricular

c) Taquicardia ventricular

d) Flutter auricular

e) Taquicardia paroxística supraventricular

FOTO: Taquiarritmia con QRS angosto, sin onda P, regular, a 200 lpm.

105) Un niño de 6 meses de edad ha presentado múltiples infecciones respiratorias bajas y ha incrementado peso a una tasa más baja de la esperada. Al examen físico se auscultan crepitaciones pulmonares bibasales y un soplo cardíaco holosistólico, en todo el precordio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Comunicación interauricular tipo ostium secundum

b) Comunicación interventricular

c) Tetralogía de Fallot

d) Coartación aórtica

e) Ductus arterioso persistente

108) Un niño de 8 años, sin antecedentes de importancia presenta un cuadro de desviación de la mirada, con movimientos rítmicos de las extremidades, seguidas de caída al suelo y posición tónica de las extremidades superiores en flexión. El diagnóstico más probable es:

a) Crisis parcial motora

b) Epilepsia

c) Crisis atónica

d) Crisis conversiva

e) Primoconvulsión

109) Un niño de 6 años comienza con importante prurito anal, que le produce gran inquietud psicómora y le dificulta el sueño. Su examen físico es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio de este paciente?

a) Rectosigmoidoscopia

b) Test para alergias alimentarias

c) Test de Graham

d) Coproparasitológica

e) Prick test

118) Un niño de 8 meses presenta fiebre alta, hasta 40 grados, sin decaimiento ni compromiso del estado general. La fiebre desaparece bruscamente al tercer día. ¿Qué alteración es esperable que aparezca en este niño?

a) Placas blanquecinas en la mucosa oral

b) Úlceras en el paladar blando

c) Hematuria

d) Petequias generalizadas

e) Exantema morbiliforme

120) Un niño de 9 años consulta por aparición de lesiones eritematosas en las extremidades inferiores, asociadas a dolor en sus tobillos. Al examen físico presenta edema y aumento de volumen en ambos tobillos y las lesiones, que se muestran en la IMAGEN. Se solicita un hemograma que muestra hemoglobina: 15 g/dl, hematocrito: 44%, plaquetas: 280.000 por mm³ y blancos: 6.500 por mm³. Su examen de orina muestra proteinuria +, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

a) Prednisona oral

b) Inmunoglobulina

c) Hidrocortisona endovenosa

d) Paracetamol

e) Naproxeno

FOTO: pápular eritematosas en las piernas y algunas en los muslos, de 5 mm de diámetro.

124) Usted evalúa a una niña de 8 meses de edad, quien presenta botón mamario bilateral. No tiene cambios en la pigmentación de la areola mamaria, ni vello púbico y su desarrollo psicomotor y nutricional es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Observar evolución y controlar en dos meses

b) Solicitar estradiol plasmático

c) Solicitar FSH y LH plasmáticas

d) Solicitar resonancia magnética de hipófisis

e) Solicitar cariógrama

137) Un niño de 6 años presenta un cuadro de dolor cervical, asociado a fiebre y malestar general. Al examen físico presenta un nódulo cervical muy doloroso, eritematoso y fluctuante, en relación a la línea media anterior del cuello, a la altura del hueso hioides. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Adenitis supurada

b) Quiste del conducto tirogloso infectado

c) Quiste branquial infectado

d) Higroma quístico infectado

e) Tiroiditis subaguda

151) Un niño de 16 años, con IMC en percentil 97 para la edad, presenta un cuadro de polidipsia y poliuria, por lo que se solicita una glicemia de ayuno, que resulta 203 mg/dl. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

a) Insulina

b) Metformina

c) Insulina

d) Solo dieta

e) Glibenclamida

172) Un paciente de 8 años, diabético tipo 1, en tratamiento con insulina en esquema intensificado, es ingresado por una cetoacidosis diabética. Al examen está en orientado, vigil, con leve deshidratación. En sus exámenes presenta pH: 7,30, HCO₃: 15 mEq/L, glicemia: 380 mg/dl, K: 4,6 mEq/L, Na: 135 mEq/L y cetonas positivas en sangre. ¿Cuál es la primera medida terapéutica?

a) Solución salina al 0,9% 20 cc/Kg endovenoso, en bolo

- b) Bicarbonato de sodio endovenoso
- c) Insulina cristalina s.c.
- d) Solución salina al 0,9% déficit más requerimiento
- e) Insulina cristalina e.v.

173) Una niña de 6 años presenta gran picazón en la cabeza, desde hace 7 días. Al examen físico se observan múltiples liendres en el cabello, sin poder observar ningún piojo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Tratar con permetrina al 5% tópica
- b) Tratar con permetrina al 1% tópica**
- c) Tratar con ivermectina oral
- d) Tratar con lindano al 1% tópico
- e) No tratar mientras no se visualicen piojos

171) Además de las vacunas entregadas por el sistema nacional de vacunación, ¿qué vacuna se puede recomendar a un lactante de dos meses?

- a) Vacuna contra la influenza
- b) Vacuna contra el rotavirus**
- c) Vacuna contra la hepatitis A
- d) Vacuna contra la varicela
- e) Vacuna contra el meningococo

176) Un recién nacido de 3 semanas de edad presenta vómitos frecuentes, que van en aumento. Al examen físico está deshidratado y en sus exámenes destaca K: 6,3 mEq/L y Na: 129 mEq/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Atresia duodenal
- b) Estenosis hipertrófica del píloro
- c) Intususcepción intestinal
- d) Hiperplasia suprarrenal congénita**
- e) Galactosemia

177) Un recién nacido de 26 días de vida, se le cae el cordón umbilical hace 7 días, persistiendo con salida de líquido claro por el ombligo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Persistencia del conducto onfalomesentérico
- b) Onfalocele
- c) Granuloma umbilical**
- d) Hernia umbilical
- e) Onfalitis

DICIEMBRE 2017

86) Un adolescente consulta por aparición de lesiones en zona nasogeniana, eritematosas, pruginosas, desde hace una semana. Al examen físico se aprecian costras mielicéricas en la zona descrita. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Amoxicilina más ácido clavulánico**
- b) Macrólidos
- c) Betametasona
- d) Cefoperazona

e) Ciprofloxacino

87) Un recién nacido de 5 días de vida tiene un hemangioma en el párpado izquierdo, de 1 cm de diámetro, que cubre parcialmente el iris. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Observar evolución

b) Indicar propranolol oral

c) Indicar corticoides orales

d) Biopsiar

e) Derivar a cirujano plástico infantil

93) Un niño de 7 años es mordido por un perro callejero en el brazo derecho. Además del manejo de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto a la profilaxis de la rabia?

a) Observar al niño por 10 días

b) Vacunar al niño solo si el perro presenta síntomas

c) Administrar la vacuna antirrábica al niño

d) Vacunar al niño solo si el perro muere

e) Administrar inmunoglobulina antirrábica al niño

120) Un niño de 4 años presenta intenso prurito anal, desde hace varios días, lo que se ha asociado a dificultades para dormir y bruxismo. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

a) Parasitológico de deposiciones

b) Test de Graham

c) Hemograma

d) Prueba de reacción cutánea a la escoriación (Prick test)

e) Recuento de inmunoglobulina E específica

121) Un niño de 11 meses de edad presenta un cuadro de fiebre, hasta 38,7 grados celsius, asociado a diarrea acuosa abundante, con deposiciones explosivas, ácidas, más irritabilidad importante.

a) Rotavirus

b) Enterovirus

c) Escherichia coli

d) Shigella

e) Adenovirus

122) Una niña de 4 años presenta un cuadro catarral, con abundante rinorrea. Evoluciona con eritema y dolor periocular derecho, asociado a proptosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Celulitis preorbitaria

b) Celulitis orbitaria

c) Orbitopatía distiroidea

d) Pseudotumor orbitario

e) Etmoiditis aguda

123) Un niño de 2 meses, es traído por su madre a vacunarse. ¿Qué vacuna, fuera de las del Plan Nacional de Inmunizaciones, se le puede recomendar?

a) Rotavirus

b) Varicela

c) Pneumocócica polisacárida

- d) Hepatitis A
- e) Trivírica

124) Un niño de 6 años sufre un accidente en el campo, golpeándose con un palo en la cabeza y resultando con una herida supraciliar derecha de 5 cm de longitud. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Afrontamiento con cianoacrilato
- b) Afrontamiento con tela adhesiva
- c) Sutura con punto separado
- d) Sutura intradérmica
- e) Dejar que cure por segunda intención

125) Un recién nacido de 5 días, aún no ha eliminado meconio. Además presenta irritabilidad, vómitos postprandiales frecuentes y distensión abdominal. Se realiza un enema baritado, que muestra un ano permeable, con colon proximal dilatado y colon distal estrecho. El examen más adecuado para confirmar el diagnóstico es:

- a) TAC abdominal
- b) Ecografía abdominal
- c) Test del sudor
- d) Biopsia por succión
- e) Radiografía de abdomen simple

126) Un lactante de 4 meses, alimentado con lactancia materna exclusiva, tiene índice talla edad: normal, índice peso edad: normal e índice peso talla: +1. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional de acuerdo a la OMS y el Minsal?

- a) Desnutrición
- b) Riesgo de desnutrición
- c) Eutrófico
- d) Riesgo de obesidad
- e) Obesidad

127) Un preescolar de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 38 grados, asociado a eritema en las mejillas, que aumenta en los periodos de fiebre y con el calor y se vuelve más pálido cuando no hay fiebre. Luego se agrega un exantema reticular en el tronco. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Virus rubéola
- b) Virus Coxsackie
- c) Parvovirus B19
- d) Streptococcus pyogenes
- e) Virus herpes 6

128) Un preescolar de 2 años, presenta un cuadro de fiebre alta, desde hace 5 días, asociado a marcado decaimiento. Al examen físico presenta un exantema eritematoso en el tronco, asociado a eritema de las manos y ojo rojo. La boca muestra amígdalas congestivas y lengua enrojecida. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome pie mano boca
- b) Eritema infeccioso
- c) Escarlatina
- d) Sarampión
- e) Enfermedad de Kawasaki

129) Un recién nacido de 18 horas de vida, desarrolla ictericia hasta los muslos. Se solicitan niveles plasmáticos de bilirrubina que resulta 15,3 mg/dl, con fracción indirecta de 15 mg/dl. La madre era O-IV Rh positiva y el niño es B-I Rh negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
- b) Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh
- c) Ictericia fisiológica
- d) Hepatitis neonatal
- e) Ictericia por lactancia materna

130) Un recién nacido de 4 semanas de vida presenta un cuadro de vómitos postprandiales abundantes, desde hace una semana, asociada a detención del incremento ponderal. La madre refiere que lo nota hambriento y toma leche ávidamente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar radiografía de abdomen simple
- b) Realizar tratamiento endoscópico
- c) Observar evolución
- d) Realizar pilorotomía de Ramstedt
- e) Realizar funduplicatura gástrica

131) Una preescolar de 4 años presenta prurito en la cabeza. Al examen físico se ven abundantes liendres, a menos de 3 cm del cuero cabelludo, sin visualizar piojos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Ivermectina oral
- b) Permetrina tópica al 1%
- c) Permetrina tópica al 5%
- d) Lindano tópico
- e) No tratar, mientras no se visualicen piojos

132) Una niña de 4 años, celiaca desde hace 2 años, en tratamiento con dieta, desde el diagnóstico. En el último tiempo ha presentado diarrea y metorismo, por lo que los padres sospechan que está incumpliendo la dieta en el jardín infantil. ¿Cuál es el examen inicial para confirmar la sospecha diagnóstica?

- a) Endoscopia digestiva alta, con biopsia de duodeno
- b) Anticuerpos anti gliadina clásicos
- c) Anticuerpos antireticulina
- d) Anticuerpos anti endomisio
- e) Prueba de la D-xilosa

133) Una paciente de 14 años sufre una convulsión tónico clónica, luego de una noche con privación de sueño y exposición a pantallas. Previo a esto, presentaba movimientos bruscos, como sacudidos, de manera involuntaria. Sus amigas relatan que en ocasiones “se queda pegada” por algunos segundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Epilepsia mioclónica juvenil
- b) Epilepsia de ausencia juvenil
- c) Epilepsia tónico clónica
- d) Epilepsia focal
- e) Crisis convulsiva por privación de sueño

134) Una niña de 5 años consulta por disuria dolorosa, asociado a orinas turbias y de mal olor, sin fiebre. Se solicita un examen de orina por sondeo, que muestra 20 a 30 leucocitos por campo, con 3 a 4 glóbulos rojos por campo y bacterias abundantes. El urocultivo está pendiente. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección?

a) Nitrofurantoína

b) Ciprofloxacino

c) Metronidazol

d) Amoxicilina

e) Cefoperazona

135) Un niño de 18 meses presenta un cuadro de fiebre hasta 39 grados, asociado a decaimiento e irritabilidad. La madre refiere orinas de mal olor, por lo que se realiza un examen de orina por sondeo, que da salida a un líquido con abundante bacterias, 50 piocitos por campo y escasa hematuria. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

a) Ciprofloxacino

b) Cefadroxilo

c) Nitrofurantoína

d) Gentamicina

e) Cefoperazona

136) Un lactante de 1 años de vida ingresa al servicio de urgencia en malas condiciones generales, soporoso, con extremidades pálidas y frías en la zona distal. Se indica hidratación endovenosa, pero, a pesar de intentarlo, es imposible acceder a un vía venosa. ¿Cuál es la vía de elección para administrar fluidos en este paciente?

a) Catéter venoso central

b) Línea arterial

c) Sonda nasogástrica

d) Denudación venosa

e) Osteoclisis

137) Un recién nacido presenta aumento de volumen en la cabeza. Al examen físico se aprecia blando y fluctuante, sin sobrepasar la línea media. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Absceso de cuero cabelludo

b) Cefalohematoma subperióstico

c) Meningocele

d) Hemorragia intracerebral

e) Bolsa serosanguínea

138) Un recién nacido presenta un soplo pansistólico, que se escucha entre el tercer y cuarto espacio intercostal. Además presenta algunas crepitaciones escasas en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Comunicación interauricular

b) Comunicación interventricular

c) Ductus arterioso persistente

d) Estenosis mitral

e) Atresia tricuspídea

139) Un niño de 5 años presenta fiebre no cuantificada, asociada a un exantema que inicia en las mejillas y que luego se extiende a la zona proximal de las extremidades, con una disposición, en encaje. Al examen físico tiene 37,1 grados de temperatura y se aprecia la faringe congestiva, con amígdalas rosadas y el exantema descrito. El diagnóstico más probable es:

a) Exantema súbito

b) Eritema infeccioso

c) Exantema por virus Coxsackie

- d) Rubéola
- e) Escarlatina

140) Un niño de 4 años presenta retraso generalizado del desarrollo psicomotor. Solo dice 4 palabras inteligibles. Además realiza movimientos estereotipados de rotación y manierismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Distrofia muscular de Duchenne
- b) Síndrome de Gilles de la Tourette
- c) Trastorno del espectro autista
- d) Parálisis cerebral
- e) Síndrome de West

141) Una niña de 13 meses de edad, desde hace 4 meses ha detenido su crecimiento. Además presenta diarrea, con deposiciones pastosas y tendencia al meteorismo. En sus exámenes destaca anemia ferropénica. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

- a) Anticuerpos IgA antiendomiso
- b) Recuento total de inmunoglobulinas
- c) Test del sudor
- d) Radiografía de mano
- e) 17 – OH – progesterona

142) Un escolar de 6 años presenta aumento de volumen submandibular derecho, doloroso. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen, de aspecto eritematoso, de 3 cm de diámetro, doloroso a la palpación. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Bacteroides fragilis
- b) Peptoestreptococo
- c) Streptococcus tipo A
- d) Staphylococcus aureus
- e) Escherichia coli

143) Un paciente de 8 años consulta por fiebre alta, asociada a odinofagia intensa. En su examen físico se aprecia faringe eritematosa, asociada a exudado bilateral. Se solicita una prueba rápida de detección de antígenos estreptocócicos, estreptocócicos, la que resulta positiva. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Amoxicilina
- b) Amoxicilina + ácido clavulánico
- c) Azitromicina
- d) Clindamicina
- e) Metronidazol

144) ¿Cuál es la conducta más adecuada ante un recién nacido, cuya madre tiene el diagnóstico de hepatitis B?

- a) Administrar la vacuna anti-VHB e inmunoglobulina anti-VHB al niño
- b) Prohibir la lactancia materna
- c) Dar antivirales al niño
- d) Solicitar pruebas hepáticas al niño
- e) Observar evolución

145) Un niño de 27 días de vida presenta ictericia, que inició hace una semana. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y no ha tenido otros síntomas. Se solicitan exámenes que muestran una bilirrubina total de 18,8 mg/dl y una bilirrubina directa de 18,0 mg/d. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Ictericia por leche materna
- b) Ictericia fisiológica
- c) Atresia primaria de las vías biliares
- d) Hipotiroidismo congénito
- e) Hepatitis neonatal

146) Una lactante de 7 meses se alimenta con 4 mamaderas al día, de leche purita fortificada al 7,5% más cereal al 5%, más 1 sopa puré. ¿Qué suplemento alimenticio debería estar recibiendo?

- a) Tiamina
- b) Zink
- c) Vitamina A
- d) Vitamina D
- e) Ácido fólico

147) Un niño de 3 años presenta un cuadro de congestión nasal, con rinorrea serosa, asociada a tos y ligera odinofagia. Al examen físico tiene temperatura 37,3 grados celsius, faringe congestiva, rosada y nariz con rinorrea abundante. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Solución salina intranasal
- b) Amoxicilina oral
- c) Corticoides nasales
- d) Diclofenaco oral
- e) Azitromicina oral

148) Un adolescente de 15 años presenta dolor frecuente del testículo izquierdo. Al examen físico se palpa aumento de volumen perotesticular, compatible con un varicocele y además se palpa el testículo izquierdo de menor tamaño que el testículo derecho. Se solicita una ecografía testicular que muestra una dilatación patológica del plexo pampiniforme.

- a) Observa evolución hasta que complete su desarrollo puberal
- b) Realizar varicosectomía
- c) Solicitar espermograma
- d) Realizar biopsia testicular
- e) Solicitar cariograma y niveles de testosterona, LH y FSH

JULIO 2017

3) Un lactante de 12 meses de edad es traído por su madre, ya que presenta coloración amarillentaanaranjada en las palmas de las manos, las plantas y en las mejillas. No tiene otros antecedentes, pesa 9,5 Kg y mide 73,5 cm y su examen físico no muestra otras alteraciones. ¿Cuál es la causa de esta alteración?

- a) Hipercolesterolemia
- b) Hipertrigliceridemia
- c) Hiperbilirrubinemia de predominio directo
- d) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- e) Un componente de la dieta

6) Un recién nacido presenta aumento de volumen parietal izquierdo, limitado a la zona parietal, que no sobrepasa la línea media. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la alteración descrita?

- a) Fistulización a la piel
- b) Osteomielitis
- c) Disección de cuero cabelludo
- d) **Hiperbilirrubinemia**
- e) Abscedación

20) Un escolar de 7 años consulta por una zona alopécica de 2 semanas de evolución, que ha ido en creciendo. Al examen físico se aprecia la placa alopécica de 4 cm, con descamación y pelos entrecortados, tal como se muestra en la siguiente imagen:

INSERTAR FOTO ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) **Tiña capitis**
- b) Tricotilomanía
- c) Alopecia areata
- d) Lupus discoide
- e) Dermatitis solar

27) Un niño de 2 años presenta tos de 3 días de evolución, asociado a odinofagia y fiebre de 38 grados Celsius. Al examen físico presenta congestión y eritema de la faringe y las amígdalas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) **Ibuprofeno oral**
- b) Amoxicilina oral
- c) Azitromicina oral
- d) Aciclovir oral
- e) Oseltamivir oral

31) Un lactante de 5 meses presenta opacidad corneal bilateral, asociado a epifora y aumento del diámetro corneal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Retinoblastoma
- b) Macrocórnea
- c) **Glaucoma congénito**
- d) Atresia lagrimal
- e) Catarata congénita

33) Un lactante de 18 meses de edad, presenta una convulsión tónico-clónica de 3 minutos de duración. Al examen físico está afebril, sin alteraciones en el examen segmentario. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis?

- a) **Diazepam**
- b) Ácido valproico
- c) Fenitoína
- d) Carbamazepina
- e) Topiramato

36) Un niño de 7 años presenta olor axilar, vello púbico en Tanner 2, testículos de 2 cc de volumen. Se solicita radiografía de mano, que muestra edad ósea acorde con la edad cronológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tumor suprarrenal
- b) Pubertad precoz central
- c) Pubertad precoz periférica

d) Hiperplasia suprarrenal congénita

e) Adrenarquia normal

39) Un lactante de 5 días de vida, alimentado con lactancia materna exclusiva, presenta ictericia en la cara y el tronco, que inició hace 2 días. Se solicita bilirrubina plasmática, que resulta 10 mg/dl, bilirrubina directa de 0,3 mg/dl, hematocrito de 56%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Hepatitis neonatal

b) Atresia biliar primaria

c) Ictericia fisiológica

d) Ictericia hemolítica

e) Ictericia por leche materna

45) Un niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 39,5 grados, asociada a tos con expectoración mucopurulenta, de 2 días de evolución. Además refiere cefalea y marcado malestar general. Al examen físico está decaído, febril, con FC:100x', RR2T, sin soplos, examen pulmonar con presencia crepitaciones localizadas en la zona superior del campo pulmonar derecho. Se realiza radiografía de tórax, que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

a) Mycoplasma pneumoniae

b) Chlamydia pneumoniae

c) Streptococcus pneumoniae

d) Haemophilus influenzae

e) Staphylococcus aureus

56) Un lactante de 7 meses, con antecedente de haber sido hospitalizado en varias oportunidades por cuadros respiratorios febriles, presenta diarrea de algunos meses de evolución, asociada a esteatorrea y mal incremento ponderal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Enfermedad celíaca

b) Inmunodeficiencia primaria

c) Fibrosis quística

d) Alergia a la proteína de la leche de vaca

e) Giardiasis intestinal

62) Un niño de 3 años presenta diarrea de 3 meses de evolución, intermitente, generalmente acuosa, pero que en ocasiones contiene escasos restos vegetales. Ha subido 600 gramos en ese periodo y su talla es 90 cm. Tiene signos vitales normales, se aprecia hidratado y su examen abdominal muestra un abdomen blando, depresible e indoloro, sin visceromegalia ni otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

a) Diarrea crónica inespecífica

b) Enfermedad celíaca

c) Enteropatía perdedora de proteínas

d) Alergia a la proteína de la leche de vaca

e) Intolerancia a los disacáridos

64) Un niño de 7 años comienza hace 3 meses con pestañeo frecuente asociado a expresiones faciales como levantar las cejas, a lo que en el último tiempo se agregan movimientos involuntarios de las extremidades superiores, asociados a sacudidas bruscas de la cabeza y en los últimos días además se ha agregado carraspea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de Gilles de la Tourette
- b) Trastorno obsesivo
- c) Corea
- d) Enfermedad por tics**
- e) Crisis epiléptica parcial

72) Un recién nacido de 2 semanas es hospitalizado por presentar apneas. La madre refiere tos de 3 semanas de evolución, en crisis, que en ocasiones la hacen vomitar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

- a) Amoxicilina
- b) Azitromicina**
- c) Ceftriaxona
- d) Oseltamivir
- e) Aciclovir

75) Un niño de 2 años presenta un cuadro de 7 días de fiebre hasta 39 grados, asociado a inyección conjuntival y boca roja con labios partidos, a lo que se agrega un exantema eritematoso generalizado. Al examen, se aprecia decaído, con fiebre de 38,8 grados, presenta adenopatías cervicales y se observa descamación gruesa de los dedos de las 4 extremidades. Se encuentra hospitalizado, recibiendo un tratamiento adecuado. ¿Cuál es la evolución más probable en este paciente?

- a) Daño permanente de las arterias coronarias
- b) Recurrencia esporádica de los síntomas
- c) Resolución completa, sin secuelas**
- d) Daño vascular periférico generalizado
- e) Daño a las válvulas cardíacas

77) Un niño de 10 años convulsiona a la mañana siguiente, de haber trasnochado jugando videojuegos. Además refiere mioclonías matinales frecuentes, desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. ¿Cuál es la medida más adecuada?

- a) Prohibir por completo los videojuegos
- b) Iniciar ácido valproico**
- c) Iniciar carbamazepina
- d) Iniciar fenobarbital
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro

79) Un niño de 2 años y 8 meses realiza rabietas con frecuencia, se tira al suelo y grita cuando no se hace lo que él quiere, lo que ha pasado frente a sus padres y las profesoras del jardín infantil. Dice 300 palabras y su desarrollo motor es acorde a su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno oposicionista desafiante
- b) Trastorno de conducta
- c) Trastorno por déficit atencional
- d) Trastorno generalizado del desarrollo
- e) Oposicionismo normal para su desarrollo**

100) Un recién nacido de 20 días de vida presenta ginecomastia bilateral. Se palpa tejido mamario de 1,5 cm en cada mama, de consistencia firme. El resto del examen físico es normal y ha subido adecuadamente de peso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar niveles plasmáticos de prolactina
- b) Solicitar niveles de estrógenos, progesterona, LH y FSH

- c) Solicitar ecografía mamaria
- d) Realizar biopsia
- e) Observar y controlar ambulatoriamente

103) Un niño de 12 meses recibe sus vacunas, según el Plan Nacional de Inmunizaciones, más una dosis de la vacuna pentavalente, que estaba atrasada. Diez días después, presenta fiebre hasta 38 grados Celsius. ¿Qué vacuna es la responsable de la fiebre, con mayor probabilidad?

- a) Antimeningocócica
- b) Antineumocócica
- c) Trivírica
- d) Pertusis
- e) Anti-Haemophilus

108) Un niño de 4 años, hace 24 horas ingiere 7 comprimidos de algún medicamento desconocido, evolucionando con malestar general, vómitos e ictericia. Se solicitan exámenes, en los que destaca GOT: 403 UI/L, GPT: 390 UI/L, bilirrubina plasmática total: 5,2 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar L-carnitina endovenosa
- b) Administrar deferoxamina endovenosa
- c) Administrar N-acetil-cisteína endovenosa
- d) Administrar carbón activado vía oral
- e) Administrar piridoxina vía oral

109) Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar parcial, de los labios menores. No tiene desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias, ni genitales. El resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar lavados con ácido acéticos
- b) Aplicar corticoides tópicos
- c) Remover las sinequias de manera quirúrgica
- d) Indicar antibióticos
- e) Realizar aseo y masajes en la zona

111) Usted controla a una niña de 7 meses de edad, con antecedente de síndrome de Down, con infecciones respiratorias en múltiples ocasiones que han requerido hospitalización y que aún no ha podido duplicar el peso de nacimiento. Al examen físico se ausculta ritmo regular en dos tonos, con soplo holosistólico intenso, ² irradiado a dorso, asociado a un desdoblamiento del segundo ruido. El diagnóstico más probable es:

- a) Comunicación interauricular tipo ostium secundum
- b) Canal auriculoventricular
- c) Atresia tricuspídea
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Comunicación interventricular

122) Usted atiende a un lactante de 10 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro a las 30 semanas y que pesó 1.300 gramos al nacer. Según el Plan Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), ¿qué tipo de leche debe recibir?

- a) Fórmula de inicio
- b) Fórmula de continuación
- c) Leche purificada
- d) Fórmula de inicio para prematuros

e) Fórmula de continuación para prematuros

123) Un niño de 4 años presenta sensación febril y ojo rojo bilateral, asociado a ardor y lagrimeo, lo que se acompaña de rinorrea y odinofagia. Varios de sus familiares tienen los mismos síntomas. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Chlamydia trachomatis
- b) Staphylococcus aureus
- c) Streptococcus pyogenes
- d) Haemophilus influenzae

e) Adenovirus

126) Un escolar de 8 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades inferiores, consistentes en pápulas eritematosas, palpables. Refiere además artralgias migratorias en las manos, rodillas y codos, y también hematoquezia en algunas oportunidades desde hace algunos días. ¿Cuál es la complicación más probable en el mediano plazo?

- a) Aneurismas coronarios
- b) Infartos cerebrales
- c) Hepatitis
- d) Daño vascular periférico

e) Nefritis

128) Una niña de 8 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y aparición de ictericia asociado a orinas oscuras que se identifica como coluria. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT 1.525 UI/L, GPT 1.216 UI/L, bilirrubina total 11,3 mg/dL de predominio directo e IgM para VHA (+). Se indica reposo por 10 días evolucionando favorablemente, sin embargo, 10 días después reaparece la ictericia, agregándose prurito y astenia. Se controlan pruebas hepáticas que muestran protrombinemia: 90%, GOT: 1.025 UI/L y GPT: 968 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hepatitis crónica
- b) Remisión completa
- c) Portación asintomática del virus

d) Remisión parcial con recurrencias

- e) Falla hepática

130) Un niño de 4 años presenta fiebre hasta 39 grados Celsius, mialgias y tos de 3 días de evolución. Además ha presentado rinorrea y cefalea. Al examen físico presenta temperatura de 38,8 grados y su examen pulmonar es normal. Se realiza test pack para virus respiratorios, que resulta positivo para virus influenza B. ¿Cuál es el fármaco de elección para el tratamiento de este paciente?

- a) Oseltamivir

b) Acetaminofeno

- c) Aciclovir
- d) Amantadina
- e) Amoxicilina

131) Una paciente de 15 años, con menarquia a los 14 años, consulta por atraso menstrual de 2 meses. No tiene vida sexual. Su examen físico segmentario no muestra alteraciones y tiene desarrollo mamario y genital acorde a su edad. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Pedir niveles plasmáticos de TSH y prolactina
- b) Solicitar ecografía transvaginal

- c) Realizar histerosonografía
- d) Iniciar anticonceptivos orales
- e) Dar progesterona oral, si el atraso dura un mes más

132) ¿Qué alteración del examen físico, obliga a descartar una disraña espinal de tipo espina bífida oculta?

- a) Melanocitosis cutánea congénita
- b) Nevus ammeus sacro
- c) Nevo congénito en la zona sacra
- d) Hoyuelo sacro o “fosita pilonidal”
- e) Seno dérmico sacrococcígeo

137) Un niño es diagnosticado de displasia de cadera a los 6 meses de vida, mediante una radiografía, que muestra la displasia, con luxación del extremo proximal del fémur izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Doble pañal
- b) Correas de Pavlik
- c) Yeso con Yjador
- d) Osteotomía periacetabular tipo Ganz
- e) Reducción abierta y Yjación con osteosíntesis

140) Un lactante de 7 meses, en tratamiento con domperidona por re ujo gastroesofágico, presenta desviación del cuello a la izquierda, asociado a llanto y movimientos irregulares de los ojos. Al examen físico presenta contractura de los músculos del cuello. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Crisis epiléptica focal
- b) Distonía aguda por fármacos
- c) Disquinesia aguda por fármacos
- d) Síndrome de West
- e) Infección por Clostridium tetani

142) Un niño de 6 años presenta múltiples en el tronco, que se muestran en la imagen. Su padre tiene lesiones similares.

INSERTAR FOTO El diagnóstico más probable es:

- a) Neurofibromatosis tipo 1
- b) Enfermedad de Addison
- c) Enfermedad celiaca
- d) Síndrome de Peutz-Jeghers
- e) Hiperplasia suprarrenal congénita

156) Una niña de 8 meses de edad presenta un cuadro febril hasta 39,2 grados Celsius, sin otros síntomas, ni alteraciones en su examen físico. Se realiza un urocultivo por recolector, que resulta positivo para Escherichia coli sensible, con 45.000 unidades formadoras de colonias, por ml. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Tratar con cefadroxilo oral
- b) Tratar con nitrofurantoína oral
- c) Tratar con amoxicilina oral
- d) Solicitar hemograma, VHS y PCR
- e) Repetir el urocultivo por sondeo vesical

158) Un lactante de 15 meses de edad presenta una convulsión tónico-clónica de 1 minuto de duración, autolimitada, mientras cursaba con fiebre de 39 grados Celsius. Al examen está bien perfundido, algo pálido, consciente, con pulso y presión arterial normales, sin signos focales, ni signos meníngeos. El resto de su exploración, no presenta hallazgos de importancia. Además de bajar la temperatura del niño ¿cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar punción lumbar
- b) Iniciar diazepam
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
- d) Iniciar ácido valproico
- e) Mantener en observación por 4 horas

julio 2018

Un lactante de 8 meses de edad presenta un cuadro de malestar general y decaimiento desde hace 3 días. Hace 24 horas se agregan deposiciones líquidas y disintéricas, con oliguria. En sus exámenes destaca bilirrubina: 4,3 mg/dl, GOT: 76 UI/L, sodio: 132 mEq/L, potasio: 5,1 mEq/L, creatinina: 2,1 mg/dl, BUN: 70 mg/dl, hematocrito: 27%, plaquetas: 110.000 por mm³, leucocitos: 7.800 por mm³, y frotis con abundantes esquistocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Enterocolitis por Shigella
- b. Endocarditis bacteriana
- c. Fiebre tifoidea
- d. Enterocolitis por Clostridium difficile
- e. Síndrome hemolítico urémico

Una niña de 8 meses de edad presenta botón mamario bilateral. No tiene alteraciones en la areolas ni presencia de vello púbico. Su desarrollo psicomotor es normal, al igual que su antropometría. La conducta más adecuada es:

- a. Controlar en dos meses
- b. Solicitar niveles de estradiol
- c. Solicitar niveles de FSH y LH
- d. Realizar resonancia magnética pélvica
- e. Solicitar test de LHRH

Una niña de 12 meses de edad que presenta botón mamario bilateral, con desarrollo de Tanner 2 en ambas mamas, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a. Observar evolución
- b. Solicitar estradiol plasmático
- c. Solicitar LH y FSH plasmática
- d. Solicitar test de LHRH
- e. Solicitar RMN de pelvis

Un recién nacido de 37 semanas de gestación presenta al nacer hipotonía letargia, microcefalia, asociada a ictericia, hepatoesplenomegalia y aparición de un exantema generalizado precoz. Su ecografía cerebral muestra calcificaciones. El agente etiológico más probable es:

Seleccione una:

- a. Parvovirus B19
- b. Streptococcus agalactiae
- c. Streptococcus pneumoniae

d. Citomegalovirus

e. Virus herpes simplex

Un niño de 4 meses, sin control presenta episodio de marcado decaimiento, dificultad respiratoria y cianosis desde hace 3 horas, por lo que sus padres lo llevan a urgencia. Al examen físico llama la atención cianosis generalizada y presencia de frémito cardíaco al palpar el tórax, con examen cardíaco en que se ausculta un soplo de intensidad IV/VI en la zona paraesternal izquierda. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

a. Atresia tricuspídea

b. Tetralogía de Fallot

c. Ductus arterioso persistente

d. Comunicación interauricular

e. Atresia tricuspídea

Un niño de 24 meses presenta desde hace varios meses diarrea, con deposiciones líquidas frecuentes, asociada a distensión abdominal e inapetencia. En el último año ha subido 980 gramos, t actualmente tiene un IPE de -1 y un IPT de -2. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Fibrosis quística

b. Giardiasis

c. Enfermedad celíaca

d. Alergia alimentaria

e. Intolerancia a la lactosa

Un niño de 4 años presenta aparición de ronchas evanescentes, desde hace 4 días. Además, desde hace algunos días presentaba congestión nasal, con rinorrea y estornudos. Al examen físico se observan habones en el tórax y dermatografismo en las extremidades. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Indicar corticoides orales

b. Solicitar prick test

c. Indicar antihistamínicos orales

d. Solicitar IgE sérica total

e. Solicitar test de parches

Un adolescente de 14 años consulta por una lesión de color rojo, en el tórax, que apareció hace algunas semanas y que ha sangrado varias veces, en relación al roce de la ropa. Se muestra a continuación:

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

a. Pioderma gangrenoso

b. Hemangioma infantil

c. Nevo atípico ulcerado

d. Granuloma telangiectásico

e. Queratosis seborreica

Un niño de 4 años es traído por su madre, ya que presenta un cuadro de 2 meses de evolución de diarrea intermitente, que dura 4 a 5 días, con deposiciones líquidas y fétidas, asociadas a meteorismo, distensión abdominal y malestar abdominal. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

a. Amebiasis intestinal

- b. Colitis por Clostridium difficile
- c. Giardiasis intestinal**
- d. Enterocolitis por Shigella
- e. Infección por rotavirus

Una niña de 4 años ingiere accidentalmente soda cáustica hace 2 horas. Al examen físico, está en buenas condiciones, con FC: 78 por minuto, presión arterial normal, sin alteraciones de conciencia ni del examen abdominal. La conducta más adecuada es:

- a. Realizar lavado gástrico con carbón activado
- b. Administrar bicarbonato
- c. Administrar suero fisiológico endovenoso
- d. Administrar sucralfato
- e. Realizar gastroscopía dentro de las próximas 6 horas**

Un niño de 11 años, presenta un cuadro de 2 horas de evolución de disnea y dolor torácico. Su frecuencia cardíaca es 200 a 240 lpm, PA: 120/80. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación: La conducta inicial es:

- a. Aplicar hielo en el abdomen
- b. Adenosina endovenosa
- c. Amiodarona endovenosa
- d. Compresión del seno carotídeo**
- e. Verapamilo endovenoso

Un niño de 4 meses, desde hace 2 horas presenta letargia, decaimiento y compromiso de conciencia. Su fondo de ojo muestra petequias retinales. ¿Cuál es el examen más adecuada para proseguir con el estudio?

- a. Punción lumbar
- b. TAC de cerebro**
- c. Sedimento de orina y urocultivo
- d. Hemocultivos
- e. Radiografías de cráneo

Un recién nacido de 6 semanas se atora al inicio de las tomas de leche, presentando tos, que le hace interrumpir la toma de leche, por varios segundos. Actualmente pesa 5.190 gramos y al nacer pesó 3.890 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a. Fístula traqueoesofágica
- b. Reflujo gastroesofágico fisiológico
- c. Reflujo gastroesofágico patológico
- d. Estenosis hipertrófica del píloro
- e. Reflejo eyectolácteo acentuado**

Nota. Probablemente, la madre eyecta mucha leche al inicio de la toma, por lo que el exceso de leche produce estos síntomas. No hay regurgitación como para pensar en reflujo y ha subido 30 gramos diarios de peso, lo que es normal.

Un recién nacido de 30 semanas de edad gestacional, presenta un síndrome de dificultad respiratoria grave, con cianosis, taquipnea y uso de musculatura accesoria. Su examen pulmonar demuestra algunos crépitos y requiere FIO₂ de 0,6. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

Seleccione una:

- a. TAC de tórax

b. Radiografía de tórax

- c. Hemocultivos y cultivos de expectoración
- d. Ecocardiografía
- e. Cateterismo cardíaco

Un recién nacido de 3 días de vida, presenta múltiples lesiones amarillentas, pequeñas, apenas sollevantadas en ambas alas nasales. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- a. Corticoides tópicos
- b. Antimicóticos tópicos
- c. Vaselina líquida tópica
- d. Mantener el aseo habitual**
- e. Antibióticos tópicos

Una niña de 14 años aún no ha tenido su menarquia. Al examen físico no presenta desarrollo puberal y tiene talla baja. Como antecedente, fue operada de una coartación aórtica hace varios años. ¿Cuál es el examen más adecuado para seguir con el estudio en esta paciente?

Seleccione una:

- a. Niveles de FSH
- b. Hormona antimülleriana b. Hormona antimülleriana
- c. Edad ósea
- d. Niveles de estradiol
- e. Cariograma**

Un niño de 7 años presenta aumento de volumen en el cuello, que se desplaza con la deglución. El examen físico, se aprecia en la siguiente imagen.

¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?

Seleccione una:

- a. TAC de cuello
- b. Ecografía de cuello**
- c. Radiografía de cuello
- d. Cintigrafía con yodo radiactivo
- e. Captación de yodo radiactivo

Un niño de 8 años consulta por un cuadro de 6 horas de evolución de fiebre, asociada a artralgias y malestar general, con aparición de un exantema macular eritematoso progresivo. Al examen físico tiene t°: 38,9 °C, FC: 104x', PA: 100/66 mmHg, con petequias en el tronco y las extremidades y una equimosis en el dorso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

- a. Enfermedad de Kawasaki
- b. Púrpura trombocitopénico inmune
- c. Púrpura de Schönlein Henoch
- d. Meningococcemia**
- e. Infección por parvovirus B19

Un niño de 4 meses de edad presenta un cuadro de fiebre y letargia de 2 días de evolución. Su hemograma demuestra leucocitos: 12.500, con desviación izquierda y su TAC de cerebro es normal. Se realiza punción

lumbar, que da salida a líquido turbio, con glucosa: 35 mg/dl, proteínas: 1.080 mg/L, células: 890 por mm³, con 90% de polimorfonucleares. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a. Virus herpes simplex
- b. Streptococcus pneumoniae**
- c. Staphylococcus aureus
- d. Coxsackie virus
- e. Listeria monocytogenes

Una niña de 13 años es encontrada inconsciente en el baño de su casa, con el Calefont apagado. Presenta FC: 70x', PA: 120/80 mmHg, FR: 25x', saturación arterial de 97%, sin cianosis. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a. Administrar oxígeno al 100%**
- b. Administrar carbón activado
- c. Administrar suero glucosado endovenoso
- d. Administrar suero fisiológico endovenoso
- e. Administrar bicarbonato endovenoso

Un lactante de 17 meses consulta por fiebre de 5 días de evolución, asociada a decaimiento y malestar general. Al examen físico, tiene T°: 38,5°C, con exantema eritematoso cutáneo, generalizado. Se palpan adenopatías cervicales bilaterales, sensibles y tiene inyección conjuntival. Su hemograma tiene hematocrito: 36%, blancos: 14.000 por mm³, plaquetas: 380.000 por mm³. Su boca se muestra a continuación:

El diagnóstico más probable es:

- a. Enfermedad de Kawasaki**
- b. Exantema súbito
- c. Fiebre tifoidea
- d. Reacción adversa a fármacos
- e. Enfermedad por arañazo de gato

Un niño de 6 años, presenta odinofagia intensa, con fiebre y decaimiento. Además, aparece luego un exantema eritematoso, generalizado, que es más marcado en los pliegues inguinales y axilares. Al examen físico, está febril, con temperatura de 38.7°C, faringe eritematosa. Tiene adenopatías cervicales bilaterales, sensibles y la piel se palpa áspera al tacto. ¿Qué tipo de complicación puede desarrollar este paciente?

- a. Aneurismas coronarios
- b. Meningitis
- c. Fasceítis necrotizante
- d. Glomerulonefritis**
- e. Miocarditis

Un niño de 8 años, inmigrante, que no ha recibido la vacuna BCG. Está asintomático y su examen físico es normal. Su padre está siendo tratado para la tuberculosis en su país de origen. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a. Solicitar PPD
- b. Solicitar radiografía de tórax
- c. Solicitar baciloscopías
- d. Iniciar profilaxis con isoniazida**
- e. Administrar la vacuna BCG

¿Qué vacuna, que no está contenida en el Plan Nacional de Inmunizaciones, se puede indicar a un niño de 2 meses? indicar a un niño de 2 meses?

- a. Hepatitis A
- b. Varicela
- c. Trivírica
- d. Influenza
- e. Rotavirus

Un recién nacido de término, sin mayores antecedentes, desde los 7 días de vida comienza con ruido al respirar, de tonalidad alta, que es mayor en la inspiración. Su examen físico no muestra mayores alteraciones y su examen pulmonar es normal. Ha subido adecuadamente de peso y no presenta otros síntomas. EL diagnóstico más probable es:

- a. Fístula traqueoesofágica
- b. Laringomalacia
- c. Membrana laríngea
- d. Epiglotitis
- e. Laringotraqueobronquitis

Un niño de 18 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea, disfonía y fiebre, hasta 38,5°C. Hace una hora presenta un cuadro de dificultad respiratoria, con respiración ruidosa. Al examen físico se aprecia niño taquipneico, con estridor inspiratorio, uso de musculatura accesorio, sin cianosis. La auscultación pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a. Laringitis aguda viral
- b. Croup espasmódico
- c. Cuerpo extraño bronquial
- d. Laringomalacia
- e. Coqueluche

Un niño de 6 años consulta por epistaxis bilateral frecuente. Además, tiene antecedente de ser respirador bucal, roncar en la noche y presentar infecciones respiratorias altas a repetición. El diagnóstico más probable es:

- a. Rinofibroangioma bilateral
- b. Rinitis alérgica
- c. Enfermedad de von Willebrand
- d. Hipertrofia de adenoides
- e. Atresia de coanas

Un niño de 18 meses es traído por su madre, ya que presenta malestar general, fiebre y odinofagia importante. Presenta además rinorrea y congestión nasal. Al examen físico se observa faringe eritematosa, con exudado amigdalino de aspecto blanquecino, bilateral, con adenopatías cervicales bilaterales. Su examen pulmonar es normal. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a. Staphylococcus aureus
- b. Streptococcus pyogenes
- c. Streptococcus pneumoniae
- d. Virus de Epstein Barr
- e. Adenovirus

Un lactante de 20 meses dice 4 a 5 palabras con sentido. Apunta con el dedo y no ha logrado aún marcha espontánea. Al examen físico tiene hipotonía, reflejos normales y debilidad muscular. Lo cuida su abuela, de 70 años, con movilidad reducida por artrosis de caderas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Falta de estimulación

- b. Neuropatía
- c. Miopatía
- d. Trastorno generalizado del desarrollo
- e. Parálisis cerebral

Una niña de 17 meses de edad consulta por dolor muy intenso en la cadera derecha, que le impide la marcha, asociada a fiebre y compromiso del estado general. Al examen físico tiene T°:39°C e intenso dolor de la cadera derecha, tanto a la movilización pasiva, como activa. El diagnóstico más probable es:

a. Artritis piógena de cadera

- b. Enfermedad de Kawasaki
- c. Sarcoma de Ewing pélvico
- d. Osteomielitis femoral
- e. Sinovitis transitoria

Una niña de 4 años presenta, desde hace 5 días, tos, odinofagia, rinorrea y congestión nasal, a lo que ahora se agrega aumento de volumen del ojo izquierdo, con proptosis y edema del globo ocular. El diagnóstico más probable es:

a. Celulitis orbitaria

- b. Meningitis aguda
- c. Mononucleosis infecciosa
- d. Celulitis preorbitaria
- e. Infección por adenovirus

Un recién nacido de término presenta ictericia a los 7 días de vida. Se solicita bilirrubina total: 14,2 mg/dl y bilirrubina directa: 4,0 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar hemograma, grupo-Rh y prueba de Coombs directo al recién nacido

- b. Solicitar hemograma, grupo-Rh y prueba de Coombs directo a la madre
- c. Solicitar pruebas hepáticas
- d. Solicitar sedimento de orina y urocultivo
- e. Fototerapia